

神经精神疾病古今效方

主编 李传如

科学出版社

1998



A0289793

内 容 简 介

本书从大量古今文献中精选出治疗神经精神疾病的有效方剂,用于神经精神系统常见病和多发病。每种疾病先简述其发病原因、临床表现,再述及中医药治疗概况和新进展。所选方剂,每一方剂详述其组成、来源、功效、适应证和方药简析,还附医案以说明其作用和功效。

本书对治疗神经精神疾病将起到极大的帮助,是临床医生、医学院校师生,尤其是神经精神科医师的必读之书。

图书在版编目(CIP)数据

神经精神疾病古今效方/李僖如主编.--北京:科学出版社,1998.8

ISBN 7-03-006519-0

I. 神… I. 李… II. ①神经系统疾病-验方②精神病-验方 N. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 01164 号

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码 100717

北京双青印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1998年8月第一版 开本:787×1092 1/32
1998年8月第一次印刷 印张:25 5/8
印数:1~3 000 字数:590 000

定价:39.00元

本书编写人员名单

主 编 李 倩 如

副主编 李成文 郭建新 冯福海

陈安民 郭新民 乔岩岩

孔德荣 于俊丽

序

当新世纪的大门轻启之际,正是我们伟大的中华民族空前兴旺发达的历史时期,也是科学技术进步发展的关键时期。数千年来,中国传统科学的中医中药为中华民族的繁衍昌盛做出了绝大的贡献,而今在新时期中,中医学也面临着时代赋予的机遇和挑战。

中医学将如何发展,怎样吸取现代科技研究成果,与时代同步前进,怎样深入发掘和不断丰富、补充,是中医学界共同面临的课题。

80年代中期,我们曾有计划地组织过中医临床理论,基础理论,历朝历代著名中医学代表流派和实践经验研究及中西医结合研究成果的出版工作。临床理论、临证经验方面,出版过《中国名医名方》、《最近十年中医临床经验精华》和《最近十年中医方剂精华》等;基础理论方面,推出过《中医学基本丛书》及《历代中医名著精华丛书》;研究历代医家独到经验方面,出版了《历代名医临床经验精华》等;中西医结合方面,出版过《中医内科辨病治疗学》等多种图书。

自90年代以来,山西、山东、河南、云南、四川、安徽及江苏、浙江、广东、吉林、北京、上海等地中医院校和大学学报、各省中医期刊编辑部多次合作,相继推出过不少书刊,这些资料的出版、流传,对中医药普及、发掘和推广、提高,做出了不可磨灭的贡献。

我们从1994年开始组织几个省、市、自治区中医院校有关人员编选《古今临床效方丛书》以来,出版过9本小册子。在

那个基础上,今天又组织编写了这套《胃肠疾病古今效方》、《肝胆疾病古今效方》、《妇科疾病古今效方》、《神经精神疾病古今效方》、《皮肤科疾病古今效方》、《头面疾病古今效方》丛书。

实际上,中医的方与药,是比较难以区分但又必须有所区分的。《神农本草经》中说,云母主治死肌,中风寒热,除邪气,安五脏,益子精,这是言药;《千金要方》中说,云母粉方寸匕,治积年不愈之赤白痢,这即是言方;盖云母甘平性升,色白入肺,为助气解邪之品,久痢伤气,服之辄效。所以清朝名医徐大椿先生说:“方之与药,似合而实离也。”

中医学的方剂,起源很早。古时最简单的“呶咀”,即是方剂的滥觞。《汉书·艺文志》中记有“汤液经法”,可以说是我国最早的方剂专著。

中医学的方药,浩如烟海。中药,可以说是用以治病的物质;方剂,可以说是通过药物选择性应用的一种组合。方者,法也;剂者,齐也。法是治疗方案和药物选择的法则,齐是药效的时限控制和一定的给药途径。总之,方与药,都是治疗、预防疾病的一种武器。

从中药角度来说,虽然成分很复杂,其有效成分,确实存在一定的限度和范围。譬如说众所周知的麻黄,其具发汗平喘之功,当主要用其发汗时,往往需要配合桂枝;主要用其平喘时,往往离不开杏仁。经过一番特殊的调整,根据治疗需要,则能改变中药的某些特性。同样说麻黄,厚朴麻黄汤,不主发汗,而主疗咳;甘草麻黄汤,不主发汗,而主利小便;千金麻黄醇酒汤,不主发汗,而主疗黄。这些就不是正治范畴,而是经过特殊组合的变通之法了。

凡病都有证,有名,有机,有情。高明的医家临证施治,能审察病机病情,投药用方,眉目分明,药无虚设。张仲景用药用

方,可以说是简括明净,其与病机病情、病证病名相对照,丝丝入扣,毫发不紊,不惟一味变而方药方义相殊,即分量稍差而意旨亦别。还再如说麻黄,其解表功能方面,麻黄汤中加用桂枝,而桂枝汤中不用麻黄。用麻黄后有用桂枝之法,而用桂枝汤后,无用麻黄之法。即使是风寒之症,营卫两伤,二方合用,用“麻黄桂枝各半汤”或“桂枝二麻黄一汤”。麻黄作为解表的主方,当出现内热时,则变化为大青龙汤;当内有郁水时,则变化为小青龙汤;内陷于脾,则变化为越婢汤;内热重陷,则变化为麻杏石甘汤。张之为大青龙,缩之为小青龙,驯之为越婢之法,或温,或清,或辛温,或辛凉,或发汗平喘,或利尿退黄,区区一味麻黄,所表现的作用很多,这就是“方无成药”,其出发点,都是病情的需要,这大概就是中药方剂的精华所在。选药得当,无药不效;组方合法,无方不验。

河南中医学院李僖如教授,多年来于教学、编辑、临床研究素深,在她的带领下,几个省的中医院校资深编辑、教师经过三年余的努力,整理了这一套效方丛书,搜集资料广泛,在方剂临床使用方面,很有参考价值。书成之即,应作者邀,简单地记述了一下这套丛书的诞生历史和相关意义,权且为序。在此套图书即将面世之际,又抽阅了数章,发现还有个别不妥之处,也希望读者诸君能够不吝指教,以便再版时,能予厘正。

卢祥之

1998年5月7日于北京三慎堂

目 录

1	视神经炎	1
2	三叉神经痛	13
3	面神经炎	29
4	面肌痉挛	41
5	急性感染性多发性神经病	49
6	多发性神经炎	65
7	肋间神经痛	77
8	坐骨神经痛	83
9	梅尼埃病	99
10	急性脊髓炎	119
11	急性脊髓前角灰质炎	126
12	脊髓空洞症	136
13	运动神经元性疾病	144
14	偏头痛	153
15	散发性脑炎	174
16	脑囊虫	185
17	癫痫	196
18	脑梗死	220
19	脑出血	246
20	蛛网膜下腔出血	261
21	眩晕	268
22	高血压脑病	285
23	震颤麻痹	290

24	小舞蹈病.....	298
25	肝豆状核变性.....	304
26	不安腿综合征.....	310
27	多发性动脉内膜炎.....	318
28	重症肌无力.....	327
29	周期性麻痹.....	342
30	先天性脑发育不全.....	351
31	视神经脊髓炎.....	357
32	遗传性共济失调.....	362
33	遗尿.....	370
34	脑积水.....	381
35	雷诺病.....	394
36	红斑性肢痛症.....	404
37	脑震荡.....	415
38	脑挫伤.....	424
39	脑外伤综合征.....	431
40	麻木.....	440
41	意识障碍.....	446
42	排尿性晕厥.....	454
43	焦虑性神经症.....	465
44	恐怖性神经症.....	485
45	强迫性神经症.....	496
46	癔症.....	511
47	神经衰弱.....	534
48	精神分裂症.....	550
49	躁狂抑郁症.....	582
50	周期性精神病.....	602
51	反应性精神障碍.....	623

52	抑郁症.....	638
53	更年期精神病.....	660
54	脑动脉硬化性精神病.....	676
55	老年性精神病及早老性精神病.....	697
56	有机磷中毒伴发精神障碍.....	723
57	吗啡类药物依赖.....	736
58	儿童期多动综合征.....	745
59	睡行症.....	760
60	失眠.....	775
	方名索引.....	798

可完全恢复(2~3周),眼底视乳头的充血水肿状态可同时消退,最后视乳头可恢复原状,但色泽一般较淡。重症病例可遗留不同程度的视力障碍、视野缺损和视神经萎缩。本病的诊断主要是注意球后视神经炎,尤其是慢性者,检查脑CT、MRI以排除颅内病变,必要时请眼科会诊。同时还需与视神经乳头水肿、假性视乳头水肿、癰病性黑矇、颅内肿瘤相鉴别。

视神经炎属于中医眼科中暴盲、青盲的范畴。其主要临床症状是视力急剧下降或丧失,病位在目系。发病急骤,病势凶险,多因七情内伤(尤其是暴怒或抑郁)、中毒(酒精或化学药品服用过量)、劳倦过度,饮食失节,外感风热毒邪,致使邪毒内攻,肝失疏泄,痰浊、淤血上扰壅滞目窍,目窍不利,视物昏蒙或失明;或气血精津亏耗,目失濡养,视物逐渐不清,终至失明。本病初起多为实证,与肝关系密切,涉及脾肾;从肝论治为主,或疏肝理气,活血通络,或清肝泻火,开窍明目。久病或病至后期多为虚证或虚实夹杂,以虚为主,当扶正祛邪,或补气养血或滋补肝肾,兼活血通络,开窍明目。对病因不清,且整体又无证可辨者,(如球后视神经炎),也应参上法。为了加强疗效,促进视力迅速恢复,可在辨证基础上,加升麻、防风、菊花、柴胡轻清升发,引药直达目部;若视乳头水肿可加车前子、泽泻、茯苓、薏苡仁淡利水湿;血管充盈较重淤血明显加赤芍、牡丹皮、丹参、茺蔚子活血祛瘀通络;眼部炎症明显加青箱子、菊花、石决明、决明子、夏枯草清肝明目;眼球转动疼痛明显加香附、川楝子、延胡索、郁金通络理气止痛;渗出物吸收不良加丹参、桃仁、红花、薏苡仁、冬瓜子祛瘀;视神经萎缩可加健脾补肾,活血通络之品,同时配合针刺如新明穴等,也可参考视神经萎缩的治疗。

李建国用中药、针灸、针药兼施治疗视神经炎16例,其中针药组10例(17只眼),中药组3例(5只眼),针灸组3例(4

只眼)。6人为单眼患病,余双眼同病。男7人(11只眼),女9(15只眼)。16~20岁6例,21~35岁8例,36岁以上2例。患病时间最短者10天,最长者46天。辨证属于肝肾阴虚型6例,治宜滋阴补肾,养血明目,杞菊地黄汤加减(生地黄、山药、白芍、何首乌、黄精各12g,山茱萸、枸杞子、女贞子各15g,白术、茯苓、五味子各9g);肝郁气滞6例,治宜疏肝解郁,健脾渗湿,清肝解郁益阴渗湿汤加减(女贞子、白菊花、木贼、柴胡各9g,牡丹皮、茯苓、栀子、白芍各12g,车前子15g);肝脾湿热型4例,治宜平肝健脾,清热除湿,药用白微、茯苓、泽泻、谷精草、山药、赤芍各12g,车前子、薏苡仁各15g。针灸常用睛明、太阳、足三里、球后、健明、翳风、风池、承泣、光明、头临泣、肝俞、肾俞等穴。每次局部取2穴,远端取2穴,每日针1次,10次为1疗程。病属偏阴虚者,远端可施灸法或针灸并用。治疗结果,针药组10例,痊愈(视力恢复正常或发病前水平,眼底视乳头及视网膜充血水肿消失,渗出、出血少许)7例;显效(视力提高5行以上,眼底视乳头及视网膜充血水肿基本消失,陈旧性渗出及出血少许)3例。中药组3例,显效1例,进步(视力提高2~3行,眼底视乳头及视网膜水肿部分吸收,陈旧性出血较多)1例,无效1例(治疗2个疗程后疑为蝶鞍部肿瘤而转外院)[新中医,1991,(7):32]。

郭霞用中西医结合治疗视神经炎26例,年龄10~60岁;双眼同时或前后发病17例,单眼发9例;病程最短3天,最长7个月;视神经乳头炎18例,球后视神经炎8例;情志因素引起者8例,感冒4例,劳累2例,原因不明12例。辨证属于肝气郁结,气郁化火型12例,用丹栀逍遥散加减;湿热邪毒内蕴型6例,用双花解毒汤加减;热入营血型4例,用犀角地黄汤加减;肝肾亏虚型2例,用杞菊地黄汤加减;阴虚火旺型用青蒿鳖甲汤加减。其中18例配合地塞米松,7例配合维生素B₁、

维生素 B₁₂、地巴唑、ATP 等。治疗后痊愈(视力 5.0 以上,眼底恢复正常)14 只眼;显效(视力提高 4 行以上,眼底大致正常)11 只眼;有效(视力提高 2 行以上,眼底视乳头稍淡)4 只眼;无效 14 只眼;总有效率 67%[辽宁中医杂志,1992,(2):23]。

李志英用中西医结合治疗急性视神经炎 27 例,年龄 18~57 岁。①早期口服加味桃红四物汤,桃仁 10g,红花 10g,生地黄 15g,赤芍 15g,川芎 10g,当归 10g,柴胡 10g,栀子 10g,田七末(冲)3g,丹参 15g,连翘 15g;视网膜水肿加木通、车前子、茯苓;眼痛加白蒺藜、郁金;盘周出血加侧柏叶、荆芥炭;②川芎嗪 160mg 加入 5%葡萄糖注射液 250ml 中静脉滴注,每天 1 次;③口服泼尼松,总量一般 $\leq 450\text{mg}$,根据病情渐递减量,每日 1 次,晨服;④同时服肌苷、维生素类药物;⑤中期继续口服中药,在活血祛瘀基础上兼用黄芪、党参等益气之品;⑥恢复期用杞菊地黄丸、补中益气丸,每日 2 次,每次 15g。结果 27 例 36 只眼中治愈(视力恢复至 1.0 以上,视乳头充血消失,视盘周围出血吸收,P-VEP、FFA、CSF 及视野检查均正常)12 例 16 只眼;显效(视力和眼底检查同治愈标准,P-VEP、CSF、FFA 及视野检查中 2 项以上恢复)6 例 10 只眼,有效(视力提高,但未达到 1.0,以上各项检查指标均有程度不同的改善)7 例 8 只眼,无效 2 例 2 只眼;总有效率 94.44%。治疗时间最短者 12 天,最长者 52 天[中国中医眼科杂志,1995,(3):149]。

孟秀阁等用中西医结合治疗视神经炎 25 例 34 只眼,年龄 14~48 岁;急性球后视神经炎 14 例 20 只眼,慢性球后视神经炎 3 例 4 只眼,视神经网膜炎 8 例 10 只眼;病程最短者 7 天,最长 45 天;中医辨证属肝火亢盛型 14 只眼用龙胆泻肝汤加减;气滞血瘀型 12 只眼用丹桅逍遥散加减;阴虚火旺型 7

例用知柏地黄汤加减。同时配合针刺(睛明、球后、攒竹、太阳、风池、合谷、内关、太冲、足三里、百会。每次选用4~5穴,强刺)和西药(急性视神经炎给予地塞米松注射液3~5mg,球后注射2~3天,配合抗生素及维生素类药物治疗)。结果治愈(视力达1.0以上,视野恢复正常,视乳头及视网膜无明显异常,或P₁₀₀波潜时及振幅均在正常范围内)27只眼;显效(视力提高4~6行,视野正常或暗点缩小,视乳头及视网膜无明显异常,或P₁₀₀波潜时缩短振幅升高)4只眼,有效(视力提高1~3行,视野留有暗点或向心缩小,视乳头正常或色淡或边界模糊)2例;无效1例;总有效率97%。其中肝火亢盛型14只眼中治愈12只眼,显效2只眼;气滞血瘀型12只眼中治愈10只眼,有效2只眼;阴虚火旺型8只眼中治愈5只眼,显效2只眼,无效1只眼;病程最短7天,最长45天[中国中医眼科杂志,1995,(4):209]。

彭清华从肝论治球后视神经炎45例,年龄5~47岁;单眼发病17例,双眼发病28例;病程最短4天,最长4年半,1个月内23只眼,1~3月者18只眼,3个月以上32只眼;中急性32只眼,亚急性13只眼,慢性28只眼;合并早期视神经炎萎缩23只眼,陈旧性中心浆液性视网膜病变4只眼,屈光不平27只眼。辨证属于气滞型36例58只眼,用逍遥散加减,治愈29只眼,显效4只眼,好转20只眼,无效5只眼;肝郁血瘀型5例8只眼,用血逐瘀汤加减,治愈4只眼,显效1只眼,好转2只眼,无效1只眼;肝郁阴虚型4例7只眼,用舒肝解郁益阴汤(柴胡、当归、生地黄、白芍、茯苓、白术、枸杞、桑椹、女贞子、旱莲草、石斛、甘草),治愈3只眼,显效1只眼,好转1只眼,无效2只眼。服药最短12天,最长217天;总有效率89.1%[江苏中医,1991,(3):10]。

朱跃平用头针,取视区,即从枕骨粗隆尖端向两侧水平地

旁开 1cm,由此上引,使与头部前后正中线平行的 4cm 长的直线。病员正坐,术者选 26~30 号,长 1.5~2.5 寸毫针,持针使与病员头皮呈 30 度角,沿头皮快速进针。刺入帽状腱膜下层时,拇指与食指指掌关节不断伸屈,使针体来回快速旋转(200 次/min,每次左右各旋 2 转)。持续半至 1min 后,留针 5~10min,再重复捻转 2 次,即可起针。起针时如针下无沉紧感,可缓缓出针。起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻,以防出血。每日 1 次,15 次为 1 疗程。若需下 1 疗程治疗,宜间歇 3~5 天。治疗球后视神经炎 25 例,12 例视力 5.0~5.2,8 例 4.7~5.0,4 例 4.0~4.7,1 例无效[浙江中医杂志,1990,(7):324]。

潘纪华用耳穴,取肝、新眼点、眼,风热加耳尖,阳亢加肝阳,痛甚加神门等。方法:先用探针在所选穴区,探寻敏感压痛点,找到后画点为号。取 0.5cm 四方的胶布粘王不留行籽于正中,然后丸对点,准确的粘牢贴紧。嘱患者每穴每次按压 4min,每日按压 5 次。隔日换贴 1 次,双耳轮换贴压,10 次为 1 疗程。治疗期间停用一切药物及疗法。治疗急性视神经炎 22 例,结果痊愈 18 例,显效 3 例,有效 1 例(新中医,1990,(2):31)。

章淑华用丹栀逍遥散加减,处方:牡丹皮 10g,山栀 10g,柴胡 10g,茯苓 12g,白术 10g,当归 10g,白芍 10g,赤芍 10g,郁金 10g,生甘草 3g,车前子 10g,薏苡仁 15g,木通 6g。治疗急性视神经炎 21 例 30 只眼,其中视神经乳头炎 10 例,球后视神经炎 11 例,结果治愈 17 例 23 只眼,显效 2 例 3 只眼,有效 1 例 2 只眼,无效 1 例 2 只眼,总有效率 93.4%[南京中医药大学学报 1996,(5):45]。

【方名】 菊花明目饮。

上攻目系所致；治以菊花明目饮3剂。3月17日二诊，上述症状大减。检查视力右4.7，左4.6，眼底同前。守方继服6剂。3月24日三诊，视力右4.8，左4.7，头晕头痛已除。眼底：双视盘略红，边缘稍模糊，视网膜静脉轻度充盈。至此，风热之象基本得以控制。乃加当归尾增养血活血之力，守方继服18剂，视力逐步提高。4月24日来诊：诸症皆除。视力5.2(双)，眼底仅见视盘颞侧略淡，乃停药。

例二，李某，男，6岁。1981年7月6日来诊。主诉：两目突然视物不见6天，无任何不适。检查视力：光感可疑(双)，双瞳孔中度散大，强光照射收缩后即刻散开，眼压指试正常。眼底双视盘色红，边缘模糊，视盘周围有白色渗出物，水肿高起约2屈光度；视网膜动脉细，静脉扩张纡曲，黄斑部充血。舌质红，苔薄微黄，脉弦浮数。诊断：视神经炎(双)。给以菊花明目饮3剂，剂量酌减。7月9日复诊：查视力，指数/20cm(双)，眼底视盘水肿减轻。守方继服3剂，7月12日三诊：视力继续增加，瞳孔大小恢复正常，眼底视盘色红减轻。7月18日四诊：视力<4.0(双)，视盘色开始变淡，边界变清楚。此后，每三五天来诊1次，主方不变，随症加减，视力逐渐提高，至8月7日(即发病1个月后)检查视力：右4.5，左4.6；眼底：双视盘变苍白，边界清，生理凹陷消失，视网膜血管正常。守方继服，视力不断提高。至10月26日前后共治疗113天，视力达5.2(双)，但眼底视盘苍白始终未能改变。随访5年，视力正常。

【方名】 当归川芎方。

【组成】 当归15g，川芎6g，薄荷9g，甘草6g，天麻6g，菊花15g，连翘12g，枸杞子12g，白芷12g，密蒙花6g。

【来源】 乔炳杰，河北中医，1988；(2)：41。

【功效】 疏风清热，活血明目。

【适应证】 视神经炎。

【方药简析】 方中菊花、薄荷、连翘、白芷、天麻疏风清热；当归、川芎、枸杞子、密蒙花养血活血，通络明目；甘草调和诸药。气滞血淤者加桃仁、红花、牡丹皮；肝阳上亢者加钩藤、石决明、磁石；阴虚肺热者加黄芩、阿胶。同时结合球后三联针（2.5%醋酸泼尼松龙 0.5ml、庆大霉素 1 万 U、妥拉苏林 12.5mg）注射，4 次为 1 疗程，每周注射 1 次。乔氏用上法治疗 36 例视神经炎，男 14 例，女 22 例。单眼 31 例，双眼 5 例。最大年龄 64 岁，最小 8 岁，平均 42 岁，以 30~40 岁者最多。治疗前视力：无光感者 3 眼，手动~4.0 者 33 眼，4.3~4.6 者 5 眼，共计 41 只眼，治疗后视力 4.0 者 4 眼，4.3~4.6 者 20 眼，4.7~5.0 以上者 17 眼。

【病案举例】 例一，齐某，男，58 岁，1977 年 11 月 21 日初诊。1977 年 11 月 18 日凌晨骤发头痛、头晕、耳鸣，继而视物不清，加重 3 天后检查视力：右眼 1 尺手动，左眼 1 尺手动。外眼正常，眼底：双眼底视神经乳头充血，边缘不清，隆起约 0.5~1 屈光度，静脉弯曲怒张，动脉稍细，有轻度交叉压迫征。视乳头周围网膜有少量棉絮样及线状出血，其余大致正常。胸部透视阴性，血压 21.3/12kPa，血常规及血沉均正常，诊为双眼视神经乳头炎。处方：桃仁、红花、当归尾、菊花、赤芍、枸杞子各 15g，连翘、木贼、柴胡、蝉蜕、密蒙花、薄荷各 10g，天麻 5g 水煎服。服 15 剂后视力好转，检查视力：右眼 4.6，左眼 4.8，诸证皆减，视神经乳头水肿消失，渗出物吸收。带药 5 剂回家服用以巩固疗效。

例二，田某，男性，34 岁，双眼视物不清逐渐加重旬余，伴头晕头痛，耳鸣重听而入院。查体视力：右眼 4.0，左眼 4.3，均不能矫正，瞳孔光反应存在，双眼眼底乳头充血，轻度水肿，乳头周围反光增强，黄斑区网膜可见线状条纹。诊断为视神经乳

头炎。中医辨证：肝阳上扰，乱于目窍，则发暴盲。治宜平肝抑阳、养血明目，处方：石决明 30g，磁石 20g，钩藤 20g，菊花 15g，当归 10g，连翘 20g，密蒙花 10g，天麻 10g，甘草 5g，枸杞子 15g。三联针球后注射，每周 1 次。服 15 剂诸恙消失，双眼视力增至 5.0。药既奏效毋庸更方，再取 5 剂以善其后。

【方名】 清泄和络汤。

【组成】 菊花 6g，夏枯草 10g，紫花地丁 15g，蒲公英 15g，珍珠母 24g，决明子 12g，生地黄 12g，赤芍 10g，当归 10g，川芎 6g，车前子 15g，生甘草 3g。

【来源】 王彤云，南京中医药大学学报，1997，(1)：57。

【功效】 清泄和络。

【适应证】 视神经炎之肝火亢盛型。

【方药简析】 方中紫花地丁、蒲公英、菊花清泄肝胆火热；菊花、夏枯草、决明子清热明目；珍珠母平肝潜阳；四物汤滋阴养血，活血化淤通络；车前子利湿清热化痰；生甘草调和诸药。如视乳头充血明显，可酌加丹参 10g，红花 10g；视乳头、视网膜水肿明显者，酌加茯苓 10g，泽泻 10g。据中药药理研究，菊花、夏枯草、蒲公英、紫花地丁具有显著的解热、镇痛、消炎之功；而和血通络之赤芍、当归、川芎等具有降低毛细血管通透性，减少炎性渗出，改善微循环的作用。另外，方中的生地黄、生甘草亦有激素样作用。三者协同有利于眼底充血、水肿等炎性改变的吸收。方中的珍珠母、决明子、车前子、当归等药所含的微量元素及维生素 B₁ 等成分具有促进视神经和视网膜细胞的新陈代谢功能，有利于修复炎症后的损害。王氏用上方治疗视神经炎 15 例 21 只眼，年龄 21～62 岁，病程 3～90 天，中医辨证为肝火亢盛型。结果治愈 8 只眼，显效 5 只眼，有效 8 只眼，总有效率 85.7%。

【病案举例】 刘某,女,22岁,右眼视力突然下降20天,左眼视力突然下降17天,于1986年1月8日入院。患者20天前突感右眼视力下降,去该厂医务室就诊,未发现异常,故未予治疗。3天后左眼视力也突然下降,即去皖南医学院附属医院门诊,拟为“双眼急性视神经乳头炎”收住入院。用地塞米松、地巴唑、维生素B₁等治疗半月,效果不佳而出院,后经人介绍来本院眼科住院治疗。入院时双眼视物模糊,眼球胀痛,头昏,夜寐不安,口苦咽干,大小便自调,舌红,苔薄黄,脉弦数。既往史无特殊,惟平素情志抑郁。体检:神清,面色红润,发育正常,营养良好,形体偏胖,心肺正常,肝脾肋下未及。视力右2.0,左3.6,双外眼安静,屈光间质透明,眼底双侧视神经乳头充血,境界模糊,静脉充盈、迂曲,A:V=1:3,乳头周围网膜轻度水肿,黄斑区未见异常。视野检查:右眼不能测出,左眼显著向心性缩小。实验检查:白细胞计数 $15.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞计数 $8.9 \times 10^9/L$ 。中医暴盲,肝火亢盛型(视神经乳头类)。治拟清泄和络法,处方:珍珠母24g,决明子12g,菊花6g,夏枯草10g,蒲公英15g,紫花地丁15g,生地15g,赤芍10g,当归10g,枸杞子10g,车前子15g(煎),生甘草3g。1月31日(用药后第23天),视力左4.85,右4.3。此时双眼视物明显清晰,眼胀痛已瘥,头昏已除,夜寐安实,口不干苦,舌偏红,苔薄微黄,脉弦不数。眼底视乳头充血明显改善,境界增清,静脉略充盈,迂曲,视网膜后极部反光略强。视野右眼颞侧尚缩小,左眼基本正常。即以原方去蒲公英、紫花地丁,加丹参12g,益母草15g,继进7剂。2月7日(用药后第30天),视力左5.0,右4.8。此时双眼视物清楚,别无不适,舌淡红,苔薄白,脉细弦。眼底视乳头境界清晰,色泽如常,右眼静脉略充盈,不迂曲,A:V=2:3,视乳头周围网膜无水肿,视野基本正常,即以原方去生地、赤芍,加女贞子10g,党参10g,

2 三叉神经痛

三叉神经痛是面部三叉神经分布区域内反复发作的、短暂的、阵发性剧烈疼痛。其发病率为 35.1/10 万,40 岁以上女性多发,但青年亦有发病者。可分为原发性和继发性两大类,原发性三叉神经痛病因不明,多无明确的病理损害。但近来认为可能由于各种致伤因素破坏半月节或感觉根的髓鞘,使脱髓鞘的轴突与邻近无髓鞘纤维形成“短路”(又称伪突触),以致轻微的触觉刺激即可通过短路传入中枢,中枢传出的冲动也可通过短路再传入中枢,这些冲动达到一定总和时,即可激发半月节神经元而产生疼痛。继发性三叉神经痛有明确的病因,如桥脑或延髓肿瘤、转移瘤、脑膜炎、脑干梗死、多发性硬化、带状疱疹、蛛网膜炎等侵犯三叉神经的感觉根或髓内感觉核而引起疼痛,多伴有邻近结构的损害和三叉神经本身的功能丧失。本病主要表现是面部三叉神经一支或几支分布区内突发的电击、针刺、刀割、撕裂或灼烧样的剧烈疼痛。疼痛可长期固定在某一支,一般多在第Ⅰ、第Ⅱ支分布区发生,第Ⅰ支的发生率约为 5%。随病情进展可影响其他分支,甚至三支全部累及,亦可第Ⅰ、第Ⅱ支同时受累,多为单侧、极少双侧。疼痛以面颊、上颌、下颌或舌部最明显,尤以上唇外侧、鼻翼、颊部、口角、犬齿、舌等处最敏感,稍加触动即可发作疼痛(此为扳机点)。可伴有面部发红、皮肤温度增高、结膜充血、流泪、流涕、流涎等。严重者引起反射性面肌抽搐,口角牵向一侧(即痛性抽搐),洗面、刷牙、说话、咀嚼、吞咽、呵欠,喝热水、冷水均

花 12g,白芷 12g,赤芍 15g,细辛 10g,全蝎 10g)活血散瘀止痛;阴虚型用杞菊地黄丸加龟板 15g,细辛 10g,全蝎 10g,育阴潜阳熄风。共治疗本病 94 例,其中风塞型 30 例,治愈(疼痛完全消失,半年内无复发)25 例,显效(疼痛基本消失,偶有发作)2 例,有效(疼痛程度减轻,发作次数减少)2 例,无效 1 例;风热型 23 例,痊愈 18 例,显效 2 例,有效 1 例,无效 2 例;郁热型 27 例,痊愈 19 例,显效 3 例,有效 3 例,无效 2 例;淤血型 9 例,痊愈 7 例,显效 1 例,有效 1 例;阴虚型 5 例,痊愈 3 例,显效 1 例,无效 1 例;总共痊愈 72 例,显效 9 例,有效 7 例;总有效率 93.6%[陕西中医,1991,(2):67]。

闰国章用息痛饮(龙胆草 10g,地龙 30g,桃仁 10g,红花 10g,豨莶草 30g,煅磁石 30g,石决明 30g,全蝎 10g,蜈蚣 1~5 条,钩藤 30g,菊花 15g,天麻 12g),治疗三叉神经痛 168 例,男 54 例,女 114 例;年龄最小 17 岁,最大 62 岁;病程 3 个月以内 32 例,半年以内 57 例,1 年以内 42 例,3 年以内 20 例,3 年以上 17 例;一侧者 156 例,双侧者 12 例;第 I 支疼痛 14 例,第 II 支疼痛 67 例,第 III 支疼痛 45 例,I、II 支合并疼痛 6 例,II、III 支合并疼痛 33 例,3 支全疼痛 3 例。结果治疗 1 个月以内有效者 137 例,2 个月以内 28 例,2 个月以上者 3 例;临床痊愈 95 例,显效 48 例,有效 23 例,总有效率 98.8%[天津中医,1992,(5):9]。

马奎云等用阵痛片(猪苓 15g,茯苓 15g,泽泻 12g,白术 9g,桂枝 12g,木防己 9g,共制成 16 片),每次 8~9 片,每日 2 次,病情缓解后每天可改为 1 次,疼痛消失后宜巩固疗效再服 2 周。1 个疗程 4 周,重症可连用 2~4 个疗程,总量一般为 400~800 片,个别患者连服 4 个月,总量达 1200 片。治疗三叉神经痛 162 例,男 66 例,女 96 例。病程最短者半小时,最长者 32 年,平均 5 年,其中 129 例曾经卡马西平、苯妥英钠、普

鲁卡因及乙醇溶液封闭和手术等治疗无效或效果不佳。结果治愈(停药 10 天以上无疼痛发作者)63 例,显效(偶有疼痛,但很轻微,不影响生活及工作)41 例,好转(疼痛有缓解)45 例,无效(症状无明显变化)13 例,总有效率 92.1%[中西医结合杂志,1986,(2):111]。

王占玺用加味三黄泻汤(黄芩 10g,黄连 12g,大黄 6~12g,夏枯草 15g,连翘 15g,青橘叶 12g,板蓝根 12g,大青叶 15g,生石膏 45g,白芷 12g,蜈蚣 5 条,全蝎 3g)治愈三叉神经痛 8 例;用芎黄散加减(川芎 10g,生大黄(后下)12g,芒硝冲 10g,板蓝根 10g,金银花 18g,枳壳 6g,僵蚕 6g,全蝎 3g)治愈本病 2 例;用杞菊地黄丸加味(枸杞子 12g,菊花 12g,生地 12g,熟地 12g,生山药 12g,山茱萸或女贞子 12g,丹参 12g,茯神 12g,泽泻 12g,青橘叶 12g,白芷 12g)治愈 4 例;用细辛 3~10g,生石膏 15~60g,治疗本病 7 例,痊愈 6 例[中西医结合杂志,1982,(1):47]。

【方名】 芍防钩芎汤。

【组成】 芍药 30g,防风 20g,钩藤 30g,延胡索 10g,川芎 10g,天麻 6g,全蝎 6g,僵蚕 9g,蜈蚣 1 条,柏子仁 10g,炙甘草 10g。

【来源】 刘斌,河南中医,1995,(3):185。

【功效】 育阴潜阳熄风,活血理气止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 方中芍药重用育阴潜阳,濡养筋脉,缓急止痛;防风、钩藤、天麻、僵蚕平肝熄风;延胡索、川芎疏肝理气通络止痛;全蝎、僵蚕、蜈蚣解痉止痛;柏子仁安神养心以止痛;柏子仁、芍药、炙甘草监制风药燥性,调和诸药。刘氏用本方治疗三叉神经痛 11 例,均获良效。

【病案举例】 朱某,女,56岁。自诉左侧面部刀割样疼痛3年余,1日发作数次至十几次。入冬易发,吃饭、说话时容易诱发。曾到多家医院诊治,诊断为三叉神经痛,予苯妥英钠、舒乐安定、腺苷辅酶维生素B₁₂,消炎痛等效果不佳。来我科初诊时,患者表情痛苦,抑郁不乐,并言其多年来生活不顺意,某日清晨突发此症,3年来时轻时重,不堪其苦,予上方3剂嘱其煎服,3日后复诊,疼痛大减,后以本方为基础稍事增减,服10余剂而愈。

【方名】 芎膏汤。

【组成】 生石膏 15g,川芎 10g,半夏 6g,细辛 3g,白芷 10g,沉香 6g,白芍 15g,甘草 6g。

【来源】 阙淑华,甘肃中医学院学报,1995,(3):53。

【功效】 清热泻火,理气化痰。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 三叉神经痛多属实证,初病实证易愈,久病缠绵难已。其与痰、火关系密切,多由胃火熏蒸,痰热循足阳明经上攻头面;治当清热祛痰为主。方中生石膏为君,清胃中积热;辅以川芎、白芷、细辛疏风止痛;而川芎长于止痛,善治少阳经和厥阴经头痛。白芷善医阳明经头痛,细辛偏止少阴经头痛。痰因气滞而聚,凝阻络道,故佐以半夏降逆化痰;但化痰须辅以行气,其力方雄,故用沉香辛散,以行气降逆;白芍敛阴缓急止痛;甘草调和诸药,更相与白芍相伍,复增缓急止痛功效。若兼有风寒可加荆芥、防风;兼有风热可加薄荷、菊花;胃热盛,大便干结者加大黄、芒硝、黄连;如化热伤阴,症见口渴欲饮者,加生地、玄参、知母;久治不愈者酌加全蝎、桃仁、红花等。

【病案举例】 杨某,女,42岁,1986年9月就诊。1周前

左侧太阳穴处突发疼痛,继而牵引左侧牙痛,痛如锥刺,火灼,十分剧烈。时发时止,因疼痛4昼夜未能入眠。除疼痛外兼见头晕恶心,大便干结,小便短赤。曾用大剂量镇静止痛药无效。查体:舌质红、苔黄腻、脉弦数。诊断:三叉神经痛。中医辨证,乃阳明经胃热上攻,灼液作痰,痰热交阻于经络。治宜泻火清热,理气祛痰止痛。处方:生石膏15g,川芎10g,半夏6g,细辛3g,白芷10g,沉香6g,大黄(酒洗)10g,白芍15g,甘草6g;并嘱其勿食辛辣食物。服药后疼痛大为减轻,大便亦正常。但疼痛时有欲发之势,仍见舌质红,脉弦数,继守前方,去大黄,减生石膏为10g,加当归10g,炒白术10g,茯苓10g,以健脾祛湿,杜绝生痰之源,继服6剂疼痛痊愈。半年后随访知从未复发。

【方名】 镇痛汤。

【组成】 当归10g,川芎7.5g,僵蚕10g,牛膝6g,白芷10g,白芍15g,生地15g,细辛5g。

【来源】 尚艳华,吉林中医药,1991,(6):15。

【功效】 养血活血,通络止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 方中当归、生地、白芍养血活血;川芎、牛膝、当归活血通络;僵蚕、白芍、细辛缓急止痛。伴有风热者加菊花15g,荆芥10g,防风10g;肝阳上亢者加钩藤10g,天麻10g;寒凝经脉者加羌活10g,吴茱萸10g;心烦失眠者加酸枣仁20g,夜交藤20g,百合20g;痛剧者加珍珠母15g,天麻15g,丹参15g。尚艳华用本方治疗三叉神经痛32例,结果治愈(疼痛消失1年以上未复发者)12例,显效(剧痛明显缓解或疼痛基本消失达3个月者)18例;无效(疼痛无明显缓解,或疼痛虽有所减轻,但仍发作频繁者)2例。总有效率达

93.7%。

【病案举例】 张某,男,51岁,1987年11月30日初诊。患右侧头面部及同侧上唇、齿龈疼痛已6年,疼痛反复发作,逐年加重,近3个月因情绪波动,疼痛每日发作数次,顶墙顿足,难以忍受。精神萎靡,面色晦暗,舌红苔厚,脉弦。诊为三叉神经痛,用镇痛汤原方加天麻10g,珍珠母20g。服药6剂后疼痛减轻,发作次数减少,再予上方加钩藤10g,服6剂后,仅余右侧面部轻微疼痛。继服上方10剂,疼痛完全消失,随访1年未复发。

【方名】 三叉止痛汤。

【组成】 当归12g,夏枯草12g,白芷10g,细辛3g,钩藤15g,升麻6g。

【来源】 孔荣,新中医,1987,(3):35。

【功效】 养血活血,熄风止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 方中当归养血活血,通络止痛;钩藤、夏枯草、白芷、细辛平肝熄风,解痉止痛,升麻引药入头面部,更好发挥疗效。若合并高血压则重用夏枯草、钩藤,失眠钩藤加倍,症状减轻后,单用基本方加黄芪、党参,继续巩固2~3疗程,如两个疗程不减轻者作为无效。服中药期间,不用西药镇静止痛剂。孔荣用本方同时配合西药(维生素B₁20mg,每日3次;维生素B₁₂500~1000μg,每日1次肌肉注射,共用1~2周),治疗原发性三叉神经痛50例,其中男23例,女27例;年龄2~78岁,以40~60岁者居多,占70%;病程最短者23天,长者18年,经用其他疗法效果不佳者42人,未经治疗者8人;单侧发病49例,右侧27人,左侧22人,双侧1例;Ⅰ支病者25例,Ⅰ、Ⅱ支混合者23例,Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ支混合者2例。结果优

(疼痛完全消失)32例,良(疼痛明显减轻)17例,差1例;总有效率98%。

【病案举例】 例一,汪某某,男,65岁,患者右下颌突发性、放射性锐痛,张口与触及时疼痛加剧,间歇期短,持续数分钟,病史达18年之久,经长期治疗无效,于1981年11月2日来我院求治。口干唇燥,大便秘结,舌红、少苔,脉细数。诊断为原发性三叉神经痛(右Ⅱ支)。常规用维生素B₁、维生素B₁₂,按疗程服中药。继续用药3个疗程。1983年5月16日复查,偶尔有轻微疼痛,又服中药1疗程,疼痛消失,至今未复发。

例二,代某某,女,58岁。患者右上下颌痛4~5年,呈阵发性剧痛,近2年来加重,发作频繁,呈闪电、刀割样疼痛,吃饭、洗脸、讲话时尤甚,持续数分钟,伴有咽干、口渴、大便干,舌红、苔黄,脉弦数。诊断:原发性三叉神经痛(右Ⅰ、Ⅱ支),经服三叉止痛汤合清胃散化裁。常规用维生素B₁、维生素B₁₂,1疗程后疼痛明显好转,连服中药2个疗程,疼痛完全消失,又巩固治疗1个月,未再复发,追踪4年零7个月至今未患。

【方名】 柔肝解痉汤。

【组成】 白芍30~60g,全蝎6~10g,蜈蚣3条,川芎30g,炙甘草15g。

【来源】 刑萍,新中医,1992,(8):16。

【功效】 养血柔肝,熄风止痉。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 三叉神经痛多由情感内伤,肝失调达,郁而化火,上扰清窍,或肝阴亏虚,筋脉失养,肝风内动而致,本虚标实为本病病机,故以养血柔肝、熄风止痉为治疗大法,重用白芍养血柔肝、缓急止痛;全蝎、蜈蚣熄风解痉,通络止痛;因

【方名】 菊花茶调撮风散。

【组成】 菊花 12g,川芎 24g,白芷 9g,细辛 5g,蜈蚣 3g,全蝎 9g,僵蚕 9g,钩藤 30g,白芍 12g,甘草 6g。

【来源】 刘红军,山东中医杂志,1992,(2):32。

【功效】 宣散外邪,解痉止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 本方是由菊花茶调散与撮风散加减而成,前者治疗重症头痛,后者专治小儿撮口风、惊风。方中菊花、川芎、白芷、细辛,清散祛风止痛;蜈蚣、全蝎、僵蚕、钩藤,镇痉通络止痛;尤其是川芎具有补血润燥、行气搜风之长,故对各型疼痛皆有治疗作用,因此用量较大。为避免以上药物的辛窜耗散之偏,故加入白芍、甘草,二者既能养阴又能和解诸药,以制其弊。对剧烈疼痛并伴有心中烦躁不安,舌尖红者,酌加牡丹皮、栀子以清心经之热。若因阵痛频繁影响睡眠者,则重用蝉蜕解痉镇静,或兼用塞鼻法以助汤药之力。刘氏用本方配合蝎蝎散(全蝎 60g,蜈蚣 5 条,共为细末,平均分为 20 包。用于患病较久、疼痛剧烈者,与汤剂并用,每日 2 次,每次 1 包。服汤剂有困难或疼痛停止者,可用该散剂以巩固疗效。)及鼻塞药(冰片 1.5g,川芎 3g,白芷 3g,川乌 3g,细辛 3g。共为细末,瓶装密封备用。另外备花生粒大小的泡沫海绵多块。使用鼻塞药时,取泡沫海绵 1 小块,蘸取适量鼻塞药粉,塞入病变对侧鼻孔即可。每日 2 次,每次塞药 3~4h)治疗三叉神经痛 39 例,其中男 13 例,女 26 例;年龄最小 33 岁,最大 82 岁,平均 53 岁。发病时间最短 1 周,最长 20 余年。疼痛部位左侧 17 例,其中受累神经支:Ⅰ支 6 例,Ⅱ支 8 例,Ⅰ、Ⅱ支共同受累 3 例;右侧 22 例,其中受累神经支:Ⅰ支 8 例,Ⅱ支 10 例,Ⅰ、Ⅱ支共同受累 4 例。结果显效(经治疗后疼痛消失,随访半年

以上未复发者)12例;良好(经治疗后剧痛消失,但尚有轻微的发作性疼痛)16例;改善(疼痛减轻,发作次数减少,间隔时间延长)11例。服药最少者9例,最多35例,平均用16剂。

【病案举例】 张某,男,57岁,1987年8月20日初诊。右侧牙龈及右侧面部皮肤呈刀割样剧痛半年。开始发病时每日疼痛发作5~6次,近日加重,每日8~10次。常因洗脸、刷牙、张口等诱发疼痛,屡用镇静止痛药,局部封闭等法均无明显效果。诊断:右三叉神经痛(Ⅲ支)。因惧怕手术,改用中药治疗,投菊花茶调散合撮风散加减:菊花12g,白芷9g,细辛5g,僵蚕9g,全蝎9g,蜈蚣2条,钩藤30g(后入),白芍12g,甘草6g,蝉蜕30g。水煎服,每日1剂,同时用塞鼻药。8月23日二诊:服药3剂,疼痛明显减轻,但觉身倦神疲、嗜睡。原方去蝉蜕,又进3剂后,精神大振,疼痛消失;停塞鼻药。为防复发,上方又进10剂。8个月后随访,未复发。

【方名】 散偏汤。

【组成】 川芎30g,白芷8g,白芥子10g,白芍12g,香附10g,郁李仁12g、柴胡12g,甘草5g。

【来源】 《辨证录》。

【功效】 理气活血,通络止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 方中川芎行气开郁,活血止痛,为镇痛药;柴胡、香附、白芥子理气涤痰消饮,散结和解;白芍、郁李仁、甘草柔润缓急。诸药合用,可使气血通畅无阻,而达到通则不痛的目的。刘康平用本方治疗三叉神经下颌支痛13例,服药1疗程(6天为1疗程)痊愈者5例,服药2疗程痊愈者5例,服药3疗程痊愈者2例,服药3疗程后无效者1例,总有效率92%。

【病案举例】 高某某,48岁,1982年7月15日就诊。因发作左下颌痛伴牙龈根部痛1年余,疼痛伴口角及舌抽向患侧。1年内曾拔牙3次,将左侧臼齿全部拔掉,但疼痛不解,发作更频。经用西药去痛片、消炎痛、普鲁卡因等,药效过后疼痛依然。诊为三叉神经下颌支痛。按上法服药3剂,疼痛缓解,续进3剂而愈。随访1年,未复发[浙江中医杂志,1986,(1):18]。

【方名】 白乌膏。

【组成】 生川乌 15g,生草乌 15g,白芷 15g,黄丹 100g
香油 100g。

【来源】 尚兴彦,新中医,1980,(2):36。

【功效】 温散止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 生川乌、生草乌通血脉,搜风止痛;白芷行气散血,祛风止痛;黄丹又叫铅丹,有清热拔毒作用,是制作膏药中重要成分,在高热油脂中对油脂之聚合起催化作用;香油甘微寒,缓解疼痛,是铅丹膏的主要溶剂与赋型剂,为调制膏药的重要材料。将上药用香油浸泡24h,然后文火煎药,炸焦去渣,在油中徐徐加入黄丹成膏状,再将药倒入冷水浸24h(去火毒)备用。亦可将上药煎成汤剂,加水200ml,煎至60~80ml盛瓶中备用。用法:发作频繁、痛剧烈者,将中药汤剂用纱布折叠数层湿敷患处,一般1~2天疼痛可减轻。继将膏剂少许加热摊在纱布块上(依疼痛部位剪成圆形或长条)贴在患处,每5日换药1次。方中生川乌、生草乌、白芷镇静镇痛、止痛和麻醉作用通过香油的渗透对末梢神经麻醉而起到止痛效果。个别入若遗留蚁走感,可在膏中加入麝香。另外由于膏药熬制需要一定的技术,火候难以掌握,老嫩不易控制,故可将

上药研为细末,加入清凉油内外涂,以代替膏药外贴,也可获得满意效果。

【病案举例】 李某某,男,51岁。1974年秋,右侧面部阵发性闪电样刀割似剧痛,在我院门诊确诊为三叉神经痛,经用维生素 B₁₂、654-2 肌注,口服苯妥英钠及止痛镇静药等无效,曾转西安市某医院神经科作无水酒精注射,稍有好转,1年后复发,再去北京某医院手术治疗,1年后又复发。由于患者对手术恐惧,拒绝再次手术,我们即用中药汤剂湿敷2天痛减,后改用白乌膏外贴,1年余未复发。

【方名】 芍甘全蝎汤。

【组成】 白芍 30g,炙甘草 15g,全蝎(冲)6g。

【来源】 马子知,河北中医,1991,(6):7。

【功效】 活血化淤,缓急止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 方中用芍药、甘草,缓急止痛,全蝎熄风止痉。热者加生石膏、天花粉;淤者加川芎、红花;抽搐加钩藤、蜈蚣;侵犯上颌支加柴胡、黄芩;下颌支加葛根、白芷;病久疼剧加制马钱子粉 0.3g,连续服药,疼痛缓解后,再服3剂。马氏用本方治疗三叉神经痛46例,其中男14例,女32例;年龄26~40岁4例,40~50岁24例,50~63岁8例。结果治愈(连续服药疼痛止后,未见复发者)18例,显效(连续服药,疼痛止后,偶有复发,但病情轻缓,服原药3天内疼痛消失者)16例,有效(连续服药,疼痛减轻,每周发作不超过2次者)8例,无效(连续服药6剂,症状无明显改善者)4例。治疗结果表明,患三叉神经痛,年龄越大,疗效越差;年龄越小,疗效越好。病程长,疗效差,病程短,疗效好。单独侵犯某支与同时侵犯2支、3支的病人,疗效差别不明显。

【病案举例】 袁某,男,52岁,1987年3月13日诊。患者右侧面部阵发性电击样疼痛3年。疼痛逐渐加重,频繁发作,舌色淡黯,脉沉细。诊断为三叉神经痛(上、下颌支)投芍甘全蝎汤加味:白芍30g,赤芍30g,炙甘草15g,全蝎6g,钩藤12g,蜈蚣2条,菊花10g。3剂痛减,6剂而安,又服3剂,随访2年,未复发。

【方名】 温经止痛汤。

【组成】 麻黄10g、黄芪20g、白芍30g、乌头10g、甘草15g、细辛6g、桂枝10g、蜂蜜20g。

【来源】 宋瑞霞,河北中医,1993,(6):16。

【功能】 温经散寒,祛风止痛。

【适应证】 三叉神经痛。

【方药简析】 本方是宋氏在《金匱要略》乌头汤基础上加减化裁而成,用于寒为本,热为标的三叉神经痛。方中乌头驱寒温经,白芍、甘草开血痹以通经脉,使其阴阳宣通而气血畅行;麻黄发汗力猛,用黄芪固表;乌头有毒,用白蜜甘以缓之。使寒湿之邪微微汗出而解,邪去而正不伤,达到通阳行痹之目的;细辛、桂枝以增祛风散寒,止痛通络之力。细辛之用量要逐渐递增,最多可用至20g。疼痛剧烈难忍者加蜈蚣5条、全蝎4g、葛根20g;肺胃有火者加石膏24g、栀子10g、大黄6g。使用本方时,先将其加水500ml,文火煎至300ml,纳入蜂蜜再煎,煮取200ml,每服100ml,日2次,10天为1疗程。宋氏用上方治疗三叉神经痛33例,男10例,女23例;34~44岁7例,45~55岁16例,56~77岁10例;病程最长者5年,最短者5个月。结果治愈13例,其中1个疗程治愈者2例,2个疗程治愈者6例,3个疗程治愈者5例;显效10例;好转7例;无效3例。总有效率为91%。疗程最短7天,最长30天,平均22.9

天。

【病案举例】 唐某,女,27岁,1985年4月3日初诊。因2年前外出冒受雨淋,即感左侧面颊部阵发性、如刀割样、烧灼样疼痛,痛不可忍,数分钟后自行缓解,每于进食、刷牙、漱口、洗脸时疼痛加剧,每日约10~20次不等。曾多次求治,经针灸、中药、封闭等治疗效果不佳,唯服卡马西平可暂时缓解,其病一直未愈。检查时,触及面部扳机点,引起发作,舌质淡红,苔薄白,脉弦。诊为三叉神经痛,中医辨证属风寒,治以温经止痛汤加味:麻黄10g,黄芪20g,白芍30g,乌头10g,甘草15g,细辛6g,桂枝10g,全蝎4g,蜈蚣5条,蜂蜜20g。共服20剂而愈,随访5年,未复发。

3 面神经炎

面神经炎是指由面神经管段面神经的非化脓性炎症所致的一种特发性周围性面瘫,又叫贝尔(Bell)麻痹,通称面神经麻痹。为神经内科常见病,发病率为425.7/10万。本病确切病因不明,可能是茎乳突孔内的面神经经急性病毒感染和水肿所致神经受压或局部血液循环障碍而产生面神经麻痹。部分患者可有受冷风侵袭或急性鼻咽感染的病史。近年来也有认为可能是一种免疫反应。面神经炎可见于任何年龄,但以20~40岁青壮年最为多见,男性略多。起病急骤,多于晨起洗漱时或进食时突然发现或被人发现,1~2天可达高峰。主要表现为一侧面部所有表情肌瘫痪,如额纹消失,闭眼、皱额和蹙眉不能,用力闭眼时,眼裂闭合不全,眼球转向外上方露出白色巩膜,此称为贝尔现象。患侧鼻唇沟变浅,口角下垂,嘴歪向健侧,鼓气时患侧嘴角漏气,食物常易滞留于患侧颊龈沟内,茎乳孔区有自发性疼痛及压痛。由于病变波及部位的不同,其临床附加症状亦不同;病变自茎乳孔向近端波及鼓索神经时,可出现舌前2/3味觉障碍;涉及镫骨肌支时,可有听觉过敏;若面神经膝状神经节受带状疱疹病毒感染时,除上述所有症状外,还可见外耳道疼痛或感觉迟钝和疱疹,此称亨特(Hunt)综合征。

本病一般于病后2周开始恢复,大多数约75%的病人于1~3个月内好转康复,6个月以上无恢复迹象则预后较差,可遗留麻痹,面肌痉挛和挛缩(眼裂变小,鼻唇沟加深,嘴歪向患

侧,但嘴部作主动运动时仍歪向健侧)。如有再生错位出现支配交错现象,闭眼时同侧口角上提,闭嘴时同侧眼轮匝肌收缩,称联带运动;嘴嚼食物时,同侧颞部分泌大量汗液,几分钟内即刻看到汗珠滴下,称耳颞综合征;嘴嚼食时同侧眼流泪,称鳄鱼泪征。肌电图检查可提供预后估计。根据本病的起病形式和临床特点及病前受寒史,即可诊断。但需与中枢性面瘫,急性感染性多发性神经炎、耳源性(中耳炎、迷路炎、乳突炎可并发)面神经炎、颅后窝的桥脑角肿瘤、颅底脑膜炎、转移性癌肿等引起的周围性面瘫相鉴别。在急性期应尽早改善局部血液循环,消除面神经管内的神经水肿和炎症,兼以促进神经功能的恢复。常选用激素,扩张血管药,利尿药物及大量B族维生素;恢复期营养神经,促进代谢,增强神经功能,对症处理,预防和减少后遗症。必要时考虑手术,同时配合理疗、针灸,促进神经功能恢复。

面神经炎属于中医“口僻”、“中风”的范畴。本病多因正气不足,络脉空虚,风邪侵犯面部经络,经气不利,气血痹阻,肌肤筋脉失于濡养,以致出现口眼歪邪之症。病初邪盛,多属实证,治宜祛邪为主;散风解毒,通经活络。后期当宜扶正祛邪,调其阴阳,补其气血,扶助正气。临床多分为风寒阻络型用大秦艽汤加减,风热郁闭型用普济消毒饮加减,肝肾阴虚型用杞菊地黄丸加减,气血亏虚型用补阳还五汤加减。针灸也是治疗本病最有效的方法之一,一般在发病后5~6天开始治疗,可选用体针、电针、水针、拔罐等,连续30~40天,直至痊愈。

闻建民用冰芥膏(冰片2g、白芥子3g共研细末,加浓茶水适量调糊,摊于敷料上,贴于患侧面部;敷药后若局部皮肤疼痛较剧则应停用)外敷治疗面神经炎取得较好效果[浙江中医杂志,1992,(1):70]。

陈安辉用面麻膏,马钱子粉1g,樟脑粉0.3g,膏药脂4g,

将以上药物加热调匀后涂于 7cm×7cm 膏药布备用。同时将膏药烘软后贴在患侧耳垂前面神经干区域,4 天换药 1 次,此间停用其他方法。治疗面神经麻痹 100 例,少则 1 张(4 天),多则 8 张(32 天),结果治愈 98 例,好转 2 例。57 例随访 1~4 年,未见复发。除个别患者贴药后出现局部瘙痒感外,无任何不良反应[江苏中医,1988,(6):31]。

曾广盛等用巴豆穴位熏治法,取去壳巴豆 4~8 粒,投入 50°白酒 250g,置火上煮沸后,将白酒盛于小口瓶中,乘热熏健侧劳宫穴(即左病取右,右病取左)约 20min,每日 1 次,10 次为 1 疗程。在治疗期间,一般有轻度腹泻,或局部脱皮现象。但毋须作其他处理。治疗病程 1 天至 8 年的颜面神经麻痹 42 例,其中 16 痊愈,10 例好转,6 例有效,10 例无效。通常治愈的时间为 6~25 天,疗效与病情、病程有关[浙江中医杂志,1980,(2):86]。

郭莉仙等用马钱子外贴面部穴位,方法是马钱子在治疗前 1 天浸泡在少许温水中,用时取出以刀横切成两瓣,然后把切面贴于太阳穴和下关穴位上,再用胶布将其全部覆盖固定,隔日换药 1 次。换药 3~4 次后患侧眼裂闭合好转时,加贴颊车穴,太阳穴和下关穴则改为隔日交替贴药。治疗周围性面神经麻痹 45 例,男 19 例,女 26 例;发病就诊时间 1~40 天,平均 8 天。结果贴药 8~10 次治愈者 40 例,14~16 次治愈者 5 例,治愈率 100%[中西医结合杂志,1992,(12):51]。

高希斋用斑蝥和巴豆敷贴,方法是斑蝥 1.5g、巴豆仁 1.5g,共研细粉,蜂蜜调成稠粘状;取边长 5~6cm 的方纱布 4 层,将调好的药物均匀地涂在纱布上,涂布直径约 2~3cm,敷贴于病侧下关、颊车二穴连线中点略前方,胶布固定。贴药后 2~3h 局部有灼热感,揭开纱布一角,如见皮肤潮红,似要起疱时即取,隔 7 天 1 次。治疗面神经炎 80 例,结果治愈 78 例,

薄庆用口腔粘膜放血(选择患侧口腔颊膜处的麻痹区,怒张的静脉血管,阳性反应物如条索状团块状物等。操作步骤:手术刀消毒后,在上述部位割划出血,斜切口,深0.1~0.3cm,长1~1.5cm,每次割2~3处,出血量以3~5ml为宜。每隔3日放血1次,6次为1疗程;间隔5天,再进行第2疗程的治疗)治疗周围性面瘫72例,痊愈(症状完全消失,功能恢复,外观正常)54例,有效(症状基本消失,说笑时口角稍有歪斜)17例,无效(症状无明显改善)1例,总有效率98.6%[四川中医,1994,(2):29]。

刘瑞祥用补中益气汤加味(生黄芪15g,党参10g,当归10g,陈皮9g,升麻6g,柴胡6g,白术12g,甘草6g,枳壳15g,防风9g,全蝎3g)治疗1例面神经麻痹,服15剂而愈[内蒙古中医药,1987,(2):封三]。

缪娟用疏风汤(全蝎、蜈蚣各3g,僵蚕12g,制白附子、南星、桑叶各10g,白蒺藜6g,白芍15g,生地黄20g,川芎、薄荷各6g,钩藤15g,牡丹皮10g,荆芥、防风各6g,黄芩10g,细辛3g,羌活9g,甘草5g)治愈面瘫3例[江苏中医,1983,(5):52]。

【方名】 洋白附子通窍活血汤。

【组成】 洋白附子60g,赤药12g,川芎12g,桃仁9g,红花6g,羌活12g,白芷12g,防风18g,生地24g,蜈蚣(酒洗焙干研粉,分3次吞服)5条,甘草6g。

【来源】 谢存柱,中医杂志,1987,(12):42。

【功效】 祛风化痰,活血通窍。

【适应证】 面神经麻痹。

【方药简析】 本方是白附子与通窍活血汤加减组合而成。方中洋白附子(即天南星科独角莲),善祛头面风痰;配羌

活、白芷、防风、蜈蚣疏散头面部风邪；赤芍、川芎、桃仁、红花活血化淤通窍；甘草为使调和诸药。本病初期若兼风寒者加麻黄 10g，细辛 4g；兼风热者加桑叶 10g，薄荷 10g；后期兼气虚者加黄芪 30g，党参 24g；血虚者加当归 15g，白芍 15g；病久不愈，风痰恋络者加天麻 12g，礞石 20g；其他驱风通络之品，钩藤、地龙、僵蚕、全蝎、白花蛇舌草、胆南星、川乌等均随证选用。谢氏用本方治疗周围性面神经麻痹 52 例，右侧麻痹者 28 例，左侧麻痹者 24 例；病程最短者 2 天，最长者 1 年；有外伤史（颅底骨折）者 2 例；单独中药治疗 46 例，配合针刺治疗 6 例。结果治愈（面肌功能恢复正常）50 例，显效（眼睑闭合正常，留有口角轻度歪斜，喜笑时方可觉察，静止时不明显）2 例；治愈时间最短者 2 天，最长者 35 天，多数患者在接受治疗 20 天左右获愈。其病程短者见效快，疗效好；病程长超过 2 个月者，见效慢，疗效差；病程在 20～30 天以内者，一般疗效均好；而疗程与年龄、性别并无明显差别。6 例配合针刺者的疗效与单独服中医者疗效、疗程无显著差异。

【病案举例】 丁某某，女，36 岁，1976 年 11 月 15 日初诊。患者出现左侧口眼歪斜 1 周，左侧前额皱纹及鼻唇沟消失，左眼不能闭合，目赤涩流泪，面肌松弛，不能鼓腮噉嘴，时流口水，舌淡红、苔薄黄，脉略浮。诊为周围性面神经麻痹，辨证属风中经络，血行不畅，脉络淤阻，伴微感风热犯目。法当活血祛淤，祛风通络，少佐疏散风热之品。拟洋白附子通窍活血汤加桑叶 10g，薄荷 10g，连翘 15g。服药 2 剂后，鼻唇沟渐清楚，闭目时眼裂逐渐缩小，巩膜充血变淡，流泪停止，薄黄苔已退，脉转沉。上方去桑叶、薄荷、连翘，加麻黄 9g，细辛 6g，桂枝 10g。续服 4 剂后，左目能闭合且有力，鼻唇沟复常，口眼歪斜等症已无，双侧面肌活动基本一致，经多年观察效果良好。

【方名】 加味牵正散。

【组成】 黄芪 100g, 当归 15g, 白附子 10g, 白僵蚕 10g, 全蝎 10g。

【来源】 郭云露, 浙江中医杂志, 1983, (9): 422。

【功效】 益气祛风痰, 通络止痉挛。

【适应证】 面神经麻痹。

【方药简析】 方中重用黄芪益气补虚, 推动血行, 扶正祛邪; 当归活血通络; 牵正散使歪邪之肌肉恢复常位。若肝肾阴不足, 肝阳上亢加石决明、天麻、枸杞子、石斛; 脾运失司, 内生痰浊加制胆南星、浙贝母; 头痛加川芎、夏枯草; 多梦失眠加珍珠母、龙齿、酸枣仁; 若肝阳上亢, 血压超过 24/133kPa 以上者, 黄芪改为 20g。郭氏用上方(水煎滤汁后加白酒 10ml, 1 天分 3 次服完)配合穴位注射(维生素 B₁₂ 1mg, 呋喃硫胺 20mg, 混合注射病侧, 每 3 个穴位 1 组, 两组交替注射, 4 天为 1 疗程; 颊车、翳风、地仓为 1 组, 下关、头维、迎香为 1 组)治面神经麻痹 101 例, 痊愈 50 例, 显效 46 例, 好转 3 例, 无效 2 例; 总有效率 98%。疗程 7~31 天, 平均 12 天。

【病案举例】 郭某某, 男, 40 岁, 1970 年 2 月 16 日入院。2 月 8 日上午突然语言蹇涩不利, 经治疗无效。证见面色少华, 头晕耳鸣。左眼不能闭, 口向右歪, 时流涎, 舌淡、苔薄白, 脉虚大。诊断: 面神经麻痹。内服加味牵正散, 穴位注射颊车、翳风、地仓; 2 天后, 诸症大减, 语言清晰, 左眼能睁闭, 口歪不显, 惟笑时才现。前后共服 6 剂, 局封 1 次, 痊愈。随访至今无复发。

【方名】 补血祛风牵正饮。

【组成】 白附子 15g, 黄芪 30g, 丹参 30g, 当归 30g, 川芎 15g, 羌活 9g, 钩藤 15g, 防风 9g, 白芍 9g, 僵蚕 9g, 全蝎 5g, 甘

草 5g。

【来源】 刘宏年,河南中医,1995,(3):166。

【功效】 养血活血,祛风止痉。

【适应证】 面瘫。

【方药简析】 方中黄芪、当归、川芎、白芍、丹参益气养血,活血通络;白附子、僵蚕、全蝎、羌活、钩藤、防风祛风化痰止痉;甘草调和诸药。若面部肌肉麻木,或面部发痒或蚁行感者加蝉蜕、地肤子、白鲜皮;目干涩,耳道疼痛加菊花、龙胆草、石斛、玉竹;鼻腔灼热,牙床肿痛加生石膏、栀子、黄连。刘氏用上方治疗面瘫 26 例,男 9 例,女 17 例;年龄 19 岁 1 例,21~30 岁 5 例,31~40 岁 9 例,41 岁以上 11 例;病程 1 周以内者 6 例,半月以内者 4 例;左侧面瘫 18 例,右侧面瘫 8 例。结果治愈 24 例,显效 2 例,有效率 100%。

【病案举例】 熊某,女,48 岁,农民,1994 年 12 月 17 日初诊。3 天前夜间突然醒后自感面部抽紧,起床后出现右眼不能闭合,口眼歪斜,虽经医治未见效果。诊见嘴角向左歪斜,右眼流泪,右眼大,右额纹消失,人中偏倾左侧,左嘴角上提,右嘴角下吊,吐字不清,右侧口角漏水、漏饭,皱眉,露齿困难。闭嘴鼓腮、吹气均不能,右侧面部麻木,触觉不敏感,口淡无味,目干涩,鼻腔及眼均有灼热感。诊断:面神经麻痹,中医辨证为风邪中络,治宜祛风散寒通络,益气补血和营。方用补血祛风牵正饮加龙胆草 15g,菊花 15g,生石膏 30g,石斛 15g,玉竹 15g。服药 6 剂后面部麻木消失,额纹呈现,口角漏水漏饭已止,鼻腔及眼灼热悉愈,唯见发笑时人中及嘴角轻微歪斜。按基本方加蜈蚣 2 条,服用 8 剂后症状完全消失,面肌功能恢复正常。追访至今无复发。

【方名】 强直牵正复元汤。

【组成】羌活 15g, 防风 18g, 当归 15g, 川芎 18g, 天麻 10g, 细辛 10g, 白附子 10g, 黄芪 45g, 桃仁 10g, 红花 10g, 僵蚕 10g, 蜈蚣 3 条(冲), 全蝎 6g(冲), 生棕叶 30g。

【来源】张兆云, 甘肃中医, 1994, (1): 21。

【功效】祛风养血, 通经活络, 祛痛。

【适应证】面神经麻痹。

【方药简析】本方是由强神汤、省风汤、牵正散、补阳还五汤加减而成。方中羌活、防风、细辛、天麻疏散风邪; 当归、川芎、红花、桃仁、黄芪益气养血, 活血通络; 白附子、僵蚕、全蝎、蜈蚣化痰去风, 通经解痉。发病初期加荆芥、白芷; 风邪偏盛加川乌; 痰盛加姜半夏、天南星; 气血双亏加重黄芪、当归; 气机淤滞加丹参、血竭、青皮; 头痛甚加重川芎; 高血压加钩藤、地龙、菊花; 病后期加红参。张氏用上方治疗面神经麻痹 154 例, 年龄 5~75 岁; 病程 3 天~1 年以上; 用药时间 15~30 天; 除 2 例外, 其余 152 例均获痊愈。

【病案举例】王某, 男, 49 岁, 于 1990 年 5 月 10 日初诊。主诉: 口眼歪斜 2 月余。2 月前, 晨起突觉颜面麻木不仁, 中午时突感口眼歪斜, 口向左斜, 食入即由口角漏出, 流涎涎, 眼睑不能闭合, 住局医院内科治疗, 诊为“面瘫”, 经输液服药、针灸, 外用黄鳝血敷患侧, 治疗 2 月余疗效不显, 邀余门诊。目睑不合, 流泪, 尤其在说话或笑时歪斜明显, 右额及患侧麻木不仁, 舌淡红, 苔薄黄, 脉弦滑。诊断: 面神经麻痹, 遂拟强直牵正复元汤, 处方: 羌活 15g, 防风 18g, 天麻 10g, 白芷 10g, 白附子 10g(冲), 黄芪 30g, 赤芍 15g, 川芎 18g, 桃仁 10g, 红花 10g, 僵蚕 10g, 全蝎 6g(冲), 蜈蚣 3 条(冲), 生棕叶 30g。水煎服, 1 日 1 剂, 连服 7 剂。外用自制“整容复元膏”贴患侧, 每 3 日换药 1 次, 7 次后, 口、鼻、眼完全对称, 目睑闭合如常。再进补中益气汤加羌活 15g, 防风 20g, 白附子 10g, 细辛 10g。连

【功效】 疏风化痰、通经活络。

【适应证】 面神经麻痹。

【方药简析】 牵续汤是在《千金要方》小续命汤和《杨氏家藏方》牵正散二方的基础上化裁而成。单用小续命汤则欠缺化痰通络之品，单用牵正散则欠缺扶正解表之药，故取二方之长，疏风化痰，通经活络。方中麻黄、桂枝发汗解表；桂枝配白芍又能调和营卫；党参、白芍补益气血，以扶正祛邪；防风、羌活疏散外风；川芎香窜上行，能活血疏风止头痛；白附子祛头面之风；僵蚕祛络中之风，二药且能化痰；全蝎搜风定搐；蜈蚣祛风止痉；甘草健脾和中。若素有高血压病史或现有高血压者加钩藤、牛膝、去党参，减少麻桂的用量；有内热者去麻黄，减少桂枝之用量，再加黄芩；肝火旺者去麻黄、桂枝、党参，加龙胆草、菊花。姜氏用上方治疗 78 例面神经麻痹，治愈 53 例，显效 17 例，有效 5 例，无效 3 例；总有效率 96.2%，其中治愈时间，5 天以内者 5 例，10 天以内 27 例，15 天以内者 33 例，20 天内者 9 例，20 天以上者 1 例，平均 13.5 天。

【病案举例】 郑某某，男，45 岁，1970 年 11 月 3 日初诊。患者自述 4 天前始觉左侧面部发胀、麻木。于今晨起床后发现嘴角向右侧歪斜，左眼不能闭合，流泪；左侧面部麻木不仁，喝水时从左嘴角向外流，进食时左腮内存留食物。查体：鼻唇沟向右侧歪斜，左侧额纹消失，吹不响口哨，鼓腮不起。体质虚弱，舌淡苔薄白，脉浮紧。诊断：面神经麻痹，中医辨证为风寒外袭，邪滞经络所致。治宜扶正解表，通经活络。处方：麻黄 8g，桂枝 10g，白附子 6g，川芎 10g，党参 15g，白芍 15g，防风 30g，羌活 12g，全蝎 6g，蜈蚣 2 条，僵蚕 6g，甘草 6g。11 月 5 日复诊，左眼睑能交睫，左腮内不存食，嘴角偶尔流少量口水，诸症均见好转，仍按上方再进药 2 剂。11 月 7 日复诊，诸症消失，功能完全恢复，共服牵续汤 4 剂而告痊愈。

【方名】 面瘫汤。

【组成】 制白附子 10g,白芷 10g,三棱 10g,莪术 10g,僵蚕 10g,炮穿山甲 10g,乌梢蛇 10g,石见穿 30g,板蓝根 30g,生黄芪 30g,蜈蚣 3g,全蝎 3g。

【来源】 陈森,新中医,1991,(10):31。

【功效】 搜风通络,活血散瘀。

【适应证】 面神经麻痹。

【方药简析】 面瘫汤是在牵正散的基础上发展拟成的。方中白附子,性燥而升,善散祛风,能引药势上行于头面,治中风口歪,配伍白芷(麝香代用品)祛风效力尤强,能引补气药通行十二经,故更有助于黄芪补气扶正,以增强机体免疫功能,抗御病毒,使面神经麻痹复苏;板蓝根协同石见穿抗病毒;全蝎、蜈蚣、僵蚕善搜经络内之风邪,具有攻毒祛邪之功,也为治中风口眼歪斜上乘之品;乌梢蛇善于搜风通络,为面肢麻木,筋脉拘挛,口眼歪斜等症常用药;三棱、莪术活血通络。陈氏用上方治疗 51 例面神经麻痹,痊愈 50 例,好转 1 例。服药最短 7 天,最长 30 天,平均 21 天。

【病案举例】 蒋某某,男,70 岁,教师。1987 年 2 月 23 日初诊。患者于 1 个多月前因右侧面瘫在本市某医院诊治,经神经内科确诊为右侧周围性面神经麻痹,经用维生素 B₁、维生素 B₁₂、地巴唑、泼尼松以及针刺疗法,症情未能好转,病人十分焦急,由子女陪伴前来门诊。右侧颜面口眼歪斜,病情表现符合面神经麻痹之诊断。舌苔薄白,脉细弦。中医辨证因年届古稀,正气不足,风中经络,脉络淤阻,气行不畅所致。治宜扶正祛邪,搜风通络,活血散瘀,调畅气机为法。予面瘫汤治疗。病人先后来院门诊 6 次,共服 30 剂而愈。2 月后随访,患者面部表情肌活动正常。

4 面肌痉挛

面肌痉挛是一侧面肌阵发性不自主的抽搐,又称面肌颤动或面肌阵挛,为阵发性不规则的一侧面神经支配的肌肉不自主无痛性收缩。通常这种阵挛性收缩局限于一侧面部,亦称半侧面肌痉挛。以中年妇女多见。其发病原因未明,面肌痉挛的异常冲动可能是因面神经通路上某些部位受到病理性刺激引起。近期研究证实,这种刺激来自血管(小脑下后动脉、小脑前下动脉、椎动脉、动脉瘤、动脉畸形)或脑瘤对面神经的机械压迫,进一步损及神经髓鞘而脱失,轴突受刺激产生神经冲动(动作电流),且无髓鞘绝缘面短路,同步化增强,导致一侧部分面肌痉挛。少数可能为面神经炎的后遗症。面肌痉挛多自眼轮匝肌开始,呈轻微的间歇性肌肉颤搐,逐渐可向下半部面肌扩展到一侧面部,尤以口角抽搐最明显,肌收缩时常伴眼裂缩小;每次抽搐持续数秒至数分钟。严重时可累及同侧的颈阔肌,甚至整个面肌发生痉挛。痉挛的程度轻重不等,可因精神紧张,情绪激动,疲劳,自主运动时加剧,安静时减轻,睡眠时消失。少数病人于痉挛时伴有头痛,耳鸣,心烦意乱,影响工作。严重者可伴有面肌无力和肌肉挛缩,同侧面部缩小,眼裂变小,鼻唇沟加深,口歪向病侧。本病多为单侧,双侧罕见,呈进行性发展,但很缓慢。一般均不会自然好转,如不给予治疗,部分病例以患侧面肌麻痹而终结,而此时痉挛亦告停止。肌电图可发现有肌纤维震颤与肌束震颤电位。本病无其它神经系统阳性体征,根据临床表现诊断并不困难。但需与局灶运动性

癫痫、功能性睑痉挛,习惯性抽动症,三叉神经痛,桥脑小脑角肿瘤或炎症,舞蹈病及手足徐动症相鉴别。面肌痉挛目前多采取综合性对症处理,常选用左旋多巴、卡马西平、苯妥英钠或鲁米那等,重症可试用 50%乙醇溶液行皮下面神经分支处封闭,或茎乳孔面神经主干处封闭;对顽固性病例可考虑切断面神经分支或其主干。封闭和手术都可引起面神经麻痹。

面肌痉挛属中医风中经络,筋惕肉瞤的范畴。多因外风侵袭,或阳亢、血亏引动肝风所致;其病位主要在面部经络,病性以实证居多。治疗上应以祛风通络为主,兼以补气养血,平肝潜阳,滋补肝肾,健脾化痰,活血化淤。外风阻络型用大秦芩汤,气血虚弱型用八珍汤,肝阳上扰型用龙肝泻肝汤,肝肾阴虚型用镇肝熄风汤。针灸(体针、耳针、头针、水针)治疗本病效果较佳。本病最多用的是芍药甘草汤。

祝融以芍药甘草汤为主(白芍 100g,知母 15g,葛根 15g,蝉蜕 15g,甘草 15g;精神紧张加朱砂、夜交藤,女性加香附)治疗本病 11 例,全部治愈;最少者服 3 剂,最多者服 9 剂[辽宁中医杂志,1980,(9):40]。

曹国容用芍药甘草汤加味(党参 10g,薏苡仁 10g,当归 12g,白芍 12g,炙甘草 6g,木瓜 6g,牡蛎 20g)治疗本病 42 例,效果良好[湖北中医杂志,1991,(1):46]。

钟华用芍药甘草汤(白芍 45g,炙甘草 10g,生半夏 12g,薏苡仁 30g)治疗本病 32 例,总有效率 93.8%[中西医结合杂志,1991,(1):43]。

管遵惠等用肠线穴位埋藏法,主穴:四白、地仓、巨髎,配穴:阳白、丝竹空、攒竹、迎香、颊车、颧髎、承浆。每周 1~2 次,每次 2~4 穴,12 次为 1 个疗程。操作方法:将 3/0 号医用羊肠线剪成 2~3mm 长的小段,置入高压消毒过的 9 号注射针头的针芯内,浸泡于 75%乙醇溶液内备用。将选定的穴位常

规消毒后,医者左手捏起穴位表皮,右手持针快速刺入皮肤,循经(或逆经)进到肌肉层,将2寸毫针插入针芯,把肠线植入穴位内,缓慢退出针头,按压针孔。同时配合穴位注射(对面肌痉挛但无严重面部肌肉挛缩患者,采用苯巴比妥钠0.1g加1%普鲁卡因溶液2ml穴位注射。取穴风池、太阳、地仓、颊车、四白、迎香、巨髎,每次2~3穴,每穴0.2~0.5ml。部分病人注射后会出现面部或穴位周围皮肤水肿,一般可在48h内自行消退。面肌痉挛同时伴有面部肌肉萎缩的患者,则采用丹参注射液2ml、复方当归注射液2ml混合后穴位注射,循经取穴,每次2~3穴,每穴0.5~1ml。治疗面肌痉挛40例,男性12例,女性28例;年龄17~73岁,40岁以上34例,占85%;病程6天~26年,其中1年之内9例,1~5年17例,5~10年11例,10年以上3例;属面神经炎后遗症7例。结果治愈(面肌痉挛症状完全消失,面肌运动正常,半年内无复发)3例,显效(面肌痉挛基本消失,有诱因时面肌仍有轻微抽搐,痉挛程度、时间、次数均明显减少)18例,好转(面肌痉挛明显减轻,有诱因时虽有发作,但程度、时间减少者)15例,无效4例;总有效率90%[山东中医杂志,1990,(3):26]。

郝广义用智能针,患侧穴位选合谷、风池、三阴交、太阳、鱼腰、颧髎、人迎、颊车。交替使用。全身调节,选用百会、太冲。进针后,有针感时,接上智能针仪上连着的小夹子,固定在百会、太冲穴上。然后采用调制波,为三角波,频率50Hz,基波为正负脉冲波1000Hz,600Hz。脉宽为200 μ s,输出20min,得到起伏密疏波。电流强度以病人耐受能力而定。每日1次,10天为1疗程,疗程间休息3天。治疗阵挛性面肌痉挛46例,治愈10例,显效进步15例,进步16例,未愈5例,总有效率89.13%[实用中西医结合杂志,1995,(9):573]。

张和平用多针浅刺头面部敏感点(先取头部穴位神庭、上

星、前顶,每次选其中 1~2 穴用 28 号~30 号毫针行平刺,并在每 1 针行快速捻转手法 1min,留针期间每隔 20min 行针 1 次,共留针 100~120min。然后以左手中指、无名指、食指在患者头面部健侧或患侧进行轻轻揣摸,当摸到压痛点感觉敏感点或硬节和棱索或抽动最明显处,即为敏感点。局部常规消毒后,避开较大血管,用 28 号毫针直刺 1~2cm,每次不包括神庭、上星、前顶 3 穴,选(敏感点)8~12 个点,留针 80~120min,不捻针,每日 1 次,10 天为 1 疗程,疗程间休息 5 天。在留针期间令患者坐或仰卧位集中精力体会针感,切禁大声喧哗或打瞌睡)治疗面肌痉挛 39 例,年龄 20~62 岁;左侧 19 例,右侧 16 例,双侧 4 例;病程最短者 1 个月。结果治愈(症状消失,半年以上不复发)16 例,显效(正常情况下不发作,但在情志不遂等诱因条件下出现短时间而又轻微的面肌抽搐)14 例,有效(发作次数减少,抽搐程度减轻)6 例,无效 3 例;总有效率 89.74%。最多治疗 6 个疗程,最少 2 个疗程[新中医,1991,(12):31]。

闵捷等用望江南(清肝明目,健胃通便,清热解毒)单味或配伍其它药物治疗多种痉挛 156 例,其中面肌痉挛 25 例,胃痉挛 28 例,膈肌 12 例,眼轮匝肌痉挛 53 例,腓肠痉挛 38 例。结果治愈 122 例,好转 34 例。总有效率 100%[上海中医药杂志,1985,(5):30]。

李忠用脐痉散敷脐治疗面肌痉挛取得了较好效果,具体方法是将脐部用温水洗干净并擦干,把具有益气活血、搜风止痉、温阳化痰功效的齐痉散(胆南星 8g,雄黄 3g,醋芫花 50g,黄芪 30g,马钱子总生物碱 0.1mg,共烘干研为细面,再喷入白胡椒挥发油 0.05ml,混匀密封备用。若肝阳上亢加羚羊角粉、阿胶。血淤加逐淤散山楂 100g,葛根 100g,甘草 30g,白芍 150g,水煎两次,浓缩成膏;乳香、没药各 100g,溶于 95%乙醇

力,面部麻木不适,纳呆眠差,大小便调,面色萎黄不华,形体消瘦,舌淡苔腻,脉沉滑。诊为阵挛性面肌痉挛,中医辨证系阳明经脉亏虚,风痰留着。治以益气养血,祛风化痰。方用加味胃风汤:党参 12g,白术 9g,茯苓 9g,黄芪 15g,当归 12g,川芎 9g,白芍 15g,肉桂 5g,地龙 12g,全蝎 6g,白芥子 6g。5 剂后面部麻木明显好转,面肌抽搐次数亦减少。在上方基础上随证加减,至第 1 疗程结束,诸症若失,仅时有眼轮匝肌轻微抽搐。后改香砂六君丸,全蝎、蜈蚣为末,冲服以巩固疗效。至 1988 年得知,其病已愈,未再复发。

【方名】 加味芍药甘草汤。

【组成】 白芍 30g,炙甘草 10g,生牡蛎 30g(先煎),鸡血藤 30g,全蝎 8g。

【来源】 薛效东,实用中医内科杂志,1994,(3):24。

【功效】 养血祛风,缓急止痉。

【适应证】 面肌抽搐。

【方药简析】 方中白芍、鸡血藤养血活血;白芍、炙甘草、全蝎缓急止痉;生牡蛎、全蝎祛风止痉。若肝气郁结而见急躁、头晕、哭闹、舌质红、脉弦缓者,加柴胡 10g,香附 12g,栀子 10g;肝风内动每遇愤事抽搐加剧,舌暗红,脉弦细有力者,加钩藤 15g,天麻 10g,羚羊角 2g(另煎);肝血不足,目昏,舌质淡,脉弦细无力者,加当归 12g,熟地黄 15g;风邪阻络,头痛,鼻塞、恶寒,舌质淡,苔薄白,脉浮者,加荆芥 10g,防风 8g,白芷 10g;风痰阻络,患侧面肌发麻,咳痰,脉弦滑,舌体肥大,苔薄白者,加制南星 8g,制半夏 8g;久病淤滞,舌质淤点或紫暗,脉细涩者,加姜黄 10g,穿山甲 10g。薛氏用本方治疗多例颜面肌抽搐,疗效较好。

【病案举例】 刘某,女,干部,1989 年 4 月 13 日来我院

求诊。患者7天前因家事不遂,情志抑郁,易怒、纳差。右侧嘴角及面颊呈阵发性抽搐,舌质红,苔薄黄,脉弦。诊断:面肌痉挛,中医辨证属肝气抑郁型。治宜疏肝解郁、平抑肝阳。处方:白芍30g,炙甘草10g,生牡蛎30g(先煎),鸡血藤15g,全蝎8g,柴胡10g,香附12g,生栀子10g。服上方3剂,面颊及嘴角抽搐明显减轻,饮食增进,以上方加减又服4剂,病告痊愈。

【方名】 镇痉祛风散。

【组成】 白花蛇40g,全蝎8g,蜈蚣15g,威灵仙32g。

【来源】 徐峰炳,河北中医,1993,(6):30。

【功效】 祛风止痉。

【适应证】 面肌抽搐。

【方药简析】 方中白花蛇透骨搜风,为治风病之要药;蜈蚣、全蝎合为止痉散,功专止痉制抽。徐氏用上方(前3味共研细末,分为8份,每天冲服1份,8天为1疗程。停药4天,每日取威灵仙30g,清水煎服;第13天续服镇痉祛风散8天,全疗程为20天)治疗面肌痉挛32例,年龄18~65岁,病程3天至9年6个月。结果服药2个疗程治愈(临床症状消失)30例,无效2例;总有效率93.8%。

【病案举例】 刘某,男,45岁,1992年8月5日就诊。主诉9年来右侧面部抽搐不停,昼重夜止,十分痛苦。患者右侧口角和面肌不断频繁痉挛抽搐,间隔几秒钟到几十秒钟就抽搐1次,痉挛时右口角向上方抽搐,可见右眼裂尤显缩小。诊断:面肌痉挛症。方用镇痉祛风散。服药8天后患者面肌抽搐大减,药已中病,嘱其停药4天,取威灵仙30g,煎汤服,第13天续服第2个疗程。20天后患者告捷,面肌痉挛完全消除。

5 急性感染性多发性神经病

急性感染性多发性神经病又称急性感染性多发性神经根炎,或急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病,多称为格林-巴利综合征,是常见的特发性急性或亚急性周围神经病,主要侵犯脊神经、颅神经,有时可累及脊膜、脊髓及脑部。病情进展迅速且大多可以恢复,也是多发性神经病中的一个特殊类型。本病病因至今不明,一般认为有原发性病毒感染及自身免疫两种学说。多数病人发病前可有特异性病毒感染(如流行性感感冒、水痘、带状疱疹)及免疫接种史,使病变神经根水肿充血,局灶性血管周围淋巴细胞浸润,神经纤维出现节段性脱髓鞘和轴突变性。其发病率 1985 年 21 省农村流行病学调查为 16.2/10 万,六城市为 9.5/10 万。任何年龄均可发病,东北 3 省调查表明 4~6 岁及青年是两个发病高峰;约 75%集中在 6~10 月份,男性略多,妊娠、外科手术和疫苗接种可诱发,淋巴瘤病人发病率高。本病多数患者病前数天至数周有全身或局部感染史,常见的是上呼吸道感染或胃肠道感染症状,或因淋雨受凉、过度劳累而诱发。起病急,最快可在 24h 内出现四肢远端对称性无力,很快加重并向近端发展,可波及躯干和颅神经,严重者可累及肋间肌和膈肌导致呼吸麻痹。但多数人发病缓慢,在 1~2 周内(少数在 3~4 周)达到高峰;症状起伏波动或缓慢进展,呈缓解—复发状。约 80%以上病人首发双下肢无力,渐至对称性弛缓性瘫痪,腱反射减弱或消失,病理反射阴性,后期肢体远端可有肌萎缩,个别病人仅有双下肢或单

肢软瘫。感觉障碍较运动障碍轻，末梢感觉异常或手套、袜套样感觉减退，或无感觉障碍。颅神经损害以双侧面神经麻痹最常见，其次为舌咽和迷走神经麻痹，出现面瘫，声音嘶哑，吞咽困难，偶见视乳头水肿。可有出汗、皮肤潮红、手足肿胀、营养障碍、心动过速，血压降低，括约肌障碍等植物神经功能损害。检查脑脊液蛋白增高，细胞数基本正常。常并发肺部感染及肺不张、需和脊髓灰质炎，急性脊髓炎，周期性麻痹，肉毒中毒，多发性肌炎相鉴别。本病按起病形式及病程可分为急性型、慢性复发型及慢性进行型，按病损部位可分为脊神经型、脑神经-脊神经型、脑神经型，按病情轻重可分为轻、中、重或普通型和呼吸肌-球麻痹型。急性期防止呼吸肌麻痹予以激素、神经营养药物或试用免疫抑制剂，恢复期予按摩、主动和被动锻炼及理疗，肢体放置功能位置，防止肢体挛缩畸形。大多数 1~3 个月好转，半年~1 年半痊愈。

急性感染性多发性神经病属中医瘫痪范畴，急性期以邪实为主，风暑湿热为患，与湿邪关系最为密切，湿热浸淫为最常见类型；恢复期补虚扶正，活血通络，配合针灸推拿加强功能锻炼，防止肌肉跟腱挛缩，提高疗效。注意在辨证基础上使用马钱子起痿兴废，开通经络，透达关节，直达病所，因其有毒需炮制且不能久服，先从小剂开始逐渐加重，10 天为 1 疗程，间隔 3~4 天，不超过 3 个疗程，防止中毒；同时甘草用量宜大，其所含类皮质激素可增强疗效。近年来本病多用中西医结合方法，取得较好效果。

罗再生用补阳还五汤合三妙散加络石藤、海风藤治疗本病取得了较好疗效〔湖南中医杂志，1988，(3)：31〕。

马奎云等将本病分为急性期，用《奇效良方》乌药顺气散，恢复期用《医宗必读》的神效黄芪汤，共治疗 34 例，总有效率 91.18%〔中西医结合杂志，1983，(3)：257〕。

樊祥冲用复方马钱子汤：生马钱子 3~9g，桑寄生 15~30g，仙灵脾 15~30g，葛根 15~30g，黄精 30~60g，黄芪 30~60g，枸杞 30~60g，甘草 10~20g。治疗 656 例，痊愈 177 例，基本痊愈 212 例，好转 245 例，死亡 22 例[中西医结合杂志，1986，(8)：192]。

周玉林等用复方甘草汤(甘草 20g，板蓝根 20g，蒲公英 20g，连翘 15g，黄连 5~10g)治疗 100 例，其中呼吸肌-球麻痹型 60 例，普通型 40 例，总有效率 96%，死亡 3 例[中西医结合实用临床急救，1995，(3)：107]。

冯福海等辨证分型治疗本病 9 例，其中男性 7 例，女性 2 例；年龄最小 11 岁，最大 17 岁；病程最短 6 天，最长 1 年；急性期 5 例，缓解期 4 例；急性期用黄芪 60g，黄精、金银花、大青叶、枸杞、桑寄生各 30g，葛根、伸筋草各 20g，红花、全蝎各 10g，仙灵脾 15g，油制马钱子 0.3~30g，甘草 3~30g，蜈蚣 3 条；益气清热，活血通络；缓解期用黄芪 60~150g，续断 30g，杜仲、桑寄生、枸杞子、鸡血藤、黄精各 30g，怀牛膝、伸筋草、山药各 15g，当归、仙灵脾各 12g，全蝎 10g，蜈蚣 3 条，油制马钱子 0.3~3g，甘草 6~30g；健脾补肾，活血通络。结果痊愈 3 例，好转 6 例，最短治疗 24 天，最长 74 天[河南中医，1991，(2)：15]。

石晓军用扶正治痿汤，莲子 15g，芡实 10g，龟板 15g，麦门冬 10g，黄芪 25g，甘草 10g，当归 20g，连翘 20g，板蓝根 10g，木瓜 10g，山药 10g，牛膝 7.5g，同时配合捏脊治疗本病 9 例，痊愈 5 例，有效 3 例[吉林中医药，1990，(6)：21]。

【方名】 加味三妙丸。

【组成】 苍术 10g，牛膝 10g，茯苓 10g，车前子 10g，半夏 5g，薏苡仁 30g，金银花 15g，泽泻 15g，藿香 30g，黄柏 10g。

多,原方去安痛藤、延胡索,继服 6 剂,下肢能行走,但感无力,手能拿筷碗吃饭。守方继服 4 剂,手足功能完全恢复正常,舌苔变薄白,步行出院。

【方名】 加味右归饮。

【组成】 熟地黄 20g,附子(先煎 30min)15g,枸杞子 15g,山茱萸 12g,肉桂 6g,杜仲 10g,山药 30g,炒白术 12g,石斛 15g,玉竹 12g,炙甘草 10g。

【来源】 李公伦,云南中医杂志,1992,(4): 11。

【功效】 温补肾阳,滋阴填精,益气健脾。

【适应证】 格林 巴利综合征。

【方药简析】 方中附子、肉桂、杜仲引火归源,温补肾阳;熟地黄、枸杞子、山茱萸、石斛、玉竹滋阴填精;山药、炒白术、炙甘草益气健脾,调和诸药。本方乃右归丸加味即为阴中求阳,阳得阴助,则生化无穷。后期若腿软无力,纳差,苔薄白,脉虚数时可用党参、茯苓、白术、黄芪、炙甘草、大枣、菟丝子、熟地黄、怀牛膝、山药、谷芽、麦芽、焦山楂,益气健脾,生化气血,滋养筋脉。可随症配伍活血通络,强筋壮骨药物,如丝瓜络、伸筋草、鸡血藤、猴骨等。同时配合针灸,上肢:举臂、抬肩、肩髃、曲池、合谷、手三里、外关、后溪;下肢:环跳、承扶、髀关、委中、风市、殷门、足三里、解溪。每日 1 次,10 次 1 疗程,每疗程间隔 2 天。穴位注射①维生素 B₁100mg,维生素 B₁₂1000μg;②红花、当归注射液各 2ml,每组注射 2~4 个穴位,2 组药物交替使用,小儿减半剂量,7 天 1 疗程,间隔 3 天。李公伦等用上法以中药为主共治疗 27 例,年龄最大为 38 岁,最小 4 岁;瘫痪最长者 212 天,最短 60 天;治愈 23 例,好转 4 例。27 例经 3~14 年随访,无 1 例复发。

【病案举例】 陈某,男,4 岁,1976 年 3 月 20 日因四肢瘫

【病案举例】 王某,男,44岁,1981年11月4日诊。平素身体健康,本次发病因夜睡感受风寒,醒后即感周身发硬不适,不能自己穿衣,手不能持物,小腿发凉,继而呼吸费力,痰不能咯出而来诊。查体:体温 36.4℃,脉搏 120次/min,血压 16/12kPa,呼吸 20次/min。表情紧张,轻度发绀,呼吸困难,胸式呼吸减弱,双肺有痰鸣音,双眼睑不能闭合,双鼻唇沟浅,伸舌居中,四肢肌张力低,除颈肩略可活动外,全无自主活动,腱反射未引出,无病理反射,双侧肘膝关节以下痛觉减退,尿、便无障碍,苔白腻,脉浮滑。实验室检查:白细胞计数 $11.6 \times 10^9/L$,中性分叶核粒细胞 0.71,中性杆状核粒细胞 0.17,淋巴细胞 0.08,单核细胞 0.04;血钾 4.2mmol/L。心电图显示窦性心律,正常心电图。诊断为格林-巴利综合征。当即予小续命汤,日1剂,水煎服。因病情危重拟转诊,在等待救护车时家属将2剂药合在一起煎了3次,取汁约500ml,被病人在朦胧中1次顿服。约20min后,患者自觉心慌,不久便入睡,经3个小时,病人有尿意,醒后手足有酥酥串电感,而且可以活动自如。次日又服上方1剂,诸症消失,而获痊愈[吉林中医药,1992,(1):13]。

【方名】 冬青四物汤。

【组成】 金银花 15g,大青叶 15g,板蓝根 7.5g,赤芍 5g,当归 5g,川芎 5g,生地黄 5g,薏苡仁 12g,地龙 12g,牛膝 5g,僵蚕 5g,甘草 5g。

【来源】 冯永喜,中医药学报,1988,(1):37。

【功效】 清热利湿,活血通络。

【适应证】 格林-巴利综合征。

【方药简析】 方中大青叶、板蓝根、金银花清热解毒;四物汤养血活血柔肝;薏苡仁健脾除湿;地龙、僵蚕疏风通络;牛

膝引药下行兼以和血；甘草调和诸药。冯永喜用上方内服，并把药渣装入布袋，敷于大椎至骶尾部，每天敷3次，每次20分钟。同时配以针灸（上肢：肩髃、曲池、内关、外关、合谷等；下肢：环跳、委中、承山、足三里、上巨虚、昆仑等；背部：肾俞、肝俞等。语声低微，哭声无力，进食呛咳者，取外廉泉）按摩（在瘫痪肢体上采用滚法、揉法，至皮肤微红为度，并在针灸诸穴揉按。同时捏脊从大椎至腰骶从上至下，或从下至上5~6次）方法，共治疗8例女患儿，其中生后5个月者1例，2~3岁者5例，6~8岁者2例，重证3例。用药后一般肢体功能2~3天开始恢复，7~8天可在扶持下站立，2~3天基本恢复，所有病例，全部治愈。冯氏用药垫热敷配合治疗本病，不仅符合中医辨证施治方法，同时也符合现代医学本病的病理生理特点，热敷部位从大椎至骶尾部，使药力直达脊神经根水肿，轴突肿胀，周围神经间质淋巴细胞浸润，对温通血脉，活血祛瘀，通经活络起到了重要作用。

【病案举例】 程某某，女，5个月，1984年2月20日就诊。患儿于9天前开始发热，体温高达40.7℃，当地医院诊按上呼吸道感染治疗，次日发现患儿四肢发软，以后日渐加重，已服小儿麻痹糖丸，近2天患儿持续高热，体温38.5℃，精神萎靡，面色发红，呼吸急促，四肢呈弛缓性瘫痪，对针刺无反应，哭声无力，语声低微，吃奶呛咳。咽部红赤，心律140次/min，无杂音，两肺呼吸音粗，肝脾大小正常。颈强（-），双上肢肱二头、三头肌反射消失，双下肢膝腱反射消失，病理反射未引出。舌质红，苔白厚，指纹紫在气关。白细胞计数 $9.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.45，淋巴细胞0.55；红细胞计数 $4.2 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白8.4g/L；脑脊液，外观正常，细胞数 $2 \times 10^6/L$ ，氯化物100mmol/L。诊为格林-巴利综合征，中医辨证为湿热浸润，热重于湿。处方：忍冬藤15g，大青叶15g，板蓝根

7.5g,当归 5g,茯苓 5g,全蝎 1.5g,僵蚕 5g,蜈蚣半条,赤白芍各 5g,川芎 5g,生地黄 5g,地龙 5g,牛膝 5g,甘草 5g,水煎 150ml,分 3 次服,同时配合按摩、针灸、药垫热敷。次日热退,吃奶已不呛咳,哭声有力,3 日后双下肢可以屈曲,左上肢可以移到胸前,右上肢活动欠佳,守上方加薏苡仁 7.5g、桂枝 2.5g,共治疗 28 天痊愈。

【方名】 白虎升陷汤。

【组成】 黄芪 15g,知母 12g,升麻 3g,桔梗 3g,柴胡 3g,桂枝 3g,干姜 3g,炙甘草 3g,人参 9g,毛冬青 9g,生石膏 24g。

【来源】 蒋下文,湖南中医杂志,1989,(2):38。

【功效】 升陷泄热,益脾养阴。

【适应证】 急性多发性神经根炎。

【方药简析】 本病乃阴亏热淫,气陷欲脱,故以白虎加入参汤养阴生津,益气清热;黄芪、人参、甘草、升麻、柴胡益气升陷;干姜、桂枝温阳救急;桔梗利咽以利呼吸;毛冬青活血化淤通络,共奏升陷救脱、育阴泄热之功,使阳升阴应、气血和畅。若囿于泄热,清利养阴生津,则反有损气致脱之嫌。

【病案举例】 例一:张某,男,12 岁,1986 年 6 月 17 日就诊。患者 1 周前感寒身热,体倦乏力,未介意。突在 1 日前吞咽困难,当晚呼吸急促,声音嘶哑,着衣无力,翌日晨四肢呈进行性瘫痪,急诊入院。见胸闷多痰,寒热间作。查体:体温 38.5℃,咽反射、咳嗽反射、吞咽及四肢腱反射均消失,西医诊为急性多发性神经根炎。经予肾上腺素、洛贝林、可拉明等药物治疗未见明显好转;午后出现浅昏迷,血压 9.3/8kPa、体温 39.5℃,继予升压及配合人工呼吸机救治,神志稍清,乃邀余会诊。证见面色灰滞,气息短促,汗出不止,身热肢厥,咽干作渴,小便失禁,大便秘结,口唇指甲青黯,舌暗尖红,苔薄燥,脉

细数无力、两寸细微欲绝。中医辨证乃阴亏热淫，气陷欲脱。亟以升陷泄热为法，方予升陷汤合白虎汤化裁：黄芪 15g，知母 12g，升麻、桔梗、柴胡、桂枝、炙甘草各 3g，人参、毛冬青各 9g，生石膏 24g，嘱水煎频服。进药 1 剂，厥回热退，气息渐平、汗出顿减、脉现转机，守方去干姜加忍冬藤、络石藤、当归各 9g。药进 2 剂后，热除神清，大小便复常，且四肢略可抬举，惟胸闷多痰，言语不清，乃守方去人参、石膏，加贝母、瓜蒌仁各 9g，胆南星、桃仁、杏仁各 6g。继服 5 剂，胸畅痰除，纳增神爽。尔后与党参、白术、茯苓、扁豆、玉竹、木瓜、桑枝等益脾和中、舒筋和络之品出入，继服 10 余剂，诸症递除，体力倍增，四肢活动恢复正常。

例二：魏某，男，48 岁，1987 年 9 月 25 日就诊。患者 3 日前恶寒发热，翌日下肢痿软，两手持物无力，乃至大小便不能自行人厕，就餐须人饲喂。入院后即见呼吸急促，咽喉憋闷，声音嘶哑，吞咽困难；查体：体温 38.2℃，两肺呼吸音弱，四肢呈弛缓性瘫痪，自主运动基本消失，西医诊为急性多发性神经根炎。治予肾上腺素、可拉明及抗感染药物未见显效，余应邀会诊。证见气短难续，烦躁心悸，胸咽憋闷，身重面黄，恶热喜凉，口唇紫黯干燥，渴而少饮，四肢痿软微肿，扪之略热，小便短赤频数，大便燥而不爽。舌暗红、苔黄厚腻，脉濡数、左部微弱不起。诸症合参，中医辨证乃湿热化燥伤阴，大气虚陷。治予升陷汤合二妙散加味：黄芪 18g，知母 12g，升麻、桔梗、柴胡、苍术、黄柏、生甘草各 3g，忍冬藤、沙参、玉竹各 9g，薏苡仁、当归各 6g；服药 1 剂，气息渐平，心悸烦躁均缓。续服 3 剂，胸咽舒，大小便畅，体温复常，四肢略可抬举。守方去忍冬藤，加防己、蚕砂各 9g；服药 4 剂，诸症递除，且足可行立，手可持物，患者惟以腰膝酸软为诉，乃守方与熟地、龟板、巴戟天、黄精、锁阳等益肾填精之品出入，继服 20 余剂，体趋强健。

【方名】 益气健脾汤。

【组成】 黄芪 30g, 人参 30g, 白术 15g, 茯苓 24g, 陈皮 9g, 当归 9g, 玉竹 12g, 麦门冬 12g, 丹参 15g, 桃仁 9g, 桂枝 9g, 炙甘草 6g, 马钱子粉 0.09g。

【来源】 李绍发, 山东中医杂志, 1983, (5): 38。

【功效】 健脾益气, 活血通络。

【适应证】 感染性多发性神经炎。

【方药简析】 本方由补中益气汤化裁而来, 方中黄芪、人参、白术、茯苓益气健脾, 利水祛湿; 当归、丹参、桃仁、桂枝活血通络; 玉竹、麦门冬养阴生津; 马钱子透关通窍, 促进气血运行; 炙甘草、陈皮理气和中; 调和诸药。同时甘草又有类肾上腺皮质激素样作用, 对治疗本病有独到之处, 马钱子要注意炮制和用量。

【病案举例】 轩某, 女, 38岁, 1977年10月5日初诊。自述于17天前无明显原因突然发病, 四肢软瘫, 不能活动, 神志清醒, 县医院诊为“急性神经根炎”, 住院治疗10余天无效, 病情逐渐加重而来济南某医院就诊, 经检查诊为“急性感染性多发性神经炎”, 予常规治疗效果不显著而来我院求治。现患者四肢瘫痪, 不能活动, 神志尚清, 精神不振, 食欲欠佳, 吞咽不利, 大小便正常。舌苔白, 脉沉无力。中医辨证: 脾虚阳困, 气血不能充养肌肤达于四末。治宜健脾益气, 佐以活血通络。处方: 黄芪 30g, 人参 30g, 炒白术 15g, 茯苓 24g, 陈皮 9g, 当归 9g, 玉竹 12g, 麦门冬 12g, 丹参 15g, 炒桃仁 9g, 桂枝 9g, 炙甘草 6g, 马钱子粉 0.09g。服药3剂后四肢活动较前好转, 上肢已能抬举, 下肢如前, 胃纳略增, 大小便正常, 舌苔白, 脉细弱。上方加白芍 12g、橘红 12g, 继服3剂。服药后病情明显好转, 自己能起床, 扶持能走动, 食欲增加, 仍感四肢无力, 全身麻

本，舌苔白，脉沉涩。上方改白芍 24g，当归 24g，继服 3 剂。服药后四肢活动渐好，自己能上二楼，余无异常，苔白，脉沉缓。上方去马钱子粉，加人参 6g、丹参 30g、白芍 30g，继服 3 剂。10 月 20 日五诊，服药共 12 剂，已能自己上楼就诊，两手活动自如，胃纳及大小便正常。嘱上方人参改为 15g 继服，以巩固疗效。后随访 2 年，未见复发。

【方名】 七味解毒汤。

【组成】 苍术 10g，黄柏 10g，板蓝根 30g，忍冬藤 30g，络石藤 15g，鸡血藤 15g，虎杖 15g。

【来源】 吴敬农，江苏中医杂志，1981，(1)：29。

【功效】 清热解毒，舒筋活血。

【适应证】 急性感染性多发性神经根炎。

【方药简析】 方中苍术、黄柏清热燥湿，板蓝根、虎杖清热解毒活血；忍冬藤、络石藤、鸡血藤清热活血通络，兼以养血。重症可每日 2 剂，分 4 次服，儿童酌减。此方用于急性期 20 天左右。后期肝肾受损，肌肉明显瘦削乏力，脉细弦可用健步汤（独活 10g，桑寄生 15g，怀牛膝 10g，枸杞子 12g，炒白芍 10g，杜仲 15g，鸡血藤 15g，龟板 15g，鹿角片 10g，红枣 6 枚）补益肝肾，柔筋活络。若伴肌肉抽搐加全蝎 1.5g；心悸多汗失眠加煅龙骨、煅牡蛎，远志；舌红口干加沙参、石斛。吴敬农用上方治疗本病 20 例，男 12 例，女 8 例，10 岁以下 3 例，11～20 岁 8 例，21～30 岁 6 例，31～41 岁 3 例。结果痊愈 7 例，好转 13 例；其中治疗 1～20 天痊愈者 2 例，21～30 天好转者 6 例，31～40 天好转者 6 例，41～50 天好转者 2 例，51～60 天好转者 3 例，61～100 天治愈者 1 例。

【病案举例】 例一：汤某，男，14 岁。患者于 1974 年 7 月 29 日自觉上肢疼痛无力，不能握物，行走时突然跌倒，于 8 月

2日入院。双上肢对称性下垂,不能握物,双下肢对称性瘫痪。检查:四肢无畸形,心肺未见异常,膝反射消失,肌力0级。诊断:急性感染性多发性神经根炎。服用七味解毒汤18剂,后服健步汤30余剂;恢复期并予加兰他敏、维生素B₆辅助治疗。患者于8月17日已下床行走,双手能握物,肌力逐渐恢复,10月25日出院时已能扶梯上楼,但肌肉消瘦,上下肢肌力已达Ⅳ级。于11月5日随访1次,患者肌肉丰满,并能正常活动。

例二:钱某,男,23岁。患者发热1天后,四肢无力,下床突然跌倒,于1974年8月12日入院。双上肢呈对称性弛缓性瘫痪,卧床时下肢尚能轻度伸屈,但不能行走。检查:心律齐未闻明显杂音,两肺呼吸音粗,肝脾不肿大,血象正常,握物无力,上肢肌力Ⅰ级,下肢肌力Ⅱ级,膝反射消失。予七味解毒汤11剂后,患者能握汤匙吃粥,后服健步汤,同时使用加兰他敏、维生素B₁₂注射液,15天后下肢已能跛行,上肢肌力达Ⅲ级,下肢肌力Ⅳ级,治疗34天出院。出院后患者已能骑自行车从十多里外的农村来院就诊。同年12月初随访1次,已从事劳动生产。

【方名】 补气养阴汤。

【组成】 人参10g,麦门冬15g,五味子12g,黄芪30g,当归12g,白术12g,茯苓15g,黄精20g。

【来源】 张茂祥,甘肃中医学院学报,1994,(4):30。

【功效】 补气健脾,养阴生津。

【适应证】 格林-巴利综合征。

【方药简析】 本方方名及剂量为编者所加。方中生脉散益气生脉,黄芪、黄精、茯苓、白术助人参大补元气;当归、黄精助麦门冬、五味子养阴生津。张茂祥所治该病例为第三次复

发,且病情发展迅猛,数日即累及除眼球运动神经以外的所有颅神经运动支、脊神经根、脊神经,病情危重,危及生命。该病例复发次数如此之多,累及范围如此之广,病情进展如此之快,实属临床罕见。且经西医大剂量激素、环磷酰胺、大量 γ -球蛋白静脉点滴及自体血、异体血光量子疗法等多种积极综合抢救治疗,病人均无明显效果。此例患者中医辨证为气阴双损,故用重剂补气养阴之品,自始至终,宗其大法,严守病机,合理用药,中西结合,获此奇效。

【病案举例】 王某,女,20岁,1990年5月26日住院。患者于1981年春,因四肢无力在本院神经内科住院检查诊断为“格林-巴利综合征”,经治疗痊愈。1982年冬复发,第二次住本院神经内科,诊断为“复发型格林-巴利综合征”,经治疗肌力逐渐恢复。1990年5月22日因“上呼吸道感染”,自服“感冒通”2次(剂量不详),于1990年5月26日上午,自觉双下肢力弱,下午不能上楼梯,即来本院神经科就诊,查体:颅神经无异常,四肢肌力Ⅳ级,下蹲起立困难,括约肌功能正常,感觉功能正常,病理征阴性,以“格林-巴利综合征(第三次复发)”急诊收入住院。入院后神志清楚,语言流畅,精神无异常;查体:体温 36.6°C ,呼吸20次/min,脉搏72次/min,血压 $13.3/10\text{kPa}$,心肺无异常,肝脾未触及,双小腿肌肉萎缩,自主运动四肢减少,肌张力四肢减低,双手推力差,轻度鸭型步态,其它神经系统检查均未发现阳性体征。即予以对症治疗。入院后四肢无力进行加重,第2天即出现咳嗽力弱,语言低下,颈肌力弱,双上肢肌力Ⅰ~Ⅱ级,双下肢肌力Ⅱ级,双膝反射未引出,下病危通知。到5月29日出现呼吸急促,浅弱,即气管切开。继之胸式呼吸消失,腹壁呼吸微弱,双肺听不到呼吸音,呈浅昏迷状态,四肢肌力为0级,开始应用人工辅助呼吸机,并调换三通气管插管,鼻饲饮食。6月1日,因排尿困

难,放置导尿管,痰培养检出绿脓杆菌。6月6日,不能皱眉、闭目、努嘴,伸舌只能到口唇内侧,腹式呼吸也完全消失,双下肢腱反射消失。到6月13日双上肢出现肌肉萎缩,双下肢肌肉萎缩扩大,程度加重,神经系统体征无好转迹象,病情在渐进性加重。7月21日请中医会诊:患者被动体位,神情淡漠。全身消瘦衰竭,不能语言,鼻饲饮食,气管切开插管,人工辅助呼吸机加皮球,放置导尿管,舌体胖大,舌质淡暗,舌苔薄白略腻,脉沉细略滑而数。中医辨证,气阴双损。拟方如下:人参、麦门冬、五味子、黄芪、当归、白术、茯苓、黄精,水煎(浓)鼻饲每日1剂,嘱用10剂。二诊(7月28日),病情略见好转,四肢肌力可达Ⅰ级,余无明显变化,继服上方。三诊(8月4日),病情逐渐好转,停呼吸机后可见胸式呼吸,但弱,仅能维持2分钟,余无明显变化,上方调整剂量并加桂枝、陈皮、甘草继服。四诊(8月14日),病情明显好转,神情淡漠减轻,有反应意识,胸式呼吸运动表现较以前增强,腹式呼吸运动亦出现,停呼吸机,自主呼吸能维持4分钟,双肩及双上肢肌力可达Ⅰ级,可自行排尿,即拔除导尿管,治疗激素减量。舌体仍胖大,舌质淡暗,舌苔薄白,脉沉细略数,调整处方:人参、麦门冬、五味子、黄芪、当归、白术、制半夏、茯苓、黄精、丹参、路路通,水煎(浓)鼻饲。五诊(8月24日),患者病情进行性好转,停用呼吸机,自主呼吸可维持3~4h,并无明显胸闷、气短、发绀。能自行咀嚼吞咽少许食物,意识清楚,能简单发音,四肢肌力同前,精神明显好转,舌脉基本同前,嘱其继服8月14日方,到9月10日始白天完全停用呼吸机,但半夜仍需使用人工辅助呼吸机。六诊(10月11日),神志完全清楚,反应正常,语言能力明显好转,自行进食,吞咽良好,四肢肌力Ⅰ~Ⅲ级,拔除胃管,停用人工呼吸机,堵塞气管套管。上方调整个别药物剂量继服。患者于1991年1月16日拔除气管插管,并可搀扶下床

活动而出院,嘱其上方继服,巩固治疗。出院后3个月随访,病情逐渐好转,半年后随访,患者活动自如,可自行料理生活,四肢肌力Ⅳ级,肌肉萎缩明显好转。1年后随访,四肢肌力Ⅴ级,四肢肌肉恢复正常,可进行家务劳动。2年后随访健如常人。

6 多发性神经炎

多发性神经炎也称周围神经炎,末梢神经炎,对称性多发性神经炎,以肢体远端对称性感觉、运动和植物神经障碍为主要表现的临床综合征,真正为炎症感染者极少,实质上多属神经变性,它是众多原因均可引起的多发性神经损害,任何年龄都可发生,以青壮年多见,性别无差异。其发病原因众多,可归纳为:① 感染与变态反应性疾病(周围神经的直接感染如麻风、带状疱疹。伴发或继发于各种急性和慢性感染如流行性感冒、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、猩红热、传染性单核细胞增多症、钩端螺旋体、伤寒、疟疾、布氏杆菌病、结核性脑膜炎、败血症、梅毒、急性血吸虫病等。可直接感染引发本病的白喉、破伤风、细菌性痢疾;格林-巴利综合征、血清注射或疫苗接种后)。② 重金属及化学药品中毒(砷、铅、汞、铜、金、磷、锑、铋、锰,呋喃类。磺胺类药物、异烟肼、氯霉素、链霉素、乙胺丁醇、痢特灵、冠心宁、甲硝唑、他巴唑、阿糖胞苷、乙胺碘呋酮、苯妥英钠、氯喹、长春新碱、顺铂等。二硫化碳、苯胺、二硝基苯、溴甲烷、三氯乙烯、五氯苯酚、氯醛、磷酸三甲酚酯、丙烯酰胺、有机氯杀虫剂、有机磷农药、丙酮、甲醇、CO等)。③ 营养缺乏、代谢及内分泌障碍(B族维生素缺乏、慢性酒精中毒、手术后、妊娠、慢性胃肠道疾病、脚气病等。糖尿病、尿毒症、血卟啉病、粘液性水肿、肢端肥大症、痛风、淀粉样变性、甲状腺功能减退、烧伤、支气管扩张,各种原因引起的恶病质)。④ 结缔组织疾病及外伤(红斑性狼疮、结节性多发性大动脉炎、硬皮病、巨细

益气,当归、川芎、地龙、鸡血藤养血活血,桂枝、芍药调和营卫,可同时配合针灸治疗,效果更好。黄芪桂枝五物汤是临床最常用的方剂。

陈超用黄芪桂枝五物汤重用黄芪治疗多发性神炎 35 例,痊愈 6 例,显效 10 例,有效 16 例,无效 3 例[新疆中医药,1991,(1):41]。

金万斌用活血化瘀法(丹参 20g,郁金 15g,乳香 10g,延胡索 10g,威灵仙 10g)治疗末梢神经炎 2 例,均收到满意效果[新疆中医药,1989,(2):60]。

李勤良用血痹汤,黄芪 30~60g,人参 5~10g,生姜 5~10g,白芍 10~15g,甘草 10~15g,大枣、牛膝、桂枝、桑枝各 10~15g,白花蛇舌草、忍冬藤、灯笼花、鸡血藤各 30g,丝瓜络、熟附子各 10~20g,夜交藤、丹参各 10~20g;共治疗多发性神经炎 28 例,男 19 例,女 9 例;年龄最大 59 岁,最小 28 岁;病程最长 10 个月,最短 10 天;因细菌性痢疾、肠炎、流行性感胃、风湿热、糖尿病、慢性肾衰继发或伴发者 17 例,痢特灵、异烟肼中毒引起者 8 例,亚急性合并变性、引产术后、慢性酒精中毒引起者各 1 例。治愈 23 例,基本痊愈 3 例,好转 2 例,总有效率 100%;治愈时间最短 9 天,最长 35 天,显效最快者 3 天,最长 10 天[实用中西医结合杂志,1991,(7):409]。

张欣用益气养阴、活血通络中药,黄芪 50g,党参 15g,鸡血藤 30g,赤芍 25g,当归 15g,红花 15g,桃仁 15g,甘草 10g,川芎 10g,葛根 15g,丹参 15g;治疗糖尿病末梢神经炎 27 例,有效 16 例,显效 9 例,无效 2 例[辽宁中医杂志,1993,(3):26]。

赵世杰用丹参注射液合 654-2 治疗 4 例多发性神经炎,经 20~75 天治疗全部治愈[中西医结合杂志,1987,(6):

359]。

徐占元用化淤健脾汤,鸡血藤 20~50g,牛膝 15~30g,红花 10~15g,桃仁 10~15g,白术 25~50g,人参 10~15g,黄芪 25~50g,焦三仙各 20~30g,当归 15~40g,姜黄 10~20g,天麻 10~20g,桂枝 5~20g(后下),白花蛇末 3g(冲服))配合按摩、维生素 B₁、维生素 B₆、肌苷等治疗多发性神经炎 28 例,结果痊愈 22 例,好转 5 例,无效 1 例;用药 26~118 剂,平均 62 例[中西医结合杂志,1988,(10):622]。

【方名】 消渴痹痛汤。

【组成】 黄芪 30g,生地黄 20g,鸡血藤 30g,牛膝 15g,赤芍 15g,地龙 15g,山茱萸 15g,当归 10g,桃仁 10g,三七 10g,桂枝 6g,川芎 15g。

【来源】 黄镇鹏,新中医,1996,(12):21。

【功效】 益气养阴扶正,活血通络。

【适应证】 糖尿病性周围神经病。

【方药简析】 本病本虚标实,本虚乃气阴两亏,标实为血淤阻络,致使筋脉失养。故用黄芪益气以帅血;生地、山茱萸养阴生津;鸡血藤、赤芍、川芎、当归、桃仁、三七、桂枝、牛膝、地龙活血通络。疼痛甚者加白花蛇 3g,搜剔脉络,则效果更好。黄氏用上方治疗本病 26 例,男 14 例,女 12 例;年龄 40~58 岁 11 例,59~76 岁 15 例;血糖平均 13.2mmol/L;并发周围神经病最短时间半年,最长 6 年,平均 4.2 年。对照组 10 例,男 6 例,女 4 例;年龄 40~58 岁 4 例,59~76 岁 6 例;血糖平均 12.8mmol/L;并发周围神经病变最短时间 5 个月,最长 5 年 8 个月,平均 4 年。两组病例糖尿病诊断标准均符合 WHO 制定的糖尿病 I 型标准。两组均控制饮食,餐前各食 1 片优降糖控制血糖;治疗组加服本方,对照组加服维生素 B₁、维生素

莲草、女贞子、龟版；手腕或足背下垂者加升麻、柴胡，重用黄芪、党参；行走摇摆者加僵蚕、全蝎、天麻；痰湿盛者加白芥子、白附子；湿热重者加苍术、黄柏；皮肤溃瘍者加蒲公英、地肤子；肾精不足加黄精、川断、巴戟天等。谭氏用本方治疗多发性神经炎 25 例，男 16 例，女 9 例；年龄最小者 9 岁，最大者 62 岁；病程最长者 16 年，最短者 65 天；感染和因中毒作用于神经者 22 例，体外感受其它有毒物质（如铅、砷等）作用于神经者 2 例，营养缺乏所致者 1 例；伴腕下垂者 9 例，伴足背下垂者 8 例，伴行走摇摆者 6 例，伴瘫痪者 2 例，全部病例都有感觉障碍者且肢体对称。结果治愈（自觉症状消失，四肢活动自如，步履稳健）17 例；显效（自觉症状好转，肌力提高到Ⅲ级以上，功能明显恢复，但留有轻微麻木，指趾细小动作欠灵活）5 例；好转（自觉症状有所减轻，在原基础上提高肌力Ⅰ～Ⅱ级）2 例；无效 1 例。疗程最短者 31 天，最长者 6 个月。

【病案举例】 谢某某，男，32 岁，患者从事炼砷工作 2 年余，渐觉双手指触物不敏感，继则四肢远端重着，麻木无力，渐次向近端发展，曾经上级医院中西药治疗无效。2 月前双手腕下垂，手不能摄物，伴下肢对称性肌肉萎缩，行走不便，口干，口苦，纳呆，小便黄，大便不爽。查体：神识清楚，语言低微，面色萎黄；双手腕下垂不能活动，颅神经正常，口眼无歪斜，感觉障碍明显，腱反射弱，未引出锥体束征；舌体胖、质淡红、边有淤点、苔黄腻、脉细缓。诊断为多发性神经炎。中医辨证属脾胃虚弱，气虚血滞，经脉失养，营卫不和、湿热内蕴。方用益气行滞汤加苍术、黄柏、升麻、柴胡，6 剂，水煎服。药后四肢重着麻木减轻，口干、口苦已除，续服上方化裁 50 余剂，诸症悉除，嘱其加强营养，更换工种，追访至今，未见复发。

【方名】 双乌乳银汤。

【组成】 制川乌 5g,制草乌 5g,乳香 3g(后下),金银花 10g,生甘草 3g,制南星 3g,黄芪 15g,蜂乳 15g(后下)。

【来源】 单元晴,江苏中医杂志,1985,(3):40。

【功效】 温经逐瘀,除湿活络。

【适应证】 末梢神经炎。

【方药简析】 方中川乌、草乌温经散寒通络,据现代药理研究,川乌、草乌有促进血液循环功能;黄芪、蜂乳含维生素B、氨基酸、蛋白质、糖类,黄芪含有葡萄糖、叶酸等,是促进维生素B族生成的因素;制南星能去络中之痰,佐乳香以行气活血;甘草、金银花解毒去邪。单氏用本方治疗痢特灵引起的四肢麻木效果满意。

【病案举例】 王某某,男,40岁。1年前患胃小弯溃疡,经服痢特灵治疗3个月,胃部症状基本痊愈,继则感双上下肢末梢麻木,诊为服痢特灵引起末梢神经炎,先后用维生素B₁、谷维素、地巴唑等药效果不佳,转诊中医。病乃服痢特灵过多,致使气血流通失畅,四肢末梢筋脉肌肉失养;治宜温经逐瘀,除湿活络。用上方服10剂而愈,随访3年未复发。

【方名】 黄芪桂枝八物汤。

【组成】 生黄芪 30~60g,桂枝 10~18g,甘草 15g,玄参 15g,山药 15g,苍术 15g,白芍 20g,牛膝 20g。

【来源】 胡同斌,湖北中医杂志,1991,(2):24。

【功效】 补气养阴,活血化瘀。

【适应证】 糖尿病性周围神经炎。

【方药简析】 本方乃胡仿效施今墨经验,一方面降低血糖和尿糖;用黄芪补脾益气,山药益气阴,固肾精,苍术健脾燥湿降血糖,玄参滋肾泻火养阴。另一方面用黄芪、桂枝、白芍、甘草、牛膝益气通络,活血强筋,改善肢端血管神经的营养代

谢,坚持治疗半年至一年,远期疗效可明显提高。同时长期口服复合维生素B和复方丹参片。胡氏用上法治疗糖尿病周围神经炎26例,其中男10例,女16例,年龄45~60岁之间,均属糖尿病Ⅱ型,病史3~12年;出现周围神经症状最短者半年,最长者6年,平均2年9个月;就诊时,糖尿病已得到有效控制者6例,反复波动不稳者9例,11例空腹血糖在7.8~14.4mmol/L。感觉型者24例,运动型4例,共济失调型1例;膝腱反射减弱者17例,消失者5例,亢进者2例,跟腱反射减弱者16例,消失者8例,亢进者1例。结果近期疗效优者6例,良者18例,中2例;远期疗效优者3例,良者19例,中者3例,差1例。观察中发现运动型远期疗效较近期疗效好,而共济失调型近期、远期均差,大概与脊髓神经损害不易恢复功能有关。

【病案举例】 徐某,男,59岁,1987年9月21日就诊。自诉1年半前起,两下肢萎缩无力,踩地如踏棉花感,近半年需扶持行走,伴有夜间口干舌燥但不饮,每日夜尿2~3次,量多而清。入院查血压19.95/11.97kPa,心、肺、肾正常,大腿肌肉瘦削,双下肢肌力Ⅰ~Ⅱ级;膝腱反射迟钝,跟腱反射消失,血糖8.3mmol/L,尿糖(+~+++),否认有药物中毒、感染及其他神经病变发生史,诊断为糖尿病性周围神经病变。经用上法治疗2个月后,病者行走已无须扶持,肢体感觉正常,伴随症状亦减,血糖6.8~7.5mmol/L,评为优良。再经服药8月余,血糖尿糖值正常,行走自如,精神良好,大腿肌肉结实而丰满,腱反射正常。随访至今,病情稳定,评为远优。

【方名】 马钱子酒。

【组成】 制马钱子60g,当归60g,川牛膝60g,红花60g,乌梢蛇60g,蜈蚣60条,白花蛇2条。

【来源】 徐应坤,浙江中医杂志,1989,(6):256。

【功效】 温经散寒,活血通络。

【适应证】 多发性神经炎。

【方药简析】 本方药物共为粗末,水煎3次,合并滤液,浓缩至1500ml,兑入白酒1500ml。根据体质、年龄、病情不同,用量可以增减,但每日用量不能超过60ml。如服后出现轻度头晕,肌肉紧张,或关节一时性强直现象,为最佳治疗量,可逐渐减量。方中马钱子祛风散寒,通经活络,强筋壮骨,透达关节,鼓动诸药直达病所,故能一举荡其痼病而收显效,但应防马钱子中毒。对该酒的耐受量越大,疗效越差;耐受量越小,疗效越高。服药1个月左右,要服1次接近中毒量,疗效最佳。12岁以下儿童忌用,心脏病、高血压、严重肝肾疾病者慎用。当归、川牛膝、红花养血通络;乌梢蛇、蜈蚣、白花蛇通络祛风,共成温经散寒,养血活血,舒筋通络之方。徐氏用药酒精治疗末梢神经炎6例,均取得显著疗效。

【病案举例】 徐某某,男,55岁,四肢进行性瘫痪4年余。从1983年2月起,感觉手足指(趾)尖麻木,3个月后出现手套、短袜样感觉异常,有蚁走感,并逐渐向近端发展,继之四肢活动不灵活,软弱无力,肌肉萎缩,皮肤光滑变薄发冷,四肢腱反射初起减弱后消失,省级医院诊为重型多发性神经炎。中西医多方治疗,病情逐渐加重。1986年3月2日诊查,双上肢从指尖到肩部,不能自动抬举,伸屈不利,不能握物;大小鱼际、伸腕肌、指间肌均萎缩。双下肢从足趾尖向上扩展到脐平,远端肌肉萎缩,肌张力减低,不能站立和行动,生活不能自理。脉弦细,舌红,苔薄白。病属痿证,服用马钱子酒3个月,症状逐渐减轻,双上肢能抬举,伸屈较前有力,双下肢能在室内拄拐杖行走几步。连续服用至21个月,四肢活动明显好转,手套样、短袜样异常感觉消失,皮肤由薄变厚,余症均有改善,生活

炒白术各 10g,桂枝、炙甘草各 6g,党参、茯苓各 15g。连服 3 剂,可扶杖缓行,纳食亦增,后以上方略有增减,共服 10 剂而痊愈。

【方名】 加味桃红四物汤。

【组成】 当归 20g,川芎 10g,赤芍 15g,生地黄 30g,桃仁 15g,红花 15g,黄芪 30g,党参 30g,黄精 50g,枸杞子 20g。

【来源】 崔家英,实用中医内科杂志,1991,(2):25。

【功效】 活血化瘀,益气养阴。

【适应证】 糖尿病末梢神经炎。

【方药简析】 方中桃红四物汤加枸杞子养血活血,化瘀通络;黄芪、党参、黄精,补益养阴;其中生地、黄芪、黄精、枸杞子又有降低血糖功效。若烦渴多饮,多食易饥明显加玄参 30g、黄连 10g;若兼心烦热再加地骨皮 20g。崔氏用本方(每个病例服 1~6 个月,平均 3 个月;每周查 1 次尿糖,每 2~3 周查 1 次血糖)治疗糖尿病末梢神经炎 28 例,男 16 例,女 12 例。其中属 NIDDM 者 23 例,属 IDDM 者 5 例。患糖尿病 5 年以上者 22 例,不足 5 年者 6 例。治疗结果,痊愈(对称性肢体远端感觉异常、麻木、疼痛之症状全部消失,尿糖及血糖有明显下降,停药 3 个月以上无复发)15 例;显效(末梢神经炎症状基本消失,尿糖及血糖亦有明显下降)9 例;好转(末梢神经炎症状明显改善,但尿糖及血糖下降不理想)3 例;无效(临床症状及血、尿糖检查结果均无明显改善)1 例。

【病案举例】 麻某某,女,67 岁,1986 年 3 月 8 日初诊。患者于 2 年前出现双膝关节以下麻木,时有烧灼样疼痛,昼轻夜甚。近 2 个月病情加重,彻夜不能入寐,痛时下肢伴肿胀感。经用强痛定方可缓解,但片刻疼痛又发,兼见口干,口渴不多饮。查舌质暗红,苔少,脉细涩。双下肢皮肤色泽正常,双侧膝

7 肋间神经痛

肋间神经痛是肋间神经支配区内的疼痛综合征,其疼痛位于一个或几个肋间,多呈持续性疼痛,发作性加剧,常因深吸气或咳嗽、喷嚏而激发或使疼痛加剧。有时疼痛呈束带样,也可放射至同侧肩部和背部。相应的皮肤区可有感觉过敏和肋骨边缘压痛。本病多见于成年人,原发性少见,多数是继发性的,由胸腔疾病(胸膜炎、肺炎、主动脉瘤)、胸椎及肋骨外伤(继发骨痂形成骨肋炎、胸椎退行性病变、胸椎结核)、脊髓肿瘤及炎症和带状疱疹等引起。因带状疱疹引起者,相应肋间皮肤可有疱疹,但疼痛可在疱疹发生之前出现,在疱疹消失后存在相当长的时间,其主要病理是由于损伤、受压、炎症、代谢障碍,使肋间神经变性、缺血,刺激感觉纤维导致疼痛。典型表现是自胸椎沿相应肋间至胸骨呈半环形剧烈放射性疼痛,大多为一侧单支,或少数几支肋间神经痛;而双侧多支肋间神经则多为刺激或灼痛,呈持续性或阵发性发作,常伴有患病部位的肌肉痉挛。带状疱疹引起者,可有早期低热,全身不适等。检查患部胸椎棘突及旁突,肋间隙或腹壁压痛,根性痛者屈颈或压颈试验阳性,受累神经分布区感觉过敏减退,肌肉萎缩。本病的诊断主要是查找病因,排除肿瘤等疾病。但有时很难找出病因,多对症止痛,局部封闭,物理康复(紫外线、红外线、微波电、CO₂激光、直流电普鲁卡因或草乌碱离子导入、干扰电)疗法,达到镇痛目的,并可调整大脑皮层和植物神经系统功能,阻断由下丘脑下部通过交感神经系统向周围发出的兴奋,以

提高痛阈,并降低局部肌张力,调整血管舒缩功能,激发镇痛物质产生,抑制疼痛。本病须与心绞痛、胃溃疡、胆囊炎相鉴别。

本病属中医肋痛范畴,主要与肝胆有关,早期多为实证,治宜理气活血、清热化痰,可选用青皮、香附、佛手、川楝子、川芎、延胡索、丹参、当归、鸡血藤、桃仁、龙胆草、青黛、梔子、丹反、旋复花、半夏、南星等;久则精血亏虚,肝肾阴液不足,宜滋阴养血;同时避免理气药耗阴,不宜过量久用。

余志兵用四逆散加地龙、葶苈子治疗渗出性胸膜炎引起的肋间神经痛 32 例,治愈 20 例,好转 12 例;疗程最短者 36 天,最长者 90 天[湖北中医杂志,1992,(1):15]。

李宇俊用留针拔罐法,取穴:双内关、患侧阳陵泉和阴陵泉。患者仰卧,先用捻转进针法刺内关穴,待有感应后用提插法加大刺激量,使针感向上肢放散,同时令患者进行深呼吸。刺阳陵泉和阴陵泉用透刺法,从阳陵泉横刺向阴陵泉,一针二穴,待有感应后用捻转法加大刺激量,使针感上下传导。上述穴位刺毕,将针置于所刺穴位,每隔 5min 行针 1 次。最少者留 30min,最多者可留 60min 以上。取针后在患者疼痛最明显处,用碘酒棉球常规消毒,取梅花针由轻而重地叩刺,即刺到局部皮肤明显发红,并有微微出血的程度时,取一只大号火罐用投火法吸附于上,留 10~15min 待皮肤淤血呈紫红色时取罐。针刺每天 1 次,拔罐可 2 天 1 次,6 天为 1 疗程,休息 2 天后再根据病情的需要继续第 2 个疗程)治疗肋间神经痛 46 例,男 32 例,女 14 例;年龄最小者 19 岁,最大者 62 岁;病程最短者 7 天,最长者 1 年半,结果痊愈者(自觉疼痛完全消失,半年未复发)34 例;显效(自觉疼痛明显减轻,但用力尚有轻微疼痛)8 例;无效 4 例。痊愈者治疗次数最少者 2 次,最多者 12 次[云南中医杂志,1985,(4):33]。

【方名】 活络效灵丹。

【组成】 当归、丹参、乳香、没药等量。

【来源】 张锡纯《医学衷中参西录》

【功效】 活血祛瘀，通络止痛。

【适应证】 气血淤滞疼痛。

【方药简析】 方中当归养血活血止痛，丹参活血祛瘀，乳香、没药活血止痛，可佐以青皮、穿山甲、川楝子理气通络，提高止痛效果。除用于肋间神经痛外，还可用于宫外孕、冠心病、脑梗死、坐骨神经痛、盆腔炎等属气滞血凝者，蒋其学用本方加柴胡、郁金、瓜蒌皮、薤白，治疗肋间神经痛 36 例，临床治愈 26 例，显著好转 10 例[浙江中医杂志，1965，(12)：18]。

【病案举例】 李某某，男，24 岁，1962 年 10 月 5 日初诊。右胸有发作性疼痛 1 年以上，胸肋胀满不适，以手自行按摩后能缓解。某医院确诊为肋间神经痛，曾服中西药，局部封闭及离子透入等方法治疗，效果不明显。察脉弦滑，舌苔白腻。证属肝气横逆，治以疏肝理气。方用活络效灵丹加疏肝理气之品。处方：当归、丹参、乳香、没药各 15g，瓜蒌皮 12g，柴胡、枳壳、郁金、陈皮各 6g，薤白 9g。服 3 剂后，胸痛减轻过半，胀满感基本消失，脉略弦；原方去当归、丹参，再服 3 剂，胸痛全部消失，经观察 3 个月无复发。

【方名】 枳陈槟榔汤。

【组成】 枳壳 9g，陈皮 9g，槟榔 6g，木香 4.5g，小茴 4.5g。

【来源】 刘重明，中医杂志，1964，(9)：22。

【功效】 理气血散淤结。

【适应证】 肋间神经痛。

【方药简析】 方中枳壳、陈皮、木香理气疏肝，散结止痛；小茴、槟榔温通止痛。若外伤在胸部加桔梗宜散胸部淤结；伤在剑突下加丁香、肉桂辛热入脾胃和肝经，以散淤通气；伤在左肋部加郁金、刘寄奴、丹皮、红花行淤通络，伤在右肋部加砂仁、桑皮、百部行气降逆。挫伤较重加大黄、红花活血化淤。刘氏用本方治疗胸壁挫伤引起的肋间神经痛 60 例，男 50 例，女 10 例；年龄大多在 20~55 岁之间；受伤部位在胸部者 28 例，剑突下者 3 例，左肋部 16 例，右肋部 13 例；受伤到开始治疗前之病程日数在 1~5 天的 33 例，6~10 天的 15 例，11~20 天的 3 例，21 天以上的 9 例。其中 14 例曾采用局部封闭及服镇痛片，4 例经中医治疗，效果均不显著；另 42 例未经任何治疗。全部病例经上述方法治疗后，平均服药 2~6 剂后即告痊愈。一般早期治疗者，治愈快，反之则较慢。如胸部受伤而引起骨折或有严重胸腔内部症状及胸膜炎等则不易用本方。

【病案举例】 例一：某某，男性，26 岁，1963 年 3 月 5 日初诊。主诉：胸部被平车杆碰伤已 3 天，胸骨部压痛明显，但无固定压痛点，无骨折现象，局部无肿胀，咳嗽呼吸时疼痛加重，别无不适。诊断为胸壁挫伤。治疗用上方加桔梗 9g，服 2 剂而愈。

例二：某某，男性，28 岁，于 1963 年 11 月 5 日由 3 米高处摔下，左肋部受伤，经某中医诊断为气血郁滞，内服中医乳香、自然铜、桃仁、红花等 9 剂未愈。于 17 日转骨科门诊检查：左侧 7~8 肋处压痛明显，咳嗽深呼吸均痛，局部无肿胀及骨折现象。诊断为左侧胸部肋间神经痛。用上方加郁金、刘寄奴，服 4 剂而愈。

【方名】 瓜蒌薤白四逆散。

【组成】 酒炒薤白 9g，瓜蒌皮 9g，白芍 9g，柴胡 45g，炒

枳壳 45g,炙甘草 45g,郁金 4.5g,桃仁 6g,香附 6g。

【来源】 汪慎之,浙江中医杂志,1964,(6):16。

【功效】 疏肝理气,活血定痛。

【适应证】 肋间神经痛。

【方药简析】 本方由瓜蒌薤白白酒汤合四逆散而成。方中以薤白通阳逐秽,解痉止痛,柴胡疏肝解郁为君;白芍和血止痛,香附调气止痛为臣;瓜蒌清热涤痰,桃仁活血化淤,枳壳利气宽胸,郁金行气破淤为佐;甘草甘缓和中为使,白酒助药力以上行直达病所,使气血通畅,痛自能定。肋痛甚者,酌加川楝子、独活 9g、香白芷 6g、青橘叶 4.5g;痛剧者,加乳香、没药各 3g;淤血停蓄者,加刘寄奴 6g、红花 3g;咳嗽者,加杏仁、炙苏子各 6g。汪氏用上方治疗肋间神经痛 50 例,男 43 例,女性 7 例;年龄在 18~60 岁之间,18~30 岁(23 例),31~40 岁次之(16 例),41 岁以后逐渐减少(41~50 岁 8 例,51 岁以上 3 例)。在发病 1 月前后曾有负伤史者 10 人,有用力过猛史者 8 人,有其他劳伤史者 8 人,有情绪刺激史者 11 人,无特殊病史可述者 13 人。此外并有咳嗽者 7 人。左侧疼痛者 30 人,右侧疼痛者 15 人,双侧疼痛者 5 人。治疗结果肋间神经痛症状全部消失。其服药后症状消失天数:计 3 剂者 6 例,4 剂者 2 例,6 剂者 14 例,8 剂者 6 例,平均 4.8 剂强,有 5 例在 3 个月后复发,仍用原方见效。

【病案举例】 夏某某,女,53 岁,1963 年 7 月 1 日初诊。患者左乳房上部第 2~4 肋骨疼痛,呼吸时加剧,并伴有头胀,纳呆已有 1 周,起病前 3 周,曾有拼伤史,痛作时经厂医务室治疗无效,介绍至某医院 X 线透视无特殊发现,诊断为肋间神经痛(劳损性),给予优散痛及维生素 E,口服 2 天,未见减轻,来本院中医治疗。初因劳动拼伤气分,继则无形之厥气,与有形之湿痰交阻,清阳之气不宜,肋痛偏右,转侧不利,甚至屏

息不敢作深呼吸,胸闷,纳少,舌苔薄白,脉濡数。治拟疏肝通络,滑利气机。处方:酒炒薤白、炒瓜蒌皮、白芍各 9g,柴胡、炒枳壳、炙甘草、郁金各 4.5g,桃仁、制香附、白芷各 6g。2 剂疼痛显著减轻,4 剂,肋痛消失。

胸、压颈静脉试验及拉赛格征阳性,可有 L₅、S₁ 分布的感觉减退,跟腱反射减低或自觉小腿及足背外侧有针刺和烧灼感。干性者臀部以下的环跳穴、委中穴、承山穴,及内踝后点处压痛明显,颈胸、压颈静脉试验阴性;坐骨神经支配区的肌肉松弛,轻度肌萎缩,跟腱反射也常减低或消失,肌张力低下,下肢无力。坐骨神经痛应与腰肌劳损,梨状肌综合征,髋关节炎,间隙性跛行证相鉴别。

坐骨神经痛属于中医痹证及腰痛范畴,其病因病机是素体正气不足或突然弯腰用力过度,加之居住潮湿,涉水冒雨,气候剧变,冷热交替,风寒湿邪乘机侵袭经络关节,痹阻气血而为痹证,日久成为顽痹。本病多虚实夹杂,病性常易转化,临证宜灵活辨析。首先是对因治疗,纠正腰椎间盘突出,积极处理原发病;二是依据经络痹阻病机,在辨证(肝肾亏虚用独活寄生汤,血虚用当归四逆汤,气虚用补中益气汤,疼痛剧烈用张氏变通三痹汤,气虚血瘀用补阳还五汤,化热用重剂白虎汤,外伤用桃红四物汤)基础上,选用善于走窜筋骨经络的全蝎、蜈蚣、地鳖虫、白花蛇活血通络止痛,酌择马钱子、威灵仙、老鹳草、白龙须、鲜鸡尿藤增强疗效;三用牛膝、杜仲、补骨脂、续断补益肝肾,强壮筋骨;四是应用止痛药,因坐骨神经痛以根性疼痛最为多见,其疼痛剧烈有时难以忍受,故多用乌头、附子镇痛祛痹,先从小剂量开始,逐渐加量,以知为度或得效后递减。乌头须先煎 3h,附子先煎 2h,至毒性基本消失(口尝至舌间无麻木感为度),而有效作用不致破坏。另外,当其拘急痛甚之时,亦不可滥用驱风燥湿之剂,以免伤津劫液,亦不必用乳香、没药、延胡索等止痛之品,当重用白芍、炙甘草,则拘急掣痛可解。曹志刚用桂枝 500g,当归 250g,丹参 250g,乳香 250g,没药 250g,全蝎 250g,蜈蚣 100 条。共研细末,过 100 目筛子,水酒各半泛为绿豆大,每次 6~9g,每日 3~4 次;治疗

志,1990,(1):17]。

萧永俭等用头针(于头部取患侧的对侧感觉区,在其上点常规消毒后,将两寸毫针从该处刺入,向下点方向沿头皮下进针1.5~2寸,动作应轻柔,以防弯针而不利捻转,然后快速捻转,200次/min以上,5min捻转1次,两次间休息5min,第3次捻转完毕后起针,此为一次治疗)治疗坐骨神经痛4例,2例为腰椎间盘突出,2例为坐骨神经炎,均治愈[山东中医杂志,1990,(2):22]。

巫德芳以补阳还五汤(黄芪50g,当归10g,赤芍10g,桃仁9g,红花9g,地龙9g,桂枝10g,川牛膝12g,五加皮15g,僵蚕9g,防风10g,制马钱子2g)为基础方,将坐骨神经痛分为3型,风寒性型重用桂枝;郁热阻络型加知母、黄柏、秦艽;瘀血阻络型加骨碎补、丝瓜络。10天为1疗程,休息2~3天后再服,一般3个疗程即可。共治疗坐骨神经痛31例,痊愈15例,显效6例,好转如常10例[四川中医,1986,(9):44]。

【方名】 蠲痹汤。

【组成】 羌活10g,独活10g,桂心10g,秦艽10g,当归10g,川芎10g,炙甘草3g,海风藤10g,桑枝15g,乳香6g,木香6g。

【来源】 程钟龄《医学心悟》。

【功效】 祛风除湿,散寒止痛。

【适应证】 风寒湿痹。

【方药简析】 本方是古今诊治痹证的首选方,临证可依据病机及风寒湿邪偏颇而择药量,灵活加减。方中羌活、独活、桂心祛风散寒兼以除湿为君;海风藤、桑枝、川芎、当归、乳香活血散瘀,通络止痛为臣;秦艽为佐,一助君药祛风除湿,二伍当归、羌活、独活、桂心、川芎辛燥太过而耗血生热;木香、炙甘

草为使,理中和胃,兼调诸药。因祛湿药较少,故程氏在方后特注加防己、萆薢、薏苡仁除湿健脾祛着痹。风气胜更加秦艽、防风;寒气胜加附子,湿气胜加防己、萆薢、薏苡仁;寒久变热去桂心、黄柏。本方除用于坐骨神经痛外,还可用于风湿性关节炎,类风湿性关节炎,系统性红斑性狼疮等。江淑安用上方为主,症状重者每日两剂,分4次温服,药后覆被,以遍身微微出汗为佳;10剂为1疗程。风邪偏胜加防风,寒邪偏胜加制川乌、细辛,湿邪偏胜加防己、薏苡仁,伴腰痛加杜仲、桑寄生、白芍;同时配合当归注射液作痛点或肌肉注射。共治疗坐骨神经痛59例,结果痊愈39例,好转19例,无效1例;总有效率98%。治疗时间最长118天,最短时间10天。

【病案举例】 刘某,男,54岁,1982年1月17日住院。因睡地铺,几天后,突然出现右侧腰及下肢酸胀疼痛,伴肢体沉重麻木,屈伸不利,步履艰难,舌苔白,脉弦紧。证属风寒湿痹,治以程氏蠲痹汤,并配合环跳、承山处拔罐,10天后痊愈出院[国医论坛,1986,(4):29]。

【方名】 当归四逆汤。

【组成】 当归 10g,芍药 15g,细辛 6g,通草 9g,桂枝 12g,甘草 5g,大枣 3枚。

【来源】 张机《伤寒论》。

【功效】 温经散寒,养血通脉。

【适应证】 血虚受寒,血滞寒凝之痹证。

【方药简析】 方中当归、芍药为君,养血活血通络;桂枝、细辛温经散寒止痛;通草为佐助君活血通络;甘草、大枣调和诸药,补益脾胃,使药物之精华充分吸收。本方病机为寒袭血滞,流行不畅,故而手足厥冷疼痛,有人提出本方方名四逆,当有附子、干姜,若有附子则治疗坐骨神经痛偏寒血虚者更为合

拍,因附子与细辛共用止痛效果更佳。本方还常用于治疗血栓闭塞性脉管炎及冻疮。喻书安用当归四逆汤为基础方治疗原发性坐骨神经痛,加木瓜、牛膝、伸筋草、丹参、鸡血藤;偏寒加川乌、草乌、附子,偏湿加苍术、防己,偏风加防风、威灵仙;病久痛剧,瘀淤交阻加桃仁、红花、五灵脂、丹参、穿山甲、乳香、没药;伴腰痛及椎旁点明显压痛加狗脊、续断、杜仲、枸杞子、桑寄生、巴戟天、淫羊藿、地鳖虫;气虚加黄芪、党参。治疗本病取得较好疗效[云南中医学院学报,1980,(4):37]。

【病案举例】 樊某,男,57岁,1993年12月20日就诊。自述煤矿井下作业20年,5年前巷道冒水,水深齐腰,后发生“坐骨神经痛”,经针灸治疗后好转。此后每因劳累、着冷均可使腿痛加重。近20天来右腿疼痛日剧,活动受限,不能抬腿并引及右半侧腰痛,每于咳嗽、打喷嚏可使右腿痛不可忍。查体:第四、第五腰椎右侧压痛明显,腰肌紧张,右下肢拉赛格征阳性;X线拍片“腰椎骨质增生”。舌苔薄白,脉沉细,诊为“腰椎骨质增生”、“继发性坐骨神经痛”。属寒凝血淤,投当归四逆汤合大黄附子汤加味。当归10g、桂枝10g、白芍24g、细辛5g、木通3g、炙甘草5g、附子10g、大黄3g、鸡血藤30g、牛膝10g、大枣5枚。每日1剂,服10剂腰痛明显减轻,继服10剂而痊愈[马波,河南中医,1996,(5):287]。

【方名】 曲直汤。

【组成】 山茱萸30g,知母9g,乳香9g,没药9g,当归15g,丹参15g。

【来源】 张锡纯《医学衷中参西录》。

【功效】 养肝清热,活血止痛。

【适应证】 肝血虚疼痛。

【方药简析】 山茱萸、当归滋阴养血补肝,知母清热,当

归、丹参、乳香、没药疏通经络，流通气血，而止热痛。下肢发凉加附子、肉桂去知母，痉挛抽痛加全蝎、蜈蚣、芍药，阴雨寒冷加剧加独活、威灵仙，气虚加黄芪，腰痛加杜仲、桑寄生。

【病案举例】 仲某某，男，41岁，1984年9月26日。腰痛及右下肢疼痛半年，检查右臀部环跳穴处压痛明显，右下肢拉赛格征阳性（30度），舌淡红，苔薄白，脉沉细。诊为坐骨神经痛，曲直汤加减。山茱萸 30g、当归 15g、丹参 15g、乳香 9g、没药 9g、知母 9g、杜仲 15g、桑寄生 15g；10月5日复诊，服5剂后症状基本消失，因公务繁忙未来就诊，近2日右下肢在跑步后微有疼痛，拉赛格征近90度时微有疼痛，照原方加五加皮 15g，又连服5剂而愈，随访至今未复发〔应励，四川中医，1986，（9）：44〕。

【方名】 当归四逆桃红饮。

【组成】 当归 25g，白芍 25g，桂枝 20g，川芎 20g，细辛 2g，红花 10g，牛膝 30g，威灵仙 20g，白芷 15g，龙胆草 20g，甘草 10g，大枣 10枚。

【来源】 刘俊杞，河南中医学院学报，1980，（4）：45。

【功效】 温经散寒、养血通脉，活血化淤，祛风除湿。

【适应证】 坐骨神经痛。

【方药简析】 本方是当归四逆汤和《济生方》中桃红饮加减而成，疼痛严重者加乌头、草乌；病程短为行痹加秦艽、羌活、独活；病程长偏血淤加赤芍、丹参、五灵脂、穿山甲、乳香、没药；伴腰痛及脊椎旁点明显压痛加狗脊、续断、杜仲、枸杞子。刘氏用本方共治疗14例，痊愈12例，显效2例，最少服6剂，最多服40剂。

【病案举例】 杜某某，男，38岁，1976年9月就诊。1975年5月1日骑车返里，汗出当风，又用冷水冲洗双腿后腰及左

患者右下肢疼痛三月余,当地治疗效差,疼痛反甚不可忍受,右下肢不能屈伸,稍动即嗷嗷不止,他人搀扶才能跛行。检查拉赛格征阳性,其疼痛点立即从臀部向下至脚背放射,如电掣一般;舌红苔薄。诊为坐骨神经痛,中医辨证寒湿入侵,筋脉痹阻。用桂枝芍药知母汤基本方,7剂水煎服。药服完后,能下床跛行上厕所;药已中病,仍遵上方,麻黄减至4g,加鸡血藤30g、木瓜20g。继服7剂后,疼痛基本消失,行走100m后略感臀部微痛。随宗上方继服7剂,症状消失,行走如常,病告痊愈,随访1年未见复发[湖北中医杂志,1989,(4):18]。

【方名】 芍药五藤汤。

【组成】 白芍、海风藤、宽筋藤、络石藤、鸡血藤、石南藤各30g,威灵仙20g,入地金牛、延胡索各15g,甘草12g。

【来源】 卢桂梅,新中医,1994,(12):34。

【功效】 祛风活络,补益肝肾,散寒止痛。

【适应证】 坐骨神经炎,腰椎肥大性骨质增生。

【方药简析】 本方实为芍药甘草汤加藤类药组成,白芍、甘草养血和阴,缓急止痛;藤类药祛风湿,舒筋活络;鸡血藤、威灵仙活血通络止痛;入地金牛祛风消肿止痛,延胡索镇静镇痛;其药渣复煎外洗患肢。腰痛加桑寄生30g,杜仲、骨碎补各15g;下肢疼痛甚而又偏寒加木瓜15g、乌头(先煎)6g;如风湿热痛加桑枝、薏苡仁各30g,黄柏15g。卢桂梅用本方治疗坐骨神经痛52例,显效38例(疼痛完全消失1年以上未发作),好转12例,总有效率96.1%,最短7天,最长92天,平均21天。

【病案举例】 例一:张某,男,60岁,因腰部疼痛20多天,于1986年11月20日住院。既往有腰痛史,患者左下肢持续性钝痛,阵发性加剧,疼痛从腰部及臀部沿大腿后侧、小腿后外侧向足背部放射,活动多在夜间安静时痛甚,彻夜难眠,

左下肢活动障碍,腰椎侧弯,拉赛格征阳性,左膝反射减弱,腰椎骨质增生;舌淡红,苔薄白,脉弦细。诊断:根性坐骨神经痛,中医辨证肝肾两虚,阴血不足,外受风寒湿邪,寒湿血淤阻滞经络,筋脉失养。上方加桑寄生 30g、乌头 6g、杜仲 15g。药渣外洗,药后疼痛减轻,夜间能安睡;再照上方加党参、牛膝。7剂后腰腿疼痛基本消失,又进 10 剂,诸症消失,功能活动正常出院。随访 3 年未复发。

例二:李某,男,45 岁,1991 年 3 月 12 日来诊。主诉右下肢从臀部至小腿疼痛 1 周,走路跛行,既往有关节疼痛病史,受凉加剧,拉赛格征阳性,坐骨神经通路上有压痛点,口苦干不引饮,舌红,苔白腻,脉弦滑数。诊为干性坐骨神经痛,中医辨证风湿热邪流阻经络,痹阻不通;原方加薏苡仁、黄柏,同时外洗患肢;4 剂后疼痛明显减轻,再服 7 剂疼痛消除,自觉疲乏,胃纳欠佳,照上方减甘草用量,加麦芽、茯苓调理,5 剂而愈。随访 2 年未复发。

【方名】 四生丸。

【组成】 僵蚕 10g,白附子、草乌各 9g,地龙、五灵脂各 15g。

【来源】 陈自明《妇人大全良方》。

【功效】 祛风散寒,活血通络。

【适应证】 腰椎增生,风湿病,椎管狭窄及腰椎间盘突出引起的坐骨神经痛。

【方药简析】 方中白僵蚕、白附子、草乌祛风化痰,散寒除湿,宣痹止痛;地龙、五灵脂清热通络,活血止痛。患肢冷痛,遇风冷加重,得热则舒加桂枝 10g、乌头 9g;腰及双下肢酸软无力加仙灵脾 15g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、金毛狗脊 10g;心悸气短加黄芪 15g、党参 10g、白术 10g;下肢沉重,行走不利,

藤、木瓜、白芍、牛膝、鹿衔草活血通络，缓急止痛。久病入络加蜈蚣 2 条、全蝎 10g；挟风湿加制草乌 10g、乌梢蛇 30g；若久郁化热或素体阳盛湿热下注去桂枝，附子减为 1/10 量，加黄柏 30g、桑枝 30g、知母 30g、沙参 30g；气血两虚加黄芪 30g、当归 15g、党参 30g。每日 1 剂，严重者可加至 2 剂，3 周为 1 疗程。也可研末，炼蜜为丸，每次服 8~12g，每天 3~4 次。黎氏用本方配合振颤按摩，气功点穴，针灸治疗法共治疗坐骨神经痛 48 例，基本痊愈 18 例，好转 10 例，有效 12 例，总有效率 83.4%。

【病案举例】 曹某，女，76 岁，1987 年 12 月 3 日初诊。主诉左下肢沿坐骨神经走向呈放射性、闪电样疼痛，动则更剧，经常腰痛，转侧不利，俯仰艰难 3 年余。遂经多方治疗，疼痛不减，住院治疗 3 月余，反见疼痛症状加重，骨节胀痛，不敢屈伸，触之如刺如裂，苦不堪言，曾连续 72h 不寐。足软，不能久立或步履，腰及下肢常觉冷感，精神不振，气短乏力，腰膝酸软，头晕眼花，面色萎黄，舌淡有淤斑，苔薄白，脉沉细。诊为坐骨神经痛，中医证属脾肾阳虚，气滞血淤，筋骨失养。投坐骨舒加红参 15g、蜈蚣 4 条、巴戟天 40g、仙灵脾 40g、杜仲 40g，7 剂；结合气功点穴，着重运气点按环跳、阿是等穴，强刺激，疼痛稍减缓时即在患处施行振颤按摩，以平衡整体经络功能，激发经络活力，调畅气血。10 日二诊，疼痛大减，能翻身、屈腿，晚间可安然入睡；效不更方，上方再进 7 剂，点穴按摩改为膀胱经、肾俞、三阴交穴等为主，着重补益脾肾。17 日三诊，患者已能下床移步，疼痛基本消失。继上法治疗，2 个月后行走自如。嘱服金匱肾气丸、补中益气丸等善后。随访至今未见复发。

【方名】 祛寒宣痹汤。

【组成】 川乌 6g，细辛 6g，全蝎 10g，蜈蚣 5 条，制乳香

10g,制没药 10g,苍术 10g,独活 10g,川牛膝 15g,当归 10g。

【来源】 吴士丁,河北中医,1992,(2):13。

【功效】 祛寒宣痹,活血通络。

【适应证】 坐骨神经痛。

【方药简析】 方中川乌、细辛祛寒宣痹止痛;全蝎、蜈蚣搜风通络止痛;苍术、川牛膝、独活祛湿;乳香、没药、当归活血化淤。气虚加黄芪 30g,肾虚加淫羊藿 15g,湿重加薏苡仁 30g。吴氏用本方治疗坐骨神经痛 54 例,结果痊愈 28 例,有效 22 例,无效 4 例;总有效率 92.6%。

【病案举例】 米某,男,34 岁,1988 年 1 月 6 日诊。患者 3 月前因居住潮湿出现左腰背部酸疼,左下肢呈放射样灼痛,自臀部沿大腿后面、腘窝放射至小腿外侧,自觉下肢冷凉沉重,得热则舒。西医诊断为坐骨神经痛,曾服激素、抗风湿药物治疗病情无好转,要求中医治疗。舌质淡,苔白滑,脉象沉涩;此为寒湿内侵,气血不畅,脉络痹阻所致。治以祛寒除湿,活血通络。处方:川乌 6g,细辛 6g,全蝎 10g,蜈蚣 5 条,制乳香 10g、制没药 10g,苍术 12g,独活 10g,川牛膝 15g,当归 10g,薏苡仁 30g。5 剂后复诊,左侧腰痛减轻,下肢仍有轻度放射疼痛,自觉下肢温暖,舌脉同前。守上方续服 20 剂诸症消失。随访 1 年未见复发。

【方名】 鹿马丸。

【组成】 鹿角胶 60g,川牛膝 40g,狗脊 40g,麋虫 40g,制马前子 3g。

【来源】 曾庆佩,实用中医内科杂志,1993,(3):31。

【功效】 温补肝肾,活血通络,散寒止痛。

【适应证】 坐骨神经痛。

【方药简析】 方中鹿角胶、狗脊补肝肾、固根本;川牛膝、

马前子温筋脉、祛寒湿；麝虫破淤通络，并借牛膝之力引药下行，直达病所，使筋脉通和，气血畅行，而疼痛自止。药理研究证实，马前子具有兴奋中枢神经，促进血液循环的作用。曾氏用本方（除鹿角胶外，其余药物烘干，共研细末，过筛；鹿角胶烊化，加蜂蜜适量，文火煎浓，加入药粉调匀，制丸如绿豆大，每次 6g，每日 2~3 次，连服 10 日为 1 疗程）治疗坐骨神经痛 54 例，男 40 例，女 14 例，年龄 22~80 岁；发生在双下肢 4 例，单下肢 50 例，有 42 例为左下肢。服鹿马丸 1 疗程者 14 例，2 疗程者 24 例，3 疗程者 10 例，4 疗程者 4 例，5 疗程者 2 例；其中服 1~3 疗程者共 48 例。结果痊愈 30 例，基本痊愈 12 例，有效 10 例，无效 2 例；总有效率 96.3%。其症状消失时间平均为 11.3 天，比普通疗法的复原时间 6~8 周大大提前。本方中马前子有大毒，需用细砂拌炒至棕褐色，刮干净毛绒，方可入药。孕妇及对鱼虾过敏者，不宜应用。

【病案举例】 刘某，女，51 岁。患左侧坐骨神经痛 3 年，1989 年 6 月严重发作，经某医院肌注维生素 B₁、维生素 B₁₂，口服激素、安络痛、布洛芬及中药 20 余剂，针灸、穴位注射、电磁波照射等治疗月余无效，于 8 月 27 日来我院就医。患者表情痛苦，左手撑腰，由他人搀扶，7 年前曾有“闪腰”病史。查体：腰椎左侧弯，第 5 腰椎左旁、左臀部、腘窝及腓肠肌等处压痛，直腿抬高试验阳性；舌质紫黯，苔腻，脉象濡缓。诊断：坐骨神经痛。即以鹿马丸口服，服至第 3 天疼痛大减，食欲增强，夜间能安静入睡；第 5 天疼痛消失，精神振作；第 7 天即能下地劳动。共服本方 3 个疗程，迄今 3 年未复发。

【方名】 黄芪桂枝三七汤。

【组成】 黄芪 60~90g，桂枝 6g，三七 6g，独活 9g，牛膝 20g，杜仲 15g，续断 15g，乌梢蛇 12g，当归 10g，白芍 30g，秦

羌 10g, 防风 9g, 桑枝 15g, 薏苡仁 30g, 甘草 6g。

【来源】 刘天海, 广西中医药, 1991, (3): 103。

【功效】 温经通脉, 散寒除湿。

【适应证】 坐骨神经痛。

【方药简析】 方中重用黄芪补脾益气; 当归、白芍养血活血, 配三七破瘀阻兼止痛; 桂枝、桑枝、薏苡仁、秦艽、独活、防风、乌梢蛇温通筋脉, 祛寒除湿; 佐以杜仲、续断、牛膝、白芍补益肝肾, 强筋壮骨, 而引药下行; 甘草调和诸药。辨证属寒者加熟附子 12g, 桂枝加至 12g; 气虚明显者加党参 20g, 黄芪加至 90g; 血虚加鸡血藤; 湿热重者加黄柏 9g; 疼痛剧烈者加乳香 6g, 没药 6g。刘氏用本方配合穴位注射和针灸推拿治疗坐骨神经痛 36 例, 其中 14 例配合穴位注射当归针、维生素 B₁₂, 2~3 天注射 1 次。主穴: 环跳、委中、阳陵泉, 辅穴: 肾俞、殷门、承山、悬钟、昆仑。10 例配合针灸推拿, 针灸以疏导经气为治则(同时配合穴位注射)。一般采用泻法, 对慢性反复发作者, 采用平补平泻法, 属寒者配合灸法。疼痛消失, 大腿活动自如后(即临床症状消失), 均口服吉林产人参再造丸 20~30 丸, 每日早晚各服 1 丸, 以防复发。结果 36 例全部治愈, 用药时间最长 35 天, 最短 8 天, 平均 24 天。

【病案举例】 林某, 男, 27 岁, 1983 年 5 月 17 日就诊。自述突然右腿针刺样疼痛, 从臀部直至足底, 酸胀麻木, 屈伸不利, 行走困难, 下蹲大便疼痛加剧。诊见神情苦楚, 舌质淡, 苔薄白, 脉弦。检查腰部无压痛点, 右侧臀部、大腿后侧和腓肠肌压痛明显, 直腿抬高试验阳性。诊断为右侧坐骨神经痛; 中医辨证为寒湿阻络之痛痹。处方: 黄芪 60g, 桂枝 6g, 三七 6g(冲服), 独活 9g, 牛膝 20g, 杜仲 15g, 续断 15g, 乌梢蛇 12g, 当归 12g, 白芍 30g, 秦艽 10g, 防风 9g, 桑枝 15g, 薏苡仁 30g, 甘草 6g。3 剂后, 精神好转, 疼痛减轻, 余症同前; 药已对证, 守前方

再服 5 剂，右腿痛消失，行走正常，屈伸自如，直腿抬高试验阴性；嘱其服吉林人参再造丸 20 丸，每日早晚各 1 丸。随访 4 年未复发。

9 梅尼埃病

梅尼埃(美尼尔)病又称内耳眩晕症,是植物神经功能失调等原因导致迷路动脉血管痉挛,膜迷路积水、水肿引起的以发作眩晕、波动性听力减退及耳鸣为主要表现的内耳疾病。本病确切原因目前尚不明确,可能是血管运动神经功能失调,导致迷路动脉痉挛,发生局部供血不足或内耳毛细血管渗透性增加,继而使内淋巴产生过多或吸收障碍,导致迷路水肿及内淋巴系压力增高。本病大多数于中年起病,男性略多于女性;起病急骤,反复发作。

梅尼埃病的典型表现为发作性眩晕,波动性听力减退及耳鸣。眩晕常为突然发作,为外境或自身在旋转或摇晃的运动错觉;严重时多伴恶心呕吐,面色苍白,出汗等迷走神经刺激症状;并出现持续时间较短的眼球震颤。每次晕眩发作持续数分钟、数小时或数天不等,但多数于2天内逐渐缓解。平时常有一侧性听力减退与耳鸣,眩晕发作时耳鸣加剧且听力进一步减退,发作后听力可有部分恢复,但难以恢复到原来水平。听力检查呈现典型的感音性耳聋,且有复聪现象。眩晕发作频繁程度不一,多数为数日或数月发作1次,亦有1周多达数次者。眩晕的发作往往随耳聋的加重逐渐减少,至完全耳聋,病侧迷路功能丧失,眩晕发作常亦终止。本病在发作间隙期检查大多数病人有感音性听力减退;前庭功能冷热水试验,提示功能减退,甘油试验阳性。本病的诊断比较明确,但一定要注意有无眼球震颤,必要时请耳鼻喉科会诊。并需和梅尼埃综合征

相区别,梅尼埃综合征可由炎症、出血、外伤及耳硬化症等内耳疾病及前庭神经元炎(眩晕常常于上呼吸道感染后骤然发作,闭目难立征阳性,无耳鸣或耳聋,听力正常)、内听动脉供血不足,小脑桥脑角肿瘤等引起,虽然其眩晕感觉类似,但病因不同,在病因未确定之前,统称为梅尼埃综合征。在急性发作期,应卧床休息,半流质饮食。恶心呕吐明显者,应注意水电解质平衡及营养。发作时间长,症状较重者,可予镇静剂、安定剂、止吐剂和血管扩张药物。发作间隙期可用中药调理。若发作频繁,眩晕严重,药物治疗2年以上仍不能控制其发作者,可施行手术,以消除病理性刺激性的前庭冲动或使其不能传入中枢。

梅尼埃病属中医眩晕、呕吐的范畴,主要是风、火、痰、淤上犯清窍或衰耗精血,清窍失养所致;其病位主要在内耳,与肝脾肾有关,病性属本虚标实,以脾肾亏虚为本,风、火、痰、淤为标。临床辨治一般分为风阳上扰用天麻钩藤饮加减,痰浊中阻用半夏白术天麻汤加减,阳虚水泛用真武汤加减,气血亏虚用补中益气汤加减,淤血阻络用通窍活血汤加减。可配合体针、耳穴、头针以加强疗效。魏传余将梅尼埃综合征分为痰热上逆型,眩晕呕恶,吐涎色黄,心悸不眠,胸闷脘痞,口苦尿黄,舌尖红,苔黄腻,脉滑数为辨证要点。方用黄连温胆汤加菊花、钩藤。若口渴喜饮,热象明显加胆南星、黄芩;面赤目红加白芍、龙齿。肝胆虚寒型:眩晕呕逆,头痛,吐涎沫,甚者头顶冷痛,舌淡苔白,脉沉细为辨证要点。方用吴茱萸汤加姜半夏、茯苓、花椒。若涎冷量多加干姜、灶心土;头顶冷痛明显加藁本、细辛。邪郁少阳型:头目眩晕,口苦咽干,往来寒热,胸胁苦满,脉弦细为辨证要点。方用小柴胡汤加钩藤、天麻。若头晕兼前额痛加白芷、蔓荆子;头晕兼两侧头痛加夏枯草、细辛;头晕兼盗汗加龙齿、五味子;头晕兼肢麻加白芍、石决明。痰(饮)蔽清阳

型:头痛眩晕,昏重如蒙,呕恶涎多,苔白滑腻为辨证要点。方用半夏白术天麻汤加川芎、蔓荆子。若痰多脘冷加干姜、吴茱萸;形寒肢冷,耳鸣耳聋加仙茅、淫羊藿、韭子、巴戟天。阳虚水逆型:眩晕,身瞤动,振颤欲倒,腰膝酸软,畏寒肢冷,舌淡胖有齿痕,苔白润,脉沉弱为辨证要点。方用真武汤加巴戟天、淫羊藿。若咯清稀白痰或呕清稀冷涎加干姜、吴茱萸、姜半夏;短气乏力,耳鸣耳聋加补骨脂、黄芪。共治疗 68 例,男 26 例,女 42 例;年龄最小 16 岁,最大 52 岁;病程最短 3 天,最长 8 年。结果治愈(眩晕症状消失,无平衡障碍)47 例,好转(眩晕症状减轻)15 例,无效 6 例,总有效率 91.18%[实用中医内科杂志,1992,(4):14]。

杨大俊等用梅尼煎,处方:当归、生地黄、牛膝、柴胡、法半夏、茯苓、黄芩、酸枣仁、菊花、蝉蜕、白术、路路通各 9g,山药、桃仁、红花、陈皮、黄连各 6g,川芎、白芍、枸杞子、木通、泽泻、竹茹、麦冬、车前子、女贞子、五味子各 12g,芦根、天麻各 15g,生姜 3 片;5 日 1 疗程。治疗梅尼埃病 35 例,同时配合眩晕停 50mg,每日 3 次。结果治愈 19 例,好转 15 例,总有效率 97.15%[中西医结合杂志,1988,(8):475]。

王俭用五苓散(茯苓 20g,白术 15g,桂枝 20g,泽泻 20g,猪苓 12g)加味治疗梅尼埃病 60 例,女 42 例,男 18 例;年龄最大 66 岁,最小者 10 岁;病程最短者 2 天,最长者 8 年;首次发病者 30 例,一个月发作 3 次以上者 20 例。结果全部治愈,服药最少者 2 天,最多 45 天;初发者经 1~5 年随访无 1 例再发,反复发作者都随访 1 年未发作者 18 例,1 年发 1 次者 3 例,5 年未发作者 8 例。再发作者发作时症状轻微,持续时间短,再服本方仍有防治作用。其机制可能是促进血液循环,减少内淋巴生成,消除膜迷路水肿;或调节植物神经功能,解除内耳毛细血管痉挛,或镇静安神[中西医结合杂志,1986,

(5): 303]。

董风增等用晕得宁(白术 12g, 苍术 10g, 陈皮 10g, 泽泻 10g, 半夏 10g, 神曲 10g, 茯苓 10g, 女贞子 10g, 甘草 6g, 共制成 22 片; 每次 5~7 片, 每日 3 次, 6 日 1 疗程) 治疗梅尼埃综合征 330 例, 男 129 例, 女 201 例; 年龄 7~77 岁, 其中 21~50 岁者 260 例; 眩晕者 330 例, 耳鸣者 285 例, 耳聋者 191 例, 恶心 273 例, 呕吐 189 例, 失眠 120 例, 眼震 114 例, 耳闷 132 例, 耳痛 19 例。结果治愈 142 例, 好转 181 例, 总有效率 97.9%; 疗程最短者 3 天, 最长者 12 天[中西医结合杂志, 1990, (1): 55]。

王淑波用温胆汤加味(制半夏、陈皮、黄芩、竹茹、白术各 10g, 泽泻、钩藤各 15g) 治内耳眩晕症 52 例, 男 10 例, 女 42 例; 年龄 16~55 岁, 病程 3 天~23 年。结果痊愈 48 例, 好转 3 例, 无效 1 例[广西中医药, 1986, (2): 20]。

王祖柏辨证治疗内耳眩晕症 121 例, 男 21 例, 女 100 例, 年龄 11~69 岁, 病程 28 天~22 年。痰湿型 72 例用苓桂术甘汤加味(茯苓 30g, 桂枝 4g, 白术 15g, 甘草 6g, 半夏 10g, 天麻 10g, 生龙骨、生牡蛎各 18g); 风眩型 49 例用天麻钩藤饮加减(天麻 10g, 钩藤 10g, 石决明 15g, 牛膝 10g, 杜仲 10g, 桑寄生 10g, 夜交藤 10g, 栀子 10g, 黄芩 10g, 益母草 10g, 茯苓 12g), 同时用维生素 B₆ 静脉滴注, 结果全部治愈, 3 剂治愈者 104 例, 5 剂治愈者 7 例, 6 剂治愈者 9 例, 8 剂治愈者 1 例[广西中医药, 1989, (2): 18]。

张爱玲用晕平汤(桑叶 10g, 白菊花 6g, 防风 6g, 白芷 5g, 车前子 12g (包煎), 泽泻 25g, 白术 5g, 牡丹皮 5g, 焦栀子 10g, 钩藤 12g, 代赭石 15g, 丹参 20g, 路路通 10g, 炙甘草 5g) 疏风利湿, 清热祛瘀; 治疗 90 例梅尼埃病。伴乏力, 少气懒言, 脉虚无力 43 例, 乏力, 舌肿有齿印, 脉虚无力 22 例; 乏力, 自

天,平均6.5天。眩晕消失后,给予六君子汤加泽泻、车前子以固本善后。

【病案举例】 徐某,女,48岁,梅尼埃病反复发作3年。头晕目花,视物旋转,如乘舟车,呕吐,耳鸣,不思饮食,脉弦滑,舌苔黄腻。诊为梅尼埃病,中医诊为眩晕,证由痰湿中阻,肝阳上亢所致,拟降浊化痰、平肝健脾。处方:白术10g,泽泻25g,通草6g,姜半夏10g,天麻10g,白芍10g,陈皮6g,生甘草3g。连服5剂,眩晕消失。再拟党参10g,炒白术10g,姜半夏10g,泽泻10g,茯苓10g,车前子(包)10g,陈皮6g,甘草3g,10剂,以固本善后。经随访1年,未见复发。

【方名】 美的平。

【组成】 黄芪30g,茯苓15g,白术30g,泽泻24g,龙胆草30g,黄芩12g,柴胡12g,半夏12g,茵陈30g,枸杞子15g,当归24g,鹿角胶9g(烊化),桑寄生24g,炙甘草10g,地龙12g。

【来源】 曹耀中,河北中医,1990,(5):15。

【功效】 健脾除湿,补益肝肾。

【适应证】 梅尼埃病。

【方药简析】 曹氏认为本病乃上盛下虚,本虚标实之证,其病机是肝肾阴虚,脾虚不得制水,水浊上泛,上蒙清窍。故方中用黄芪、茯苓、泽泻、半夏、茵陈、龙胆草益气健脾,利水降浊;枸杞子、当归、鹿角胶、桑寄生滋补肝肾,养阴补血;黄芩、柴胡、半夏和解少阳以治耳鸣;地龙功专通络;甘草调和诸药。易失眠患者加用磁石丸6g,日2次,丹参、泽兰叶,炙甘草改用生甘草;恶心呕吐,头胀闷感严重者加菊花、泽兰叶,重用茯苓、泽泻;耳聋者,汤剂酌加葛根、丹参,配用耳聋左慈丸1丸,日3次。曹氏用本方治疗梅尼埃病56例,痊愈35例,显效18例,有效9例,无效4例;总有效率92.5%。随访2年,痊愈者

未见复发,显效及有效共 19 例,有 12 例复发,但继服本方仍然有效。

【病案举例】 刘某,女,32 岁,1986 年 3 月 5 日就诊。自诉于 1985 年 12 月 24 日首次发病,经省某医院确诊为梅尼埃综合征。经用镇静、改善微循环药物治疗 2 月余,不见好转。现证:旋转性眩晕伴恶心呕吐,耳鸣呈波动性持续发作,耳堵塞感,舌苔滑腻,舌质紫黯,脉弦滑。电测听检查提示:感音性耳聋重振现象,低频听力损害严重。前庭功能检查有自发性眼震,旋转试验阳性。诊为梅尼埃病。予美的平汤 5 剂,自述眩晕减轻,但夜寐差,头部烘胀感,耳鸣如蝉,酌加磁珠丸 6g,日 2 次。续服 10 剂,眩晕明显好转,夜寐可,但入睡不深,易惊醒,遇事易心悸,耳鸣如蝉有增无减,加生龙骨、生牡蛎各 24g、玄参 30g、丹参 30g,再服 5 剂。电测听检查:听阈由 45dB 降为 20dB,重振现象好转。前庭功能检查:自发性眼震消失,旋转试验仍为阳性,眩晕偶作,耳部堵塞感,腰膝酸软,加生地 24g、怀牛膝 15g、葛根 15g、丹参 30g,耳聋左慈丸 1 丸,日 3 次,又服用 10 剂,诸证愈,电测听检查及前庭功能均正常,随访 2 年未复发。

【方名】 止眩平晕汤。

【组成】 天麻 10g,钩藤 15g,半夏 15g,代赭石 30g,车前草 15g,泽泻 20g,丹参 15g,夏枯草 15g。

【来源】 李克诰,江苏中医,1996,(7):12。

【功效】 平肝熄风,降湿止呕。

【适应证】 内耳眩晕症。

【方药简析】 李氏认为内耳眩晕症是本虚标实,为眩晕发作的基础。发作时以风阳和痰浊为主要病机,故拟止眩平晕汤以治。方中天麻、钩藤、代赭石平肝潜阳;夏枯草清肝泄火;

半夏燥湿祛痰,和胃止呕;泽泻、车前草化痰行水;半夏与代赭石合用化痰湿、降浊气,增强降逆止呕作用。特别是泽泻气平味甘而淡,淡能渗泄,气味俱薄,所以利水泄下。现代实验研究该药含有大量钾盐,故利水而不伤阴。丹参活血祛瘀,有镇静安神、扩张血管,改善内耳血液循环作用;2药合用可改善耳内血液循环,又能促进耳内淋巴液排泄,消除迷路水肿。全方具有平肝潜阳,化痰湿、降浊气,止呕吐,利水活血之功,用于风阳上扰或痰浊上蒙清窍之眩晕症,多获良效。痰湿交阻、上蒙清窍者,加竹茹、石菖蒲、白术、茯苓;气虚血亏、髓海失养者,加黄芪、党参、何首乌、当归;瘀热攻冲、上扰神明者,加郁金、黄连、栀子、赤芍;阴虚风动、肝阳浮越者,加白芍、枸杞子、菊花。李氏用本方治疗60例内耳眩晕症,痊愈30例,显效18例,进步8例,无效4例;总有效率93.33%。

【病案举例】 吴某,女,51岁,1993年7月12日就诊。患者因搬居新家,劳累后晨起突发眩晕,呈旋转性,闭目卧床,不敢翻身或转动头部,睁眼视物如坐舟车,恶心呕吐并伴耳鸣如蝉,左耳听力障碍。诊为内耳眩晕症。患者形盛体胖,眩晕头重,胸闷气塞,泛恶失眠,口粘多涎,舌苔腻,脉滑。中医诊为眩晕,证属痰湿交阻,上蒙清窍,以止眩平晕汤加减治疗。天麻12g,钩藤20g,夏枯草15g,代赭石(先煎)30g,泽泻24g,丹参18g,半夏15g,白术15g,茯苓30g,车前草15g,石菖蒲15g。每日1剂,水煎慢慢呷服。上方连服6剂而愈,随访至今未见复发。

【方名】 撤痰平肝汤。

【组成】 半夏30g,茯苓30g,泽泻30g,生姜30g,车前子15g,牡蛎15g,钩藤10g,磁石20g,炒苍耳子6g。

【来源】 金涛,湖南中医杂志,1992,(4):39。

【方名】 止眩汤。

【组成】 制半夏 15g, 陈皮 10g, 竹茹 10g, 远志 10g, 甘草 3g, 生姜 6g, 茯苓 30g, 浮小麦 30g, 葛根 30g, 生龙骨 30g, 泽泻 20g, 丹参 20g。

【来源】 潘志宁, 广西中医药, 1994, (6): 15。

【功效】 健脾利水, 蠲饮除痰。

【适应证】 内耳眩晕症。

【方药简析】 本方乃以《千金方》温胆汤为基础方加入浮小麦、远志、丹参、葛根、生龙骨、泽泻而组成止眩汤。方用制半夏、陈皮、茯苓、竹茹、生姜以燥湿化痰止吐为主药, 辅以生龙骨、远志及浮小麦镇惊宁心安神, 以调节植物神经功能的紊乱; 并以丹参、葛根活血祛瘀扩张血管、解痉、镇静及增加脑血流量, 改善微循环等。从而改善因神经功能紊乱而致迷路动脉痉挛, 造成局部缺血缺氧状态出现膜迷路积水, 而造成的眩晕、耳鸣及波动性听力减退症状。眩晕较甚, 呕吐频作加天麻、白芷、代赭石; 痰湿较盛, 证见胃脘痞闷, 咽部多痰, 舌苔厚腻加苍术、薏苡仁、滑石; 气血两虚, 证见气短乏力, 面色白加党参、黄芪、当归; 肾气虚, 证见腰膝酸软加菟丝子、女贞子、桑寄生; 肝肾阴虚, 证见咽干, 心烦失眠, 腰酸加生地黄、白芍、枸杞子、知母; 若痰郁化热, 肝火偏盛, 证见心烦易怒, 口苦面红, 苔黄加龙胆草、栀子、黄连、胆南星。病重酌情给予静脉补液。潘氏以本方治疗 58 例内耳眩晕症, 临床治愈 50 例, 好转 6 例, 无效 2 例; 总有效率 96.5%。服药最长时间 7 天, 最短 3 天, 平均 6 天。

【病案举例】 陆某, 女, 42 岁, 1993 年 8 月 20 日因发作性眩晕, 伴耳鸣耳聋, 呕吐反复 3 年, 再发 2 天初诊。诉于 1990 年 6 月 18 日起病, 每因劳累后反复出现发作性眩晕, 耳

鸣耳聋,听力逐渐下降,恶心呕吐,平均每1~2月发作1次。病后曾先后多次在市内某医院检查治疗,作过前庭功能测验,电测听及甘油试验,西医确诊为内耳眩晕病,每次发作均用东莨菪碱、安定片、谷维素口服,654-2静脉注射等治疗。平时常外出参加聚餐,咽部多痰。刻患者:体胖,舌淡红,苔白腻,脉滑。中医诊为眩晕,证属痰湿型。治以燥湿化痰,和胃止吐。药用自拟止眩汤加味:制半夏15g,陈皮10g,竹茹10g,远志10g,甘草3g,生姜6g,茯苓30g,浮小麦30g,葛根30g,生龙骨30g,代赭石30g,泽泻20g,丹参20g,薏苡仁45g,滑石25g。3剂后诸症大减,原方加减再进3剂诸症消失。随访近一年未复发。

【方名】 清眩汤。

【组成】 柴胡12g,半夏10g,黄芩10g,党参15g,泽泻10g,白术10g,川芎8g,钩藤10g,生姜10g,大枣3个,甘草4g。

【来源】 故毓恒,实用中医内科杂志,1994,(3):34。

【功效】 清利少阳,和胃降浊。

【适应证】 梅尼埃病。

【方药简析】 本方是由小柴胡汤合泽泻汤加减而成。方中柴胡、黄芩和解少阳;党参、白术、大枣、甘草益气健脾和胃祛湿;半夏、泽泻、生姜燥湿和胃,降浊止呕;川芎、钩藤活血通络,平肝熄风止眩晕。气虚甚加黄芪;血虚加当归、白芍;血瘀加丹参、红花;夹湿加藿香、佩兰;肝阳上亢加石决明、珍珠母。服药期间宜避风寒,避免劳累和精神紧张,忌肥甘厚味。胡氏用本方治疗梅尼埃病32例,年龄30~63岁,病程3天~21年。治疗结果痊愈(症状及体征完全消失,随访1年以上无复发)21例,有效(症状及体征明显减轻或完全消失,但1年之

内复发者)11例,总有效率100%。治疗时间最短者3天,最长21天,平均14天。

【病案举例】 李某,男,40岁。患梅尼埃病5年,约每月发作1次,每次持续3~5日,中西医久治终不能控制复发,于1987年10月6日就诊。头晕目眩,不敢睁眼,头重脚轻,恍恍然如坐舟车,恶心呕吐,耳鸣为蝉,脉弦缓,舌质淡红,苔薄白,西医诊为美尼尔病,中医诊为眩晕证属胆胃失和,浊阴上干清窍,用眩汤。1剂眩晕止,3剂而安。后间断服上方约20剂,随访5年无复发。

【方名】 止眩除晕汤。

【组成】 半夏18g,桂枝15g,泽兰15g,陈皮15g,川牛膝12g,生姜12g,车前子30g,牡蛎30g,白术24g,丹参24g,茯苓24g,琥珀6g(冲)。

【来源】 王忠民,陕西中医,1986,(12):540。

【功效】 祛湿化痰,活血化淤。

【适应证】 梅尼埃病。

【方药简析】 方中半夏、陈皮、生姜化痰止呕;桂枝、茯苓、白术健脾益气化浊;车前子洁净府;泽兰、丹参、琥珀、牛膝活血祛瘀,改善耳蜗血循环,更兼利水消肿,改善和调节毛细血管通透性;配以牡蛎安定平肝降逆。痰多苔腻,口粘者重用半夏、陈皮加佩兰;舌胖便稀,带下量多重用茯苓、白术,加山药;呕吐频繁,难以服药者重用生姜,加代赭石;急躁易怒,口苦而干加栀子、竹茹;面色苍白,汗出无力加人参、黄芪;口粘无味,纳谷不香加木香、砂仁。王氏用上方治疗梅尼埃病64例,年龄21~65岁,首次发作15例,余均有2次以上发作史;伴呕吐泛恶63例,耳鸣61例,听力减退或感音性耳聋57例,眼球震颤54例,食欲不振38例,舌胖大34例,苔略腻43例,舌暗红

或见淤点 17 例,脉滑或濡 34 例。结果全部治愈,其中服 2~3 剂症状消失者 11 例,4~5 剂者 29 例,6~10 剂者 16 例,10 剂以上者 8 例。治愈后随访 2 年,其中 5 例复发,仍复投原方而获愈。

【病案举例】 徐某,女,32 岁,1983 年 10 月 12 日初诊。罹反复发作性眩晕 2 年余,期间发作 3 次,多骤然而作,自感天眩地转,呕恶频繁;近日症情加重,多次发作。平素右耳常鸣,纳差无味,胸闷,肢怠无力,带下量多,舌苔厚腻,脉缓无力。检查:右耳听力减退,两眼球可引出 I 度水平震颤,快相向左。前庭功能冷热试验反应减低。西医诊断梅尼埃病,中医辨证眩晕。处方,上方加山药 15g、黄芪 12g、代赭石 20g。服 3 剂后诸症减轻,继服 3 剂,恙除病愈。随访 2 年未见复发。

【方名】 眩平汤。

【组成】 苍术 10~25g,厚朴 12g,姜半夏 12g,泽泻 15~40g,柴胡 3~9g,白芍 10~25g,钩藤 15g,石菖蒲 15g,甘草 3g。

【来源】 白墨,河南中医,1987,(4):25。

【功效】 化痰降逆,平肝熄风。

【适应证】 耳源性眩晕。

【方药简析】 方中苍白术燥湿化痰,量大力专;厚朴理气化痰,使中焦气顺;泽泻淡渗利湿,三者共用,使脾运痰清;用柴胡疏肝气,解肝郁,白芍柔肝之体,助肝之用,平肝之逆。钩藤平肝熄风,使肝郁解,肝阳得平,肝风得熄;石菖蒲芳香化痰开窍,柴胡又升清阳,使清阳升,九窍明,如此,痰化阳平风熄,则眩晕解矣。若兼恶心呕吐者,加姜竹茹 12g、代赭石 30g;兼面色白,气短,身倦无力,不欲饮食者,加黄芪 20g、党参 15g、白术 12g;兼肝阴血虚,面白心悸,失眠,眼球震颤者加当归

12g、麦门冬 12g、白蒺藜 10g、菊花 15g；兼腰膝酸软，耳鸣耳聋，肾精亏虚者加枸杞子 12g、女贞子 15g、桑寄生 15g、杜仲 12g；伴有汗出过多者加煅龙骨、煅牡蛎各 15g；颈项强硬，转动不便者加葛根 12~25g。白氏用本方治疗耳源性眩晕 67 例，男 22 例，女 45 例。其中 21~30 岁者 7 例，31~40 岁 12 例，41~50 岁 24 例，51~60 岁 19 例，60 岁以上者 5 例。服药剂数最多的 37 剂，最少的 4 剂，平均 11 剂，一般服药 2 剂即可见效。结果临床治愈（症状消失，随访 2 年未复发者）49 例，好转（症状基本控制或部分控制，或偶有复发，但较前间隔时间延长）15 例，无效（治疗前后症状无大改善，甚或加重）3 例；总有效率 95.45%。

【病案举例】 韩某某，女，47 岁，1982 年 7 月 5 日初诊。患者于 2 年前因脑力劳动过度引起眩晕，经省人民医院诊为耳源性眩晕。用谷维素、维生素 B₁、维生素 B₆、晕海宁、654-2 等药治疗，症状得到暂时控制。3 天前因劳累过度而旧疾复发，继续服上药，数日无效，特来诊治。患者此次发作，旋转感明显，自觉一切都在旋转，不敢睁眼，未见眼球震颤，头部稍有转动则眩晕加重，且伴见恶心呕吐清水痰涎，汗出心悸，夜不能寐，舌质暗淡，苔厚腻，脉弦滑。西医诊断：耳源性眩晕，中医诊为眩晕。证属脾运失职，痰浊阻滞，风阳挟痰上扰，蒙蔽清窍。治宜化痰浊，平肝风。方药：苍术 25g，姜半夏 15g，泽泻 30g，柴胡 4.5g，白芍 20g，钩藤 12g，珍珠母 15g，煅龙骨、煅牡蛎各 20g，甘草 3g。药后旋转感减轻，头部轻微活动及睁眼眩晕不再加重，汗出止，精神转佳。但颈项强直，转动不便，夜寐不佳，不欲饮食，大便溏，舌苔白腻。宗上方苍术减为 15g，去煅龙骨、煅牡蛎，加葛根 15g，夜交藤 30g，炒麦芽 20g。6 剂后，眩晕基本消失，饮食渐增，面色转润颈强消失，但遇劳又作，体倦无力，动则气喘吁吁，舌淡，苔薄白，脉细弱。宗上方苍术、半

注或口服安定、眩晕停片、烟酸及各种维生素,严重时曾注射过甘露醇、山梨醇等西药,能控制症状,但仍反复发作,要求中医治疗。检查:双耳鼓膜正常,呈水平性眼震,快相向右侧,听力检查为右耳轻度感音神经性耳聋。前庭功能冷热水试验为右半规管轻瘫。西医诊断:梅尼埃病,中医辨证为痰湿上扰型眩晕。给予基本方3剂。1988年3月13日复诊,诉眩晕好转,但仍有呕吐、胃纳差,给予原方加旋复花(包)、代赭石、木香各10g,3剂。1988年3月16日复诊,恶心呕吐消失、耳鸣仍不断,原方加灵磁石30g、石菖蒲6g,3剂。1988年3月25日复诊,症状全部消失。1989年9月25日随访观察未复发,按疗效标准判断: V 值=0, H 值 $>25\text{db}$,结果为痊愈[实用中西医结合杂志,1991.(1):37]。

【方名】 旋复代赭汤。

【组成】 旋复花 9g,人参 6g,生姜 10g,代赭石 9g,甘草 6g,半夏 9g,大枣 4枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 降逆化痰,和胃止呕。

【适应证】 胃气虚弱,痰浊内阻的梅尼埃综合征。

【方药简析】 方中旋复花性温下气消除痰涎,降逆除噫。代赭石体重沉降,善镇冲逆;生姜温胃化痰,散寒止呕;半夏祛痰散结,降逆和胃;人参、甘草、大枣,补中益气,和胃调脾。丘健明用旋复代赭汤为主,加减(肝肾不足加熟地、山茱萸、牛膝;气血不足加熟地、当归、黄芪、白芍;痰湿阻滞加陈皮、厚朴、石菖蒲;肝气郁结加柴胡、白芍、枳壳、香附;脾胃虚弱加白术、茯苓、山药)治疗梅尼埃病21例;男8例,女13例;40岁以下5例,40~50岁12例,51岁以上者4例;每年发作1次者6例,发作2次者9例,发作3次以上者6例。治疗结果痊

愈(眩晕消失,随访1年未再复发)17例,好转(眩晕减轻)4例。

【病案举例】 周某,女,38岁。患者反复眩晕发作已近4年,每年均发作1~2次。经西医诊断为内耳眩晕症。患者平素身体较虚弱,近日来,因家事忧虑劳累过度致眩晕又发,曾经给予西药安定、颠茄合剂、烟酸片、654-2针、静注葡萄糖溶液等无效,已2天未进食。诊见头晕目眩,动则益剧,纳呆,食入呕吐,泛吐清水,面色白,自汗,耳鸣,胸胁胀闷,舌淡红,苔白腻,脉弦细。西医诊断梅尼埃综合征。中医诊为眩晕,证属脾胃虚弱、肝气犯胃、痰湿阻滞。方药:旋覆花15g(包煎),代赭石25g(先煎),党参15g,炙甘草、制半夏各9g,大枣3枚,茯苓20g,柴胡9g,枳壳10g,山药15g,白术10g,生姜3片,1剂水煎温服。服药后约1h即觉气自胸胁向下移动,随后矢气频频,自觉腹中饥饿,眩晕减轻,进食稀粥1碗未呕,方已对证,原方再进2剂,诸症消失。以香砂六君丸调服半月余,随访1年未复发[实用中医内科杂志,1993,(2):37]。

【方名】 化饮平眩汤。

【组成】 泽泻15g,白术15g,半夏10g,茯苓17g,生姜10g,天麻10g,川芎3g。

【来源】 林沛湘,广西中医药,1991,(5):208。

【功效】 利水化饮平眩。

【适应证】 内耳眩晕综合征。

【方药简析】 本方实乃《金匱要略》泽泻汤和小半夏加茯苓汤加味而成。方中白术健脾运水,燥湿化饮,善能治眩;泽泻渗利水湿而起阴气,2药合用,一燥一滋,相得益彰。半夏与生姜辛通降逆,茯苓利水宁神,合为蠲饮止呕止悸之效。天麻辛甘质润,为治疗眩晕之要药,用于本方之中是对症治疗药物,

可加速症状的缓解,体现了“因症同治”的原则。用少量川芎,引药上行,以为使药,共奏利水化饮平眩之功。观全方既重视了病因的解除,也注意到症状的控制。林氏用本方治疗水饮上逆型内耳性眩晕综合征 46 例。其中治愈 42 例,好转 4 例。在治愈的病例中,一般 3 天症状好转,1 周内症状消除。

【病案举例】 刘某,女,42 岁,1986 年 4 月 21 日就诊。反复眩晕 3 年,发作 10 天。患者自述于 3 年前开始发病,近年来每年眩晕发作 1~5 次不等。10 天前因劳累过度而眩晕,胸腹胀满,呕吐,心悸,不敢睁眼,动则尤甚,几天来服用中西药物治疗,症状未有好转。诊得舌质淡红,舌苔白而偏腻,脉左弦右弱。西医诊断:眩晕综合征。中医辨证眩晕属水饮内停,上逆耳窍。治宜利水化饮平眩,处方:泽泻 15g,白术 15g,半夏 10g,茯苓 17g,生姜 10g,天麻 10g,川芎 3g。病人服用上方 2 剂后症状明显好转,再服 1 剂,症状消失。嘱继续服用 3 剂,巩固疗效。随访 2 年未见复发。

【方名】 仙鹤草汤。

【组成】 仙鹤草 60g。

【来源】 贺留儒,实用中医内科杂志,1992,(3):38。

【功效】 平肝止血。

【适应证】 梅尼埃综合征。

【方药简析】 《内经》云:“诸风掉眩,皆属于肝”。肝气郁结,气郁化火伤其阴,风阳易动,上扰头目,而发眩晕。中药仙鹤草虽常作收敛止血、驱虫之用,因它性味苦凉,入肺肝脾经,具有平肝,养阴之功。现代药理研究,仙鹤草具有明显的收缩周围血管之作用,加速血液循环,消除迷路动脉痉挛,有利于内淋巴吸收,故此,收到独特疗效。临床诊断准确,无不验者。贺氏用单味仙鹤草煎汤内服,治疗梅尼埃综合征 22 例;男 7

例,女 15 例;年龄 13~30 岁者 11 例,31~50 岁者 7 例,51 岁以上者 4 例。病程 2~12 月 18 例,1~10 年者 4 例。发作时的症状:22 例中有眩晕突然发作,旋转性,伴恶心,呕吐,出汗,闭目或卧床,不敢翻身或转动头部,双侧听力减退。眩晕时有耳鸣,眩晕过后耳鸣消失者 6 例;有上述症状无听力减退者 6 例;有上述症状伴有 1 侧听力减退者 10 例。结果用药 3 剂治愈者 3 例,4 剂治愈者 17 例,8 剂治愈者 2 例,治愈率 100%。

【病案举例】 张某,女,28 岁,1989 年 12 月 26 日初诊。患眩晕病 10 年,每次发作前自觉耳鸣、恶心,继则出现天地旋转,两眼不敢睁,不敢转动头部。发作过后全身是汗,双侧听力明显减退。脉细沉,空腹血糖 6.6mmol/L,血红蛋白 140g/L,红细胞计数 $4.8 \times 10^{12}/L$,白细胞计数 $7.8 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.70,淋巴细胞 0.30,曾用中西药治疗未能奏效。西医诊断梅尼埃综合征,中医诊为眩晕。经用干品仙鹤草 60g 水煎服后即明显见效,共服 4 剂病愈。1 年后随访未复发。

10 急性脊髓炎

急性脊髓炎,亦称急性非特异性脊髓炎,系指一组原因不明的急性横贯性脊髓损害。临床表现为病损以下的肢体瘫痪,传导束性感觉缺失和以膀胱、直肠功能障碍为主的植物神经功能损害,为神经科常见疾病之一。一年四季均可发病,但以冬末春初或秋末冬初较为常见。本病病因目前尚不清楚,但大组临床资料提示,多数患者在脊髓症状出现之前1~4周有发热、腹泻等病毒感染的症状,故认为本病可能是病毒感染后所诱发的一种自身免疫性疾病。外伤和过度疲劳可能为其诱因。本病以青壮年和农民较为多见,散在发病。多数在脊髓症状出现前数天至数周有发热、全身不适等上呼吸道感染症状,或有负重、扭伤等诱因。脊髓症状出现急骤,在数小时至1~2天发展至完全性截瘫。部分病人可有背部疼痛、腹痛、束带感、肢体麻木、乏力等先驱症状,数天至数十天后逐步发展至高峰,出现脊髓完全性横贯性损害。脊髓炎的临床症状,取决于受累脊髓的节段和病变的范围。脊髓各段均可受累,以胸段最为常见(74.5%),其次为颈段(12.7%)和腰段(11.7%)。以胸段横贯性脊髓损害为例,其典型症状为①运动障碍:胸段脊髓以下运动障碍,早期呈现脊髓休克现象:肢体肌张力降低,腱反射消失,病理反射阴性,腹壁、提睾反射均消失。随着脊髓休克期的恢复,瘫痪肢体伸性反射恢复,病理锥体束征阳性。此后逐步出现跟腱反射,肌张力增高和部分肌力恢复,肌力恢复始于足趾,然后肢体可在床面伸缩并逐步进行抗重力运动。②感觉障

碍:急性期在病变节段以下的所有感觉缺失。有些病人在感觉消失区上缘可有1~2个节段的感觉过敏区,或有束带状感觉异常。局灶性脊髓炎症者可能出现脊髓半切型感觉障碍,即病变同侧的深感觉缺失和病变对侧肢体的浅感觉障碍。③膀胱、直肠和植物神经功能障碍:脊髓炎早期,大、小便潴留。脊髓休克期过后,逐渐出现反射性膀胱,出现尿频、小便失禁。因肛门括约肌松弛可导致大便失禁。由于植物神经损害,病变节段以下的皮肤干燥,不出汗,热天可因散热不良而出现体温增高,截瘫肢体水肿,趾甲脆裂,角化过度,足底皲裂。少数病人则见瘫痪区皮肤菲薄、变嫩、易破。甚至有水泡形成等。脊髓炎的临床症状还随损害节段不同而有其特殊性。颈段脊髓炎者,出现四肢瘫痪。颈4以上节段受累时,出现呼吸困难,有时需人工辅助呼吸;颈膨大脊髓炎者出现两上肢弛缓性瘫痪,而下肢为上运动神经元性瘫痪,腰段脊髓炎者,仅出现下肢瘫痪和感觉缺失而胸腹部正常。骶段脊髓炎者,出现马鞍会阴区感觉缺失,肛门反射和提睾反射消失,无明显肢体运动障碍和锥体束征。当脊髓损害由较低节段向上发展,累及较高节段,特别是病变以下肢开始,迅速发展至完全性截瘫,并逐步上升,依次出现胸、臂、颈甚至呼吸肌肉的瘫痪和感觉缺失,出现吞咽困难,言语不能和呼吸困难者,称为上升性脊髓炎。病变上升至脑干出现多组颅神经麻痹,累及大脑出现精神异常者,称为弥漫性脑脊髓炎。当病变累及脊髓膜和脊神经根时,可出现脑膜和神经根刺激症状,体检时可有项强,克匿格征、直腿抬高试验阳性等,分别被称为脊膜脊髓炎、脊膜脊神经根脊髓炎。本病临床诊断并不困难,但需与感染性多发性神经根炎、硬膜外脓肿、脊髓肿瘤、急性脊髓前角灰质炎、结核性脊髓炎、梅毒性脊髓炎、视神经脊髓炎等病相鉴别。

急性脊髓炎属于中医痿痹范畴,其病因病机是由于感受

【方名】 黄芪桂枝五物汤。

【组成】 黄芪 30g,白芍 15g,桂枝 10g,生姜 6g,大枣 3枚。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 益气温经,和经通痹。

【适应证】 血痹证,肌肤麻木不仁。

【方药简析】 本方即桂枝汤去甘草,倍生姜,加黄芪而成。血痹由素体“骨弱肌肤盛”,劳而汗出,腠理开,受微风,邪遂凝于血脉,致肌肤麻木不仁,但无痛,状如风痹。《素问·痹论》曰:“营气虚,则不仁。”故用黄芪合桂枝,以益气通阳,芍药养血和营,生姜、大枣调和营卫。本方旨在温通阳气,调和营血,使邪去而血痹自通。临证可依据病机及邪正胜衰而择药量,灵活化裁。本方除用于急性脊髓炎外,还可用于末梢神经炎、大动脉炎等。

【病案举例】 赵某,女,16岁,学生。1974年10月14日就诊。因负重远行,疲劳汗出,继又感寒,入夜即恶寒发热,两臂疼痛,次晨两脚不能站立,腰以下失去知觉,大小便排出困难。急诊于某医院,以“急性进行性横贯性脊髓炎”收住院。用西药治疗无效,病势逐渐上行至胸,连发3次病危,家属求诊于中医。诊见:胸以下温、痛、触觉均消失,大小便失禁,不能进食3天,发热喘急,咯白色泡沫痰,面色萎黄,脉微沉涩,尺脉小紧,舌质淡,苔白。证属外感风寒湿邪,阻塞经络。治以黄芪桂枝五物汤加味:黄芪 30g,桂枝 15g,白芍 18g,生姜 12g,大枣 15g,五加皮 24g,白藓皮 24g,独活 15g。每日1剂,3剂后皮肤有痛温觉,每餐能食粥一小碗,上方加淫羊藿 30g。服5剂后,能扶杖下床活动,但仍觉腰以下发冷,足不任身,此乃肾气衰,督脉虚,精髓空。原方去独活,加制附片 30g,肉苁蓉 24g,鹿角胶 24g。连服8剂可弃杖行走。3个月后随访,各项

功能均正常〔李治沧,四川中医,1985,3(9):39〕。

【方名】 玉女煎。

【组成】 麦门冬 10g,熟地黄 15g,石膏 15g,知母 10g,牛膝 10g。

【来源】 张景岳《景岳全书》。

【功效】 清胃滋阴。

【适应证】 胃热阴虚。

【方药简析】 本方治证,原方为“少阴不足,阳明有余”,是由胃热阴伤所致。方中石膏辛甘大寒以清“阳明有余”之热,是为君药。熟地甘而微温,以补“少阴不足”之阴,用为臣药。两药相伍,是清火滋水并用。知母是用其苦寒质润,助石膏以清胃热,与白虎汤配伍方义雷同。麦门冬滋阴,助熟地黄以滋胃阴,均为佐药。牛膝滋补肾水,并可引热下行,故为使药。诸药配合,共奏清胃滋肾之功。此为标本两顾之法,以使热彻阴存,变“有余”与“不足”而至平调向愈。

【病案举例】 刘某,男,29岁,农民。1982年8月22日就诊。患者初起恶寒发热,3天后双下肢沉重以致完全瘫痪。查体:双下肢呈被动体位,胸椎6~8棘突轻微压痛,腹壁反射、腱反射均消失;脑脊液示:白细胞计数 $6.5 \times 10^9/L$,蛋白质 $1.05g/L$,诊为“急性脊髓炎”。曾用四环素、氢化可的松等药治疗无效,遂求治于中医。症见腰脊酸软,双下肢痿软不用,心烦口渴,恶寒喜暖,舌红,苔根黄厚,脉弦数,重按无力,此乃温热为患之痿躄。方用玉女煎加味:石膏 30g,板蓝根 30g,知母 10g,牛膝 10g,丹皮 10g,木瓜 10g,麦门冬 12g,生地 40g,钩藤 15g,何首乌 15g,鸡血藤 15g。此方出入服 11 剂,苔、脉趋正常,双下肢活动自如,二便畅,随访 4 个月未复发〔安徽中医学院学报,1987,(2):27〕。

【方名】 四妙丸。

【组成】 黄柏 10g, 薏苡仁 30g, 苍术、怀牛膝各 15g。

【来源】 《全国中成药处方集》。

【功效】 清热利湿。

【适应证】 湿热下注, 两足麻痺肿痛等症。

【方药简析】 方中黄柏苦寒, 寒以清热, 苦以燥湿, 且偏入下焦; 苍术苦温, 善能燥湿, 两药相伍, 合成清热燥湿之效。薏苡仁利湿清热作用尤佳; 牛膝能祛风湿, 补肝肾, 且引药下行, 故主治湿热下注的两足麻痺肿痛等。

【病案举例】 李某, 男, 17 岁。主诉左胸部疱疹, 局部奇痒及灼痛, 伴胸背部皮肤麻木 1 周, 两下肢麻木、无力 3 天。查体: 体温 38.2℃。沿左胸第 7 肋间簇集小水疱, 舌尖红, 苔薄黄微腻, 脉细滑数, 两下肢肌张力减低, 肌力左下肢Ⅰ级, 腹壁及提睾反射消失, 膝反射亢进, 双侧巴氏征(+), 两下肢关节位置觉减退, 脑脊液示: 白细胞计数 $7 \times 10^6/L$, 蛋白质 0.824g/L。诊为“带状疱疹性脊髓炎”。中医辨证属湿热下注, 闭阻经络。治以清热利湿, 方选四妙丸加味: 炒黄柏 9g, 苍白术各 6g, 牛膝 15g, 薏苡仁 15g, 玄参 15g, 板蓝根 15g, 金银花 15g, 蒲公英 15g, 滑石 15g, 桔梗 9g。服 4 剂后疱疹结痂, 两下肢麻木无力明显好转, 25 剂后, 双下肢症状消失[中西医结合杂志, 1987, 7(7): 427]。

【方名】 解毒化淤汤。

【组成】 黄柏 10g, 薏苡仁 30g, 川牛膝 15g, 连翘 12g, 赤芍 10g, 苍术 10g, 川芎 10g, 当归 12g, 金银花 30g, 丹参 20g。

【来源】 冯福海, 河南中医, 1996, 16(5): 307。

【功效】 清热解毒, 利湿化淤。

【适应证】 急性脊髓炎。

【方药简析】 急性脊髓炎多是湿热侵袭，气血运行不畅，筋脉肌肉失养所致。方中黄柏、薏苡仁、川牛膝、苍术即四妙具清热利湿之效；金银花、当归养血活血。呛咳咽干、发热者加黄芩、辽沙参；脊背疼痛加葛根；小便不利加萆薢、虎杖；胸闷、气短加黄芪、太子参；大便干结加肉苁蓉、火麻仁、枳实；痉挛瘫痪去连翘、苍术加白芍、鹿筋、鸡血藤、木瓜；肌肉瘦削枯萎者去连翘加龟板、鹿角胶、桑寄生；受刺激而下肢阵挛加全蝎、蜈蚣、珍珠母。

【病案举例】 范某，男，58岁。因双下肢软弱无力，低热20天入院。20天前因受凉出现寒战、高热，脊背及平乳以下皮肤针刺样疼痛，经用西药治疗1周，寒颤及皮肤针刺样疼痛消失，但仍低烧，双下肢软弱无力，行走困难，平乳以下皮肤感觉障碍。大便秘结，小便窘迫，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊为急性横贯性脊髓炎，中医辨证属湿热浸淫，气血不运。治以清热燥湿、活血通络。药用解毒化淤汤：黄柏、薏苡仁、川牛膝、连翘、当归、赤芍各15g，苍术、川芎、虎杖各10g，金银花、鸡血藤、萆薢、火麻仁各30g，蒲公英、丹参各20g。5剂后下肢力量增加，可徒步行走数百米，大便已不干结，小便可控制，原方化裁继服20余剂，下肢行走稳健，走数百米而无疲劳感，皮肤湿润有汗，临床痊愈。

11 急性脊髓前角灰质炎

急性脊髓前角灰质炎俗称小儿麻痹症,是由脊髓灰质炎病毒直接感染引起的一种急性传染病,主要侵犯中枢神经系统。本病在麻痹前期有发热、咳嗽、咽红、全身肌肉疼痛,或伴有呕吐、腹泻等症状,继而肢体痿软,肌肉弛缓,后期以肌肉萎缩,骨骼畸形为主要临床特征。本病多见于1~5岁的小儿,尤以6个月~2岁者为最多,学龄儿童及成人亦可发生。脊髓灰质炎的潜伏期最短3天,长的35天,一般5~14天,症状出现后,病程大致分为五期。①前驱期:起病初多有低热或中度发热,伴有头痛、乏力、全身不适、多汗和厌食等病毒血症症状,或有呕吐、腹痛和腹泻等消化道症状;亦或有流涕、咽痛及咳嗽等呼吸道症状。经1~4天后热退,症状消失。如疾病终止于此阶段,称顿挫型。②瘫痪前期:前驱期热退后,经1~4天的无症状期,然后体温再度上升,伴有较剧烈头痛、呕吐、烦躁不安、嗜睡、颜面和全身皮肤潮红、多汗,肢体及颈背肌疼痛、感觉过敏。婴儿拒抱,喜安静卧床,肢体震颤;年长儿颈背肌强直疼痛,卧位起坐困难,双上肢向后支撑身体,呈三脚架征,不能屈颈背,亦可出现较重呕吐、腹泻。本期发热可持续3~6天或更长,若不出现弛缓性瘫痪,即为无瘫痪型。③瘫痪期:瘫痪前首先出现腹壁反射消失,继之膝反射减弱或消失。瘫痪随发热而加重,体温下降后,不再进展。按其病理及临床表现,将瘫痪分为脊髓型(瘫痪可发生在颈肌、肋间肌、膈肌、躯干肌、腹肌及四肢肌任何一组或几组肌群,而以单侧下肢瘫痪最为常见。

亦可出现不能竖头,不能坐起和翻身;或有呼吸表浅,双翼煽动,甚则呼吸衰竭;或有患侧腹部隆起,便秘,尿潴留等症状)、脑干型(脑神经麻痹:表现为面瘫,舌、咽、喉部肌肉瘫痪,吞咽困难,喝水发呛,咽部分泌物潴留,痰涎自鼻孔反流,声嘶,发音不清,软腭下垂,咽反射消失,易致吸入性肺炎。亦有表现为肩下垂,颈无力,头偏向健侧,眼球运动障碍,眼睑下垂等。呼吸中枢麻痹:表现中枢性呼吸衰竭,以致严重缺氧而发绀,烦躁不安,甚至神志不清,昏迷惊厥,可迅速死亡。血管运动中枢麻痹:早期面色潮红,心律不匀,脉搏微弱;晚期面色灰青,意识不清,血压下降,表现严重的循环衰竭)、脑炎型(突然高热,嗜睡,肢体呈痉挛性瘫痪,意识不清,昏迷和惊厥等)、混合型(脊髓型与脑干型混合,或脊髓型与脑炎型混合,两型表现同时出现)。④恢复期:体温降至正常,瘫痪停止发展,瘫痪肌和肢体功能逐渐恢复,从手足指(趾)远端开始,渐及近端大肌群。头1~2个月恢复较快,6个月以后减慢,至1~1.5年甚至更久仍不完全恢复。⑤后遗症期:病变神经细胞坏死,肌群失其神经冲动而废用,久则肌肉萎缩或松弛,骨关节畸形,如足下垂、足马蹄内翻或外翻,肢体变细缩短,脊柱侧弯或前凸等。本病应与急性感染性多发性神经根炎、流行性乙型脑炎、病毒性脑膜脑炎、白喉后瘫痪、家族性周期性瘫痪、假性瘫痪等病相鉴别。

急性脊髓前角灰质炎根据临床表现不同分属于中医瘫痪、温病范畴。本病主要由于风热暑湿时行疫毒之邪,由口鼻侵入肺胃二经,继则伤及心、肝、肾、脑等脏,使功能失调所致。麻痹前期属于温病范畴,后期为邪毒侵犯经络,而致肢体麻痹则属痿证范围。本病初起多为邪实,以温热毒邪伤津耗液为主,后期则以正虚为主,为肝肾精血亏虚,肌肉筋脉失养。临床应根据起病急缓,虚实之主次,审因论治。邪犯肺胃用葛根芩

连汤合甘露消毒丹,邪注经络用三妙丸,气虚血滞用补阳还五汤,肝肾亏损用虎潜丸。根据脊髓灰质炎病程特点,肖氏分为初热期、麻痹期、纯瘫期和枯萎期进行治疗。初热期:治以解表清热,祛湿活络为主,用甘露消毒丹。麻痹期:治以疏通经络,调和气血为主,偏于湿热者,用宣痹汤治疗;偏于麻痹肢软者,用葛根、黄连、白芍、全蝎、蜈蚣、麻黄、防己、桂枝、川芎、防风等组方治疗。枯萎期:治宜补肝益肾,健脾益气,强壮筋骨;用虎潜丸、补阳还五汤加减治疗。此外,应用祛痿方(防风 10g,防己 10g,威灵仙 15g,赤芍 20g,泽泻 12g,海风藤 20g,黄柏 10g,木瓜 20g,薏苡仁 20g,葛根 15g,甘草 6g)和复痿方(黄芪 30g,茯苓 15g,当归 12g,炙甘草 6g,牛膝 15g,白术 12g,熟地 15g,麻黄 6g,山药 20g,人参 15g)治疗急性脊髓前角灰质炎;祛痿方用于麻痹前期,复痿方用于麻痹期及后遗症期,共治疗 46 例,痊愈 29 例,显效 9 例,好转 21 例[哈尔滨中医,1965,(2):25]。

胡义保等根据脊髓灰质炎的临床表现分湿热阻络型,气虚血滞型进行治疗。湿热阻络型(瘫痪期):治宜清化湿热,舒通经络,用脊灰 I 号(苍术、忍冬藤、独活、木瓜、川芎、丹参、怀牛膝各 6~9g,黄柏 3~6g,薏苡仁 9~12g)。气虚血滞型(恢复期):治宜益气养血,活血通络,用脊灰 II 号(黄芪 12~15g,赤芍、丹参、鸡血藤各 9~12g,地龙 4~6g,桑寄生、当归、怀牛膝各 6~9g)。共治疗 50 例,总有效率达 90%[浙江中医杂志,1990,(7):319]。

董士锋用瘫痪丸(马钱子、菟丝子、淫羊藿、川芎各 90g,木瓜、制狗脊、丹参各 180g,人参、附子、姜黄、蜈蚣、全蝎、天麻各 30g,川乌 15g,草乌 9g,络石藤 300g,怀牛膝、僵蚕、白花蛇各 60g,当归 120g,蜂蜜 1500g。共研成细末,制成丸剂 3000 粒,1~2 岁每次 1 粒,3~4 岁每次 2 粒,5 岁以上酌增,每日 3

次,空腹口服)治疗脊髓灰质炎 30 例,7 例治愈,12 例明显好转,8 例好转,3 例无效[浙江中医杂志,1980,(10):436]。

【方名】 三才封髓活络丹。

【组成】 天门冬 15g,熟地黄 20g,党参 15g,防风 10g,白芷 8g,木瓜 20g,桑寄生 20g,鹿茸 3g,生麻黄 5g,乌梢蛇 20g,川牛膝 20g,共为细面过箩。用法:1 岁小儿分 40 包(其他年龄酌情加减),每次 1 包,1 日 2 次,冰糖水冲服。

【来源】 吴明钦,河南中医,1989,(1):34。

【功效】 益气滋阴,通经活络。

【适应证】 肾虚型小儿麻痹。

【方药简析】 方中天门冬、熟地黄滋阴生津为君;佐以党参益气健脾;鹿茸、牛膝、木瓜、桑寄生补肝肾,壮筋骨;防风、白芷祛风散邪,生麻黄宣通气血,且制熟地黄、天冬腻胃之弊;乌梢蛇舒通筋脉。诸药共奏补肝肾、壮筋骨、通血脉、益气血之效。

【病案举例】 张某,女,11 个月,1981 年 12 月 23 日初诊。患者 40 天前曾发热,继而右下肢软弱,活动不自如,不能屈伸,指纹细,色紫红,向内弯,舌质淡嫩红,苔滑润。此属肾虚型小儿麻痹,用三才封髓活络丹,分作 40 包,1 日 2 次,每次 1 包,冰糖水冲服。1982 年 2 月追访已愈。

【方名】 脾肾两补通痹散。

【组成】 炒白术 15g,党参 15g,茯苓 15g,熟地 20g,鹿茸 3g,乌贼骨 20g,鸡内金骨 15g,枸杞子 20g,生麻黄 8g,乌梢蛇 20g,木瓜 15g,麦芽 20g。有汗者去麻黄。此为 1~1.5 岁量,分 25 包。

【来源】 吴明钦,河南中医,1989,(1):34。

【功效】 健脾补肾，舒筋通络。

【适应证】 脾肾两虚型小儿麻痹。

【方药简析】 方中党参、熟地、鹿茸益气补肾共为主药；辅以白术、茯苓、鸡内金、麦芽健脾和胃；枸杞子滋阴补肾；乌梢蛇、木瓜舒筋通络；生麻黄宣通气血，且制熟地之腻性。

【病案举例】 孔某，女，1岁3个月，1982年元月3日初诊。因发热、腹泻后引起双下肢瘫痪，不能站立，两足外翻，左腿重于右腿，出虚汗，腹泻，指纹红紫，向内弯曲，达气关，苔薄白。此属脾肾两虚型小儿麻痹。脾肾双补通痹散去麻黄，分25包，1日2次，每次1包。3月8日复诊，服药两料后，双下肢屈伸活动正常，已能行走，但易跌倒。继服上方1副，以巩固疗效。

【方名】 金水两全通经散。

【组成】 熟地黄 20g，天门冬 15g，杏仁 10g，川贝母 10g，北沙参 15g，党参 15g，枸杞子 15g，鹿茸 3g，乌贼骨 20g，乌梢蛇 15g，地龙 15g，鸡血藤 20g。2岁量分成30包。

【来源】 武明钦，河南中医，1989，(1)：34。

【功效】 润肺滋肾，活血通络。

【适应证】 肺肾两虚型小儿麻痹。

【方药简析】 方中熟地黄、天门冬、北沙参润肺滋肾为君；辅以杏仁、川贝母、枸杞子清热润肺生津；鹿茸、乌贼骨补肾壮骨；党参益气健脾；乌梢蛇、地龙、鸡血藤活血通络。

【病案举例】 汤某，男，2岁，于1984年7月3日初诊。3个月前发热7天，继而出现左下肢软弱无力，足外翻，不能站立，兼咳嗽，出虚汗，指纹微紫，舌质淡红，苔薄白腻。此属肺肾两虚型小儿麻痹。用金水两全通经散原方分作30包，每次1包，每日2次，冰糖水冲服。8月2日复诊，左下肢已能站立，

足外翻减轻,出虚汗、咳嗽均好,唯有左膝关节强硬。上方加川木瓜、桂枝,以加强舒筋活络之力。9月份随访,已告显效。

【方名】 加味金刚丸。

【组成】 萆薢 12g,生杜仲 12g,肉苁蓉 12g,菟丝子 18g,巴戟天 12g,天麻 12g,乌贼骨 12g,僵蚕 12g,蜈蚣 6g,全蝎 10g,木瓜 12g,川牛膝 12g,淫羊藿 12g,制马钱子 25g。共为细末蜜丸 3g 重。

【来源】 王占玺《临床验集》。

【功效】 补益肝肾,温通经络。

【适应证】 小儿麻痹后遗症。

【方药简析】 生杜仲、肉苁蓉、淫羊藿温补肾阳为君;辅以菟丝子、巴戟天加强补益肝肾之力;天麻、僵蚕、全蝎、蜈蚣祛风通络;木瓜、川牛膝、制马钱子舒筋活络。

【病案举例】 李某,女,5岁,1961年5月6日初诊。双下肢瘫痪已2年,有严重之畸形,两脚呈严重之下垂和内翻状,肌肉萎缩,膝腱和两踝反射均消失,患肢逆冷。证系经脉闭塞,久失气血濡养,筋骨两伤。治宜补益肝肾、温经通络。方用加味金刚丸,每次1丸,日2次。连服2个月后,患者能弃杖行走数十米。

【方名】 痿痹通络丹。

【组成】 川牛膝、杜仲、伸筋草、木瓜、桃仁、地龙、天麻、生地黄、侧柏叶、当归各 10g,桑枝 15g,羌活、独活、二风藤各 12g,红花、广木香、丹皮、川芎各 6g,蜈蚣 3g,全蝎 5g,麻黄 4g,麝香 1.5g。共为细末蜜丸 3g 重。

【来源】 王占玺《临床验集》。

【功效】 逐风通络,活血舒筋。

【适应证】 小儿麻痹后遗症。

【方药简析】 方中牛膝、杜仲、生地补肝肾，强筋骨；桑枝、伸筋草、羌活、独活、二风藤祛风通络；红花、丹皮、当归、川芎养血活血；桃仁、地龙、蜈蚣、全蝎舒筋活络；麝香性善走窜而通九窍。

【病案举例】 许某，女，3岁，1965年5月12日初诊。右下肢不用已1年半，于1963年10月因发烧神志不清，3天后热退，而腰以下及两下肢不能活动。经过治疗，腰及左下肢恢复正常。唯右下肢仍不用，不能屈伸，皮肤发凉，舌质红，苔稍黄厚，脉细数，手心热，诊为小儿麻痹后遗症。证属中医之风湿痹证，筋骨痿软。治宜逐风通络、活血舒筋。与痿痹通络丹1丸晚间服，服用1月后，患肢已能独立，扶物能行走，肌肉较前丰满，又继服用半年基本恢复接近正常。

【方名】 麦门冬汤。

【组成】 麦门冬 6g，半夏 9g，人参 6g，甘草 4g，粳米 6g，大枣 3枚。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 滋养肺胃，降逆和中。

【适应证】 肺胃阴虚。

【方药简析】 方中重用麦门冬为君药，以其甘寒之性，滋养肺胃之阴，且清虚火。以半夏为臣，意在降逆化痰，其性虽燥，但与大量麦门冬配伍，则燥性减而降逆之性存，独取其善降胃虚逆之气，且又使麦门冬滋而不腻。佐以人参补益中气，与麦门冬配伍，大有补气生津之功。复加粳米、大枣、甘草补脾益胃，使中气健运则津液自能上输于肺，于是胃得其养，肺得其润。

【病案举例】 许某，男4岁，1966年9月14日初诊。

1964年初夏发烧1周后,出现下肢软瘫不能站立,逐渐发展至腰骶以下肌肉严重萎缩,西医诊断为小儿麻痹症。来诊时已瘫痪2年余。患儿发育中等,营养较差,食欲不振,潮热盗汗,干咳气喘,双下肢瘫痪,肌肉严重萎缩,皮温低,膝反射消失,舌质红,苔薄黄,脉数。此为痿痹重症,辨证属肺胃痰热,肝肾阴虚,治当从上而下,循序渐进,予麦门冬汤加乌梅10g,北沙参15g,天花粉9g,桑叶9g,服药10剂,能自动站起沿床学步,食欲颇佳,舌红少苔,脉数。前方加龟板15g,枸杞子9g,牛膝6g,杜仲9g。15剂后,下肢肌力增加,扶之能步行十几步。共治疗半年,患儿基本康复。[刘保尚,上海中医药杂志,1983,(6):23]。

【方名】 白虎加入参汤。

【组成】 石膏30g,知母9g,炙甘草3g,粳米9g,人参10g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 清热,益气,生津。

【适应证】 阳明气分热盛,津气皆伤之证。

【方药简析】 方中石膏为君,取其辛甘大寒,以制阳明内盛之热。以知母苦寒质润为臣,一以助石膏清肺胃之热;一以借苦寒润燥以滋阴。人参补气生津;甘草、粳米既能益胃护津,又可防止大寒伤中之偏,共为佐使。五药共用,具有清热益气生津之功。

【病案举例】 杨某,男,3岁,1973年6月28日初诊。诉高烧2天后出现右下肢瘫痪,西医诊为小儿麻痹症。患儿发育营养中等,神识清楚,检查体温39.5℃,颈软,右下肢瘫痪,面赤唇红,口渴喜饮,汗多,舌红有裂纹,脉大而数。证属感受暑湿,阳明热炽,气阴两伤,宗筋失养,发为痿痹。治拟清暑益气,

养阴润筋,白虎加入参汤加減:西洋参 6g,石膏 24g,知母 9g,麦门冬 9g,薏苡仁 15g,生地黄 15g,丹皮 6g,甘草 4.5g。服 3 剂后热退,遗留右足软瘫未差,舌光剥有裂纹,脉虚数。上方加生地黄 15g,玄参 12g,女贞子 9g,旱莲草 9g,地龙 6g,杜仲 9g,丝瓜络 30g。连续 30 余剂,能行走数十步[刘保尚,上海中医药杂志,1983,(6):23]。

【方名】 独活寄生汤。

【组成】 独活 9g,桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、甘草、当归、赤芍、生地各 6g。

【来源】 孙思邈《备急千金要方》。

【功效】 祛风湿,止痹痛,益肝肾,补气血。

【适应证】 脊髓灰质炎瘫痪等。

【方药简析】 方中以独活为君,取其理伏风,善祛下焦与筋骨间之风寒湿邪。伍以细辛发散阴经风寒,防风祛风邪以胜湿;秦艽除风湿而舒筋;桑寄生、杜仲、牛膝祛风湿兼补肝肾;当归、川芎、生地、白芍养血又兼活血;人参、茯苓补气健脾;肉桂心温通血脉。甘草调和诸药。发热口渴加钩藤、知母;湿热偏重加苍术、黄柏;病久气虚加党参、黄芪;上肢瘫痪加羌活,下肢瘫痪加续断;患肢肌色苍白隐青、肤冷加红花、桂枝、鸡血藤。苏如林等用加減独活寄生汤治疗脊髓灰质炎瘫痪 20 例,治愈(瘫痪消失,行动自如)15 例;好转(瘫痪好转,已能活动,但稍有跛行)4 例,无效 1 例。

【病案举例】 林某,男,4 岁,1978 年 8 月 20 日诊。78 年 7 月 4 日发热头痛,呕吐,全身酸痛,颈强直,确诊为脊髓灰质炎。经住院治疗,诸证好转,唯两下肢软瘫不能站立,伸屈不便,肌肉弛缓,感觉存在,患肢肌色苍白微肿,肤冷,双足微向外翻,并感小腿部酸麻疼痛,面色萎黄,纳谷不香,舌质淡红,

苔白厚腻，脉缓滑。证属风湿凝滞，经脉阻塞，血行不畅而成痿躄。法当祛风湿，活血通络，处方：独活寄生汤去赤芍、川芎、甘草加桂枝 6g，苍术 6g，鸡血藤 10g。20 余剂后患肢肤冷转温，微有汗出，浮肿见消，伸屈自如，但仍不能站立，上方去防风、苍术，加黄芪 30g。40 余剂后始能站立步行，半年后随访，一切正常[苏如林等，浙江中医杂志，1983，18(3)：125]。

12 脊髓空洞症

脊髓空洞症与延髓空洞症是一种缓慢进展的脊髓及/或延髓的退行性病变,其病理特征是髓内有空洞形成及胶质增生。临床主要症状是受损阶段的分离性感觉障碍,下运动神经元障碍、长传导束功能障碍以及营养障碍。本病病因至今尚未最后肯定,大部分学者认为本病是一种先天性发育异常所致,因这类病人常伴发其他先天性异常,如颈肋、脊柱后侧突、脊柱裂、脑积水、扁平颅以及先天性延髓下疝畸形等,尤其是小脑扁桃体下疝 50%以上都伴有脊髓空洞症;后天性的病因常因脊髓肿瘤、蛛网膜炎及外伤等引起。本病病程进展缓慢,最早出现症状常呈节段性分布,因病灶最多见于颈下段及胸上段脊髓,故大多数患者首先影响上肢,初发症状每为手部感觉减退,也有以手部小肌肉消瘦无力及营养障碍始引起患者注意。由于空洞的位置及大小不一,其临床表现存在着个体差异,当空洞逐渐扩大时,可在空洞水平以下出现传导束功能障碍,此与初发症状之间可间隔数年,发病年龄通常为 20~30 岁,偶尔发生于儿童期或成年以后,文献中最小年龄为 3 岁,最大为 60 岁。男性与女性比例为 3:1。其临床表现为①感觉症状:由于空洞常始于中央管背侧灰质的一侧或双侧后角底部,最早症状是单侧的痛、温觉障碍;如病变侵及前连合时可有双侧的手部、臂部、尺侧或一部分颈、胸部的痛、温觉丧失,触觉及深感觉正常,称为分离性感觉障碍。病人常在手部发生灼伤或刺、割伤后才发现痛、温觉的缺损。以后痛、温觉丧失范

围可以扩大到两侧上肢、胸、背部,呈短上衣样分布。如向上影响到三叉丘脑束交叉处,可以造成面部痛、温觉减退或消失,角膜反射消失。有些病人在痛、温觉消失区域内有自发性的疼痛,或其他感觉异常。晚期后柱及脊髓丘脑束被累及,可造成病变水平以下痛、温、触及深感觉异常及不同程度的障碍。②运动障碍:脊髓前角细胞受累后,可出现一侧或双侧小肌肉及前臂尺侧肌肉软弱和萎缩,可有肌束颤动及肌张力减低,腱反射消失,逐渐波及上肢其他肌肉、肩胛带等,出现痿废不用,手部肌肉萎缩严重时呈“爪形手”,当病变累及同侧锥体束时,该侧下肢即出现病理反射,肌张力增高,腱反射亢进,运动障碍,由此呈现本病典型的运动系统症状,即一侧上肢为下运动神经元瘫痪,同侧下肢为上运动神经元瘫痪。③营养障碍:患肢的营养障碍表现为皮肤发绀、角化过度、指甲变粗变脆、无汗或多汗,皮肤及手指末节的创伤,尤其是烫伤造成的溃疡难以愈合,甚至手指末节可能发生坏死。④其他症状:关节的痛觉缺失引起关节磨损、萎缩和畸形,关节肿大,活动度增加,运动时有摩擦音而无痛觉,晚期可出现膀胱、直肠括约肌功能障碍。由于延髓空洞常不对称,症状和体征常为单侧型。累及疑核可造成吞咽困难及呐吃,软腭及咽喉肌无力,悬壅垂偏斜。舌下神经核受影响时造成伸舌偏向患侧,同侧舌肌萎缩伴有肌束颤动,如面神经核被累及时可出现下运动神经元型面瘫。三叉神经下行根受累时造成同侧面面部感觉呈中枢型痛、温觉障碍。侵及内侧弓状纤维则出现半身触觉、深感觉缺失。如果前庭小脑通路阻断可引起眩晕,可能伴有步态不稳及眼球震颤。

脊髓空洞症临床首先表现为肌肤麻木、不知痛温,当属于中医“痹证”,尤以风痹更为近似;随着病情的发展,出现肌肉萎缩,举动不能,故后期可归属中医痿证范畴。中医认为本病

【适应证】 痿痹证。舌强不能言,足废不能用,口干不欲饮等。

【方药简析】 方中熟地黄、山茱萸滋补肾阴;肉苁蓉、巴戟天温壮肾阳,为君药。而以附子、肉桂之辛热,协上药以温养真元,摄纳浮阳;麦门冬、石斛,五味子滋阴敛液,使阴阳相配,均为臣药。菖蒲、远志、白茯苓交通心肾开窍化痰,是为佐药。少用生姜、大枣、薄荷为引,和其营卫,均为使药。诸药合用,共成滋肾阴,补肾阳,开窍化痰之功。使水火相济,痰浊得除,则痿痹可愈。本方是治疗痿痹的主要方剂,若只痹证,可将菖蒲、远志、薄荷等宣通开窍之品减去。

【病案举例】 韩某,男,50岁。1972年出现四肢发热,右手活动不灵活,逐渐延及上肢。痛、温觉迟钝,肌力减退,肌肉萎缩。1973年右下肢也出现肌无力和肌肉萎缩,活动受限。查体:颅神经(-),右上肢肌力Ⅰ级,肌肉萎缩,较对侧细3cm,斜方肌、岗上肌萎缩,右下肢肌肉萎缩,右颈1~胸1,右胸2~胸4痛觉消失,触觉存在,深感觉正常,诊为脊髓空洞症。曾用同位素及神经营养药治疗不效遂来就诊。症见:精神不振,全身倦怠无力,步态不稳,四肢不温,性欲减退,舌淡,脉沉细无力。方用地黄饮子加桃仁10g,防风10g。服药6剂,自觉症状减轻,右侧肢体灵便,右半身微有汗出,守方继服10余剂,四肢有力,步态较稳,上肢可握工具。仍以上方加减继服50余剂,药后病愈,随访10年身体健康[田维柱,辽宁中医杂志,1984,8(7):31]。

【方名】 左归丸。

【组成】 熟地黄20g,山药15g,枸杞子15g,山茱萸10g,川牛膝10g,菟丝子20g,鹿角胶15g,龟板胶15g。

【来源】 张介宾《景岳全书》。

具,牛骨髓、黄芪各 30g,制马钱子末 0.1g(冲服)。水煎日 1 剂,早晚 2 次,黄酒 30ml 冲服,食肉喝汤。

【来源】 王广见等,吉林中医药,1992,(3):26。

【功效】 温补元阳、益精填髓、温通经脉。

【适应证】 脊髓空洞症。

【方药简析】 方中紫河车可阴阳双补,返本还原;阿胶、山羊内外肾、牛骨髓为血肉有情之品,同气相求,专事益精填髓;鹿茸、熟附子禀纯阳雄壮之性,补火散寒,含蕴生发之气;肉苁蓉厚重下降,直入肾脏养命门、兴阳气,力挽丹田虚冷、阳道久沉;菟丝子辛温润燥,为克肾苦之敌;杜仲为补肝肾、壮筋骨之要药;补骨脂为补肾阳、强腰膝之上品;当归、鸡血藤补血活血、祛瘀生新;麻黄辛温轻扬、善开络道;细辛芳香辛烈、开结散滞;桂枝辛甘温热、温经通脉;马钱子、地龙搜剔经络、起痿振废;炙甘草温中益气、缓众药之峻;黄芪补气;清酒通利;尤妙葶解一味渗达疏导。合方阴阳完实,气血充足,精足髓满,诸症得遣。

【病案举例】 耿某,男,35岁,1988年6月20日初诊。患者4年前在施工中被楼板挤伤腰部,疼痛不可转侧,昼夜无休。某医院X片未见异常,以软组织损伤治疗数周,症状旋愈旋复,每遇劳累、性交及阴雨天加重。2个月后发现左腿麻木,背及下肢发凉,感觉异常,痛温觉受障,曾不自觉烫伤肢体,性事大减。经某军医院神经科诊断为脊髓空洞症,屡治鲜效。查体:双下肢麻痹无力,步态不稳,肌张力强,肌肉消瘦,精神萎靡,面色黯黑,痛温觉不敏感,左胫有 5cm×3cm 陈旧性伤疤,腹壁反射减弱,腱反射亢进。头晕目眩,腰膝酸冷,胁下顽麻,大便溏薄而不畅,小便短涩不痛,舌苔淡白,脉细弱。脊柱CT扫描报告:腰椎段椎管前后颈扩大,脊髓增宽,脊髓空洞症确立。辨证为肾阳衰微,髓海空虚,气血双亏,经络阻闭。治以温

补元阳、益精填髓、温通经脉、搜剔寒邪。用金刚丸加味，水煎日1剂，早晚2次，黄酒30ml冲服，食肉喝汤。服药半年，痛温觉敏感，房事正常，肤泛华色，腹壁、腱反射、肌张力正常，舌脉趋常，肢体活动与病前无明显差别。告愈停药，追访至今，情况良好。

13 运动神经元性疾病

运动神经元疾病是一组脊髓前角细胞和下位脑干颅神经运动核或大脑皮质运动神经元的进行性变性疾病,迄今病因尚未明确。临床表现为不同组合的肌无力、肌萎缩、延髓麻痹及锥体束征,而感觉完全正常。本组疾病包括进行性脊肌萎缩症、进行性延髓瘫痪症、肌萎缩性侧索硬化症、原发性侧索硬化症、进行性痉挛性延髓瘫痪症等疾病,但经长期观察,不少初期诊断为进行性脊肌萎缩症和原发性侧索硬化症的病例,最终都演变成肌萎缩侧索硬化症,故有些学者认为,这几种运动神经元疾病或许就是一种疾病,仅仅在发病年龄、起始病灶部位以及临床进程、预后等方面不同而已,故统归于此,其中肌萎缩性侧索硬化症最为多见,故常以此为代表。其发病率每年为2~7/10万,占成人死亡率1/1000。运动神经元病大都发病徐缓或隐袭起病,常发于中年之后,通常在40~70岁之间,国内发病于青壮年期者也不少见,男性较多见,男女之比为3~4:1,大多数无家族遗传倾向,主要表现为①肌无力与萎缩:肌肉无力常是本病的首发症状,最初出现在上肢,最常见的发病征象是手部小肌肉的无力,并逐渐出现萎缩,随后扩展到前臂及肩胛带肌群,两肩低垂。②肌肉挛缩与颤动:手部肌肉萎缩并逐渐波及邻近肌群,进一步发展形成肌肉挛缩,肌张力增高,形成所谓“鹰爪手”或“猿手”。③发音含糊与舌萎:发音不清是延髓麻痹的征象,常发生在本病的晚期,讲话时丧失正常字与字之间的停顿,造成字与字相互套叠,语音含糊,

愈,5例好转[浙江中医杂志,1993,(6):251]。

【方名】 生髓复痿丸。

【组成】 鹿角 150g,熟地、淫羊藿、锁阳、巴戟天、桂枝、赤芍各 100g,黄芪 200g,何首乌、补骨脂、骨碎补、续断、党参、白术各 120g,蜈蚣 10 条,制马钱子 150g,共为细末,炼蜜为 300 丸,1 日 2 次,每次 1 丸。

【来源】 蒋德源,四川中医,1989,7(5):38。

【功效】 补养肝肾,养血荣精。

【适应证】 肌萎缩性侧索硬化症。

【方药简析】 方中鹿角、黄芪、马钱子益气温阳,通经活络为主药;熟地、淫羊藿、锁阳、巴戟天、骨碎补、续断填精益髓,补养肝肾;配以桂枝、蜈蚣、赤芍温阳活血通络;党参、白术以培补后天之本。

【病案举例】 钟某,男,57岁,1985年6月9日初诊。患者于2年前发觉右手拿物无力,活动不灵活,到冬天症状更为严重,右手萎缩、麻木、肢冷厥、时震颤,在某医院诊为“肌萎缩性侧索硬化症”。查体:面肌稍萎缩,右上肢肌肉比对侧细2cm,手部肌肉萎缩如削,大小鱼际肌消失,掌骨间隙凹陷,皮色发绀、粗糙、厥冷、十指强硬。中医辨证属肝肾亏损,精血不荣之痿痹症。治以补肾益肝。用生髓复痿丸。服药期间若出现肢体肌肉颤动,精神过度兴奋减量;反之,效果不显,肌力恢复不快,可酌加剂量,但每次不得超过2丸,服1料后,肌力增加,肢冷转温,手指灵活,凹陷的掌骨间隙开始丰满。再服1料后,萎缩之肌肉部分接近正常。

【方名】 加味健步虎潜丸。

【组成】 黄芪、仙灵脾、鹿角各 100g,海龙、海马、人参、

龟板、当归、白芍、熟地黄、枸杞子、杜仲、续断、菟丝子、锁阳、白术、薏苡仁、陈皮、牛膝、木瓜、秦艽各 30g,白花蛇 3 条,豹骨 9g,补骨脂、知母、黄柏、桂枝、羌活、独活、防风各 15g。共研极细末,水冷为丸。每服 3~9g,每日 2~3 次。

【来源】 谢文正,上海中医药杂志,1985,(11):32。

【功效】 培本补元,通和气血,温通经络,强壮筋骨。

【适应证】 进行性肌萎缩性侧索硬化症。

【方药简析】 方中重用黄芪、仙灵脾、鹿角培本补元,以资先后之天;熟地黄、白芍、枸杞子、杜仲、龟板滋阴养血,以补肝肾之阴;豹骨、补骨脂、菟丝子、续断、牛膝强壮筋骨;知母、黄柏以泻火清热;锁阳、海龙、海马、当归温阳益精,养筋润燥;人参、白术、薏苡仁大补元气以建中州;桂枝、木瓜、秦艽、羌活、防风、白花蛇舒筋活络。

【病案举例】 景某,男,43 岁,1969 年冬出诊劳累,感右下肢软瘫无力,抬腿困难。1972 年右手大、小鱼际肌、骨间肌趋向萎缩,肌纤维颤动。1974 年左侧肢体亦渐感乏力。查体:两手大小鱼际肌萎缩,右甚于左,肌力:右上肢Ⅲ级,左上肢Ⅳ级,右下肢Ⅲ级,左下肢Ⅳ级,双下肢腱反射亢进,双髌阵挛(+),踝阵挛(+),肌电图示:典型的慢性前角细胞病损。诊为进行性肌萎缩性侧索硬化症。查其面色萎黄,神疲身倦,形体瘦削,步态跛行,舌苔薄,舌胖边有齿印,质暗红,六脉细弱,中医辨证属本元内伤,气化不及,阴阳俱损,肢体失于温养,遂成痿证。以加味健步虎潜丸持续服用 9 年,病情稳定,肌萎缩控制,肌纤维震颤消失,肌力恢复,面色红润,形体趋丰,精神转佳,可坚持半日工作,且尚能操持家务。

【方名】 补中益气汤。

【组成】 黄芪 20g,炙甘草 5g,人参 10g,当归 10g,陈皮

6g,升麻 3g,柴胡 3g,白术 10g。

【来源】 李东垣《脾胃论》。

【功效】 补中益气,升阳举陷。

【适应证】 脾胃气虚,气虚下陷。

【方药简析】 方中以黄芪益气为君;人参、白术、炙甘草健脾益气为臣;共奏补中益气之功。配陈皮理气,当归补血,均为佐药。升麻、柴胡升举下陷清阳,为补气方中的使药。综合全方配伍大意,一是补气健脾以治气虚之本;一是升提下陷阳气,以求浊降清升,于是脾胃和调,水谷精气生化有源,脾胃气虚诸证可以自愈。

【病案举例】 王某,女,12岁,1983年1月22日初诊。2月前,因头晕乏力,心动过速等症入某医院住院治疗。查:发现患儿冈上、下肌,三角肌,胸大肌等轻度萎缩,双手大小鱼际肌及骨间肌轻度萎缩,以左手明显。四肢肌力,肌张力正常,腱反射活跃,以下肢较明显,经各项检查及化验,未见明显异常。后经做肌肉活检示:横纹肌萎缩变性,诊为“肌萎缩性侧索硬化症”。给服维生素类药物不效。症见:下肢痿弱无力,不能独立行走,终日卧床。左手大小鱼际肌明显萎缩,头晕,不能左右顾盼,语声低微,面部表情呆滞,纳差,口干,尿黄少,舌质红,苔薄白,脉虚大,重按无力。中医辨证为脾胃气虚、精血不足、筋肉失养。治以益气健脾升清。方用补中益气汤加减:生黄芪、桑寄生各 30g,当归、续断、党参、陈皮各 10g,炙甘草、柴胡、五味子、黄芩各 6g,麦门冬、怀牛膝各 15g,白术 12g,白芍 18g,升麻 3g。药尽 14 剂,已能行走自如,左手大小鱼际肌恢复正常,头不晕,食量日达一斤余。上方继进 70 余剂,四肢肌肉渐丰满,行走自如,已复学上课[姚树田,新中医,1985,(5):36]。

【方名】 振痿汤。

【组成】 黄芪 50g, 知母 20g, 白术 25g, 党参 25g, 当归 20g, 乳香 10g, 没药 10g, 牛膝 20g, 灵仙 10g, 制附子 10g, 制马钱子 3g。

【来源】 冯慕良, 辽宁中医杂志, 1984, (7): 38。

【功效】 健脾益气, 活血通络。

【适应证】 肌萎缩性侧索硬化症。

【方药简析】 方中黄芪、党参、白术益气健脾, 资后天而生气血; 知母滋阴补肾; 制附子温补脾肾; 当归、乳香、没药、牛膝养血和血通络; 威灵仙、马钱子舒筋活络。诸药共奏益气养血、健脾补肾、温经活络之功。

【病案举例】 张某, 男, 40岁, 1981年10月9日来诊。两腿沉重无力, 发凉月余, 脐以下至两腿麻木, 运动失灵, 逐渐加重。近3周来两腿痿废不用, 尤以右腿为甚, 站立需拄双拐用力扶持勉强迈步。眩晕耳鸣, 口干不渴, 脘闷纳呆, 尿黄便粘。症见: 形体尚丰, 神志清楚, 面色淡黄, 舌润, 苔薄黄腻, 脉沉缓。检查右腿痿废不用, 左腿运动失灵, 两腿肌肉拘紧, 无萎缩, 腱反射亢进, 巴氏征阳性, 右侧腹壁反射及提睾反射消失。诊为侧索硬化症。中医辨证属肝肾亏虚, 脾胃虚弱, 气血运行迟滞。治以补气血, 健脾胃, 通血脉以润宗筋。方用振痿汤, 守方连服30余剂, 左腿运动灵活, 右腿痿废减轻, 头晕, 口干不渴, 面部时有烘热, 舌淡红, 无苔, 脉沉细尺弱。上方加熟地 25g, 山茱萸 25g, 石斛 20g, 麦门冬 15g, 继服2月, 两腿麻木消除, 运动灵活, 能自由蹲立, 走路不拄拐, 膝腱反射正常, 巴氏征阴性, 腹壁反射及提睾反射正常, 脉象和缓。

【方名】 加味六味地黄丸。

【组成】 生地黄、熟地黄各 45g, 生山药 30g, 山茱萸

25g,丹参 25g,茯苓 30g,泽泻 30g,当归 30g,桑枝 60g,钩藤 30g,白蒺藜 30g,菊花 18g,蝉蜕 15g。共为细末,炼蜜成丸,每丸重 10g,早晚各服 1 丸。

【来源】 王占玺《临床验集》。

【功效】 补肾平肝熄风。

【适应证】 进行性脊髓性肌萎缩症。

【方药简析】 方中生地黄、熟地黄滋肾阴、益精髓是为君药。山茱萸酸温滋肾益肝,生山药滋肾补脾,共成三阴并补以收补肾治本之功。泽泻配生熟而泻肾浊;丹参配山茱萸以泻肝火;茯苓配山药而渗脾湿。当归、菊花柔肝和血;桑枝通经活络;钩藤、白蒺藜、蝉蜕平熄肝风。如此配伍,虽是补泻并用,但实际还是以补为主。

【病案举例】 张某,男,32 岁,1968 年 3 月 7 日初诊。2 年前发现左手尺侧麻木,手臂无力,提物吃力,随经某医院诊为进行性脊髓性肌萎缩症。此后逐渐两手大、小鱼际萎缩,消失,作肌电图检查三角肌、大鱼际肌均有双相及多相电位。且逐渐发生两臂不能抬起,左上肢变瘦,较右侧为细,肌张力降低,有时成束肌肉颤抖,不能持重物,舌苔薄白,脉细。中医辨证属痿证,乃肾阴偏虚,虚风内动致萎而肢麻等,随与补肾平肝熄风缓治其本,方用加六味地黄丸,早晚各服 1 丸,服药 6 个月,两手握力明显增加,手臂活动弹性较前为好,已消失之大、小鱼际肌又重新出现,且接近常态,左前臂麻木已去大半,并接近正常,舌苔薄白,脉细,仍宗前方 1 料,加全蝎 25g,蜈蚣 10 条,红花 25g,共为细末,炼蜜为丸,继续服用以巩固疗效。

【方名】 甘露消毒丹。

【组成】 滑石 30g,茵陈 25g,黄芩 12g,石菖蒲 15g,川贝

型发作者约 10%，常有家族史，青春期发病，头痛发作前有明显的视觉先兆，如眼前闪光、暗点、黑团、视野缺损（偏盲）或视物不清，甚至出现幻觉。个别病人可有头晕、肢体麻木、面红或苍白等症状。大约 10～30min 后上述症状消失，而突然出现一侧颞部搏动性头痛，常伴有恶心和呕吐，痛侧眼部充血，面色潮红或苍白。颞浅动脉轻度隆起，搏动对比侧明显，手压其颈动脉或颞动脉头痛减轻；低头、憋气、腹压增加或遇热时头痛加剧。发作持续 3～10h 后缓解，极少数可达 1～2 天缓解；女性患者在月经期前后发作频繁，高温环境亦可诱发。普通型发作在临床上更为多见，发作前多无先兆，头痛逐渐加重，可为一侧性，也可双侧性，头痛程度较轻，但持续时间可常达数天。特殊型发作者除具备偏头痛一般特点外，有其特殊症状和体征。如眼肌麻痹型偏头痛，基底动脉型偏头痛等。本病根据青春期前后长期反复发作的一侧头痛史，体检及有关家族史诊断并不困难。若试用麦角胺剂止痛有效，则诊断更加明确。但需与高血压性头痛、颅内占位性病变、丛集性头痛、颞动脉炎、肌紧张性头痛、脑血管畸形、头痛型癫痫、三叉神经痛、神经官能症相鉴别。其治疗主要是解除头痛的发作症状和减少或防止头痛的反复发作。平时避免过度疲劳和精神紧张，饮食不宜过饱或过饥，不吃高脂肪食物和饮酒，对已知的激发性饮食项目应避免。发作期应在安静、避光的室内休息，或服镇静剂及镇痛剂（水杨酸类和消炎痛等）；头痛严重者可选用麦角胺制剂，若偏头痛处于持续状态或严重的头痛可予硫酸可待因或杜冷丁等麻醉剂及镇痛剂。间歇期每月发作 2～3 次以上者应考虑长服用预防药物如心得安、尼莫地平、西比林、西比灵或丙戊酸钠。亦可选用精神疗法、催眠疗法、自我训练、生物反馈疗法等。

偏头痛属于中医的头痛范畴。病因病机多与肝、脾、肾三

脏有关。根据临床表现可分为四型。肝阳亢盛型用天麻钩藤饮,淤血阻络型用通窍活血汤,痰浊蒙窍型用半夏白术天麻汤,风邪侵袭型用川芎茶调散。针灸对治疗本病也能收到良好疗效,如体针、耳针、梅花针、水针等均可选用。

于淑云用天麻芎蝎冲剂(天麻 10g,川芎 30g,全蝎 10g,水蛭 10g,牛膝 30g,菊花 10g,白芷 15g,蔓荆子 20g,甘草 10g。共研细末,每次 10g,每日 2 次)治疗血管性头痛 42 例,男 18 例,女 24 例;年龄最小的 18 岁,最大 55 岁;病程最短 15 天,最长 15 年。结果治愈 21 例,近期好转 19 例,无效 2 例,总有效率 95.2%[河南中医,1995,(4):211]。

邱德明用 He-Ne 激光照射经络穴位(神庭、百会、头维、风池、上星、大椎、太阳、合谷、血海、风市、三阴交和膻穴,也可取耳穴,每穴照射 5~10min,每次 3~5 穴,每日 1 次,7 次为 1 疗程,疗程间隔 2~3 天。激光输出功率 1~2 毫瓦)治疗顽固性头痛 11 例,痊愈(头痛消失,半年来无复发)6 例,显效(头痛基本消失,偶有轻微疼痛)3 例,好转(头痛缓解或显著减轻,但 1 个月后复发)2 例[四川中医,1988,(7):25]。

鲁万强用五磨饮子加郁金、香附、青陈皮、川芎治愈 1 例头痛[四川中医,1988,(12):38]。

余泽勋等用通窍止痛汤(桃仁、红花、当归、赤芍、川芎、白药、地黄、羌活、白芷、鸡血藤)治疗慢性顽固性头痛 100 例,男 31 例,女 69 例;年龄最小 12 岁,最大 60 岁;病程最短半年,最长 30 年。属风寒型(合麻黄附子细辛汤)16 例,风热型(加黄芩、柴胡、石膏、蔓荆子)13 例,淤血型 53 例,痰湿型(合五苓散、二陈汤)9 例,肝肾阴虚型(加枸杞子、菟丝子、钩藤、生龙骨、生牡蛎、石决明)9 例。共治愈 45 例,显效 35 例,好转 18 例,无效 2 例。其中淤血型治愈 29 例,占 54.7%;其它 4 型治愈 16 例,占 34.6%[实用中西医结合杂志,1991,(7):426]。

孙小苍用川芎嗪注射液(每次 40~50mg,每日 1~2 次,肌注)治疗偏头痛 12 例,结果 1 疗程(10 天)后,全部病人在发作期头痛减轻,2 疗程后发作频率减少,头痛持续时间平均从 2 天半缩短为半天。经 2~3 年随访,有 8 例 2 年以上未发作;3 例 1 年发作 1 次;1 例半年发作 1 次。治疗中未发现有毒副反应[实用中西医结合杂志,1991,(3):156]。

任世玉用穴位内埋针(准备皮内针 2 枚,用 75%乙醇溶液浸泡 15min,镊子 1 把,1cm×1.5cm 橡皮膏 2 块。选取患侧太阳、头维。如疼痛延伸到整个头部,可增加上星、百会。令患者取坐位或侧卧位,在所选穴位处进行常规消毒,然后用镊子夹住皮内针柄,使针体与经络走向成“+”字垂直,沿皮下横刺而下,当针体达 0.8~1.5cm 深处时,用橡皮膏固定(有毛发生长部位,可剃去周围毛发,以便固定)。病轻者留针 1~2 天,病重者留针 2~4 天)治疗偏头痛 50 例,男 17 例,女 33 例;年龄最小者 13 岁,最大者 56 岁,其中 16~35 岁者 40 例;病史最短者 1 年,最长者 5 年。均在接受治疗后 24h 内达到完全止痛效果,近期疗效为 100%[中医杂志,1988,(7):51]。

俞子彬用头痛停糖浆(丹参 15g,当归 10g,白芍 10g,川芎 12g,熟地黄 10g,鸡血藤 15g,夏枯草 9g,珍珠母 20g(先煎),细辛 2g(后下),刺蒺藜 10g,菊花 6g,秦艽 10g;加水 1 000ml煎煮后加入白糖溶化浓缩至 100ml)每日 1 剂,12~15 天为 1 疗程,治疗前后查血液流变学及脑血流图,服药期间停服其他药物。治疗高原地区血管性头痛 30 例,男 11 例,女 19 例;年龄 17~51 岁;病程 1 年内 4 例,2 年 8 例,5 年 7 例,8 年 2 例,10 年 6 例,15 年以上 3 例。治疗结果:临床近期治愈(头痛及伴随症状消失,脑血流图恢复正常,观察半年病情稳定)9 例,显效(头痛明显减轻,发作次数显著减少,脑血流图好转)18 例,无效(头痛未见减轻,脑血流图异常)3 例[中

医杂志,1988,(5):20)】。

徐启刚用头痛煎(川芎 15g,羌活 12g,细辛 3g,白芷 15g,赤芍 15g,延胡索 10g,三七 6g)。风热加桑叶、薄荷;痰湿重加半夏、桔梗、竹茹;肝旺加天麻、钩藤、菊花。治疗血管性头痛 51 例,偏头痛型 29 例(普通型 16 例,典型偏头痛 10 例,眼肌麻痹型 3 例),非偏头痛型 22 例;男 18 例,女 33 例;年龄 15~66 岁;病程<1 年 10 例,1~5 年 27 例,5~10 年 11 例,10 年以上 3 例。根据头痛发作程度及频率可分 3 类:重型 13 例,中型 32 例,轻型 6 例。51 例经神经系统检查,其中 1 例头痛侧眼球外展受限,2 例头痛侧眼球内收、上下活动受限,其余正常。眼底检查均正常,5 例做了脑超声检查,中线波均无移位。治疗结果症状缓解 12 例,进步 38 例,无效 1 例,总有效率 98%[中医杂志,1986,(2):34]。

姚永年用颅痛饮,Ⅰ号方由白芍、钩藤、龙齿(先煎)各 30g、川芎 20g,葛根、白芷、白蒺藜各 20g,细辛 15g,生石决明(先煎)60g 组成。Ⅱ号方由白芍、钩藤、龙齿(先煎)各 30g,川芎 6g,薄荷(后下)10g,丹参、白芷各 15g,葛根、白蒺藜各 20g,生石决明(先煎)60g 组成。每天煎 1 剂,分 2 次服。个别重症可增加半剂,即每天 1 剂半,分 3 次服。Ⅰ号方适用于头痛无明显呕吐及血管搏动感,舌质偏暗或有淤斑,痛时面色变白,辨证为淤血而表现为血管收缩者。Ⅱ号方适用于头痛伴明显呕吐,血管搏动,或痛侧目珠发红、面赤,血管呈扩张者。痛剧时,Ⅰ、Ⅱ号方内均可加泽泻 30g,Ⅰ号方内可加细辛 15g。搏动感明显者可在Ⅱ号方内加麻黄 15~24g(先煎 20min,去上沫),心率较快,血压较高时则不加麻黄。治疗血管性头痛 569 例,男 108 例,女 461 例;年龄 16~72 岁,以 20~40 岁居多;病程最短 14 天,最长 50 年。治疗结果 569 例中,控制发作 400 例(服药后头痛缓解并控制 2 个月以上不复发者)占

70.3%；显效 112 例(头痛明显减轻,不影响正常工作学习。或服药痛止,停药痛作,需长期依赖药物者)占 19.7%；无效 57 例(头痛不能缓解,仍需加西药止痛者)占 10%[上海中医药杂志,1992,(1):27]。

陈国庆用头痛灵(柴胡、当归、白芍各 15g,川芎、郁金、延胡索、白芷各 9g,细辛、高良姜各 6g,甘草 3g。上药共研细粉,炼蜜和丸,每丸重 9g,1 次 1 丸,1 日 2~3 次。总量 30 丸为 1 个疗程。在偏头痛剧烈,发作频繁时,还可改为汤剂,一旦症缓,即改用丸剂)治疗偏头痛 96 例,年龄 18~60 岁,病程 3 个月~10 年。结果治愈 58 例,好转 32 例,无效 6 例;总有效率 94%[陕西中医函授,1993,(5):34]。

聂云汉等用皮内埋针方法(准备 1.5~2 寸毫针 2 枚,将针柄捏制成圆形或半圆形小圈,用 75%乙醇溶液浸泡 15min;1.5~2cm 橡皮膏 2 块,选取患者的颞前线,在颞部两鬓内,从额角下部向耳前发处,(即由颌厌穴连悬厘穴)和颞后线在颞部耳上方,耳尖直上方处(即由率谷穴连曲鬓穴)。令患者取坐位或侧卧位,在所选的区域上进行常规消毒,医者右手拇指、食指夹持圆形或半圆形针柄,快速沿皮横刺而入 1.5~2 寸(患者自感局部沉紧或麻电感)为宜,然后将针柄贴靠在头皮上(须剃周围毛发,以便粘贴固定)用橡皮膏粘贴固定,留针 24~48h 或更长一些时间,待疼痛停止后,方可起针。起针后用消毒干棉球压迫 2~3min,以防出血)治偏头痛 166 例,结果埋针 12~24h 疼痛停止者 92 例,占 55.4%;25~48h 疼痛停止者 46 例,占 27.7%;48h 以上疼痛停止有短暂发作者 28 例,占 16.9%。就近期疗效而言,总有效率 100%[新中医,1990,(10):32]。

【方名】 芎芷石膏汤。

【组成】 川芎 12g,白芷 9g,石膏 21g,菊花 9g,羌活 9g,藁本 12g。

【来源】 吴谦《医宗金鉴》。

【功效】 疏风清热,活血止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中川芎、白芷、菊花、石膏疏风清热;羌活、藁本疏散风邪;川芎、菊花兼熄内风,更有川芎行血中之气,祛血中之风,上行头目,为治头痛之要药。现代研究表明川芎可透过血-脑屏障,扩张血管,白芷兴奋血管运动及迷走神经,羌活对微血管有抑制及调节作用,菊花、藁本、石膏均有较好镇痛、解痉、止痛功效。杜纪鸣用本方治疗偏头痛型血管性头痛 78 例,年龄 17~68 岁,病程 1~8 年。结果痊愈(症状完全消失,1 年以上无复发)42 例,有效(头痛基本消失,除偶有一过性头痛外,无大发作)29 例,无效 7 例,总有效率 91%。

【病案举例】 张某,女,38 岁,1985 年 4 月 12 日初诊。患右侧偏头痛 4 年余,为持续性跳挖痛,并阵发性加重,重时抱头不动或企图撞墙,多次经内科、神经科检查均未查到与头痛有关的阳性体征,口腔与耳鼻喉亦未查到与头痛有关病灶,眼底正常;脑血流图提示脑血管紧张度增高,诊断为血管性头痛。经常用烟酸、利眠宁、苯妥英钠、鲁米那等,严重时需服可待因,因效果不佳,求服中药。症如前述,投上方,服 15 剂后,头痛较前明显缓解,为巩固疗效,继服 15 剂。随访年余,未复发[广西中医药,1989,(5):24]。

【方名】 定痛饮。

【组成】 全蝎 6g(研细末分吞),川芎 15g,钩藤 30g(后下),天麻 15g,菊花 15g,川牛膝 15g,赤芍 15g,白芍 30g,菖蒲 6g,葛根 20g,生石决明 25g。

【来源】 赵培基,实用中医内科杂志,1992,(4):30。

【功效】 平肝熄风,化痰通络止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 偏头痛主要病因为风、火、痰、淤、虚,病位在脑,肝风上扰,痰淤阻窍,气血亏损,肝肾不足,为其病机,但主要是肝阳上亢或肝风上扰,痰淤互阻所致者约占偏头痛的80%以上,尤其是在急性发作期,以风火痰淤标实为主。方中生石决明、天麻、钩藤、川牛膝、菊花、葛根平肝熄风;川芎、赤芍、白芍、川牛膝、全蝎,活血化淤,通络止痛;菖蒲豁痰开窍。若兼眩晕加龙骨、牡蛎;眼眶疼痛牵及眼球时加白芷、旋复花;恶心呕吐加半夏、代赭石;耳鸣、目干、腰酸腿软加当归、生地、龟板。赵氏用本方治疗偏头痛100例,男37例,女63例;年龄12~62岁;病程4个月~21年;普通型65例,眼型25例,椎-基底动脉型10例。结果治愈(症状消失,停药半年~1年未见复发)41例,好转(头痛兼证基本消失,停药1年有复发,但发作次数减少,疼痛减轻)56例,无效3例,总有效率97%。其中有5例因疼痛较剧烈而临时口服卡马西平。

【病案举例】 李某,女,38岁,1987年4月2日初诊。于4年前无明显诱因,发作左侧偏头痛,其发作前眼前发黑,视物模糊;发作时左侧头痛较剧,呈胀痛、针刺样疼痛,可扪及血管搏动,时有呕吐,约3~4h缓解,此后每月均发作。西医诊为偏头痛,给以麦角胺治疗,可缓解一时,随后再发,也曾延中医诊治,但疗效不佳。近1个月来,阵发性偏头痛,有时波及全头部,剧时如锥刺,令家属用绳索束之头上,痛处不移,伴恶心呕吐,舌红,舌下络脉迂曲,脉弦。月经后延,其色黑有块,其人平素性急如火,无端与家人发脾气。西医诊断:偏头痛。中医辨证,郁怒伤肝,肝郁化热,日久暗耗阴液,而肝阳化风上扰。痛久有淤,脑络阻滞,肝旺乘上,土虚湿困,化浊生痰。证属肝风

上扰,淤痰阻滞清空。治以平肝熄风,化痰通络止痛。处方:全蝎 6g,川芎 15g,钩藤 30g,菊花 20g,生石决明 20g,白芍 30g,川牛膝 15g,赤芍 15g,天麻 10g,菖蒲 6g,葛根 20g,半夏 10g,代赭石 25g。药入 3 剂,头痛明显减轻,再进 3 剂而痛止。后在上方的基础上减生石决明加龟板、当归改配丸药调理,追访 2 年未复发。

【方名】 活血止痛汤。

【组成】 当归 10g,川芎 35g,白芷 6g,菊花 12g,白芥子 6g,香附 6g,柴胡 6g,桃仁 9g,甘草 3g。

【来源】 邵正泰,陕西中医,1986,(11):492。

【功效】 活血化淤,行气止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中重用川芎搜风破淤血而止痛;当归、桃仁佐川芎以活血行淤,白芷、香附、菊花、白芥子利气行气以活血;柴胡入少阳引药直达病所;甘草调和诸药。左侧痛加龙胆草、黄芩;右侧痛加藁本、独活;痛连巅顶加藁本、珍珠母;刺痛明显加红花、制乳香;久痛或痛不可忍加全蝎、蜈蚣、水蛭;体虚乏力加黄芪、党参;失眠多梦加远志、石菖蒲、夜交藤;血压偏高者加牛膝、地龙、龙胆草、钩藤、石决明;饮食不佳加陈皮、焦三仙。邵氏用上方治疗偏头痛 84 例,年龄 9~78 岁;病程 15 天~12 年。结果治愈 69 例,好转 11 例,无效 4 例,总有效率 95.24%。

【病案举例】 张某,男,58 岁,1983 年 6 月 3 日就诊。患者左侧头痛 3 年余,呈间断性发作,痛如锥刺,呼叫不已,彻夜难眠,时有呕吐,曾在某医院诊为“血管性头痛”,服药不效,故来求诊。查形体消瘦,痛苦病容,血压 16/9.3kPa,舌质偏暗,苔薄白稍腻,脉沉细而涩。西医诊断:偏头痛,中医辨证证属气

愈。随访5年未复发。

【方名】 偏痛饮。

【组成】 川芎 20g, 细辛 13g, 全蝎 4g, 石决明 50g (先煎), 白芍 30g, 丹参 20g, 苦丁茶 10g。

【来源】 张西恒, 河北中医, 1990, (1): 13。

【功效】 活血通络, 祛风止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中川芎、丹参活血化瘀, 通络止痛; 重用石决明配伍全蝎、白芍、细辛、苦丁茶平肝潜阳熄风, 解痉止痛。张氏用本方治疗偏头痛 98 例, 男 22 例, 女 76 例; 年龄 13~59 岁; 病程 20 天~13 年。服药 3~9 天, 头痛停止并稳定 3 个月无复发 79 例, 为治愈; 服药 10 天以上, 头痛发作减少程度减轻 14 例, 为好转; 无效 5 例; 总有效率 94.9%。

【病案举例】 牛某, 女, 29 岁, 1986 年 11 月 1 日初诊。反复发作性右侧偏头痛 3 年, 每遇劳累或情绪波动时发作。胀痛剧烈, 伴有恶心。常服西药止痛, 缓解片刻, 停药复发作。西医诊断: 偏头痛。舌红苔白, 脉弦细, 改服偏痛饮, 9 剂而痛止, 随访半年未复发。

【方名】 头痛宁。

【组成】 蔓荆子 15g, 延胡索 20g, 石决明 20g, 当归 15g, 白芍 20g, 川芎 15g, 生地黄 20g, 钩藤 20g。

【来源】 李宝玉, 湖北中医杂志, 1993, (6): 20。

【功效】 协调阴阳, 化淤通络。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中蔓荆子、石决明、钩藤、当归、白芍养血柔肝, 平肝熄风; 重用川芎辛香走窜上达巅顶, 下通血海为治

头痛要药。心血虚易见心悸,心烦失眠,加酸枣仁 12g、远志 12g、龙眼肉 15g;痛在前额者加白芷 15g;痛在两侧者加柴胡 10g、黄芩 10g;痛在巅顶者加藁本 12g、吴茱萸 10g;因受寒诱发者去生地加桂枝 10g、防风 10g;痰多恶心者,去生地、白芍加半夏 10g、竹茹 12g;肝阳上亢者加菊花 15g、夏枯草 12g、栀子 10g、怀牛膝 15g;久治不愈伴舌有淤斑点者加赤芍 15g、全蝎 3g、蒲黄 10g、五灵脂 10g;气短体倦无力者加黄芪 20g、党参 12g。李氏用本方治疗偏头痛 80 例,年龄 20~72 岁,病程 2 个月至 20 年;其中典型偏头痛 44 例,普通偏头痛 20 例,基底动脉型偏头痛 10 例,眼肌麻痹型偏头痛 6 例。经检查脑血流图,脑血管供血不足者 21 例,两侧循环不对称者 29 例。未作脑血流图检查者 30 例。结果临床近期治愈(头痛及伴随症状消失,观察 1 年病情稳定)52 例,显效(头痛明显减轻,发作频率降低,发作周期延长,原 1 日发者延长至 3 日以上 1 发,原 1 周 1 发延长至半月以上 1 发)26 例;无效(连续治疗 6 周以上头痛及伴随症状无明显缓解,发作频率和周期无明显变化)2 例。治疗后脑血流图复查恢复正常 45 例。

【病案举例】 王某,女,30 岁,1990 年 5 月 10 日就诊。反复发作偏头痛 4 年,每周发作 2~3 次,每次持续时间 2~3h,月经前尤易发作,伴头昏,面部烘热感,眼前飞舞金星,口苦,心烦易怒,恶心,溲赤便干,舌边尖红,苔薄黄,脉弦数。脑血流图和脑电图检查均正常。曾服止痛、镇静西药,均无效。追问家族史,其母患有偏头痛。综观脉症,证属肝血不足,血虚生热,风动火生,风火上扰清窍,导致络脉阻滞,精血内痹发为头痛。治以养血清热,平肝熄风,通络止痛为法。药用钩藤 20g(后下),石决明 20g,当归 15g,生地黄 30g,白芍 30g,川芎 15g,延胡索 20g,栀子 12g,夏枯草 15g,菊花 12g,竹茹 12g。二诊,服上方 3 剂后,头痛大减,但夜寐不宁,予上方加远志

12g,生龙骨、生牡蛎各 20g,续服 24 剂后,诸症消失。随访 1 年未见复发。

【方名】 蠲痛汤。

【组成】 僵蚕 12g,蜈蚣 2 条,菊花 20g,连翘 12g,玄参 15g,荷叶 15g,白茅根 15g,藁本 10g,荆芥穗 12g,川牛膝 15g。

【来源】 张丽,辽宁中医杂志,1992,(1):34。

【功效】 祛风散寒清热,通络止痛。

【适应证】 顽固性头痛(偏头痛)。

【方药简析】 本方剂量为编者所加。方中僵蚕、蜈蚣祛风止痉,通络止痛;藁本上达巅顶,为头部疼痛引经药,使诸药直达病所;荆芥穗散风热清头目;菊花、薄荷、荷叶、白茅根清利头目;连翘、玄参、川牛膝散风清热,养阴生津,凉血活血,引邪下行,与荷叶查配升清降浊。偏风热重用菊花、连翘、薄荷;风寒型重用藁本;经前头痛重用川牛膝,加丹参、益母草;肝阳上亢型重用川牛膝加代赭石。张氏用本方治疗偏头痛 150 例,年龄 16~69 岁,病程 2 天~40 年;其中属风寒型 56 例,风热型 82 例。治疗结果,近期痊愈(疼痛完全消失,随访 1 年,未见发作)138 例,显效(疼痛完全消失,随访 3~6 月内有复发,但病情减轻,发作次数减少,再次治疗仍然有效)9 例,有效(疼痛基本消失,但仍然经常发作)2 例,无效(治疗前后无变化)1 例。远期疗效,经治疗后 1 年,随访疼痛消失 138 例,复发 2 例,复发率 1.4%;经治疗后 2 年,随访疼痛消失 50 例,复发 1 例,复发率为 2%;经治疗后 3 年,随访疼痛 11 例,无复发。一般复发病例的自觉症状,大部分较治疗前为轻,继续治疗仍然有效。总有效率 99.3%。

【病案举例】 李某,男,45 岁。反复发作剧烈头痛 19 年

余,发作时头剧烈疼痛而胀,时轻时重,重时酷似针刺火燎,痛苦难言,1日发作3~5次,多达20余次。舌质红,苔黄,脉浮数。曾用中药、西药、针灸治疗效果不佳。检查:眼底乳头边清,生理凹陷存在,余正常。诊断为顽固性头痛。用自拟蠲痛汤加减方2剂,疼痛明显好转,再按原方服药2剂,疼痛完全消失,经随访观察至今,未见发作。

【方名】 升清降浊汤。

【组成】 净荷叶 10~15g,怀牛膝 15~24g,柴胡 6g,黄芩 6g,川芎 30g,生白芍 18g,蔓荆子 6~15g,土茯苓 30g。

【来源】 白俊峰,北京中医杂志,1993,(3):25。

【功效】 升清降浊,除湿止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中荷叶、柴胡轻扬升散,升清降浊;怀牛膝活血化淤,引淤下行而降浊;川芎、生白芍活血通络,缓急止痛;黄芩、蔓荆子清上疏风止痛;土茯苓清热利湿解毒。左侧疼痛,重用荷叶;右侧疼痛,重用怀牛膝;肝阳偏亢,加代赭石、钩藤;淤血阻络,加丹参、桃仁、水蛭。白氏用本方治疗偏头痛60例,年龄16~66岁;男21例,女39例,35~45岁者28例;病程3个月~10年。结果显效(头痛及兼证完全消失,停药1年以上疗效巩固,未再反复)31例,有效(头痛与兼证消失,停药半年至1年内有反复,但发作次数明显减少,疼痛程度明显减轻)28例,无效(头痛与兼证虽然减轻或消失,但停药后半年内出现反复,且疼痛程度无明显减轻)1例,总有效率98.33%。

【病案举例】 周某某,女,42岁。患偏头痛4年,多次医治疗效欠佳,曾赴北京某医院检查,诊断为“血管神经性头痛”,初服用麦角胺咖啡因疼痛可止。今年头痛频作,服用麦角

胺咖啡因、镇脑宁、镇天丸、复方羊角冲剂等药不效。刻诊：左侧额颞部刀割样剧痛，痛连眼、齿部位，痛作时伴心烦恶心、以头撞墙为快，痛止后头重胀，精神不振，舌质红，苔薄白，脉弦小数。处方：荷叶 15g，怀牛膝 15g，柴胡 6g，黄芩 6g，川芎 30g，生白芍 18g，蔓荆子 10g，土茯苓 30g。进药 1 剂，疼痛缓解，效不更方，又进 5 剂，以资巩固，随访 2 年，疗效稳定。

【方名】 清上蠲痛汤。

【组成】 当归 10g，川芎 10g，白芷 10g，羌活 10g，独活 10g，防风 10g，苍术 10g，黄芩 10g，菊花 6g，麦冬 6g，甘草 6g，细辛 3g，生姜 3 片。

【来源】 王志成，河北中医，1993，(2)：10。

【功效】 活血行瘀，祛风止痛。

【适应证】 血管性头痛。

【方药简析】 当归、川芎养血活血，通络止痛；羌活、独活、防风、白芷、细辛、生姜祛风止痛；黄芩、菊花清利头目；苍术芳香化湿；麦冬养阴生津防祛风药辛燥之弊。风盛痛甚者，加荆芥 10g，木瓜 10g，苍耳子 10g；痰壅、食积或前额眉棱骨痛甚者，加天麻 10g，半夏 10g，山楂 10g，枳实 10g；气血两虚伴有自汗者，加黄芪 15g，党参 15g，白芍 10g，生地黄 15g；巅顶痛者，加藁本 10g、全蝎 5g；左偏头痛者，加红花 6g、柴胡 10g、龙胆草 6g，生地黄 10g；右偏头痛者，加黄芪 10g，葛根 10g。聂家驹用本方治疗偏头痛 32 例，男 9 例，女 23 例；丛集性头痛 15 例，男 4 例，女 11 例；紧张性头痛 21 例，男 10 例，女 11 例，共计 68 例。年龄大小不一，14~45 岁者为数最多；病程最短 2 个月，最长 11 年，平均 2~3 年。结果痊愈 36 例，显效 16 例，无效 5 例，总有效率 92.65%。

【病案举例】 温某，女，28 岁，发作性左颞侧头痛 3 年，

疼痛呈搏动性跳痛,伴同侧眼眶胀痛,每2~3个月发作1次,最近4~5个月来,头痛发作频繁,且多伴呕吐,失眠,每精神紧张或月经期时即发作。血压13.3/9.33kPa。舌质淡,舌苔白,脉弦细。眼底(-),双侧颞动脉搏动对称。多普勒超声检查:双侧脑血流量高低比值 >1.2 。1989年4月20日初诊,予清上蠲痛汤加红花6g,天麻10g,半夏10g,服3剂。二诊时头痛减轻,恶心、呕吐消失,续服原方5剂。三诊时诸症消失。为巩固疗效,嘱其月经来潮前3天服上药至经净为止,共2个周期而告愈,1年后追踪观察无复发。

【方名】 加味散偏汤。

【组成】 川芎30g,白芍15g,白芷3g,郁李仁3g,柴胡3g,甘草3g,白芥子10g,香附6g。

【来源】 张玉学,四川中医,1988,(2):30。

【功效】 活血化淤,祛风止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 方中川芎为君,乃血中气药,性善疏通,上行头目,活血行气,祛风止痛;现代研究表明,川芎有较强的解热镇痛作用,辅以白芷辛温芳香,温通上达,能祛风通络止痛。2药合用,无论外感或内伤均可收效。再以柴胡、香附理气开郁止痛,白芥子散结止痛,白芍、郁李仁柔润以佐之,甘草以调和之。本方用川芎量较大,辛窜之力较强,但未见偏弊之弊。偏头痛兼气虚明显者,加黄芪30g、党参12~15g;兼肝阳上亢明显者,加龙胆草6~10g,菊花15~20g,石决明30g;兼痰湿重者,加石菖蒲10~12g,郁金12~15g,陈皮12g,半夏12~15g,茯苓15g;肝血不足者加当归10~12g,生地黄、何首乌、酸枣仁、夜交藤各2~15g。张氏用本方治疗22例偏头痛患者,其中男性9例,女性13例;年龄22~55岁之间;病程最短

6天,最长13年。患者均于发作初期就诊。每天发作5次以上者6例,2~4次者15例,1~2次者1例。每次发作时数分钟或数小时不等。结果治愈21人(其中服药3剂治愈者11人,持续服药4~6剂痊愈者8人,服药7~10剂痊愈者2人),好转1人。服药过程中未见任何不良反应。

【病案举例】 李某,男,45岁,1985年5月20日就诊。5年来右侧偏头痛连及脑后,逐渐加重,曾经中西药物及针灸治疗,症状时轻时重而终未愈。近半年发作频繁,痛不可忍,重时1日可达数十次,每次5~10min,伴心烦急躁,口苦,纳差。舌质红,舌边见淤斑,脉弦滑。西医诊断偏头痛,中医辨证,证属肝经郁热,风痰上扰,淤阻清窍。拟散偏汤加味:菊花15g,龙胆草10g,石决明30g,僵蚕10g。3剂后头痛即缓解,头痛次数由每日10次减为3~5次,每次发作仅1~2min即过。继进4剂,头痛已不发作。随访半年未见复发。

【方名】 乌头芎芷散。

【组成】 乌头15g,川芎15g,白芷30g,甘草15g,薄荷10g,细茶10g。

【来源】 清《太医院秘藏膏丹丸散方剂》。

【功效】 疏风清热,通络止痛。

【适应证】 顽固性偏正头痛。

【方药简析】 顽固性偏正头痛乃因风邪外袭,循经上扰头窍,阻遏清阳之气所致。方中乌头为辛热之品,能祛风除湿,温经通络,具有较强的止痛作用;川芎止头痛,善上行巅顶,且善治阳明经头痛;甘草调合诸药,用时以薄荷、清茶叶调下,取薄荷能清利头目,搜风散热。张进安等用上方治疗多例顽固性偏正头风及三叉神经痛,屡获佳效。

【病案举例】 王某,女,28岁,1993年5月7日初诊。主

3天,痊愈出院。随访2年余,未见复发。

【方名】 柴胡川芎饮。

【组成】 柴胡 15g,当归 15g,白芷 15g,僵蚕 15g,葛根 15g,白芍 15g,川芎 30g,细辛 7.5g,甘草 10g,吴茱萸 10g。

【来源】 陈治水,四川中医,1988,(5):31。

【功效】 活血通络,熄风止痛。

【适应证】 偏头痛。

【方药简析】 偏头痛之病因,古人有风、火、痰、淤之说,然肝胆二经受邪,气血逆乱,扰及清窍乃本病之主要原因。头部两侧属少阳,足厥阴肝经上行连目系,出于额,与督脉会于巅顶。《临证指南》中曰:“头为诸阳之会,与厥阴肝脉会于巅,诸阴寒邪不能上逆;为阳气窒塞,浊邪徐以上据,厥阴风火乃能逆上作痛。”指出了阴寒、浊邪、风火犯厥阴则头痛。本方中以柴胡、川芎为主药,柴胡入肝胆二经,能疏肝理气,条畅气血,引清阳之气上升,导诸经之药直达病所;川芎上行头目,下行血海,为治诸经头痛之要药。《丹溪心法》中曰:“头痛须用川芎,如不愈各加引经药。太阳川芎,阳明白芷,少阳柴胡,太阴苍术,少阴细辛,厥阴吴茱萸。”笔者集诸经之药于一炉,加当归养肝血,僵蚕熄风化痰,葛根、白芍、甘草缓急止痛,全方温凉并用,能疏利肝胆,熄风化痰,化淤通络。挟肝火者加龙胆草、栀子各 10g,夏枯草 15g;肝阳上亢者去吴茱萸、川芎,加生龙骨、生牡蛎、生石决明各 20g(先煎);夹湿者加半夏、天南星、羌活各 9g;夹淤血者加桃仁、红花各 15g。陈氏用本方治疗偏头痛 56 例,男性 17 例,女性 39 例;年龄 16~65 岁;病程最短者半年,最长者 12 年,平均 4 年 6 个月。经治疗后,痊愈(症状消失,随访 1 年无复发)36 例,显效(症状基本消失,1 年内偶有复发,但症状大为减轻)15 例,好转(症状有所缓解)5 例。

服药最少 6 剂,最多 30 剂。

【病案举例】 刘某某,女,27 岁,1985 年 1 月 11 日诊。左半侧头痛,间断发作 12 年。每次发作前双手麻木,眼冒金花,继之左半侧头部剧烈刺痛或跳痛,以颞部为重,牵连眼眶和左上齿疼痛,伴恶心,呕吐,四肢不温。20 天左右发作 1 次,每次持 2~3 天。本次发病 1 天,舌质暗淡,苔薄白,脉弦紧。诊断:偏头痛,中医辨证乃肝经寒气上犯清阳而致。方用柴胡川芎饮加半夏 15g,生姜 3 片。服药 6 剂,诸症消失。随访 2 年余,头痛未再发作。

【方名】 九白镇痛汤。

【组成】 白菊花 10~30g,白芍 10~30g,白芷 10~38g,白芥子 6~18g,白附子 3~10g,白僵蚕 3~10g,白蒺藜 6~18g,白术 10~24g,葱白 1~5 茎,葛根 10~30g,制乳香 3~15g,制没药 3~15g,甘草 6~12g。

【来源】 袁源,河南中医,1989,(1):32。

【功效】 疏风祛邪,化痰止痛。

【适应证】 偏头痛及顽固性头痛。

【方药简析】 方中白菊花、白芷、葱白、葛根疏风祛邪;白芥子、白附子、白僵蚕、白术、白蒺藜健脾化痰,熄风解痉;白芍、制乳香、制没药、甘草缓急止痛。其小量为基本用量,大量为重用量。若属风寒型重用白芷、葱白;风热重用白菊花、葛根,加黄芩;肝阳减白附子,重用白芍、白僵蚕、白蒺藜,酌加夏枯草、生龙骨、生牡蛎;淤血重用白芷、白僵蚕、制乳香,加桃仁、红花、郁金;气虚用白术、重加黄芪、党参、何首乌;血虚重用白芍,加何首乌、酸枣仁、熟地黄、枸杞子;肾虚加补肾药;冷痛、剧痛者重用白附子加川乌;痰湿重用白芥子、白附子;头痛缓解后,宜予杞菊四物汤巩固疗效。袁氏用本方治疗头痛 248

例,男 96 例,女 152 例;年龄最小 11 岁,最大 65 岁,16~35 岁 199 例,病程最短 2 天,最长 12 年。属风热型 75 例,风痰湿型 64 例,风寒型 41 例,偏头痛 19 例,肝阳型 21 例,肾虚型 6 例,血虚型 13 例,淤血型 6 例,气虚型 3 例。治疗结果,除 4 例自动停药(1 例颅内肿瘤、1 例头痛型癫痫、2 例肾虚头痛)外,全部治愈,最少 2 剂,最多 26 剂,平均 8.73 剂。

【病案举例】 韩某某,女,38 岁,1984 年 9 月 18 日初诊。患者 10 年前产后始发头痛,痛在前额及后脑,持续性隐痛,阵发性加剧,不耐寒热劳累,冬春更剧,伴目昏口淡,项紧,恶风,心烦心悸,乏力多梦,舌淡红,苔薄腻,脉细滑。诊断:偏头痛。中医辨证此血虚伤风,痰湿内阻,阳气不得通达所致,方予:白菊花 10g,白芍 10g,白芷 10g,白芥子 18g,白附子 10g,白僵蚕 6g,白蒺藜 10g,白术 15g,葱白 3 茎,葛根 15g,制乳香、制没药各 10g,甘草 3g,酸枣仁 30g,何首乌 30g。5 剂头痛缓解,又 5 剂,痼疾除,八珍汤善后。随访至今未复发。

15 散发性脑炎

散发性脑炎简称散脑,是特指原因不明的,散在发生,无明显地区性、季节性的,在临床上符合脑炎表现的急性脑病,而不是一个独立的疾病。目前认为散脑是一个没有病毒学、免疫学诊断基础的一个过渡性诊断名词,实质上在这一疾病的名称下包括真性病毒脑炎(如单纯疱疹病毒脑炎)和各种病毒感染所致的急性脱髓鞘脑病两大类,有时甚至将中毒性脑病也包括在内。随着病毒学的研究进展,散脑这一名称将被更确切的诊断名称所代替。散脑病理改变主要包括两大类:一类是似病毒性脑炎样改变,病变主要在灰质内局灶性神经细胞变性、坏死,脑膜及血管周围可见淋巴细胞及单核细胞浸润,有血管套形成,神经细胞损坏后胶质细胞增生。另一类为变态反应性脑炎改变,病变主要在白质;大脑各叶白质有大片状坏死、软化及脑和脊髓中髓鞘脱失,神经胶质弥漫性增生;灰质及白质都可见血管周围淋巴细胞浸润,静脉周围更明显。

散脑一年四季均可发病,青壮年居多,无明显地区性,有统计表明,某些地区以夏秋多见。多数呈急性或亚急性起病,急性者可于数日内症状达到高峰,亚急性急病者可于10多天、1个月,甚至数月发展至高峰。半数病例于病前1~4周有前驱症状,如头痛、发热、畏寒、全身肌肉酸痛、鼻塞、流涕以及腹痛、腹泄、恶心、呕吐等。本病临床表现错综复杂多变而无规律性,主要见发热,体温 $38\sim 40^{\circ}\text{C}$,也可为持续高热,高达 40°C 以上,但部分病人初起可无发热;精神异常,病人有不同

程度的意识障碍,半数左右有精神症状,甚至以精神失常为首发症状。其特点为急性脑器质性精神症状——意识障碍症候群。常表现为定向力障碍,对客观环境及自我意识模糊,谵妄,谵语,表情淡漠,茫然无欲或情绪不稳、紧张恐惧,常有生动的幻觉或感知综合障碍,反应迟钝,思维困难或不连贯,注意力涣散,行为动作怪异、寻衣摸床,智能减退等。常出现呆痴、遗尿、木僵、躁动、自伤或伤人。约 50%~90% 病例可有不同程度的意识障碍,甚至昏迷,为本病的基本症状。当病变涉及脑干中脑灰质和网状结构上升激活系统时,呈深昏迷。皮层局灶损害者表现为意识内容和范围缩小,皮层广泛损害出现去皮层状态。抽搐症状较多见,可为大发作或局灶性发作。不少病例出现为口、肢体或面部局限性或多部位不同步阵挛发作。此为脑炎时多个刺激病灶的特征之一。不少病例在急性期即有颅压增高表现,如头痛,呕吐,眼底视乳头水肿,甚至脑疝形成;是致死的原因之一。另外尚有局灶性体征,约 28%~80% 有偏瘫或四肢瘫,也可为单瘫;第 IV、X 对颅神经易损害而出现吞咽障碍等;基底节受累可出现多动、舞蹈、咀嚼、舔舌甚至出现震颤麻痹症状;主半球损害出现失语、偏瘫等;约 50%~80% 出现病理反射,如唇反射、掌颏、吸允、下颌和上下肢病理反射。本病多有白细胞增高,脑脊液检查约有半数病例异常;脑电图异常多见高波幅弥漫性波;脑 CT 可发现界限不清楚的低密度病灶。有条件可进行免疫学、病毒学及脑活检以明确诊断,但需与精神分裂症、癔病、反应性精神病、情感性精神病、颅内占位病变、脑炎及其他脱髓鞘疾病相鉴别。本病多选用 α -干扰素,病毒唑注射液、阿糖胞苷、肾上腺皮质激素对因治疗及对症处理,同时予以保护脑细胞减轻损害和利于神经功能恢复的药物。

散脑属于中医温病范畴,其病多实,治宜祛邪为主。邪在

上焦可用银翘散合白虎汤加减,邪犯中焦用雷氏芳香化浊汤合白虎汤加减,热陷下焦用清瘟败毒饮加减,中成药牛黄清心散、醒脑静,或安宫牛黄丸均可配合使用;金银花、板蓝根、菊花可煎汤代茶。

司志国等用中药,大青叶、板蓝根各 20g,陈皮、半夏各 10g,胆南星、僵蚕各 12g,甘草 6g。肝郁失疏者加柴胡、枳实;痰湿壅盛者加竹沥、橘红、远志、天竺黄等;热盛者重用石膏、知母;火痰交炽者加银花、芦根、连翘;意识障碍者选用菖蒲、郁金;昏迷不醒者给予牛黄安宫丸鼻饲;若风火相兼,肝风内动者加用全蝎、蜈蚣、钩藤、珍珠母;头痛项强者加用牛膝、葛根;淤证明显者重用水蛭。配合西药(常规使用维生素及抗菌素治疗,大部分病例给予皮质激素或极化液静脉点滴,少数病例加用三磷腺苷、辅酶 A 等细胞能量药物。有癫痫发作或精神症状明显者给予抗癫痫或抗精神病药物治疗,其中有 11 例用了东莨菪碱 0.3mg/日静脉点滴,有 2 例应用了阿糖胞苷治疗。9 例危重型病例曾施行气管切开术或使用人工呼吸机辅助呼吸)治疗散发性脑炎 86 例,年龄 13~58 岁,30 岁以下 57 例;西医分为精神型(31 例)、脑膜脑炎型(12 例)、局灶型(12 例)、颅内压增高型(10 例)、癫痫型(9 例)、脑干脑炎型(8 例)、小脑炎型(2 例)、有 2 例未能定型。中医分 4 型:痰湿淤型 21 例,证见神昏目眩,倦怠无力,肢麻语暗、步履维艰,舌紫淤斑,苔白腻,脉弦滑。此证多适于西医分型中的脑干脑炎型、局灶型和小脑炎型;血液流变学检查常提示有血粘度增高改变。痰气郁结型 27 例,此证表现为神志抑郁,情淡少语,目呆不瞬,便遗不能自理,舌质淡,苔薄腻,脉弦而滑。西医分型精神型中的精神运动抑郁症状者多属此型。痰蒙心窍型 28 例,证见神明失守,躁动不宁,头痛谵语,行为异端,舌红苔黄,脉弦滑数。此证多见于精神运动兴奋型和颅内压增高型。肝风

基本治愈 39 例,好转 14 例,无变化 3 例,死亡 1 例[吉林中医药,1992,(2):19]。

张振波用清热解毒,镇肝熄风法;清热祛湿,化痰开窍法;甘寒清热,化痰开窍法;清热凉血,芳香醒脑法。清热养阴凉辨治散发性脑炎 37 例,取得了较好疗效[新中医,1992,(4):48]。

刘仕昌治疗病毒性脑炎分为 3 期;暑湿蕴蒸,阻滞少阳三焦用蒿芩清胆汤;极期最易暑湿酿痰,蒙闭清窍,早用三宝配合豁痰开窍之品;后期往往耗伤气津,宜清补清养,选用西洋参、沙参、石斛、生地等;后期食闭应防邪闭,宜解暑化痰,豁痰开窍,消积化滞,饮食须清淡,少量多餐[新中医,1991,(11):3]。

汤克仁用银翘散加减(金银花、连翘、荆芥、薄荷、牛蒡子、贯众、大青叶、板蓝根。高热者,酌加水牛角、牡丹皮、赤芍、黄连、生地;轻度意识障碍者,加远志、石菖蒲;伴有抽搐者,加钩藤、僵蚕、生牡蛎;昏迷者,鼻饲安宫牛黄丸或静脉点滴安宫牛黄注射液)治疗散发性脑炎 21 例,痊愈 9 例,好转 10 例,死亡 2 例;其中昏迷者 16 例,痊愈 6 例,好转 8 例,死亡 2 例[山东中医杂志,1989,(3):35]。

陈家建将散发性脑炎 54 例,辨证分为卫气型 16 例,治以清热解毒为主(黄芩、金银花、连翘、大青叶、淡竹叶、菊花、鲜芦根、石膏、知母);营血型 38 例,治以清营凉血,开窍止惊为主(生地黄、玄参、冬门麦、竹叶心、黄连、栀子、牡丹皮、赤芍);结果治愈 32 例,有效 18 例,无效 4 例,有效率 92.5%[江苏中医杂志,1987,(10):4]。

【方名】 白清汤。

【组成】 地黄 20g,玄参 20g,牡丹皮 12g,麦门冬 12g,金

【功效】 熄风化痰，活血通络。

【适应证】 散发性脑炎。

【方药简析】 散发性脑炎因痰所致，但在疾病发展过程中，又兼见淤血阻滞，痰浊与淤血相互兼挟，转化，以致病情迁延。风、痰为本病致病的内在因素，火、热等外邪为诱发因素，而痰淤互相为病情迁延的原因所在。风动痰涌，痰淤互结，留扰神明，阻塞清窍脉络为本病的病理基础。因此，熄风化痰，活血通络为治疗本病的关键。故方中用钩藤、僵蚕熄风止痉；胆南星、橘红、半夏、菖蒲、郁金化痰开窍；木香行气化痰；丹参、赤芍活血通络，使气顺痰畅，血活风灭，同时可促进昏迷苏醒，缩短疗程。若发热加金银花 15g、连翘 15g、大青叶 10g，甚者加生石膏 30g；高热抽搐用羚羊角 1g、全蝎 1g、蜈蚣 1 条共研末冲服；昏迷者鼻饲安宫牛黄丸；呕吐加竹茹 5g、枇杷叶 6g；颈强加葛根 30g、牡丹皮 10g；口噤加秦艽 10g、全蝎 2g（冲）；颅压增高部分患者配合 20%甘露醇溶液静滴；后期伴气阴两虚者加沙参 15g、麦门冬 12g、玉竹 10g、石斛 10g。王氏用本方治疗散发性脑炎 106 例，年龄 3~53 岁，15 岁以下儿童 46 例；发病前有呼吸道感染史者 41 例，胃肠道感染史者 23 例。发病至就诊时间最短 1 天，最长 4 天；急重症 57 例。首发症状以意识障碍（昏迷、嗜睡、意识模糊）为主者 33 例，精神障碍为主者 33 例，癫痫发作者 18 例，发热呕吐者 11 例，高热抽搐者 24 例。伴见脑膜刺激征者 17 例，步履不稳或轻瘫者 8 例。脑脊液正常 94 例，压力升高者 9 例，细胞计数及蛋白轻度增高者 12 例。脑电图轻度弥漫性异常者 54 例，中度异常 46 例，重度异常 6 例，伴癫痫放电 15 例。结果治愈（临床症状和体征消失，能自理生活，实验室检查恢复正常）74 例，显效（临床症状和体征基本消失，能自理生活，实验室检查明显改善）19 例，有效（临床症状、体征、实验室检查有所改善）9 例，无效 4 例；

总有效率 96.23%。其中意识障碍 33 例,治疗后症状消失 26 例,明显改善 3 例,无变化 4 例;精神障碍 20 例,治疗后症状消失 17 例,明显改善 2 例,无变化 1 例;癫痫发作者 18 例,治疗后消失 8 例,明显改善 10 例;发热 35 例,治疗后消失 32 例,无变化 3 例;脑膜刺激征 17 例,治疗后体征消失 15 例,明显改善 2 例;步态不稳,轻瘫 8 例,治疗后消失 5 例,明显改善 3 例。重症 57 例中治愈 32 例,显效 12 例,有效 9 例,无效 4 例;一般病例 49 例,治愈 42 例,显效 7 例。

【病案举例】 冯某,女,9 岁,1989 年 11 月 9 日因发热、昏迷、抽搐入我院。患儿 4 天前因受凉而发热,在当地卫生院按感冒治疗,发热不退。15h 前突然昏迷,全身抽搐。诊见患者发热神昏,四肢抽搐,颈项强直,喉中痰鸣,舌紫暗,苔黄腻滑润,脉滑数。查:体温 38.4℃,脉搏 140 次/min,呼吸:34 次/min,血压:14.7/9.33kPa。瞳孔等大,对光反应迟钝。布氏征(+),克氏征(+),巴氏征(+).血常规:血红蛋白 132g/L,白细胞计数 $9.3 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.60,淋巴细胞 0.40。脑脊液:无色透明无凝块,细胞计数 $80 \times 10^6/L$,以淋巴细胞为主,蛋白总量 0.2g/L,葡萄糖 3.9mmol/L,氯化物 197.47mmol/L。脑电图:中度弥漫性异常。西医诊断:散发性脑炎。中医辨证属肝风挟痰热上蒙,脑脉淤阻。治用星香加味方加减:胆南星、橘红、僵蚕、钩藤、贝母、瓜蒌皮各 10g,石菖蒲、连翘各 10g,丹参 12g,赤芍、白芍、半夏各 9g,甘草 5g,木香 3g。水煎滤汁约 300ml。加羚羊角粉、全蝎(为末)、蜈蚣(为末)、琥珀末各 1g,鲜竹沥 30ml 调服。安宫牛黄丸 1 丸温开水调服。以上药物 24h 内间断鼻饲。11 月 11 日患儿神志清醒,抽搐停止。12 日发热止,继服原方 2 剂,至 11 月 15 日诸症消失,实验室检查恢复正常,告愈出院。

【方名】 加减芎芷石膏汤。

【组成】 川芎 10g,白芷 10g,生石膏(先煎)50g,菊花(后下)20g,栀子 15g,黄芩 15g,板蓝根 30g,石斛(先煎)10g。

【来源】 邹耀光,黑龙江中医药,1993,(1):14。

【功效】 疏风清热解毒。

【适应证】 病毒性脑炎。

【方药简析】 本方是在《医宗金鉴》芎芷石膏汤中去辛温羌活、藁本加上黄芩、栀子、薄荷、知母、葛根、板蓝根、石斛、三仙等。薄荷、菊花辛凉疏风清热;生石膏、知母清阳明气分之热;栀子、黄芩、板蓝根清热解毒泻火;白芷疏风止痛;川芎活血行气祛风止痛,载药上行头目为治头痛之要药;石斛养胃生津,滋阴除热。诸药合用,共奏疏风清热之功,本方轻者日服1剂,重者日服2剂,每6h1次,每次服150ml。意识障碍酌加凉开三宝,另服;颈强加葛根20g;口渴加知母20g;口苦加龙胆草20g;痰盛者加胆南星15g,天竺黄15g;湿盛者加薏苡仁20g;呕吐者加竹茹20g,藿香20g;纳差加焦三仙各15g。邹氏用本方治疗病毒性脑炎16例,年龄17~42岁;病程14~23天。结果治愈15例,1例好转(因经济条件所限,难能坚持治疗),总有效率100%。

【病案举例】 孙某某,女,17岁,1992年4月6日入院。主诉头痛,发热,颈项有强硬感5天。该患者自诉在7天前去过同学家1次,回来之后,觉得头痛、发热,颈项有强硬感,周身疼痛,不思饮食,在本地农场卫生院用了大量西药治疗,效果不佳,病情逐渐加重。到我院就诊,做腰穿诊断:病毒性脑炎。头痛如裂,发热恶风,颈强,而目红赤,口渴喜冷饮,小便色黄,大便秘结。舌质红,苔黄厚而干,脉浮滑数。查:体温37.8℃,脉搏100次/min,血压13.3/8.0kPa,呼吸22次/min,双侧巩膜轻度充血,颈强(+),腱反射亢进,巴彬斯基征

16 脑囊虫

脑囊虫病是猪绦虫幼虫(囊尾蚴)寄生脑部所致,常以癫痫、高颅压、精神障碍为主要临床表现,约占人体囊虫病的80%以上,散发于我国东北、华北、西北及华东北部,分布在25个省(区市);其中东北三省、内蒙古、河南、河北、山东是猪带绦虫与囊虫病的高发区。据估计全国人囊虫病感染者至少有300万人。在亚、欧、美洲除因宗教信仰不食猪的地区外,均有发病,其病因主要是因吞食污染虫卵的食物或肠绦虫患者呕吐时虫卵逆流入胃,在十二指肠内孵化成幼虫,穿过肠壁经血液循环至全身,演变为囊尾蚴,寄生于大脑皮质、软脑膜、脑室、脑池和椎管内。急性期引起脑局部炎症、水肿;慢性期主要为胶质增生、萎缩、机化,形成纤维结节性包囊,有的可以钙化。包囊多在软脑膜和脑皮质内,散在多个,有的达数百。有的寄生在脑室或脑池内,阻塞脑脊液通路。囊虫分泌的毒素刺激可使脑脊液分泌增加,使脑积水和颅内压增高加重。约数年至数十年后,囊虫死亡钙化,但仍可为机械性和化学性刺激引起癫痫的根源。由于囊尾蚴在脑内寄生部位、感染程度和囊尾蚴本身的生物学特性与宿主对寄生虫的免疫反应的不同,导致了脑囊虫病的临床症状极为复杂多样,有的可无症状,有的则极为严重,或突然死亡。通常病程缓慢,刺激症状较破坏症状占优势,以癫痫发作最为多见。其他可见头痛、神志不清、视力模糊、颅压增高等。也可出现瘫痪、失语、眼底病变和神经症状。按临床特点分为脑膜脑炎型(由一次大量感染后引起弥漫

性脑水肿和反应性炎症变化,症见精神异常、癫痫、瘫痪、失语、感觉障碍、共济失调、脑膜刺激征和昏迷等),癫痫型(可为大发作、小发作、局限性发作或精神运动性发作,同一病人常有两种以上发作形式,且类型可以转变),脑瘤型(高颅压、癫痫、强迫头位或其他神经局灶征等)。病人通常有皮下或肌肉囊虫结节,多分布于头部和躯干,结节大小不等,可在皮下或肌肉中自由移动,无压痛;结节可陆续、分批出现或消失。脑囊虫病的诊断较难,应根据流行病学、病史、活体组织(囊虫结节)检查,脑脊液、PCR、脑CT、MRI和临床表现综合分析以确诊。本病还需与其他原因引起的癫痫发作、颅压高及脑膜炎相鉴别。其治疗主要用吡喹酮和丙硫咪唑。若病情严重,药物难以控制,或囊尾蚴阻塞脑室系统而致颅压高者,则用手术治疗,切除脑内囊尾蚴。

脑囊虫以癫痫发作为主者属于中医痫症范畴;以头痛发作为主者属于中医头痛范畴。多因饮食不节,虫寄生于脑,阻塞清窍,气血运行受阻,气机逆乱发为痫症;或因痰浊上蒙清窍,肝阳上扰清窍,气血不足,清窍失养;或肾精亏,脑髓空虚,瘀血阻滞清窍而发为头痛。其治疗以辨证为主,兼以驱虫,可选用鹤虱、槟榔、使君子、南瓜子、仙鹤草芽等药。以癫痫发作为主者可参考癫痫的治疗并配以驱虫药。河南医科大学一附院研制的囊虫丸Ⅰ号、Ⅱ号治疗脑囊虫效果较好,且无不良反应,使用安全,可长期服用。

张万江用囊虫丸Ⅱ号(雷丸、水蛭、牛膝各150g,僵蚕、白芥子、茯苓各200g,陈皮、大腹皮、大黄各50g,干漆炭25g,陈皮、黄连、瓜蒌仁、羌活各15g;共研细末,以五灵脂500g与醋1.75kg煮沸取汁,与上药末共为蜜丸,每丸15g,日服3次每次1丸)活血化淤治疗囊虫病引起癫痫发作者取得了较好疗效[天津中医,1985,(6):15]。

曾学荣用中药(南瓜子仁 50~90g,晨起空腹时 1 次服,2 h 后服槟榔(100g 加水 400ml)200ml,30min 后服硫酸镁 25~30g;同时服用吡喹酮 50mg/(kg·d),分 3 次服,10 天为 1 疗程)治疗脑囊虫 35 例,治愈 25 例,显效 10 例;总有效率 100%[实用中西医结合杂志,1992,(2):115]。

刘光汉用珠矾丸(珍珠 4.5g,明矾 500g,黄蜡 120g,蜂蜜 60g。先将珍珠置铁锅内文火炒微黄后研极细,明矾研细末;将黄蜡放入锅内溶化后加入蜂蜜,熔匀后离火;先将珍珠粉均匀撒入蜜蜡液中边搅边撒,再将明矾末熔于蜜蜡中边搅边撒。待混匀后,趁热做成梧桐子大小,晾干备用,30 丸/次,约 3g 重,每日 3 次,饭后服,服完为 1 疗程。病程 1 年内服 1 个疗程,长者服 2~3 个疗程或更长)治疗脑囊虫病 10 例,男 3 例,女 7 例;年龄 25~63 岁;所有病例均经病理活检确诊;病程最短者发现 2 个月,最长 9 年;10 例均有皮下包囊,7 例合并脑囊虫伴反复抽搐,皮下结节最少 6 个,最多 404 个。结果治愈 7 例,有效 2 例,无效 1 例;总有效率 90%[中国中西医结合杂志,1988,(3):183]。

杨吉林等用癫痫Ⅱ号片(生川乌、生半夏、生南星、生白附子、白芍、黑大豆、姜汁等,各药经炮制,按比例研细末制成制片,每片含生药 0.3g,成人每次 5~6 片,每日 2 次),发作期同时服宁痫汤(桂枝 9g、石菖蒲 15~30g、姜半夏 9g、胆南星 9g、僵蚕 9g、茯苓 9g、黄芩 9g、枳壳 9g、木香 9g、甘草 6g,肝阳动风加生龙骨、生牡蛎;痰热内盛加焦栀子、天竺黄;风痰闭阻加蜈蚣、全蝎;瘀血阻络者加川芎、丹参;肝肾阴虚加玄参、白芍;脾虚痰盛加黄芪、白术。)辛热开破治疗癫痫 217 例,临床治愈 46 例,显效 70 例,有效 57 例,效差 39 例,无效 5 例[中国中西医结合杂志,1993,(11):677]。

刘玉玺用狼毒大戟碱性提取液(狼毒大戟 1 000g 的水煎

液,经阴离子交换树脂柱吸附,用0.3%氨水洗脱,浓缩至1000ml,每毫升相当于原生药1克,成人20ml/日,儿童10ml/日,分2次服,连续1个月为1疗程)治疗癫痫72例,男48例,女24例;年龄7~50岁,平均19.3岁;病程1~25年,平均8.1年。34例连用3个疗程,28例用药4~6个疗程,10例用药7~10个疗程。显效30例,有效26例,效差及无效共16例,总有效率78%[中国中西医结合杂志,1994,(5):282]。

【方名】 加味二陈汤。

【组成】 半夏9g,陈皮9g,茯苓12g,甘草9g,白芥子12g,薏苡仁18g,芫荇9g。

【来源】 柳占枕,山东中医杂志,1985,(6):13。

【功效】 健脾化痰,杀虫散结。

【适应证】 脑囊虫。

【方药简析】 本病以痰浊阻滞,囊虫侵扰为主要病机。囊虫病来源于绦虫的演变繁殖,治疗首宜杀虫为要务,以翦除后患;终则健脾化痰,杀虫散结收功。皮下或肌肉有囊包者,治宜杀虫软坚,化痰散结;风阳内动痫证发作,治宜豁痰(涤痰)开窍,杀虫(熄风)定痫;湿痰上扰,宜涤痰化浊;痰火扰心,狂证发作,宜涤痰开窍,清心泻火。总之,治疗以虫、痰为念,消补兼施,扶正达邪,以冀瘤消痫平。方中二陈汤合薏苡仁健脾化痰,白芥子搜经络之痰,芫荇杀囊虫。若有囊包加榧子仁、雷丸(二者等量,研末每次服9g);痫证发作,加琥珀3g,朱砂2g(冲服),郁金9g,远志9g,胆南星9g,僵蚕9g;风阳搐搦,加钩藤15g,全蝎6g;痰浊上扰,加胆南星9g,竹沥30g(冲服);痰火扰心,加石菖蒲10g,郁金15g,黄连10g,栀子10g;五心烦热,加地骨皮15g,牡丹皮10g;肝气郁滞,加柴胡9g,白芍9g;气虚,加党参15g,黄芪30g;血淤,加丹参30g,当归尾15g。柳氏

用本方治愈脑囊虫病 30 例取得较好效果。

【病案举例】 孙某某,男,52岁,1963年3月12日初诊。遍体长黄豆大之圆形囊包月余,以前胸、后背及两臂内侧为著。周身板滞不适,性情急躁,眩晕头痛,胸闷不舒,旋即跌仆,昏不识人。面色苍白,牙关紧闭,手足搐搦,口吐白沫,移时苏醒,一如常人,1~3日1发,形体尚丰,精神萎靡,言语如常。舌淡红,苔白腻,脉象沉缓。经皮下结节活体检查,确诊为囊虫病。内科诊断为脑囊虫并发癫痫。中医辨证为痰凝虫积,蒙蔽清窍之虫瘤、虫积成痫。治宜涤痰散结,杀虫定痫。方用加味二陈汤化裁:半夏9g,陈皮9g,茯苓12g,白芥子12g,榧子仁、雷丸各9g,琥珀3g(研冲),胆南星9g,全蝎6g,僵蚕9g,郁金9g,远志9g,薏苡仁18g,甘草6g。磁朱丸6g,日2次服。1963年4月6日二诊:迭进20剂,囊包消失1/3,肢体关节伸展自如;眩晕减轻,痫证月再发,寐食如常,舌淡红,苔白,脉象濡缓。宗原方加竹沥30g(冲服)。1963年5月10日三诊:续服30剂,囊包尽消,饭食、大小便如常;痫证偶发,发则眩晕昏沉约2分钟即过,已无昏仆、抽搐。面色渐泛红晕,神志自若,舌淡,苔白,脉缓。拟健脾化痰,杀虫定痫之剂:党参15g,白术9g,炙甘草9g,半夏9g,陈皮9g,胆南星9g,远志9g,雷丸、榧子仁各9g,琥珀3g(研冲),僵蚕9g;水煎服。1963年10月5日四诊:复进30剂,诸证消失,病臻痊愈,体质康复,恢复工作月余。随访至1979年11月未复发。

【方名】 囊虫丸。

【组成】 雷丸250g,水蛭125g,干漆125g,茯苓500g,大黄125g,僵蚕180g,生桃仁180g,黄连125g,牡丹皮500g,橘红125g,生川乌30g,荒花30g,五灵脂浸膏200g。

【来源】 王圭一,吉林中医药,1981,(1):29。

【功能】 杀虫止痛，活血行瘀散结。

【适应证】 脑囊虫。

【方药简析】 方中以雷丸为主，取其消积杀虫；干漆、水蛭破症逐瘀；牡丹皮、桃仁、五灵脂活血通络；黄连、橘红燥湿化痰；川乌辛散温通，以破积聚；大黄推陈致新。茯苓既能健脾利湿，又能补中化饮，有标本兼顾之效。诸药合用，具有杀虫散结，除痰通络，消除包囊，控制抽搐发作、缓解症状的作用。王圭一用囊虫丸（将药物共研细面，加入五灵脂浸膏，炼蜜为丸，每丸 5g，每次 1 丸，每日 2～3 次；重症抽搐频繁发作，包囊结节甚多者，每服 2 丸）治疗脑囊虫 60 例，男 51 例，女 9 例；年龄最小者 15 岁，最大者 60 岁，15～20 岁者 3 例，21～30 岁 9 例，31～40 岁者 22 例，41～50 岁者 24 例，51～60 岁者 2 例。用药量最少者 120 丸，治疗 2 个月；最多者 2 350 丸，治疗 3 年；服药 120～200 丸，治疗 2～3 个月者 4 例；200～400 丸，治疗 3～6 个月者 18 例；400～700 丸，治疗半年至 1 年者 16 例；700～1 000 丸，治疗 1 年至 2 年半者 8 例；1 000～1 500 丸，治疗 2 年者 8 例；1 500～2 000 丸，治疗 2 年至 2 年半者 4 例；2 000 丸以上，疗程达 3 年者 2 例。结果显效（临床症状消失，无抽搐，包囊结节部分消失或缩小，恢复工作者）17 例，好转（临床症状减轻，包囊结节部分消失或缩小，抽搐次数减少，时间缩短，发作较轻，可恢复工作者）18 例，效果不佳（临床症状有所减轻，抽搐发作仍较频繁，部分包囊结节有缩小变软之势，但在用药过程中，仍有新的包囊结节出现）11 例，无效 14 例，总有效率 58.3%。

【病案举例】 例一：于某某，男，42 岁，有绦虫病史。1968 年发现头、颈、两臂、胸背、及下肢等处有散在性如蚕豆大小、呈圆形或椭圆形之包囊结节 40 余个，触之均较坚硬，可移动，伴有头痛头晕，头部麻木，后头胀闷，每月抽搐 2～3 次，每次

【方药简析】 潘氏继承其叔父经验,以治虫先治血,血清虫自灭为治疗原则。方中生桃仁、红花活血化淤;党参、乌梅、黄连、附子、花椒仿乌梅丸之意,合雄黄、红芽大戟、槟榔、南瓜子仁、商陆、蛇床子、地肤子驱杀囊虫;竹茹、半夏、木瓜、钩藤化痰祛风,共成活血化淤,杀虫化痰之方。同时可依据囊虫寄生的部位不同,加减使用本方;若在大脑运动中枢倍增木瓜,加益智仁、桔梗;在小脑加益智仁、藁本;眼底加赤芍、菊花、荆芥穗、桔梗、苍术、藁本;第四脑室倍增钩藤,加砂仁、藁本;头部结节多加桔梗、大黄;全身、四肢结节多倍牛膝加桂枝、蚂蚁;咳嗽在肺加百合、大黄,在肝脏治之无效。服用应在早饭前40min以本方所煎汤剂冲服甲粉(雷丸150g、鹤虱140g、红花20g、仙鹤草20g,共研成细末,每次7g,以化淤杀虫),晚饭后40min以本方所煎汤冲服乙粉(红花20g、炙蛇蛻100g、炙红芽大戟0.15g、槟榔100g、木瓜10g、钩藤20g,共研细末,每次12g),90天为1疗程,间隔4天可再服。潘氏用上法共治疗囊虫病(头部型包括囊虫在大脑皮质运动中中枢者、在小脑者、在眼底、在第四脑室;躯体型)48例,年龄14~57岁,病程2个月~1年以上。结果治愈(临床症状全部消失,化验正常)40例,2个疗程治愈23例,3个疗程治愈17例;显效(主要症状消失或基本消失,恢复工作、学习,化验检查基本正常,囊虫免疫试验(一)或(±))5例,均服药2个疗程;有效(主要症状好转,基本恢复工作或轻工作、轻劳动)2例,用药2个疗程;无效1例,总有效率97.9%。治愈病例经1~5年随访,未见复发。潘氏总结说,凡囊虫在脏者先服甲粉后服乙粉;囊虫在腑、经络、奇恒之腑,先服乙粉后服甲粉。经临床运用三十多年表明,对初病体实者,先活血化淤杀虫,后扶正;久病体质尚好者,先活血化淤,再调理脾胃;久病体虚明显者,先理脾化淤,补益气血,然后杀虫排囊。凡药后有恶心、呕吐、眩晕者(临床

较少见)可暂停药1~2天,再继续服药直至治愈。

【病案举例】 赵某,女,45岁,1983年8月8日就诊。平素有吃生菜习惯。头痛头晕难忍,两眼凸痛半年之久,经多处诊为囊虫病,治疗无效而来诊。刻诊:头面有肿块状小结节,按之痛,四肢沉重无力,眼球阵阵凸痛而胀,面色萎黄,脉弦有力。眼底有一灰白色小结节,血液囊虫免疫试验阳性。诊断:眼底囊虫病。证属湿邪侵袭肌肤和机体部,使气血淤滞,运行受阻,气机不利所致。治以活血化淤杀虫排囊,健脾益气,温经化痰。以排囊汤与甲粉、乙粉常规服之,共服2个疗程,药尽病愈,随访2年未复发。

【方名】 通腑降浊汤。

【组成】 番泻叶 6g,川芎 12g,白芷 10g,藿香 12g,薏苡仁 30g,扁豆 15g。

【来源】 郑万忠,河北中医,1994,(5):37。

【功能】 通腑降浊。

【适应证】 脑囊虫高颅压型。

【方药简析】 高颅压型脑囊虫病,病情危重,治疗棘手;如用灭囊虫药物治疗,可因虫体变性死亡后引起变态反应,使颅内压进一步增高,严重的可诱发脑疝,不仅影响继续治疗,甚至威胁患者生命。目前治疗本病,首先应用大量脱水剂将颅内压降至正常后才开始用药物灭囊,灭囊过程及灭囊后仍需大量激素、脱水剂控制颅压。而一些长期高颅压型患者,由于反复大量应用激素和脱水剂,会产生一些严重不良反应,如肾上腺皮质萎缩、肾功能损害、电解质紊乱等。临床表现多有头痛头晕,头沉如裹,项强,肢体沉重,脘闷,纳呆,便秘或不爽,舌体胖,舌苔厚腻,脉滑等,辨证皆属湿浊困扰三焦,蒙蔽清窍所致。治宜通腑降浊,使三焦腑气通顺,浊阴得降,清阳得升,

好转。患儿出院，门诊继服“囊虫散”治本。番泻叶泡茶隔日 1 服。至今已正常上学 8 月余，无任何不适。

17 癲 病

癲癇是一種由於大腦皮層神經元突然、短暫和反復異常快速放電引起反復發作的短暫大腦機能失調的慢性疾病。其特點是突然意識障礙和全身抽搐，或僅表現為運動、感覺、行為、意識和植物神經等方面的不同程度障礙，也可以不同組合方式出現。具體表現根據涉及的神經元部位和放電擴散的順序和範圍而定。癲癇是常見疾病，國內流行病學調查其發病率為1‰左右，而患病率約為5‰，占門診病人的11.8%~28%。引起癲癇發作的原因很多，臨床上分為原發性和繼發性兩類。

1. 原發性癲癇，雖有長期反復癲癇發作，但在腦部找不到明顯的結構異常和代謝障礙。據統計原發性癲癇有家族史者3.7%~7.6%，明顯高於普通人口的8倍，故與遺傳因素有密切關係。

2. 繼發性癲癇亦稱症狀性癲癇，是許多疾病中的一個症狀而已，多見於腦部的器質性病變和全身性疾病。腦部的各種感染性病變，如細菌性、病毒性、真菌性和寄生蟲引起的腦膜炎、腦炎和腦膿腫等，均可導致癲癇發作。顱腦損傷是繼發性癲癇中的一個重要因素。顱內腫瘤，尤其是小腦幕上腫瘤是中年开始發生癲癇的常見病因，額葉的腫瘤易引起癲癇持續狀態。腦血管疾病常引起老年癲癇發作。變性疾病，先天性疾病均可引發癲癇。全身性疾病的內分泌與代謝障礙（如兒童低鈣，成年人的低血糖，非酮性糖尿病昏迷，肝壞死和甲狀腺機

能亢进等),中毒(尿毒症、酒精中毒、CO中毒等),心血管疾病(先天性心脏病,风湿性心脏病引起的瓣膜病和心肌病等)。影响癫痫发病的因素主要有:年龄(6岁以下儿童的大脑抑制系统发育不全,在诱发因素的影响下易发癫痫。遗传因素所致的癫痫易在儿童期起病。同时年龄与发作类型有关,6~10岁是失神小发作的好发年龄,而大发作多起于11~15岁少年,成人多发生局灶性癫痫),睡眠(典型小发作、肌阵挛发作、婴儿痉挛和三分之二大发作病初在睡醒时发生,随着病程进展,有转向白天发作的趋势;颞叶癫痫伴大发作者几乎均在睡眠中发作,有些精神运动性癫痫常在白天发作),内分泌(多数癫痫在经前期发作频繁或仅在经前期发作,妊娠期发作相对减少或停止发作。性腺功能对癫痫性发作有一定影响,大发作在青春期起病,小发作在此期可转化为大发作),诱发因素(机体内外环境的暂时变化可激发癫痫发作,常见有高热、疲劳、饮酒、过度饮水、过敏反应、饥饿、惊恐、剧烈运动造成的过度呼吸和便秘等。长期或大量服用抗痉药患者,突然停药常促其发作。个别人在特定条件下可引起发作,如闪光(看电视)、阅读、听音乐、头部转动、突然起步、挤压胸部、皮肤被擦击、咳嗽等,这些被称为反射性癫痫)。

癫痫发作的临床表现是多种多样的,主要分为大发作(又称为强直-阵挛发作,以突然意识丧失和全身抽搐为主要症状,这是最常见的发作类型,占全部癫痫的68.8%~72%),小发作(以短暂意识障碍为临床特点,多见于青少年)。还有部分运动发作,局限感觉发作,内脏性发作,精神性发作和其他类型的发作。癫痫的诊断应根据突然性、阵发性、反复性这3个特点来判别,无论表现为什么形式,最后依据脑电图确诊并分类。明确诊断后,当想尽办法找出发病原因,以便为治疗提供根据。癫痫还需要与晕厥、癔病、精神病腹痛、头痛相鉴别。

癫痫的治疗应遵循从一种药开始,适当联合;正规服用,不能突然停药;维持最佳控制量,使之不良反应最小的原则。若出现癫痫持续状态,应积极处理。癫痫大发作应首选丙戊酸钠 $15\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或苯巴比妥 $3\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,其次苯妥英钠 $5\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或苯巴比妥和苯妥英钠合用。局部发作可首选苯妥英钠,其次卡马西平 $6\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。小发作可首选丙戊酸镁 $15\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或乙琥胺 $0.75\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,其次可选用硝基安定 $0.1\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或醋氮酰胺 $12\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。精神性发作可首选卡马西平或扑癫酮 $5 \sim 20\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,其次为苯妥英钠或丙戊酸镁,也可用溴剂 $20\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。婴儿痉挛可首选 ACTH 或泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,其次也可选用硝基安定或安定 $0.1\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。必要时改用丙戊酸钠加氯硝安定。肌阵挛发作可首选丙戊酸钠和氯硝安定。辅助药物有 γ -氨基酪酸、维生素 B_6 、天麻密环菌片、钙剂等,可增加上述药物作用。同时应对因治疗。

癫痫属于中医痫症的范畴,二者临床表现基本相同,多因骤受惊恐,先天禀赋不足,脑部外伤,饮食不节,过度劳累或其他因素,导致风痰闭阻,痰火内盛,心肾亏虚,气血郁滞,气机逆乱,引发本病,尤以痰邪作祟最为重要。其病理基础是本虚(肝脾肾虚)标实(风阳痰浊,蒙闭心窍,流窜经络)。癫痫的治疗需分清标和本,在频繁发作时,以治标为主,着重豁痰顺气,熄风开窍定痫;平时以治本为重,宜健脾化痰,补益肝肾,养心定神,调摄精神。癫痫在发作期着重豁痰开窍醒神,平肝熄风,故用针灸疗法为主,取穴重在督脉、心经及心包经,用泻法。1. 百会、印堂、人中、内关、神门、三阴交。2. 中脘、内关、间使、太冲、鸠尾。休止期根据临床表现不同分为痰火内盛型用龙胆泻肝汤,脾虚痰盛型用六君子汤,肝肾亏虚型用大补元煎,瘀血阻络型用通窍活血汤。也可配合电针、头针、耳针、穴位埋线、

理疗等方法以加强疗效。

陈俊宁等在柴胡桂枝汤基础上制成桂芍镇痫片(柴胡、党参、甘草、半夏、桂枝、生姜、黄芩、芍药、大枣)治疗难治性癫痫 36 例,显效 11 例,有效 5 例,效差 20 例,总有效率 44.4%,虽可适用各型癫痫,但对普遍性强直阵挛发作或普遍性失神发作为好[中成药研究,1982,(12):20]。

张树臣以王清任龙马自来丹加上西药制成治痫灵(丹参浸膏 1 000g、黄花败酱浸膏 100g、缬草浸膏 100g、珍珠贝粉 1 195g、樟脑 80g、冰片 20g、溴化钠 1 000g、苯巴比妥 500g、士的宁 5g、共为 10 000 片含量),其对小鼠注射戊四唑引起的惊厥及电惊厥,均有明显的拮抗作用,临床应用对癫痫小发作尤为适用[吉林中医药,1983,(5):35]。

王焕庭将紫金锭中加入苦参治疗癫痫 40 例,痊愈 17 例,有效 13 例,无效 10 例,总有效率 75%,其对癫痫大发作及精神运动性发作效果较好[中医杂志,1983,(1):48]。

张华受《医林改错》的启示,采用补气升阳的补中益气汤加减治疗癫痫 54 例,1 年以上不发作者 24 例,2 年以上不发作者 11 例,16 例发作次数明显减少,2 例无效[贵阳中医学院学报,1984,(3):36]。

陈建家使用从石菖蒲挥发油中提取的 α -细辛醚(α -Asarone)注射液(每支 10mg/2ml)与脱水剂(20%甘露醇溶液静注)合用,抢救癫痫持续状态 18 例,显效(治疗后大发作持续状态立即停止,10min 内意识恢复正常,3 天内未再发作)8 例,有效(用药后大发作持续状态立即停止,意识于 30min 内恢复正常,3 天内未再发作者)10 例,以原发性癫痫,辨证属痰浊者为优[中医杂志,1982,(12):39]。

陈克彦等用头针刺刺激胸腔区、运动区、晕听区、制痛区、舞蹈震颤控制区,治癫痫 70 例,有效率 67.71%[中国针灸,

1981,(3):13]。

蒲廷相用腧穴割治法,以督脉穴为主,大椎、身柱、神道、癲痫(大椎与尾骨端连线之中点)、筋缩、中枢、脊中、命门、腰奇(第二骶椎棘突下)。常以大椎、癲痫、身柱、命门,神道、腰奇3对为主穴。一般病例每次取穴2个;5岁以下取穴1个;病程长病势重者每次取穴3个。割治时令患者俯卧于手术床,充分暴露放平背部。常规消毒,局麻后,用手术刀在上述穴位作1切口(约0.5cm长),并将皮下纤维组织挑净,然后在每个穴位上拔火罐半小时,最后消毒割治部位,覆盖纱布、胶布固定。每周1次,3次为1疗程。治疗癲痫170例,癲痫每日发作1~20次者54例,10日左右发作1次者40例,1个月发作1次者43例,3个月发作1次者27例,半年以上发作1次者6例。男96例,女74例。年龄最大76岁,最小1岁。病程最短4个月,最长达45年,其中1年以内25例,2~5年53例,6~10年41例,11年以上51例。结果治愈(治疗后,随访1年以上未犯病者)48例,其中1次获愈者5例,2次获愈者6例,3次获愈者37例;有效(治疗后,发作时间缩短,间歇期延长,次数减少,发作时症状明显减轻者)97例;无效25例;总有效率为85%[四川中医,1988,(11):29]。

王进才用背3针(经大椎、神道透至阳、腰奇)。酌以配穴;急性发作期配人中、百会、内关、涌泉、合谷、太冲以平肝熄风,化痰通络,促其苏醒;缓解期酌配足三里、心俞、膈俞、肝俞、脾俞、血海、太溪、丰隆以调其脏腑功能,健脾益肾,化淤通络,涤痰熄风,镇惊安神,以治其本;白天发作配申脉,夜间发作配照海。大椎取1.5寸毫针,直刺1.2寸,小儿酌减。神道透至阳、腰奇三穴取3寸长毫针沿督脉皮下横刺,配穴按常规进针,均采用平补平泻手法。每日针刺1次,10次为1疗程,共针3个疗程,疗程期间休息3~5天,嘱患者忌辛辣、油腻,注意精神

术 8~15g,钩藤 10~15g,茯神 20~30g,全蝎 6~12g。

【来源】 李春辉,新中医,1997,(1):19。

【功效】 祛风化痰。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 本方适用于情志抑郁或忧思过度,肝郁化火,伤阴耗液的心脾两虚之癫痫。方中浮小麦养心阴、安心神;炙甘草、大枣补中缓急;地龙、煅龙骨、珍珠重镇安神止痫;僵蚕、钩藤、蝉蜕、全蝎、天麻祛风化痰;茯神、五味子宁心安神;党参、白术益气健脾。风痰闭阻加胆南星、白矾;痰火内闭者加礞石、竹沥;肝肾亏虚,一般发作较轻,智力减退加益智仁、山茱萸;心脾两虚加黄芪、当归;气滞血淤,头部刺痛或痛有定处,面色晦黯,多见于头痛型癫痫,加三七、川芎。连服3个月为1疗程。病者经服中药连续2个月不再发作,每晚炖服团鱼汤,连食10天。李氏用本方共治疗癫痫48例,男28例,女20例;年龄最小3岁,最大42岁;病程最短3个月,最长17年;癫痫大发作23例,小发作15例,局限性发作4例,头痛型癫痫4例,腹痛型癫痫2例;发作最多者每天2~8次,最少每月1~2次;全部病例脑电图检查均有痫性放电。结果痊愈(发作完全控制3年以上,脑电图恢复正常)28例;显效(发作频率减少75%以上,或与治疗前发作间隔比较,延长1年以上未发作,脑电图明显改善)12例;有效(发作频率减少50%~75%,或发作症状明显减轻,持续时间缩短1/2以上,脑电图有所好转)6例,无效2例,总有效率95.8%。属风痰闭阻和心脾两虚者疗效较好,小儿疗效较成人疗效好。

【病案举例】 黎某某,女,7岁,1991年4月9日初诊。1岁时因高热抽搐入院,病愈出院数月后,某日突然失神抽搐,牙关紧闭,失声尖叫,其后不省人事,口吐白沫,自此以后,每周有2~6次发作,严重时1天数次。经某医院脑电图检查,诊

为癫痫。长期服用卡马西平等多种抗癫痫药,病情有所减轻,但每周仍有1~2次发作。至7岁时发现肝功能损害,SGPT不断上升,遂转中医治疗。症见病儿消瘦,面色萎黄,表情淡漠,精神困倦,舌淡红,苔薄白。诊为癫痫,中医辨证属心脾两虚,风痰闭阻。处方:浮小麦30g,大枣4枚,炙甘草4g,地龙9g,白术、煅龙骨各15g,僵蚕、钩藤各12g,党参、山药各12g,五味子、蝉蜕各8g,全蝎5g,茯神40g,珍珠末(冲服)2支。服15剂后,病情明显改善,半月中偶发作1~2次。继续服上方60天未发作,开始食用团鱼汤。其后隔天服1剂,略作加减以期巩固。2个月后改用3天服1剂,3个月后每周服1剂,半年后停药。经4年追踪,未有发作,脑电图恢复正常,且身体健硕,学习成绩良好。

【方名】 健脾祛痰调气和中汤。

【组成】 太子参9g,茯苓12g,半夏9g,石菖蒲9g,胆南星9g,橘红6g,枳壳9g,川芎6g,厚朴9g,白芍12g,甘草6g。

【来源】 李新民,中医杂志,1996,(9):550。

【功效】 健脾祛痰,调气和中。

【适应证】 小儿腹型癫痫。

【方药简析】 腹型癫痫多见于小儿,其病位主要在于脾,病机主要责之虚、痰、气3个方面,脾虚痰阻,气机失调。方中太子参、茯苓健运脾胃;石菖蒲、半夏、胆南星祛痰醒神;橘红、枳壳、厚朴调畅气机;川芎活血行气,白芍、甘草和中缓急。李氏将小儿腹型癫痫分为脾虚痰阻型(伴意识障碍明显者上方加郁金,下肢疼痛加木瓜、独活),痰热偏盛型(上方加黄芩、菊花、天麻或竹茹、代赭石等,若痰浊动风伴肢体抽搐加天麻、钩藤),痰淤交阻型(上方加郁金、桃仁、红花,重用川芎)。初时予水煎剂,每日1剂。待病势减缓可发作不甚频繁者,将上药制

为散剂,每日3次,4岁以下1~2g/次,4~7岁2~3g/次,7岁以上3~5g/次。共治疗本病31例,男18例,女13例;年龄2~7岁16例,7~13岁15例;首次发病年龄1~3岁6例,3~7岁14例,7~10岁11例;病程小于1年者15例,1~3年12例,3~10年4例;有病因可参者12例,其中早产2例,产伤2例,生后颅外伤1例,脑炎1例,CO中毒1例,高热惊厥4例,患儿母亲或祖父有癫痫病史者2例。发作时伴头痛头晕者3例,伴恶心呕吐者9例,伴面色苍白或大汗淋漓者13例,伴左下肢疼痛者1例,时伴肢体抽搐者2例。发作间歇最长者3~5个月发作1次,最短者1日发作10~15次,每周有2~3天发病;每月发作1次或1次以上者24例。发作持续时间在10min以内者8例,10~30min者14例,30min以上者9例,最长者持续2天。治疗后显效25例(发作频率减少75%以上),有效(发作频率减少51%~75%)4例,效差(发作频率减少26%~50%)1例,无效(发作频率减少25%以下)1例,总有效率93.4%。其中脾虚痰阻型21例,显效19例,有效2例,总有效率100%。用药时间最短6个月,最长3年,平均11.8个月。

【病案举例】 林某,男,8岁,1988年11月27日初诊。反复发作脐周剧烈疼痛11个月,发作时面色苍白,头晕乏力,严重时伴呕吐痰涎,每次持续30~40min,1~2日发作1次,发作后入睡,醒后如常。某医院曾进行体格检查及各项理化检查未发现异常,但脑电图异常,诊为腹型癫痫,予鲁米那15mg,每日3次,服药后2周发作逐渐控制,但3个月后病发如故。诊时已自停鲁米那16天,患儿面色少华,纳差乏力,舌质淡,苔薄白,脉滑弱;次日于腹痛发作时查脑电图示痫性放电。诊断为腹型癫痫,证属脾虚痰阻,气机逆乱;治予涤痰顺气,健脾和中。处方:石菖蒲10g,胆南星9g,半夏9g,橘红6g,枳壳

9g,厚朴 9g,茯苓 12g,太子参 9g,川芎 6g,白芍 12g,天麻 10g,羌活 6g,甘草 6g。服药后 1 周发作渐止,再仿上方继续治疗,6 个月后改为散剂巩固疗效。1 年以后曾先后 2 次复查脑电图均未见明显异常,2 年后停药,追踪至 13 岁一直未见发作。

【方名】 止痫灵。

【组成】 黄芪 10g,黄精 10g,柴胡 10g,三棱 6g,莪术 10g,丹参 15g,川芎 6g,牵牛子 3g,青礞石 15g,石菖蒲 10g,黄连 3g,黄芩 6g,蜈蚣 3 条,生龙骨 15g,生牡蛎 15g,珍珠粉 15g。

【来源】 王允荣,中医杂志,1986,(3):20。

【功效】 补益活血,化痰熄风。

【适应证】 小儿各型癫痫。

【方药简析】 方中黄芪、黄精补气养阴,扶助正气;柴胡、川芎、三棱、莪术、丹参理气活血化淤;黄连、黄芩清热燥湿;青礞石、石菖蒲、牵牛子化痰开窍;生牡蛎、生龙骨、珍珠粉重镇平肝熄风,合蜈蚣止痉制抽。王氏用上方(制成冲剂,每袋相当于 2 剂中药剂量,每次 1/4 袋,日 2 次;夜间发作者睡前服半袋,1 次顿服。对发作频繁,体质壮实患儿可辅以平肝熄灭风之汤剂)治疗小儿癫痫 57 例,1 岁以下 2 例,1~5 岁 15 例,5~10 岁 30 例,10 岁以上 10 例;病程 1 年以内 34 例,1~5 年 14 例,5 年以上 9 例;每日发作 17 例,1~15 天发作 1 次 11 例,15 天~1 个月发作 1 次 12 例,1~3 个月发作 1 次 17 例。大发作 43 例,小发作 4 例,精神运动性发作 2 例,头痛性发作 4 例,腹型发作 1 例,混合型 3 例。治疗结果发作完全控制 23 例,发作控制 50%以上 21 例,发作控制 30%~50%7 例,发作频度明显改善 6 例,总有效率 89.4%。服药最短 3 个月,最

长2年,其中24例在1年以上。

【病案举例】 罗某,女,4岁,1983年11月7日初诊。患儿1983年10月24日至11月5日,突然抽搐3次,无明显诱因。首次发作时四肢抽搐,小便失禁,口吐涎沫、牙关紧闭,双目凝视,意识丧失,约3~5min缓解,第7、第12天又各发作1次,症状同前。脑电图示中度异常,诊为“癫痫大发作”。予“止痛灵”,每次1/4袋,每日2次。治疗初3个月患儿有肝经郁热之象,辅以龙胆泻肝汤,用以清肝熄风镇惊。用药一个月内曾发作2次,以后11个月抽搐未再发作。1985年6月随访,患儿精神、饮食、智力及体格发育均正常。

【方名】 疏肝理脾汤。

【组成】 柴胡6g,枳壳6g,川楝子6g,白术6g,甘草6g,郁金9g,佛手9g,延胡索9g,白芍9g,麦芽9g,蒲公英9g,茯苓12g。

【来源】 钟建岳,新中医,1996,(12):20。

【功效】 疏肝解郁健脾,缓急止痛。

【适应证】 腹型癫痫。

【方药简析】 腹型癫痫属间脑癫痫,其发病率国内约为癫痫的1.1%。钟氏认为其病机与肝脾密切相关。故用茯苓、白术健脾渗湿;柴胡、郁金疏肝解郁;佛手、枳壳、川楝子、延胡索行气止痛;蒲公英、麦芽清肝消滞;白芍柔肝缓急;甘草调和诸药。本方药量为6~8岁儿童服用;若肝虚加党参、山药、陈皮;食滞加神曲、鸡内金、莱菔子,伴呕吐加法半夏、竹茹、藿香,大便秘结,加生大黄、枳实、莱菔子;腹痛部位走窜者加全蝎、蜈蚣;腹痛部位刺痛不移者加桃仁、赤芍;肝火旺者加栀子、牡丹皮。前2周每日服1剂,后2周隔日服1剂,4周为1疗程,连服3个疗程,有效者坚持3~6个疗程,以巩固疗效。

钟氏用上方治疗本病 26 例,男 12 例,女 14 例;年龄最小 3 岁,最大 14 岁,平均 7.5 岁;病程最短为 4 个月,最长为 6 年;腹痛发作最多每天 10~20 次,最少每周 1~2 次;腹痛持续时间最短 5~10min,最长 1~2 天。脑电图检查重度不正常 5 例,中度不正常 12 例,轻度不正常者 9 例;出生时有窒息病史 3 例,头部外伤病史 4 例,高热惊厥病史 13 例,无明显原因者 6 例。已用过多种抗癫痫西药治疗效果欠佳者 19 例。结果近期治愈(癫痫腹痛发作及伴随症状消失,脑电图检查恢复正常,1 年以上无复发)15 例,其中 3 个疗程内治愈者 7 例,3~6 个疗程内治愈者 8 例;有效(癫痫腹痛发作次数及伴随症状明显减少或减轻,脑电图检查有好转)10 例;无效 1 例;总有效率 96.15%。

【病案举例】 徐某某,女,7 岁,1989 年 10 月 23 日初诊。患者反复腹痛 2 年多,每次均呈突发性、阵发性疼痛,以脐周为甚,伴恶心,出汗,面色苍白,四肢发凉,发作时间 10~20min 不等,每月发作 4~6 次。脑电图检查为中度异常,诊为腹型癫痫,已用抗痉药物治疗,效果欠佳。刻诊:患者痛苦面容,颜面发青,汗出,四肢发凉,弯腰按腹,口中呻吟。舌淡,苔薄白,脉弦;诊断:腹型癫痫。中医辨证为脾虚气滞,肝旺侮木型腹痛;治宜运脾理气,抑肝止痛。处方:党参、茯苓各 12g,郁金、佛手、延胡索、白芍、麦芽、蒲公英各 9g,柴胡、枳壳、川楝子、白术、甘草各 6g。连服 3 天后腹痛症状缓解。前后服药 3 个疗程,脑电图复查已恢复正常,随访 1 年未见复发。

【方名】 加味黄芪桂枝五物汤。

【组成】 黄芪 30g,白芍 40g,桂枝 10g,甘草 10g,乌药 10g,石菖蒲 15g,百合 15g,酸枣仁 30g,生姜 10g,大枣 5 枚。

【来源】 李延培,山东中医杂志,1993,(1):52。

【方药简析】 本方原无剂量,用量为编者所加。方中用白花蛇祛风活络、定惊;羚羊角粉、金钱莲、珍珠粉、全蝎清热平肝,镇惊熄灭内;胆南星、天竺黄、石菖蒲豁痰开窍;藏红花通经活络,活血化淤;人参、黄芪健脾益气,使清气上升,浊气下降,痰湿不生;白芍、柴胡、沉香疏肝理气,调和营卫,顾护少阳之气。痰火盛者用黄芩、天花粉清热泻火;风痰盛者用僵蚕、白附子熄风祛痰;脾虚痰盛者用白术、茯苓补气健脾;肝火痰热者用龙胆草、钩藤清肝泻火;肝肾阴虚者用山药、杜仲补肝肾;心肝血虚者用当归、何首乌,补肝养血;痰淤互结用桃仁、川芎,活血化淤,行气通经。如此,使之热清、痰消、风熄、气顺、淤化、窍开、邪去、正复,达到标本兼治的目的。上述药物须制成散剂,每日1次,每次10g,用瘦肉汤或猪心汤每晚睡前冲服(小儿酌减),12天为1疗程。林荣书等用抑痫散治疗癫痫889例,男516例,女373例,年龄2~12岁298例;13~23岁214例;24~33岁126例;34~43岁123例;44~63岁128例。病程1年以内223例,2~6年298例,7~15年179例,16~23年120例,24~33年69例。均有癫痫发作史。其中曾患脑炎者137例,颅脑外伤史277例,颅脑手术史40例,病因不明者43例,所有病例均随访3年。结果显效(2~12个疗程后症状消失,脑电图正常,随访3年未再复发)580例,好转(12个疗程后发作次数减少50%以上,症状减轻,脑电图癫痫波改善)270例,无效39例,总有效率95.6%。

【病案举例】 金某,女,40岁,1992年8月3日初诊。患者于1971年7月20日因受惊后突然出现尖叫,昏迷仆倒,神志不清,四肢抽搐,口吐涎沫、牙关紧闭、大小便失禁,颜面口唇青紫,常在夜间受惊后发作,每次持续1~2min,最长6min,可自行苏醒,醒后头昏乏力,不能忆起发病时的症状。每周发病2~3次,甚则1天2次。曾多次诊治于省内外医院,

脑电图痫样波,诊为“癫痫”。采用中西医等治疗,疗效均欠佳而来诊。辨证为心肝火旺,风痰上涌,气血逆乱,蒙闭清窍。治宜清热平肝,化淤开窍,熄风定惊,通经活络。予以黄芩、天花粉加“抑痫散”治疗。每次10g,每日1次,用瘦肉汤每晚睡前冲服。治疗2个疗程后症状明显减轻,治疗6个疗程后症状消失,复查脑电图正常,随访3年未复发。

【方名】 抗痫灵。

【组成】 白矾30g,人工牛黄1g,天麻15g,全蝎15g,蜈蚣10条,胆南星15g,玳瑁15g,羊鼻虫(焙)15个,天竺黄10g,赤金30张,琥珀15g,青礞石(煅)30g。

【来源】 朱秀罗,河南中医,1995,(4):24。

【功效】 清心化痰,熄风止痉。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 本方是根据河南中医学院杨毓书教授治疗癫痫经验方化裁而来的。方中人工牛黄、白矾、胆南星、天竺黄、玳瑁清心化痰开窍;青礞石、羊鼻虫、赤金、煅青礞石、琥珀、天麻重镇潜降,熄风止痫。朱氏用本方,共研细面,装入0号胶囊,0.5g/粒,成人6粒/次,每日2次;儿童1~2岁每次1粒,2~4岁1~2粒,4~6岁2~3粒,6~9岁3~4粒,9~14岁4~5粒,14~18岁5~6粒;3个月1个疗程,连服1~4个疗程。治疗癫痫150例,结果基本控制127例,无效23例。

【病案举例】 刘某某,女,5岁,1991年4月16日诊。1990年9月某日中午患儿突发呕吐,伴头晕头痛,一时性失语。1991年2月17日又出现上述症状,至1991年3月每日发作4~5次,头晕、头痛症状日渐加重并伴口渴,过后一如常人。3月16日检查脑CT提示有癫痫病灶,脑电图提示:中度异常放电。诊时正遇发作,头摇,四肢抽动,面色苍白,欲饮水。

时间达 2min,神志清晰,语言流利。舌质淡,苔薄白,脉弦滑。诊为头痛性癫痫。治宜化痰开窍,镇惊熄风解痉。嘱服抗痫灵,1日2次,1次2粒。之后发作次数逐渐减少,10日后即停止发作。嘱其坚持服药至1992年2月,其间从无发作,遂停药。随访3年未见复发。

【方名】 加减小柴胡汤。

【组成】 柴胡 10g,黄芩 12g,半夏 12g,党参 15g,丹参 15g,石菖蒲 15g,龙骨 30g,牡蛎 30g,钩藤 20g,羚羊角 3g,蝉蜕 6g,黄连 6g,琥珀 9g。

【来源】 王伟,四川中医,1988,(10):26。

【功效】 和解少阳,涤痰止痉。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 王氏认为癫痫多属少阳郁滞,痰热风动所致,故用小柴胡加减以符合其病机。方中柴胡、黄芩和解少阳以清郁热;党参、半夏、石菖蒲健脾益气,除湿涤痰;丹参、黄连、龙骨、牡蛎、琥珀清营安神;钩藤、羚羊角、蝉蜕平肝止痉。舌质红,苔黄腻加栀子、瓜蒌仁各9g;心烦失眠加酸枣仁10g,朱砂3g;抽搐频繁加龟板、鳖甲各10g,白芍15g;痰涎多加煅蒙石9g,天竺黄6g。王氏近10年来用本方(服用时16岁以下儿童用量减半,10岁以下用量减为1/3)治疗癫痫107例。其中,男64例,女43例;年龄3个月~1岁16例,2~10岁25例,11~16岁28例,16~30岁24例,20~60岁14例;病程7天~3月37例,4月~2年34例,3~10年20例,10年以上16例。脑电图重度异常22例,中度异常76例,轻度异常9例。结果痊愈(症状消失,脑电图恢复正常)34例;显效(症状消失,脑电图异常改善)51例;好转(发病次数减少,发作时间缩短,脑电图无改变)15例;无效7例,总有效率93.5%。治疗

结果表明,年龄越小,病程越短,疗效越好;小于16岁者69例,痊愈27例,显效29例,好转10例,无效3例;16岁以上38例,痊愈7例,显效22例,好转5例,无效4例。病程半年以内者74例,痊愈26例,显效38例,好转9例,无效1例;1年以上者33例,痊愈8例,显效13例,好转6例,无效6例。

【病案举例】 白某,男,2岁,1976年10月21日就诊。患者1岁半时,突然出现点头、弯腰,几秒钟即能缓解。尔后每日均有3~8次类似情况发生。经四川医学院诊治,脑电图检查示:“中度异常”。诊断为:婴儿痉挛。曾服用地塞米松、硝基安定、脑复康3个月而病情无好转。近1个月来,发作频繁而来就诊。患儿系足月顺产,无产伤、外伤及脑膜炎病史。诊见表情淡漠,舌质淡,苔薄白,指纹淡紫。治以疏郁涤痰,平肝熄风。处方:柴胡、蝉蜕、黄连、琥珀各3g,黄芩、半夏、党参各9g,龙骨、牡蛎各10g,石菖蒲9g,钩藤15g,羚羊角2g(研末,分次兑服)。服上方17剂后,不再出现点头、弯腰,复查脑电图为“正常范围”。再服15剂,上症仍未复发。为巩固疗效,遂以益气健脾,滋水熄风法治之。处方:沙参、山药、枸杞子、天竺黄、炒僵蚕各6g,炒白术、砂仁、蝉蜕各3g,山茱萸5g,钩藤15g,羚羊角1g(兑服)。服上方20剂后,病情无反复,查脑电图仍为“正常范围”。随访2年,一切如常。

【方名】 止痫散。

【组成】 麝香2g,牛黄5g,羚羊角粉5g,玳瑁20g,琥珀20g,天竺黄20g,胆南星20g,远志20g,蜈蚣10g,全蝎10g,白矾10g。

【来源】 孙立德,河北中医,1992,(1):1。

【功效】 清心开窍,祛痰通络。

【适应证】 癫痫。

便溏,咳嗽痰多,恶心欲呕。脉濡滑,舌淡苔腻。证属脾虚痰盛型癫痫。处方用:陈皮 9g,清半夏 9g,茯苓 18g,甘草 6g,白术 9g,党参 12g,薏苡仁 9g,竹茹 9g,旋复花 9g。并服止痛胶囊,每次 2 粒,日 3 次。连服 3 个月。诸症消失,痫病未发。停药汤药,单服止痛散。半年后复查脑电图正常,遂逐渐减量停药。随访 6 年,未复发。

【方名】 抗痫胶囊。

【组成】 麝香 3g,石菖蒲 100g,全蝎 100g,僵蚕 100g,郁金 100g,天竺黄 100g,紫河车 100g,龟板 100g,朱砂 50g。

【来源】 王有章,河北中医,1993,(3):11。

【功效】 滋阴熄风,祛痰开窍。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 癫痫发作,多表现为痰、风、气、淤等邪作祟;细究其源,又多与先天不足、肾亏虚有关。肾虚脑髓失养,水不涵木、阳亢风动,虚火灼津为痰,痰阻窍闭,气滞血淤。故其病理基础是本虚标实。因此用紫河车益精血充髓,龟板滋阴潜阳,益肾健骨,且防紫河车性温助火之弊,以治本;麝香、石菖蒲开窍醒脑;全蝎、僵蚕、天竺黄熄风化痰,朱砂镇惊安神,以治标。有脑髓病变或经辨证肾精亏虚明显者,紫河车、龟板用量加倍;由脑外伤引起或夜半后熟睡中发病或妇女经期发病或经辨证淤血征明显者加红花、丹参各 100g。诸药相合,标本兼顾,阴升火降则绝生痰之源,风熄神安则除耗精之弊。王氏用抗痫胶囊(上药除麝香外,余药共研细末,再加入麝香研合均匀,装入 0 号胶囊,每粒重 0.5g,每次成人服 4 粒,每日 3 次;服药后停止发作 4~12 月后逐渐减量,2 个月后停药;长期用抗痉药者,逐渐减少抗痉药用量,一般 1~6 个月停药抗痉药)治疗癫痫 30 例,男 18 例,女 12 例;年龄最小者 1 岁半,

闭,口唇青紫,四肢抽搐,持续约 5min,逐渐清醒,数日 1 发。诊见患者头面、四肢动摇不定,蹒跚步态,语言断续涩滞、持物不稳,书写困难,右眼斜视;闭目难立征阳性,巴氏征阳性。舌质红,苔白稍腻,脉细弦滑。右拇指侧多指,弓形足。家族中无发病史,其父通贯掌纹,其母弓形足。脑电图中度异常。经省、地两级医院神经内科检查,均诊断为少年脊髓型共济失调继发癫痫。按上述用药方法,服抗痫胶囊后痫证不发,连服半年后停药,随访 2 年未复发。其他临床症状亦有程度不同的减轻,能够从事一般轻体力劳动。

【方名】 三石丸。

【组成】 青礞石 30g,磁石 20g,石决明 12g,羚羊角 1.5g,地龙 12g,全蝎 8g,胆南星 8g,鲜菖蒲 12g,竹沥 10g,琥珀 12g,猪胆汁 100g。

【来源】 秦智中,实用中医内科杂志,1994,(1): 11。

【功效】 化痰定风。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 方中青礞石、磁石、竹沥、胆南星、鲜菖蒲祛痰开窍;地龙、全蝎内走脏腑,外行经络搜风邪;石决明、磁石、琥珀潜阳育阴,平肝熄风;羚羊角、猪胆汁清热止痉。外伤引起者加水蛭、乳香、没药,再与金石定惊之类定痛熄风。秦氏用本方(上药混合磨粉,制成蚕豆大丸,成人每次 4 粒,小儿 1 粒,每日早晚开水冲服,3 个月一疗程)在 20 年间治疗癫痫 100 例,其中男 44 例,女 56 例,年龄 5~10 岁 14 例,10~20 岁 49 例,20~30 岁 37 例;病程 6 个月~1 年 38 例,1~3 年 41 例,3~10 年 21 例。治疗结果,发作期 2~4 个疗程 28 例,6 个疗程 48 例,休止期 24 例。随访 5~10 年未发作者 78 例,10~20 年 16 例,其中 6 例住处变动,不知下落,上大学 3 例,普高 40

例,初中毕业 51 例,其中 6 例查不准实住处。

【病案举例】 刘某,男,9 岁,1968 年 4 月 18 日来诊。因母亲在孕期中突然受激烈惊吓,但一切正常。6 岁时突然发生抽搐、吐白泡沫,醒后一切正常,反复服用中西药,反复住院治疗,反复作脑电图检查,为棘慢波,于 1968 年 4 月 18 日来我院住院治疗,服三石丸前 2 疗程按标准治疗,后 4 疗程减半量服药,一直服 10 多年,反复随访 20 余年无复发,生下 1 男 1 女,体质好,本人某师范毕业后,在学校现任负责人。

【方名】 癫痫症。

【组成】 石菖蒲 30g,钩藤 30g,僵蚕 12g,人参 5g,陈皮 15g,茯苓 12g,竹茹 12g,白术 12g,皂角 12g,地龙 15g。

【来源】 李善举,实用中医内科杂志,1994,(3):13。

【功效】 祛痰熄风,健脾扶正。

【适应证】 癫痫。

【方药简析】 方中石菖蒲、僵蚕、竹茹、陈皮、茯苓、皂角祛痰健脾;人参、白术、茯苓益气扶正,以杜绝生痰之源;地龙、僵蚕、钩藤,搜风止痫。李氏使用本方时(上药共研细末过筛,装胶囊,每粒重 0.3g,每次 3 粒,每日 3 次,45 天为 1 疗程),先服导痰散(苍术、胆南星、双花、生巴豆各等份共研为面,每日 1 次,晨起空腹服,每次 1 包(1.5g)。此为成人用量。小儿按成人剂量折算,1~2 岁 $1/6 \sim 1/5$ 包,2~4 岁 $1/4$ 包,4~7 岁 $1/3$ 包,16 岁以上按成年计算。另外还需视体质强弱而定,一般依吐泻为准,不吐不泻需加量。用温茶叶水冲服,服后若恶心,胃中不适,需急多饮茶水,呕吐后亦服茶水。若泄泻后心慌,需急饮稀面汤。饮食以流质易消化食物为宜,忌生冷油腻之物。一般连服 3 次,身体强者可连服 5 次),此后改服癫痫症胶囊,每 3 个月加服 1 次导痰泻药,以防新痰再生而为积癖。

共治疗癫痫 106 例,男 67 例,女 39 例;年龄 1~7 岁 13 例,8~18 岁 30 例,19~60 岁 61 例,60 岁以上 2 例;病程 1~5 年 50 例,6~10 年 22 例,11~20 年 27 例,20 年以上 7 例。辨证属肝火痰热型 51 例,肝肾阴虚型 23 例,脾胃虚弱型 19 例,肝风痰浊型 13 例。结果肝火痰热型 51 例,治愈 16 例,显效 16 例,好转 12 例,无效 7 例,有效率为 86.2%;肝肾阴虚型 23 例,治愈 5 例,显效 3 例,好转 8 例,无效 7 例,有效率为 69.5%;脾胃虚弱型 19 例,治愈 3 例,显效 1 例,好转 5 例,无效 10 例,有效率为 47.3%;肝风痰浊型 13 例,治愈 3 例,显效 5 例,好转 3 例,无效 2 例,有效率为 84.6%。肝火痰热型与肝风痰浊型疗效明显高于其他各型。总有效率 76.4%。病程 5 年以内疗效最好,有效率为 83.2%,6~10 年为 72.4%,11~20 年为 67.3%。1~7 岁 13 例,治愈 3 例,显效 3 例,好转 4 例,无效 3 例,有效率为 76.9%;8~18 岁 20 例,治愈 9 例,显效 8 例,好转 11 例,无效 2 例,有效率为 93.3%(青少年组效果最好),19 岁以上 63 例,治愈 15 例,显效 14 例,好转 13 例,无效 21 例,有效率为 66.7%。凡服药在 400 粒以内者停药易复发,疗效较差,在 28 例中有效率为 72.3%;服药在 800~1 200 粒以上者有效率为 81.2%;1 600 粒以上者有效率为 88.4%。

【病案举例】 李某,男,10 岁,患者于 5 年前患病毒性脑炎,半年后发现每隔 1 周左右便厉声尖叫,口吐涎沫,两目上视,失去知觉,四肢抽搐,时有大小便失禁,每次发作约 10min 左右。曾按癫痫治疗,服谷氨酸、脑复新、丙戊酸钠、苯巴比妥等多种药物未能控制。1987 年 12 月 3 日来我科求治。症见神情呆痴,癫痫不定时发作,并头晕、胸闷、乏力、恶心欲吐,脉浮弦,舌质微红,舌苔白腻。脑电图检查呈癫痫波形,CT 及心电图各项检查正常。诊为继发性癫痫;中医辨证属肝风痰浊型。

处方：导痰散 2 包，每日 1 次，每次半包，空腹服，连服 3 天，温茶叶水冲饮，后服癫痫痊胶囊，每日 3 次，每次 2 粒。二诊，患儿于初诊翌日晨 7 时服半包导痰散，约 15min 后，胃内难受，急饮茶叶水 1 杯，开始呕吐，呕吐 2 次，吐出清淡色粘液痰约 250ml，此后半小时开始腹泻，轻微腹痛。初泻时暗黄色稀便，后为黄色粘液，胶冻样。9 时许，患儿感到饥饿，饮稀面粥 1 碗，泄泻渐止，第二三天如是，但呕吐泻泄粘液减少，此后食欲大开，病情豁然而愈，继服癫痫痊半年，其间曾加服 1 次导痰散，至今随访，病未再复发，脑电图检查已恢复正常。

18 脑 梗 死

脑梗死是指局部脑组织,包括神经细胞、胶质细胞和血管,因缺血缺氧所致的坏死、软化。其发病率约为 200/10 万,无论发病率、死亡率或患病率均是男性高于女性,以中老年为多。脑梗死包括动脉粥样硬化血栓形成性脑梗死(简称动脉硬化性脑梗死)和脑栓塞。动脉硬化性脑梗死,是供血脑部的动脉系统中的粥样硬化和血栓形成,使动脉管腔狭窄、闭塞,造成局部血流中断、缺血软化。脑栓塞是由于异常的物体(固体、液体、气体)沿血液循环进入脑动脉或供应脑的颈部动脉,造成血流阻塞而产生脑梗死。动脉硬化性脑梗死的基本病因是动脉粥样硬化。最常见的伴发病是高血压。两者之间虽无直接的病因联系,但高血压常使动脉粥样硬化的发展加速、加重。动脉粥样硬化是可以发生在全身各处动脉管壁的非实质性变性,其发病原因与脂质代谢障碍和内分泌改变有关,确切病因尚未阐明。

脑梗死较脑出血起病缓慢,常有先兆症状,如头昏、一侧肢体麻木或无力等。动脉硬化性脑梗死常于休息、静止或睡眠时发生症状。通常不出现意识障碍,面色稍苍白,脉搏较快,血压可能不高。以肢体不灵活或偏瘫、口角歪斜、言语不清等为主症,神经系统局灶性损害主要在颈内动脉血栓(偏瘫多不完全伴病侧失明)、大脑中动脉血栓(对侧中枢性偏瘫,可伴偏盲、运动性或感觉性失语)、大脑前动脉血栓(对侧中枢性偏瘫,伴精神障碍)、小脑后下动脉血栓(眩晕,同侧肢体共济失

调、闭目难立偏向病侧)、椎基底动脉血栓(突发性眩晕、复视、共济失调、交叉性偏瘫等为特点)。脑栓塞则以发病急,初起即有短暂意识障碍,有心脏病、骨折等前驱期病史。随栓塞不同部位而有不同症状。如:大脑中动脉栓塞,亦可见3偏,并有局限性癫痫;脂肪栓塞于肺部,可表现有胸痛、咳嗽、血色痰、呼吸困难和体温升高;空气栓塞可表现突然头痛、恶心、视力障碍,甚至昏迷、惊厥;细菌栓塞可引起脑部感染。本病应与脑出血、颅内占位性病变、颅脑损伤、蛛网膜下腔出血等病相鉴别。

脑梗死属中医中风病范畴,由于发病后一般意识清楚,因此多属中经络。中医学认为本病属于情志所伤,生活起居失宜,年老体衰,饮食不节等使人体阴阳平衡失调,以致气血亏损、气滞血淤、血阻经络,发为本病。总之,风(肝风)、火(肝火、心火)、痰(湿痰、风痰)、气(气虚、气逆)、血(血虚、血淤),相互影响,在一定条件下(包括情绪激动),诱发本病。急性期虽有本虚之证,但以风阳、痰热、腑实、血淤等标实之候为主;又因风夹浊邪蒙蔽心窍,壅塞清阳之府,故上盛证状也较明显。治宜平肝熄风(用镇肝熄风汤)、化痰通腑(用涤痰汤)、活血通络(选补阳还五汤)、清热涤痰(择黄连温胆汤)诸法。此时邪气盛、证偏实,故治无缓法,速去其病则安。恢复期多属本虚标实,侧重在本虚,治应扶正为主,然半身不遂、偏身麻木之症俱在,乃淤血、湿痰阻络而成,故治宜标本兼顾,益气活血、育阴通络、滋阴潜阳、健脾化痰均是常用之法。

李建生等用益元活血汤(何首乌、黄精、沙苑子、蒲黄、三七等)治疗老年人腔隙性脑梗死 52 例,基本痊愈 8 例,显效 13 例,有效 9 例,无效 2 例。

景昕等用黄芪 30g,当归 15g,龙眼肉、天麻、鹿角胶(烊化冲服)各 12g,乳香 6g,甘松 9g,治疗缺血性脑血管病 40 例,治愈 26 例,好转 14 例[陕西中医,1995,(9):410]。

阳化风型急性脑梗死 60 例,总有效率 87.5%[湖南中医杂志,1992,(1):3]。

姬胜杰等用益气化淤汤(黄芪 120g,川芎 12g,赤芍 40g,当归 15g,地龙 10g,红花 10g,桂枝 30g)治疗中风 88 例,基本痊愈 61 例,显效 11 例,有效 14 例,无效 2 例,总有效率为 97.7%[山东中医杂志,1992,(1):21]。

宋秀芝等用行气通栓汤(木香、厚朴、槟榔、枳壳各 30g,丹参、赤芍、川芎各 20g,桃仁、红花各 15g)为主治疗脑血栓形成 96 例,基本痊愈 34 例,显著进步 36 例,进步 20 例,无变化 6 例,总有效率 93.75%[辽宁中医杂志,1991,(11):23]。

李西秦等用瘫可愈丸(黄芪 17%,丹参 17%,仙鹤草 17%,僵蚕 4.27%,伸筋草 4.27%,海风藤 17%,青风藤 4.27%,大黄 4.27%,鸡血藤 6.4%,水蛭 3.85%,白芍 4.27%,以上诸药研末水泛为丸,每丸 0.1g,每次 20~30 丸,日 3 次,温开水冲服)治疗中风后遗症 102 例,基本治愈 66 例,好转 29 例,无效 7 例,总有效率为 93.4%[陕西中医,1991,12(10):442]。

李桥等用醒脑活血汤(丹参 30,石菖蒲、郁金、胆南星、桂枝、红花、桃仁、水蛭、豨莶草各 10g,刘寄奴、葛根各 15g,益智仁 12g)治疗脑梗死恢复期 58 例,总有效率为 91.4%[中医药研究,1995,(5):17]。

王维开等将椎基底动脉供血不足分为心气不足,不能运血型(治以益气升阳为主,用补中益气汤加减:黄芪、党参各 20g,当归、陈皮各 15g,升麻、柴胡、远志、枣仁、五味子各 10g)、经络阻滞型(治以通经活络为主,用蠲痹汤加减:姜黄、当归、赤芍、鸡血藤各 10g,桂枝、川芎、天麻各 12g 等)、气虚不运型(治以益气通络为主,药用补中益气汤与蠲痹汤合方加减:黄芪、党参各 20g,当归、升麻、柴胡各 10g,姜黄、羌活各

12g,鸡血藤 30g,桂枝、川芎、炙甘草各 6g 等)共治疗 93 例,显效 60 例,好转 25 例,无效 8 例[四川中医,1992,(6):32]。

龙登全等用溶栓通脉汤(丹参、赤芍各 15g,当归、川芎、红花各 12g,桃仁、益母草、鸡血藤各 18g,穿山甲 10g,地龙、黄芪各 20g,血竭 6g)治疗脑血栓形成,总有效率达 97.5%[四川中医,1991,(9):23]。

哈志远等用脑血栓协定处方:脑血栓 1 号方(钩藤 15~30g,石决明 30g,生石膏 30g,瓜蒌 30g,生大黄 9g,川芎 15g,红花 15g,僵虫 9g,桃仁 9g)治疗脑血栓急性期;脑血栓 2 号方(黄芪 30~60g,当归 9g,川芎 15g,赤芍 9g,红花 9~15g,桃仁 9g,僵虫 9~15g)适应于脑血栓恢复期;脑血栓 3 号方(生地黄 24g,山萸肉 9g,山药 9g,麦门冬 9g,石斛 12g,牛膝 9g,巴戟天 15g,肉苁蓉 15g,菖蒲 9g,远志 9g,肉桂 1.5g,黄芪 30g,川芎 9g,全蝎 3~9g)适应于脑血栓后遗症或伴有脑软化患者。共治疗脑血栓形成 150 例,痊愈 33 例,显效 72 例,好转 37 例,无效 8 例,死亡 2 例,总有效率为 94.6%[中医杂志,1982,(3):240]。

刘国栋用口腔点含液(石菖蒲、乌梅各 40g,白芥子 20g,皂荚粗粉、细辛各 15g,防风、龟板粗粉、清半夏、天麻粗粉各 30g,冰片 2g。浸于预先配制好的溶剂,6%醋酸溶液 300ml,加 95%乙醇溶液 200ml 中浸 5 天,滤取清液制成)滴于舌下、舌面中部和两颊内侧各 2 滴,每日 3 次,共治疗脑血栓假性球麻痹吞咽困难共 33 例,显效 23 例,有效 7 例,无效 3 例,总有效率为 90.9%[中医杂志,1992,(12):33]。

【方名】 固本通灵涤痰汤。

【组成】 太子参 30g,当归 10g,生黄芪 30g,防风 10g,全蝎 10g,羚羊角粉 1.5g(分两次口服),山茱萸 15g,枸杞子

15g,胆南星 10g,钩藤 15g,沙苑子 15g,竹沥汁 20ml,节菖蒲 10g,麝香 0.5g。

【来源】 王达权等,河南中医,1992,(2):78。

【功效】 益气养血,化痰清热通窍。

【适应证】 脑血栓。

【方药简析】 方中太子参、黄芪、当归益气养血为君药;山茱萸、枸杞子、沙苑子滋阴补肾为臣药;羚羊角粉、钩藤平肝熄风;防风、全蝎祛风通络;胆南星、竹沥汁、节菖蒲、麝香化痰开窍醒脑共为佐使。

【病案举例】 杨某,男,57岁,1990年9月9日入院。昨夜突然右半身不灵活,语蹇口歪。患者头晕7年,近半年加重。健忘,少语,胸闷,烦躁,失眠,头昏胀,足底如踩棉絮感。检查:神清,颈软,命名性失语,右侧肢体肌力Ⅳ级。血压28/19kPa。脑血流图:脑动脉硬化,供血不足。心电图:心肌供血不足。脉弦滑无力,舌边尖红,苔薄黄腻。诊断:高血压,脑动脉硬化症,腔隙性脑梗死。中医辨证:肝肾阴虚,阴不抑阳,气虚湿阻,郁火浮越,化热炼液成痰,痰火阻络蒙蔽清窍。治则:益气养阴,祛风豁痰开窍。方用固本通灵涤痰汤水煎服,日1剂。上方随证加减,共服药50余剂,出院时头晕基本消失,语言流畅,头脑清晰,行走自如。血压16~20/11~12kPa。

【方名】 培元熄风通络汤。

【组成】 当归 10g,黄芪 30g,生地黄 15g,赤、白芍各 15g,全蝎 10g,天竺黄 10g,白蒺藜 15g,地龙 15g,胆南星 10g,天麻 10g,钩藤 15g,白附子 10g,桂枝 10g,竹沥汁 20ml。

【来源】 王达权等,河南中医,1992,(2):78。

【功效】 益气温阳,温经通络,豁痰熄风。

【适应证】 脑血栓。

【方药简析】 方中黄芪、桂枝益气温阳；全蝎、地龙祛风通络；天麻、白芍、白蒺藜、钩藤平肝熄风；赤芍、生地黄清热凉血；天竺黄、胆南星、制白附子、竹沥汁清热豁痰开窍。

【病案举例】 陈某，女，74岁，1990年9月16日入院。2天前忽然左侧肢体不利，继而加重。诊时患者神昏，左半身不遂，痰涎壅盛，大小便失禁。检查：口歪舌偏，左上肢肌力Ⅰ级，左下肢肌力Ⅱ级，肌张力增强，腱反射亢进，左侧巴氏征、夏朵克征、霍夫曼征均阳性，舌质淡红，苔黄厚腻，脉弦滑数。诊断：右基底节区大面积梗死。证属肝肾阴虚，气虚痰阻，化火生风。治则：益气温阳，温经通络，豁痰熄风。方药：培元熄风通络汤水煎服，日1剂。上方加减，共服60余剂，出院时神清，语言流利，肢体屈伸行走自如。

【方名】 大补元煎。

【组成】 山茱萸、炙甘草各3g，炒山药、杜仲、当归、枸杞子各6g，人参6g，熟地黄9g。

【来源】 张景岳《景岳全书》。

【功效】 补气养血。

【适应证】 气血大虚，肾虚精亏，精神失守之症。

【方药简析】 方中人参、熟地黄大补气血为君药；炙甘草、炒山药补中益气，枸杞子、山茱萸滋阴养血共为臣药；佐以杜仲、当归补肾养血和血。

【病案举例】 张某，女，68岁，1984年7月2日初诊。素来受寒辄发腰酸腿痛。5天前因事不遂意，出现头胀头晕，唇舌麻木，足跟疼痛，右半身肢体麻木酸痛，痿软无力，不能提物，步履艰难，夜寐欠安。头颅CT示：左基底节腔隙性脑梗死。症见神志清楚，语言清晰，五官端正，面色淡白，神萎纳差腹胀，口干不思饮。舌淡，苔薄白，脉沉细弦。此乃气虚血滞，

肝风内动。治以益气通络,柔肝熄风。用大补元煎加味:党参 20g,当归 15g,黄芪 20g,熟地 20g,枸杞子 12g,何首乌 20g,白术 12g,茯苓 15g,白芍 12g,钩藤 15g,生龙、牡蛎各 30g,豨莶草 15g,鸡血藤 30g,地龙 10g,川牛膝 15g,杜仲 15g,炙甘草 5g。服药 8 剂收显效,头晕头胀消失,夜寐转安,患肢活动复常,步履自如,除腰酸腿软外,别无他苦,守方再服 5 剂,4 个月后,访知一直操持家务如往[唐承孝,四川中医,1985,(11):19]。

【方名】 八味顺气散。

【组成】 人参、白术、茯苓、青皮、白芷、乌药、陈皮各 30g,甘草 15g。

【来源】 危亦林《世医得效方》。

【功效】 补气健脾,顺气消痰。

【适应证】 气厥身冷、痰壅神昏、牙关紧闭、状似中风者。

【方药简析】 方中四君子汤益气健脾;青皮、陈皮、乌药顺气化痰;白芷发散风邪。潘化远等用该方治疗脑梗死 175 例,治愈 124 例,好转 43 例,无效 8 例。

【病案举例】 管某,男,56 岁,1986 年 8 月 23 日晨起出现右侧肢体活动不灵并逐渐加重,乃至偏瘫伴口歪语蹇。CT 检查:左侧脑梗死。病人短气乏力,精神萎靡,脉细弦右关滑,舌暗淡苔粘腻。诊断:脑梗死。中医辨证属正气亏虚,痰浊淤血阻滞经络,治当益气活血,化痰通络。方用八味顺气散化裁。数剂后腻苔渐化,肢体功能开始恢复。服 40 剂后肌力达Ⅳ级。1990 年 10 月 9 日又发生右侧脑梗死,再以上方治之获瘳[山东中医杂志,1994,(3):109]。

【方名】 益气通脉汤。

状、体征基本消失,生活自理,偏瘫肢体达Ⅳ级以上);7例显效(临床症状、体征显著好转,生活基本自理,偏瘫肢体肌力进步2级以上);3例好转(临床症状、体征好转,生活不能自理,偏瘫肢体进步1级以上)。全部有效。有高血压者加夏枯草15~30g;高血脂加生山楂、决明子各15g;瘫痪肢体下肢重加川牛膝15g,上肢重加桑枝10g;淤血重加虻虫10g;痰湿重加南星、陈皮各10g;大便秘结加大黄6~10g。

【病案举例】 张某,女,74岁。因偏瘫、失语1小时,于1989年8月3日入院。患者高血压病史10余年。于晨8点突然跌倒于地,右侧肢体活动不灵,口角歪斜,失语,当时无昏迷。舌红,舌下脉络淤黯,脉弦细。查体:血压20/13.3kPa,神清,口角向左歪斜。右上肢肌力0级,腱反射减弱。病理反射未引出。诊断为高血压病脑血栓形成。方用通脉汤加夏枯草15g,桑枝10g。服药5剂,病人能下床行走,能说简单语言。共服上方15剂,右侧上下肢肌力恢复正常,语言清晰,生活自理,痊愈出院。

【方名】 补气活血化淤汤。

【组成】 黄芪150g,川芎15~20g,牛膝、赤芍、丹参各30~40g,桂枝20~30g,当归、地龙、郁金、石菖蒲、桃仁、红花、虻虫、泽泻、伸筋草各10g。

【来源】 刘家铭,浙江中医杂志,1992,(8):343。

【功效】 补气活血,化淤通络。

【适应证】 脑血栓形成属气虚血淤者。

【方药简析】 方中黄芪、当归、川芎、丹参、桃仁、红花、郁金、赤芍、牛膝等药已被确认为有补气活血化淤的作用;伸筋草、桂枝、虻虫、地龙等通阳化气、祛风舒筋,通络止痛;石菖蒲、泽泻能开窍,降低颅内压,消退脑水肿。诸药配合,其作用

川贝母、郁金；呕呃加旋复花、代赭石、刀豆子；抽搐加鳖甲、龟板、牡蛎；发热加薄荷、青蒿；气虚加黄芪；便秘加生大黄；昏迷嗜睡加至宝丹。

【病案举例】 曹某，女，80岁，1985年5月15日住院。患者高血压病史10余年，2天前因精神紧张，从沙发上滑下而突然语言蹇涩，不能行走，前来急诊。诊见：神识恍惚，呼之能应，语言蹇涩，半身不遂，大小便失禁，舌卷质红，燥而无苔，脉弦细数。检查：神清，失语，血压22.5/13.3kPa，右侧上下肢肌力0级，巴氏征阳性，双膝反射亢进。诊断：脑血栓形成。辨证为痰瘀互阻，阴虚阳亢。治以涤痰开窍，滋阴潜阳。方用加减涤痰汤加生地黄、麦门冬各15g，羚羊角粉3g（冲），钩藤20g及至宝丹1粒。服药2剂神志清楚，能颌首示意，发音呼唤家属姓名，故去至宝丹续进3剂。服后开始少量进食，大小便有知觉，肌力恢复至Ⅱ级，右手指能半握拳，下肢亦能屈伸；口渴，舌红转淡，但燥而无苔。原方去羚羊角粉，并予玄参、麦门冬煎汤代茶。至6月4日，语言渐清，口渴缓解，伸舌自如，上肢肌力恢复至Ⅳ级，下肢Ⅱ级。原方加当归尾、赤芍、桃仁、红花等活血通络之品，调治至由人携扶下地，生活自理出院。

【方名】 佛手补髓汤。

【组成】 当归30g，川芎9g，补骨脂6g，黄芪15g，黄精10g，枸杞子6g，赤芍9g，水蛭5g，甘草6g。

【来源】 夏永潮，吉林中医药，1989，（3）：27。

【功效】 活血化淤，填精补肾。

【适应证】 脑梗死。

【方药简析】 方中当归、川芎名曰佛手散，活血化淤为主药；辅以赤芍、水蛭破血行淤；补骨脂、黄芪、黄精、枸杞子益气填精补肾为佐；甘草调和诸药为使。夏氏用本方治愈1例伤寒

后脑梗死。

【病案举例】 杜某,女,4岁半,1987年7月21日来诊。其母诉患儿于1987年3月21日突发高烧,并发生昏迷。住某医院抢救治疗,诊为副伤寒。经治高烧退,神志清,但遗有精神神经症状:频频嗅自己的手,咬人,烦躁不宁,四肢无力,行路摇晃不稳。脑电图:中度异常。脑CT:右颞顶缺血性梗塞。检查:神志清楚,精神兴奋,易激惹,有频繁地嗅自己手及咬人动作,步态蹒跚,摇摇欲倒,四肢力弱,肌力Ⅲ级,共济运动失调,指鼻试验不准。四肢腱反射活跃,双侧巴氏征阳性。舌淡暗,苔白,脉细。诊断:伤寒病后脑梗死。中医辨证为高热内燔,气血耗伤,肝肾不足,髓海空虚,经络通畅失谐。治以补气血,养肝肾,化淤滞,通经络。方用佛手补髓汤。经加减服药40剂时,异常动作减少,走路已恢复正常。服药至57剂时,嗅手、咬人动作均先消失,行路正常,共济运动良好,能唱歌跳舞,临床治愈。

【方名】 蛇蝎蜈蚣散。

【组成】 白花蛇1条,蜈蚣1条,全蝎10g。

【来源】 潘春生,吉林中医药,1989,(4):15。

【功效】 熄风化痰通络。

【适应证】 脑血栓形成急性期。

【方药简析】 中风多属阴不配阳,阳亢风动,饮食变痰,风邪挟痰,直冲于脑,清窍郁闭,或旁达四肢而致,故风痰为标。急性期熄风祛痰以治其标,缓解期滋水涵木以治其本。故临证首投白花蛇、全蝎、蜈蚣以清热化痰,熄风通络,直折其标。潘春生用该方治疗脑血栓47例,24例痊愈(语言清晰,患肢活动自如,手可做精细活动,生活完全自理,但握力较健侧差,下肢行走微见跛行);17例有效(语言清晰,患肢活动自

如,手可持物,但不能做精细动作,握力差,行走明显跛行,生活基本自理);6例无效(症状改善不明显)。总有效率87%。

【病案举例】 傅某,男,71岁,1985年6月20日来诊。平素头晕眼花,每因情绪激动而眩晕欲仆。2天前因家庭不睦,情志不遂,致使头晕目眩,肢体麻木。当晚8时许,自觉语蹇,肢麻,口角流涎,继之口眼歪斜,左半身不用,头痛头晕。查体:精神疲惫,动作艰难,形体消瘦,口眼歪斜,舌质暗红,苔黄腻。颈软,左侧肢体偏废不用,脉弦滑。诊断:脑血栓形成。中医属中风、中经络。治以熄风化痰通络。方用蛇蝎蜈蚣散,日1剂,分3次口服。用药17天,语言清晰,上下肢活动灵活,可离床行走。为巩固疗效,继服上方5剂,辅以杞菊地黄丸滋阴潜阳,用药2周,除行走微见跛行,余如常人。

【方名】 消栓汤 I。

【组成】 黄芪 50g,地龙 15g,当归 25g,桃仁 10g,红花 15g,甘草 6g,赤芍 15g,川牛膝 15g,何首乌 15g,茯苓 10g。

【来源】 董守田,吉林中医药,1989,(5):22。

【功效】 益气化痰,滋阴熄风。

【适应证】 气阴两虚型脑血栓形成。

【方药简析】 方中黄芪、何首乌益气滋阴;当归、桃仁、红花、赤芍、川牛膝活血化瘀;地龙熄风通络;茯苓健脾渗湿;甘草调和诸药。肝风内动加珍珠母、钩藤、石决明;痰浊偏盛加天竺黄、胆南星;便秘腹胀加麦门冬、生地黄、芒硝;言语蹇涩加石菖蒲、郁金、僵蚕、全蝎;周身麻木加党参、桂枝、菟丝子。董守田用该方治疗脑血栓 35 例,12 例基本治愈(功能恢复正常或基本正常,生活能自理,恢复正常工作);15 例显效(功能明显恢复,部分症状消失,能执杖步行);6 例好转(偏瘫有改善,症状有好转);2 例无效(治疗前后无变化)。总有效率为

94.3%。

【病案举例】 于某,男,64岁。1964年8月19日患脑血栓,经某医院治疗数天无效,故特来诊治。病人神志朦胧,左侧肢体瘫痪,口眼歪斜,口角流涎,语言蹇涩,舌质红绛无苔,脉结代。诊断:脑血栓。证属气阴两虚而风阳内动,上扰神明,瘀血痰阻之候。治以滋阴熄风,益气化淤。药用消栓汤加减:黄芪50g,地龙15g,当归25g,桃仁10g,红花15g,赤芍15g,生地30g,麦门冬15g,石菖蒲15g,石决明15g,钩藤25g,珍珠母25g,连服25剂后,神志如常人,偏瘫消失,可自己行走,生活已能自理,并能从事轻微劳动。

【方名】 消风通脉饮。

【组成】 丹参20g,葛根30g,黄芪20g,牛膝20g,桂枝20g。

【来源】 李秀琴等,吉林中医药,1989,(6):18。

【功效】 益气活血,温经通络。

【适应证】 脑血栓。

【方药简析】 方中黄芪、桂枝益气温经通络,丹参、牛膝、葛根活血化淤。肝阳上亢加天麻、杜仲;脉络空虚加秦艽、防风、赤芍;气虚血淤加党参、当归。

【病案举例】 袁某,男,56岁,1987年5月6日初诊。素嗜醇酒厚味,患高血压多年,常持续27.9/16kPa。5天前,因家庭纠纷,情绪不畅,入睡夜起,自觉手足重滞,右半身不遂,肢体麻木,言语不清,口眼歪斜,查舌红脉弦滑。诊断:脑血栓。证属阳化风动,痰火阻络中风之候,投消风通脉饮加天麻10g,杜仲、石决明15g,胆南星6g。服药10剂,症状改善;服药15剂后,生活自理,临床治愈。

【方名】 建瓴汤。

【组成】 代赭石、牛膝、龙骨、生牡蛎、山药各 30g,生地、柏子仁各 15g,白芍 10g。

【来源】 张锡纯《医学衷中参西录》。

【功效】 育阴潜阳,平肝熄风。

【适应证】 中风急性期。

【方药简析】 方中代赭石、生牡蛎、龙骨镇潜熄风;山药健脾以宁肝风;生地、白芍育阴平肝;柏子仁柔肝安神;牛膝引药下行,使上逆之肝风沉潜。王明山等用建瓴汤治疗脑血栓 30 例,痊愈 19 例,好转 10 例,无效 1 例。

【病案举例】 王某,男,47 岁,1988 年 12 月 9 日诊。2 天前曾出现 2 次左侧肢体麻木,片刻症状即消,今晨发现左侧肢体瘫痪,口眼歪斜,语言蹇涩,舌体歪斜,伴头痛头晕。舌红苔薄黄,脉弦硬有力,尺部无力。血压 21/12kPa,血总胆固醇 5.695mmol/L,甘油三酯 3.22mmol/L, β -脂蛋白 18.81mmol/L。证属肝胆火盛,肝肾亏虚,拟建瓴汤加龙胆草、夏枯草各 20g,首乌、泽泻各 30g,川芎、牵正散(另服)各 10g。9 剂后,头痛消失,左肢体已能活动,舌脉好转,但仍时有头晕,上方去胆草、夏枯草、泽泻,加天麻、僵蚕、全蝎、蜈蚣、乳香、没药、鹿角胶,再进 13 剂,生活自理,别无不适,舌脉和平而痊愈[王明山等,浙江中医杂志 1990,(12):246]。

【方名】 消栓汤Ⅰ。

【组成】 丹参 20g,川牛膝 15g,大黄 6g,川芎、葛根、桃仁、红花、赤芍、僵蚕、地龙、天竺黄、制胆南星各 10g。

【来源】 俞大毛,浙江中医杂志,1987,(10):441。

【功效】 熄风除痰,祛瘀通腑。

【适应证】 脑血栓。

【方药简析】方中葛根、川芎扩脑部血管,能引药上行直达病位;牛膝、大黄活血化淤引血下行,四药合用升降并行,确能起到扩张血管作用,使血行风自灭。天竺黄、制胆南星、僵蚕、地龙、丹参、赤芍、桃仁、红花除痰化淤,痰淤同治。诸药合用,共奏熄风除痰,祛痰通腑之功。俞大毛用消栓汤治疗脑血栓 68 例,基本治愈 29 例(神经系统症状基本消失,偏瘫完全恢复,肌力达Ⅳ级以上,生活可以自理);显著好转 16 例(神经系统症状部分消失,偏瘫明显恢复,肌力达Ⅲ~Ⅳ级以上,能扶杖步行,生活基本能自理);好转 12 例(神经系统症状有好转,偏瘫有进步,肌力达Ⅰ~Ⅱ级仅能扶杖步行,不能单独行走和生活自理);无效 11 例(经治疗后神经系统及偏瘫无好转或恶化死亡)。总有效率为 83.8%。大便干燥加玄明粉、瓜蒌、炒莱菔子;痰多失语,舌苔厚腻加菖蒲、郁金、鲜竹沥;意识障碍加羚羊角片,并吞服安宫牛黄丸;血压偏高加钩藤、石决明。

【病案举例】沈某,男,72 岁。1985 年 3 月 21 日初诊。嗜烟酒 40 余年,罹高血压 15 年余,血压常在 20~24/13~14.5 kPa。常觉头目昏眩,手足发麻。昨因饮酒饱食加上暴怒,即觉头晕肢麻,口眼歪斜,语言不利,8h 后抬来就诊。血压 26/15 kPa,右上肢肌力Ⅰ级,口眼歪斜,语言欠利,神志时清时迷,喉有痰鸣,舌红苔黄腻,脉弦滑有力,头痛烦躁不安,大便 2 天未行。诊为脑血栓形成急性期。辨证为风痰阻络,络脉不通。急拟消栓汤熄风除痰,祛痰开窍通腑,冀其转危为安。药后下燥屎甚多,测血压 22/14kPa,头已不痛,右上下肢肌力恢复在Ⅱ级左右,神志清楚,喉无痰鸣,言语较前清楚,舌红苔转微黄腻,脉弦滑。前方去大黄加炒莱菔子,续服 5 剂,右上肢肌力恢复至Ⅲ级,右下肢肌力达Ⅳ级,能扶杖在室内行走,二便正常。再予消栓汤续服 1 周,偏瘫完全恢复,口眼已不歪斜,生活能自理,诸症均减,血压降至正常。

【方名】 起瘫煎。

【组成】 瓜蒌、鸡血藤、忍冬藤、大血藤、络石藤、地龙、牛膝各 12g,半夏 9g,黄芩 10g,丹参 30g,大黄 8g。

【来源】 李传方,浙江中医杂志,1980,(6):281。

【功效】 清降痰热,化淤通络。

【适应证】 脑血管病引起的偏瘫。

【方药简析】 方中大黄清热泻火,通腑泄浊,可迅折气火上逆之势;黄芩协大黄清上焦之热;四藤活血通络;地龙、丹参活血舒筋;牛膝引火下行,半夏燥湿化痰,诸药共奏活血通络,平肝潜阳,燥湿化痰之功。

【病案举例】 周某,男,67岁,1979年3月10日初诊。有高血压病史13年,3天前出现左上下肢软弱无力,神志清楚,面色潮红,头晕沉重,舌强言蹇,口略斜,胸烦闷,口干不欲饮,大便燥结,舌体胖,质红,苔黄腻而干,证属气火挟痰热上逆,阻塞脑络,治拟清降痰热,化淤通络,引血下行。方用起瘫煎去大黄加石斛。3剂后,头昏口歪悉除,肢能屈伸。半月后肢体灵活,步履正常,大便通顺,舌苔薄黄微腻。以后仍守原方加减治疗1月,出院时除手握力稍差外,余均恢复正常。

【方名】 益化通汤。

【组成】 黄芪 45g,半夏、陈皮、川牛膝各 15g,瓜蒌、石菖蒲各 12g,胆南星、全蝎各 10g,鸡血藤、丹参、川芎各 30g,甘草 6g。

【来源】 赵学东等,四川中医,1992,(7):29。

【功效】 益气活血,祛痰开窍。

【适应证】 中风后遗症。

【方药简析】 方中黄芪益气使气足血旺;半夏、陈皮、瓜

萎、胆南星、石菖蒲化痰开窍；鸡血藤、丹参、川芎、全蝎、郁金活血通络以消淤滞；甘草调和药性。此方集益气、化痰、通络于一体，使气充、痰化、窍开、络通而收效。

【病案举例】 王某，男，47岁，1988年9月14日诊。患者1月前患脑血栓，经用低分子右旋糖酐等药治疗，肢体功能恢复，惟口眼歪斜，口角流涎，言语蹇涩。故邀中医诊治。症见面色晦暗，神志清楚，口角左歪，言语不利，舌质淡紫，边有齿印，苔薄白，脉虚无力。证属气虚血淤，痰淤互结，经脉痹阻。治宜益气活血，祛痰开窍。投益化通汤。服药10剂后，口眼歪斜、流涎已有转机，言语渐清，嘱上方再进20剂后，口眼歪斜、流涎消失，言语进步，余无所苦，疾病向愈。

【方名】 可保立苏汤。

【组成】 黄芪30g，党参、白术各15g，核桃仁、补骨脂、山茱萸、当归、白芍、酸枣仁各10g，炙甘草3g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 健脾补肾，益气养血。

【适应证】 脑血栓形成等。

【方药简析】 方中党参、白术、黄芪、炙甘草健中州，生气血，充四肢，养脑窍；山茱萸补肾气，添精髓，疗耳鸣；补骨脂能温脾益肾，通命门，暖丹田，敛精神；核桃仁补气养血，润肺化痰，益命门，利三焦；当归、白芍、酸枣仁养血柔肝，与补脾药合用以求气不耗，归精于肾而为精，精不泻，归精于肝而化精血。诸药配伍，中气健升降调，肝体养，气机畅，肾气旺，脑髓充，以达止呕吐、定眩晕、治耳鸣、疗痿废之目的。脾虚甚者重用党参、白术、黄芪、炙甘草；兼肾阴虚加山药、沙参、麦门冬；兼痰浊加天竺黄、竹叶、竹茹、竹沥；肾虚甚加熟地、杜仲。

【病案举例】 张某，男，56岁。因眩晕呕吐伴站立不稳，

鼻饲安宫牛黄丸；头痛剧烈，项强者加葛根、泽泻；喉中痰鸣加鲜竹沥膏；有表证加秦艽、防风。

【病案举例】 孟某，男，56岁，因晨起后卒然出现右侧面部麻木，口角流涎，言语不利，右上下肢软弱无力而于1991年12月15日入院。患者素有高血压病史5年，现血压24/13.3 kPa，神志清楚，形体较胖，语言蹇涩，右侧额纹变浅，双侧瞳孔等大等圆，对光反射存在，口角舌体偏向左侧，项强，甲状腺不大，心肺无异常，左侧上下肢肌力Ⅰ级，腱反射减弱，病理反射未引出。TCD提示：大脑动脉系统广泛硬化，右侧中动脉血流速减慢（其分支闭塞），全血粘度及血浆粘度明显增高，诊为脑血栓。舌质淡紫，苔薄白，脉弦细。辨证属气虚血淤，肝风上扰。投黄芪通脉汤加夏枯草、泽泻、葛根，10剂后，颈软，予上方减泽泻、葛根，加地龙，叠进20余剂，口眼歪斜明显减轻，言语清楚，左侧上下肢肌力Ⅳ级，生活可自理。

【方名】 导痰通络汤。

【组成】 半夏、橘红、泽泻、石菖蒲各12g，枳实、红花、黄连、大黄、僵蚕各10g，茯苓、丹参各20g，甘草6g。

【来源】 刘万森，四川中医，1994，（7）：23。

【功效】 清热燥湿化痰，活血通络。

【适应证】 痰浊阻络型脑血栓。

【方药简析】 方中半夏、陈皮、枳实、茯苓、僵蚕、石菖蒲、甘草具有燥湿化痰，祛风通络，理气和中之功；黄连、大黄、泽泻通腑泻热；使湿热之邪从二便去；丹参、红花活血化淤。刘万森用该方治疗脑血栓37例，28例治愈（神志清楚，偏瘫及言语蹇涩消除，生活能自理）；6例显效（症状及体征基本消失，生活尚未完全自理）；2例有效（瘫肢活动和肌力较治疗前有一定提高，神志清，失语恢复，但表达能力欠佳，生活不能自

理);无效1例。血压偏高加菊花、夏枯草各12g、生石决明30g;言语蹇涩加远志、全蝎各10g;血脂高加何首乌20g,山楂30g。

【病案举例】 曹某,男,63岁,于1992年12月21日初诊。患者平素嗜酒肥甘,此次发病突然。症见:形体丰满,左半身不遂,言语蹇涩,舌强难伸,口角向右侧歪斜,流涎,饮食困难,喉中痰鸣,咯痰不爽,舌红苔黄腻,脉弦滑。血压21/12 kPa。诊为脑血栓。证属痰热阻络,治宜清热化痰,活血通络。投导痰通络汤加制南星10g,生石决明12g。经治半月,患者肢体明显好转,言语较前有明显恢复,舌质红苔薄黄,脉沉弦。继守原方治疗月余,语言表达清晰流畅,肢体功能恢复,行走如常,生活能自理。

【方名】 补气化淤通络汤。

【组成】 黄芪150g,川芎15~20g,牛膝、赤芍、王不留行、丹参各30~40g,桂枝20~30g,当归、地龙、郁金、石菖蒲、桃仁、红花、麝虫、泽泻、伸筋草各10g。

【来源】 刘家磊等,浙江中医杂志,1995,(12):543。

【功效】 益气活血,化淤通络。

【适应证】 气虚血淤型脑血栓。

【方药简析】 方中以大剂量黄芪为主药,补气行血;当归、川芎、丹参、桃仁、红花、郁金、赤芍、牛膝等活血化淤;桂枝、伸筋草、王不留行、地龙、麝虫等通阳化气,祛风舒筋,通络止痛;石菖蒲、泽泻开窍利尿。诸药合用,与现代医学之扩血管、抗凝、降低颅内压、改善局部血循环及局部细胞代谢等有异曲同工之妙。刘家磊用该方治疗脑梗死208例,134例基本治愈(症状、体征基本消失,生活可以自理);43例显效(主要症状、体征明显改善,患肢肌力提高2级以上);26例有效(主

要症状、体征改善,患肢肌力提高 1~2 级);5 例无效(症状、体征无好转或反而加重)。总有效率为 97.6%。

【病案举例】 丁某,男,68 岁,1986 年 9 月 25 日诊。昨晚突发中风偏瘫。查体:右上下肢肌力 0 级,口舌歪斜,语言蹇涩,舌质紫暗,边有淤点,苔薄白,脉沉迟。血压正常,实验室检查血脂、胆固醇均正常。诊断:脑血栓,证属气滞血淤。投补气化淤通络汤。半月后,右下肢肌力 II 级,右上肢肌力 I 级。口舌歪斜,语言蹇涩均明显好转。续治 4 周,右下肢肌力 IV 级,右上肢肌力 III 级,可扶杖行走,语言基本清晰,右手可持物。为巩固疗效,继服上方 20 剂而愈,随访 6 年未复发。

【方名】 防瘫汤。

【组成】 丹参、石决明、地龙、何首乌各 30g,桃仁 10g,当归、钩藤各 20g,黄芪 60g,郁金、赤芍、川芎、石菖蒲、泽泻各 15g,甘草 3g。

【来源】 杨华等,四川中医,1990,(6):35。

【功效】 活血化淤,补气滋阴通络。

【适应证】 中风先兆。

【方药简析】 方中丹参、当归、赤芍、川芎、桃仁活血化淤为主,配以大量黄芪,意在补气行血,加强活血化淤药物的作用,使经络通畅,血归常道,不使外溢;何首乌、泽泻益肝肾之阴,降低血中脂质及血粘度,使血运阻力减少,流速加快,杜绝血栓形成。石决明、钩藤、地龙三药镇肝潜阳熄风降压;更配郁金、石菖蒲化郁滞,清痰火祛湿开窍;甘草调和诸药。全方配伍共用起到活血行淤,补气滋阴通络的作用。凡属中风偏瘫之早期,运用本方多能应手取效。杨华等用防瘫汤治疗中风先兆 63 例,35 例显效(血液流变学检查指标均降至正常,临床症状消失,治疗时间在 30 天以内);24 例有效(血液流变学指标部

分降至正常,部分有所下降,临床症状明显改善,治疗时间在50天以内);4例无效(治疗时间50天,指标症状无改善)。总有效率为93.7%。

【病案举例】 王某,男,48岁,1989年3月10日诊。两月前开始头晕头痛,心烦,神疲,反应迟钝,行走不稳,言语迟缓,伴左侧肢体麻木症状。经中风预测检查,属紧急危险期。症见舌质暗红少津,苔薄,脉弦迟。血压21.3/13.3kPa。此属肝肾阴虚,火旺风动,血淤阻络所致。治以活血化淤以熄风,补气滋阴以通络,投防瘫汤。服5剂后,头晕、头痛大减,肢体麻木好转。守方连服25例,临床症状全部消失。血液流变学指标均降至正常,血压18.7/12.0kPa。

【方名】 涤痰化淤汤。

【组成】 天麻、川芎各15g,赤芍、连翘各12g,茯苓、半夏、胆南星、天竺黄、枳实、贝母、珍珠粉各10g,石菖蒲6g。

【来源】 杨仁旭等,四川中医,1993,(3):24。

【功效】 平肝解郁,清热逐淤,化痰开窍。

【适应证】 痰淤阻窍型脑血栓。

【方药简析】 方中天麻平肝潜阳,化痰开郁;半夏、胆南星、天竺黄、贝母粉清热化痰,佐以连翘清心热透邪外出。石菖蒲开窍醒脑,珍珠粉镇心、定惊、平肝;川芎、赤芍活血化淤通络。因此本方具有平肝解郁,清热逐淤,化痰开窍醒脑之功能。杨仁旭等用此方治疗多发梗死性痴呆14例,6例痊愈(智力评分31分以上,主要症状基本消失,神志清楚,定向健全,回答问题正确,反应灵活,生活自理,能参加一般社会活动);6例有效(主要精神症状有所减轻或部分消失,生活基本自理,回答问题基本正确,但反应迟钝,智力与人格仍有部分障碍,智力评分22~30.5分);2例无效(主要症状无改变或病情有

发展,生活不能自理,回答问题不正确,神志痴呆。智力评分在21.5~10分以下)。

【病案举例】 杨某,男,70岁。于1992年4月15日入院。患者素有高血压、糖尿病史,因右侧肢体活动障碍,言语蹇涩,吞咽发呛,哭闹无常,夜游不寐20多天。查体:表情呆板,反应迟钝,性格违拗,回答问题吐词不清,词不达意,近记忆力丧失,远记忆力不准确,计算简单数字正常,100-7计算2min内不能完成,时间、地点判断不准确,理解力有误,长谷川简易智能测定评分8分,右上肢肌力Ⅳ级,舌质红,苔黄腻,脉弦滑,脑CT示:多发额叶梗死。诊断:高血压病4期,多发梗死性痴呆。中医辨证属痰热阻窍,瘀血阻络。治以涤痰清心,化淤苏灵。方用涤痰化淤汤。1个月后复测智能,评分进步为17.5分,2个半月后肢体功能,语言功能恢复,生活基本自理,反应灵活,复测智能评分为30.5分,仅为轻度智能低下。

【方名】 芳香醒脾汤。

【组成】 藿香6g,石菖蒲、厚朴、陈皮、木香、佩兰各12g,白术、车前子、泽泻、桂枝、制半夏、制南星各9g,草豆蔻、白芥子各18g,生姜3片。

【来源】 高殿珩等,河南中医函大,1985,(3):35。

【功效】 芳香宣透,淡渗利湿,辛散温通。

【适应证】 痰湿阻络型脑血栓。

【方药简析】 方中藿香、石菖蒲、佩兰、草豆蔻、白术芳香化湿醒脾;车前子、泽泻淡渗利湿;白芥子、制半夏、制南星化痰祛湿,散结通络;厚朴、陈皮、木香行气化湿;桂枝与生姜相伍,则畅营以宣卫,走表以散湿,共奏芳香化湿,淡渗利下,辛散温通之功。方中白芥子,去痰除湿,其功尤胜,用量宜重,必不可少。

【病案举例】 薛某,女,56岁,1974年9月6日初诊。体型肥胖,素有眩晕病史已6年,血压26/16kPa,半月前因暴怒所加,卒然昏仆,后经中西医抢救治疗,神志已转清晰,但语言蹇涩,右侧上下肢瘫痪,痿废不用,经西药治疗疗效不显,乃求治于中医。现症同前,伴食欲不振,脘腹胀满,大便微溏,舌质淡,苔白腻,脉濡滑。诊断:脑血栓。中医辨证属湿困脾土,痰湿阻络,营卫不畅;治宜健脾化湿,祛痰通络,宣营畅卫之法,方用芳香醒脾汤。5剂后,言语渐转清晰,肢体稍觉有力,饮食增加。上方加丝瓜络12g,连进10剂,肢体已基本能做各种轻微活动,语言已基本清晰。上方去泽泻、车前子,加地龙6g,叠进10剂而愈。

孔散大或不对称,脉膊增加,血压降低,四肢运动完全消失。当出血使下丘脑前部受损,出现突然发生的中枢性发热。桥脑出血以两侧瞳孔极度缩小为特点。小脑出血先见眩晕和剧烈头痛,没有偏瘫为特点、较易引起脑水肿和脑干受压。脑室出血在深度昏迷的同时,迅速出现两侧病理反射和脑膜刺激征,本病应与脑梗死、颅内占位性病变、蛛网膜下腔出血等病相鉴别。

脑出血属中医中风病范畴。虽有经、络、脏、腑所中不同,有闭、脱、虚、实之异。但在急性期其病因皆以风、火、痰为主,其病理系血苑于上或淤阻经络。年高气衰、情绪激动、形体肥胖、痰浊湿盛、过食肥甘、饮酒过度等是形成上述病理变化的因素,本病多为本虚标实,风火交煽、痰浊壅塞、淤血内阻为标,在本为阴阳偏胜,气血逆乱。由于本病复杂多变,证见多端,来势迅急,故辨证应首辨病位浅深和病情轻重,中经络者邪浅而病轻,中脏腑者,邪深而病重;再辨闭证与脱证,闭证多属邪实,急宜祛邪;脱证是阳脱于外,多属虚证,急宜扶正。闭证和脱证均为危急重证,多属虚证,治法不可混同,应详审细辨;一辨病势的顺逆,中脏腑经治神志转清者为顺,中经络后神志渐趋不清者为逆,治疗上首先脱水降颅压,以纠正脑水肿,然后根据中经络、中脏腑之不同进行辨证用药。中经络者络脉空虚,风邪入中型用大秦芫汤;肝肾阴虚、风阳上扰型选镇肝熄风汤;痰热腑实、风痰上扰型择星蒺承气汤。中脏腑者属阳闭用至宝丹或安宫牛黄丸;阴闭选苏合香丸;脱证用参附汤。

陆志强用脑血宁方,水蛭 3g,怀牛膝、生大黄 8g,胆南星 6g,水牛角 15g,泽泻、鸡血藤、石菖蒲各 10g,天竺黄 4g。治疗高血压性脑出血 22 例,结果死亡 2 例,恶化 1 例,无变化 3 例,进步 16 例[中国中西医结合杂志,1993,13(7):405]。

林亚明用破瘀醒神汤：炒水蛭、虻虫各 20g，桃仁、红花各 10g，酒制大黄 15g，白薇、石菖蒲各 10g。治疗出血性中风急性期 43 例，总有效率 79.1%，无效死亡率为 20.9%〔中医杂志，1992，33(5)：25〕。

韩臣子等对急性高血压性脑出血分 4 型治疗，风火上扰窍型予清泻肝火、辛凉开窍法，急性期予安宫牛黄丸，继以当归芦荟丸加减（当归、石菖蒲、郁金、大黄各 10g，红花、龙胆草、栀子、黄连、黄柏各 12g，赤芍、水牛角粉各 15g，每日 1 剂，灌服或鼻饲），神清便通后，去大黄加玄参 30g，麦门冬 24g，生地 20g。痰湿蒙塞心神型用豁痰熄风、辛温开窍法。急性期予苏合香丸，继以涤痰汤加减（姜半夏、生黄芪各 15g，枳实 10g，胆南星、茯苓、红参、当归、赤芍、丹参各 10g，石菖蒲、竹茹、甘草各 6g，制白附子 4g，生姜 3 片，大枣 7 枚，竹沥汁 20ml。每日 1 剂，灌服或鼻饲）。痰热内闭心窍型予清热豁痰开窍，急性期予安宫牛黄丸，以金银花、薄荷煎汤化开，灌服或鼻饲。后以清瘟败毒饮加减（生石膏 120g，水牛角粉 30g，黄连、栀子、玄参、丹皮、竹叶各 10g，甘草 6g）。元气败脱，心神散乱型予益气回阳、救阴固脱。予大剂量参附汤合生脉散加减（黄芪 240g，人参 20～30g，附子 12g，麦门冬 30g，当归、川芎、红花各 10g，生龙骨、生牡蛎各 60g，日 1 剂。神清后减少人参、黄芪用量，加大活血药用量）。以上 4 类证候恢复期遗有口舌歪斜者，均可加服牵正散，每日 2 次，每次 10g，热酒调服。共治疗 82 例，基本治愈 6 例，显效 10 例，有效 55 例，恶化 11 例〔中医杂志，1993，(10)：607〕。

芦尚岭用自拟大黄瓜萎汤（大黄 4.5～9g，瓜萎 24～30g，胆南星、虻虫各 9g）治疗脑出血 45 例，结果：痊愈 6 例，显效 11 例，好转 23 例，无效 2 例，病情加重或死亡者 3 例〔山东中医学院学报，1987，11(3)：14〕。

孙怡等把脑出血分为 5 型进行辨证治疗。痰热蒙蔽清窍型用辛凉开窍,清肝熄风法;方选羚角钩藤汤、天麻钩藤汤、镇肝熄风汤化裁(羚羊角粉 0.3g 冲,天麻、钩藤各 12g,生石决明 30g,栀子 12g,生大黄 10g 后下,益母草、玄参、竹沥、黄芩各 12g,白芍 10g,天门冬 12g),同时配用安宫牛黄丸。共治疗 25 例,结果基本治愈 10 例,显效 4 例,有效 5 例,恶化 6 例。痰热阻络型,治以清热化痰,通腑活络法;方选温胆汤与涤痰汤加减(枳实、竹茹、黄芩、远志、石菖蒲、陈皮、法半夏各 10g,茯苓 15g,水蛭 9g,生大黄 8g),共治疗 21 例,结果基本治愈 10 例,显效 1 例,有效 7 例,恶化 3 例。脉络空虚,风邪入络型,治以祛风通络、养血祛瘀法,方选大秦芩汤加减(黄芩、秦芩、羌活各 10g,生地黄、当归各 15g,赤芍 12g,水蛭 9g)。共治疗 21 例,结果基本痊愈 13 例,显效 4 例,有效 2 例,恶化 2 例。气虚血瘀型,治以益气活血、祛瘀通络法,方选补阳还五汤加减(黄芪 30g,地龙、桂枝、红花、川芎各 10g,赤芍 15g,当归、桃仁各 12g,生大黄 6g 后下)。共治疗 12 例,结果基本痊愈 6 例,显效 3 例,有效 3 例。阴虚风动型,治以滋肾柔肝、祛痰通络法,方选一贯煎、知柏地黄丸、地黄饮子加减(生地黄、牛膝、麦门冬各 15g,石斛、山茱萸、枸杞、知母、当归各 12g,石菖蒲、水蛭各 10g)。共治疗 5 例,结果基本治愈 1 例,显效 4 例[中医杂志,1991,(2):30~31]。

李秀林治疗脑出血,急性期用 1 号语言散(羚羊角 10g,水牛角 30g,牛黄、麝香各 3g,僵蚕、蝉蜕、黄连各 30g,朱砂、琥珀各 10g,珍珠粉 6g,海浮石、胆南星、天竺黄、石菖蒲各 30g,冰片 1.5g,共研细面),每次服 3g,每日 3 次,温水送服。脑出血后 3 个月左右用 3 号语言散(牛黄、麝香各 1.5g,僵蚕、石菖蒲、蝉蜕各 30g,琥珀 10g,珍珠粉 3g,朱砂 3g,天竺黄、海浮石、川贝母、橘红、胆南星、郁金各 30g)。制服方法同

上。脑出血1周后失语者用2号语言散(珍珠粉、朱砂各3g,麝香、牛黄各1.5g,海浮石、石菖蒲、天竺黄、胆南星、僵蚕、蝉蜕、川贝母各30g,琥珀10g)。制服方法同上。脑出血半年以上者用4号语言散(全蝎30g,蜈蚣10条,胆南星30g,白花蛇2条,牛黄、麝香各2g,珍珠粉、朱砂各3g,琥珀10g,天竺黄、橘红、石菖蒲各30g,僵蚕、海浮石、川贝母、蝉蜕各30g,共研细面),每服10g,日3次,温开水送服[上海中医药杂志,1982,(8):13]。

张存志等用通脉乐胶囊(川芎、桃仁、三棱、莪术、红花各10g,赤芍15g,干地黄15g,当归、水蛭各15g,虻虫1g,麝虫20g等组成)。治疗脑出血32例,痊愈16例,显效10例,好转5例,无效1例。

林业明以破瘀醒神汤(石菖蒲、炒水蛭各15g,麝虫20g,桃仁、红花、酒制大黄、白薇各10g等)为主,治疗出血性中风急性期43例,痊愈22例,显效9例,有效3例,无效2例,死亡7例,总有效率79.1%[中医杂志,1992,(5):25]。

【方名】 补阳还五汤。

【组成】 黄芪120g,当归尾、赤芍各6g,地龙、川芎、红花、桃仁各3g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 补气、活血、通络。

【适应证】 脑出血后遗症。

【病案举例】 狄某,男,59岁。素有高血压病史,因外出工作,操劳过度,下车后突然昏厥,不省人事,诊断为脑溢血。经某医院抢救渐苏,出院后来诊:左半身不遂,口眼歪斜,口角流涎,言语不清,大便秘结,血压20/12kPa,舌苔灰黑而滑,脉象弦滑。证属风阳升动虽退,气已虚惫、络脉不和、筋骨不用;

更兼痰火炙灼,肠胃津液内损。法当培气滋阴,活络化痰。予补阳还五汤加天竺黄 10g,石蟹 12g。连服 40 余剂,诸症消失,步履如常,迄今 5 年,身体健康[俞淦琪,上海中医药杂志,1990,(7):35]。

【方名】 四石汤。

【组成】 怀牛膝、石决明、磁石、代赭石各 30g,丹参、石膏各 20g,草决明 15g,生山楂 25g,地龙 12g。

【来源】 王延富,四川中医,1985,(11):13。

【功效】 镇肝潜阳,化痰清热。

【适应证】 脑出血急性期及恢复期。

【方药简析】 方中石决明、磁石、代赭石、石膏镇潜熄风清热为君;草决明、地龙平肝潜阳;怀牛膝引火下行、导龙入海;生山楂、丹参活血化淤。口干加麦门冬、知母;大便干燥加火麻仁;眠差加柏子仁、炒枣仁。

【病案举例】 李某,男,56岁,1972年8月20日初诊。患者原有高血压病史,半月前突受精神刺激,卒倒不语住院。经头颅CT示:左侧内囊出血。现症:鼾睡不语,不识人,口眼歪斜,右侧偏瘫,面红唇赤,呼吸气粗,呼出之气灼热,已五天未大便。舌质红,苔黑干燥,脉弦数洪大有力,血压 24/16kPa。诊断:脑出血。中医辨证水不涵木、肝阳暴亢,淤热阻滞神明之府之中风证。治以滋阴清热、镇肝化淤、通络醒脑法,方用三石汤加火麻仁 30g,生地 30g,麦门冬 20g。上方加减治疗 3 月余,血压降至正常,语言流利,能扶杖步履。半年后,右侧偏瘫、口眼歪斜等症全部消失而愈。

【方名】 镇肝降逆汤。

【组成】 桑寄生、杜仲各 20g,枸杞子、桃仁各 12g,怀牛

膝、磁石、代赭石各 30g,红花、丝瓜络各 10g。

【来源】 王延富,四川中医,1985,(11): 13。

【功效】 补肾镇肝,活血通络。

【适应证】 脑出血恢复期。

【方药简析】 方中磁石、代赭石镇潜降逆为君;桑寄生、枸杞、杜仲滋阴补肾为臣;怀牛膝引火下行并有滋补肝肾之效,丝瓜络、桃仁、红花化淤通络共为佐使。

【病案举例】 杨某,男,65岁,1973年3月10日初诊。原有高血压,冠心病史。1周前突然卒倒偏瘫求治。当时血压 24/16kPa。查体:鼾睡不语,口眼歪斜,左侧偏瘫,形体肥胖,不识人,但能进食,呼吸均匀,面红唇赤,舌质红,苔黄腻,脉弦数而滑。头颅CT示:右侧外囊出血。诊断:脑出血。此乃肾精不足,肝气上逆,淤血阻滞之证。治以补肾镇肝、活血通络之法,用镇肝降逆汤加枳壳、薤白各 10g。此方加减治疗半年后,语言已较流利,能步履,生活可自理。

【方名】 羚羊钩藤汤。

【组成】 羚羊角片 4.5g,霜桑叶 6g,川贝母 12g,淡竹茹、生地黄各 15g,钩藤、菊花、茯神木、白芍各 9g,甘草 2.4g。

【来源】 俞根初《通俗伤寒论》。

【功效】 凉肝熄风,增液舒筋。

【适应证】 肝经热盛,热极动风。

【方药简析】 方中羚羊角、钩藤为君,凉肝熄风、清热解痉;配合霜桑叶、菊花为臣,以加强熄风之效;风火相煽,最易耗阴灼液,故用白芍、生地养阴增液,柔肝舒筋;和羚羊角、钩藤等凉肝熄风药同用,有标本兼顾之意。邪热亢盛,每易灼津成痰,故用川贝、竹茹清热化痰,热扰心神,又以茯神木平肝、宁心安神,俱为佐药。生甘草调和诸药为使,与白芍相配,又能

之弊,均为佐使药。诸药合用,成为镇肝熄风之良剂。

【病案举例】 赖某,男,52岁,1987年2月15日初诊。患者有高血压家族史并患高血压病多年,两日前夜间突然昏倒。头颅CT示:右侧内囊出血。经医院抢救2天1夜未能脱离险期,遂请余诊治。查体:左半身瘫痪,右手撮空,烦躁不寐,口开失语,小便短赤,大便燥结,瞳孔对光反射迟钝,体温:38℃,血压23/15kPa,脉洪大数,舌红干瘦,苔少略黑。中医辨证乃一派阴虚阳亢、肝风内动之象。急拟镇肝熄风汤加减:天麻10g,羚羊角3g,牛膝20g,龙骨、牡蛎各20g,石膏20g,青蒿15g,天门冬、白芍、钩藤、川楝子各10g。服药1剂,当晚病有转机,始能吞服汤药及橘子水。二诊:脉舌同前,阳稍和而风已柔。药属对症,于原方加酸枣仁、石斛,每日1剂,连服3剂。三诊:患者目能视物,能辨亲疏,口仍张不合,已能纳食,脉弦数,舌红干瘦,苔黑。此肾阴虚极,水不涵木,肝阳仍亢。遂改处六味地黄汤加蒺藜、菊花、枸杞子等,并配以针灸调理3个月,左手已能握物,脚能行走[曹仰南,中医杂志,1985,26(3):64]。

【方名】 茯苓四逆汤加味。

【组成】 茯苓60g,牛膝、丹参各30g,红参10g 蒸兑,三七6g 开水磨兑、炮姜、炙甘草各15g,附子10g。

【来源】 樊淡,国医论坛,1989,14(2):15。

【功效】 逐瘀通络,涤痰泄饮。

【适应证】 急性脑血管病。

【方药简析】 方中重用茯苓涤痰泄饮,丹参、三七逐瘀通络,牛膝引血下行,炮姜、附子温阳,红参、炙甘草益气。取炮姜、附子并用,以建逐寒通脉之勋;炮姜、炙甘草同施,以奏温经调血之功;红参、附子齐投,以收回阳活络之效。合之,使脑府壅塞之痰瘀速决,凝血得行,出血可止。兼面热如醉加生大

黄 15g;面唇或四肢抽动加羚羊角挫粉兑服,口角流涎或喉中痰声漉漉加鲜竹沥,生姜汁各 30ml 兑服;醒后见口眼歪斜加丝瓜络 30g,海风藤 13g,半身不遂加木瓜 10g,伸筋草 10g,千年健 30g。

【病案举例】 赵某,男,64岁,1985年8月24日初诊。患者自1972年罹“原发性高血压病”,1981年经血脂测定及脑血流图检查诊为“脑动脉硬化”。常服复方降压胶囊、脉通、丹参片等。1985年8月23日夜19时许,患者骤觉头痛,遂上床休息。至12时,其老伴发现患者口角流涎,口眼歪斜,神志昏糊伴运动障碍。查体:患者神志不清,口角流涎不断,面色暗黑,口唇发绀,肢体欠温,舌体偏向左侧,舌质暗红,苔薄白,脉弦滑。血压21/13kPa。瞳孔双侧等大等圆,对光反射对称存在,右侧眼裂增宽,鼻唇沟变浅,面、唇明显歪向左侧;右上、下肢肌力增高,肌力0级;腹壁及提睾反射减弱,腱反射亢进,肌力0级;霍夫曼征、巴彬斯基征、奥本海姆征、戈登征均阳性,诊为脑出血。中医辨证属中脏腑,系淤阻脑府、痰蒙元神所致。急宜逐淤通络、涤痰泄饮。予茯苓四逆汤加味增竹沥、姜汁各10ml灌服。进1剂后,神志转清,6剂服完,语言流利,口眼歪斜基本消失,可拄杖下地行走。

【方名】 血府逐淤汤。

【组成】 桃仁12g,红花、当归、生地黄、牛膝各9g,川芎、桔梗各5g,赤芍、枳壳各6g,柴胡、甘草各3g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血祛淤,行气止痛。

【适应证】 胸中血淤,血行不畅;中风之淤阻脑窍等。

【方药简析】 本方是用以治疗“胸中血府血淤”所致诸症,由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。方中桃红四物

汤活血化淤而养血，四逆散行气和血而舒肝，桔梗开肺气，载药上行，枳壳则升降上焦之气而宽胸，尤以牛膝通利血脉，引血下行，互相配合，使血活气行，淤化热消而肝郁亦解，诸证自愈。

【病案举例】 李某，男，47岁。于1985年12月28日，骑车途中突感右侧肢体无力，数分钟后不能骑车，随送到医院，当时测血压27/19kPa，经对症治疗无效，次日觉头晕、头痛、嗜睡。头颅CT示：左基底节区血肿。症见语言不利，右上肢不能活动，右上肢肌力0级，下肢肌力Ⅱ级，口干口苦，大便干结，脉沉细弦，舌质暗，苔薄白。确诊为脑出血。证属气滞血淤。治以活血化淤。方用血府逐淤汤加味：当归、桃仁、红花、川芎、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝各12g，生地、赤芍、莱菔子各20g，桑枝30g。服药1周，右上肢略能动，不能抬举，下肢可抬高20度，头痛消失，大便正常，脉沉弦，舌质暗，苔薄白。守前方继服2周，右手可自由活动，但握物无力，右下肢能下地走，时感枕部麻木，前方加钩藤30g，黄芪40g，丝瓜络15g，鸡血藤20g，去柴胡、枳壳、桔梗、莱菔子。继服1周，生活能自理，随访至今仍正常[罗普树，四川中医，1987，(8)：43]。

【方名】 大黄廑虫丸。

【组成】 大黄、黄芩、甘草、桃仁、杏仁各10g，白芍、生地黄各20g，干漆5g，虻虫1.5g，水蛭、蛭螭、廑虫各20g。(用量为作者加)。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 祛淤生新。

【适应证】 五劳虚极；中风之淤阻脑络。

【方药简析】 方中大黄逐淤攻下；并能凉血清热；廑虫攻下积血，共为君药；桃仁、干漆、蛭螭、水蛭、虻虫助君药以活血

通络,攻逐瘀血,共为臣药;黄芩配大黄以清瘀热;杏仁配桃仁以润燥结,且能破血降气,与活血攻下药配伍则有利于祛瘀血;生地黄、白芍养血滋阴,共为佐药;甘草和中补虚,调和诸药,以缓和诸破血药过于峻猛伤正。诸药合用,祛瘀血,清瘀热,滋阴血,润燥结。

【病案举例】 高某,男,64岁。患高血压病数年,1988年7月某日卖西瓜时突然昏倒,不省人事,随送某医院确诊为脑出血。抢救脱险后遗左侧肢体瘫痪,语言不利,面目痴呆,痰盛且粘,身形肥胖,脉沉细弦滑,舌紫,苔厚浊腻,血压24/13.3kPa。此为痰湿素盛,壅塞脉道,血瘀于脑,久而脉道涨破,血溢于脑中,治当化痰涤浊,活血通络。方用大黄廑虫丸加减。大黄15g,杏仁12g,黄芩10g,白芍15g,桃仁12g,虻虫9g,蛭螭15g,廑虫15g,干漆9g,生地15g,水蛭9g(研分冲),甘草9g,全瓜蒌30g,胆南星10g,橘红12g,石菖蒲10g,云苓12g,枳壳15g,川贝10g,金礞石15g,酒煎,日1剂。服30剂后,语言较前稍清,目活,面痴有减,痰少且稀,苔仍厚腻,脉沉细弦滑,血压21.3/12.3kPa。原方去虻虫,加白花蛇1条(研分冲),三七10g,全蝎9g,制马前子1.5g(研分冲)。5剂后语言虽缓,但已能清楚叙述病痛,痴呆已去,下肢可扶杖而行,手指颤抖不能握物,血压20/12kPa。继进10余剂,除手指颤抖,握物无力外,一切均恢复正常,嘱其坚持服大黄廑虫丸合人参再造丸,4个月后随访,指颤已基本痊愈[闫钧天,河南中医,1992,12(1):18]。

【方名】 通脑化痰汤。

【组成】 陈皮、半夏、枳实、竹茹、茯苓、胆南星各10g,珍珠母、生地黄、代赭石各15g,大黄12g,芒硝10g(兑服)。

【来源】 王揭晓,国医论坛,1988,(4):51。

步);11例好转(4周内神志清楚,烦躁呕吐、抽搐消失,颈抵抗消失,肢体能蠕动);3例无效(病情加重,改他法治疗);死亡1例。总有效率为87.9%。

【病案举例】 谢某,男,52岁,1989年2月27日入院。患者素有高血压之疾,1天前因赴宴饮酒后突然头晕,鼻衄及吐血,量约80ml,继而昏仆于地,呼之能应,不能言语,右侧肢体废而无用,呕吐、视物模糊,曾用脱水抗感染效差,而转本院。查体:血压22/18kPa,浅昏迷,面色潮红,伸舌偏右,颈抵抗,心界向左扩大,心率96次/min,律齐,双肺呼吸音粗糙,右侧上下肢肌力0级,双侧巴氏征阳性。舌黯红,苔白腻,脉弦数。脑CT:左侧内囊出血,约40ml(吸收期)。诊为脑出血。证属阴虚阳盛,肝阳暴张,脑络灼伤,络破血溢。予脑衄化淤汤加决明子20g,草果10g,日1剂,水煎。少许频服,再用20%甘露醇溶液250ml与50%葡萄糖溶液60ml,交替应用,日3次。3天后血压19/10kPa,呕吐消失,神志清楚,颈软,右上肢肌力Ⅰ级,右下肢Ⅱ级,舌红少苔,治宗前法,上方去草果加西洋参10g,虻虫改8g,停用其他治疗措施,先后守方15剂,患者已能正常行走,惟上肢肌力恢复较慢。上方去泽泻,再加枸杞子、丹参各20g,桂枝10g。服药2月余,下肢肌力恢复正常,上肢肌力Ⅲ级。

【方名】 吴茱萸心夺命汤。

【组成】 吴茱萸、人参、大黄、黄连、黄芩各10g,血竭15g,没药6g,生姜5g,大枣6枚,麝香0.1g(冲)。

【来源】 王金桥,四川中医,1992,(7):28。

【功效】 暖肝温肾,清热泻火,活血散瘀。

【适应证】 肝肾阳虚,风动火炽之脑出血。

【方药简析】 吴茱萸心夺命汤由张仲景《伤寒论》吴茱萸

汤、《金匱要略》泻心汤合王肯堂《证治准绳》夺命散加麝香组成。方中吴茱萸汤暖肝温肾、降逆止呕、安脑髓止头痛、调营卫助化源,补气血充脑海,与活血散瘀之夺命散配合能散脑中淤滞、行周身气血。泻心汤善借阳明通络,清除五脏热结,下横行之逆气,保少阴之真液,化祛离经之淤血,以达火清气降而血自静之目的。麝香通诸窍、开经络、透肌骨、治中风,为醒脑回苏要药。如斯配伍虚实并调,气血流畅,共凑回真阳,清实火、调气血、化淤滞,通窍道之功。肝肾阳虚甚者重用吴茱萸、人参,减黄芩、黄连用量,火盛气逆甚者重用大黄、黄连,加牛膝、代赭石;痰浊壅盛加天竺黄、竹茹、竹叶、竹沥;有阴虚征象者加熟地、山茱萸;气虚加白术、黄芪。

【病案举例】 张某,男,54岁。因突发头痛,继则昏仆12h,于1989年7月10日急诊入院。查体:血压24/13kPa,双侧巴氏征阳性。经脱水降颅压治疗后行腰穿术,确诊为脑出血。按西医常规疗法治疗3天无效。此时配合中药治疗。刻下症:神志不清,口眼歪斜,面赤气粗,口臭,大便不行,四肢厥冷,干呕吐涎,舌红苔黄燥,脉沉弱。中医辨证为中脏腑,中脏腑证属肝肾阳虚,火热炽盛,气血上逆。治以暖肝温肾,清热泻火,活血散瘀,方用吴茱萸泻心夺命汤原方,水煎500ml,分2次鼻饲,日1剂。次日厥回便通。后按上方加减治疗5天,神志转清,脉象转缓。后按恢复期治疗,1个月后痊愈出院。

20 蛛网膜下腔出血

颅内血管破裂后,血液流入蛛网膜下腔称为蛛网膜下腔出血。临床上可分为损伤性和非损伤性(自发性)两大类。自发性蛛网膜下腔出血每年每10万人口约有16~19.4人,占全部中风患者的8%~10%。各种年龄均可发病,但以青壮年为多见。蛛网膜下腔出血的病因很多,常见的有颅内动脉病及畸形动静脉的破裂,高血压、动脉硬化引起的动脉破裂、血液病、颅内肿瘤、血管性过敏反应,脑与脑膜炎症、抗凝治疗的并发症、脑血管闭塞性疾病引起出血性脑梗死,颅内静脉的血栓形成,妊娠的并发症,脊髓病变等。蛛网膜下腔出血绝大多数是自发性的,主要表现为突发剧烈头痛,伴恶心呕吐,面色苍白,出汗,血压升高或降低,体温不稳定。多数患者有意识障碍,有时伴有精神异常、烦躁、谵妄、木僵、定向障碍、痴呆以及虚构等。少数或引起局限性的或全身性癫痫发作。发病数小时后可出现脑膜刺激征。可见眼底出血或玻璃体膜下出血,偶见视乳头水肿,本病应与血管神经性头痛、高血压脑病、脑部感染性疾患、高血压脑出血等病相鉴别。

蛛网膜下腔出血不伴有意识障碍者,属中医头痛范畴;出现意识障碍者,属中风范畴。其病因病机多因情志不舒、肝气郁结、肝郁化火、风阳暴涨、血随气逆、上扰清窍;或因肝气横逆、乘克脾土、脾土受损、健运失司、聚湿生痰、郁久化火、肝风挟痰上扰;或因饮食不节、损伤脾胃、痰湿内生、郁久化热、上犯清空;或因肝气郁结,气滞血淤,发为本病。其发生与心、肝、

二、与功能失调密切相关。在标为瘀血、痰湿、火热。本病多虚实夹杂,病情易转化,临证宜灵活辨析。首先是对因治疗,积极处理原发病;二是止血;三是使用止痛剂和镇静剂以对症治疗,防止躁动而引起再出血;四是根据病机审因论治(肝火上扰用龙胆泻肝汤,胃火上逆宗泻心汤,痰热上扰择黄连温胆汤,瘀血阻滞选通窍活血汤)。由于出血性脑病恢复期多有血肿存在,宜用活血祛瘀法,药用白芷、川芎、血竭、红花、桃仁、赤芍、乳香、没药、大黄、麝虫等,止血多用三七参、代赭石等。

裴衣怀用导赤承气汤加减(黄连、黄芩、杏仁各 10g,生大黄 15g,生地、赤芍、全瓜蒌各 10~18g,生石膏、白茅根各 30~50g,葶苈子、琥珀各 6~10g,头痛甚加夏枯草、钩藤、丹参;呕吐加竹茹、枇杷叶;便秘加芒硝;尿黄加淡竹叶、芦根;抽搐加羚羊角、全蝎、地龙;痰多加天竺黄、莱菔子;嗜睡加石菖蒲、郁金;昏迷加安宫牛黄丸、至宝丹)治疗蛛网膜下腔出血 12 例,治愈 9 例,好转 2 例,无效 1 例[中医杂志,1985,26(11): 31]。

王志先等将老年蛛网膜下腔出血分为急性期和后遗症期(出血控制后)进行论治。急性期用镇肝熄风汤加减(羚羊角 6g,钩藤、玄参、白芍各 15g,丹参、黄芩、大黄、鱼腥草、川楝子各 10g,代赭石 30g,龟板、生龙骨、牡蛎各 20g)。后遗症期用自拟涤痰通络汤(天竺黄 12g,石菖蒲、远志、黄芩、赤芍、炒桃仁各 10g,红花、川芎各 6g,地龙 15g,乌梢蛇 20g,鸡血藤 30g)。共治疗 80 例,其中临床治愈 54 例,有效 10 例,无效 16 例,总有效率 80%[国医论坛,1994,45(3): 33]。

【方名】 大承气汤。

【组成】 大黄 12g,厚朴 15g,枳实 12g,芒硝 9g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 峻下热结。

【适应证】 阳明腑实证；热结旁流；里热实证之热厥、神昏、病或发狂等。

【方药简析】 方中大黄泻热通便、荡涤肠胃，为君药；芒硝助大黄泻热通便，并能软坚润燥，为臣药，2药相须为用，以助下热结之力甚强；积滞内阻，则腑气不通，故以厚朴、枳实行气散结，消痞除满，并助硝、黄推荡积滞以加速热结之排泄，共为佐使。

【病案举例】 宋某，男，49岁，1980年4月14日初诊。患者高血压病4年余。1980年4月1日因突发剧烈头痛、呕吐入院。检查血压24/14kPa，脑脊液呈均匀血性，诊为蛛网膜下腔出血，经用甘露醇、止血敏、降压片等药治疗5天，效不显，遂请中医会诊。症见：神志恍惚，项强，呕吐，身热烦躁，口苦，腹胀，6日未解大便。舌红苔黄腻，脉弦滑数。证属阳明邪热燥结，腑气不通，阳化风动，挟痰浊上逆，扰心犯脑所致。治宜通腑泄浊化痰，平肝潜阳。方用大承气汤加味：生大黄10g（后下），芒硝9g（冲），枳实9g，全瓜蒌12g，代赭石30g（先煎），羚羊角粉0.5g，钩藤15g，石菖蒲5g，胆南星5g，竹沥水10ml（分服）。2剂后泻下臭秽粪便，日1~2次，热退神清，头痛渐减，知饥索食。苔转薄黄，舌红中有裂纹，脉弦细而滑，原方化裁成养阴化痰，平肝潜阳之剂治疗20天，脑脊液恢复正常，痊愈出院[孔荣观，四川中医，1985，（11）：21]。

【方名】 泻心汤加味。

【组成】 黄连10g，黄芩10g，大黄10g，石膏30g，知母12g，牛膝15g，枳实10g，郁金10g，当归10g，竹茹10g。

【来源】 陈贵廷《实用中西医结合诊断治疗学》。

【功效】 清胃泻火。

【适应证】 邪火内炽，迫血妄行等症。

【方药简析】 方中大黄、黄连、黄芩清泻上、中、下三焦实火；石膏、知母清泻胃火；牛膝引火下行，枳实与大黄合用荡涤阳明燥结；郁金、当归舒肝活血；竹茹降火止呕。

【病案举例】 王某，男，51岁，1992年7月1日初诊。于3天前在骑车途中，突然出现剧烈头痛以前额部疼痛为主，并向头枕部扩散，伴恶心呕吐，旁人急将其送至某医院。头颅CT示：蛛网膜下腔出血。经用甘露醇脱水降颅压，6-氨基己酸止血等疗法，治疗1周，头痛减轻，呕吐减少，邀中医会诊。症见：前额部疼痛，牵连及项，时有呕吐，口臭口干，口舌生疮，渴喜冷饮，夜寐不安，大便秘结，小便黄赤，舌红苔黄，脉弦大。证属肝胃火盛，上逆迫脑，脑络受损，络破血溢。治以清胃泻火，方用泻心汤加味：黄连12g，黄芩10g，大黄15g，石膏50g，知母15g，牛膝10g，枳实10g，郁金10g，当归12g，竹茹10g，羚羊角粉3g（另冲），珍珠粉4g（另冲），三七粉6g（另冲），竹沥水10ml。服药2剂，泻下臭秽大便数次，呕吐止，夜可安枕。上方石膏减至15g，大黄减至10g。继进6剂，大便畅顺，头痛大减，口疮渐愈。上方加减治疗月余，诸症消失（韩丽华等，奇难病精华）。

【方名】 黄连温胆汤。

【组成】 半夏10g，茯苓12g，黄连10g，陈皮10g，枳实10g，竹茹10g，甘草6g，大枣1枚，生姜5片。

【来源】 陈言，《三因极一病证方论》。

【功效】 清热化痰。

【适应证】 胆胃不和，痰热内扰。

【方药简析】 方中黄连、清半夏清胃泻火、燥湿化痰共为君药；以竹茹为臣，清热化痰、止呕除烦；枳实行气消痰，使痰

随气下；佐以陈皮理气燥湿，茯苓健脾渗湿，俾湿去痰消；使以生姜、大枣、甘草益脾和胃而协调诸药。

【病案举例】 罗某，男，40岁，1972年2月14日初诊。于4天前在干活中，突感左侧头部剧痛，伴恶心呕吐，神昏，躁扰，急送某医院，诊为“蛛网膜下腔出血”。经脱水降颅压，止血等疗法治疗4天，症状无变化而请中医会诊。症见：头痛如裂，烦躁不安，时时呕吐，神昏，口干不欲饮，腹胀纳呆，大便数日不下，舌质红，苔黄厚腻，脉弦滑数。证属痰火上扰清窍，清阳被蒙。治宜清热祛痰，方用黄连温胆汤加减：黄连、竹茹、清半夏各10g，茯苓、陈皮各12g，胆南星、枳实各9g，车前子、生大黄、苍术各15g。服药4剂，头痛渐减，大便已通，烦躁稍安，呕吐止。上方加羚羊角粉3g。继服20余剂，诸症皆消（上海市卫生局编，上海老中医经验选编）。

【方名】 血府逐瘀汤。

【组成】 生地、牛膝各15g，红花、柴胡、川芎各9g，枳壳、当归、桃仁、赤芍、桔梗各10g，甘草6g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血祛瘀，行气止痛。

【适应证】 胸中血瘀，血行不畅等。

【方药简析】 血府逐瘀汤内桃仁四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。方中桃仁四物汤活血化瘀而养血，四逆散行气和血而舒肝，桔梗开肺气，载药上行，合枳壳则升降上焦之气而宽胸，尤以牛膝通利血脉，引血下行，互相配合，使血活气行，瘀化热消而肝郁亦解，诸证自愈。

【病案举例】 拉某，男，41岁，1987年3月9日初诊。患者因突然剧烈头痛，恶心呕吐，颈项强直入院。入院后行腰椎穿刺，脑脊液全部为血性，诊为蛛网膜下腔出血。经西医多方

治疗,其他症状缓解,但头痛持续不止而转中医治疗。症见头痛如刺,颈项强痛,神志清楚,面色暗红,心烦不安,大便干,小便赤,脉弦数。中医属血瘀头痛。治宜活血化瘀、清热行气止痛,方用血府逐瘀汤加减:生地黄、玄参、牛膝各 15g,当归、桃仁、赤芍、桔梗、丹皮各 10g,红花、柴胡、川芎各 9g,甘草 6g。服 6 剂后,心烦、口干苦已止,大便正常,其余症状均减轻。原方去丹皮、玄参继服 9 剂治愈,至今未见复发[谢亚强,四川中医,1989,(3):29]。

【方名】 犀角地黄汤。

【组成】 水牛角 100g,丹皮、赤芍各 15g,生地黄 20g。

【来源】 孙思邈《备急千金要方》。

【功效】 清热解毒,凉血化瘀。

【适应证】 蛛网膜下腔出血等。

【方药简析】 方中水牛角清热凉血,配生地黄既可解血中热毒而止血,又可养阴生津;赤芍和营泄热,丹皮凉血散血,同助水牛角、生地以奏凉血止血、清热解毒之功。陈楚玺用犀角地黄汤加黑大黄治疗蛛网膜下腔出血 20 例,痊愈(头痛、呕吐、颈强均消失,脑脊液中无红细胞,可进行日常活动)15 例;好转(头痛、颈强减轻,脑脊液中无红细胞,瘫痪肢体恢复到Ⅳ~Ⅴ级)3 例;无效(头痛、呕吐症状未减轻,动眼神经麻痹,3 个月后未恢复)2 例。总有效率为 90%。

【病案举例】 张某,男,30 岁。1985 年 3 月 7 日初诊。1 天前患者在劳动时突然头痛,伴呕吐,小便失禁,呼之不应,约 30min 后好转,急来门诊。查体:体温 37.3℃,脉率 90 次/min,呼吸 20 次/min,血压 18.7/12kPa,发育正常,营养一般,急性痛苦面容,心肺(一),肝脾未触及,瞳孔等大等圆,眼底视乳头边缘清楚,无出血及渗出,项强,克氏征、布氏征(+);白

细胞计数 $13.0 \times 10^9/L$, 分叶粒细胞 0.70, 淋巴细胞 0.24; 脑脊液呈均匀一致血性。诊断为蛛网膜下腔出血。经西药降颅压、止痛、止血 3 个月效不佳。邀中医会诊。症见: 面色紫黯, 头痛剧烈, 呕吐项强, 3 日未解大便, 舌质红绛, 脉细数。证属热毒内盛, 络破血溢, 瘀血内阻。遂用犀角地黄汤加黑大黄 30g。3 天后头痛、呕吐减轻, 10 日后项稍强, 再进 10 剂, 患者一切症状消失, 痊愈出院 [陈楚弩, 国医论坛, 1992, 31(1): 28]。

谷不化,湿浊内停,导致清阳不升,浊阴不降发为眩晕。或因跌仆坠伤,头脑受损,瘀血内停,阻滞经络,气血不能上荣,脑失所养发为眩晕。眩晕一证多属本虚标实,肝肾阴虚,精髓不足,气血虚弱,髓海空虚为本;风寒暑湿火痰瘀为标。临床应审证明辨。风热眩晕用羌活胜湿汤,暑热上蒙用竹叶石膏汤,髓海空虚用左归丸,气血虚弱用归脾汤,肝阳上亢用天麻钩藤饮,痰浊中阻用半夏白术天麻汤,瘀血内停用通窍活血汤。

陈志涵根据眩晕的病因病机及临床症状,审证求因,综合成九法,分别论治。① 滋水涵木:用六味地黄汤加减;② 补肾益精:方用右归丸(偏于肾阳虚)或左归丸(偏于肾阴虚)加减;③ 平熄肝阳:用天麻钩藤饮;④ 养血熄风:方用归脾汤、十全大补汤加减;⑤ 益气止晕:方用补中益气汤加减;⑥ 平肝祛痰:方用半夏白术天麻汤加减;⑦ 辛甘化风:药用枸杞子、何首乌、甘草、当归身、龙眼肉、女贞子、桑叶、菊花炭、胡麻;⑧ 滋肾潜阳:药用熟地、山茱萸、五味子、茯神、磁石、青盐、龟板、龙骨、牡蛎、牛膝;⑨ 温阳化饮:用苓桂术甘汤或真武汤加减[浙江中医杂志,1981,(5):00221]。

聂天义用补阳敛风汤治疗阳虚眩晕 15 例,基本方:白术 15g,茯苓、附片、淫羊藿各 20g,半夏、川芎各 12g,荆芥 10g,龙骨、牡蛎各 20g,炙甘草 5g。阳虚湿阻加藿香、石菖蒲、泽泻;阳虚饮逆加桂枝、旋复花、代赭石;虚阳上越加女贞子、白芍、龟板、珍珠母、磁石。结果痊愈 10 例,好转 5 例[四川中医,1985,(11):34]。

何光明等用自拟活血除眩汤(葛根、丹参各 30g,当归 15g,红花 10g,天麻 12g。气虚血瘀加黄芪 15~30g;阴虚血瘀加生、熟地黄各 15~30g;痰瘀互结加制半夏、白术各 10g,茯苓 15g;高血压病加菊花、怀牛膝各 10g,石决明 30g;耳鸣加磁石 30g)治疗瘀血眩晕 20 例,临床痊愈 15 例,显效 9 例,有

巩固疗效。

【方名】 定眩汤。

【组成】 白术 15g, 泽泻 20g, 茯苓 20g, 半夏 10g, 菊花 12g, 石菖蒲 15g, 桑枝 10g, 天麻 10g, 钩藤 15g, 荷叶 10~15g。

【来源】 张平, 山东中医杂志, 1992, (3): 22。

【功效】 利湿化痰, 平肝熄风。

【适应证】 梅尼埃综合征。

【方药简析】 方中泽泻、白术、茯苓、半夏健脾利湿, 以绝生痰之源; 石菖蒲化痰开窍, 以利清窍; 天麻、钩藤、平肝潜阳; 荷叶化湿醒脾、升清降浊, 复取桑叶、菊花清利头目, 以达标本兼顾, 共奏除眩定晕之效。张平用该方治疗美尼尔综合征 42 例, 39 例痊愈(旋转性眩晕、恶心呕吐、耳鸣消失, 1 年以上未复发); 2 例好转(眩晕明显减轻或消失, 1 年以上复发); 1 例无效(连服中药 6 剂, 症状改善不明显)。总有效率 98%。气虚加黄芪 20g, 党参 15g; 肾阴不足加旱莲草、女贞子、何首乌各 15g; 虚火上炎加知母、黄柏各 6g, 牛膝 10g; 肝火明显加龙胆草、黄芩各 10g; 血压偏高属肝阳上亢加代赭石 15~30g, 生龙骨、生牡蛎 15~30g; 失眠加炒枣仁 15~30g, 夜交藤 30g; 恶心呕吐明显加竹茹 10g。

【病案举例】 黄某, 男, 40 岁, 1983 年 8 月 3 日初诊。眩晕 7 天, 7 天前中午休息起床时, 突然目眩, 视物旋转, 随即恶心呕吐, 耳鸣, 畏光闭目, 不敢转头, 势欲仆地, 伴有失眠多梦纳呆。查体: 血压 14. 7/10/7kPa, 轻度水平性眼震, 双鼓膜轻度内陷, 听力减弱, 舌质红, 苔腻, 脉弦。诊为梅尼埃综合征。证属风痰阻蔽清阳。治宜平肝熄风, 利湿化痰开窍, 佐以安神。投以定眩汤加酸枣仁 30g, 夜交藤 30g, 日 1 剂。饭后 1h 服。连

进4剂,眩晕、耳鸣明显减轻,恶心呕吐消失。继进3剂后眩晕消失,精神转佳,为巩固疗效,继服前方3剂,随访2年无复发。

【方名】 镇眩汤 1。

【组成】 当归 12g,熟地黄 15g,川芎 10g,白芍 15g,茯苓 15g,桂枝 10g,白术 15g,生龙骨、生牡蛎各 20g,甘草 6g。

【来源】 陈宝田等,辽宁中医杂志,1991,(7):20。

【功效】 补虚祛瘀,温化痰饮,平肝潜阳。

【适应证】 各种原因引起的眩晕。

【方药简析】 方中以四物汤补虚祛瘀;苓桂术甘汤温化痰饮;生龙骨、生牡蛎平肝潜阳。陈宝田等用镇眩汤治疗眩晕症 300 例,其中椎动脉型颈椎病 180 例,57 例治愈(眩晕症状消失,能够完成全日工作),54 例显效(眩晕症状明显减轻,能坚持工作),66 例有效(眩晕症状减轻,生活能自理),3 例无效(眩晕症状未减或加重,生活能自理)。椎基底动脉供血不足 48 例,12 例治愈,30 例显效,6 例有效。梅尼埃综合征 30 例,15 例治愈,15 例显效。功能性眩晕 21 例,15 例治愈,6 例显效。前庭神经炎 9 例,6 例治愈,3 例显效。延髓外侧综合征 3 例均有效。椎动脉系血栓性脑梗死 3 例均有效。低颅压综合征 3 例均显效。吡喹酮毒性反应 3 例均显效。

【病案举例】 陈某,女,37 岁,1984 年 10 月 24 日初诊。诉眩晕病史 2 年,2 年来每隔 1~3 个月发作 1 次,伴呕吐、耳鸣,小便不利。此次发作于 10 月 23 日晚,突然感到周围墙壁在摇动,自觉有浮空感,立即卧床,继而呕吐,耳鸣,不能进食,来院就诊。查体:两眼呈水平震颤,面色苍白,舌质淡,脉弦缓。诊为梅尼埃综合征。投镇眩汤加半夏 10g,水煎服,1 剂即效,眩晕减轻,呕吐消失;再服 2 剂,症状完全消失。又继服 2 剂

后,随访半年未复发。

【方名】 眩晕丸。

【组成】 当归、五味子、山药、酸枣仁、龙眼肉。上药等份,共研细末,过 80 目筛,蜜制为丸,每丸重 5g,日服 3 次,每次 2 丸。

【来源】 徐锦山,浙江中医杂志,1987,(4):39。

【功效】 养心安神镇静。

【适应证】 各种原因引起的眩晕。

【方药简析】 方中当归,治血虚眩晕;五味子能补不足,敛阴益精;山药健脾益肾;酸枣仁“久服安五脏”;龙眼肉补心安神,五药相合,补虚、安神、镇静,共奏良效。徐锦山用眩晕丸治疗眩晕 100 例,21 例显效(服药 5 天内症状消失);71 例有效(服药 10 天内症状消失或减轻);8 例无效(15 天内症状未见减轻或反加重)。

【病案举例】 戴某,女,31 岁,1973 年 9 月 20 日初诊。头晕耳鸣,恶心呕吐,间歇发作 4 年余。近年来发作较频繁,因情志不遂发病 10 天,就诊时由其女搀扶,头扎手帕,状如产妇,畏光闭目,自觉身晃如坐舟。舌淡红,苔少脉弦细。予眩晕丸,日 2 次,每次 4 丸。3 天后,眩晕明显减轻,双目不再畏光。再服 2 天,诸恙消失如常人,继服以作巩固。

【方名】 防眩汤。

【组成】 石菖蒲 20g,半夏、白术、防风、山茱萸、蔓荆子、天麻各 10g,茯苓、珍珠母(先煎)各 30g,生姜 3 片。

【来源】 张健臣,新中医,1995,(1):51。

【功效】 健脾燥湿,化痰降逆。

【适应证】 内耳眩晕症。

【方药简析】 方中半夏白术天麻汤燥湿健脾；加防风、蔓荆子祛风定眩；山茱萸、生姜温中降逆；天麻为治风痰眩晕之圣药；珍珠母镇潜降逆。诸药合用，共奏燥湿健脾，化痰降逆。朱健国用防眩汤治疗内耳眩晕症 38 例，治愈（自觉症状全部消失，听力恢复正常）31 例；显效（眩晕停，呕吐止，听力明显好转，耳鸣减轻）7 例。气虚甚者加党参、黄芪 30g，血虚甚者加当归 15g、白芍 30g。

【病案举例】 徐某，男，53 岁，1991 年 3 月 28 日初诊。患有眩晕病史 10 余年，每遇劳累而发作，初发 1~2 周，病情呈进行性加重。此次因出差旅途疲劳而突发，经治半年无效。参见：自觉眩晕，耳鸣，恶心欲吐，视物摇晃旋转，难以自主，胸闷，气短乏力，舌淡，苔薄白，脉细。诊为内耳性眩晕症。防眩汤加太子参、黄芪各 30g，5 剂后诸症大减，效不更方，继服 5 剂，症状消失，病告痊愈。

【方名】 黄芩苍术汤。

【组成】 黄芩、苍术、菊花、茶叶各 10g，车前子、夏枯草、清半夏各 15g，代赭石 30g。

【来源】 荣加和，四川中医，1992，（7）：25。

【功效】 清热除湿，平肝熄风。

【适应证】 湿热眩晕。

【方药简析】 方中黄芩苦寒清热燥湿为君；苍术苦温燥湿；车前子淡渗利湿；夏枯草、菊花寒凉清热共为臣；代赭石平肝潜阳；清半夏辛温燥湿、化痰降逆止呕同为使药。诸药共奏清热除湿平肝熄风之效。热重加炒黄连；流涕鼻塞、恶寒加川芎，柴胡，防风，羌活。

【病案举例】 李某，男，32 岁，1988 年 7 月 10 日诊。几天前突然头晕目眩，头重如裹，恶心干呕，发热口苦，胸闷，尿黄，

舌苔黄腻，脉濡数。诊为眩晕，乃湿热上扰，清阳不升。遂予茵陈苍术汤加炒黄连，共服6剂而愈。随访半年未复发。

【方名】 四苓散。

【组成】 茯苓、猪苓、泽泻各30g，白术15g。

【来源】 朱丹溪《丹溪心法》。

【功效】 健脾利湿。

【适应证】 内耳眩晕症。

【方药简析】 方中泽泻、猪苓利水渗湿；茯苓、白术健脾化湿。四药合用，共奏健脾行水、蠲饮除痰之功。吴国军用四苓散加味治疗梅尼埃病45例，均获痊愈（眩晕、耳鸣、恶心呕吐消失，听力减退好转，或不再加重，随访1年不复发）。

【病案举例】 张某，女，68岁，1989年8月17日初诊。患者眩晕2年余。甚则卧床不起，稍动则感天旋地转，下床则仆不能行步，腕痞纳差，恶心欲吐，血压22/11kPa，舌质淡红，苔白腻，脉弦滑。诊为内耳性眩晕症。证属痰饮内停，清阳不升，浊阴上蒙，蒙蔽清窍。治当利水健脾，蠲饮除痰。方用四苓散加天麻、石菖蒲各10g，炙甘草6g，服5剂后，眩晕锐减，续服上方4剂，眩晕止，诸症悉除，追访两年，眩晕一直未复发[吴国军，四川中医，1994，（4）：25]。

【方名】 仙鹤响铃汤。

【组成】 仙鹤草、响铃草各60g，雄子鸡1只，去毛和内脏，洗净后文火炖至鸡肉离骨，加盐、姜调味，饮汤吃鸡，1日内分早晚服完，每周1~2次，连服3周。

【来源】 唐桂文，四川中医，1986，（9）：35。

【功效】 调补气血，补肾益虚。

【适应证】 内耳眩晕症。

【方药简析】 仙鹤草有调补气血,强心和恢复疲劳的作用;响铃草补肾益虚,与雄子鸡同炖,温中益气。本方具有饮膳的形式而兼有营养疗法的意味。

【病案举例】 林某,女,50岁,1981年10月30日诊。患者于1977年患眩晕症。诊断为内耳性眩晕症。时常复发,近半年来发作较频,发作时剧烈眩晕,头不能抬,眼不能睁,自觉周围环境有定向性旋转,伴恶心呕吐,多汗,耳鸣如蝉,记忆力减退。检查:重听,眼球震颤。即予仙鹤响铃汤服5天后,症状大减,续于原方加大1倍煎水炖子鸡服汤食鸡,半个月后,全身舒适,病告痊愈。

【方名】 术附汤。

【组成】 白术 10g,附子 15g,炮生姜 10g,甘草 5g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 温补脾肾。

【适应证】 脾肾阳虚之眩晕。

【方药简析】 方中白术益气健脾为君;附温补肾阳为臣;佐以炮生姜温补脾胃,使以甘草调和诸药。四药合用共奏温补脾肾之功。李国华用术附汤加味治疗3例阳虚眩晕,均获痊愈。

【病案举例】 王某,男,50岁,1984年10月6日初诊。昨晚突发头晕目眩,畏寒,前额沉重,不能起床登厕,闭目静卧,则眩晕略轻。症见形体虚胖,苔淡白,脉沉细。证属脾肾阳虚,处方术附汤加大枣5枚,仙鹤草12g。1剂眩晕大减,能起床登厕,已不恶心。继服2剂,诸症俱除[李国华,四川中医,1986,(9):33]。

【方名】 益气聪明汤。

志,1995,(9):397]。

【方名】 桃红定眩汤。

【组成】 桃仁、白芍、党参各 12g,红花、菊花、白芷、刺蒺藜各 10g,丹参 15g,川芎 9g,石决明、葛根各 20g。

【来源】 黄锡深,广西中医药,1995,18(2):7。

【功效】 益气活血,化淤通络。

【适应证】 颈性眩晕。

【方药简析】 方中桃仁、红花、当归、丹参、川芎活血化瘀;白芍养血活血;菊花、刺蒺藜、石决明平肝祛风明目;葛根解肌达郁,舒缓痉挛;白芷有止晕止眩止痛的作用。气虚加黄芪、天麻;痰湿加苍术、半夏;阳虚加附子、桂枝。黄锡深用桃红定眩汤治疗颈性眩晕 60 例,42 例治愈(临床症状消失,脑血流图未恢复正常);12 例显效(眩晕症状基本控制,其他症状消失或减轻,脑血流图未恢复正常);6 例无效(临床症状改善,但未完全消失,脑血流图无改善)。总有效率为 90%。

【病案举例】 李某,女,55 岁,于 1991 年 6 月 8 日就诊。头晕眼花 4 年,加重 15 天。于 4 年前某日中午突发眼前发黑,头晕目眩,如坐舟车。经某医院处理后缓解。4 年来反复头晕眼花,病情逐渐加重,经服中西药无效。症见:头顶刺痛,头晕目眩,时有胸闷呕吐,口干疲乏,失眠纳少,大便调,唇舌紫暗,舌边有淤点,苔薄白,脉细涩。检查:血压正常。颈椎正侧位片示:第 4、5 颈椎骨质增生。脑血流图提示:供血不足。血流变学示:红细胞压积 55%。诊为血淤所致眩晕。治以益气活血、化淤通络。方用桃红定眩汤加黄芪 20g,赤芍 15g。6 剂后,症状减轻,效不更方。又继服 10 剂后,症状消失,各项检查基本正常,复查脑血流图已恢复正常。血液流变学示:红细胞压积 0.45。随访 1 年未见复发。

【方药简析】 方中党参味甘、平，白术甘、温，山药味甘、平，皆入脾以补气扶中；当归味甘、辛、温，养血缓急以实肝体；川芎味辛、温，血中之气药，活血行气以解肝郁；钩藤甘、微寒，刺蒺藜甘、辛、平，寒能清热，苦能泻热，辛能解郁，二药相伍有清肝热、疏肝郁、平肝阳之功；生龙骨甘、涩、微寒，生牡蛎咸、微寒，二药皆质重性凉，能镇肝潜阳、凉肝熄风。眩晕甚者，加珍珠母、石决明；痰多色白者，加陈皮、清半夏；痰多色黄者，加黄芩、竹茹；失眠多梦者，加二至丸、夜交藤；呕吐甚者，加代赭石、姜竹茹、清半夏；腰膝酸软者，加熟地、桑椹；冲热明显者，加生代赭石、牛膝。

【病案举例】 何某，女，36岁，1977年3月21日诊。3日前因家事不顺而郁怒不欢，是夜起床小解，忽感头晕目眩，不能站立，但觉四周旋转倒立，冲热呕吐。清晨由家人护送到我院求治。问之，但言气短不欲语，观其舌淡不荣，面色少华，苔薄白，脉左弦右滑。诊为梅尼埃综合征。系脾虚肝旺所致，投以平肝扶中汤加香橼 12g，代赭石 30g。服药 2 剂后，呕吐、冲热消失，其眩晕十去有九，唯感气短身倦，纳谷不香，以香砂六君子汤加白芍，刺蒺藜善后。患者连服 3 剂，随访，已上班 3 天，病遂痊愈。

【方名】 平肝化痰汤。

【组成】 生石决明、磁石各 30g，白芍、桑椹各 15g，菊花、陈皮各 9g，茯苓、竹茹、天麻各 12g，半夏 6g，钩藤 24g，朱砂 3g。

【来源】 史方奇等，四川中医，1988，(11)：30。

【功效】 平肝潜阳、燥湿豁痰。

【适应证】 肝阳上亢，痰湿内闭之眩晕。

【方药简析】 方中生石决明、磁石、钩藤平肝潜阳；白芍、

桑椹、菊花养阴柔肝；陈皮、茯苓、半夏、竹茹燥湿豁痰降逆；天麻熄风祛痰；朱砂镇静安神。诸药共奏平肝潜阳、养阴熄风、燥湿豁痰之功。

【病案举例】 马某，男，45岁。患者于3年前出现头眩耳鸣，手足麻木，头重脚轻，站立不稳，足如着棉，行走欲倒，甚则呕吐，诊为植物神经功能紊乱，经各种治疗数年无效。症见精神萎顿，站立行走困难，需人搀扶，舌质淡，苔白，脉弦细。证属肝阳上亢、痰湿内闭之候。治以平肝潜阳、豁痰之剂，方用平肝化痰汤。服药2剂后，各症减轻。6剂后，即能站立，10剂后，头重脚轻之症减轻，已能行走，起居自如，生活自理而出院。

【方名】 五味定眩汤。

【组成】 丹参、泽泻各60g，黄芩、半夏、天麻各30g。

【来源】 段天荀，四川中医，1993，(1)：480。

【功效】 化痰利水，降火祛淤。

【适应证】 梅尼埃病。

【方药简析】 方中丹参活血化淤，对内耳微循环具有疏通作用，能消除内耳迷路水肿，疗效好且无不良反应；泽泻味甘而淡，淡能渗泄，所以能利水而泄下，该药含大量钾盐，故利水而不伤阴，能促进内淋巴液排泄；黄芩清热泻火，能消除内耳迷路炎性水肿；半夏燥湿化痰，天麻平肝熄风。五药合用，共奏化痰利水、泻火祛痰、平肝熄风之功，使内耳迷路水肿消退而眩晕顿除。段天荀用五味定眩汤治疗梅尼埃病52例，痊愈（眩晕、耳鸣、恶心呕吐、汗出等消失，听力恢复正常，停药后无复发）38例，好转（眩晕、耳鸣、听力较前明显好转，恶心呕吐、汗出消失）12例，无效（症状和体征无变化）2例，总有效率96%。

【病案举例】 湛某，女，52岁，1991年8月4日诊。患者

6 天前于赶集途中突发头晕目眩,自觉天旋地转,如坐舟车,大汗淋漓,恶心呕吐,被人抬回家后,卧床仍觉眩晕、耳鸣、恶心呕吐、汗出,不思食,听力明显下降,舌质淡红,苔厚腻,脉数。诊断:梅尼埃病。中医诊断:眩晕。服五味定眩汤 1 剂后,安然入睡,次晨即觉全身轻松,头晕目眩消失,听力好转,服药 3 剂后,眩晕、耳鸣止,听力恢复正常,恶心呕吐、汗出消失,活动如常,痊愈出院。随访至今,未复发。

【方名】 镇眩汤 II。

【组成】 泽泻 30g,白术、茯苓、代赭石、钩藤各 15g,天麻、半夏、甘草各 10g,荔枝草 30g。

【来源】 符承越,广西中医药,1995,18(2):62。

【功效】 镇肝熄风,扶脾益肾,涤痰降逆。

【适应证】 梅尼埃综合征。

【方药简析】 自拟镇眩汤中,首选泽泻利水渗湿,为《金匱要略》用治“支饮冒眩”之主药;配以白术、茯苓、甘草扶脾益肾、健运脾阳,以阻断生痰之源;半夏燥湿化痰,和胃降逆以止呕;天麻平肝熄风、祛风止痛;钩藤熄风止痉、清热平肝;代赭石性寒重坠、平肝降逆;荔枝草辛淡微温、强壮补益。综观诸药相配,具有镇肝熄风、扶脾益胃、涤痰降逆的作用。眩晕较甚、呕吐频作者,加竹茹,信用代赭石以镇逆止呕;胸脘满闷,泛恶不食者,加白豆蔻、藿香以化浊开胃;耳鸣重听者,加石菖蒲、葱白以通阳开窍;急躁易怒、头痛且胀者,加白蒺藜、石决明以平肝潜阳;肢体颤抖者,加牡蛎、珍珠母以镇肝熄风;心悸失眠者,加远志、酸枣仁以养血安神;汗出肢冷、面色苍白、神疲懒言、血压偏低者,加西洋参、黄芪、干姜、肉桂以益气助阳。符承越用此方加减治疗梅尼埃综合征 68 例,痊愈(临床症状消失) 56 例;有效(临床症状明显减轻) 9 例;无效(临床症状无变化)

3例,总有效率95.6%。

【病案举例】 陈×,女,30岁,1984年1月2日初诊。自诉患头晕目眩逾3年,时发时止,近日因烦劳而突发加重。症见:头晕耳鸣,胸闷痰多,恶心呕吐,旋转动摇如坐舟车,倦怠嗜睡,不思进食,舌苔白腻,脉细数。遂投以镇眩汤加减:泽泻30g,白术10g,半夏12g,茯苓10g,代赭石20g,甘草10g,天麻10g,荔枝草30g,竹茹10g,生姜10g。2剂后眩晕渐平,呕吐已停,能起床活动,但脾胃未健、精神未复,依前方减荔枝草、代赭石,加陈皮8g,藿香10g以健脾和胃。2剂告安。

【方名】 补中益气汤。

【组成】 黄芪、党参各30g,白术、陈皮、柴胡各10g,甘草、升麻各6g,当归15g。

【来源】 李东垣《脾胃论》。

【功效】 益气健脾升清。

【适应证】 脾胃气虚,中气下陷诸症。

【方药简析】 方中党参、黄芪、白术益气健脾;陈皮理气和胃;柴胡、升麻升举清阳;当归养血和血;甘草调和诸药。纳差欲呕者加砂仁、生姜;视物模糊者加枸杞、菊花,郑爱国用此方加川芎、桃仁、红花、地龙各12g,丹参15g;治疗动脉硬化性眩晕54例,45例显效(临床症状消失,脑血流图示脑供血明显改善,血脂下降至正常范围);8例好转(临床症状明显减轻,脑血流图示脑供血改善,血脂下降);1例无效(临床症状无改善,脑血流图与血脂均无变化)。总有效率为98%。

【病案举例】 李某,男,60岁,1992年5月4日初诊。诉头晕、眼花、记忆力减退,神疲乏力1年半,伴左上肢麻木感,口苦乏味,胸闷,甚则头晕欲倒,查:心率88次/min,心前区可闻及期前收缩,未闻及杂音,舌胖暗红,苔薄白,脉弦滑。脑

22 高血压脑病

高血压脑病是因恶性高血压时,平均动脉压迅速升达20kPa(150mmHg)以上,脑小动脉发生过强的自动调节反应即普遍的脑血管痉挛,使脑部缺血缺氧而导致脑水肿,毛细血管破裂(点状出血)和组织坏死(微梗死)而产生的症状、体征。本病见于原发性高血压或继发性高血压,如急性肾小球性肾炎、妊娠毒血症、嗜铬细胞瘤、柯兴综合征、促肾上腺皮质激素中毒和铅中毒等。恶性高血压时更易发生。高血压者漏服抗血压药,也可诱发。本病常以急性或亚急性起病,常见的症状是严重头痛、全身软弱无力、恶心呕吐、黑蒙、易激惹或嗜睡、抽搐。症状发展迅速,可出现意识模糊、木僵或昏迷,有的尚可出现一过性与波动性神经性障碍,如单瘫、偏瘫、失语等。有的病人,发作前可有头痛,并伴有发作性眩晕。发病时血压的升高呈恶性程度,高达24/16kPa以上,或平均动脉压在20kPa以上。在小儿的急性肾小球性肾炎和妊娠毒血症患者中,当血压在21/13kPa时,就可出现本病;而慢性高血压患者,虽血压高出33/22kPa时,可仍不出现本病。此外有高血压视网膜病变(视网膜出血、渗出、小动脉痉挛、视盘水肿),并可有高血压性肾及心脏病变。本病应与高血压性脑出血、蛛网膜下腔出血、偏头痛等病相鉴别。

高血压性脑病无意识障碍时,属中医头痛范畴,有意识障碍时则属于中风。中医学认为,本病是由于情志内伤,肝失调达,郁久化热,肝火上炎,上扰清窍;或肝肾阴虚,尤其是肾阴

原方去芒硝、大黄、代赭石、钩藤，加茯苓、泽泻、淫兰、茅根。5剂后，诸恙咸安，复查血压正常，尿蛋白（-），继以六味地黄汤善后。

【方名】 葛根汤合旋复代赭汤。

【组成】 桂枝、白芍、旋复花各 9g，炙甘草 6g，葛根 30g，党参 12g，代赭石 15g，姜半夏 10g，红枣 5 枚，生姜 3 片。

【来源】 许秀平，四川中医，1986，（4）：35。

【功效】 调和营卫，和胃降逆。

【适应证】 高血压脑病。

【方药简析】 方中葛根汤解肌祛风、调和营卫，旋复代赭汤和胃降逆。2 方合用，病药合机，邪退正安。

【病案举例】 万某，女，56 岁，1982 年 7 月 13 日诊。素患眩晕，近因恼怒，加之露宿贪凉，而致眩晕复作，血压 29/16 kPa。某医院诊为高血压脑病。经注射利血平后血压急剧下降，头晕加甚，乃转中医治疗。症见：恶风，发热（37.8℃），自汗，头晕目眩，颈项不适，目不能展，恶心呕吐，动则更甚，十指挛缩，呈鸡爪状，不能进食，舌体胖大而嫩，质淡，苔白，脉浮缓。证属太阳中风，胃气虚逆。治宜解肌祛风、和胃降逆。方用葛根汤合旋复代赭石汤主治。服 1 剂，并嘱药后啜热稀粥 1 碗。药后，诸症消失，血压正常，饮食稍进，守原方继进 1 剂而愈。活动、饮食一如常人。

【方名】 养血柔肝熄风汤。

【组成】 当归、白芍、全蝎各 10g，天麻、僵蚕、枸杞子、地龙各 15g，钩藤、菊花各 18g，牛膝、龙骨、牡蛎各 30g，蜈蚣 4 条。

【来源】 赵育才等，四川中医，1989，（3）：6。

【功效】 养血柔肝熄风。

【适应证】 高血压脑病。

【方药简析】 方中当归、白芍、枸杞子养血柔肝，天麻、钩藤、菊花平肝熄风，僵蚕、地龙、牛膝、全蝎、蜈蚣祛风通络，龙骨、牡蛎育阴潜阳。诸药共奏养血柔肝潜阳熄风之效。赵育才等用养血柔肝熄风汤加减治疗(10天为1疗程)高血压脑病60例，47例治愈(自觉症状消失，血压正常且稳定，停药2月无复发)；10例有效(症状消失，血压正常且稳定，停药后血压不稳定)；3例无效(连续用药3个月疗程症状减轻，但血压不稳定)。

【病案举例】 马某，男，57岁，1988年9月20日初诊，患者有高血压病史10余年，血压波动在22.7~25.3/13.3~17.3kPa。1周前因情绪激动，突发头痛，眩晕，恶心呕吐，右侧头部及肢体麻木，血压25.3/17.3kPa。刻诊：舌质暗红、少苔、脉弦大，重取空无，辨证阴虚，定位在肝肾，证型为肝风上扰。治以养血柔肝熄风，方用养血柔肝熄风汤加防己30g，磁石40g。7剂后，血压降至21.4/13.3kPa，嘱续服10剂，血压降至20/12.7kPa。继服15剂后，除右侧肢体麻木，余无所苦。原方减防己，加丝瓜络10g，续服20剂后，右侧肢体麻木消失，血压稳定在20/12kPa。随访至今未复发。

【方名】 凉膈散。

【组成】 大黄、栀子、黄芩、竹叶、连翘各9g，芒硝9g(另冲)，甘草6g，薄荷6g。

【来源】 《太平惠民和剂局方》。

【功效】 泻火通便，清上泄下。

【适应证】 高血压脑病等。

【方药简析】 方中连翘清热解毒为主，配黄芩以清心胸

郁热,栀子通泻三焦之火引火下行,竹叶、薄荷外疏内清,用芒硝、大黄荡涤胸膈邪热、导泻下行,配以甘草,缓和硝、黄峻泻之功。

【病案举例】 李某,男,55岁。因上腹部剧痛伴呕吐10小时,于1975年10月2日夜急诊入院。近1年来,经常头晕、头痛、心烦失眠,入院前10h因暴食后发生上腹部剧烈疼痛,伴大汗出,恶心呕吐2次,但无腹泻及畏冷发烧。查:体温36.2℃,脉搏60次/min,呼吸28次/min,血压22.1/16.0kPa。左下肺有明显湿性罗音,右肺(-),腹部稍膨隆,肠鸣音活跃。化验:白细胞计数 $12.7 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.91。心电图示左室肥大。入院诊断:急性胃炎,高血压。入院后至凌晨2点腹痛止,开始出现头晕,头痛,烦躁不安,有时抽搐,测血压25.9/16kPa,神志不清,狂躁谵语等。检查眼底见视乳头水肿,经会诊诊断为高血压脑病。10月5日病情不见改善,血压仍为29.3/18.6kPa,病人极度烦躁。下午5点出现昏睡,呼吸困难,紫绀,抽搐,尿失禁等,病情危笃,于当晚请中医会诊,中医辨证:患者平素心肝热盛,经常头晕,心烦失眠,病前恣食鸡、酒等热性食物,昏睡抽搐,喉中痰鸣,肢厥舌塞,苔焦黄,证属阳旺热盛、腑实燥结、热扰心包。治宜急下存阴,釜底抽薪。方用凉膈散加钩藤、白芍各15g,牛黄清心丸3粒,分3次开水化服。服药1剂后,大便1次,为黑色稀便,极臭秽。神志逐渐转清,能食稀粥1小碗。诉头晕而痛,胸中炽热如焚,口干渴。舌已能自动伸出,苔老黄而下,舌质红赤,脉弦。上方再服1剂。血压降至24.0/17.3kPa,腹泻1次,量多而色黄。自诉头晕失眠,心烦口渴,舌苔薄白而干,舌质红,脉弦,又给予滋阴潜阳之剂,患者血压降至20/14.1kPa,神志清楚,继续服中药降压[新医药学杂志,1976,(10):45]

23

震颤麻痹

震颤麻痹也称帕金森病,是以肌张力增强和震颤为特征的锥体外系病变。一般将原因不明者称为震颤麻痹,查明原因者则根据其病因命名为震颤麻痹综合征。本病发病年龄多在40岁以上,青年发病亦有,男多于女。原发性震颤麻痹(帕金森病)的主要病理是黑质变性,但引起黑质变性的原因至今未明。虽有在一个家族中容易见到多个患者的情况(约15%的病人有家族史),但并未证明有单基因遗传。有人推测本病是一种罕见的病毒感染,或是接触某种未明毒物所致,但亦未能得到证实。感染(如流行性甲型脑炎、梅毒等)、脑动脉硬化、颅脑外伤或一氧化碳、锰等中毒及服用某些药物可引起与震颤麻痹类似的表现,称之为震颤麻痹综合征。许多年轻的震颤麻痹患者,无明显脑炎,只有流行性感冒的病史,这种所谓“少年型震颤麻痹”,其中一部分可能系脑炎的后遗症。本病起病多很缓慢,呈进行性加重。主要症状包括震颤、肌强直及运动障碍等,症状中孰先孰后,因人而异。①震颤:常为本病之早期症状,多见于头部及四肢,尤以手部明显,震颤多自一侧上肢远端(手指)开始,然后逐渐扩展到同侧下肢及对侧上下肢,而下颌、口唇、舌头及头部一般均最后受累。在本病早期,震颤仅于肢体处于静止状态时出现,作随意运动时可减轻或暂时停止,至晚期则变为经常性出现。情绪激动时加重,睡眠时则完全停止。②肌强直:是由于锥体外系性肌张力增高所引起。伸肌与屈肌的肌张力均增高,在关节被动运动时,感觉有铅管样阻

钩藤饮加减;肝肾不足型:治以滋补肝肾、育阴熄风,方选大定风珠加减;髓海不足型:治以补肾荣脑,方用自拟健肾荣脑汤(紫河车 5g,龙眼肉 10g,桑椹子 10g,熟地黄 15g,当归 12g,太子参、茯苓、何首乌、胡桃肉、白芍各 20g 等);肝阳上亢型:治以平肝潜阳,选镇肝熄风汤加减;痰热上扰型:治以清热化痰,用化痰透脑丸(胆南星 6g,天竺黄 6g,皂角 3g,琥珀 3g,郁金 20g,清半夏 10g,蛇胆、陈皮各 10g,远志 10g,珍珠 6g,沉香 3g,麝香 2g)[新中医,1993,(2):13]。

陆曦等根据震颤麻痹症的临床表现,将其分为肝风内动型(治宜滋阴潜阳,方用二甲复脉汤加味:白芍 20g,生地 15g,麦冬 15g,鳖甲 15g,麻仁 10g,阿胶 10g,陈皮 12g,制半夏 10g,厚朴 10g)、肝肾亏虚型(治宜滋补肝肾、健脾除湿,方用杞菊地黄丸合六君子汤加减:熟地黄 15g,枸杞子 20g,人参 10g,白术 15g,茯苓 20g,石菖蒲 20g,炙甘草 10g,陈皮 10g,制半夏 10g,当归 12g,白芍 20g,泽泻 15g,川芎 10g)、脾胃虚弱型(治宜健脾和胃,方用六君子汤加味:党参 15g,茯苓 20g,白术 20g,陈皮 15g,制半夏 10g,炙甘草 10g,柴胡 6g,厚朴 10g,白芍 20g)、热扰心神型(治宜泻火解毒,方用黄连解毒汤合芍药甘草汤:黄连 10g,黄芩 10g,黄柏 10g,栀子 10g,白芍 15g,炙甘草 6g)4 型,共治疗 20 例,明显好转 8 例,9 例好转,3 例无效[福建中医药,1993,24(4):9]。

潘澄濂将震颤麻痹分 3 型:水不涵木,风阳自动型,用大补阴丸合独活汤加减(龟板 20g,地黄 20g,独活 10g,防风 10g,知母 15g,黄柏 10g,当归 12g,川芎 10g,全蝎 6g,僵蚕 15g);风痰阻络型,用定振丸加减(当归 12g,川芎 10g,白芍 15g,地黄 15g,独活 10g,威灵仙 15g,竹沥 10ml,胆南星 6g,僵蚕 15g,钩藤 15g);心神虚弱型用补心丸(人参 10g,地黄 15g,当归 12g,川芎 10g,茯神 15g,柏子仁 15g,酸枣仁 15g,

琥珀 6g,石菖蒲 20g,远志 10g,麝香 3g)[浙江中医杂志, 1990,(12): 483]。

王永炎等根据震颤麻痹的临床表现,将其分为气血两虚、血瘀风动(治宜益气养血、活络熄风,以黄芪 20g,党参 20g,当归 15g,白芍 20g,天麻 12g,钩藤 20g,珍珠母 30g,丹参 20g,鸡血藤 30g,羚羊角粉 3g 等药随证加减);肝肾不足、血瘀风动(治宜育阴熄风活络以生地黄、熟地黄各 15g,何首乌 15g,玄参 12g,钩藤 20g,白蒺藜 12g,羚羊角粉 3g,生牡蛎 20g,丹参 20g,赤芍 15g,杜仲 20g 等药随证加减);痰热动风(治宜清化痰热、熄风活络,以全瓜蒌 15g,胆南星 6g,竹沥 10ml,钩藤 20g,天麻 10g,羚羊角粉 3g,珍珠母 20g,丹参 20g,赤芍 20g 等药随证加减)3 型,共治疗 35 例,结果临床治愈 1 例,显著进步 11 例,进步 15 例,无进步 8 例,总有效率为 77.2%[中医杂志,1986,27(8): 22]。

【方名】 定振丸。

【组成】 生地黄、熟地黄、当归、川芎、白芍、钩藤、何首乌、枸杞各 15g,黄芪 24g,白术、天麻、防风、威灵仙各 10g,全蝎 6g,蜈蚣 2 条。

【来源】 王肯堂《证治准绳》。

【功效】 滋补肝肾,熄风通络。

【适应证】 震颤麻痹。

【方药简析】 方中生地黄、熟地黄、当归、川芎、白芍活血养血,血充肝有所养,筋以得荣;黄芪、白术益气健脾,培土以缓肝宁风;天麻、全蝎、蜈蚣、防风、钩藤搜肝风;天麻、生地、当归配何首乌、枸杞子滋阴养肝以熄风;威灵仙助搜肝风,又通经络,强筋骨而舒筋脉。诸药合之,使诸脏调运,筋脉荣和,震颤自止。李怀生用定振丸加减治疗震颤麻痹 11 例,治疗后 7

例震颤及全身症状消失,其中用药1个月者1例;1个月以上~2个月者3例;2个月以上~3个月3例;4例震颤转缓,全身症状消失。治愈者随访1年无复发。

【病案举例】 崔某,女,62岁,1988年11月3日就诊。患者手颤13年,4年前患中风,治愈后手颤加重,又伴右半身震颤,每发不能自止。遇事或遇生人则震颤加重,剧甚时吃饭亦需他人帮忙。西医诊断为震颤麻痹,虽转数家医院诊治不见好转。今见:形体消瘦,双上肢屈曲颤抖不止,伴头晕肢麻,舌质暗红,苔薄白,少津,脉弦细而数。证属阴血不足,肝风内动。治宜滋阴养血、平肝熄风。方用定振丸加菊花10g。服药5剂,头晕止,又服10剂,震颤转缓。上方去菊花,加重滋阴及虫类药,继服月余,身动止,手仍颤,肢麻。又服15剂后,将上方3剂量研成细末,炼蜜为丸,每丸重9g,日3次,每次1丸。药尽症除,又服1剂以巩固疗效[李怀生,浙江中医杂志,1993,(4):186]。

【方名】 复方养血熄风汤。

【组成】 白芍、钩藤各16g,山茱萸10g,全蝎、鹿角胶(烊化)9g,枸杞子、生地黄、白附子、当归各12g,蜈蚣2条,甘草6g。

【来源】 徐尚华等,浙江中医杂志,1994,(12):534。

【功效】 滋阴柔肝,养血熄风。

【适应证】 震颤麻痹。

【方药简析】 方中白芍、山茱萸、枸杞子、鹿角胶、生地黄、当归滋阴柔肝养血;全蝎、蜈蚣、白附子、钩藤熄风止痉。徐尚华用该方治疗震颤麻痹(3个月为1疗程)24例,13例痊愈(震颤麻痹消失,停药后6个月随访无复发);8例显效(震颤麻痹消失,停药3个月后虽有复发,但经重新治疗1疗程症状

仍可消失);3例无效(服药后症状有好转,但停药后症状又如前)。

【病案举例】 董某,男,62岁。患震颤麻痹病近3个月。症见神志清晰,表情正常,语言流畅,生理反射存在,左上肢持续性小幅度不自主颤动,手肌无萎缩,无病理反射。头部摆动不能自制。右上肢及双下肢未见异常。颈软,舌质淡,脉弦细。证属肝阴不足、血虚风动。以滋阴柔肝养血熄风,复方养血熄风汤主之。药后21天,手震颤头摆动均减。继进上方至78天,诸症消失,随访3年无复发。

【方名】 阳和汤。

【组成】 熟地黄 30g,肉桂 3g,麻黄 2g,鹿角胶 9g,白芥子 6g,炮姜 2g,生甘草 3g。

【来源】 王维德《外科全生集》。

【功效】 温阳补血,散寒通滞。

【适应证】 阳虚寒凝之阴疽等。

【方药简析】 方中重用熟地温补营血。鹿角胶填精补髓、强壮筋骨,藉血肉有情之品助熟地以养血。寒凝痰滞,非温通经脉不足以解散寒凝,故以炮姜、肉桂温中有通;麻黄开腠理以达表;白芥子祛皮里膜外之痰;与温补药共用,可使补而不腻。生甘草有化毒之功。全方组成,一以温补营血不足;一以解散阴凝寒痰,使其阴破阳回,寒消痰化。

【病案举例】 廖某,女,42岁,1984年3月30日初诊。患者1982年冬月感寒后,全身战栗不止。次日即到医院就诊,经针灸、中药短期治愈。1983年9月,劳累过度后出现手足抽搐颤动,头摇,不能胜任一般体力劳动,至今达7个月之久。西医诊断为震颤麻痹,病人要求中医治疗。症见面色苍白,双目无神,语言低微,神志清楚,四肢颤抖不已,头摇。四肢肌肉瘦削,

少。脉弦细略数,舌质暗红前半无苔,舌苔薄黄。血压 21.5/13.5kPa,右侧上下肢不停地摆动,上肢为前臂旋前旋后动作,下肢向外侧呈扭转样动作,左手握不住东西,肌张力稍增高,右侧肢体正常,膝反射存在,腹壁及提睾反射消失,无明显感觉障碍。中医辨证为肝肾阴虚、虚风内动。治宜养阴熄风。拟二甲复脉汤加羚羊角粉(冲服)3g,何首乌 12g,钩藤 15g,全蝎 6g。服药 4 剂后略显效果,发作间隔时间延长,持续时间缩短,又照上方将羚羊角粉改为 2g,续服 5 剂,病情显著好转,每日大发作 2~3 次,但轻微颤动仍较频繁。原方加僵蚕、炙地龙各 10g,再服 15 剂,完全恢复正常[新医学杂志,1978,(10):17]。

24 小舞蹈病

小舞蹈病,又称风湿性舞蹈病、感染性舞蹈病,是一种多见于5~15岁儿童的神经系统感染中毒性疾病。本病于1684年由薛登汗氏首先报道,故又称薛登汗舞蹈病。本病常为急性风湿病的一种表现,女性多于男性,临床以不自主的运动,伴有肌力减弱、自主运动障碍和情绪改变为特征。本病可自愈,但复发者不少。成人发病主要见于孕妇,称为妊娠舞蹈症,常见于17~23岁的初产妇,且多在妊娠的前半期发病,多属小舞蹈病的复发者。小舞蹈病多为亚急性起病,亦有因情绪激动而骤然发病者,临床以运动与情绪的变化为特征。运动的变化,其临床症状由病变部位所决定;如基底节的病变出现本病特有的舞蹈样动作;小脑的病变,出现肌张力降低和共济失调;皮质的病变则出现肌无力。早期症状表现为病儿较平时不安宁,注意力分散,书写字迹歪斜,肢体动作笨拙,手中所持物体经常失落和步态不稳等,逐渐出现一种极快的不规则的跳动或无意义的不自主运动,即舞蹈样动作,可因情绪激动或做自主样动作而加剧,平卧安静时减轻,睡眠时完全消失。舞蹈样动作以肢体远端最严重,上肢重于下肢,常起于一肢逐渐扩及一侧,再蔓延到对侧,若局限于一侧者,称偏身舞蹈症。发病时上肢各关节交替发生伸直、屈曲、扭转等动作,手指不停的屈伸与内收;上肢平举或举臂过肩时可见其手掌与前臂过度内旋(旋前肌征);其步态颠簸,常常跌倒;躯干亦可绕脊椎卷曲或扭转;头部可左右扭转或摆动;面肌不自主运动表现为扮

鬼脸、皱额、噉嘴、眨眼、吐舌、挤眉等。由于舌肌、口唇、软腭及其他咽肌的不自主运动,可致言语不清、咀嚼和吞咽困难;躯干肌与腹肌的不自主运动可使呼吸变为不规则。体检时可发现其肌力常减弱,与之握手则可发现其握力忽大忽小变幻不一。肌张力普遍降低,各关节可过度伸直。因肌张力降低,共济失调或真性肌无力而使自主运动不能协调,不自然,每一动作均呈突然冲动而出。精神的改变,轻重不一。常见患者情绪不稳,容易兴奋而致失眠,严重者可出现妄想、幻觉、意识模糊、躁动或木僵等。噪音与强光的刺激,均可使其躁动及舞蹈样动作加重。此外,有的可伴急性风湿热的其他表现,如发热、关节炎、皮下结节等。有风湿性心脏病者可有心脏扩大或杂音,有的在后期可有皮肤苍白及贫血等症状,但大多数患者全身症状甚轻微或完全缺如。本病应与老年性舞蹈病、慢性进行性舞蹈病、遗传性舞蹈病、习惯性抽搐、抽动秽语征候群等病相鉴别。

小舞蹈病属中医癇纵范畴。由于外感风邪,或禀赋不足,失于调摄,饥饱失宜,劳倦内伤,或久病失养等因导致阴血亏损,筋脉失养而发病,病变与心、肝、脾、肾有关,而主要在肝、心二脏。本病有虚实之别,但以虚证居多。外感风邪属实,阴血亏虚、阳化风动及血虚风动为虚,临床应灵动辨析。在辨证(阴血亏虚、血虚风动用天麻钩藤饮合四物汤;心血不足、阳亢风动用天王补心丹;外感风邪用大秦芩汤;气血两虚用八珍汤)基础上,可酌加全蝎、蜈蚣以熄风定搐;心烦急躁甚者加黄连、黄芩,以清心泻火;兴奋不寐、狂躁妄想者加炒枣仁、琥珀粉、远志以安神定志;言语欠清、咀嚼障碍者加远志、石菖蒲化痰开窍。

薛乐斌用芍药甘草汤加味(白芍 100g,甘草 50g,生地黄 30g,木瓜、蝉蜕、山茱萸、防风、僵蚕各 10g,赤芍、枸杞子各

20g,女贞子、菟丝子各 12g、龟板、茯苓各 15g、蜈蚣 3 条,全蝎 3g)治疗小舞蹈病 2 例,均获痊愈[四川中医,1990,(8):36]。

潘建华用芍药甘草汤合镇肝熄风汤化裁(生白芍、忍冬藤、生石决明、生龙牡各 30g,甘草、钩藤、天麻、全蝎、僵蚕、蝉蜕各 10g)治愈 1 例小舞蹈病患者[四川中医,1990,(4):38]。

王俭用桂枝加龙骨牡蛎汤合甘麦大枣汤加味(桂枝、秦艽各 12g,白芍、甘草、郁金、钩藤各 15g,生姜 6g,浮小麦、龙骨、牡蛎各 30g,天麻 9g)治疗小舞蹈病 14 例,基本治愈 13 例,好转 1 例[中医杂志,1986,27(5):346]。

【方名】 玉真八珍合方。

【组成】 制南星 10g,白附子 10g,天麻 10g,白芷 10g,羌活 10g,防风 10g,钩藤 20g,黄芪 30g,党参 30g,白芍 15g,当归 15g,川芎 15g,茯苓 15g,白术 15g,炙甘草 6g。

【来源】 邹世光,湖南中医杂志,1992,(2):35。

【功效】 补养气血,祛风化痰,平肝止痉。

【适应证】 舞蹈病。

【方药简析】 方中以八珍汤加黄芪补气养血,扶正以祛邪;以玉真散加钩藤祛风化痰、平肝止痉。诸药共凑补养气血、祛风止痉之功。肢体抽搐较甚加蜈蚣 3 条、全蝎 10g;喉痛咽干加菊花 15g、公英 15g;舌有淤点或淤斑加桃仁 15g、红花 15g。邹世光用该方治疗舞蹈病 29 例,显效 26 例(舞蹈症状消失,肌力正常,肢体运动自如,语言正常);无效 3 例(仍时有舞蹈动作,自主运动障碍,肌力减弱)。

【病案举例】 刘某,女,16 岁,1991 年 10 月 9 日初诊。诉右上下肢不自主、不规则运动 1 年余,加重 1 月。1 年前,因咽痛、双膝关节痛而经西药治疗缓解,不久即出现上述症状,屡

【方药简析】 方中桂枝汤解肌发表,调和营卫。龙骨、牡蛎镇惊安神、收摄心神。

【病案举例】 李某,女,10岁,1984年5月4日诊。3日前,因卒受惊恐后出现左上下肢挥舞乱动,时而裂嘴,挤眉,扭头,但入睡则消失。舌质淡红,苔白薄,脉弦缓。根据“诸风掉眩,皆属于肝”,百病皆因痰作祟的理论,按肝风挟痰上扰清空施治。治以补阴和阳、镇惊安神、止搐。方用桂枝加龙骨牡蛎汤原方,服3剂诸症减轻,继用上方加全蝎3g。服4剂后诸症悉愈,随访至今未见复发[四川中医,1986,(9):23]。

【方名】 赭石牡蛎汤。

【组成】 生代赭石、生牡蛎、白芍、威灵仙各30g,钩藤15g,防风、当归各12g,全蝎9g,蜈蚣3条,露蜂房、白花蛇各6g,地龙20g,羚羊角粉3g(冲服)。

【来源】 吴光辉四川中医,1985,(11):43。

【功效】 镇肝潜阳,熄风清心,活血通络。

【适应证】 急性风湿性舞蹈病。

【方药简析】 方中生代赭石、生牡蛎镇肝潜阳;钩藤、白芍、羚羊角平肝熄风;防风、全蝎、蜈蚣、地龙、白花蛇祛风通络定惊;当归养血和血;露蜂房、威灵仙舒经通络。

【病案举例】 卢某,男,9岁,1984年3月21日诊。半月前不慎跌伤左侧头部及臂部。次日感全身酸痛,头痛,恶寒发热,口歪眼斜,四肢不自主抽动。某医院诊为风湿性舞蹈病。检查:血沉42mm/h,抗“O”1:400。症见头部不断前倾后仰,吐舌挤眼,四肢蜷曲抽动,口下欲饮,头身微汗出,舌尖红,苔薄白,脉沉细微数。证属经络淤阻,风寒湿之邪淫于筋骨,肝风内动,筋脉失养,心经热盛。治以镇肝潜阳、熄风清心,佐以活血通络。方用赭石牡蛎汤原方。进5剂后,精神好转,头摇、四肢

抽动渐减,舌仍有颤动。上方加党参12g,磁石30g,又进7剂。舌颤止,说话时口角略见偏歪,手足时有不自主抽动,已能扶杖行走几步。上方去露蜂房加鸡血藤20g,合欢皮15g,再服7剂后,神志安定,手足抽动消失,语言流利,行走较稳健,舌质红润,脉细缓。上方加减治疗月余,已能恢复学习,复查血沉正常,随访1年未见复发。

【方名】 桃红四物汤加味。

【组成】 生地黄、磁石各10g,当归、赤芍各6g,川芎、桃仁、僵蚕各4g,红花、胆南星各3g,钩藤、地龙各5g。

【来源】 陈映标,北京中医,1994,(5):8。

【功效】 活血化淤,祛风化痰。

【适应证】 风湿性舞蹈病。

【方药简析】 方中生地黄养血、凉血、生津;当归、川芎补血活血行气以祛风;赤芍活血凉血散淤,四药合用,成为调血养血的良方。桃仁、红花活血通络祛淤;僵蚕、胆南星、钩藤清热化痰,解痉熄风。诸药合用具有活血化淤、养血通经、祛风化痰、镇痉熄风的功效。

【病案举例】 杨某,女,10岁,于1979年11月4日初诊。患者因神志紊乱常作不自主动作已两个多月,发作时扬手舞足,挤眉弄眼,心悸,经多方治疗未效。查抗“O”在800IU以上。诊见:似痴似呆,在诊室内手舞足蹈,有似跳舞,面色苍白,舌质淡,苔薄白,脉弦滑,诊为风湿性舞蹈病。中医辨证为肝风内动,挟痰上逆,阻碍脉络。治宜养血熄风、化痰祛淤,方用桃红四物汤加味再加磁石、郁金。服药5剂,前症好转,发作次数减少,原方续进10剂,患者病情稳定,神志清,谈笑自如。拟原方去磁石,胆南星,加黄芪,鸡血藤。给药5剂,病情基本痊愈,症状消失,唯恐复发,嘱其按上方继续服药10剂,以巩固疗效。

25 肝豆状核变性

肝豆状核变性,又称 Wilson 病、进行性豆状核变性或 Westphal-Strumpell 假性硬化症,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍所引起的家族性疾病。常侵犯儿童或青年人,有急性型与慢性型之分。若不及时治疗,急性病例常在数月至 1 年内死亡,慢性病例可存活数年至数十年。主要病理改变为豆状核变性和肝硬化;临床上表现进行性加剧的肢体震颤、肌强直、构音困难、精神改变、肝硬化及角膜色素环等症状。肝豆状核变性多在 10~20 岁间起病,男多于女,多数患者有家族遗传史。主要表现为①震颤、手足徐动、舞蹈症样不自主运动;起初可以随意控制,睡眠时停止。常自一手开始,先为细小的,逐渐变为粗大的震颤,随意运动时加重,以手足远端部位较显著。初期局限于一个肢体,以后扩展至四肢、躯干及头部,头部及下颌发生震颤时影响语言及咀嚼。②肌张力逐渐增高,表情肌强直,初期多局限于一肢体,而后扩延到四肢、躯干,面肌强直者呈“面具脸”。亦可见强哭强笑,或出现扭转痉挛,手足徐动等症。③癫痫样发作:少数可见局限性癫痫,有的类似破伤风痉挛发作,不伴意识障碍,但伴明显的恐惧、出汗与疼痛感。④植物神经症状:如多汗、多涎及多饮、多尿。⑤精神症状:表现为智能衰退、记忆力减退、注意力不能集中,重至痴呆,或表情淡漠,或出现幻觉等。⑥角膜色素环(K-F 环)出现。⑦患者若有肝病症状,肝脏边缘可扪及质坚硬、但无压痛。神经系统症状出现后肝脏则不能扪及,可为肝硬化萎缩,脾脏增大并可

扣及。⑧由于钙磷代谢障碍,患者骨骼疏松,易发生骨折。⑨实验室检查,尿铜增高;血清总铜量和血清铜蛋白量降低;血清铜氧化酶活性降低。本病应与震颤麻痹、继发性肝脑变性、酪氨酸血症、精神分裂症、扭转痉挛、多发性硬化、舞蹈病等病相鉴别。

祖国医学古代文献对本病缺乏系统阐述,但据其主要症状,似可归属于中医的“积聚”、“肝风”、“风痰”入脑等证候。中医学认为本病起于禀赋不足、肾精亏虚,继之肝血不足,终至火生风动,产生诸症。病位在肝肾脑,以肝为主。属本虚标实之证,肝肾精血不足为本,风、火、痰、淤为标,临证应细审详辨。肝郁化火用龙胆泻肝汤合泻心汤;脾胃虚弱择香砂六君子丸合藿朴夏苓汤;痰淤互滞选四逆散合膈下逐淤汤;肝肾阴虚用大补阴丸合大定风珠。

冯彦臣以益气熄风化痰法为主,基本方为黄芪、鸡血藤各20~30g,白芍、钩藤、乌梢蛇、丹参、僵蚕各15~20g,天竺黄、红花、当归、全蝎、川芎、制白附子各10g,胆南星4.5g,蜈蚣2~3条,甘草6g。治疗肝豆状核变性4例,结果治愈2例,显效1例,好转1例[河南中医,1985,(1):19]。

杨任民等用肝豆汤(大黄6g,黄连、黄芩各10g,鱼腥草、半枝莲、泽泻各20g)治疗肝豆状核变性107例,显效9例,好转81例,无效17例,总有效率达84.2%[中医杂志,1993,(11):676]。

赵政等对肝豆状核变性以肝风论治。肝阴不足、虚风内动,治以养阴柔肝熄风,药用生地黄、白芍、麦门冬、阿胶、鸡子黄、钩藤等。肝风内动、气血痹阻,治以平肝熄风、化痰和络,药用枸杞子、菊花、白蒺藜、生南星、丹参、赤白芍、钩藤、菖蒲等。肝风内动、痰热郁结,先治以健脾利湿化痰,药用陈皮、姜半夏、茯苓、生熟薏苡仁、砂仁、炒谷麦芽、炒山楂曲等;后治以养

阴清热、平肝熄风,药用菊花、桑麻丸、陈胆星、远志、钩藤、白蒺藜、苍术、生石膏、北沙参、女贞子、茯苓、丹参、当归龙荟丸等。肝肾阴虚、湿热内蕴、经络不利,治以清湿热、补肝肾、祛风通络,药用生石膏、生苍术、茵陈、桑寄生、女贞子、熟地、怀牛膝、菊花、菟丝子、玄参、桑枝、茯苓、当归龙荟丸等。共治疗7例,有5例已治疗近4年,病情持续保持缓解,从未复发,其中1例参加生产队劳动,4例上学,学习成绩中上[中医杂志,1982,23(9):675]。

【方名】 解毒排铜汤。

【组成】 黄连 12g,大黄 10g,半枝莲 20,土茯苓 40g,萆薢 30g。

【来源】 冯福海,全国中医药专科专病学术研讨会论文集,1995,8:181。

【功效】 清热解毒,利湿排铜。

【适应证】 肝豆状核变性。

【方药简析】 方中黄连、大黄清热燥湿、解毒通便;半枝莲、土茯苓、萆薢利湿排铜。心肾两虚、髓海不足型加柏子仁、杞果、红参各 10g,麦冬 12g,熟地黄、熟首乌各 15g,菖蒲 20g;肝血不足、血虚风动型加白芍 15g,生地黄 30g,五味子、川芎、天麻、制白附子、黑芝麻各 10g;当归 12g。

【病案举例】 李某,女,16岁。于2年前无明显诱因出现行走不稳、肢体震颤,学习费力,时哭时笑,月经闭止,曾在某医院按“肝豆状核变性”给予口服青霉胺治疗半年,症状无改善,且出现发热、药疹、肾病等不良反应,无奈求治于中医。诊见:头及肢体震颤,行走不稳,书写困难,哭笑无常,易怒,健忘,腹胀,右胁疼痛,月经闭止已2年,舌质暗,苔薄黄,脉弦细涩。化验:血清铜氧化酶活性 0.11 光密度,肝功能正常。辨证

属肝血不足、血不养筋、虚风内动。治以养血熄风。药用解毒排铜汤加炒白芍、黑芝麻各 20g,生地 30g,五味子、天麻、制白附子、红花、远志各 10g,当归、川芎各 15g,丹参 40g。加减治疗半年余,患者头及肢体震颤消失。复查血清铜氧化酶活性 0.23 光密度,随访 4 个月,症状未复发。

【方名】 二陈汤。

【组成】 半夏 15g,陈皮、茯苓各 10g,炙甘草 3g,生姜 3g。

【来源】 《太平惠民和剂局方》。

【功效】 燥湿化痰,理气和中。

【适应证】 湿痰诸症。

【方药简析】 方中以半夏为君,取其辛温性燥,善能燥湿化痰,且可降逆和胃而止呕;以陈皮为臣,理气燥湿,使气顺而痰消;佐以茯苓健脾渗湿,俾湿去脾旺,痰无由生;生姜降逆化饮,既可制半夏之毒,且能助半夏、陈皮行气消痰;使以甘草调和诸药,兼可润肺和中。

【病案举例】 李某,男,12岁,1984年3月29日收住院。1982年2月初起,皮肤逐渐变黑,半年后伴口角流涎,1年来双手不自主抖动,手指不能伸直,不能持物和书写,因学习成绩下降,言语含糊不清而辍学。1983年3月曾口服青霉胺,因先后两次出现肾炎而中止治疗。其兄有同样病史,19岁时死亡。检查:双眼角膜有 K-F 环,面具脸,“O”形腿,四肢肌张力呈铅管状增高,联合运动消失,血清铜氧化酶 0.01 光密度。诊见:神呆,脉滑,舌苔白如积粉,舌边尖紫红,呕恶,流涎,脐周疼痛,不思饮食。治拟芳香化湿,悦脾醒胃,方用二陈汤加厚朴、佩兰、藿香各 10g,砂仁、白蔻仁各 6g。服药 14 剂,肌张力减低至基本正常,手指可伸直,舌不红,苔薄白,言语转清。血

26

不安腿综合征

不安腿综合征,系指小腿深部于休息时出现难以忍受的不适,运动、按摩可暂时缓解的一种综合征。该综合征是由 Willis 在 1685 年首次记述,1945 年经 Ekbom 详细报道的。其发病机制及病因不明,尽管对症治疗的方法很多,但迄今为止尚无对因治疗措施。不安腿综合征的主要临床表现为:①不安,休息时常走来走去,或不停地搓腿,躺在床上时常翻来复去或摇动身体。②感觉异常,在休息尤其清晨与夜间时大腿深部有爬行样不舒感,常为双侧受累,迫使患者要经常活动其两腿。③睡眠中周期性腿动,为刻板地屈曲运动,在 6h 的睡眠中至少发生 40 次以上的腿动。④醒时不自主腿动,在卧位或坐位休息时常发生下肢的不自主屈曲运动。⑤睡眠障碍,由于感觉异常和腿动常导致患者失眠。⑥夜间加重,尽管白天休息时也可有感觉异常、腿动和不安等症状,但夜间有明显的加重趋势。⑦本病好发于老年人,有些患者有阳性家族史。⑧无阳性的神经体征。

不安腿综合征根据其临床表现似属中医躁证范畴,其病因病机多为劳损过度,或肝火素盛,或劳心思虑过度,导致气血不足,阴精亏虚,痰淤阻络所致。亦有因痰火扰心所致者。本病多为本虚标实之证,临床应辨虚实之主次,结合病机,在辨证(肝肾阴虚用左归丸,气血两虚用归脾汤,痰火扰心用黄连温胆汤)基础上,选用善于镇静安神的珍珠母、夜交藤、朱砂、琥珀以定志宁心,酌择百合、枸杞子、麦门冬增强疗效。

王德义等用活络效灵汤加味(当归 15~30g, 丹参 15~30g, 生乳香 9~12g, 牛没药 9~12g, 怀牛膝 9~15g, 薏苡仁 15~30g。风甚者, 苔薄白, 脉浮缓加防风、羌活、独活; 偏寒者, 苔白腻, 脉濡缓, 加防己, 苍术)治疗不安腿综合征 30 例, 显效 18 例, 有效 8 例, 无效 4 例, 总有效率 87%[中医药研究, 1992, (3): 54]。

尚礼俭在应用芍药甘草汤的基础上, 合用二至丸加味治疗不安腿综合征 25 例, 结果全部治愈。基本方: 白芍 50g, 甘草 10g, 女贞子 20g, 旱莲草 18g, 丹参 30g, 木瓜、怀牛膝各 15g。随症加减: 失眠多梦加酸枣仁、龙骨、牡蛎、夜交藤; 心悸、气短加黄芪、党参、当归、柏子仁; 苔黄腻加苍术、黄柏、滑石、薏苡仁[浙江中医杂志, 1991, (2): 78]。

李广振等用四妙丸加味治疗不安腿综合征 13 例。基本方: 苍术 10g, 黄柏、川牛膝各 15g, 汉防己 15g, 薏苡仁、忍冬藤各 30g, 车前子 12g。结果治愈 9 例, 显效 3 例, 有效 1 例[江苏中医, 1992, (9): 24]。

吴作敬等以真武汤加味: 附子 10g, 白芍、龙骨、牡蛎各 30g, 白术、茯苓、钩藤各 15g, 全蝎、生姜、甘草各 6g。气虚加黄芪 30g, 党参 15g; 血虚加鸡血藤 20g, 何首乌、当归各 15g; 肾虚加桑寄生 30g, 续断、杜仲各 15g。治疗不安腿综合征 25 例, 治愈 15 例, 显效 8 例, 无效 2 例[实用中医内科杂志, 1992, (2): 42]。

李中海等以止痉散方: 蜈蚣 2 条, 全蝎 4g, 研细末装胶囊为 1 日量, 分 2 次内服, 治疗不安腿综合征患者 5 例, 结果痊愈 3 例, 2 例好转[浙江中医杂志, 1991, (11): 497]。

【方名】 芍药甘草汤加味。

【组成】 白芍 30g, 甘草 10g, 赤芍 20g, 丹参 30g, 红花

锥刺患处皮肤直至流血。半年后痛及手背,每月发作6~7次至十数次不等,每次持续1~2h,痛止后如常人。苔薄白,脉细数。予甘麦大枣汤加生龙骨20g,生地黄、麦门冬、茯神各9g,白芍、柏子仁、桑叶各6g,柿蒂3g,生姜3片,朱砂1g。用药7天,诸症大减,继服中药40剂,痊愈[余保红,浙江中医杂志,1987,(10):447]。

【方名】 逍遥散加味。

【组成】 柴胡、当归各10g,白芍25g,地龙15g,川牛膝、茯苓、白术各12g,生牡蛎30g,全蝎3g。

【来源】 王卫平,国医论坛,1995,53(5):35。

【功效】 疏肝解郁,舒筋活络。

【适应证】 不安腿综合征。

【方药简析】 方中逍遥散疏肝解郁以治其本,另用全蝎、川牛膝、地龙舒筋活络、熄风止痉以治其标,生用牡蛎安神镇静,亦即《素问》“阳气者,精则养神,柔则养筋”之意。偏气虚加黄芪;血虚重用当归,加熟地、黄精;兼脾虚纳呆加焦三仙;阳虚加枸杞子、巴戟天;兼风寒湿滞者去当归、白术,加独活、路路通;兼痰湿者去当归,加半夏、陈皮。王卫平用该方加减治疗不安腿综合征10例,治愈(临床症状完全消失,自我感觉良好)2例;好转(双下肢不适感明显减轻,或仅遗留足心酸麻不适感)7例;无效(临床症状未见明显改善)1例,总有效率90%。

【病案举例】 孙某,女,41岁,1994年2月24日就诊。患者2月前无明显原因出现双下肢麻木、爬虫样感觉,需经常揉按未缓解。近半个月症状加重,需不断摆动左腿以期缓解,伴头晕、头颈部摇动。发病时心烦,恶闻人声,不欲言语,用镇静剂亦不能缓解。平素食欲不振,大小便尚调。诊见神情烦躁,

语言流利但不能完整叙述病史,头部、左下肢不断摆动,步态不稳,舌质淡,边有淤斑,脉沉细。诊为不安腿综合征,治以疏肝解郁、活血通络、熄风止痉为法。投逍遥散加味再加焦三仙各10g,丹参15g。服药3剂后,患者饮食增,右下肢麻木感稍减轻,余症同前。效不更方,继进上方12剂后,双下肢不适感明显减轻,左下肢及头部偶有摆动,转移其注意力可使摆动止。上方去全蝎,加木瓜20g。继服7剂后诸症大减,仅遗留左足心麻木感,于同年3月28日好转出院。出院后继以丸药调理脾胃1月,如常人,随访半年未发。

【方名】 加味知柏地黄汤。

【组成】 生地黄、茯苓、当归、鳖甲、鹿角霜各15g,山茱萸、知母、怀牛膝各10g,丹皮、生山药、泽泻各20g,赤芍、白芍各12g,黄柏6g,葛根30g。

【来源】 韩清等,河南中医,1995,(5):307。

【功效】 滋阴清热,通络除烦。

【适应证】 不安腿综合征。

【方药简析】 方中知柏地黄汤滋阴清热;当归、赤芍、白芍养血活血;鳖甲、怀牛膝、鹿角滋阴补肾;葛根解肌生津。

【病案举例】 周某,女,41岁,以双下肢烦困不适2月余为主诉于1993年5月19日入院。2个月前出现双下肢膝关节以下烦热酸胀,沉困不安,时感肌肉掣疼,得凉则减,入夜加重,辗转反侧不能入睡,故要求住院治疗。查体:体温37.2℃,脉率86次/min,呼吸22次/min。轻度贫血貌,神经系统检查无异常。诊为不安腿综合征。刻下证:身倦乏力,腰膝酸软,午后低热,面色潮红,五心烦热,夜间双下肢灼热酸胀,烦困不安,得凉则减,时头汗出,口干不欲饮,舌质红,苔薄黄,根部略腻,脉虚细而数。证属阴虚内热,络脉失和。治以滋阴清热,通

络除烦。方用加味知柏地黄汤。加减进退 15 剂后,下肢酸胀疼痛烦困消失,夜间能安静入眠。继以知柏地黄丸每日 2 丸,早、晚各 1 丸巩固治疗 1 个月,追访年余病情无反复。

【方名】 舒筋安腿汤。

【组成】 当归、白芍各 12g,吴茱萸、甘草各 9g,乳香、没药各 6g,伸筋草 18g,丹参、千年健、川牛膝各 15g。

【来源】 周亚彬等,四川中医,1995,(2):25。

【功效】 柔肝补肾,舒筋活血。

【适应证】 不安腿综合征。

【方药简析】 方中以当归活血和血,白芍养血敛阴,配甘草具有活血柔肝止痛之效;吴茱萸取其散寒温中燥湿解郁之功;伸筋草舒筋通络,祛风止痛,千年健强筋壮骨,两药相合是治手足拘挛之要药;配川牛膝活血祛瘀,补肝肾而强筋骨;乳香、没药相须为用,合丹参增强活血止痛之效。全方标本兼治,以柔肝补肾,舒筋活血,蠲痹解痉,强筋壮骨,通络利脉于一体,用治不安腿综合征最合其病机。伴腰痛加杜仲、桑寄生各 12g;下肢有灼热感去吴茱萸,加丹皮、黄柏各 9g;下肢畏寒加菟丝子、制附子各 9g。周亚彬等用该方加减治疗不安腿综合征(5 剂为 1 个疗程)34 例,8 例治愈(两小腿症状消失,夜间能安然入睡);20 例显效(症状明显减轻,夜能入睡);4 例好转(症状减轻,睡时发作时间缩短);2 例无效(治疗 3 个疗程症状无改善)。总有效率为 94.12%。

【病案举例】 黄某,女,1989 年 3 月 2 日初诊。诉两年来每当休息时,双下肢相继自小腿及足背之间出现麻木、疼痛,似有蚁行感。近日来症状加重,两小腿伴有烧灼感,难以忍受,用手拍打或下地活动后略感轻松,已数夜通宵不寐。诊见:痛苦面容,精神疲乏,两小腿及足背部皮肤未见异常,神经生理

反射均正常。舌淡边有齿痕，苔薄白，脉沉弦细。遂拟舒筋安腿汤加味。服6剂后，诸症悉平。1年后随访，未见复发。

【方名】 桂枝新加汤。

【组成】 桂枝 15~30g，白芍 20g，大枣 5枚，甘草 6g，生姜 9g，人参 10g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 祛风散寒，益气养血，调和营卫。

【适应证】 不安腿综合征等。

【方药简析】 方中桂枝汤祛风散寒、调和营卫。加入参益气养血、固表实卫。诸药共具益气养血、活血和营之功。

【病案举例】 徐某，男，48岁。患者于1989年12月患感冒后，双小腿肌肉出现灼痛、肿胀，触之痛甚，行走时及夜间加剧，3个月后出现夜间双小腿肌肉痉挛，心烦意乱，夜不能寐，痛苦不堪，4个多月内体重竟下降10kg。经腰穿、椎管内造影、免疫及神经系统等检查，均未发现异常。诊断为“不安腿综合征”。患者面色不华，神疲，汗出，纳少，舌质紫暗、苔薄白，脉弦细数。证属营卫不和，气滞血淤，筋脉失养，用桂枝新加汤加黄芪30g，当归、川芎、延胡索各20g，桃仁10g，汉防己12g。药进3剂，疼痛减轻，余症缓解，夜可入睡。守原方再进9剂后症状及体征完全消失，随访1年未复发[吕丽，中医杂志，1992，(5):278]。

【方名】 桃红四物汤。

【组成】 熟地黄 15g，川芎 8g，白芍 10g，当归 12g，桃仁 6g，红花 4g。

【来源】 吴谦等，《医宗金鉴》。

【功效】 养血，活血，逐淤。

【适应证】 瘀血内停诸症。

【方药简析】 方中四物汤养血活血，加桃仁、红花并入血分而逐瘀行血。

【病案举例】 王某，男，58岁。1992年5月2日初诊。患者自述近半年来每到夜间就觉得小腿深部肌肉有一种难以言状的不适感，即酸痛、困胀、沉紧、发麻，有时自觉奇痒难忍，犹如无数蚂蚁在小腿深部爬行，捶捶揉揉或下床活动后可暂时缓解，但很快症状复现，西医诊为“不安腿综合征”，曾服用各种西药无效，遂来我科应诊。诊见：精神疲倦，面黄肌瘦，愁眉不展，双下肢不红不肿，皮肤粗糙。舌质淡，苔薄黄，边尖有瘀血点，脉沉涩。证属血虚挟瘀。治宜养血补虚、活血化瘀。方用桃红四物汤加鸡血藤、木瓜各30g，怀牛膝20g，炙甘草10g。连服10剂，症状悉除[医学科普，1995，(1)：40]。

27 多发性动脉内膜炎

多发性动脉内膜炎又称大动脉炎或缩窄性大动脉炎。为主动脉及其分支的慢性、进行性、且常为闭塞性的、非特异性炎变,造成狭窄或闭塞。因病变侵犯的部位不同,临床表现亦不同,其中以头和臂部动脉受累引起的上肢无脉症最多见,其次为降主动脉、腹主动脉受累引起的下肢无脉症。过去所指的无脉症、主动脉弓综合征、不典型主动脉狭窄、慢性锁骨下动脉-颈动脉梗阻综合征,或主动脉弓分支血栓闭塞性脉管炎等,即指本病而言。本病多见于女性青少年。据国内报告,女性占 65% 以上,发病年龄 5~45 岁,而以 30 岁以内发病占 90%。多发性动脉内膜炎活动期有发热、全身不适、食欲不振、出汗、面色苍白,或有关节炎、结节红斑等。头臂动脉型,由于主动脉和椎动脉狭窄或闭塞,引起脑缺血症状:头晕、头昏、头痛、记忆力减退、视力减退、视野缩小、甚至失明,咀嚼时肌肉疼痛等,少数患者尚有鼻中隔穿孔、齿摇发落,上颌及耳壳溃疡,面部萎缩,角膜混浊、虹膜混浊和白内障等。上肢缺血可出现单侧或双侧上肢乏力、发凉、酸痛、麻木等。胸、腹主动脉型,由于下肢缺血而无力、发凉、酸麻、易疲劳及间歇性跛行等症状。上肢血压持续增高,可有高血压的各种症状,甚至心力衰竭。波及冠状动脉时会发生心绞痛或心肌梗死;肾动脉型,有持续、严重而顽固的高血压,以及由高血压引起的各种症状;混合型(广泛型)比较多见,约占 40%,为广泛、多发性病变,病情一般比较严重。本病应与先天性动脉缩窄、动脉粥样硬

化、血栓闭塞性脉管炎等病相鉴别。

多发性动脉内膜炎属于中医头痛、眩晕、发热、中风、脉痹、伏脉、无脉等范畴。本病症状多种多样与其病因复杂有关。外邪侵袭,尤其是寒邪为患,寒为阴邪,伤人阳气,阻碍气血运行,使筋脉收缩,脉微欲绝。也有因为热邪,郁热极深,反见假寒之象,脉涩滞之甚,但伏而非伏。另外气滞血淤或气虚血淤,引起的剧烈疼痛,可以有血脉不通,出现伏脉,称之为痛极则脉伏,痛止则脉出。说明血淤血脉不通,则发为无脉症。当血液流通后,脉可复出。寒凝、热邪为本病的发病原因,气虚、阳虚为本病的内在原因,而七情、饮食、气候变化为本病的诱因。本病症状复杂,病情多变,辨证当抓住血脉不通、血淤为主要矛盾。但其本质为虚证,以心肾阳虚为主,然有部分患者久病阴阳俱虚,阴虚生内热,有热象。郁热极深时,有假寒之象,当需鉴别。治疗则先滋阴清热通络以治标,然后再顾及病之根本,在辨证(心肾阳虚用四逆汤,阴虚发热用青蒿鳖甲汤,肝阳上亢用龙胆泻肝汤,风湿热痹用小活络丹合白虎加桂枝汤,气滞血淤用桃红饮)基础上,选用善于破血行淤的虻虫、水蛭、穿山甲等逐淤通脉,酌择鸡血藤、桂枝、制附子以增强疗效。

殷德燧用补阳还五汤加味治疗多发性动脉内膜炎 6 例,3 例临床治愈,2 例明显改善,1 例有改善[浙江中医杂志,1981,(9):396]。

王春荣等用黄芪桂枝五物汤加减(黄芪、党参各 30g,桂枝、桃仁、红花各 10g,赤芍 15g,鸡血藤、地龙各 20g)治疗多发性大动脉炎 34 例,显效 12 例,有效 17 例,无效 5 例,总有效率 85.3%[甘肃中医,1992,(1):20]。

陈敏等将多发性大动脉炎分为湿毒阻络、心脾两虚淤血阻络、脾肾阳虚寒凝血淤、肝肾阴虚风痰阻络四个证候。湿毒阻络用新加四妙四物汤加减(金银花、连翘、牛膝、薏苡仁、川

减轻,身觉有力,右侧桡动脉搏动较前有力,上方加桂枝20g,继服50例,诸症消失。

【方名】 通脉饮。

【组成】 桃仁、红花、赤芍、当归、苏木、莪术、炮穿山甲各10g,丹参、黄芪、地龙、生地黄各20g,川芎、麝虫各5g。

【来源】 杨林,吉林中医药,1989,(6):7。

【功效】 活血化淤,益气化痰通脉。

【适应证】 多发性大动脉炎中期。

【方药简析】 方中用桃红四物汤养血活血为基本方,再配苏木、麝虫、莪术峻烈逐淤,合炮穿山甲搜风活络,使淤去新生,再佐黄芪、地龙益气化痰。

【病案举例】 郑某,女,22岁。主诉以左上肢酸痛、发麻、末冷2年余,诊为无脉病,经泼尼松、肠溶阿司匹林治疗2年,效果不显。刻诊:左上肢麻木,酸痛发冷,头晕而痛,眼前时而发黑,心慌胸闷,舌质紫黯,苔白,脉左寸关尺均无,右寸关尺沉伏。查体:左侧桡动脉搏动消失,血压测不到,左上肢体温33.7℃;右侧动脉血压、体温均正常。心电图示:左室劳损,诊为无脉病(多发性大动脉炎),此属淤血痹阻心脉血络所致。治拟活血化淤、益气通脉,方用通脉饮加桂枝10g,三七6g,水煎服,日1剂,分3次口服。连服68剂,左上肢酸麻胀痛均除,肢体转温,头晕痛好转,左侧桡动脉可扪及搏动,左上肢测血压14/7.5kPa,体温上升至36.2℃,继用上药加减间断服用32剂,随访5年未复发。

【方名】 温脉饮。

【组成】 熟地黄、鹿角胶、肉桂、干姜、骨碎补、当归、白芥子各10g,黄芪、地龙、丹参各30g,水蛭2g,甘草5g。

【来源】 杨林,吉林中医药,1989,(6):7。

【功效】 温阳通脉,益气活血。

【适应证】 多发性大动脉炎晚期。

【方药简析】 熟地、鹿角胶、滋阴填精;肉桂、干姜、白芥子温阳化痰通脉;骨碎补温补肾阳;黄芪、地龙、丹参、水蛭益气化瘀通脉;甘草调和逐瘀药之峻猛之性。

【病案举例】 曹某,女,32岁,1968年3月5日入院。双上肢麻木软弱无力5年余,当时误为劳累所致,未加介意,相继出现头晕眼花、气短乏力,易于外感,畏寒肢冷,四肢关节疼痛,腰背酸软,双上肢脉搏消失,血压难以测到,诊为多发性大动脉炎(混合型)。刻下:面色苍白,口唇紫绀,形体消瘦,畏寒肢倦,步态蹒跚,四肢酸痛,苔白,四肢无脉。查体:体温36.2℃,心率86次/分,血压测不到,左侧桡、肱、腋、颈、颞动脉搏动减弱,右侧消失,两侧颈部、锁骨上窝及胸锁乳突肌外有连续性杂音。心电图示:左室劳损,房性早搏。证属气阳大伤,心脉痹阻。治拟益气温阳,活血通脉,方用温脉饮加红参、附子各10g,水煎服。20剂后诸症渐平,上药获效。后主药不更,随证加减,继服3月,四肢血压稳定在14~17/7.5~8.5kPa。两侧脉搏缓和有力,余症悉除,心电图恢复正常。

【方名】 四妙勇安汤。

【组成】 当归20g,玄参30g,金银花50g,甘草6g。

【来源】 鲍相傲《验方新编》。

【功效】 清热化瘀通络。

【适应证】 多发性大动脉炎,脉管炎。

【方药简析】 方中当归养血活血;玄参滋阴清热;金银花清热解毒;甘草调和诸药。黄晓明用该方加减治疗多发性大动脉炎2例,均痊愈。

【病案举例】 陈某,男,49岁。因左侧肢体麻木伴左上肢发冷半年,发现左手无脉1月,于1987年4月27日入院。查体:自动体位,左手无脉,肤温低于右手,右手及两下肢足背脉搏可扪及。血压:左上肢0,右上肢13/7kPa,左下肢19/11.9kPa,右下肢15/12kPa。浅表淋巴结未及,轻度桶状胸,心界不大,心率100次/min,律齐,未闻及病理性杂音,肝脾未及。四肢关节无红肿畸形。化验:血沉2mm/h,抗“O”正常,类风湿因子阴性,抗核因子阴性,狼疮细胞阴性。患者心烦口苦,尿赤便艰,舌红苔黄。证属热壅血淤,脉络闭阻。治宜清热通络,活血化淤,四妙勇安汤加忍冬藤、蒲公英、生地黄、虎杖根、鸡血藤、薏苡仁各30g,丹参60g,黄柏、川芎、桃仁、王不留行各15g,红花9g,牛膝18g。服10剂,左手脉搏可及,肢麻减轻,血压右上肢13.5/8kPa,左上肢8.5/7kPa,原方减虎杖根、蒲公英、鸡血藤加桑枝30g。治疗1月,诸恙渐愈而出院。[黄晓明,浙江中医杂志,1987,(10):462]。

【方名】 当归四逆汤。

【组成】 当归12g,桂枝、白芍各9g,细辛1.5g,甘草5g,通草3g,大枣8枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 温经散寒,养血通脉。

【适应证】 多发性大动脉炎。

【方药简析】 本方是桂枝汤去生姜,倍大枣,加当归、细辛、通草而成。当归苦辛甘温,补血活血,与白芍合而补血虚;桂枝辛甘而温,温经散寒,与细辛合而除内外之寒;甘草、大枣之甘,益气健脾,既助当归、白芍补血,又助桂枝细辛通阳;更加通草通经脉,使阴血充,客寒除,阳气振,经脉通,手足温而脉亦复。

【病案举例】 马某,女,40岁,1985年11月6日诊。患者素有眩晕、头痛、健忘。近2月感双上肢麻木冷痛,左手持物困难,伴视物模糊,阵发性昏厥。检查:面色苍白,形体消瘦,四肢发凉,舌质淡,苔薄白,颞动脉及双侧桡动脉搏动消失,两侧颈部及锁骨上区可听到连续性杂音,心肺正常。双上肢血压为0,双下肢血压24/9kPa。眼底检查:双视乳头苍白,视网膜动静脉相互吻合,末梢血管闭塞。诊为多发性大动脉炎。此为素体血虚,复感寒邪,客于经脉,气血淤滞不通所致。治以温经散寒,养血通脉,方用当归四逆汤加味:当归、桂枝、白芍、制乳香、没药各15g,木通10g,细辛5g,大枣5枚。服药半月,眩晕头痛大减,无昏厥发作,右寸口脉微细可及。原方加黄芪、鸡血藤各15g;又服半月,双上肢麻木疼痛基本消失,肢末转温,两寸口脉沉细弱。效不更方,继服40剂,症状全部消失,脉象调和,左上肢血压12/8kPa,右上肢血压15/9kPa,眼底改变基本复常。出院后随访1年余,病未复发[陈治水,四川中医,1987,(12):27]。

【方名】 加味生脉散。

【组成】 红参、山药、桂枝各15g,麦门冬30g,葛根25g,五味子5g,丹参20g,半夏、甘草各10g,大枣12枚。

【来源】 王永发,四川中医,1990,(6):34。

【功效】 益气养阴,理血通脉。

【适应证】 多发性大动脉炎。

【方药简析】 方中重用麦门冬润肺养胃,兼清阴火;红参、甘草、山药、大枣益气养胃;半夏降逆平冲;葛根生津止渴解肌,又有活血之妙;桂枝、丹参益气养血,通利脉道,去淤生新。全方补气兼理血,益阴兼扶阳。

【病案举例】 高某,女,37岁,1987年6月5日诊。3年

多发性大动脉炎,曾用中西药治疗,效果不显。诊见:眩晕,晨起尤甚,四肢不温且麻木,面色苍白,形体消瘦,舌淡苔白,脉极细而微。血压:双上肢测不到。证属阳虚寒凝,致血不上荣,选用阳和汤原方。服药6剂后,眩晕减轻,面色好转,四末转温,脉细,右上肢血压:8.0/5.5kPa,左上肢血压:5.3/3.5kPa。原方加黄芪15g,当归15g。服药月余,已无眩晕,面色红润,四肢温暖无麻木,舌淡少苔,脉缓有力,右上肢血压:12/8kPa,左上肢血压:13/7kPa,随访2月,未见复发[孙旗立,实用中医内科杂志,1987,(1):14]。

28

重症肌无力

重症肌无力是一种神经肌肉接头处传导障碍为主的自身免疫性疾病,以横纹肌的异常易疲劳为特点,经休息或给予抗胆碱酯酶药物后,可有一定程度的恢复;发病率约为2~5人/10万。本病的发病原因至今仍不清楚,最新研究认为本病是一种在特定遗传素质的个体中,可能由于病毒或其他非特异性因子感染胸腺后,导致胸腺内肌样上皮细胞的nAChR致敏,产生循环抗体,经体循环,并在补体激活和参与下,破坏突触后膜,导致突触后膜溶解、破坏、AChR数目减少和突触间隙增宽等形态学改变和肌无力症状的发生。本病任何年龄均可发病,女性略多于男性,国内肌无力病人,14岁以下的儿童约占15%,成年病人第一个发病高峰为20~30岁,以女性为多,第二个高峰为40~50岁,男性多见,常伴有胸腺肿瘤。全身所有骨骼肌包括眼外肌、面肌、延髓肌、颈肌和肢带肌均可受累,但以颅神经支配肌(眼外肌、面肌、延髓肌)受累较脊神经支配肌更为多见。受累骨骼肌病情常有波动,朝轻夕重,疲劳加重。疾病早期可自发缓解与复发,晚期病人运动障碍较严重,虽经休息也不能完全缓解。成人常从一组肌肉无力开始,在1年至数年之内逐步累及其他肌群。眼外肌受累为首发症状者最为常见,表现为一侧或双侧眼睑下垂,常出现复视,经1夜休息后晨起症状可消失或缓解,活动以后再度加重。肢体受累时,下肢较上肢重,近端较远端重;谈话过长后则声音低哑,构音不清,并带鼻音,咀嚼及吞咽障碍;重症患者可

因呼吸肌麻痹及继发肺炎而死亡；受累肌群肌力减弱，四肢腱反射消失、减低或正常，但无感觉障碍。根据发病年龄，病变波及部位和轻重程度不同，临床分以下几型：成人型（①眼肌型 眼睑下垂，眼外肌运动麻痹，复视或眼球固定等，进展缓慢，最终波及全身；②延髓肌型 构音不清，吞咽困难，进食呛咳，咀嚼无力，闭嘴不紧；③脊髓型 上肢或下肢无力，两臂上举困难或起蹲不便，进而不能梳头，颈部竖直无力；④全身型 一开始即为全身骨骼出现不同程度的运动障碍。若有胸腺瘤，进展快，不宜控制。）、新生儿重症肌无力（为特殊类型，女病人之婴约10%~20%因含抗Ach抗体的IgG经胎盘输入胎儿，产生一时性重症肌无力。多在出生时或几小时内发病，表现肌张力低，哭声低，吸吮无力，动作少，严重时呼吸困难。一般在1~7周内痊愈，轻型者不必治疗）、儿童重症肌无力（约100%以眼肌受累为主，病情时轻时重或左右交替，有部分患者的症状能自行缓解）及先天性重症肌无力（患儿母亲无病，但有家族史倾向，表现为眼外肌型，有的出生1周发病，药物治疗效差，部分为永久麻痹）。各型患者可因感染、精神刺激、停药或用药过量、分娩及手术等因素诱发，骤然加重的严重全身无力和呼吸肌麻痹时，称为危象，常危及生命，死亡率为40%~44%，危象发生率为24.6%~26.7%。临床分为：①肌无力危象（由于疾病发展而抗胆碱酯酶药用量不足），此型最多见；②胆碱能危象（抗胆碱酯酶应用过量）；③反拗性危象（抗胆碱酯酶药突然失效），本病的诊断比较明确，若可疑时可做肌疲劳、新斯的明、重复电刺激等试验。但也需与眼肌营养不良症、运动神经元疾病、感染性多发性神经根炎、肌无力综合征、眼外肌麻痹相鉴别。本病治疗主要用抗胆碱酯酶药物，吡啶斯的明或美斯的明。若效果不佳可配合免疫抑制剂，如泼尼松或ACTH，或环磷酰胺或硫唑嘌呤，但应注意白细胞的

下降。若伴有胸腺瘤可采用胸腺切除术或胸腺放射治疗。出现危象时应及时抢救。治疗本病期间应禁用或慎用链霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素及多粘菌素 B 等氨基糖甙类和多粘菌素类抗生素,吗啡、巴比妥类抑制中枢神经系统,加重呼吸障碍的药物、奎尼丁、普鲁卡因酰胺、利多卡因、心得安等可降低肌膜兴奋性或抑制神经肌肉传递的药物,防止加重肌无力。

重症肌无力根据临床表现不同分属于中医睑废、胞睑下垂、歧视、噎证(吞咽困难)、大气下陷(呼吸困难)的范畴。多数人认为病本在脾胃,波及五脏,病性以虚为主,病位在肌肉;大多分为中气不足用补中益气汤,胃阴不足用玉女煎,肝肾亏虚用杞菊地黄汤合八珍汤。当代著名老中医邓铁涛提出本病辨证分型不必过杂,应抓住主证,兼顾五脏;其本质不是一般的脾胃气虚,而是由虚致损的虚损病;损及五脏,可向纵深发展,伤肝则肝血不足,目窍失养而致复视、斜视;肾为胃关,伤肾则致吞咽困难;损及肺肾,可致扬音不清乃至气息断续,危在顷刻。刘弼臣等将本病分为中气下陷用中益气汤,脾虚湿困用六君子汤加味,波及肝肾用杞菊地黄汤合牵正散治疗小儿重症无力 21 例,显效 7 例,有效 12 例,无效 2 例,总有效率 90.5%,服药时间为 26~146 天,平均 85.5 天[中医杂志,1985,(10):763]。

陈贯一提出肌无力并无风邪,也非“血虚生风”,虚证无“风”,而若长期用中药祛风熄风通络,则是诛罚无辜,故不宜用治痹中药,如白附子、附子、桂枝、干姜、鹿角、全蝎、白花蛇、地鳖虫、穿山甲、羚羊角等。故将本病分为肝肾阴虚型(六味地黄丸加减)、脾胃气虚(六君子汤加减),气血两亏型(八珍汤加减),共治疗 371 例,眼肌型 243 例,痊愈 145 例,基本痊愈 24 例,好转 9 例,无效 65 例;躯干型 93 例,痊愈 53 例,基本痊愈

8例,好转7例,无效25例;全身型34例,痊愈13例,基本痊愈2例,好转4例;延髓肌型1例,无效。治愈病例44例复发,经再次治疗绝大多数仍治愈。[浙江中医杂志,1988,(2):64]。

李庚和通过对432例重症肌无力患者(男179例,女253例。首诊年龄9个月~80岁,平均35.2岁,首诊病程4天~25年,平均3.5年,按改良的Osseman分型:I型232例,占53.7%,II型97例,占22.5%,III~IV型103例,占23.8%)。进行疗效分析并结合辨证分型发现,脾气虚型多见于单纯眼肌型(I型占75.9%),症见食欲不振,大便烂软不实,舌胖苔薄,脉细,宜补气健脾。脾肾气阴虚型多见于全身型(II~IV型86%),表现为全身乏力,吞咽咀嚼困难,伴有复视,舌尖红或苔剥干毛,脉细数,宜益气滋肾。脾肾阳虚型多见于全身型或延髓型(II~IV占98%),显著怕冷、憎寒、便溏,腰酸,吞咽明显困难,全身极度乏力,舌边齿痕,苔薄质淡,当温阳益气。治疗结果表明,I型及脾气虚弱效果较好,II~IV型的脾肾气阴两虚型效果次之,脾肾阳虚型再次之。年龄较小18岁以下者效果最好。同时李氏主张通过防治感冒、感染,调理月经,避免劳累,积蓄体力,调节情绪,避免在患者特定反应季节或季节交替敏感时期变动治疗措施、药物剂量等,把影响疗效的不利因素降低至最低限度,从而提高本病的疗效[上海中医医药杂志,1987,(12):2]。

袁长新用益气复元煎(红参、黄芪、白术、升麻、柴胡、枳壳、贯众等组)治疗重症肌无力27例,治愈19例,有效5例,无效3例[江苏中医,1993,(8):15]。

【方名】 强肌健力饮。

【组成】 黄芪60g,五爪龙10g,党参20g,白术15g,当归

15g,升麻 6g,柴胡 6g,陈皮 9g,甘草 6g。

【来源】 邓铁涛,中国医药学报,1993,(2):42。

【功效】 补脾益气,强筋健力。

【适应证】 重症肌无力。

【方药简析】 本方(原文中无份量,用量为编者所加)源于李东垣补中益气汤,邓铁涛根据重症肌无力的病机根本是脾胃虚损,波及五脏,故变东垣用药偏轻,旨在升发脾阳,补益中气,健运脾胃之法,而重用补气之品,加上岭南五爪龙,为强肌健力饮。方中重用黄芪,甘温大补脾气为君,五爪龙粤人称为“南芪”,与黄芪南北呼应,功能补脾益肺,生气而不助火,与党参、白术同助黄芪,加强补气之功;因血为气母,故用当归以养血生气,与上3药共助黄芪为臣。脾虚气陷,故用升麻、柴胡司升阳举陷之职;脾虚失运,且重用补气之品,则须防滞气,故用陈皮以反佐,达理气消滞之目的,与升柴共为佐药;甘草和中,调和诸药,任使药之职。本方虽在补中益气汤中只增设五爪龙一味,其益气强肌之力倍增。若复视斜视者,可加何首乌养肝血,或加枸杞子、山茱萸同补肝肾;抬颈无力或腰脊酸软者加枸杞子、狗脊以补肾壮骨;腰酸、夜尿多者加杜仲、桑螵蛸固肾缩泉;畏寒肢冷者加巴戟天、淫羊藿以温壮肾阳;吞咽困难者,以枳壳易陈皮,加桔梗一升一降,以调气机;口干、舌苔花剥者,加石斛以养胃阴;舌苔白厚或白浊,加茯苓、薏苡仁以化湿;咳嗽痰多者,加紫菀、百部、橘络以化痰;夜寐多梦,心烦失眠者,加炒酸枣仁、夜交藤养心宁神。同时邓氏强调,本病因虚损难复,故缠绵难愈,容易反复,亦易反复,治疗不宜随便更弦换辙,即使是临床痊愈后,还需坚持服药2年左右,方能根治。邓氏自91年至93年间共用上方加减治疗本病126例,其中男性68例,女性58例;年龄最小者2岁,最大者71岁;病史最短不足1个月,最长达30余年。属眼肌及少年型48例,

1992年初停药中药3月,此间曾患感冒、泄泻、痢疾,均未诱发肌无力。为防复发,其家长遵嘱继续令服上方巩固疗效,追踪至今,病无复发。

例二:胡某,女,23岁。主诉周身软弱无力,吞咽困难,上眼睑下垂,复视9个月。患者于1987年患类风湿关节炎,关节痛4年。1990年12月上旬自觉四肢无力,极易疲劳,不能梳头穿衣,下蹲无力站起,咀嚼无力,上眼睑下垂,复视。于25日在新疆库尔勒市273医院神经内科住院治疗。检查:新斯的明试验两次均为阳性,肌肉疲劳试验阳性,肌力Ⅲ~Ⅳ级;胸部CT未见胸腺瘤,心、肝、脾、肾B超检查均未见异常, T_3 、 T_4 检查正常。诊断为:①全身型重症肌无力;②类风湿性关节炎(缓解期)。口服新斯的明,每天3次,每次15mg及中药煎剂(药物未详)等。治疗3月,肌力仅有轻度增强。来信要求函诊治疗。信中附有该院中医诊查之舌、脉象,舌红少苔,脉尺沉寸弱。辨证为气阴两虚,脾肾不足,予强肌健力饮,选加紫河车、石斛、生地黄、枸杞子、何首乌、茯苓、山茱萸等2、3味随证加减。每天1剂,服药20天后,能自己梳头,下蹲能立起;仍服吡啶斯的明每天3次,每次1片。服药4月后生活完全自理,吡啶斯的明减量一半。1992年4月患者已恢复上班,吡啶斯的明只服原来的1/3量。7月31日起已完全停药吡啶斯的明,上班半年,病无反复,生活如常人。嘱其继续服中药巩固治疗。

例三:荣某某,男,71岁。患者于1989年11月因眼睑下垂,吞咽困难,全身肌肉无力在开滦矿务局总医院确诊为重症肌无力、陈旧脑梗死、脑萎缩并住院治疗。1990年7月发展为呼吸肌无力,连续两次出现呼吸、心跳骤停。经西医抢救,行气管切开、输血等病情缓解。于1990年11月24日出现黄疸、肝功异常、HBsAg阳性,诊为急性黄疸型肝炎。经中西医结合治疗肝功基本正常。肌无力症状靠呼吸机及吡啶斯的明(早90mg,

午 90mg,晚 75mg,0 时 75mg)维持。1991 年 3 月派人来穗索方,遂予强肌健力饮加巴戟天、枸杞子、人参(另炖兑服),每天 1 剂。1 月后,颈肌无力情况明显改善,但咀嚼及吞咽仍费力,进食时呛咳。以后数月参考每次复信中该院中医的舌诊、脉诊,在原方基础上,曾选加浙贝母、茯苓、何首乌、薏苡仁、枳壳、鸡血藤、淫羊藿等药 2、3 味加减治疗。1991 年 12 月 20 日该院中医科主任来信告知,患者病情稳定,全身状况及肌力逐渐恢复,能自行走 50m 左右,每天坚持户外活动 1h 以上。1992 年 4 月 14 日拔除气管插管。7 月 9 日该院来函,每天户外活动 3h 左右,自行走 200m 距离。现仍继续通信治疗。

【方名】 补中气滋肾汤。

【组成】 党参 12g,白术 10g,茯苓 10g,炙甘草 5g,黄芪 15g,当归 10g,陈皮 5g,升麻 5g,桔梗 5g,薏苡仁 12g,蚕砂 10g,枸杞子 12g,菟丝子 12g。

【来源】 刘光宪,湖南中医杂志,1988,(3):8。

【功效】 健脾渗湿,补肾益气。

【适应证】 重症肌无力眼肌型。

【方药简析】 重症肌无力的病机为肾气虚,肤腠疏松,筋脉弛缓,邪气乘虚而入,或因视力疲劳,眼肌松弛无力,邪之所凑,其气必虚。故刘氏用其父刘炳凡老中医治疗本病的经验,重视先后天的相互关联,从整体出发,予补中益气汤以桔梗易柴胡,一则免耗肝阴,再则开提肺气、启皮毛。眼胞下垂多伴有微肿,故加茯苓、薏苡仁、蚕砂以渗湿;枸杞子、菟丝子以补肾益精,共奏健脾渗湿、补肾益气之功,使五脏调和而达阴平阳秘。若腹胀,口乏味者加麦芽 10g、砂仁 3g、鸡内金 3g、去当归;斜视、复视加山药 12g、山茱萸 5g,去升麻、桔梗。刘光宪用本方治疗眼肌型重症肌无力 22 例,其中男 12 例,女 10 例;年

龄2~3岁者3例,4~9岁者9例,10岁以上者10例,年龄最小者2岁6个月,最大者49岁。病程在1年以内者9例,1~3年者6例,5年以上者7例;病程最短者30天,最长者12年。并发斜视者3例,复视者3例,影响全身者3例,嘴外斜发音不准者1例,飞蚊症、惧光者1例。经治疗痊愈(眼胞开合自如,双眼同等大小,并发病症消失者)10例,显效(眼胞开合自如,但劳累感冒后有反复者)6例,有效(眼胞下垂较原来好转,但未完全消失者)5例,无效1例。年龄10岁以下患者相对来说治愈率较10岁以上者为高,病程短者疗效好。同时刘光宪认为预防对本病尤为重要,首先应注意脾胃健运,因饥、饱、劳、逸均能伤脾;其次防止视力疲劳,更不宜在光线昏暗的环境中勉强使用目力,因本病常见于勤奋伏案作业后;三是若出现本病的预兆——视疲劳,即可用黄芪60g、苍术6g,至疲劳消失为度,可收预防之效果。

【病案举例】 詹某,男,6岁半,1986年4月16日初诊。患儿两眼胞下垂已1年,左眼球不能运转,右眼球运转不灵活,伴有复视,视物时头向右偏,肌体消瘦,口干,纳食欠佳,夜尿多,大便干结。曾在多家医院就诊,均诊为“眼肌型重症肌无力”,用吡啶斯的明、补中益气汤治疗,效果不佳。察舌质淡,苔白少津,脉细数,此乃脾胃升降失司,水津不布,累及肝肾失养,予以调脾醒胃,畅其升降之枢为治。处方:党参12g、白术10g、茯苓10g、炙甘草5g、法半夏5g、陈皮5g、黄芪15g、蒺藜10g、白芍12g、肉苁蓉12g、草决明15g、桑叶12g、砂仁3g、麦芽10g、鸡内金3g,水煎,日1剂。服药12剂后眼胞开合好转,眼球运转比以前稍灵活。刻诊:易汗,口干,夜尿多,舌淡红,苔薄白,脉弦小。根据五轮八廓理论,胞睑属脾,瞳子属肾,黑球属肝,故酌加滋养肝肾之品(党参12g、白术10g、茯苓10g、炙甘草5g、法半夏5g、陈皮5g、黄芪15g、女贞子15g、旱莲草

10g、山药 12g、山茱萸 6g、枸杞子 12g、菟丝子 12g、桑叶 10g、益智仁 3g、金樱子 15g、鸡内金 3g)。又服 25 剂后,眼胞开合自如,下垂现象基本消失,眼球运动较正常人差,汗出已止,夜尿仍每晚 1~3 次,眠食正常,舌质淡,苔薄白,脉弦小。仍予益脾气,补肝肾。宗上方去桑叶、法半夏、陈皮、山药、山茱萸,加蚕砂、谷芽各 10g。再进 20 剂,双眼胞下垂消失,开合自如,眼球运动正常,复视消失,舌质淡,苔薄白,脉缓。仍予上方以巩固疗效,追访 1 年未见复发。

【方名】 马钱子胶囊。

【组成】 制马钱子。

【来源】 裘昌林,浙江中医杂志,1986,(1):27。

【功效】 开通经络,透达关节。

【适应证】 重症肌无力。

【方药简析】 马钱子具有开通经络,透达关节的作用,是其他药所不及的。但生马钱子有毒,故使用时将生马钱子用水浸泡半月,取出去毛,切片后用香油煎至呈棕黄色,捞出后用六一散吸附,筛去六一散,磨粉。每粒胶囊装炙马钱子粉 0.2g。服法:每日 3 次,每次 1 粒,饭后即服。每隔 2~4 日增服 1 粒,逐渐加至 7 粒止。如不到 7 粒,而自觉机体局部有一过性肌肉跳动、抽动感时,亦不可再增加。原来如服西药吡啶斯的明或新斯的明者,随着肌力逐步增强,可减少用量直至停药。肌力基本正常后减少马钱子用量,直到终止治疗。裘昌林以马钱子胶囊为主,辅助以其他中药治疗并将本病分为中气虚弱型,表现为一侧或双侧眼睑下垂,四肢倦怠无力,朝轻暮重,劳后更甚,面色萎黄,食欲不振,舌质淡红,苔薄白,脉细弱。用补中益气法:生黄芪 30~45g,当归、白术各 9g,党参 15g,炙甘草 6g,升麻、柴胡各 4.5g,仙灵脾 30g;脾肾两虚型,

【组成】 黄芪 60g,党参 15g,白术 15g,茯苓 15g,陈皮 9g,当归 18g,川芎 9g,赤芍、白芍各 9g,葛根 18g,桂枝 9g,山药 15g,鸡血藤 24g。

【来源】 刘淑林,山东中医杂志,1984,(4):11。

【功效】 益气健脾,理气活血,调和营卫。

【适应证】 重症肌无力。

【方药简析】 方中黄芪、党参、白术、茯苓健脾益气,培土固本;山药补脾益肺,补肾生精;当归、川芎、赤芍、鸡血藤养血活血,葛根升发脾胃清阳之气,输布津液、滋润筋脉、振奋肌肉;桂枝温通经络、白芍和营卫,配当归、川芎促进血行,陈皮理气和胃,免生胀满之弊。刘淑林治疗本病强调抓住脾气虚弱本质,抓住主要矛盾,把握用药方向,用方当专不泛,既不可因药之偏性所致成不良反应而犹豫动摇,亦不应因证情复杂而用药庞杂,当药精力专。同时配合针灸治疗效果更为满意。

【病案举例】 孙某某,男,20岁,1976年9月19日入院。双眼睑下垂4天,吞咽困难,下肢无力2天。患者4天前在田间劳动,突感觉双眼下睑下垂,视物不清,眼球转动失灵,2天后出现咀嚼无力、吞咽困难、口角流涎,且伴双下肢沉重乏力,行走困难。诸症均在晨起或休息后减轻,傍晚及活动后加重。体格检查:神志清,发育正常,皮肤好,颈软,答话正确清楚。双侧瞳孔同大等圆,眼球运动迟缓,睁眼无力,双侧眼裂相等,约4mm,对齿动作双侧咀嚼肌收缩无力,露齿鼓腮困难而乏力。咽反射减弱,双下肢肌张力差,双上肢肌力Ⅲ级,双下肢肌力Ⅱ级,四肢腱反射存在,病理反射未引出。诊断为重症肌无力(全身型)。治疗用新斯的明,其始症状稍有改善,继用则效果渐减,且出现腹痛及频有便意等不良反应。诊见:面色萎黄,头垂目闭,全身痿软,少气懒言,舌咽困难,纳食减少,舌淡苔薄黄,脉细弱。证脉合参,乃脾胃气虚,运化失司,致摄纳无权,肌

肉失荣。治以益气健主，佐以理气活血、调和营卫之法，用补中益气汤治之。连服14剂后，患者稍可自行站立，外出尚需搀扶，视其病情，已有转机。上方不变继服，服法同前。自10月17日于原方加熟附子9g，从10月9日配合针灸治疗，取肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、风市、阳陵泉、绝骨、昆仑（均双侧）。1月后，各证大减，肌力日增，已能自行来院就诊。惟咀嚼尚感无力，还有口干咽痛、头痛、左耳疼痛等里热炽盛之证，此乃附子燥热所致，将原方山药改为24g，葛根30g，服法同上，并令其自服上清丸与汤剂交替服用，以折其火势，嘱其减用新斯的明注射量。服上方40余剂，至同年十一月底，病情痊愈如常人，面色红润、眼睑无下垂，目光有神，咀嚼有力，吞咽无困难。原每进餐1次常需1小时许，且难获一饱，现20min即可饱餐完毕。视其神态与初诊时恍若两人，遂嘱其停用新斯的明，仍按原方再服半月，以资巩固。至同年十二月中旬，病人完全恢复正常，追踪观察3年，未再复发，一直坚持全年体力劳动。

【方名】 补血安神汤。

【组成】 当归15g，熟地黄9g，白芍9g，川芎9g，桑椹子12g，乌梅12g，炒酸枣仁30g，柏子仁9g，远志9g，菖蒲6g。

【来源】 庄传芳，山东中医杂志，1985，（6）：21。

【功效】 补血活血，定志安神。

【适应证】 重症肌无力。

【方药简析】 方中当归、熟地黄、白芍、川芎、桑椹子滋阴养血活血通络；乌梅、炒酸枣仁、柏子仁、远志、菖蒲安神定志。庄氏所治本病，女性为多，故以调血作为理论指导，用四物汤合安神之药。

【病案举例】 吴某某，12岁，1974年6月5日初诊。10

天前,突受惊恐,翌晨起床,两眼睑下垂,睁眼困难,肢体倦怠,极端乏力,走路困难,诊为失寐。经内、儿科检查及作新斯的明试验阳性,诊为重症肌无力,转中医科治疗。经云“惊则气乱,恐则气下”,“恐惧而不解则伤精,精伤则骨酸痿厥”。故本病为气血失调,血随气乱;宜补血安神为治。方用当归 15g、熟地黄 9g、白芍 9g、川芎 9g、桑椹子 12g、乌梅 12g、炒酸枣仁 30g、柏子仁 9g、远志 9g、石菖蒲 6g、升麻 3g,水煎服,日 1 剂。前后 3 次复诊,共服药 40 剂,至 7 月 20 日痊愈。

【方名】 复力散。

【组成】 制马钱子 1 份,红参 6 份,黄芪 6 份,当归 2 份,山药 6 份。

【来源】 刘作良,新疆中医药,1992,(3):28。

【功效】 滋化源,开清阳。

【适应证】 重症肌无力。

【方药简析】 方中红参大补元气、益气生津、健脾补肺;黄芪补中益气、升提中焦清阳、补气而生血;山药平补脾胃、强肾固精;当归和营能;制马钱子振兴肌力,共用量每日不超过 0.5g。刘氏用复力散,根据年龄每次 3~6g,每日 2 次。治疗第 1 个月加服补中益气汤,其中黄芪用量应在 60~90g,同时加巴戟天壮命火助脾生化之源。散药服到临床症状完全消失,再继续服 2 个月停止。最长服 6 个月,最短服 4 个月。共治疗重症肌无力 10 例,男 6 例,女 14 例;年龄 3~25 岁;病程 2 个月~2 年。结果 1 个月内症状完全消失 3 例,2~3 个月内症状完全消失者 5 例;症状明显好转 2 例,总有效率 100%。

【病案举例】 黄某,女,24 岁,1989 年 3 月 14 日入院。患者双睑下垂已 13 个月,来院前曾持续用新斯的明治疗。症见双睑下垂,双睑裂 4mm,面黄少华,纳食尚可,大便溏薄,脉

滑,舌质淡、苔薄白。证属脾胃虚弱,中气下陷,上胞下垂。治以补中益气,养血通络。予补中益气汤每日1剂,日3服,复力散6g,每日早晚各1服。治疗1月,上睑拾举有力,睑裂8mm。停药汤药,继用散剂至2个月时,睑裂已11mm,眼睑开合自如。出院嘱继服散药2个月。1年后随访,疗效巩固。

29

周期性麻痹

周期性麻痹是以反复发作的骨骼肌弛缓性瘫痪为特点的肌肉疾病,有人称之周期性瘫痪。本病发作时大都伴有血清钾含量变化,按血清钾变化情况可分为低血清钾性、高血清钾性和正常血清钾性三类,但后两种情况极为少见。国外报告的周期性麻痹常有家族史,并为常染色体显性遗传,散发者约占20%左右;国内家族性周期性麻痹极为少见,多呈散发性。本病的机理目前尚不清楚,多数人认为是由于钾代谢障碍引起的,光学显微镜下病变肌纤维中部有圆型或椭圆型泡囊形成,电子显微镜下发现该泡囊为膨大的纵管和终池,并通过横管系统与细胞外相连。本病典型的临床表现为周期性发作的短期的下运动神经元瘫痪症状,好发于10~30岁之间。青壮年多见,男性多于女性。(1)低血钾型:国内常见,多散发,少数为常染色体显性遗传,常见于20~40岁发病。过度疲劳、饱食、寒冷、精神紧张和激动等为诱因,多于睡眠中或晨起发病。肢体对称性瘫痪,自下肢向上肢发展,近端较远端重,且有肢体麻木,瘫痪在1到数小时内达到高峰,每次发作可持续数小时至数天,然后逐渐恢复。发作时腱反射减弱或消失,肌肉电刺激无兴奋反应,感觉正常,神志清楚;(2)高血钾型:为常染色体显性遗传,多于10岁前起病,男性相对多于女性,临床患者少见。患者一般在运动后休息及黄昏时突然出现肢体无力,下肢近端首先受累,后累及躯干、上肢和颅神经支配肌肉,并有肌肉疼痛、痉挛和强直症状。每次持续数分钟至数十分钟,超过

ih 者少见;③正常血钾型:常染色体显性遗传,10 岁前起病,诱因与低血钾型相同。常于清晨醒来或夜间醒后出现四肢麻痹,或部分肌肉无力,如肩胛肌、小腿肌等,症状可持续 10 天,少者数达 3 周。根据本病典型发作病史(四肢对称性无力)和发作时伴有的血清钾降低,心电图(T 波降低或倒置,U 波出现,S-T 段下降,P-R、QRS 与 QT 间期延长;高血钾型 T 波幅度增高)、肌电图(发作时运动单位电位数量减少或消失,神经传导速度正常;高血钾发作时可有肌强直电位活动)可明确诊断。但在首次发作时,须与急性感染性多发性神经根炎、多发性肌炎、低血钾软病、甲状腺机能亢进合并周期性麻痹、肾病性低钾、急性脊髓炎等相鉴别。对低血钾的治疗主要是发作时补钾,可口服氯化钾或 10%氯化钾 30~40ml 加林格液或生理盐水 1000ml 静滴。也可用醋氮酰胺或安体舒通作预防性用药。发作间歇期应少食多餐,忌高糖饮食,限制钠的进量;避免过度疲劳、受寒和酗酒等激发因素,可多食榨菜、芥菜等富含钾盐的蔬菜。本病预后良好,多数病者在中年后发作逐渐稀少,并有可能自行停止;少数频繁发作者,晚期可作半肢体近端疲软甚至伴有轻度肌肉萎缩。合并甲亢者,在甲亢控制后,多数病者发作次数可以减少或消失。

周期性麻痹属于中医无力、瘫痪的范畴。主要与饮食不节或过度劳累伤及脾胃,造成脾胃功能失调,气血不足,或肾虚精亏,筋骨脉络肌肉失养,而致肌体痿软无力;与肝脾肾三脏有关,主要在脾肾两脏。中医多分为脾虚胃弱、气血两虚型,用人参养荣丸加减;肝肾两虚、筋脉失荣型用健步虎潜丸加减。瘫痪时可配合针灸治疗。对本病的中医治疗,缺乏大宗病例。

李发旺将本病分为脾胃虚(用党参 10g,白术 9g,半夏 10g,陈皮 10g,茯苓 15g,甘草 6g,木香 6g,砂仁 6g,旋复花 15g,白芥子 10g,甘松 30g,伸筋草 30g,益气健脾、燥湿化

痰),气滞痰凝(重用海藻、昆布,半夏、青皮、陈皮、当归、川芎、丹参、桃仁、红花、生龙骨、生牡蛎,理气化痰、活血通络),痰热内扰(用黄连温胆汤加鲜竹沥、远志、石菖蒲、滑石清热化痰),脾肾阳虚(理中汤合真武汤重用附子 30~60g(先煎)加黄芪、当归、木通,温阳健脾、散寒除湿)3型,共治疗 38 例,其中脾胃虚弱 30 例,痊愈 14 例,有效 11 例,无效 5 例;气滞痰凝 5 例,痊愈 3 例,有效 2 例;痰热内扰 1 例,痊愈 1 例;脾肾阳虚 2 例,痊愈 1 例,有效 1 例;总有效率 86.8%。同时李氏总结健脾化痰法可促使钾代谢恢复正常,若用西药则疗效益彰[实用中西医结合杂志,1992,(6):330]。

周汉章等用香薷饮合鸡苏散(香薷、薄荷各 6~10g,厚朴 3~8g,扁豆 10~12g,六一散 0.5~1 包),治疗本病 24 例,一般服药 2~4 剂,痊愈 19 例,好转 4 例,无效 1 例[中西医结合杂志,1985,(1):197]。

【方名】 补肝调肾汤。

【组成】 黄芪 20g,太子参 15g,醋柴胡 6g,五味子 5g,枸杞 12g,菟丝子 15g,野料豆 15g,仙灵脾 10g,巴戟天 10g,白术 10g,白芍 10g,煅牡蛎 20g,红花 5g,鸡血藤 10g。

【来源】 刘永年,江苏中医杂志,1984,(3):10。

【功效】 温养肝肾,疏达气血。

【适应证】 周期性麻痹。

【方药简析】 方中黄芪、太子参、白术、五味子益气健脾、固表止汗;红花、枸杞、白芍、鸡血藤养血濡筋、活血通络;菟丝子、仙灵脾、巴戟天、野料豆温补肾阳;煅牡蛎敛汗固表;柴胡、白芍舒肝理气。本方温而不烈,补而不燥,实乃温中带润、补阳配阴之剂,可使人气壮、用展、血活、络畅,筋骨自得其养,痿痹可愈。

【病案举例】 李某,男,43岁,1980年5月22日初诊。患者自1971年起,每届夏季即出现两下肢软弱无力,甚则延及上肢,似瘫而不能动弹。西医诊断为周期性麻痹。曾用中西药物治疗乏效。刻下旧恙复作,伴有头昏腰酸,两耳鸣响,口干倦怠,微感胸胁闷胀,四肢外形尚可,面色略显晄淡,苔薄腻,舌有细裂隙底,质不红,边有齿痕,脉象沉小微弦。属中医痿证范畴,暂从调补肝肾进治。方用干地黄12g,山药15g,山茱萸6g,茯苓10g,泽泻6g,何首乌12g,玉竹15g,龟板15g,怀牛膝10g,鸡血藤10g,丹参10g。二诊(6月21日):上方加减服用20余剂,症情无明显进退,且遇劳而下肢无力增重。并显频频自汗,气短懒言,眼睑垂重,神疲嗜睡诸症,舌苔薄,质不红,边有齿印,脉沉而细弦。肾阴固弱,肝气尤虚,转从补肝气护肾阳立法,酌参敛汗通络之品。黄芪20g,太子参15g,醋柴胡6g,五味子5g,枸杞12g,菟丝子15g,野料豆15g,仙灵脾10g,巴戟天10g,白术10g,白芍10g,煅牡蛎20g,红花5g,鸡血藤10g。三诊(9月26日):前方加减续用3月余,汗敛神振,四肢运动活泼有力,诸恙相继告释,改拟养荣丸、玉竹膏、刺五加片缓调。翌年3月,为防止复发,乃续以上方加减服用50剂,配合当归养血膏、刺五加片、黄芪注射液以治,至夏末再复发,随访至今,健如常人。

【方名】 五痿汤。

【组成】 党参12g,白术12g,茯苓12g,当归12g,麦门冬12g,薏苡仁20g,黄柏6g,知母6g,甘草6g。

【来源】 张长义,山东中医杂志,1993.(1):52。

【功效】 益气健脾,清热化湿。

【适应证】 周期性麻痹。

【方药简析】 方中四君子汤益气健脾养胃,使气血生化

有源：知母、黄柏、麦冬滋阴益肾兼清胃肾之热，黄柏又能燥湿；当归入心肝脾经，补血活血又可柔筋；薏苡仁入肺脾肾经，上清肺热，下理脾湿，又能舒筋脉，缓和挛急。可加牛膝、补骨脂等补肝肾，壮筋骨，引血下行。诸药相伍，使肌体化源不竭，正气充盛，肝肾得滋，湿热得清，四肢肌肉筋脉得到濡养，全身功能很快恢复。

【病案举例】 亢某，女，35岁，1988年8月8日初诊。2年前因劳倦过度发生四肢瘫痪，以下肢为甚，而伴有全身麻木，肌肉酸胀，下肢沉重而不痛，病后无畏寒及发热，平时胃脘痞闷，饮食欠佳，口中乏味。2年来每隔2至3个月发作1次，每次持续5至7天。发作后两下肢不能任地，两上肢不能持物，呈瘫痪状态。先后曾2次去某医院诊为周期性麻痹（低血钾性）。给予氯化钾、强的松、维生素B₁等药物治疗，瘫痪等症状时轻时重。近1月发作频繁（间隔5~6天），病情较重。诊见神志清醒，精神萎靡，面色晦滞，自述月经正常。查体：四肢瘫痪，肌力Ⅱ级，肌张力较低，生理反射存在，病理反射未引出，心率90次/分，律齐，血清钾3.1mmol/L，心电图正常。舌质红，苔薄黄腻，脉弦细数。按血痹证给予黄芪桂枝五物汤合四君子汤加减：黄芪30g，桂枝10g，白芍12g，党参12g，茯苓12g，白术10g，砂仁6g，甘草5g。8月18日复诊：服上方10剂，四肢麻木及肌肉酸胀感减轻，瘫痪伴下肢沉重不减，舌质红，苔薄黄腻，脉弦细数。四诊合参，辨证为脾胃虚弱，肝肾不足，湿热浸淫。治宜益气健脾，清热化湿。方以五痿汤治之：党参、白术、茯苓、当归、麦门冬各12g，薏苡仁20g，黄柏、知母各6g，甘草5g。8月23日三诊：服上方5剂，四肢瘫痪程度减轻，全身麻木消失，仍饮食欠佳，胃脘不适，舌淡红，苔薄黄，脉弦细数，上方加怀牛膝、陈皮各12g。8月31日再诊：服上方8剂，四肢瘫痪消除，肌张力恢复，食欲正常，胃脘舒适，舌淡红，

【方名】 振颓汤。

【组成】 黄芪 30g, 白术 30g, 当归 18g, 干姜 6g, 党参 15g, 怀牛膝 15g, 附子 10g, 桔梗 6g, 熟地黄 30g, 鹿角胶 10g, 生龙骨 30g, 生牡蛎 30g, 桂枝 9g。

【来源】 李凤歧, 山东中医杂志, 1987, (6): 39。

【功效】 健脾养血, 温阳益肾。

【适应证】 痿证(周期性麻痹)。

【方药简析】 方中黄芪、白术、党参健脾益气, 培补后天之本; 当归、熟地补血活血, 益肾柔筋; 鹿角胶、怀牛膝强壮筋骨, 通督脉补肾阳, 引血下行; 附子、桂枝温阳散寒; 生龙骨、生牡蛎熄内风收敛真气; 桔梗载药上行, 与牛膝并用升降相因。也可以用菟丝子、续断来代替鹿角胶。

【病案举例】 贺某, 男, 38岁。患者因劳倦过度, 于1957年秋季发病, 呈四肢瘫痪, 痿废不用。病后曾在8个医院单位和疗养院治疗。西医诊为: 周期性麻痹(低血钾型)。经治疗后血钾转为正常, 但周期性麻痹之证未见好转。1974年元月, 患者发作频繁(间隔4~5天)病情较重。于本月29日来我院就诊。患者素有气短, 四肢乏力, 周身之筋拘挛, 肌肉颤动, 腰时痛, 腹胀, 纳呆, 畏冷。发作时每与劳累有关, 发作后两下肢不能任地, 两上肢不能持物, 呈瘫痪状态。检查: 瘫痪肢体腱反射消失, 无疼痛麻木感, 痛觉存在。面色憔悴, 精神萎靡, 舌质淡, 苔薄白。切脉: 两寸甚微弱而短, 关弦细, 两尺沉弱。患者气血俱虚, 其胸中大气下陷, 不能斡旋全身。故见呼吸益形气短, 四肢乏力, 畏冷, 多于劳累后发作。患者周身之筋拘挛, 不能伸缩之症, 盖人身之筋, 以宗筋为主, 不能荣养宗筋者, 阳明也。因其素日胃纳欠佳, 腹胀, 为脾虚胃弱, 脾胃虚者不能化谷生液, 以荣养宗筋, 故有缩无伸, 寢成拘挛矣。肾主骨, 腰为肾之府,

脘痞闷,口粘而苦,纳差,大便粘浊,小便赤涩热痛,舌苔黄腻,脉滑而数。检查:精神倦怠,面白少华,四肢呈对称瘫痪,肌张力减退,腱反射减弱,无痛觉障碍及病理反射,查血钾 3.2mmol/L ,血沉 4mm/h ,心电图提示低钾表现,确诊为周期性麻痹。中医辨证属湿热侵淫经脉,营卫运行受阻,筋膝失却濡养,日久弛纵不收所致。治以清热祛湿,活血通络。方中用四妙散加味:苍术、黄柏、秦艽、当归、白术、鸡血藤各 15g ,牛膝、杜仲、茯苓、木瓜各 21g ,薏苡仁 30g ,羌活 6g 。服7剂后,手足下垂减轻,四肢较以前有力,感觉恢复正常,继服5剂,晨起下肢可以站起,能扶杖短距离行走。继服上方8剂,辅以功能锻炼,针灸理疗,除身倦乏力外,四肢活动自如,余症消失,继用参苓白术散加味培补中宫,调理1周而愈,随访5个月,未有复发。

30

先天性脑发育不全

先天性脑发育不全,又称精神发育不全、精神发育迟滞、精神幼稚证,是指在胎儿期,出生时或婴儿早期大脑的发育受到阻碍,导致精神发育尤其是智力发展受到限制,临床表现为运动、语言、理解力、观察力、分析、想象、思维、记忆力及社会适应力等精神发育速度缓慢,以至多方面智能达不到同龄儿童水平的一种疾病。本病的病因十分复杂,涉及范围广泛,现代医学虽然解决了部分病因,但迄今仍有一部分病因有待探讨。目前已知的病因主要有:①遗传及代谢障碍;②母孕期有害因素的影响;③分娩期不利因素的影响;④出生后有害因素的影响。大脑发育不全的临床表现,以生长发育迟缓、抬头、凝视、坐、爬、立、说话等均较同龄儿童迟缓为主要特征。也有部分患者开始时正常,以后逐渐出现智能减退,按其智能缺损程度,一般分为三类:①白痴:是本病严重的一种,智能极低。表现为不能学会讲话,只能以简单的音语来表示喜悦、愤怒或需求,不能独立生活,不知逃避危险和防御危险,躯体生长明显迟缓,常伴有其他先天性缺损,如不加照料可在婴儿期夭亡。②痴愚:其智能缺损亦很严重,可学会讲话,但吐词不清,词汇贫乏,词不达意,理解运用困难,只能反映事物表面、个别、片面的现象,不能领会理论性知识,机械性记忆尚可。患儿可与一般儿童共同学习,但对数的概念十分模糊,能辨别亲疏,情绪易暴怒、冲动。③愚鲁:智能缺损较轻,表现为智能低下,能料理一般日常生活,可进学校读书,但学业很差,其抽象思维

活动,如理解、判断、推理、分析、综合能力明显低下,缺乏创造性,极易被诱骗、玩弄、污辱,躯体不一定有异常。先天性大脑发育不全伴有异常的体征有伸舌样痴呆的小圆头,眼睛倒八字形,双眼内眦之间距离很远,内眦赘皮,阴囊样舌;苯丙酮尿症患者的头发黄软稀疏,虹膜色素过浅,皮肤嫩白,口唇鲜红,步态不稳。神经系统体征易有共济失调、指划样动作、肢体瘫痪、感觉缺损和癫痫样抽搐的出现。本病应与精神发育暂时迟缓、儿童精神分裂症、癫痫、儿童多动症等病相鉴别。

先天性脑发育不全属于中医学的痴呆、五软、五迟等范畴。其病因病机为禀赋不足,脑海失养;产伤外损,淤阻经络;湿毒邪侵,上犯于脑;积痰内盛,阻滞脑窍;饮食失节,中虚不足,致精血不能充养脑脏。治疗应从肾精亏虚入手,兼顾脏腑辨证。禀赋不足、心脑失养选用七福饮;肝肾亏虚、脑神失滋用六味地黄汤;脾虚气弱、脑海失养用调元汤;心脾两虚、脑失滋养用归脾汤;邪毒内侵、心脑失灵用泻心导赤汤;痰湿内盛、上蒙脑窍用泻心汤;气滞血淤、脑络受阻用通窍活血汤。

王烈等用治痰散(桑枝 20g,桑叶 15g,桑寄生 30g,桑棋子 30g,桑白皮 15g,桑螵蛸 15g),治疗肝肾亏损所致肢体运动障碍为主的脑发育不全;用益智散(当归 10g,茯神 10g,石菖蒲 12g,鱼鳔 12g,黑芝麻 15g,远志 10g),治疗心肾不足所致智力不全为主的脑发育不全。共治疗 70 例,显效 23 例,无效 10 例[新中医,1984,(4):26]。

邹锡听用益智灵(红参、白参各 1.5g,龙眼肉、茯苓各 10g,五味子 3g,山药 15g)治疗智能发育迟缓者 51 例,3 个月为 1 个疗程,结果平均智商有明显提高,与对照组相比较 $P < 0.05$,说明本方具有促进智能迟缓儿童的智力提高的作用[上海中医药杂志,1988,(1):10]。

张永等对心气亏虚证脑发育不全用归脾汤、养心汤加减;

心肾两虚证,用肾气丸或右归丸;心阴亏少证,用百合地黄汤、天王补心丹、生脉散等。共治疗 16 例,显效 4 例,好转 11 例,无效 1 例[上海中医杂志,1983,(6):24]。

【方名】 鹿茸益智散。

【组成】 鹿茸、木香、羌活各 20g,益智仁、鸡内金各 50g,石菖蒲、茯苓各 30g,羚羊角粉 2g。共研细末,每次服 3g,日 2 次,水调服。

【来源】 易忠禄等,四川中医,1992,(3):25。

【功效】 补肾填精,益气健脾。

【适应证】 先天性脑发育不全。

【方药简析】 方中以鹿茸峻补先天,补肾长骨以生髓;益智仁、石菖蒲益肾开窍以增智;鸡内金、茯苓、云木香消食健胃调气以养脾;羚羊角清热以制鹿茸之热,羌活引药入脑。诸药合用,功能补肾填精,健脾益气。痴呆重加郁金、远志;患肢痉挛、伸不开加僵蚕、白芍、木瓜;抽搐加天麻、白附子、僵蚕;肢体无力加黄芪、白术;合并脑积水加泽泻;热重鼻衄加栀子;便秘加大黄。易忠禄等用鹿茸益智散治疗小儿大脑发育不全 23 例,治愈 6 例(诸症明显好转,与正常同龄儿无异);有效 11 例(诸症好转,略逊于正常同龄儿);无效 6 例(症状无改善或中断治疗)。总有效率 74%。

【病案举例】 朱某,女,3 岁,1990 年 5 月 15 日诊。患儿系双胞胎。症见:头项、手足软瘫,不会说话,喜欢伸舌头;颈软,抱立时头搭拉在肩上;上肢伸时,手屈向后,手指伸屈无力,不会自己迈步;纳差食少。诊为婴儿脑性瘫痪,系由产伤所致。予鹿茸益智散 1 料,1 月后,颈能担住头,会叫爸妈,扶着能站。其母述服药后,时有鼻衄。原方去木香,加栀子 20g。服 2 剂后,不扶能走几步,牵着可走 4~5m。智力也有明显好转,

唯四肢无力，加黄芪、白术各 20g。连服 5 个月，诸症明显好转，基本治愈。

【方名】 软迟丸方。

【组成】 熟地黄 15g，山茱萸 30g，怀山药、茯苓、牛膝各 25g，鹿角霜、牡丹皮、泽泻各 15g。共为细末水丸，每服 3g，日 2 次，淡盐汤下。

【来源】 王占金《临床验集》。

【功效】 滋补肝肾。

【适应证】 先天性大脑发育不全。

【方药简析】 方中六味地黄汤补益肝肾，填精益髓；鹿角霜、牛膝温补脾肾，强筋壮骨；诸药共奏补肾填精、强筋壮骨之功。

【病案举例】 栾某，男，7 岁，1955 年 3 月 11 日初诊。患儿生后发育差，说话、长齿、走路均迟。走路时腿软经常跌倒，智力发育较差，与同龄儿相比距离很大，不能入学学习，生活不能自理。遗尿、尿急，睡眠不佳，饮食不节，大便稍干，面色黄，身瘦，舌质正常，苔淡黄，脉沉细无力。诊为大脑发育不全，此为先天不足，肝肾虚损，后天失调，以致脾虚。治宜温补肝肾、补气理脾，方用软迟丸。服药 7 个月，病情逐渐好转，走路已不跌跤，遗尿已愈，睡眠转佳，饮食渐好，大便已正常。但尚有尿频、尿急。智力发育有所好转，体力活动较前灵敏，已能入学学习。薄白苔，脉沉细，上药继服，善后调理。

【方名】 滋肾补脾汤。

【组成】 补骨脂、山茱萸、炒山药、党参、当归、白芍、鹿角胶各 10g，熟地黄、黄芪 12g，石菖蒲、桃仁、远志各 6g。

【来源】 王占金《临床验集》。

【功效】 滋肾填精，健脾益气。

【适应证】 先天性脑发育不全。

【方药简析】 方名为编者所加，方中补骨脂温补肾阳，以治肾阳虚之腰膝痿软；山茱萸、熟地黄补益肝肾，以治肝肾虚腰膝酸软者；炒山药补脾益肾，以治脾肾不足之腰痛；党参益气补中；黄芪补气扶阳，且助党参以扶脾阳；鹿角胶补气养血，以双补气血；白芍柔肝养血，以疗手足拘挛；当归能补血活血与黄芪伍用为当归补血汤以治血虚筋软；桃仁润燥破瘀；石菖蒲开窍醒神，以期改变智愚语迟；远志益智安神。诸药合用，具有温补肝肾、补气理脾、补血养血、活血的功能。

【病案举例】 胡某，女，8岁，1965年4月20日初诊。患儿因难产大脑受损，生后不会吃奶，不会哭，至4岁才会走路。现已8岁只能说简单话，走路不稳，经常跌跤，双手不能持物。睡易惊醒，饮食尚佳，二便正常。诊断为大脑发育不全。面色正常，表情和3~4岁孩子相似。舌质正常，右脉缓和，左脉稍弦。证属肝肾不足，发为五迟。治宜平补肝肾，方用滋肾补脾汤。服药9个月，患儿说话较前清楚，稍能说较复杂的话，走路较前稳，跌跤减少，上肢动作较前灵活。又服上方加减5个月，患儿一般情况如前，惟脑子发育尚较迟钝，四肢运动和正常者尚有差距。

【方名】 人参归脾汤。

【组成】 白术、茯神、黄芪、龙眼肉、酸枣仁各30g，人参、木香各15g，炙甘草8g，当归、远志各3g，生姜5片，大枣1枚。

【来源】 严用和《济生方》。

【功效】 益气补血，健脾养心。

【适应证】 心脾两虚和脾不统血引起的症状。

31

视神经脊髓炎

视神经脊髓炎又称德维克病,为脱髓鞘疾病之一。其主要特点是视神经与脊髓的脱髓鞘变。二者同时或先后发病,呈急性或亚急性起病,病程中常见缓解与复发。发病原因目前尚不清楚,主要有感染和变态反应两种可能,以20~40岁发病较多。本病多呈急性或亚急性起病,少数患者于病前数日到数周可有低热、咽痛、头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、全身不适等症状。视神经与脊髓症状可同时出现,亦可先后发生。眼部症状:双眼可同时或先后受累,患者主诉视物模糊,眼珠胀痛,病势急骤者几小时或几天可完全失明。眼底早期表现为视神经乳头炎,可见视乳头水肿或轻度炎性渗出,视野缺损可为中心暗点或向心性缩小,后期和晚期可出现视神经萎缩。脊髓症状:多呈横贯性障碍,以胸段为多见。发病后下肢麻木,排尿困难,呈完全或不完全截瘫。病变部位较高时出现四肢瘫痪,面部麻木,眼珠震颤,手肌萎缩等症。尚可出现传导束型感觉障碍、眼球麻痹等体征。本病应与多发性硬化,亚急性脊髓视神经病,急性播散性脑脊髓炎等病相鉴别。

视神经脊髓炎眼部症状早期表现为视神经乳头炎时,属中医内障范畴。后期呈现继发性视神经萎缩,属青盲范畴。当本病出现瘫痪时,又属痿证范畴。中医学认为本病发生多因感受温热之邪,耗伤真阴,阴虚火旺,虚火上炎,灼烧津液;或肝肾阴虚,精血不能上荣,目失濡养,同时由于肝肾阴虚、热灼津液或气血亏虚、筋脉失养而成痿。阴虚热盛为本病主要病机,

IgM3.2g/L。诊断：证属肝郁血虚，内风煽动，予逍遥散加减：柴胡、当归、白术、胆星、半夏、黄芩各10g，茯苓、生地、陈皮、僵蚕、天麻、钩藤、丹参各15g，白芍、石决明、磁石、生龙骨、生牡蛎各30g，全蝎6g。进药3小时后，患者即觉脊髓内有感觉，嗣后抽搐减轻。再连续服用3剂，全身抽搐消失。后以上方加减叠进20余剂，再作免疫球蛋白测定，属正常范围[浙江中医杂志，1995，(8)：376]。

【方名】 养血祛风解毒汤。

【组成】 蜈蚣3条，全蝎3g，黄芪50～80g，当归、桂枝、晚蚕砂、夜明砂各20g，虎杖、菊花、珍珠母、郁金各30g，川芎、地龙、板蓝根、大青叶、密蒙花、青箱子各15g，白蔻仁10g，砂仁5g。

【来源】 李国勇，浙江中医杂志，1985，(8)：376。

【功效】 益气活血通络，清肝解毒明目。

【适应证】 方中黄芪益气升清健脾；当归、川芎、地龙、全蝎、蜈蚣温经通络；晚蚕砂、夜明砂、菊花、密蒙花、青箱子清肝明目；郁金舒肝解郁理气；板蓝根、大青叶、虎杖清热解毒；珍珠母潜阳平肝；白蔻仁、砂仁理气和胃醒脾。诸药共奏益气活血通络、清肝解毒明目之功。李国勇用该方治疗视神经脊髓炎4例，经服药3月～1年，均获痊愈。

【病案举例】 沈某，女，32岁，1983年5月11日初诊。二年前畏寒发热，头昏、头痛、全身肌肉酸痛、腹泻、眼眶疼痛，当时按感冒治疗无效。继之出现畏光，进行性视力下降，进行性排尿困难，四肢麻木无力，胸部紧束感。后由多家医院诊断为视神经脊髓炎，叠经中西医治疗，效果不著。体检：一般情况较差，面色苍白，下肢瘫痪，腹部以下痛温觉消失，上肢痛温觉减低，霍夫曼征阳性，视力1m内仅能分辨五指。舌淡，苔薄白。

脉细。证属血虚风胜，目窍失养，治拟益气活血通络，佐以清肝解毒明目。方用养血祛风解毒汤。进药 20 余剂后，上肢麻木减轻，肌力增加，视力增至 4.0~4.3，守方治疗 3 个月，症状、体征基本消失，续治近 1 年，肢体功能恢复如常，视力达 4.9~5.0。随访 10 余年，亦未见复发。

【方名】 佛手补髓汤。

【组成】 当归 80~100g，川芎 12g，黄芪 30g，赤芍、白芍各 15g，水蛭、羌活、伸筋草、仙茅、仙灵脾、枸杞子各 9g，黄精 20g，密蒙花 10g，甘草 6g。

【来源】 夏水湖，四川中医，1990，(2)：41。

【功效】 滋阴补肾，化淤通络。

【适应证】 视神经脊髓炎后遗症。

【方药简析】 方中重用当归补血和血，配以赤芍、川芎、水蛭活血化淤；仙茅、仙灵脾、枸杞子滋阴补肾，阴阳双补；白芍、密蒙花养血柔肝明目；羌活、伸筋草祛风通络；黄芪、黄精、甘草益气健脾。诸药合用共奏滋阴补肾、益气健脾、养肝明目、化淤通络之功。

【病案举例】 柳某，女，27 岁，1987 年 12 月 26 日诊。1 年前忽发右眼视力模糊不清，四肢瘫痪，住某医院神经科诊为视神经脊髓炎。经中西药治疗好转，遗有视力不佳、四肢无力、走路不稳、肢体麻木、小便失禁等症。刻下伴见气短无力，口干苦，大便干结。舌淡苔薄白，脉弦。检查：神志清楚，心肺正常。眼底：左眼底正常，右眼底视乳头色苍白，边缘清晰，血管比例正常。颅神经检查未见异常。双上肢肌力Ⅳ级，双下肢肌力Ⅲ级，步态不稳，四肢腱反射亢进，双侧巴征阳性，感觉检查正常。西医诊断：视神经脊髓炎后遗症。证属痿证（气虚血淤），治宜化淤通络，方用自制佛手补髓汤。服 12 剂后，症状好转，

体力增强。服药 20 剂后，四肢肌力增强，右眼视力由 4.5 增至 1.7。服药 27 剂时，行路正常，神经系统检查正常，临床治愈。

32

遗传性共济失调

遗传性共济失调是一种以共济运动障碍为主要临床表现的中枢神经系统变性疾病。病因尚不明确,人都有遗传、家族史,但亦有散在者。病理变化主要累及小脑皮质及小脑脚,脊髓中长运动传导束及本体感觉传导束,亦可侵及大脑皮质。由于病灶范围和发展过程不尽相同,临床症群已有 60 多种类型,常见的有少年型脊髓型共济失调,腓骨肌萎缩型共济失调, β -脂蛋白缺乏症,橄榄体桥脑小脑变性。本病发病缓慢,症状常呈渐进性,主要症状为共济运动障碍。①步态不稳:是本病的首发症状。早年发病的,在出生后很迟才会走路,动作不灵活,行走时两腿分得很宽;成年发病的,步行时不能走直线,忽左忽右呈曲线前进,表现为剪刀步态,站立时身体前倾或左右摇晃,当足尖站立或足跟站立时,摇晃不稳更为突出。肌张力的改变随病变可由降低转变为痉挛状态,共济失调步态也可随之转变为痉挛状态。②书写障碍:首先表现为字迹的变化,字线不规则,歪歪斜斜,字行间距不等,字越写越大,严重者无法书写。检查中常用的指鼻试验,手旋前旋后轮替试验的动作不协调。③肢体震颤:本病发生震颤,可限于一个肢体或肢体的某一部分,在完全静止时可不出现震颤,在运动时增强。往往是刚开始运动及运动终了时震颤明显,且其震颤伴有协调不良,是不规则且无规律性的。④言语含糊:说话缓慢,单调而含糊,吐字不清,音量强弱不等,或时断时续,呈呐吃样言语或爆破式言语或吟诗样言语。⑤骨骼畸形:弓形足及脊柱弯

蝎 10g,蜈蚣 2 条,黄芪 30g,吴茱萸 3g。

【来源】 贺裕元等,中医杂志,1990,(8):29。

【功效】 温阳益气,活血通络。

【适应证】 小脑型共济失调。

【方药简析】 方中附子、肉桂枝、黄芪、吴茱萸温阳益气;配当归、三七、全蝎、蜈蚣活血通络。诸药合用使胸闷心悸加丹参;恶风加防风;食欲不振加党参、白术;梦遗滑精加金樱子;喉中痰多加白芥子;月经过多或淋漓不尽加阿胶,经血色淡加鹿角霜。贺裕元等用上方治疗小脑型共济失调证 11 例,连续治疗 2~3 个月后评定疗效。治疗后步态稳定,双手活动自如,言语流畅,临床症状消失,停药随诊 3 个月后未复发,评为临床治愈者 4 例;步态基本稳定,临床症状基本消失,但久行仍乏力,评为显效者 2 例;步态摇晃程度减轻,临床症状有所好转,评为有效者 3 例;步态不稳无改善,临床症状变化不大,评为无效者 2 例。

【病案举例】 胡某,男,47 岁,1988 年 4 月 2 初诊。1987 年 12 月开始出现写字歪斜,后渐行走不稳,双手抓物不准,握物无力,经某医院诊为小脑型共济失调,未予治疗,嘱请中医诊治。诊见形体消瘦,面色苍白,步态不稳,上肢颤抖,双目视力减弱,视物变形,言语断续。查体:膝及跟腱反射亢进,指鼻不准,跟膝胫试验不稳,舌质淡,苔薄白,脉沉细。辨证为阳气虚衰,阴血淤滞,风邪留着,治以温阳化淤祛风,方用桂附稳步汤,服药 5 个月后,步态已完全稳定,双手活动自如,视物不再变形,诸症悉除。

【方名】 天麻钩藤饮。

【组成】 天麻 9g,钩藤 12g,石决明 18g,栀子 9g,黄芩 9g,川牛膝 12g,杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神各 9g。

【来源】 胡光慈《杂病证治新义》。

【功效】 平肝熄风，清热活血，补益肝肾。

【适应证】 肝阳偏亢，肝风上扰。

【方药简析】 方中天麻、钩藤、石决明均有平肝熄风之效，用以为君；栀子、黄芩清热泻火，使肝经之热不致偏亢，是为臣药；益母草活血利水；牛膝引血下行，配合杜仲、桑寄生能补益肝肾；夜交藤、茯神安神定志，俱为佐使药。

【病案举例】 杨某，男，40岁。近3年来行走易跌跤，伴说话含糊，视力差，7年前曾患“坐骨神经炎”，经治好转，后行走时下肢无力，其外祖母、母亲均有类似病史，均在40岁左右发病。查体：神清、言语含糊，双瞳孔等大，光反射存在，无眼震、伸舌居中，四肢肌力对称，肌张力正常，双膝反射亢进，跟腱反射活跃，左踝阵挛(+)，指鼻试验，跟膝胫试验尚能正确完成，闭目直立征(单侧)阳性，直线行走不稳，略呈剪刀步态。诊为遗传性痉挛性共济失调，辨为肝肾阴虚，风阳内动，治以平肝熄风，补益肝肾。方用天麻钩藤饮加僵蚕10g，磁石9g，桑枝10g，桂枝6g，琥珀粉6g(另冲)。服药2月，易跌跤症状消失，可下地劳动，闭目直立征转为阴性，睡眠时间增加，继服3月行走稳健，可做体力劳动[谢丙国，江西中医杂志，1987，(5)：18]。

【方名】 镇肝熄风汤。

【组成】 怀牛膝、代赭石各30g，生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、玄参、天门冬各15g，川楝子、生麦芽、茵陈各6g，甘草4.5g。

【来源】 张锡纯《医学衷中参西录》。

【功效】 镇肝熄风，滋阴潜阳。

【适应证】 肝肾阴虚，肝阳上亢，气血逆乱。

【方药简析】方中怀牛膝归肝肾之经，重用引血下行，并有补益肝肾之效，为君药；代赭石和龙骨、牡蛎相配，降逆潜阳，镇熄肝风，是为臣药；龟板、玄参、天门冬、白芍滋养阴液，以制阳亢；茵陈、川楝子、生麦芽三味，配合君药清泄肝阳之有余，条达肝气之郁滞，以有利于肝阳之平降镇潜；甘草调和诸药，与麦芽相配，并能和胃调中，防止金石类药物碍胃之弊，均为佐使药。诸药合用，成为镇肝熄风之剂。

【病案举例】 杨某，男，33岁，于1988年2月20日初诊。1个月前和别人发生口角后出现头晕、耳鸣、失眠、多梦，自以为生气所致，未治疗。5天后出现行路不稳，渐呈醉汉步态。当地医院做头颅CT未发现异常。按“小脑缺血”住院治疗半月无效，又出现双下肢震颤，患者要求转中医治疗。诊见：行路不稳，呈醉汉步态，双下肢震颤（静坐时），伴头晕耳鸣，烦躁易怒，面红目赤，眠差，便秘，舌红苔黄，脉弦数。诊为“小脑性共济失调症”。中医辨为气郁化火伤阴，肝阳亢极化风所致。治以清火熄风，平肝潜阳。投镇肝熄风汤加减：天麻9g，白芍30g，天门冬15g，玄参10g，川牛膝30g，生龙牡各30g，生麦芽20g，栀子15g，代赭石10g，龟板30g，川楝子10g，勾藤30g，菊花30g，黄芩12g。服药5剂后，口苦、耳鸣、烦躁除，头晕、面红、目赤大减，仍有行路不稳，下肢震颤，药已中病，效不更方，连服25剂，诸证皆除〔李国银，河南中医药学刊，1990，（4）：12〕。

【方名】 加味四君子汤。

【组成】 党参30g，茯苓15g，炒白术18g，甘草5g，山茱萸30g，龟板30g，砂仁9g，炒朴仁15g，鹿角胶15g，怀牛膝30g，熟地黄30g，山药30g，菟丝子15g。

【来源】 李国银，河南中医药学刊，1990，（4）：12。

【功效】 健脾补肾,滋阴填精。

【适应证】 小脑性共济失调症。

【方药简析】 方中四君子配山药,砂仁健脾和胃、益气;山茱萸、龟板、鹿角胶、熟地黄滋阴填精;杜仲、牛膝、菟丝子温补肾阳。诸药合用,共奏滋肾填精、益气养血、健脾益胃之功。

【病案举例】 高某,男,70岁,于1989年8月10日初诊。1个月前因操劳家事,劳心过度而致头晕耳鸣,失眠多梦,渐出现行路不稳、双手震颤。曾做头颅CT示:小脑萎缩。经用地巴唑、维脑路通等药无效,求治于中医。诊见:步履迟缓不稳,自觉双下肢酸软无力,行路有摇晃欲倒之势,伴头晕耳鸣,失眠多梦,神疲乏力,便溏,胸痞纳差,舌淡、苔薄白,脉细弱无力。诊为小脑性共济失调,辨证属脾肾两虚,精血俱亏,髓海空虚所致。治以脾肾双补,方用加味四君汤原方。服药5剂,胸痞除,纳食增,大便正常,头晕、耳鸣大减,余症同前。上方加生龙牡各30g,连服30剂,上症消失。

【方名】 黄芪桂枝五物汤。

【组成】 黄芪50g,白芍、桂枝各10g,生姜10g,大枣4枚。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 益气温经,和经通痹。

【适应证】 小脑性共济失调等。

【方药简析】 本方即桂枝汤去甘草、倍生姜,加黄芪而成。方中黄芪合桂枝,以益气温阳;白芍养血和营;生姜、大枣调和营卫。本方旨在温通阳气、调畅营血。

【病案举例】 韩某,男,31岁,1957年7月29日初诊。患者近2年来,行路不稳,时常跌倒,下肢发冷,说话言语不清,不愿见人,眼光迟钝,呆似木偶,头重脚轻,经常烦躁,病情逐

渐加重。检查：血压 18.6/13.3kPa，言语不利，步态不稳，眼球震颤，闭目则身体向两侧偏斜。上下肢共济运动不良，左手向右侧摇摆。诊断：小脑共济失调症。患者现行路头重脚轻，腿脚不利，双目呆滞，不能左右视物，闭眼则不能站立，言语不清，腿胀痛而冷，并有虫行蚁咬感，入睡困难。舌淡而润，脉沉弱。证系类中风血痹，风痺之疾。治以温阳通痹，养血活血通络，祛寒止痛。方用黄芪桂枝五物汤加味：黄芪 60g，桂枝 10g，麦门冬、白芍各 20g，牛膝 15g，鸡血藤 15g，羌活 10g，朱茯神 15g，制附子 10g，当归 25g，干地黄 15g，桑寄生 25g，生姜 10g，大枣 4 枚，竹沥 10ml（兑入）。服 10 剂后，双下肢胀痛发冷大减，虫行蚁咬感已除，睡眠好转，脉舌同前。继服月余，两腿冷胀痛已愈，走路较前稳定，上下肢转动灵活。双目不似前之呆滞，眼球震颤已不明显，闭目可站立，但时间不能延久，说话较为准确，但欠流利（李和医疗经验选，68 页）。

【方名】 右归丸。

【组成】 熟地黄、菟丝子、枸杞子各 12g，山药、当归、杜仲各 9g，制附子 6g，肉桂 4g，鹿角胶 10g，山茱萸 5g。

【来源】 张景岳《景岳全书》。

【功效】 温补肾阳，填精补血。

【适应证】 遗传性小脑型共济失调等。

【方药简析】 方中肉桂、附子加血肉有情的鹿角胶，温补肾阳，填精补髓；熟地黄、山茱萸、山药、菟丝子、枸杞子、杜仲，俱为滋阴益肾、养肝补脾而设；更加当归补血养肝。诸药配伍，共具温阳益肾、填精补血以收培补肾中元阳之效。

【病案举例】 续某，女，20 岁。1975 年起，行走不稳，易跌倒，经常头晕，屡医不效，反呈进行性加重。近数月来，除双下肢站立不稳，行走困难外，上肢亦有所发展，拿东西和作精细

的动作时抖动不稳。其父母健在,为表亲结婚。检查:颅神经除双眼球水平性震颤外,余无异常;双上肢对指、指鼻试验和双下肢跟膝胫试验均阳性,闭目难立试验阳性;步履不稳,站立时基底较宽,行走时左右摇晃;全身深浅感觉无殊。入院拟诊:遗传性小脑型共济失调。约请中医会诊:患小脑共济失调症已4年,近数月来病情加重。步履蹒跚,左右摇晃,头昏耳鸣,记忆减退,形寒肢冷,腰膝无力。苔薄,舌质偏淡,边有齿印,脉细,两尺沉而无力。此乃肾气虚弱,髓海不充,精髓不足所致。当予温肾补督,益精养髓之品,拟景岳右归丸加怀牛膝3g,龟板、制首乌各12g。服药20剂后,患者自觉精神好转,足膝步履较前有力亦较稳健,惟头晕未已,口渴欲饮,苔薄脉细。前方加生地20g。连服50余剂,患者可单独行走,步履较前稳健。精神较振,纳便睡眠正常,头晕耳鸣亦瘥,对指、指鼻、快复轮替试验,跟膝胫试验,闭目难立试验均明显好转,左侧略差。随访治疗5月余,病情稳定,已能上下楼梯,单独行走,仍按原意,继续将息调治,以资巩固[杨炳初等,上海中医药杂志,1984,(2):35]。

1~2 丸。

刘润林用四神汤(补骨脂、熟肉苁、吴茱萸、益智仁各 6g,五味子 5g,猪膀胱 1 具。将上药装入猪膀胱内,并将其口扎好,用粗针头将膀胱刺数孔,放入盆内,加水 1500ml,煮沸后 1h 左右去渣及汤液,取猪膀胱切片食之。成人 1 次食完,小儿可分 2~3 次食完),治疗遗尿证 25 例,显效 17 例,好转 7 例,无效 1 例[湖南中医杂志,1991,(5):37]。

【方名】 止遗汤。

【组成】 黄芪 15g,山药 20g,白术、金樱子各 10g,山茱萸 8g,益智仁、桑螵蛸、五味子各 5g,灯心草 5g。

【来源】 邓国强,陕西中医,1991,(12):544。

【功效】 温肾益气、健脾通阳缩尿。

【适应证】 小儿遗尿。

【方药简析】 方中黄芪、白术补气健脾,黄芪还可升阳;山药、益智仁培元补肾,固涩小便;金樱子味酸而性收,缩尿中摄精气;山茱萸滋肾平调阴阳,收敛固涩,桑螵蛸补肾助阳缩尿;五味子滋肾敛津宣肺,灯心草清心利尿通淋。诸药合用,具有温肾益气、补肺敛津、健脾通阳、清热利尿、调理水道,从而达到膀胱气化正常、开阖有节、标本兼顾、阴阳平衡的目的。肾气虚弱加制附片(先煎),仙灵脾各 6g,肉桂末 5g(后下);肺脾气虚加茯苓 9g,党参 10g,大枣 8g;湿热下注加胆草 5g,木通 9g,车前子 6g。

【病案举例】 彭某,男,6 岁,1986 年 4 月 5 日初诊。患者自 4 岁起患遗尿症,每周 4~5 次,经多方就医无效,近 2 月来,遗尿症状加剧,每晚睡中遗尿 1~2 次而来就诊。诊见:遗尿每夜 1 次,白天尿数量少,大便溏薄,形体消瘦,纳食不香,神疲乏力懒动,动则额上汗出,气促,舌质淡,苔薄白,脉沉细。

证属脾肺气虚,膀胱失约。治以补益脾肺,固摄小便;用止遗汤加党参10g,茯苓9g,大枣8g。服药3剂后,症状减轻,3天遗尿1次,继予上方4剂,遗尿止,诸症皆除。

【方名】 遗尿灵。

【组成】 鹿茸1.5g,山药12g,煅龙骨、煅牡蛎各20g,鸡内金10g,石菖蒲6g。上药共研细末,装零号胶囊备用、10岁以下3~4粒,10岁以上4~5粒,日3次,晚用盐开水冲服。

【来源】 吴进录,中医药研究,1995,(5):27。

【功效】 补肾健脾,醒脑开窍,收涩缩泉。

【适应证】 遗尿症。

【方药简析】 方中鹿茸补肾助阳,健脑为君;山药、鸡内金补脾强肾,制水止遗为臣;煅龙骨、煅牡蛎固涩缩泉;石菖蒲醒脑开窍。诸药合用,补涩兼顾,培本固元,扶阳抑阴,溺水得制,遗尿可止。

【病案举例】 秦某,男,15岁,1987年10月26日就诊。自幼尿床至今,每晚尿床2~3次,夜间迷糊不易叫醒,屡治不效,随着年龄的增长,冬季的到来,本人痛苦,大人也感烦恼。经服遗尿灵,1周后尿床减少到每晚1次,且易叫醒,第2周后则尿床消失,晚上可以自己起床小便而痊愈。1995年5月随访,至今未发,且结婚,生1女孩。

【方名】 聚精丸。

【组成】 黄鱼鳔胶200g,沙蒺藜100g,五味子40g。上三味药以牡蛎粉炒热,拌炒切碎的鱼胶,至变为圆珠样时取出。俟冷,三药共研细末,炼蜜为丸如黄豆大。10岁以下7~10丸,10岁以上15丸。服时将丸用开水化开,早晚空腹各1次。

【来源】 王肯堂《证治准绳》。

【功效】 补肾缩尿。

【适应证】 小儿遗尿症。

【方药简析】 方中黄鱼鳔胶、五味子滋阴补肾缩尿；沙苑蒺藜温补肾阳，助肾气化，诸药合用，共收补肾固涩缩尿之功。朱广仁等用聚精丸治疗小儿遗尿 20 例，服药 1 月以内痊愈 14 例，2 月内痊愈 5 例，进步 1 例[朱广仁《浙江中医杂志》1982,(2):87]。

【病案举例】 张某，女，8 岁。早产儿，有肺结核史。体质虚弱，智力欠佳，遗尿，盗汗。服聚精丸月余告痊。续服 1 年，体力、智力转佳，与前判若两人。

【方名】 黄芪五子汤。

【组成】 黄芪 12g，金樱子 15g，菟丝子、覆盆子、补骨脂、枸杞子各 10g。

【来源】 郭昌全，湖南中医杂志，1992,(1):48。

【功效】 益气固肾。

【适应证】 肾虚型遗尿。

【方药简析】 方中黄芪益气，菟丝子，补骨脂补肾壮阳；金樱子、覆盆子、枸杞子固肾止涩缩尿；诸药合用共奏益气补肾固涩作用。每晚遗尿 2 次以上加煅龙骨、煅牡蛎各 10g，桑螵蛸 5g；纳呆体虚加党参、槟榔各 10g，山楂 6g；口渴低热加桑寄生、夏枯草各 10g，当归 6g，五味子 5g。

【病案举例】 陈某，女，6 岁，1990 年 4 月 20 日初诊。患儿遗尿 1 年余，每周 1~2 次，近月每晚遗尿，多则 1 晚遗尿 3~4 次。男孩性格，白天玩耍无度，晚上睡后不易唤醒，饮食不正常，余无他恙。检查：尿正常，舌淡红，苔薄白，脉细。证属气虚不固。治当益气固肾，投予黄芪五子汤加煅龙骨、煅牡蛎各 10g，桑螵蛸 5g。服完 4 剂见效，遗尿未再发生。

【方名】 健益固脬汤。

【组成】 太子参、芡实各 15g,金樱子、覆盆子、山茱萸、益智仁、桑螵蛸、红枣各 10g,陈皮、鸡内金各 5g,黄芪 10g。

【来源】 王乐平,四川中医,1992,(7):42。

【功效】 健脾益肾,固脬止遗。

【适应证】 小儿遗尿症。

【方药简析】 方中太子参益气健脾;金樱子、芡实、山茱萸、覆盆子补肾止遗;桑螵蛸、益智仁培元补肾缩尿,舒利气机;鸡内金健脾缩尿止遗;红枣、陈皮健运脾胃。俾脾气强健,肾精气足,气化正常,膀胱约束有力,遗尿自止。神疲乏力,纳少便溏加黄芪 10g,升麻 6g,砂仁 3g;睡眠过熟或多梦易醒加五味子、郁金各 6g;体虚多汗加煅龙骨、煅牡蛎各 10g;面色苍白、畏寒肢冷加补骨脂、菟丝子各 10g;遗尿久治不愈加麻黄 3g。

【病案举例】 孙某,男,8岁,1988年11月5日诊。素有遗尿,每晚必有尿床,甚则2~3次;小便频数,形体消瘦,面色萎黄,神疲乏力,食欲欠佳,大便或溏或实,舌质淡,苔薄腻,脉细数,证属脾肾气虚,膀胱失约。治拟健脾益肾,固脬止遗,方用健益固脬汤加升麻 5g。服药7剂,遗尿停止,精神转佳,食欲增进。上方继服6剂,精神佳,食欲振,遗尿未再出现。

【方名】 滋肾通关丸。

【组成】 黄柏 12g,知母 10g,肉桂 3g(后下)。

【来源】 李杲《兰室秘藏》。

【功效】 清下焦湿热,助膀胱气化。

【适应证】 热蕴膀胱,尿闭不通,小腹胀满,尿道涩痛,老年阴虚火旺,湿盛下焦之遗尿。

【方药简析】 方中黄柏、知母滋肾阴以制相火；肉桂以阳配阴助其气化。邓国强用滋肾通关丸治疗小儿遗尿43例，40例痊愈（遗尿症状、体征完全消失）；2例好转（遗尿症状、体征明显减轻）；1例无效（遗尿症状、体征无变化）。总有效率97.5%。

【病案举例】 袁某，男，67岁，1991年9月12日初诊。患尿床3月余，常入睡即尿床，每夜少则一次，甚则二三次，尿后方知，量少味臊，心烦多梦，口干口苦，喜用舌舔唇，手足心热，形体素瘦。查体：舌体瘦小光剥，舌根有腻苔，脉濡细数。化验尿液无异常。证属阴虚火旺，湿盛下焦，水湿妄行。方用滋肾通关丸加升麻、怀牛膝各5g，上方煎服3剂后，尿床次数减少。再进2剂，尿床即止，诸症悉减[王春才，四川中医，1992，（7）：25]。

【方名】 葛根汤。

【组成】 葛根10g，麻黄4g，桂枝、炙甘草、白芍各6g，生姜2g，大枣7枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 发表散寒。

【适应证】 小儿遗尿症等。

【方药简析】 葛根汤为桂枝汤加葛根、麻黄而成。方中桂枝汤调和营卫；葛根解肌生津；麻黄发表散寒。现代药理研究认为麻黄含麻黄碱，该成分对膀胱括约肌有明显的兴奋作用，故对夜间遗尿有效。

【病案举例】 李某，男，8岁，1984年1月7日诊。每在睡中遗尿3年余，一夜尿床1~2次，醒后方觉。曾服健脾益肾、固涩缩尿之品及针灸治疗，效果欠佳。患儿饮食尚可，发育正常，舌质淡，边有齿印，苔薄白，脉缓。方用葛根汤原方，连服9

剂,痊愈。随访至今,未再发生遗尿[林家坤,四川中医,1987,(5):25]。

【方名】 补中益气汤。

【组成】 黄芪、党参各 24g,白术 15g,当归 12g,陈皮、柴胡各 10g,升麻、炙甘草各 6g。

【来源】 李杲《脾胃论》。

【功效】 补中益气,升阳举陷。

【适应证】 脾胃气虚,气虚下陷。

【方药简析】 方中以黄芪益气为君;人参、白术、炙甘草健脾益气为臣;共收补中益气之功;配陈皮理气,当归补血,均为佐药。升麻、柴胡升举下陷清阳,为补气方中的使药。畏寒肢冷加肉桂、附子;多梦易惊加菖蒲、生龙骨、生牡蛎。于杨波用补中益气汤加减治疗遗尿症 13 例,治愈(遗尿完全消失,随访半年未复发)8 例;好转(服药后遗尿消失,但随访半年内每因劳累即复发)5 例。

【病案举例】 范某,女,47 岁,1991 年 10 月 9 日就诊。患者于 7 个月前出现尿失禁,始仅在劳累后发作,3 个月后休息状态亦发作,曾多方求治无效。刻诊:精神疲惫,表情忧郁,面色苍白,伴纳呆,失眠。查体:其舌质淡红边有齿印,苔白,脉细。考虑该患者为个体经营者,长期以来操心劳神,思虑过度而伤脾致中气下陷。故用补中益气汤加远志 12g,益智仁、五味子各 10g。6 剂后遗尿仅在夜间发作 1 次,且食欲增强,睡眠转佳,精神好。效不更方,继服上方 6 剂,症状完全消失,一如常人,为巩固疗效,又服上方 6 剂,随访至今未复发[于杨波,四川中医,1994,(2):33]。

【方名】 遗尿散。

【组成】 仙灵脾 120g,仙茅 90g,炒山药 90g,五味子 15g。

【来源】 孙均遂,新医学,1976,(4):162。

【功效】 温肾补阳,健脾收敛。

【适应证】 阳虚型遗尿症。

【方药简析】 方中仙灵脾、仙茅温肾补阳;山药益气健脾;五味子收敛固涩。四药合用,具有温肾补阳、健脾收敛的作用。上药晒干微烘研末,每日早晚各1次,每次6g。温盐开水适量调服。

【病案举例】 张某,男,52岁,1975年6月13日初诊。患者夜间遗尿已10余年。每到冬季更甚,每夜遗尿1~2次,伴腰脊酸软,形寒怕冷。查体:舌质淡,苔薄白,脉沉细。治宜温补脾肾,收敛固涩。方用遗尿散。连服半月后,遗尿止,诸症皆愈。

【方名】 桑螵蛸散。

【组成】 桑螵蛸、远志、石菖蒲、龙骨、人参、茯苓、当归、龟甲各30g。

【来源】 寇宗爽《本草衍义》。

【功效】 调补心肾,涩精止遗。

【适应证】 心肾两虚之遗尿症。

【方药简析】 方中桑螵蛸补肾益精,固脬止遗是为君药;龙骨敛心神而涩精气,龟板益阴气而补心肾,并为臣药;人参补中气,当归养心血,茯苓安心神,并为佐药;远志、石菖蒲安神定志而交通心肾,是佐而兼使之用。诸药配合,既能补肾益精、涩精止遗,又能补心养神,从而起到两调心肾,交通上下,收敛固涩之效。

【病案举例】 刘某,女,42岁,1983年9月29日诊。患者

夜间遗尿已30年余,每逢疲劳之后即遗尿。近因工作劳累,每夜遗尿1~2次,伴多梦,腰痛,精神萎靡,神志恍惚,健忘。查体:舌淡苔薄,脉弦细。治宜固肾气、益心神。方用桑螵蛸散加淫羊藿10g。连服10剂,30年之痼疾竟然痊愈。嘱其注意休息,加强营养,并以大补元煎常服之以善后收功[肖伍华,四川中医,1986,(10):50]。

【方名】 肚关芪附汤。

【组成】 猪膀胱1个,夜关门30g,黄芪30g,附片30g,益智仁2g,党参30g,山药30g,黑豆60g,糯米100g。

【来源】 陈胤夫,四川中医,1985,(10):53。

【功效】 补阳益气,养阴缩尿。

【适应证】 小儿遗尿症。

【方药简析】 方中附片、益智仁温补肾阳,摄缩小便;党参、黄芪、山药补脾肺之气;黑豆、糯米培土滋阴;夜关门乃养阴缩尿之要药,借猪膀胱血肉有情之品以补其膀胱之虚,诸药合用有补阳益气、养阴缩尿之功。用时先将夜关门、黄芪、益智仁加水2000~3000ml,将猪膀胱洗净,糯米、黑豆盛入其中,用针刺猪膀胱无数孔,再把党参、附子、山药放入药液中,放盐,用文火炖熟猪膀胱为度,每日3餐连同饭吃,每周1次。

【病案举例】 漆某,男,13岁,1972年12月2日诊。患尿床10年,尤以冬季为甚。近1月来加重,每晚遗尿1~2次,白天有时尿在裤内。现症:面色苍白,纳差懒言,食油腻过重则便溏,舌淡,脉沉。辨证为肾阳不足,脾肺气虚。以肚关芪附汤连服6周,病瘥,至今未发。

【方名】 补骨脂红枣汤。

【组成】 补骨脂3~6g,红枣12g,猪膀胱1个。

此乃心经痰热，予清心止遗汤。服 5 剂后，仅遗尿 1 次，再服半月，随访半年未复发。

34 脑 积 水

脑积水是指脑脊液生成循环吸收过程发生障碍而致脑脊液量过多,压力增高,扩大了正常脑脊液所占空间,引起脑室和/或蛛网膜下腔异常扩大为特征的病理状态。多发生在2岁以内的婴儿,其发生率在新生儿为0.5%~4%。脑积水根据解剖可分为交通性和非交通性两大类,交通性是指脑脊液在脑表面的吸收受阻而言,非交通性是指脑室系统内的脑脊液循环阻塞。根据发病时间,于出生时就存在脑积水者为先天性脑积水,在出生后发生者为后天性脑积水。临床上主要以非交通性脑积水多见。脑积水不是一种病,而是由多种病因引起的一种病理结果。先天性脑积水的病因主要有室间孔闭塞、导水管闭锁或狭窄、小脑扁桃体下疝畸形、四脑室正中孔和侧孔发育不良、先天性蛛网膜囊肿、先天性肿瘤和血管性病变(动静脉畸形、动脉瘤等)。后天性脑积水主要由各种良性或恶性脑膜炎或蛛网膜下腔出血后脑室系统粘连等引起。交通性脑积水常继发于脑膜炎、蛛网膜下腔出血或颅内手术后、原发性脑瘤和颅内转移瘤及少见的脉络膜丛分泌异常、颅内静脉窦狭窄或阻塞等。脑积水可引起皮质萎缩,脑回变小,脑沟变宽;阻塞部位以上的脑室和/或脑池扩大。镜下可见神经细胞退行性变、白质脱髓鞘变和胶质细胞增生。先天性脑积水主要表现为婴儿出生后数周或数月头颅快速进行性增大,增大速度为正常的2~3倍。额部前突,头皮变薄,静脉怒张,前囟增宽隆起且张力增高,颅缝裂开,叩诊可现“破壶声”。双眼下视,上巩膜

暴露呈日落征。早期或病情较重时,除大头外可有生长发育迟缓、吵闹、精神萎靡或嗜睡,以及原因不明的发热,头部不能抬起;呕吐少见,多无神经系统异常。晚期或病情严重时,则出现生长发育严重障碍,智力差,眼震,斜视,癫痫,肢体瘫痪,意识障碍而逐渐衰竭死亡。后天性脑积水可见于任何年龄,主要表现为头痛、呕吐和视乳头水肿的颅内压增高综合征。但若脑积水发展缓慢时,只有轻微的头痛、个性改变和精神障碍。本病的诊断比较明确,主要是查找病因。且须与未成熟儿,佝偻病,头大畸形,慢性硬脑膜下血肿,颅内占位性病变相鉴别。本病早期或病情较轻发展缓慢者可用利尿剂或脱水剂,也可经前囟或腰椎反复穿刺放液;必要时采用手术治疗。

小儿脑积水属中医解颅范畴,成年人脑积水根据临床主证不同则分属于头痛、呕吐、视物昏蒙范畴。其病因可分为先天因素及后天因素两种,先天因素多因母体多孕多产,或久病气血虚弱,在胎成之际元精已虚,气血供养亦差,致胎儿先天禀赋不足,产后懦弱。因此,胎禀肾气不充,精髓不能充于脑,脑腑气血运行失畅,而引起头颅逐渐增大。后天因素多因外感六淫之邪,邪气蕴结,或阳虚水泛,脉络不畅,或脾虚失运,水湿内停而致颅腔增大。中医治疗分为热毒壅滞、肾气亏虚、脾虚水泛、淤阻脑络四型,用犀角活络丹、补肾地黄丸、五苓散、通窍活血汤而取得了较好疗效。与利尿剂或手术相比,使用中药安全可靠,反复性少,用药后尿量增加,而不影响脑组织的钾钠等电解质的平衡,保持细胞内环境的相对稳定,避免或减少治疗中的不良反应和并发症。使用活血化淤药能增强血液循环动力,促进脑脊液的循环,改善毛细血管的通透性,减少脑室内脉络丛过多的分泌脑脊液,促进对脑脊液的吸收,并对因感染而受损的血-脑屏障有恢复作用。

张学文用通窍活血利水方,丹参 15~30g,川芎 10~12g,

赤芍 10~12g, 桃仁 10~15g, 红花 10~15g, 益母草 15~30g, 川牛膝 10~15g, 茯苓 15~24g, 麝香 0.1~0.2g(冲服), 缺麝香时可用白芷 10~12g, 冰片 0.1~0.15g(冲服)代替之, 鹿角胶 6~10g, 桂枝 6~10g, 石菖蒲 6~9g, 琥珀 1~2g(冲), 淡黄酒 30~50ml。共治疗脑积水 21 例, 基本痊愈 10 例, 显效 7 例, 有效 2 例[中国中医急症, 1995, (5): 209]。

史淑琴以六味地黄汤合四君子汤, 或合苓桂术甘汤, 或用扶元散治疗本病也取得了较好疗效[黑龙江中医药, 1991, (2): 27]。

郭锦章等采用补肾填髓, 健脾利水方治疗本病也取得了满意效果[江苏中医杂志, 1986, (5): 25]。

【方名】 己椒蒴黄丸合五苓散加减方。

【组成】 防己 10g, 椒目 6g, 葶苈子 8g, 熟大黄 8g, 桂枝 6g, 茯苓 20g, 白术 10g, 猪苓 10g, 泽泻 10g, 太子参 18g, 黄芪 20g, 丹参 10g。

【来源】 黄少华, 云南中医杂志, 1991, (4): 18。

【功效】 健脾利水, 活血祛瘀, 温阳益气, 利尿消肿。

【适应证】 脑积水。

【方药简析】 本方用药在传统的利小便基础上取张仲景前后分消利水之己椒蒴黄丸合温阳利水之五苓散加减以符合脑积水的病机。方中防己、椒目辛宣苦泄, 导水从小便而出; 葶苈子、大黄攻坚决壅, 逐水从大便而去, 前后分消, 水气四通, 脾气转输, 津液自生; 桂枝通阳化气行水, 白术健脾利水, 猪苓、茯苓、泽泻利小便而导水下; 太子参、黄芪、丹参益气健脾、利水活血化瘀。若肾虚加菟丝子、枸杞子、龟板胶; 痰湿甚者加竹茹、胆南星、天竺黄、半夏; 瘀血重者加赤芍、当归尾、三棱、三七。现代药理研究证实, 防己、椒目、葶苈子、大黄、茯苓、

白术、猪苓、泽泻、黄芪均有利尿作用,尤其是大黄能提高远段和中段结肠的张力并促使其运动加强,抑制大肠内水分的吸收,使水分滞留于肠腔而促进排便,使水分从后而出。另有丹参扩张血管改善全身血液循环作用,防己、泽泻有降压之功,均有助于颅内脑脊液循环障碍的改善。其机理可能是利尿与扩血管药物的协同作用降低了颅内压,疏通了脑脊液循环障碍,从而使本病部分患者得以治愈。黄少华老中医用上方治疗脑积水 21 例,其中男 15 例,女 6 例;年龄 2 岁半~8 岁,平均 3 岁半;病程 2 个月~8 年,平均病程 3 年半。治疗后显效(囟门闭合,经脑 CT 或 B 超确诊为颅内积水消失,头围恢复正常,智力发育正常,临床症状消失)1 例,有效(囟门未完全闭合但较以前明显好转,积水较前减少,头围缩小,临床体征减轻,智力发育较正常)9 例,无效 11 例。其治疗结果显示就诊时间越早,年龄越小,即在半岁至 1 岁左右则效果较好,而年龄偏大,患病时间长,至五迟、五软阶段则症属难治。21 例中,有效者均为年龄在 1 岁以内而及时就诊者。脑积水因是顽症,故治疗时间长,见效慢,一般长达 1 年以上,当需坚持服药,随证调理始能见效。

【病案举例】 陶某,男,4 个月零 15 天,1989 年 8 月 10 日就诊。患儿眼睑下垂,眼球下沉,烦躁不安,偶有呕吐,头颅明显增大,骨缝分离,前囟扩大且饱满,头皮静脉扩张,经多家医院诊为脑积水,治疗效果欠佳。患儿指纹伏,舌苔薄。中医辨证属脾气虚弱,健运失常之解颅,以益气健脾利水为法。处方:防己 10g,椒目 6g,葶苈子 5g,熟大黄 3g,桂枝 6g,茯苓 20g,猪苓 10g,泽泻 10g,白术 10g,炙甘草 3g,黄芪 18g,丹参 10g,半夏 10g,竹茹 10g。以本方加减连服 3 个月,患儿囟门逐渐闭合,精神、饮食好转。改用参苓白术散合己椒苈黄丸化裁以调理兼利水湿,坚持服药至 1990 年 10 月 10 日复诊时,B

处方,回家用药。20天后家长来函,用药后精神好转,食欲增加,呕吐消失。服45剂后复查,精神正常,头围61.5cm,前囟4.5cm×5cm,骨缝缩小。停外敷药,改用茯苓、猪苓、车前子、熟地各6g,白术4g,陈皮、半夏各5g,当归10g,桂枝、甘草、山茱萸、川牛膝各3g。至1979年4月24日复诊,精神活泼,喜笑自如,能独立坐玩;头围47cm,外形正常,骨缝已合,1983年再次复诊,健康如常儿。

【方名】 通窍活血利水汤。

【组成】 当归3~9g,赤芍3~9g,川芎3~9g,红花3~9g,桃仁3~9g,丹参3~9g,黄芪3~9g,地龙3~9g,全蝎3~9g,车前子3~9g,石菖蒲3~9g,麝香0.3g,葱白1根,大枣3枚。

【来源】 宋虎杰,新中医,1991,(7):22。

【功效】 活血化淤,通窍利水,益气扶正。

【适应证】 脑积水。

【方药简析】 本方是在王清任通窍活血汤基础上加黄芪、地龙、全蝎、车前子、菖蒲、丹参而成。通窍活血汤合丹参、地龙、全蝎活血化淤,通窍舒络;车前子、菖蒲利水去湿;黄芪、甘草补益扶正,健脾利水。若眼球震颤者,加天麻、钩藤、僵蚕;眼球下旋者,重用黄芪。同时外用活血通水膏,方药:红花60g,艾叶60g,皂角150g,麝香1g,将前三味加水2500ml,煎2h后去渣取汁,浓缩至药液能吊起线为止,再加入麝香调匀,装入瓶内密封,置冰箱或加防腐剂备用。用时先剃光患儿头发,将活血通水膏均匀涂于头上,颅缝及囟门处适当涂厚,然后再用绷带包裹,每日早、晚用温水湿敷绷带各1次,使其保持一定的湿度,每周换药1次。以上内外兼治,30天为1疗程,中间休息3天。宋虎杰用上法治疗脑积水7例,其中男4

【方名】 六味地黄利水汤。

【组成】 熟地黄 10g, 山药 10g, 山茱萸 10g, 茯苓 6g, 牡丹皮 6g, 泽泻 6g, 木通 12g, 车前子 30g。

【来源】 龙锦焯, 广西中医药, 1982, (5): 36。

【功效】 滋阴补肾, 益髓利水。

【适应证】 脑积水。

【方药简析】 本方是六味地黄丸加味而成,《成方切用》云:“六味地黄丸纯阴重味,润下之方也……,宋钱仲阳治小儿行迟,齿迟,脚软,颇开发热诸病,皆属肾虚,而小儿稚阳纯气,无补阳之法,乃用此方,应手而效。”今按其意用熟地黄、山茱萸、山药滋阴补肾;牡丹皮清泻防真阴亏损而易致上炎之虚火;泽泻、茯苓泻浊利水,合木通、车前子加强清热,促进脑内水液排出。

【病案举例】 覃某,男,11个月,1980年9月12日入院。患者6月份因患病毒性脑炎到我院留医,后期出现脑积水,经用利尿、脱水剂,症状消失而于8月23日出院。回家后15天,再度出现呕吐,头颅增大,前囟隆突紧张而重新入院。入院后确诊为脑积水,继续服原西药治疗,口服双氢克尿塞,静脉推注甘露醇,尿量日逐渐增加;连续用药4天后,颈以下躯干及四肢比入院时明显瘦小,皮肤皱褶,弹性较差,但颈以上头部形状与入院时一样,前囟始终明显隆突,头皮发亮,头颅无显著缩小,两眼眶无凹陷,考虑脑脊液通路有阻塞,因经西药治疗未见好转而改行中医试治。初诊时,患儿面色苍白,精神较差,头大脸小,头围50cm,前囟隆突饱满,近5cm×6cm,后囟已闭,颅缝明显分离,头皮静脉怒张,整个头皮软而发亮,颅部叩诊呈破罐声,眼白显露,颈软,心、肺、肝、脾无异常,指纹青淡,舌淡、苔薄白,诊为解颅。治宜滋阴补肾,佐以利水。方选六味地黄汤加味:熟地、山药、山茱萸各10g,茯苓、牡丹皮、泽

泻各 6g,木通 12g,车前子 30g。上药连进 6 剂后,精神较前有所好转,头皮有些皱缩,头围缩小 0.4cm,症状有所减轻,说明药已对证,故嘱其守方再进 12 剂。3 诊时囟门明显缩小,张力不如原来紧张,骨缝也不显著裂开,唯胃纳稍差,故原方加党参、白术以开胃健脾。上方连服 21 剂后,患儿精神活泼,进食好,头围由原来的 50cm 缩小至 45.5cm,前囟由原来的 5cm×6cm 缩小至 2cm×1cm,头皮静脉不显露,头部叩诊破罐音消失。守原方再服 8 剂,观察无复发而于 1980 年 10 月 29 日痊愈出院。

【方名】 补肾健脑方。

【组成】 鹿角粉 120g,核桃仁 200g。

【来源】 王作人,山东中医杂志,1985,(2):42。

【功效】 补肾健脑,填精益髓。

【适应证】 先天性脑积水。

【方药简析】 鹿角咸温,入肾经,兼入心肝经,补肾填精,益髓充脑,行血消肿;核桃仁甘温入肺肾经,补肾固精,健脑佳品。2 药共为细面,每日 1 次,每次服 16g,20 天为 1 疗程。同时在服药期间,坚持每日喝骨髓汤(猪、牛、羊骨均可),以脏补脏,可收到良效。

【病案举例】 李某,男,2 岁,1973 年 10 月 3 日初诊。患儿从 6 个月“头长得特别快”,现在只会站,不会走;只会吃奶,但不吃饭,常哭闹。曾去省级医院诊断为“先天性脑积水”,治疗无效,来我院求治。检查:智力迟钝,不会说话,只会发“啊啊”声,两眼球上吊,不灵活,白睛多;头围 55.2cm,前额凸出,囟门没闭合,骨缝开,可见血管跳动,头叩诊有破罐声。此为先天禀气不足,肾元大亏;肾主脑髓,肾亏则脑髓不足,治宜补肾健脑。处以鹿角粉 120g,核桃仁 200g。将 2 药共为细面,为

1 疗程量,分 20 天服完;每日 1 次,每次 16g。另外在服药期间,坚持每日喝骨髓汤,量不限(猪、羊、牛骨皆可)。上方服用 5 个疗程后,患儿不再经常哭闹,能正常饮食,会回答简单的问话,能慢慢行走 10 余步,两眼球正常,头围 50.1cm,骨缝已愈合,凶门基本闭合。药已对症,前方继进 2 个疗程。2 年后随访,和正常同年龄组儿童基本相同。

【方名】 刘春圃治脑积水方。

【组成】 金银花 30g,蒲公英 30g,黄芩 12g,漏芦 12g,路路通 12g,木通 9g,白茅根 30g,石菖蒲 12g,牡丹皮 30g。

【来源】 卢祥之,名中医治病绝招,中国医药科技出版社,1989。

【功效】 清热解毒,通窍利水。

【适应证】 耳源性脑积水。

【方药简析】 方中金银花、蒲公英、黄芩清热解毒以治病源;用漏芦、石菖蒲、路路通、木通、白茅根通窍利水以降低颅内压;更用牡丹皮凉血活血化淤以加强疗效。不仅治疗脑积水,同时亦治疗中耳炎,一举双得。

【病例举例】 陈某,女,27 岁,1990 年 1 月 21 日以“发热、头痛、呕吐、嗜睡 1 周”为主诉而入院。后确诊为“慢性化脓性中耳炎(发病 2 年余)、脑脓肿”,经过应用西药抗生素、激素、脱水剂、支持疗法及对症处理等综合措施,治疗 20 余天,病人已基本脱离危险,病情稳定。但病人仍时有头痛、恶心、呕吐症状。2 月 8 日再次腰穿,经静注 20%甘露醇溶液,2h 后测得脑脊液压力在 1.96kPa 以上,脱水剂由原来的每天 6 次逐渐减到每天 1 次。曾经试验停用脱水剂,但一停病人即出现头痛、恶心呕吐症状,再次确诊为“耳源性脑积水”,决定配合中药试停脱水剂。患者现症:时有头痛,恶心、呕吐,口苦,咽干,

大便干结、视物不清。检查：右耳有脓性分泌物流出，舌苔黄腻、质紫暗，脉弦滑。证属热毒壅盛，气血受阻，上攻于头，脑水的正常循环受阻而潴留，致使脑压增高。傅文录用《名中医治病绝招》中刘春圃老中医治疗耳源性脑积水清热解毒、通窍利水法方法。原方应用：金银花 30g，蒲公英 30g，黄芩 12g，漏芦 12g，路路通 12g，木通 9g，白茅根 30g，石菖蒲 12g，牡丹皮 30g。患者服中药 1 天后，头痛时间明显后移。服药 4 天后，脱水剂已减为隔天 1 次。后带药出院，吃中药 10 余剂，脱水剂已逐渐停用，头痛已不明显；又服用原方 20 余剂，一切恢复正常。5 月 10 日复诊，再次腰穿，脑脊液压力正常，右耳中耳炎也已痊愈，患者一如常人[中医研究，1990，(6)：19]。

【方名】 消囊利水方。

【组成】 决明子 18g，密蒙花 30g，夜明砂 18g，天麻 12g，钩藤 18g，薄荷 3g，车前子(包)15g，泽泻 18g，篇蓄 15g，木通 15g，白芷 20g，槟榔 15g，南瓜子 30g，大黄 9g，甘草 6g，青箱子 15g，莱菔子 18g，鸡内金 12g，半夏 12g，白术 12g。

【来源】 秦庆云，江苏中医杂志，1986，(6)：17。

【功效】 健脾化湿消肿，杀囊虫，止痛。

【适应证】 脑囊虫病引起的脑积水头痛。

【方药简析】 方名为编者所加，方中槟榔、南瓜子驱杀囊虫；车前子、泽泻、篇蓄、木通、白术利水祛湿；大黄、半夏引水下行；密蒙花、夜明砂、青箱子、薄荷清利头目，改善视力；天麻、钩藤、白芷平肝止头痛；莱菔子、鸡内金理气和胃；白术、甘草益气健脾。

【病案举例】 患者某某，男，25 岁，1981 年 2 月 8 日初诊。自 1978 年 6 月在济宁市山东寄生虫防治院切皮下囊包，经化验证实是猪囊虫病；用吡喹酮治疗 1 年，全身皮下囊包基

本消失,唯右耳后有 2 个包囊没有消失。患者每天头痛剧烈,难以忍受;诊断为脑积水。每日静滴甘露醇 200ml 才能入睡,否则躁动不安,故决定行颞肌下减压手术。家长不同意,要求服中药治疗。诊时头痛剧烈,视物不清,面眇白,全身浮肿,两目无神,倦怠,腰痛,纳呆,尿白,尿检正常;脑电图异常。脉细濡,舌质淡,苔白腻。处方:决明子 18g,密蒙花 30g,夜明砂 18g,天麻 12g,钩藤 18g,薄荷 3g,车前子(包)15g,泽泻 18g,篇蓄 15g,木通 15g,白芷 20g,槟榔 15g,南瓜子 30g,大黄 9g,甘草 6g,青箱子 15g,莱菔子 18g,鸡内金 12g,半夏 12g,白术 12g。2 月 12 日复诊:药后头痛消失,视物清楚,全身浮肿消失,自感气力稍增,腰痛轻,食欲增加。效不更方,续服 12 剂。患者能从事体力劳动,于 1981 年 12 月结婚,随访至今健康。

【方名】 补肾地黄汤。

【组成】 熟地黄 20g,山药 15g,肉苁蓉 10g,山茱萸 10g,茯苓 10g,泽泻 15g,车前子 10g,姜半夏 10g,姜竹茹 10g,蒲公英 15g,生甘草 5g。

【来源】 仲虎才,江苏中医杂志,1984,(4):19。

【功效】 补肾利水,兼以解毒。

【适应证】 化脓性脑膜炎性脑积水。

【方药简析】 方中六味地黄丸去牡丹皮加肉苁蓉补肾益髓;茯苓、泽泻、车前子、姜半夏、姜竹茹利水祛湿降浊,止呕引水下行;蒲公英、甘草清热解毒祛邪,调和诸药;甘草、茯苓兼以健脾。

【病案举例】 郑某某,男,6 个月,1982 年 6 月 6 日就诊。患儿 4 月底发热,喷射性呕吐,抽搐,前囟隆起,先后在区、县医院治疗,诊断为化脓性脑膜炎合并硬脑膜下腔积液。又转外地诊治,在××部队总医院及××医院均诊为“化脓性脑膜炎

(恢复期)、脑积水”，并告患者家属目前无特殊有效治疗方法。乃转由中医诊治，症见前囟隆起，按之稍软，头缝开解，头颅增大，头围 44cm，前囟 4cm×4.5cm，面色苍白，精神萎靡，频频呕吐，大小便尚调；患儿系第 1 胎，未足月生产，母乳喂养，营养、发育一般，可见患儿先天禀赋不足。肾主骨生髓充脑，为先天之本，肾亏则脑髓不足，故头缝开解；肾虚水泛，水积脑中，出现脑积水而头颅增大。治拟补肾利水，佐以止吐，用补肾地黄汤出入。处方：熟地黄 20g，山药 15g，肉苁蓉、山茱萸、茯苓各 10g，泽泻 15g，车前子（包）、姜半夏、姜竹茹各 10g，蒲公英 15g，生甘草 5g，5 剂。嘱其父母停用一切西药，将上药煎汤装在热水瓶中，少量多次给患儿喂服。复诊时，家属来诉，药投 2 剂，呕吐获除，5 剂后，小便增多，大便亦如水样。效不更法，原方去姜半夏、姜竹茹，肉苁蓉改菟丝子，加桔梗，续进 5 剂；嘱其 1 剂药服用 2 天。后以上方去蒲公英，加炒白术、薏苡仁等。用药近 50 剂，持续 80 多天，患儿头部变小，头围 40cm，前囟 3cm×3cm，积水已消。停药 7 月，未见不适。追访至今，已会走路，喜笑自在，一切如常。

歇期,指端出现水泡或局部溃疡(即坏疽)与指甲畸形,有时皮肤和皮下组织反而干燥变黑。本病的诊断根据典型临床表现及甲皱微循环和冷水或握拳激发试验即可做出。但需与雷诺现象(又称雷诺综合征,是指继发于颈椎病、多发性肌炎或其他结缔组织病等所见到的肢端动脉痉挛现象)及脊髓空洞症、颈髓肿瘤、脊髓结核、铅及砷中毒、血清中冷球蛋白血症及冷凝集素增多所引起的肢端发白、青紫现象相鉴别。西医目前尚无特效治疗,应保温防冷,避免潮湿、精神过度紧张和肢端外伤,忌烟,经常按摩肢端,促进血液循环。可使用血管扩张剂、儿茶酚胺耗竭剂、镇静剂、调节植物神经药物,并配合理疗,局部外敷硝酸甘油软膏等。

中医认为雷诺病属厥证或痹证范畴,其病位在肢端,而肢端又为人体十二经脉阴阳交接之处,若因素体血虚气弱,阳气不足,复受寒邪侵袭肢端,以致阴阳阻滞,气血运行不畅,不能温养四肢,使经脉交接处“阴阳之气不相顺接”而发病。当阴盛阳衰,寒凝血淤则见肢端阵发苍白与紫绀,继而阴消阳复,“气行则血行”,故见肢端潮红,此刻阴阳相交,气血运行复常,而病症消失。如此反复发作,迁延不愈,可使发作次数增加,持续时间延长,病情加重。辨证多分为寒凝经脉(用阳和汤)、血淤阻络(用丹参通脉汤,丹参 30g,赤芍 30g,当归 30g,桑寄生 30g,黄芪 15g,鸡血藤 30g,川芎 15g,川牛膝 15g,乳香 9g,没药 9g)、气虚血淤(用黄芪桂枝五物汤)、淤血化热(用四妙勇安汤),可配合针灸治疗。

李德俭等将其分为阳郁型(用逍遥散去柴胡加红花、桂枝、乳香、鸡血藤)、气虚寒凝型(黄芪桂枝五物汤加川芎、鸡血藤)、血虚寒凝(当归四逆汤)、阳虚寒凝(用温经回阳通淤汤,桂枝、当归、赤芍、白芍、熟地、炮姜、鹿茸、牛膝、党参、附子、红花、细辛、甘草)治疗 42 例。全部治愈,最短 20 天,最长 4 个月

[浙江中医杂志,1990,(6):254]。

陈敏等将本病分为脾肾阳虚(用黄芪桂枝五物汤加附子、干姜、肉桂、鹿角霜)、寒凝阻络(用活血通脉汤,丹参 50g,赤芍 30g,王不留行 20g,鸡血藤 30g,当归 20g,川芎 20g,地龙 15g),湿热型(用四妙勇安汤加薏苡仁、红花、苍术、丹参、黄柏、黄芩),同时配合硝苯地平共治 18 例,总有效率 94.4% [黑龙江中医药,1992,(5):14]。

高兰宇用独活寄生汤[浙江中医杂志,1998,(2):66],张学安[黑龙江中医药,1989,(3):46]、吴权国[中国医药学报,1991,(6):34]、王瑞凤[云南中医杂志,1990,(5):30]均用当归四逆汤治疗本病都取得了较好疗效。

张绍利用补阳还五汤治疗本病 3 例[上海中医药杂志,1985,(12):29]效果满意。

程运文用温阳化痰祛瘀汤(桂枝、巴戟天、熟附子、生黄芪、山茱萸、白芥子、姜半夏、浙贝母、当归、丹参、白芍、乌药各 10g,制南星、白附子、制乳香、制没药各 5g,细辛、生姜各 3g),治疗本病 40 例,治愈 37 例,好转 2 例,无效 1 例[河南中医,1991,(5):30]。

赵炎用内外结合治疗雷诺病 42 例,处方:当归、桂枝、白芍、细辛、炙甘草、川芎、木瓜、苏木、红花、地龙。寒甚加附子、肉桂、干姜;淤滞加乳香、没药、水蛭;气虚加黄芪、党参、白术;血虚加熟地、阿胶珠。水煎 3 次,前 2 次早晚分服,第 3 次加入适量童便浸手,以不烫手为度,约半小时,早晚各 1 次。结果痊愈 3 例,显效 12 例,有效 6 例,无效 1 例[浙江中医杂志,1992,(9):395]。

【方名】 温经通络汤。

【组成】 熟附子 15g(先煎),当归 20g,桂枝 25g,威灵仙

30g,鸡血藤 25g,丹参 20g,干姜 15g,黄芪 20g,细辛 5g(后下),肉桂 15g,白芍 10g。

【来源】 孟祥全,黑龙江中医药,1992,(2):18。

【功效】 温经散寒,活血通络。

【适用证】 雷诺病。

【方药简析】 方中附子能温一身之阳,上助心阳以通脉,下补肾阳以益火,《医学衷中参西录》附子解:“附子味辛,性大热,为补助元阳之主药,其力能升能降,能内达能外散,凡凝寒痼冷之结于脏腑,着于筋骨,痹于经络血脉者,皆能开之,通之”;当归、丹参、鸡血藤养血行血,活络止痛;桂枝温经通阳,白芍敛阴和营,二者合用能调营卫,和阴阳;黄芪补气固表;干姜、肉桂、细辛、威灵仙温经回阳,散寒通络;诸药共凑温经散寒,调和气血,通络止痛之功。同时结合病情应用附子,灵活掌握用量与用法。根据附子煎煮时间越长,其毒性越小,而药效不减这一特点,治疗寒症,用量从 15g 逐步增加到 50g,无一例中毒反应,而且效果显著。若伴有针刺样痛者加王不留行 20g、乳香、没药各 15g;痒痛者加川芎 15g,防风 15g;肢端冷麻者加红花 10g、乌梢蛇 20g。孟祥全用本方治疗雷诺病 20 例(其中女性 19 例,年龄在 22~39 岁;病程最短者 1 年,最长者 5 年),治愈 17 例(症状体征消失,随访 1 年无复发),好转 3 例(症状与体征基本消失,随访 1 年以上偶见转度发作),一般服药 10~15 剂开始显效,服药最少者 15 例,最多者 30 例。

【病案举例】 张某,女,35 岁,于 1988 年 2 月 4 日初诊。患者平素阳虚,四肢不温,受寒后易大便溏泄。于 2 年前冬天,因感寒冷忽然发现两手指变苍白,伴手指紧缩麻木感,当即以手揉搓后,转青紫再转潮红,然后逐渐恢复。每遇寒冷病即诱发,需用温水浸泡或揉搓后方能缓解。因冷水洗衣,现症状加重,频繁发作,经西医诊断雷诺病,多方治疗效果不佳。诊见面

色晄白,畏寒肢冷,两手指端遇寒凉冷麻刺痛,舌淡白湿润,舌体胖嫩,脉沉迟。投以温经通络汤,熟附子用 20g,(先煎 20min),红花 10g,乌梢蛇 20g,乳香、没药各 15g,王不留行 20g,服 9 剂。服药后两手指端刺痛消失,原方减去乳香、没药,增加附子用量 30g,先煎 40min,续服 10 剂。12 月 24 日三诊:服药后,两手指冷麻痛症状减轻,但仍觉四肢不温,原方重用附子 50g,先煎 80min,续服 3 剂。服药后,诸症均减,四肢转温,效不更方,再服 2 剂,病症悉除,接触冷水不再发作,随访至今未复发。

【方名】 加味当归四逆汤。

【组成】 当归 10g,黄芪 10g,桂枝 10g,制川乌 10g,丹参 10g,桃仁 10g,红花 10g,地龙 10g,细辛 5g,木通 8g,炙甘草 5g,大枣 8g。

【来源】 徐玉健,江苏中医杂志,1992,(10):16。

【功效】 益气养血,温经通脉。

【适应证】 雷诺病。

【方药简析】 徐氏认为本病病机为气虚血亏,寒凝脉痹。故用桂枝温经散寒,伍以细辛、川乌更增通阳止痛之力;黄芪与当归同用乃循补气生血之法度,俾使气血旺盛而周流正常;更有丹参之养血活血,桃仁、红花祛瘀通络,地龙、木通搜剔邪气;再使甘草、大枣协和诸药,共收鼓舞气血、温阳解凝之功。若伴见腰膝酸冷,可加仙灵脾、鹿角;湿重肿甚者,加羌活、独活、厚朴;胸胁胀满,以情绪波动为主要发病诱因者,加柴胡、白芍;瘀重痛甚者,加三棱、莪术。徐氏用本方治疗雷诺病 20 例,其中男性 3 例,女性 17 例。年龄 16~25 岁者 8 例,26~35 岁者 7 例,36~45 岁者 3 例,46~58 岁者 2 例。病程 1 年以内者 9 例,1~3 年者 7 例,3~5 年半者 4 例。发病部位在手指者

紫绀明显变淡,疼痛明显减轻,溃疡面愈合。舌淡苔薄,脉沉。前方再进,外用熏洗药,每日3次,每次浸泡10~15min。至1981年2月8日,手指颜色正常,指端变暖。由此停药,随访2年,除冬季手指略有冷感外,余无不适。

【方名】 虎参胶丸。

【组成】 壁虎 50g,丹参 50g。

【来源】 陈学连,黑龙江中医药,1987,(1):35。

【功效】 活血化淤,祛风止痛。

【适应证】 雷诺病。

【方药简析】 壁虎、丹参入心肝经,祛风止痛,活血止痛。二药焙干研极细末拌匀,装入胶丸,每日3次,每次10丸,服用方便,易于长期坚持服药。陈学连等用上方治疗雷诺病早期患者14例,痊愈11例,好转1例,因患妇科病而中途停药1例。最快者28天治愈,最长者4个月治愈,年龄均在40~55岁之间。

【病案举例】 例一:王某某,女,50岁,于1983年11月5日初诊。检查:两侧对称的手指突然变为苍白,后又见紫色,同时发凉麻木疼痛。自诉每年寒冷季节发病频繁,天暖时逐渐消失,四处求治无效。现不能持物,食纳不佳,经量少,多梦,舌苔薄白,质淡红,脉沉细。患者素体血虚,血行缓慢,血脉滞涩,不能荣于四肢,而见发白、青紫。治宜养血活血,温经通络。药用虎参胶丸兼以柴胡、阿胶之类。于11月20日复诊,双手指症状减轻,连服28天,未盈月症状完全消失。

例二:张某某,女,48岁,1984年12月15日初诊。自诉于同年10月的一天早上起床后,感到两手有麻冷和发青现象,饭后逐渐消失,后天气逐渐变冷,又复现数次,只要环境转暖,青紫色就逐渐消失;患者精神紧张,疲乏无力,舌苔薄白,脉弦

细,腰膝酸软,纳差,证为脾肾不足,寒凝阻络。治宜温补脾肾,活血通络。用虎参胶丸兼以白术、女贞子、菟丝子之类,服 56 剂,症状消失,迄今未复发。

36

红斑性肢痛症

红斑性肢痛症又称肢端红痛症,是一种病因未明的周围植物神经疾患。其特征为阵发性肢端皮肤温度升高,皮肤潮红、肿胀,产生剧烈灼热痛,尤以足底、足趾为著。本病可能是由于植物神经功能紊乱,使肢端小动脉处于极度扩张状态,因而局部充血发红,血管扩张使其周围张力增高,压迫或刺激邻近躯体神经末梢,产生灼热疼痛。本病常见于20~40岁青壮年,男性多于女性。多见于平时缺少体育锻炼,手足心多汗,怕冷,冬季易发冻疮的中青年。寒冷季多发,局部受热及长跑可为一次发作诱因。病变部位多见于四肢末端,足部多于手部,以足底与足趾最重,表现为足底、足趾的红、肿、热、痛。疼痛呈阵发性伴有烧灼感或针刺感。久站,步行,肢体下垂,夜间肢体放在被褥中暖和后,均可使疼痛加重。因此病人常将手脚放在被外睡觉,或将足浸泡在冰水中,或将患肢抬高以减轻疼痛。发作时局部皮肤充血发红,压之红色可暂时消退,表皮温度升高,可有轻度肿胀、多汗。局部触觉、痛觉过敏,怕热喜冷,怕运动喜静息。严重时患者可有局部皮肤溃破、渗液或继发感染。本病常有缓解、复发,少数患者晚期发生植物神经营养障碍,如指甲变厚等。但神经系统客观检查无感觉异常或运动障碍。红斑性肢痛症是一种症状综合征,许多疾病均可以引本症,如血栓闭塞性脉管炎,真性红细胞增多症,糖尿病性周围神经病,颈椎合并雷诺现象,硬皮病、脊髓空洞症,痛风等,均需要加以鉴别。西医尚无治疗本病特效办法,急性期卧床休息,抬

高患肢，局部冷敷或将肢体置于冰水中，以减轻疼痛，急性期过后应加强肢体局部活动锻炼，避免着热及引起局部血管扩张的刺激。避免久站或长期步行或负重步行，或湿热环境可预防或减少发作。多采用镇静止痛的阿斯匹林、颅痛定或利血平与氯丙嗪联合应用，以改善症状，可适当使用调节植物神经维生素类药；配合理疗，用超声药物（10%氯化钙，2%麻黄素等）透入，超声波水下（双手或足浸入 35~37℃ 水中）透入，局部冷疗（取适当大小而光滑的冰块贴在患部，轻柔缓慢按摩，反复进行），局部浸浴（患肢浸于治疗桶内，水温 33~35℃），氦-氖激光，电水浴离子导入（水温 30~33℃，常用氯化钙）等疗法，调节神经血管舒缩功能，防治肢端小血管的异常扩张。

红斑性肢痛症属中医“热痹”、“淤血”及“火丹”的范畴。由于风寒湿邪侵于肌腠，郁而化热，或湿热之邪侵袭，流窜肌肤、关节，导致淤血凝滞，气血运行不畅，阻滞经络，故以疼痛为主并伴以痛如针刺、日轻夜重等特征。湿盛则肿，故肢端每见肿胀；湿郁化热，故见患处灼热喜冷，遇热加重。中医辨证多将其分为湿热痹阻和淤血凝滞；而用清热通络汤（桑枝 30g，忍冬藤 30g，秦艽 12g，威灵仙 12g，薏苡仁 12g，苍术 12g，黄柏 10g，牛膝 12g，丹参 20g，生石膏 30g，乳香 10g，没药 10g）及活络效灵丹加味。

路立然等用中药（生地黄 120g，苦参 30g，黄芩 60g，太子参 15g，陈皮 10g；胃寒纳呆者加干姜 10g，砂仁 10g；大便次数增多者加地榆炭 20g，罂粟壳 10g；身冷畏寒者加黄芪 20g，减生地黄 20~40g，苦参 5~10g，黄芩 10~15g。每日 1 剂，水煎 2 次内服，10 天 1 疗程。）治疗本病 28 例，其中原发性红斑性肢痛症（以下简称原发性患者）19 例；继发性红斑性肢痛症（以下简称继发性患者）9 例，其中下肢动脉粥样硬化闭塞症 4 例，血栓闭塞性脉管炎 2 例，下肢深静脉血栓形成 2 例，外伤

1例;原发性患者男7例,女12例;继发性患者男4例,女5例;年龄:原发性患者年龄最小者10岁,最大者62岁,其余在16~50岁之间;继发性患者年龄最小者21岁,最大者62岁,其余在40~60岁之间;原发性患者病程最短者7天,最长者6个月;继发性患者病程最短者20天,最长者3个月。一般1个疗程治愈,最长者治疗33天,平均9.5天[河北中医,1991,(3):40]。

张春涛以凉血散瘀,解毒止痛的丹参15g,赤芍15g,忍冬藤15g,丹皮10g,牛膝10g,通草5g,甘草5g,紫草10g。治疗本病1例,服3剂即愈[江苏中医杂志,1981,(5):53]。

沈栢台等用罂粟藤外洗和内服治疗本病79例(其中36例单纯外洗,43例配合内服)。外洗法:将罂粟藤生药切碎,加洗米水煮沸半小时后,滤渣,待水温适度后,将患处放入药液中浸泡20~30min,早、中、晚各1次。内服法:罂粟藤15~20g,加水200~300ml,煮沸30min,分2~3次内服。疗程2~5天,平均3.5天全部治愈[中医杂志,1985,(4):52]。

牛世志用麻杏石甘汤加味,麻黄9~20g,石膏15~200g,炒杏仁9g,蛇蜕30~60g,地龙15~30g,甘草9~30g,知母15g,丹皮12g。日1剂,前两煎日服,第三煎待液温20~28℃,浸泡双足30min,日2次,禁烟酒、忌辛辣食物。治疗本病42例,临床治愈34例,好转8例[北京中医学院学报,1993,(5):5]。

唐祖宣等用解毒化淤汤(乳香、没药、桃仁、红花、当归、黄芪、金银花、赤芍、黄柏、玄参、丹参)为主,麻木胀痛加白芍、甘草;舌质淤斑重加苏木、刘寄奴;舌苔黄腻加苍术、薏苡仁。治疗红斑性肢痛33例,男12例,女21例。年龄最小者4岁,最大者48岁,其中10岁以下9例,11~20岁21例,21岁以上3例;平均15.3岁。病程最短2天,最长半年,以4~30天者为

最多,平均 27.5 天。发病在单侧上肢者 2 例,双侧上肢者 2 例,单侧下肢者 7 例,双侧下肢者 21 例,四肢均发病者 1 例。有吸烟嗜好者 3 例。治疗结果,临床治愈(症状消失,恢复工作)27 例,显著好转(疼痛消失,皮肤色泽基本恢复正常,但仍遗留轻微麻木,能进行一般工作)6 例;疗程最短 5 天,最长 35 天,平均 14.5 天。其中麻木消失 27 例,基本消失 6 例;皮色潮红消失 32 例,基本消失 1 例;遇热后无不适 32 例,稍感不适 1 例;温度恢复正常 27 例(81.8%),基本恢复正常 6 例。同时唐氏从微循环观察发现,微循环障碍可加重红斑性肢痛症的局部病变、异形管襻增多,动静脉口径扩张,部分患者血液出现泥流状,血管运动计数呈节律性开放,运动次数增多,频率加快,视野下管襻模糊较多,大部分动脉毛细血管扩张。本方可消除炎症,促进循环,使淤阻的血液正常运行。因此纠正微循环障碍是提高疗效的关键[中医杂志,1988,(2):44]。

【方名】 清心汤。

【组成】 黄连 20g,金银花 90g,白薇 15g,玄参 60g,知母 15g,白芍 30g,甘草 30g,蝉蜕 10g。

【来源】 王恒兴,河北中医,1990,(4):8。

【功效】 清心泻火,敛阴止痛。

【适应证】 红斑性肢痛症。

【方药简析】 方中重用金银花合黄连、白薇、知母清热解毒;玄参、知母、白芍清心养阴,蝉蜕兼以去风;甘草调和诸药。王恒兴用病在下取之于上的治法,以清心饮治疗本病 27 例,男 16 例,女 11 例;最小 14 岁,最大 76 岁;20~30 岁占 20 例;冬季发病 21 例,春季发病 6 例。结果服本方 2~3 剂疼痛缓解者 6 例,4~9 剂疼痛缓解者 19 例,无效 2 例,总有效率 92.5%。

【病案举例】 李某,女,18岁,1981年1月10日初诊。患者双足发作性烧灼样刺痛5天,皮肤潮红肿胀,汗出臻臻,趺阳、太溪脉洪;近日疼痛向小腿扩散,昼轻夜重,下垂或遇热加剧,舌尖红,脉数。诊断为红斑性肢痛症,辨证为湿热下注。投以苍柏二妙散化裁:苍术30g,黄连15g,薏苡仁30g,土茯苓30g,萆薢15g,牛膝10g。水煎分服。连进3剂,肿痛日益增剧。二诊详辨:起病急速,灼热阵痛,舌尖红脉洪,既有风的迹象,又有心火见症。改用清心饮加减:黄连15g,栀子15g,金银花60g,白薇15g,知母10g,玄参60g,白芍30g,甘草30g,蝉蜕10g。水煎服,2剂肿退痛止,于1981年1月16日痊愈出院。

【方名】 加味四妙勇安汤。

【组成】 金银花30g,赤芍30g,玄参30g,当归15g,牛膝15g,黄柏15g,大青叶15g,紫花地丁15g,甘草10g,穿山甲10g。

【来源】 李建萍,江苏中医杂志,1988,(11):12。

【功效】 清热解毒,利湿消肿,活血止痛。

【适应证】 红斑性肢痛症。

【方药简析】 四妙勇安汤本为治疗热毒蕴络,淤滞脉络所致的脱疽证,李氏仿其意另加黄柏、大青叶、紫花地丁以清热利湿,解毒散瘀,凉血消斑;赤芍、穿山甲活血散瘀,凉血消肿,通络止痛;牛膝活血逐瘀,引血下行,以合红斑肢痛症湿热淤结,气血不通之病机。湿热淤滞明显的加薏苡仁、车前子、防己、木通;火毒淤热型的加黄连、栀子、牡丹皮;气滞血瘀明显的加陈皮、延胡索、乳香。同时用活血消斑汤(茜草30g,大青叶30g,大黄30g,红花18g,乳香18g,没药18g,煎汤外洗浸泡,活血逐瘀,凉血消斑,消肿止痛,促进局部血运和炎性组织吸收。治疗期间应充分休息,患肢稍抬高,饮食宜清淡之品)治疗

本病 9 例,男 6 例,女 3 例;年龄 9~46 岁,20 岁以上者 6 例;病程最短者 4 天,最长者 2 年,3 天以上者 10 例,11~30 天 2 例,47 天 1 例,6 个月 1 例,1 年者 1 例,2 年者 1 例;病变部位在单侧上肢 1 例,单侧下肢 3 例,双侧下肢 5 例。中医辨证属湿热淤滞型(患肢局部皮色鲜红或暗红,灼热剧痛,沉重肿胀,皮温增高,纳呆身困,舌质红胖,苔黄厚腻,脉滑数)4 例。火毒淤热型(患处皮色红赤或紫红,疼痛剧烈不可切近,灼痛、跳痛明显,表皮灼热如炙,得冷痛减;面红,心烦口渴,口苦咽干,尿赤便结。舌质红绛、苔黄,脉洪数)3 例。气滞血淤型(患部皮色微红或暗红,疼痛有灼热感,伴胸闷,善太息或呃逆,月经不调。舌质暗红或有淤斑、舌下系带青紫、苔薄黄,脉弦细数)2 例。临床治愈(疼痛消失,肿胀消退,皮温肤色正常,恢复原工作)7 例,显效(疼痛消失肿胀消退,皮温肤色基本正常,活动时时有轻微酸麻痛)2 例;疗程最短 6 天,最长 28 天,平均 13.5 天。

【病案举例】 袁某,男,32 岁。6 个月前下水地劳动后,足远端红肿疼痛,经治疗好转。1 月余复发,多方求治不愈,外地医院诊为“红斑性肢痛症”。10 天前病情加剧,双足红肿,灼痛难熬,得冷痛稍减,夜间痛剧不得眠。某医院曾予阿司匹林,肌注镇静剂、麻黄素,患肢中枢端普鲁卡因环状封闭等治疗,效不显,建议行交感神经截除术。患者不接受,故来我院求治。诊见:体温 37℃,脉搏 124/min,血压 14.67/10.67kPa。痛苦面容,双足跖跗关节以下肿胀,皮色暗红,边缘不清,皮温增高,触痛明显,纳呆身困,尿赤便结,舌质红、苔黄厚腻,寸口脉滑数,趺阳脉洪数。证属湿热郁结,淤滞经脉。治宜清热利湿,活血通络。药用金银花、玄参、赤芍、薏苡仁各 30g,当归、牛膝、黄柏、车前子、防己、大青叶各 15g,穿山甲、甘草 10g。每日 1 剂。同时用活血消斑汤浸洗,日 3 次。4 天后红肿大消,灼痛大

减。原方去大青叶、车前子、防己，加茯苓、丹参各15g。3剂后症状全消，活动已自如。又投3剂巩固疗效，随访2年未复发。

【方名】 加减三黄石膏汤。

【组成】 石膏30g，生地黄30g，玄参30g，金银花30g，当归30g，黄连10g，黄柏10g，黄芩10g，豆豉10g，丹参30g，红花10g，牛膝10g，甘草30g，菊花15g。

【来源】 周长有，江苏中医杂志，1994，(12)：12。

【功效】 滋阴凉血，清热解毒，活血止痛。

【适应证】 红斑性肢斑症。

【方药简析】 本方是三黄石膏汤合四妙勇安汤加减而成，方中石膏、黄连、黄芩、黄柏、金银花清热解毒降火；玄参、生地凉血滋阴；当归、丹参、红花、牛膝活血散瘀止痛；豆豉祛风解表；重用甘草和诸药以防伤脾败胃。

【病案举例】 卜某，女，38岁，1990年5月6日初诊。患者两下肢至足红肿肤热，痛如火燎，朝轻暮重，昼夜不停，遇热加剧，两足不能落地步履，只有浸在井水里，灼痛稍可缓解。病发已月余，体质逐渐虚弱，时有头昏头痛。无恶寒发热现象，食纳欠佳，口干，小便短赤，大便干燥。追询病史，患此症已有20年之久。每年农历3~9月均在发作期，气温愈高，症情愈重。昼夜用井水浸泡两下肢，30min左右要更换一次水，每天需用井水3~5担。早年曾赴南京、上海、北京等地医院诊治，均诊断为红斑性肢痛症。历治无效。诊见：形体消瘦，面色少华，神疲乏力。检查：两小腿至足肤潮红如西红柿色，灼热，微肿胀，按之痛剧。两半足底肤色白，微肿胀。舌红少津，苔薄黄，脉细数。证属阴血素亏，毒热壅遏，气血淤滞，蒸发于外。治宜滋阴凉血，清热解毒，活血止痛。方以三黄石膏汤合四妙勇安汤加减：石膏、生地、玄参、金银花、当归各30g，黄连、黄柏、黄芩、

豆豉各 10g,丹参 30g,红花、牛膝各 10g,甘草 30g,菊花 15g。服 5 剂后,患肢肤红略退,灼热略减,肢痛缓解,浸水时间缩短,夜间能卧床休息 3h 左右,饮食略有增加。药中病机,守方不变,继服 5 剂。5 月 16 日三诊:两下肢肤色转为淡红,肢热减轻,灼痛大减,饮食增加,大便日 1 次为稀便,小便微黄,白天可不浸水,晚间浸水 3h 左右即入睡。苔薄白,脉浮数。原方去石膏,加生姜 10g,大枣 10 枚,继服 3 剂,巩固疗效。5 月 20 日四诊:两下肢肤色亦正常,肿胀消除,疼痛消失,两足底肤色正常,大小便尚调,能穿鞋下地行走,不需浸水。继服上药 3 剂,以收全功。1 年后随访,患者体质强健,肢痛未发。

【方名】 加味犀角地黄汤。

【组成】 水牛角(先煎)30g,赤芍 30g,生地黄 15g,丹参 15g,地骨皮 15g,稀莩草 15g,麦门冬 15g,牡丹皮 20g,防风 6g,当归 10g,生甘草 3g。

【来源】 张鲁余,浙江中医杂志,1988,(5):220。

【功效】 清热解毒,凉血散瘀。

【适应证】 红斑性肢痛症。

【方药简析】 本方是由犀角地黄汤加味而成,方中水牛角、地骨皮、丹皮、稀莩草、丹参清热解毒;赤芍、生地、丹参、麦门冬、当归清热凉血,养阴生津,散瘀止痛;防风辛散毒邪;甘草调和诸药,以合红斑性肢痛症火邪侵犯,营卫有热,扰动血分,热毒下注,发于肌肤的病机。

【病案举例】 邓某,女,43 岁,1978 年 11 月 27 日初诊。患者 5 天来双足板及趾端灼热发红,局部皮肤温度升高,疼痛难忍,行走时加剧,入夜更甚。将足浸置冷水中或露出被外则疼痛稍减,彻夜难寐,口干喜冷饮,溲少而黄。西医诊为原发性红斑性肢痛症,治疗 3 天无效,转中医诊治。检查:白细胞计数

6.2×10⁹/L,抗“O”500IU,血沉15mm/h,尿糖(-)。舌质红绛,边有数处黄豆大小紫黑色斑块,舌苔干黄无津液,脉象弦数。证属热毒入里,扰动血分,迫血下行,以致阳毒发于肌肤。治拟清热解毒,凉血散瘀,犀角地黄汤加味:水牛角(先煎)、赤芍各30g,生地、丹参、地骨皮、豨莶草、麦门冬各15g,牡丹皮20g,防风6g,当归10g,生甘草3g。服3剂后,诸症均减。原方又进10剂,症状消失,惟舌边仍有暗红色小斑点,以滋阴凉血清余毒,善其后。随访8年,病未复发。

【方名】 四妙止痛汤:

【组成】 炒黄柏6g,牛膝9g,苍术9g,知母6g,薏苡仁12g,赤芍12g,生地黄12g,独活6g,忍冬藤15g,生甘草3g,秦艽9g,木瓜9g。

【来源】 褚玄仁,江苏中医杂志,1981,(5):52。

【功效】 清热燥湿,活血止痛。

【适应证】 红斑性肢痛症。

【方药简析】 本方是由四妙丸加味而成,方中四妙丸清利湿热;佐生地、知母养阴清热;独活、秦艽祛风胜湿;赤芍、木瓜、忍冬藤活血舒筋络;生甘草调和诸药并增强泻火之功。为加强疗效外用如意金黄散(天花粉、黄柏、大黄、姜黄、苍术、天南星、白芷、厚朴、陈皮、甘草),醋调敷局部,清热利湿,解毒消肿,内外同治,收敛较捷。

【病案举例】 钱某,女,17岁。于1965年1月4日夜间睡梦中突感两大趾疼痛,至翌晨起十趾及足背均先后发生疼痛,趾关节处轻度红肿,不能行走,痛势时轻时重,持续不止,得暖及两足下垂后痛势更甚,平卧及两足踝露被外后疼痛减轻,夜间因疼痛不能入睡,不发热,大小便正常。有吸血虫病史,1964年接受锑剂治疗,余无特殊。去年2月月经初潮,量

中等,无痛经,此次患病适值经后2日,家族无同样病史。检查:两足十趾按之灼热、轻度红肿,足背微红肿,其他关节无特殊,膝反射(+)。诊断:红斑性肢痛症。中医诊断:痹证。

处方:炒黄柏6g,牛膝9g,苍术9g,炒知母6g,薏苡仁12g,赤芍12g,细生地12g,独活6g,忍冬藤15g,生甘草3g,秦艽9g,木瓜9g(煎服);并以如意金黄散用食醋加蜜少许,调敷患处。经以上处理后趾痛当晚即觉大减,两足已可放入被中,但觉趾节微痒,次日仍用原法,痛势基本痊愈,患者两足已可下垂,并在室内行走。续用前法2日,疼痛完全停止,亦不肿胀,于1965年1月17日痊愈出院。1个月后随访,未见复发,已参加正常劳动。

【方名】 消斑止痛汤。

【组成】 蒲公英20g,金银花12g,连翘10g,车前子15g,金钱草20g,薏苡仁20g,桃仁12g,红花10g,赤芍15g,生地黄15g,地龙15g,桂枝10g,牛膝12g,丹参12g。

【来源】 陈业海,广西中医药,1989,(6):26。

【功效】 清热利湿,活血通络。

【适应证】 红斑性肢痛症。

【方药简析】 方中蒲公英、金银花、连翘清热解毒;车前子、金钱草、薏苡仁清利湿邪,丹参、牛膝、桃仁、红花、赤芍、地龙、桂枝活血化瘀,通络止痛;生地黄清热养阴,以防利湿过度。

【病案举例】 罗某,男,56岁,1988年2月6日初诊。患者无明显诱因下,突然觉左足底疼痛7h。患处皮肤发红,发热肿胀。曾有类似发作病史,左右足底不定。局部加热、运动、站立甚至肢体下垂,均导致疼痛加剧;冷敷、抬高患肢或裸露在被窝外则可使症状减轻。检查见形体壮实,左脚背、踝部红

37 脑震荡

头部受到暴力作用后,大脑发生一时性的功能障碍,引起暂时性的意识丧失,称为脑震荡。脑震荡是闭合性颅脑损伤中程度最轻的一种,脑组织本身多无器质性病变。它既可以单独发生,也可与其他颅脑损伤如脑挫裂伤或颅内血肿等合并存在。脑震荡的病因主要为直接暴力致伤和间接暴力致伤所引起,直接暴力致伤系指头部直接受到钝器的打击,如石块、木棒、拳击等或头部碰撞墙壁、地面等处致伤;间接暴力致伤系指身体其他部位受到外力的冲击,如从高处跌下,先是足或臀部等处着地,或因汽车在行驶中突然急刹车,致脑组织受到惯性的冲击而受伤。脑震荡的临床表现为意识障碍,一般多较轻,可有意识丧失或一时性神志恍惚。一般持续数秒钟,数分钟不等,但多不超过 30min 即可清醒,同时可有皮肤苍白,全身松弛,出冷汗,血压下降,生理反射消失等脑性休克的现象。清醒后伤员对受伤当时的情况及受伤经过不能记忆,但对较远的事情则能清楚回忆,称为“逆行性回忆”。可有头痛、头晕,轻度恶心,可持续数日,逐渐减轻,可因体位改变或情绪紧张而加重。患者生命体征正常,神经系统检查无阳性体征。本病应与脑挫伤相鉴别。

脑震荡属于中医脑病中“外伤性脑病”的范畴。脑为髓海,为元神之府,性喜静守,恶扰动。头部一旦受到暴力打击,致使脑脏受震,脉络不通,气机逆乱,神明瞬闭,遂发为本病。本病多为淤阻脑络,脑神失守,故治疗首先是对症处理,给予镇静

和镇痛剂；二是根据脑络闭阻病机，在辨证（脑神蒙遇用至宝丹，脑气失宁用复苏汤，瘀血阻络用通窍活血汤，风痰上扰用半夏白术天麻汤，肝阳上亢用天麻钩藤饮，髓海不足用杞菊地黄汤）基础上，选用善于活血通络的三七参、丹参、苏木、制乳香、没药以活血止痛，酌情选麝香、菖蒲、珍珠粉以开窍醒脑；三用枸杞子、熟地黄、桑椹子、酸枣仁以益肾荣脑。

龙锦良等用活血洗足汤（防风 30g，牛膝、丹参各 50g，鲜水泽兰、鲜血见愁、鲜夜交藤各 500g）水煎洗足治疗脑震荡后遗症 156 例，疗效优良率为 97.4% [浙江中医杂志, 1993, (7): 319]。

叶子良用安脑合剂（福建莲座蕨、夜交藤、珍珠母各 30g，延胡索 12g，党参、徐长卿、生熟地各 10g）治疗脑震荡后遗症 120 例，基本痊愈 89 例，好转 27 例，无效 4 例，有效率达 96.7% [新医学, 1980, (5): 252]。

陈肖裸等用脑震荡方（珍珠母、牡蛎、龙齿、磁石、葛根各 30g，郁金、石菖蒲、半夏各 10g，茯苓 10~15g，陈皮 6g）随症加减治疗脑震荡后遗症 12 例，显效 10 例，好转 2 例 [浙江中医杂志, 1979, (11): 409]。

苏元波辨证治疗脑震荡后遗症 182 例，气滞血瘀型（51 例），治宜行气活血，通络止痛，方用通窍活血汤加减（赤芍、川芎、桃仁、延胡索各 10g，川牛膝 3g，生姜 9g，葱白 3 根，红枣 7 枚，麝香 0.15g）；肝风痰热型（46 例），治宜平肝熄风、清热化痰，方用天麻钩藤饮加减（天麻、钩藤、夜交藤、茯神各 10g，石决明、牛膝各 15g，黄芩、栀子、半夏、陈皮各 6g），痰阻中阳型（23 例），治宜燥湿化痰、健脾和胃，方用半夏白术天麻汤加减（半夏、白术各 10g，天麻、茯苓各 6g，橘红、甘草各 3g）；心肾两虚型（43 例），治宜益肾填精，养心安神，方用大补元煎加减（熟地黄、山药、党参各 15g，山茱萸 6g，枸杞子、当归、枣仁、远

志、杜仲各 10g); 气血两虚型(19 例), 治宜补气养血, 方用八珍汤加味(党参、熟地黄各 15g, 何首乌、枸杞子、菊花、白芍、当归、茯苓各 10g, 川芎、白术各 6g, 甘草 6g)。共治愈 145 例, 好转 37 例[北京中医, 1984, (6): 24]。

【方名】 琥珀安神汤。

【组成】 琥珀 3g(冲), 朱砂 3g(冲), 龙齿 15g, 菊花 10g, 桑叶 10g, 荆芥穗 10g。

【来源】 王惠祥, 浙江中医杂志, 1993, (3): 135。

【功效】 升清降浊, 镇惊安神。

【适应证】 脑震荡。

【方药简析】 方中琥珀镇惊安神, 散瘀止血, 用于外伤引起的气滞血瘀、神不守舍甚合拍; 朱砂、龙齿助琥珀重镇安神; 桑叶、菊花、荆芥穗祛风清头目, 能升发被遏之清阳。王惠祥用该方治疗脑震荡 8 例, 男 6 例, 女 2 例; 年龄最大 62 岁, 最小 8 岁, 均有外伤史和短暂昏迷史。头面有淤肿者加川芎、三七粉、赤芍、丹参; 恶心呕吐明显加藿香、苏梗、姜半夏、姜竹茹、丁香; 头痛剧烈加藁本、蔓荆子; 头晕目眩加天麻、钩藤、石决明、远志、茯神; 夜寐不宁加酸枣仁、夜交藤、合欢皮; 耳鸣重听加菖蒲、郁金、磁石。用药 3~9 剂, 临床症状均消失, 达到治愈之效果。

【病案举例】 许某, 男, 62 岁, 1992 年 6 月 3 日就诊。5 天前从运货车上跌下, 致头部受伤, 来我院外科治疗。外科诊为头部外伤、脑震荡。入院后, 头部外伤经缝合处理, 脑震荡经能量合剂输入及镇静疗法, 病人恶心、呕吐、头痛、头晕未减, 尤其呕吐甚为明显, 以致病人不能进食, 于入院 5 天后请中医会诊。刻诊: 患者精神疲软, 食入即吐, 夜寐不宁, 恶梦纷扰, 脉弦滑。予琥珀安神汤加菖蒲、姜半夏各 10g, 藿香、苏梗各 6g,

治2月,头痛眩晕、耳鸣健忘、心悸乏力之症皆消,随访5年,病未复发。

【方名】 天麻通络饮。

【组成】 水蛭、红花各6g,全蝎3g,姜半夏10g,川芎、地龙各9g,当归、生山楂各15g,炙甘草4g。

【来源】 杨建华等,新中医,1995,(7):51。

【功效】 化淤通络,升清降浊。

【适应证】 脑震荡后遗症。

【方药简析】 方中当归、川芎、水蛭、红花、地龙化淤通络;天麻、全蝎平肝镇痉止痛;姜半夏祛痰降逆;生山楂酸甘化阴,消食散淤;甘草调和诸药,全方合用,使淤血去,脑脉通,气血行,脑有所养,则诸症自愈。前额痛加白芷,巅顶痛加藁本,两侧痛加柴胡,枕部痛加蔓荆子,颈项痛加葛根。杨建华等用天麻通络饮治疗脑震荡后遗症40例,痊愈(头痛、头晕、遗忘、乏力等症状完全消失)19例;好转(头痛、头晕、恶心、记忆力下降等症状基本消失)17例;无效(症状无明显减轻或无变化)4例。

【病案举例】 王某,男,43岁,1991年11月23日初诊。10天前因车祸头部创伤,前额见青紫斑,常头痛头晕,遗忘,纳差,多梦,乏力,耳鸣。舌紫,苔薄白,脉细涩。证属淤血内阻,脑失濡养,治宜活血通络止痛。方用天麻通络饮加白芷9g,菖蒲8g。服6剂后症状明显减轻,时有头晕,项强不舒,上方加葛根、鸡血藤、枸杞子、牛膝。再进6剂,药后症状消失,为巩固疗效,上方改为丸剂,每丸9g,日服2次,服药月余,随访痊愈,能参加重体力劳动。

【方名】 半夏白术天麻汤。

【组成】 半夏 9g,天麻、茯苓、橘红各 6g,白术 15g,甘草 4g,生姜 1 片,大枣 2 枚。

【来源】 程国彭《医学心悟》。

【功效】 燥湿化痰,平肝熄风。

【适应证】 风痰眩晕。

【方药简析】 方中以半夏燥湿化痰降逆止呕,以天麻化痰熄风而止头眩,二者合用,为治风痰眩晕头痛之要药,故为君药;以白术为臣,健脾燥湿,与半夏、天麻配伍,祛湿化痰止眩之功益佳;佐以茯苓健脾渗湿,与白术相合,尤能治痰之本;橘红理气化痰;姜枣调和脾胃,甘草和中而调药性。诸药相伍,使风熄痰消,眩晕自愈。

【病案举例】 林某,女,28 岁。下楼不慎踏空坠落,昏迷 10 余分钟,当地医院诊断为脑震荡,治疗月余,留下后遗症。症见头重而晕,不能左右转动,动则更甚,恶心呕吐,渴不思饮,舌苔白腻。证属脾胃升降失常,痰浊蒙蔽清阳,治宜健脾燥湿祛痰,予半夏白术天麻汤。6 剂后眩晕渐止,以健脾益气之剂调理数日而愈[周大林等,浙江中医杂志,1983,(2):62]。

【方名】 祛风定震汤。

【组成】 当归、荆芥、防风、白芷各 10g,川芎、羌活、蔓荆子、槟榔、琥珀、制南星、乳香、没药各 8g,升麻 10g,肉桂 6g。

【来源】 杨植群,四川中医,1988,(1):34。

【功效】 祛风定震。

【适应证】 脑震荡。

【方药简析】 方中荆芥、防风、白芷、羌活、细辛、蔓荆子祛风止痛,疏通经络为主药;辅以当归、川芎、乳香、没药、槟榔行气活血,化淤止痛;琥珀镇惊安神、活血止痛;制南星祛经络风痰,有抗惊厥作用;升麻提升清阳之气以上营于脑;肉桂温

通督脉,以促进血行。全方共奏祛风定震之功。杨植群用该方治疗脑震荡 41 例,治愈(症状消失,能胜任原工作)32 例;有效(症状基本消失,偶有头昏不适)8 例;无效(同治疗前)1 例。总有效率 97.5%。

【病案举例】 郭某,女,43 岁,1974 年 4 月 25 日诊。患者在半小时前被从 3 米高处落下的木器击伤头顶部,当即昏迷约 15min,急送来就诊。见其神志尚清,面色苍白,瞳孔等大,光反射正常,巅顶可见血肿包块,脉浮迟。主症为头昏、头痛、恶心胸闷,腰背疼痛。诊为脑震荡。方用祛风定震汤 3 剂,3 日后步行复诊,诉头昏,头痛大减,四肢乏力,饮食无味,但步履稳健。

【方名】 祛风通络汤。

【组成】 丹参、川芎各 18g,蔓荆子、白芷、地龙、路路通各 10g,桃仁、羌活、防风、薄荷各 6g,血竭、甘草各 3g。

【来源】 贺哲等,四川中医,1990,(5):26。

【功效】 活血化淤,祛风通络。

【适应证】 脑震荡后遗症。

【方药简析】 方中丹参、川芎、桃仁、血竭活血化淤;蔓荆子、薄荷、白芷消头风而醒脑;地龙、路路通、防风、羌活祛风通络;甘草调和诸药。

【病案举例】 张某,男,38 岁,1985 年 2 月 18 日诊。3 个月前,患者与人斗殴时,被砖头击伤右侧头部,当时昏迷。某乡医院诊断为脑震荡后遗症。经治外伤愈合,尔后常感头痛,痛如锥刺,遇劳累暴晒则加重。刻诊:心烦失眠,恶心,头痛,舌质淡红,苔薄黄,脉沉细。证属破伤之后,风邪乘隙而入,与血相搏,闭阻络脉,淤阻脑窍。治宜活血化淤,祛风通络。方用祛风通络汤加合欢皮、夜交藤。治疗 20 天后,头痛、头晕、恶心

失,精神转佳,唯感记忆力减退。给予补肾滋脑,巩固疗效。随访1年余,患者健好。

【方名】 活血通络汤。

【组成】 丹参 20g,川芎、当归尾、桃仁、赤芍、地龙、石菖蒲、远志、钩藤各 10g,三七粉 5g。

【来源】 刘胜利,四川中医,1993,(12):40。

【功效】 活血通络安神。

【适应证】 脑震荡后遗症。

【方药简析】 方中丹参、川芎、当归尾、桃仁、赤芍、三七活血通络止痛;且丹参活淤血、通九窍,祛淤生新而养血安神;川芎为血中气药,辛宣上行巅顶;菖蒲、远志宣窍安神益脑;地龙、钩藤熄风平肝通络。诸药共奏活血通络、熄风利窍、安神益脑之功。心烦失眠多梦加酸枣仁、夜交藤、琥珀末;心悸、耳鸣、健忘加龙齿、茯神、何首乌;肢体麻痹加鸡血藤、秦艽、牛膝;胸闷、纳差、呕恶加香砂六君子丸。刘胜利利用活血通络汤加减治疗脑震荡后遗症 44 例,痊愈(症状消失,1 年内未见复发)34 例;有效(症状消失,1 年内有复发)8 例;无效(症状无改善)2 例;总有效率 95%。

【病案举例】 周某,男,26 岁,1987 年 10 月 12 日诊。患者于 2 月前因车祸头部着地,当时昏迷。经西医清创、镇痛、消炎等治疗,仍觉经常头痛、头晕、心悸、失眠、多梦。检查:舌质淡红,边略暗,苔薄白,脉弦细,诊断为脑震荡后遗症。辨证属外伤头部,脑络淤滞,元神失养。治以活血通络安神,方用活血通络汤加酸枣仁、夜交藤各 15g,琥珀末 5g。治疗 20 天,诸症渐除而愈。随访 1 年,未见复发。

【方名】 颅内消淤汤。

【组成】 麝香、川芎、血竭、丹参各 6g,赤芍、桃仁、红花、乳香、没药、三棱、莪术、香附、麝虫各 9g。

【来源】 章财根,浙江中医杂志,1992,(9):413。

【功效】 活血化淤,通络醒脑。

【适应证】 脑震荡。

【方药简析】 方中川芎、丹参、赤芍、桃仁、红花、麝虫活血化淤;乳香行血止痛;三棱、莪术、香附破血理气;麝香醒脑开窍。诸药共奏活血通络、化淤醒脑、理气通络之功。

【病案举例】 陈某,男,35岁。3天前不慎从2米高处跌下,后背、头部着地。当时昏迷约10min。此后一直头昏头痛,食后即吐。某医院诊为脑震荡。刻诊:苔薄黄,舌有淤点,脉弦。X线摄片示:颅骨无骨折异常。血压18.7/10.6kPa,拟颅内消淤汤加减:炒川芎、血竭、丹参、赤芍、三棱、莪术、麝虫、生黄芪、降香、姜半夏、蔓荆子各10g,桃仁、红花各6g。服药5剂,头痛减轻,呕恶缓解,精神明显好转。原方加减,共服药70剂,诸症皆除。随访未见任何后遗症。

38 脑挫伤

暴力作用于头部,造成脑组织器质性损伤,称脑挫伤。临床表现与脑震荡相似而程度较为严重,可出现脑损伤的局灶性症状,并常伴有损伤性蛛网膜下腔出血。脑挫伤时因有脑组织的器质性损伤,可出现神经系统局灶性症状和脑脊液血性。病人昏迷时间可由半小时至数天,甚至数月,最严重者可持续数年直至死亡,昏迷程度较深。清醒后头痛、头昏、恶心、呕吐等症状的程度较重,持续时间较长。根据脑挫伤的部位,可在伤后立即出现相应的神经系统局灶性症状,如偏瘫、失语、局限性癫痫及锥体束征阳性等。但若损伤发生在非重要功能区,或损伤范围较小,程度较轻,可无此等表现。脑挫伤病人常有蛛网膜下腔出血,脑脊液呈血性,并出现颈项强直。颅脑损伤当时,可有短暂脉搏细速、血压偏低和呼吸缓慢等表现,多数迅速恢复正常;若不恢复,常提示有较严重的脑干损伤,或其他合并损伤。本病应与脑震荡、颅内血肿等病相鉴别。

脑挫伤属于中医外伤性脑病范畴。由于头部受到直接或间接暴力致伤,导致脑气震激,气壅脑窍,闭塞不通,阳气不能上达于脑,神明失用;或脑脉损伤,血不循经溢于脑海,压迫脑髓,阻塞脑窍,神灵失职;或暴力袭击于脑,以至脑髓严重损伤,内溢脑窍;或因淤血压迫脑髓,髓不承压而内溢孔窍等均可使神明受折。由于脑挫伤的脑部损伤有性质和程度的不同,临床表现有显著差异,其治疗和预后迥然不同,故辨明轻症、重症与险症,实是决定本病治疗的关键。脑挫伤属危急重证,

延胡索 12g, 蔓荆子 10g; 大便干结加大黄 6g; 伴发热加金银花 15g, 连翘 10g, 蒲公英 30g, 黄芩 12g) 治疗外伤性急性脑内血肿 12 例, 结果全部临床治愈[中医杂志, 1989, (9): 552]。

【方名】 通窍利脑汤。

【组成】 菖蒲、远志各 9g, 全蝎 4.5g, 蜈蚣 3 条, 滑石 3g, 水蛭 1.5g。

【来源】 陈德信, 四川中医, 1992, (5): 210。

【功效】 破瘀通窍。

【适应证】 脑挫伤。

【方药简析】 方中菖蒲、滑石、远志开利九窍; 全蝎、蜈蚣性窜亦通经络, 加少量水蛭攻瘀散结。

【病案举例】 权某, 男, 16 岁, 1986 年 11 月 5 日诊。患者骑自行车不慎, 从约 50m 高的崖上摔下, 以严重脑挫伤收入院。治疗 4 月余, 效不显。诊见: 神志昏乱, 丧失记忆, 烦躁不安, 双目上视, 不断撕襟掐扣抓物不闲, 语无伦次, 双下肢轻瘫, 少腹胀急, 小便失禁, 大便 5~6 日 1 次, 量少, 色褐黑, 排时无知觉。脉弦细, 尺脉涩, 舌苔黄厚燥, 舌质红绛。证属郁瘀并结下焦。治以破瘀通下, 方用通窍利脑汤加桃仁 12g, 大黄 10g。服 3 剂后, 下少量胶黑便; 续服旬日, 大便稀仍为胶黑色, 烦躁略平。又进 10 剂, 诸症悉蠲, 记忆明显恢复。半年之后已如正常人。

【方名】 散偏地黄汤。

【组成】 川芎 15~30g, 白芷 6~10g, 香附 6~10g, 白芥子 6~10g, 熟地黄 15~30g, 山茱萸 10~30g, 山药 10~15g, 甘草 3~10g。

【来源】 范美德, 四川中医, 1988, (3): 32。

【功效】 滋阴补肾，活血通窍。

【适应证】 脑挫裂伤，脑震荡后遗症。

【方药简析】 方中用熟地黄、山茱萸、山药滋阴补肾；川芎、香附理气活血；白芷、白芥子祛风透窍而止痛。头痛甚加红花、丹参、赤芍；眩晕加天麻、钩藤、菊花、珍珠母；不寐加酸枣仁、合欢皮、茯神、琥珀粉、龙骨；呕恶加陈皮、半夏；气血虚加太子参、黄芪、当归，重用熟地、白芍；肝肾虚损加枸杞子、杜仲、胡桃肉、鹿角胶、龟板胶。范美德用上方治疗脑外伤后遗头痛 23 例全部治愈，一般服药 2~4 剂即可见效；8~14 剂后头痛消失，仅个别病人记忆力恢复较慢。

【病案举例】 姜某，女，23 岁。7 年前因车祸摔伤头部，当时昏迷及局部出血，急送某医院抢救，半天后转清醒，诊为脑挫裂伤。住院 40 余天，出院后仍感头痛，甚时如锥样，并有空痛感，伴有眩晕、耳鸣少寐、神疲乏力，经长期治疗效不佳。诊见：精神萎靡，痛苦面容，舌质暗，少苔，舌尖有淤点，脉细涩。证属淤血内阻，脑海失养。治宜活血化淤，滋肾益精。予散偏地黄汤加红花、陈皮各 10g，龟板胶 15g。服 2 剂后，头痛减轻。6 剂后，头痛明显好转，余症大为缓解。10 剂后，头痛基本消失，仍感眩晕。上方去红花，加当归、天麻各 10g，龙骨 30g，继服 15 剂，眩晕消除。除记忆力恢复较慢外，头痛等症状均消失。

【方名】 活血醒脑汤。

【组成】 红参 20g，黄芪 30g，石菖蒲、郁金各 15g，胆南星 6g。

【来源】 吴丕中，湖南中医杂志，1994，(3)：17。

【功效】 益气固脱，活血豁痰。

【适应证】 脑外伤昏迷。

【方药简析】 方中重用党参、黄芪,既是固脱护阳之举,又有益气和血之功,取其气旺血行之义;以菖蒲开塞宣窍,振发清阳以醒昏迷;郁金开郁导气,行血散瘀;胆南星清热豁痰,疏利气道。中度昏迷加肉桂 4g,丹参 10g;深昏迷加肉桂 6g,丹参 10g,僵蚕 10g,竹沥 10g。吴丕中用活血醒脑汤治疗脑外伤昏迷 21 例,浅昏迷 3 例,均显效(用药 3 天,患者神清,其他症状缓解)。中度昏迷 14 例,显效 11 例,有效(用药 1 周神清,其他症状基本缓解)3 例。深昏迷 4 例有效 2 例,无效(用药 2 周仍不清醒,诸症加重)2 例。总有效率 90.5%。

【病案举例】 陈某,女,47 岁。1990 年 12 月被碾米机皮带打伤头部正中,当即昏迷,急送我院。刻诊:头部正中可见长约 5cm,深约 0.5cm 伤口,渗血不止。检查:体温 36.8℃,呼吸 15 次/min,脉率 60 次/min,血压 14/10kPa。瞳孔等大等圆,各种反射消失,面色苍白,呼吸不匀,口鼻内流出泡沫,大小便失禁,四肢厥冷,脉微弱。入院后经西药对症处理后,于住院第 2 天患者生命体征稳定,但口鼻内流出大量泡沫,鼻息时有鼾声,故上置鼻饲管开始推注中药及少量牛奶。以活血醒脑汤加肉桂 6g,丹参、僵蚕各 10g,竹沥 40g。在西药支持疗法的配合下,每日 1 剂,用药 4 天,患者神志渐清,调治 1 周后痊愈出院。

【方名】 昏痛缓解汤。

【组成】 菟丝子 25g,枸杞子 10~25g,桑椹子、白扁豆、茯苓、红枣各 30g,柴胡 10g。

【来源】 陈平,四川中医,1995,(2):46。

【功效】 补肾益精,健脾和胃,疏肝理气。

【适应证】 脑损伤后综合征。

【方药简析】 方中菟丝子、桑椹子、枸杞子补肾益精;白

女贞子补肝肾、益精血、充脑髓；川芎、赤芍、红花活血化淤，祛淤生新；菖蒲、天麻、远志涤痰开窍，安神定志；柴胡升举阳气，引药上行，直达病所。诸药合用，补正不恋邪，祛邪不伤正，升降出入相平衡。头痛甚加延胡索、全蝎、蜈蚣；眩晕甚加钩藤、菊花；恶心呕吐加半夏、竹茹；失眠惊悸加酸枣仁、珍珠母；便秘加火麻仁、大黄；言语不利，记忆力减退重用菖蒲、远志，加郁金，益智仁；肢体活动不利加桑枝、川断、杜仲。崔磊等用该方治疗脑损伤后遗症 50 例，15 天为 1 疗程，治愈（临床症状消失，能正常工作，随访半年无复发）37 例；显效（临床症状基本消失，有时出现轻微的头痛、头晕、失眠、多梦等症，生活尚能自理，随访半年未加重）11 例；无效（治疗 3 个疗程症状改善不明显，生活需人照顾及中断治疗）2 例。总有效率 94.6%。

【病案举例】 王某，男，35 岁，1989 年 11 月 20 日初诊。患者于半年前在施工中不慎从 7m 高处坠下，当时昏迷不醒，耳鼻流血。送医院抢救，经拍片示颅底骨折，诊为重度脑挫裂伤，经抢救 5 天后苏醒，治疗 2 个月出院。遗有头痛头晕，恶心呕吐，失眠易惊，烦躁，记忆力减退，左侧肢体功能障碍。家属要求中药治疗，检查：表情淡漠，反应迟钝，舌淡苔白，脉细涩。证属气虚血淤，脉络阻滞，髓海失养。治以益气活血化淤通络，填精益髓，开窍安神为法，方用自拟益气活血健脑开窍汤加益智仁、桑枝、续断、酸枣仁各 15g，全蝎 6g，珍珠母 30g，钩藤 12g。共服 35 剂，诸症消除，随访半年无复发，生活工作如常人。

39 脑外伤综合征

颅脑损伤后,部分病人可残留痴呆、失明偏瘫、失语、癫痫发作等器质性后遗症。更多的病人在伤后相当长时期内主诉繁多,而神经系统检查却无客观发现,常被诊断为脑外伤综合征。一般认为颅脑损伤后近期出现的自觉症状,经过3个月以上的治疗尚未痊愈而神经系统检查无阳性发现者,可诊断为脑外伤综合征。本病多数系因颅脑损伤后引起的功能性改变特别是植物神经功能紊乱所致,部分可由未产生明显体征的轻微脑器质性损伤造成,少数与头面部或颈部神经损伤有关。而病人的精神因素对于脑外伤综合征的发生,具有十分重要的意义。脑外伤综合征的临床表现复杂多样,但以植物神经功能紊乱及癔病样症状为主。头痛最为常见,多系胀痛或搏动性头痛,每因脑力或体力劳动、嗅到异味或听到噪音而加重。尚可有眩晕、耳鸣、多汗、乏力、失眠、心悸、情绪不稳、记忆力减退、注意力涣散、性功能改变等症状。神经系统检查一般无阳性体征发现,脑电图检查在部分病人表现为弥漫性异常,但无局灶性改变,气脑造影可显示脑室系统轻度扩大。

脑外伤综合征属中医外伤性脑病范畴,其病因病机是脑伤日久,暗耗肾精,以致肾精亏虚,不能生髓,髓海不足而成。亦有因脑脏久有淤血阻滞,脑脉血流不畅而致。本病多虚实夹杂,邪少虚多,临床应详审细辨。首先是对因治疗,消除精神因素;二是根据病机,在辨证(淤血阻络用通窍活血汤,风痰上扰用半夏白术天麻汤,肝阳上亢用天麻钩藤饮,肾精亏虚用杞菊

黄、太子参各 20g,赤白芍、丹参、当归、郁金、石菖蒲、茯苓、远志、生蒲黄各 15g)治疗脑外伤后遗症病程日久以肾虚较甚者。若阴虚合用地黄饮子;有脉络淤阻合用桃红四物汤[辽宁中医杂志,1982,(9):33]。

朱广仁等用补肾益精荣脑法治疗肾精不足,脑髓不充型脑外伤后遗症,拟龟鹿补髓汤(鹿角胶、龟板胶各 15g,狗外肾、猪脊髓各 1 具,菟丝子、胡桃肉、潼蒺藜、狗脊、补骨脂、淮牛膝、枸杞各 20g,女贞子、熟地黄各 12g,砂仁、三七、菖蒲各 10g)[辽宁中医杂志,1980,(9):28]。

【方名】 化淤荣脑汤。

【组成】 当归 10~15g,赤芍 10g,熟地 15g,川芎 10g,红花 10g,丹参 25g,天麻 10g,菊花 10g,何首乌 20g,酸枣仁 30g,黑芝麻 20g,生龙齿 30g,核桃 3~5 枚(打碎)。

【来源】 姜伟等,山东中医杂志,1992,(1):23。

【功效】 活血化淤,填精荣脑。

【适应证】 脑外伤综合征。

【方药简析】 当归、赤芍、川芎等活血化淤;天麻、菊花、龙齿平肝潜阳;熟地黄、何首乌、黑芝麻、核桃滋肾填精荣脑;酸枣仁养心安神,诸药共奏活血化淤、镇静安神、补肾荣脑的功效。头痛重加延胡索、全蝎;头晕重加旱莲草、女贞子;失眠多梦加柏子仁、夜交藤、琥珀;记忆减退加石菖蒲、郁金、半夏;恶心呕吐重者加陈皮、枳壳、半夏。姜伟等用化淤荣脑汤治疗颅脑创伤后遗症(10 剂为 1 疗程)67 例,54 例治愈(临床症状消失,脑电图正常,恢复工作或学习,随访半年无复发);12 例显效(临床症状基本消失,有时出现轻微头痛、头晕、失眠、多梦等);1 例无效(治疗 2 个疗程,临床症状无明显改善或中断治疗)。总有效率 98.5%。

【病案举例】 孟某,女,31岁,1987年11月10日初诊。4年前头部砸伤,昏迷2天。X光片示:左侧顶骨有裂纹骨折,住院32天,愈后遗有头痛、头晕、头胀、恶心欲吐、烦躁失眠、记忆减退。检查:脑电图、血压正常,脉弦滑,舌淡红润,苔薄白。诊断:颅脑外伤后遗症。用化淤荣脑汤加旱莲草20g,夜交藤30g,茯苓15g,甘草10g,水煎服,日1剂。服10剂后头痛头晕、失眠多梦减轻。又随症加减,共服69剂,诸症消失,恢复工作,随访半年未复发。

【方名】 柴精汤。

【组成】 柴胡、地鳖虫各15g,黄精、怀牛膝各30g,丹皮、茯苓各20g,白芷、甘草各10g,细辛、薄荷各3g。

【来源】 张元存等,新中医,1994,(6):27。

【功效】 活血通络,升清填精。

【适应证】 脑外伤后综合征。

【方药简析】 方中柴胡升举清阳,舒肝解郁;黄精益气填精;地鳖虫、丹皮、牛膝化淤通络;白芷、细辛、薄荷祛风止痛;茯苓健脾;甘草调和诸药。外伤脉络、窍络淤阻型加川芎、桃仁各15g;血淤兼气血两虚型加党参、当归各20g;血淤兼心肾不交型加黄柏、知母各15g,山药12g;血淤兼肝气郁滞型加重柴胡,用24g;加川芎10g,木香、佛手各15g;血淤兼肾虚型加杜仲15g,熟地黄20g。张元存等用柴精汤治疗颅脑外伤后综合征40例,30例治愈(临床症状消失,恢复日常生活和工作),7例显效(临床症状基本消失,但劳动用力或精神刺激时可复发),2例有效(临床症状较治疗前减轻,但常有复发,尚不能恢复正常生活或工作),1例无效(各项临床症状同治疗前比未见改善),总有效率为97.5%。

【病案举例】 姚某,男,36岁,1991年11月22日入院。

现象,多次尿化验均属正常。入院时证见:头痛顽重,痛处不移、头晕耳鸣,畏寒喜暖,心烦不寐,烦渴多饮,小便频数,舌红暗,苔白,脉沉细。西医诊断:脑外伤性尿崩症。中医辨证为外伤血淤,髓海不足。宜补髓壮水益气化淤,当予复元活血汤加黄芪 30g,枸杞子 12g,附子、水蛭各 9g,罂粟壳 15g,甘草 5g。服药 18 剂后,尿次减至每 24h7~8 次,尿量在 3000ml 上下,头痛大减。服药至 45 剂时,头痛消失,仅感头晕,精神及睡眠均转佳,小便每日 5~6 次,尿量在 1200~1500ml 上下,已属正常范围。调方巩固半月,诸证悉除而痊愈出院[夏永潮等,中医杂志,1987,(11):59]。

【方名】 忘痛安脑汤。

【组成】 柴胡、乳香、没药、丹参各 10g,升麻、青皮各 3g,地龙 6g。

【来源】 朱丽珍等,浙江中医杂志,1983,(12):543。

【功效】 行气活血,通络止痛。

【适应证】 脑外伤后遗症。

【方药简析】 方中柴胡、青皮疏肝理气;乳没、丹参活血化瘀,地龙通经活络;升麻升举清阳,诸药共奏行气活血、通络止痛之功。本方多用于气滞血淤型脑外伤后遗症。

【病案举例】 王某,男,22 岁。1 年前因醉酒殴斗,头部受棍击,当即不省人事,经某院救治转安。此后,头痛时发,迭治不愈。日前复因郁怒而大发,剧痛若针刺刀劈,舌质紫黯,苔薄白,脉弦有力。证系脑外伤后恶血未消,复因恼怒而气上逆与其相激,不通则痛。治宜行气活血,通络止痛,方用忘痛安脑汤加降香 6g。4 剂,痛大减,续予原方 3 剂而愈。

【方名】 归芍四君子汤加味。

【组成】 党参 15g,白术、白芍、炙甘草各 10g,黄芪、茯苓各 12g,当归 6g。

【来源】 朱丽珍,浙江中医杂志,1983,(12):543。

【功效】 补气养血。

【适应证】 气血亏损型脑外伤后遗症。

【方药简析】 方中以党参、黄芪、当归为君,补气养血;以白术、白芍为臣,健脾养阴补血;佐以茯苓渗湿健脾;苓术合用,健脾之力更强;使以炙甘草,甘温调中。全方配合,共奏益气养血之功。适用于气血亏损型脑外伤后遗症。

【病案举例】 钱某,女,60岁。月前,头部被人击伤,遂致眩晕少气心悸不寐,纳食减少,精神不振,舌淡嫩,边齿痕,脉细无力。此属脑外伤后,累及中州,使之生化不足,气虚不能上荣。当补气以养血,方用归芍四君子汤加味。服 10 剂愈。

【方名】 杞菊地黄汤。

【组成】 枸杞子、山药、山茱萸各 12g,熟地黄 24g,茯苓、泽泻、丹皮、菊花各 10g。

【来源】 董西园《医级》。

【功效】 滋肾养肝。

【适应证】 髓海不足型脑外伤后遗症。

【方药简析】 方中熟地黄、枸杞子滋补肝肾、益精髓是为君药,山茱萸酸温滋肾益肝,山药滋肾补脾,共成三阴并补以收补肾养肝之功。泽泻配熟地黄而泻肾降浊;菊花、丹皮配山茱萸以泻肝火;茯苓配山药而渗脾湿。

【病案举例】 仇某,男,52岁。2年前头部负伤,当时神志尚清,然眩晕呕吐不止,经治疗后好转,继则腰酸,午后潮热,盗汗,舌红少苔,脉细数。此为脑伤后,损及肾阴,髓海失养所致,治宜滋肾阴以充髓海。方用杞菊地黄汤加紫河车 12g。服 12

剂而愈[朱丽珍等,浙江中医杂志,1983,(12):543]。

【方名】 柴胡细辛汤。

【组成】 柴胡、当归、丹参、姜半夏、泽兰叶各 9g,细辛、地鳖虫、川芎、黄连各 6g,薄荷 4.5g。

【来源】 广东中医学院,外伤科学。

【功效】 活血化淤,通络止痛。

【适应证】 脑外伤后遗症。

【方药简析】 方中当归、丹参、地鳖虫、川芎活血化淤;柴胡、薄荷舒肝升清;细辛祛风止痛;黄连、姜半夏清热化痰;泽兰芳香化湿醒脑。诸药合用,俾窍通淤破,久留血络之痰淤尽化,推陈致新,头痛诸症亦即迎刃而解。

【病案举例】 石某,女,29岁,1979年9月8日初诊。患者于1978年6月不慎从高处摔下,与石头相撞而外伤,头巅、后脑及颞部疼痛如裂。家属视病情严重,特来求治。患者伏驴背上而来,精神欠佳,动弹不得。诊视:头项强痛,头昏,畏风,恶寒,汗出如洗,面色黧黑,胸脘痞闷,泛泛欲吐,默默不愿言,眼球发红并有牵引性疼痛,腹满便秘,小便不利。检查:形体消瘦,口唇紫绀,爪甲发黑,舌苔微黄中间黑,脉弦涩。诊为脑外伤后遗症,方用柴胡细辛汤原方加石菖蒲。7剂后,头痛头晕、畏风恶寒略有减轻,但又添手足发热、烦渴、肌肤摸之烙手等症。上方加紫草 10g,5剂后诸症大减,只在阴雨天稍感头重,全身不适。继用上方7剂为粗末,早晚各冲服 15g 以巩固疗效[肖国玺,中医杂志,1982,(10):731]。

【方名】 急救稀涎散。

【组成】 猪牙皂(去皮)15g,白矾 30g。

【来源】 《圣济总录》。

【功效】 涌痰开窍。

【适应证】 痰浊蒙闭清窍诸症。

【方药简析】 方中白矾酸苦涌泄，能化浊痰，并有开窍催吐之功；猪牙皂辛能开窍，咸能软坚，尤善降除浊腻之痰。共研末，温水冲服。

【病案举例】 杜某，男，21岁，1995年2月2日下午4时入院。4h前不慎从15m高处跌下，致昏迷，呕吐入院。症见昏迷，呕吐为胃内容物，呼吸深快，左眼睑肿胀青紫，球结膜充血，双侧瞳孔不等大，对光反射消失，双鼻腔及口腔有血液及脑脊液流出，胸腹四肢无异常，体温38.5℃，脉搏60次/min，血压22/13kPa，呼吸24次/min，颈项强直，克氏征阳性，巴氏征阳性。临床诊断脑挫裂伤，颅前窝骨折。经镇痛、止血、脱水及抗感染等对症支持治疗20天，上述症状好转。但患者表情淡漠，神志痴呆，喃喃自语，应答举止失常。请中医会诊，症见：表情淡漠，神志痴呆，喃喃自语，举止失常，口角流涎，饮食尚可，大便如常，小便清长，舌质淡，苔白厚腻滑，脉滑有力。中医辨证为痰迷心窍型癫症，治宜涌痰开窍。方用急救稀涎散，温水冲服，约15min后，患者出现呕吐，呕吐为清水痰涎，量约600ml，30min后，患者神志渐清，能认清父母及旁人，应答自如，举止如常人[张宏等，中医杂志，1997，(1)：50]。

40 麻木

麻木是一种症状,其可单独存在,如末梢神经炎等。但相当一部分麻木是其他疾病伴随或初见的症状,诸如周围血管疾病(如多发性动脉炎、血栓闭塞性脉管炎、高血压引发的脑血管病变等)、结缔组织疾病(如类风湿性关节炎、结节性多动脉炎、硬皮病等)、营养障碍疾病(如脚气病等)、内分泌代谢障碍疾病(如甲状腺机能减退、肢体肥大症、糖尿病等)以及其他疾病(如急慢性感染、肿瘤等)。故麻木的证候诊断后,尚须进一步追查引发麻木的疾病。麻木是皮肤肌肉发麻,其状非痒非痛,或如同虫蚁爬行,或肌肤木然,顽而不知痛痒。麻木常发生在四肢,且多见于手指、足趾末端及远端,亦有仅见于面部一侧或舌部,系局部发生的感觉障碍。麻木一般不伴有肢体运动功能障碍及肌肉萎缩。体检时在麻木的局部可发现有感觉麻痹,感觉减退,或感觉异常,其分布区域常与神经分布走向相一致。

中医学认为麻木之病因,既有风寒湿六淫外侵,又有气血亏虚或痰淤郁滞的因素。但病机之关键,则在于营卫之气行涩,闭阻于内,不能外荣。其病因病机是风寒湿邪,乘虚侵入人体,客于肌表经络不去,闭阻营卫,使气血运行受阻;或劳倦失宜,饮食失节,损伤脾气;或房室不节,精亏气少,气虚卫外不固,更易使外邪入侵,亦有产后血虚,或局部血循失荣;或热病久羁,导致津亏血虚,肌肤失养而麻木。麻木以虚证为主,或有虚中夹实证,故治疗应以补虚为法,调补气血,助卫和营。但由

于麻木与外邪、痰湿、淤血有关；病机有由实致虚、因虚致实之变，故补虚又得适当泻实。在风寒湿邪外侵之期，可以薭痹汤祛风通络为主，又当以桂枝汤调和营卫；久病有湿痰淤血内凝者，可用双合汤化痰行淤，又当以八珍汤补益气血，但在外邪已祛，经脉疏通后，则以补气活血为法，不宜多用攻逐之剂。补气助运多用人参、黄芪、乌头、附子之类，临床常用补中益气汤、黄芪益气汤、人参益气汤等。对血虚失荣者，可用四物汤养血和营，但在此证中补血旨在运血，故不宜多用粘稠胶滋补血之剂，如阿胶、熟地之类。

【方名】 补阳还五汤加味。

【组成】 黄芪 60g，川芎、赤芍、地龙、牛膝、桃仁、红花、附子各 10g，当归尾 12g，补骨脂 20g，全蝎 6g，蜈蚣 2 条。

【来源】 赵和军，四川中医，1993，(7)：34。

【功效】 温通血脉、活血化淤。

【适应证】 四肢麻木等。

【方药简析】 方中附子，补骨脂温肾补阳，附子既能温肾壮阳，又能温通心阳；牛膝既能补肾，又能活血化淤；桃仁、红花、赤芍、川芎、地龙、当归尾均能活血化淤，通经活络；黄芪补气益血，促进气血运行；全蝎，蜈蚣通络祛风。诸药合用，能温通血脉，活血化淤。

【病案举例】 胡某，女，32 岁，1991 年 11 月 20 日诊。患者每到冬季，每日夜间要解小便 2～3 次，起床后，常头晕，四肢麻木，站立不稳，腰部冷痛，有几次倒在室内，但入被窝后症状缓解。屡治不效。诊见：面色微黄少华，嗜睡，喜热微恶寒，唇色紫绀，舌淡有淤点，苔白滑腻，脉沉涩。治宜温阳补气、活血化淤，方用补阳还五汤加味，服药 2 剂后，四肢麻木大减，站立稳当，头晕消失。附子减为 6g，续服 2 剂诸症痊愈。

【方名】 十全大补汤。

【组成】 人参、肉桂、茯苓、白芍各 8g,川芎、炙甘草各 5g,熟地黄、黄芪各 15g,白术、当归各 10g。

【来源】 太医局《太平惠民和剂局方》。

【功效】 温补气血。

【适应证】 气血不足诸症。

【方药简析】 方用黄芪、人参、白术、茯苓补脾益气;当归、白芍、熟地黄滋养心肝,加川芎入血分而理气,则当归、熟地黄补而不滞;肉桂温补肾阳;全剂配合,共收气血双补之功。

【病案举例】 李某,男,62岁,1990年12月13日初诊。患者因左侧肢体麻木1月余而入院,1月前不明原因而发生左侧上下肢麻木,以麻为主,时有发木,时轻时重,感肢体发热,乏力,纳可,大小便自调,查肢体感觉未见异常,肢体肌力均为V级,舌淡暗,苔薄腻,脉沉细,头颅CT检查未见异常。诊断为脑动脉硬化。证属气血亏虚兼见痰淤,拟补养气血,祛痰行淤之法。方以十全大补汤去人参,加桃仁6g,红花3g,地龙、半夏、川牛膝、陈皮、黄连、防风各10g,生姜3片。服药4剂后症状减轻,故仍守原方,治疗1月后,除感左下肢时有发热外,余症俱消而出院[何良志,中医杂志,1993,(12):723]。

【方名】 舒筋保安散。

【组成】 黄芪30g,当归、赤芍各12g,川芎、川牛膝、僵蚕、天麻、桂枝、汉防己、石楠叶各10g,乌药、制南星各6g,豨莶草20g。

【来源】 何良志,中医杂志,1993,(12):723。

【功效】 益气活血,祛风化淤。

【适应证】 痰淤阻络之肢体麻木症。

【方药简析】 方中黄芪补气行血；当归、赤芍、川芎、牛膝活血通络；僵蚕、天麻熄风化痰活络；桂枝、汉防己、石楠叶、豨莶草祛风除湿、行气通络，内外风俱宣，且能治肝肾风气入血分，可治四肢麻木且无力；乌药、南星顺气祛痰，以加强顺气祛痰、舒筋活络之功。

【病案举例】 吴某，男，70岁，1990年12月2日初诊。患者10天前晨起时感左半身麻木，但行走如常，伴头晕，动则气喘，纳食可。检查病人体胖，血压17/11kPa，左侧肢体痛觉轻度减退，肌力正常，舌红稍暗，苔薄黄腻，脉弦滑，头颅CT示：右侧基底节区腔隙性脑梗死。证属痰湿夹死血阻于经络，营卫失于调畅所致。拟益气活血祛风化痰之法，方用舒筋保安散加竹沥水30ml（分冲）。7剂后症状开始减轻，无其他不适，遂守原方10余剂痊愈。

【方名】 龙胆泻肝汤。

【组成】 龙胆草、柴胡、生甘草各6g，黄芩、栀子、木通、车前子、生地黄各9g，泽泻12g、当归3g。

【来源】 汪昂《医方集解》。

【功效】 泻肝胆实火，清下焦湿热。

【适应证】 肝胆实火上扰等症。

【方药简析】 方用龙胆草大苦大寒，上泻肝胆实火，下清下焦湿热，为本方泻火除湿两擅其功的君药；黄芩、栀子具有苦寒泻火之功，在本方配伍龙胆草，为臣药；泽泻、木通、车前子清热利湿，使湿热从水道排除；肝主藏血，肝经有热，本易耗伤阴血，加用苦寒燥湿，再耗其阴，故用生地黄、当归滋阴养血，以使标本兼顾；柴胡为引诸药入肝胆而设；甘草有调和诸药之效。

【病案举例】 邹某，女，32岁。舌尖奇麻如虫行针刺已2

月余,服中西药无效,痛苦非常,先后曾用食花椒、盐水外搽等方法,均无效。夜寐不宁,口苦咽干,目眩烦躁,尿少面黄,大便干燥,痰多而稠,脉弦细数,舌尖红赤,苔薄黄腻。此乃心火亢盛,胆火上逆。治宜清心泻火,舒肝利胆。方用龙胆泻肝汤加菊花、僵蚕、白蒺藜各 12g,黄连 5g。连服 4 剂后,舌尖作麻大减,仅有时轻微发作,饮食大增,烦躁已愈,夜间多梦,脉细数,舌淡红少苔。继服 2 剂,诸证消失。随访未复发[徐延良,四川中医,1993,(4):30]。

【方名】 小柴胡汤。

【组成】 柴胡 12g,黄芩、半夏、生姜各 9g,人参 6g,炙甘草 5g,大枣 4 枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 和解少阳。

【适应证】 伤寒少阳证;妇人伤寒、热入血室以及疟疾、黄疸与内伤杂病而见少阳证者。

【方药简析】 本方之柴胡为少阳专药,轻清升散,疏邪透表,故为君药;黄芩苦寒,善清少阳相火,故为臣药,配合柴胡,一散一清,共解少阳之邪;半夏和胃降逆,散结消痞,为佐药,为助君臣药攻邪之用;人参、甘草为佐;生姜、大枣为使,益胃气,生津液,和营卫,既扶正以助祛邪,又实里而防邪入。

【病案举例】 李某,女,42 岁。1 月前席地纳凉,罹患感冒,自服清热消炎药等,似愈。2 日后,忽感右臂困痛难举,继而右腿行走不便,半身麻木遍延于手指足趾、胸肋膝胯,遍治 1 月,症状如故,其苔白腻,其脉弦滑,此为风邪顺经内传,入于半表半里分肉之间,血脉不行所致。方用小柴胡汤加桂枝、当归各 15g,川芎 20g。服药 4 剂,痛麻减半,6 剂服完,诸恙皆愈[邵桂珍等,陕西中医,1987,(9):415]。

【方名】 补气升阳和中汤。

【组成】 黄芪 15g, 人参、白芍各 9g, 炙甘草、佛耳草各 12g, 陈皮、当归、白术各 6g, 生草根、黄柏、茯苓、泽泻、升麻、柴胡各 3g, 草薢、苍术各 4.5g。

【来源】 江灌《名医类案》。

【功效】 补气升阳, 利湿和中。

【适应证】 气虚湿阻之麻木症。

【方药简析】 方中补中益气汤, 升阳益气; 生草根、佛耳草、草薢化湿和中; 黄柏、苍术、茯苓、泽泻清热利湿健脾; 白芍抑肝扶土。诸药共奏补气升阳、健脾和中、清热利湿之功。

【病案举例】 李杲治一姐麻木, 六脉中俱得弦缓相合, 按之无力。其症, 闭目则浑身麻木, 昼减夜甚, 觉而目开, 则麻木渐退, 久则止。惧而不睡, 身体重, 时有痰嗽, 觉胸中常是有痰而不利, 时烦躁, 气短促而喘, 肌肤充盛, 饮食、大小便如常, 惟畏麻木不敢合眠为最苦。当升阳助气益血, 微泻阴火去湿, 通行经脉, 调其阴阳而已, 非脏腑之本有邪也, 遂以补气升阳和中汤主之。早饭后午饭前服之, 至八剂而愈。

41 意识障碍

意识是指人体对环境刺激所产生相应的内容及行为的反应状态。人类正常的意识活动应包括“觉醒状态”和“意识内容行为”。清晰的“觉醒状态”有赖于提高网状激活系统的完整，而“意识的内容与行为”则有赖于大脑皮质的高级功能活动。当各种原因引起严重功能紊乱时可出现意识障碍。临床上意识的分级为意识正常、睡眠、木僵及昏迷，本处所指意识障碍主要是指昏迷而言。昏迷是高级神经活动的极度抑制状态，临床表现以意识丧失、运动、感觉和反射等功能障碍，对外界的刺激无意识反应的一种危重症状。按昏迷程度的深浅分为浅昏迷（浅昏迷患者对外界强烈刺激如声、光、痛有一定的无意识反应）和深昏迷（对外界刺激完全无反应）两大类。引起昏迷的原因非常多，如流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症、中毒性肺炎、中毒性细菌性痢疾、脑卒中、肺源性脑病、心源性脑病、癫痫、肝病、糖尿病酸中毒、尿毒症以及药物、化学品中毒、电击、高温中暑等均可发生昏迷。

意识障碍属中医“神昏”、“昏愦”、“昏蒙”、“昏谵”的范畴。其病因病机为外感温热疫毒之邪，热毒炽盛，内陷心包，扰及神明；或温热之邪，上犯于肺，逆传心包；或阳明热盛，与实邪搏结于胃肠，上扰神明；或过食肥甘，忧思劳倦，伤及于脾，积湿成痰，或肝阳化风，风阳挟痰上闭清窍；或跌仆撞击，伤于头脑；或卒冒秽浊不正之气，清浊升降失常等原因皆可使元神失守而发生昏迷。昏迷属危急重证，病情转化迅速，临证应灵活

辨析。大致昏迷的临床表现,概为虚实两大类,如热毒、炎浊、风温、淤阻清窍,致阴阳逆乱、神明被蒙而昏迷者,属实证;气血虚耗,阴阳衰竭,不相维系,清窍失养,神无所倚而昏迷者,属虚证;也有虚实夹杂者。故在临证时应首辨病因之异、分外感内伤,二察昏迷特点、明标本缓急。在治疗时首应开窍醒神,急治其标,再祛邪扶正,标本兼顾。在辨证(热陷心营用清宫汤,湿热痰蒙用菖蒲郁金汤,腑热上冲用调胃承气汤,夏令暑厥用白虎汤,亡阴用生脉散,亡阳用参附汤)基础上,配服安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹等开窍醒脑剂。

胡臻等将老年糖尿病高渗性昏迷分4型进行治疗。①火扰心神型:治以清热解毒,醒神开窍,用清瘟败毒散或犀角地黄汤加减,药用生石膏30g,生地20g,知母20g,玄参15g,水牛角20g,炒栀子10g,黄连10g,地骨皮15g,天花粉20g等。高热便秘用增液承气汤加减。②风阳上亢型:治以滋阴熄风开窍,用羚羊角汤合六味地黄汤或滋水清肝饮加减;羚羊角3g,龟板20g,蝉衣10g,石决明20g,熟地15g,山药20g,山茱萸10g,丹皮10g,柴胡12g等。③痰浊蒙蔽型:治以化痰开窍,方用金水六君煎,药用:半夏10g,茯苓10g,陈皮12g,生甘草6g,生地15g,当归12g,菖蒲15g,葛根10g等,或服温脾汤,指迷茯苓丸等加减。④淤阻脑络型:治拟养血通络醒神,方用桃仁参芪地黄汤加减:桃仁10g,红花10g,西洋参10g,生黄芪20g,熟地黄20g,山药15g,山茱萸10g,茯苓15g等。共救治17例,其中8例经抢救治疗,高渗昏迷控制,恢复出院。9例死亡。

【方名】 代抵当丸加味。

【组成】 大黄(后下)、蒲公英、赤芍、石决明各30g,芒硝(冲)、炮山甲、半夏各15g,桃仁18g,当归20g,生地50g,牵牛

子 10g,川芎 12g。

【来源】 聂天义,福建中医药,1990,21(1):63。

【功效】 逐瘀通络,通利二便,祛痰化浊。

【适应证】 流行性出血热,少尿期昏迷。

【方药简析】 方中代抵当丸为王肯堂《证治准绳》方,功以行瘀活血,治虚人瘀血症。加半夏、牵牛子化痰降浊,通利二便;蒲公英清热解毒;赤芍、川芎与代抵当丸配伍加强活血之力;石决明平肝潜阳。

【病案举例】 王某,女,35岁,1976年8月15日初诊。患流行性出血热5天,因神昏1天延诊于余。刻诊:神昏,呼之不应,瞳孔对光反射迟钝,呼吸深大,面色晦暗,腹微胀,双下肢浮肿,按之微凹,小便每日不足200ml,大便3天未解,苔微黄欠润质红,舌下脉络青紫粗大,脉弦有力。血查尿素氮45mg%,肌酐2.5mg%。证属疫毒瘀阻所致。治当逐瘀通络,通利二便,佐以祛痰化浊,以代抵当丸加味。日1剂,2天后,神志清醒,小便增多,1日约500ml,大便日3次,微溏。复以5剂,诸症好转,复查尿素氮19mg%,肌酐1.5mg%,更以六味地黄丸善后。

【方名】 化斑汤。

【组成】 石膏 30g,知母 12g,生甘草、玄参各 10g,犀角(可用水牛角代替)2~6g,白梗米 9g。

【来源】 吴鞠通《温病条辨》。

【功效】 清气凉血。

【适应证】 温邪扰心之昏迷。

【方药简析】 本方由白虎汤加犀角、玄参组成,其中石膏是白虎汤中的主药,取其辛甘大寒,以制气分内盛之热;以知母苦寒质润,助石膏清肺胃之热,借苦寒润燥以滋阴为臣;犀

9g、枳壳、葛蒲、竹茹、天竺黄、川贝母各 6g,甘草 3g。2 天 1 剂,连服 7 天。服药期间,未见发病。连服 10 剂,症状消失,随访年余未见复发[赵济民,四川中医,1987,(4):46]。

【方名】 麻杏石甘汤。

【组成】 麻黄 5g,杏仁 9g,炙甘草 6g,生石膏 18g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 辛凉宣泄,清肺平喘。

【适应证】 外感风邪,身热不解,咳逆气急鼻塞,口渴,脉滑数者。

【方药简析】 方中麻黄为君,取其能宣肺而泄邪热,是“火郁发之”之义;但其性温,故配伍辛甘大寒之石膏为臣药,而且用量倍于麻黄,使宣肺而不助热,清肺而不留邪,肺气肃降有权,喘急可平,是相制为用;杏仁降肺气,用为佐药,助麻黄、石膏清肺平喘;炙甘草既能益气和中,又与石膏合而生津止渴,更能调和于寒温宣降之间,所以是佐使药。

【病案举例】 张某,男,4 岁,1961 年 3 月 20 日初诊。患儿于 3 天前发热、寒战、咳嗽,喉中有痰鸣,喘促气憋,烦躁不安,当晚在其父母单位医务室注射青霉素,口服磺胺片。次日晨起去儿童医院就诊,查体温 39℃,经 X 线透视检查,诊断为急性肺炎,经治症状稍有好转。自昨夜体温又上升至 39.5℃,咳嗽气憋,喉中痰鸣加重,鼻翼煽动,胸高肩抬,意识昏迷,时有四肢震颤。对言语、感觉均无反应,瞳孔等大,舌质红,苔少,口唇色绀,脉滑数。证属内有蕴热,外感表邪,内外之邪并结于肺,且有邪热内陷之势,神明被蒙。治宜清肺化痰定喘。方用麻杏石甘汤加炒葶苈子 4.5g,瓜蒌 10g,蛤粉 6g,羚羊粉 0.6g(分两次冲),紫雪散 1.5g(分两次冲),服药 1 剂后,当晚咳嗽、气憋均轻,随即安睡,喉中已无痰鸣声,醒后神智清醒。次

日就诊除有些衰弱状态外,精神已正常,体温 37.2℃,仅有时咳嗽数声,未闻及气喘痰鸣。已能进饮食,二便正常(陈家杨,实用中医神经病学)。

【方名】 茵陈栀子汤。

【组成】 茵陈 20g,生栀子 8g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 清热利湿。

【适应证】 湿热型黄疸。

【方药简析】 方中茵陈清热利湿退黄;栀子清三焦之实热,并有凉血作用。

【病案举例】 王某,女,48岁,1962年8月16日初诊。患者在半月前发热恶寒,头晕痛,恶心呕吐,胃脘不适,当时在本单位医务所诊为胃肠型感冒,经治疗后症状有些好转,但仍感全身疲倦无力。小便茶红色,发现皮肤与巩膜黄染,需转院治疗。检查:全身及巩膜黄染(++),腹胀,肝大在右肋下2.5cm,剑突下3.5cm,质软,脾未触及。肝功:胆红素4mg,黄疸指数36IU,凡登白试验阳性,麝香草酚浊度试验1.5IU。尿化验:尿三胆强阳性。经检查后诊断为传染性黄疸型肝炎,随收住院治疗。5天前病情突然变化,出现谵妄状态,近2天又出现昏迷状态,诊断为黄疸型肝炎,急性肝昏迷,请中医会诊。检查:舌质红,苔黄厚而腻,脉弦滑。辨证属湿热蕴毒,邪蒙清窍,扰及神明。治宜清湿热解毒,开窍醒神。方用茵陈栀子汤加黄连4.5g,金银花、连翘、大青叶、郁金、滑石、菖蒲各10g,甘草3g,安宫牛黄丸2丸(每次1丸)。服药2剂后,意识渐清醒,今日精神已正常,自称头晕,全身无力,不思饮食。舌质淡红,苔薄黄,脉滑缓。前方去安宫牛黄丸、菖蒲、郁金,加柏皮、焦神曲各10g,以巩固疗效(陈家杨,实用中医神经病学)。

【方名】 清宫汤。

【组成】 玄参、麦门冬各 9g, 莲子心 2g, 竹叶卷心、连翘各 6g, 犀角 2~5g (可用水牛角代替)。

【来源】 吴鞠通《温病条辨》。

【功效】 清心解毒, 养阴生津。

【适应证】 发热, 神昏谵语等。

【方药简析】 方中水牛角清营凉血为君; 玄参、麦门冬养阴清热为臣; 佐以莲子心、竹叶卷心、连翘清热解毒以透邪热, 使入营之邪促其透出气分而解。

【病案举例】 袁某, 女, 5 岁, 1960 年 3 月 18 日会诊。患儿 4 天前发热、恶寒、头痛, 继则呕吐甚急, 次日发作惊厥, 四肢抽动, 神识不清, 急送医院, 经脑脊液化验检查, 诊断为急性化脓性脑膜炎, 收住院治疗。经治疗症状不减, 呈深昏迷, 项背强直, 抽搐, 牙关紧闭, 舌质淡绛, 无苔, 脉细数。辨证属外感风温, 逆传心包, 阴虚风动, 心神被扰。治宜清营透热, 开窍醒神。方用清宫汤加生地、钩藤各 4.5g, 僵蚕 3g, 至宝丹 1 丸 (分两次冲服)。服药 1 剂, 抽搐渐止, 次日下午神识清醒, 体温 37.5℃, 今晨已能进食, 惟精神不振, 时欲睡, 大小便已知。舌红少苔, 脉细滑。再投以养阴扶正之品而收功 (陈家杨, 实用中医神经病学)。

【方名】 清瘟败毒饮。

【组成】 生石膏 180~240g, 生地黄 18~30g, 犀角 (用水牛角代替) 9~15g, 黄连 12~18g, 栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜竹叶各 10g。

【来源】 余师愚《疫疹一得》。

【功效】 清热解毒, 凉血泻火。

【适应证】 瘟疫热毒，充斥内外，气血两燔。

【方药简析】 方中重用石膏配知母、甘草，是取法白虎汤，意在清热保津；黄连、黄芩、栀子共用，是仿黄连解毒汤方义，意在通泻三焦火热；犀角、生地、赤芍、牡丹皮相配，即犀角地黄汤的成方，是为清热解毒、凉血散瘀而设，配清气法以治气血两燔之证；再配连翘、玄参“解散浮游之火”；桔梗、竹叶取其“载药上行”。本方虽合三方而成，但以白虎汤大清阳明经热为主，配以泻火、凉血，相辅而成，共奏清瘟败毒之功。

【病案举例】 赵某，男，20岁，会诊日期1956年8月19日。患者于前日发病，头痛、身疼、恶寒无汗、发热、呕吐绿水，继则神识昏迷、牙关紧闭、手足厥逆，于昨日收住院治疗。检查：体温40.6℃。神识昏迷，大小便失禁，营养发育良好，心肺正常，肝脾不大，瞳孔对光反射(+)，提睾反射弱阳性，膝腱反射(+)，克氏征(+)，踝阵挛(+)。血常规：红细胞计数 $4 \times 10^{12}/L$ ，白细胞计数 $13 \times 10^9/L$ ，中性细胞0.78，淋巴细胞0.19。诊断：流行性乙型脑炎。查：舌质红，苔白微黄，脉沉数有力。辨证属暑温夹湿，表邪未解，湿热蒙闭清窍，治宜辛凉解表、芳香开窍。方用清瘟败毒饮加羚羊角粉1g(冲服)，藿香、佩兰、竹茹、荷叶各10g，黄柏6g。服药1剂后，周身汗出，手足已返温，体温39.2℃，神识清醒，但仍有嗜睡现象，头身已不痛，呕吐已止，食欲欠佳，舌苔白腻，脉滑数有力。再以前方加减，继服2剂，一切症状消失，能下床行动，脉滑缓，体温36.8℃，停药观察。痊愈出院(陈家杨，实用中医神经病学)。

42 排尿性晕厥

排尿性晕厥是指在排尿时、排尿过程中、排尿末尾或排尿结束后立即发生为时短暂的晕厥，一般可以自行恢复，易反复发作。本病多见于男性，系由于排尿时腹盆腔内压力骤降，血液大量流入腹盆腔使血压下降，而立即性心搏加快和血压上升的神经反射功能迟缓，造成大脑一过性广泛性脑缺血。一般先有头昏、心慌、恶心、面色苍白、眼黑目眩、周身发软等先兆症状，随即意识不清和倒地。平卧后多迅速清醒，伴有冷汗和乏力感，稍事休息后即可恢复。偶可因意识短暂不清而发生外伤，一般不伴有抽搐和尿失禁。本病应同其他原因的晕厥、眩晕、癫痫发作、休克、猝倒症及瘧症相鉴别。本病目前无特别治疗方法，有人试用安定、654-2 等治疗。

本病属于中医晕眩、厥证、尿厥、急症等病证的范畴。本病的病因病机主要是由于各种原因导致肾气、肾阳不足或中气不足，或阴阳不和，或气机逆乱，以致于排尿时阴阳之气一时不相顺接。本病治疗首当辨证，若肾气、肾阳不足者用补中益气止厥汤、人参养荣除厥汤加减；若阴阳不和者用桂枝汤、柴胡桂枝汤、加味参附汤加减；若虚实错杂者用固肾摄浮汤、黄连阿胶复脉汤、知柏地黄安厥汤、复生汤加减。

渠敬文用培元固气汤（黄芪 20～60g，红参 8～15g，肉桂 6～8g（后下），山茱萸 15g，山药 30g，石菖蒲 10g，升麻 6g，益智仁 12g，炙甘草 6g）为基础方，若伴血虚者加当归、桑椹子；心悸者加柏子仁、琥珀；肾阳虚者加附子、肉桂；脾虚者加白

术、木香、茯苓；中气下陷者加柴胡。治疗本病 8 例，平均服药 17 剂，8 例全部治愈，随访 1～10 年未见复发[中医杂志，1990，(7)：32]。

【方名】 右归平厥汤。

【组成】 熟地黄 15g，当归 10g，鹿角胶 10g，附子 10g，肉桂 6g，山茱萸 6g，枸杞子 10g，山药 10g，杜仲 10g，菟丝子 10g，人参 10g，肉苁蓉 10g，巴戟天 10g。

【来源】 洪庆会，湖南中医杂志，1992，(3)：34。

【功效】 温肾填精。

【适应证】 排尿性晕厥，证属肾精不足，命门火衰者。

【方药简析】 本方是由右归饮加味而成。方中熟地、当归、鹿角胶甘温滋肾以填精；附子、肉桂温补肾阳而祛寒，能鼓舞肾中命门之阳气；山茱萸、枸杞子养肝血，助主药以滋肾补髓；山药补中养脾；杜仲、菟丝子补肝肾、壮筋骨；人参、巴戟天、肉苁蓉大补元气，以增强温补肾阳、强壮筋骨的作用。全方有温肾填精之效。洪庆会以本方为主加减治疗本病有良效。

【病案举例】 隆某，男，38 岁，1990 年 12 月 10 日就诊。患者自诉于今年 6 月以后，间歇性出现排尿时晕倒，每月可见 1～2 次，无时间规律性，同时伴有精神萎靡、腰膝酸软、头晕耳鸣、无性欲感、阳事不举，在当地多次求医，服中药数剂，效果不佳。昨夜间 3 时许，患者起来小便，当小便快排完时，突然出现头晕眼花、下肢发软而昏倒在地，神志不清，面色苍白，四肢逆冷，不抽搐，口不吐白沫，约 2min 后自行苏醒。醒后除右手小指指甲因跌伤被剥脱外，余无其他后遗症，今日清晨步入我院就诊。测血压 12/8kPa，心电图检查正常，血常规检查：血红蛋白 120g/L，红细胞计数 $4.5 \times 10^{12}/L$ ，白细胞计数 $7.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.70，淋巴细胞 0.25，其他各脏检查无病。

后脑昏沉,下肢无力,夜尿稍多,此肾阳不振、血行淤滞之征,治宜温阳益肾、活血化淤为主。予上方治疗。服药10剂,舌边紫气渐消,后脑昏沉、下肢乏力等症减轻。以此方加减调治1月,晕厥未发,病乃告愈。随访1年,排尿晕厥未再复发。

【方名】 补中益气止厥汤。

【组成】 黄芪20g,党参15g,白术10g,甘草6g,陈皮10g,冬虫夏草10g,黄精15g,山药20g,菟丝子12g,当归15g,白芍15g,川芎9g。

【来源】 管敬毕,新中医,1993,(8):19。

【功效】 益气升清,填精补髓,调整阴阳。

【适应证】 排尿性晕厥,证属清阳不升,肾精亏虚,阴阳不调者。

【方药简析】 本方由补中益气汤加减而成。方中黄芪、党参、白术、甘草益气升清;陈皮行气醒脾,补而不滞;冬虫夏草、黄精、山药、菟丝子滋阴补阳,阴生阳长而趋向协调;当归、白芍、川芎补血活血,气血调和,阴阳平衡,晕厥可愈。管敬毕以本方为主随证加减治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,54岁,1985年4月25日初诊。近2年来于小便后,常发生晕厥,每次持续约1~2min自醒,醒后感乏力,腰膝酸软,小腹拘急感,休息片刻即可复常。开始时每月有3~5次,后发展至每月7~8次。经各项检查,神经系统、血压等均无异常,省立医院诊断为:排尿性晕厥。后经中西药治疗效不佳而来诊。证见精神萎靡、乏力、头晕耳鸣、发稀落,舌淡、苔薄白,脉沉弦细。证属清阳不升,肾精亏虚,阴阳失调。治宜益气升清、填精补髓、调整阴阳。处方:黄芪30g,党参、当归、白芍、生地各15g,升麻4g,山药20g,菟丝子12g,冬虫夏草、白术、陈皮各10g,柴胡、甘草各6g。5剂,水煎服。嘱

少房事,少劳累。此后5日内发作1次,仍腰膝酸软较重。上方去升麻、白术,白芍加至20g,菟丝子仍改为12g,加川芎9g,黄精15g,15剂。二诊:此期间仍发作1次,但时间较前短暂,服药略有口干且上腹仍拘急感。三诊:半月来仅发作1次,且很快苏醒,腰酸乏力较前大减。继用本方加减,以间断服药法,即每服10剂,休息1周,再续10剂。前后共服4个月,随访2年,未见复发。

【方名】 人参养荣除厥汤。

【组成】 柴胡、升麻、附子、炙甘草、人参各6g,黄芪45g,当归、白芍、熟地黄、白术、茯苓、陈皮各12g,五味子15g,远志、石菖蒲、肉桂各15g,生姜3片,大枣10枚。

【来源】 徐集民等,新中医,1991,(9):33。

【功效】 益气补肾,升清降浊。

【适应证】 排尿性晕厥,证属气血俱虚者。

【方药简析】 本方是由人参养荣汤加减而成。方中人参大补元气,宁神益智;黄芪补气升阳;当归、白芍、熟地黄养阴补血;白术、茯苓、陈皮健脾益气;肉桂、制附子入心肾温补阳气,振奋气机;五味子滋补肾阴,纳气固精,补养骨髓,益气固脱,与肉桂、附子相配使阳生阴长;石菖蒲舒心气,畅心神,怡心情,益心志;远志,《本草纲目》曰:“远志入足少阴肾经,专于强志益精,”与菖蒲相伍,交通心肾,交接水火;柴胡、升麻升阳举陷;炙甘草、生姜、大枣调和营卫。诸药合用,使心气畅达,元气充沛,肾气旺盛,清升浊降,神清脑明,则不致昏厥。徐集民等以本方为主加减治疗本病25例,结果痊愈(3年以上未发作者)20例;显效(2年内未发作者)3例;有效(1年内未发作者)1例;无效(经治1月仍发作者)1例。其中服药最少6剂,最多达60余剂。

查：神志清楚，面色红润，舌质红，苔薄白，脉弦缓。诊断：厥证。中医辨证属阴阳之气不能顺接所致，拟选和法，以平为期，调和阴阳。投以桂枝汤，方药：桂枝 15g，白芍 15g，炙甘草 10g，生姜 3 片，大枣 4 枚，3 剂水煎服。次诊：服药后晕厥次数明显减少，仅于早晚 5～7 点（卯、酉）发作。卯酉乃是阴阳相接之时，药中病机，效不更方，续服 3 付。再诊：服药后晕厥消失，病告痊愈。随访 2 年未见复发[金树武，中医药学报，1991，（5）：41]。

【方名】 柴胡桂枝汤。

【组成】 桂枝 6g，白芍 15g，黄芩 10g，人参 10g，甘草 6g，半夏 10g，大枣 6 枚，生姜 10g，柴胡 6g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 扶正祛邪，调上达下，协和阴阳。

【适应证】 排尿性晕厥，证属元气不足，阴阳不相顺接者。

【方药简析】 本方是由小柴胡汤与桂枝汤各取半量合剂而成。以桂枝汤调和营卫，以小柴胡汤和解表里，有扶正祛邪、调上达下、协和阴阳之功。杨恒杰以本方加减治疗本病有良效。

【病案举例】 张某，男，44 岁，1980 年 3 月 5 日初诊。夜间小便时突然晕厥不省人事，移时自行苏醒，反复发作已有十余年。近来发作频繁，每夜小便时即感头晕，继之昏不识人，少时自醒，神志复常。白天小便时不发生晕厥。据家属述，患者昏倒时无口噤、吐涎沫及叫声，四肢亦不抽搐。服中西药效果不显，乃前来求诊。患者面色萎黄，形瘦食减，伴有失眠，舌苔薄白，舌质淡红，脉细。即处予柴胡桂枝汤 3 剂。药后夜间小便时不再晕厥，食欲增加，睡眠好转。为巩固疗效，上方继服 3

剂,随访至今,未再复发[杨恒杰,江苏中医杂志,1983,(1):42]。

【方名】 加味参附汤。

【组成】 人参、肉桂、甘草各 6g,熟附子 12g,阿胶(烔化)、当归各 10g,茯苓 24g,薏苡仁 30g,熟地黄 15g,车前子 30g。

【来源】 刘素秋,四川中医,1992,(5):20。

【功效】 温补心肾,化水除湿。

【适应证】 排尿性晕厥,证属阴阳失调,心肾不交者。

【方药简析】 方中人参大补元气,强心救脱;附子、肉桂补肾阳以益火之源,有强心鼓舞心气之作用;熟地黄、阿胶、当归有补肾气、敛肺气而强心气之力;茯苓、薏苡仁、车前子能健脾补中,渗利水湿。全方共收阴阳调和、水火既济之功。刘素秋以本为主随证加减治疗本病有良效。

【病案举例】 高某,女,62岁。近半月来每当夜间起床小便即将排空时则感心慌、头晕、汗出、恶心欲吐、手足发凉,每次持续约 3min 左右方能缓解。平时身倦乏力。诊见患者形体瘦弱,面色晄白无华,舌质淡苔薄白,脉沉细。血压、心电图、血常规、尿常规均属正常范围。辨证为心肾不交、阴阳失调。重在温补心肾之阳并化水除湿。拟加味参附汤治之:人参、肉桂、甘草各 6g,熟附子 12g,阿胶(烔化)、当归各 10g,茯苓 24g,薏苡仁 30g。水煎服,日 1 剂。服 3 剂后,症状好转,夜间排尿时上证发作较前减轻。拟上方加熟地 15g,车前子 30g,以加强补肾利湿之功。又连服 9 剂,诸症全消。后改用补心丹、金匱肾气丸以资巩固,1 年后随访,未复发。

【方名】 固肾摄脬汤。

【组成】 柴胡、白芍、当归各 9g,枳实、甘草、石菖蒲各 6g,黄芪 24g,金樱子、桑螵蛸、柏子仁、酸枣仁各 15g。

【来源】 蒋立基,浙江中医学院学报,1988,(12):12。

【功效】 舒肝降逆,固肾摄脬,调和气血。

【适应证】 排尿性晕厥,证属上实下虚,气机逆乱。

【方药简析】 方中以柴胡、白芍、当归、枳实舒肝降逆为主;黄芪、金樱子、桑螵蛸益气固肾摄脬为辅;柏子仁、酸枣仁、石菖蒲养心安神醒脑为佐;甘草调和诸药为使。全方舒肝降逆,固肾摄脬,调和气血。

【病案举例】 刘某,男,50岁,1984年5月16日初诊。近2月来发生排尿后昏厥4次,前3次均在白天小便快解完时,自觉天旋地转,失去知觉,倒于小便池上,无他人发现,少时清醒如常人。昨晚又发生1次,其妻闻声赶来,见其面色苍白,气息微弱,手足厥冷,但无肢体抽搐、口眼歪斜及口中吐沫等情况,约3~5min后,缓缓苏醒,全身冷汗。询知患者在发病前曾有一度烦劳过度、情怀不畅史。现偶感腰酸眩晕、心烦胸闷,纳可便调。检查:脉弦细,苔白薄。证属血气并走于上,上实下虚,气机逆乱。治宜舒肝降逆,固肾摄脬,调和气血,拟方如上。药进5剂,病人自动停药。约1月后又诊,据云昨日又发1次,惟症状甚轻,仅感头眩眼花、神识朦胧,数秒钟即止。守方再服6剂,随访至今,病未复发。

【方名】 黄连阿胶复脉汤。

【组成】 黄连 6g,栀子 10g,阿胶(烔化兑服)10g,生龙骨、生牡蛎各 20g,龟板 15g,醋柴胡 10g,生地 15g,白芍 15g,木香 6g,制香附 15g,丹参 15g。

【来源】 庞景三,江西中医药,1993,(1):13。

【功效】 清降浮阳,疏理郁滞,交通心肾,协调阴阳。

5个月以来,每当夜起小便即感头胀头晕,继之四肢厥冷,不省人事,同时伴有耳鸣、腰膝酸软等证,曾查血、尿常规,脊髓、膀胱“B超”均属正常。经服中、西药物治疗,疗效不佳。舌质暗红、苔薄微黄,脉弦细。予上方3剂后症状明显减轻,夜起小便时仅出现头胀头晕,未再出现晕厥,续服6剂告愈,随访1年未复发。

【方名】 复生汤。

【组成】 太子参20g,茯神15g,麦门冬10g,生地黄10g,五味子10g,枸杞子20g,何首乌15g,菊花10g,生龙骨、生牡蛎各20g,甘草6g。

【来源】 庞景三,江西中医药,1993,(1):13。

【功效】 益气阴,补肝肾,平亢阳。

【适应证】 排尿性晕厥,证属肝肾阴精不足、心脑失养者。

【方药简析】 本方是由生脉散加味而成。方中以太子参、麦门冬、五味子益气阴,充血脉为主;生地黄、枸杞子、何首乌养阴精补肝肾而固本为辅;佐以菊花、生龙骨、生牡蛎平潜肝之亢阳;使以甘草调和诸药。全方益气阴,补肝肾,平亢阳,缓急兼顾。庞景三以本方治疗本病有良效。

【病案举例】 周某,男,32岁。1985年5月12日上午在排小便后,即晕倒在厕所内,被抬回住室,掐人中、喂热开水后随醒。患者自述:便后先头晕、眼冒金星,继而眼前发黑,自己控制不住便倒下了。现感困乏,手足发凉。问其平时有无此类情况,答云:时有小便后头晕、心跳、眼冒金星或眼前发黑的情况,但旋即消失。检查:脉弦细数,舌红少苔,此肝肾阴精不足,心、脑失养之故。以本方服3剂后,康复如初。嘱服六味地黄丸1个月,并节房事,未见复发。

43 焦虑性神经症

焦虑性神经症即狭义的焦虑症,是以发作性或持续性情绪焦虑、紧张为其主要特征的一组神经官能症。患者的焦虑情绪并非由现实威胁所引起,其紧张程度与现实情况很不相称,常伴有植物神经症状和运动性不安,严重者可有惊恐发作,为常见的焦虑性障碍之一。既往有许多术语描述各种焦虑状态,如心脏性神经症、血管运动性神经症等。本病属一种常见的精神疾病,患病率为1.48%,女性多于男性,发病年龄大多在16~40岁。本病发病机理不完全清楚,根据临床症状的不同可分为急性焦虑(即惊恐发作,这是一种突如其来伴有植物神经功能失调的惊恐体验、(胸痛、心动过速、心跳不规则、呼吸困难、头痛、头昏、眩晕、晕厥和感觉异常,也可以有出汗、腹痛、全身发抖或全身瘫软等症状。通常起病急陡,终止也迅速,一般持续数十分钟便自发缓解,患者发作过后仍心有余悸,但焦虑情绪体验不再突出,只感到虚弱无力,经过若干天可逐渐恢复)和慢性焦虑(又称广泛性焦虑或浮游性焦虑,患者长期感到紧张和不安,做事时心烦意乱,没有耐心;与人交往时紧张急切,极不沉稳;遇事惊慌失措,六神无主,极易朝坏处着想;休息时,也坐卧不宁,担心出现飞来横祸,表现为主观过虑;伴有心悸、心慌、出汗、胸闷、呼吸迫促、口干、便秘、腹泻、尿频、尿急、皮肤潮红或苍白、失眠、阳痿、早泄、月经紊乱等植物神经失调症状,以及舌、唇、指肌震颤,坐立不安、搓拳顿足、肢体发抖、全身肉跳、肌肉紧张性疼痛等运动性不安表现)两大类。

经统计学处理后 $P < 0.001$, 具有极显著差异。疗前心电图检查, 17 例有心肌缺血改变, 疗后心电图复查 7 例有改善, 另 10 例无变化。其中以肝郁气滞型和肝郁气滞血淤型多见, 且疗效较好(天津中医, 1996, (6): 7)。二是中医的医疗气功、参禅疗法对本病有良好的精神调节作用。三是合并小剂量的苯二氮卓类药物可以迅速改善焦虑情绪和睡眠情况, 对重症患者提高治疗信心有帮助。

【方名】 栀子龙牡汤。

【组成】 栀子 10g, 龙骨 30g, 牡蛎 30g, 柴胡 10g, 木通 10g, 生地 15g, 知母 10g, 白芍 10g, 甘草 6g。

【来源】 黄敏, 江苏中医, 1995, (11): 10。

【功效】 疏肝理气, 养阴安神除烦。

【适应证】 焦虑症, 证属气郁化火者。

【方药简析】 方中栀子乃清热除烦之要药; 龙骨、牡蛎收摄心气, 为重镇安神之珍品; 柴胡、枳壳疏肝理气; 白芍、甘草酸甘化阴, 能柔肝以缓急; 生地、知母滋阴清热, 协主药以除烦; 木通清热, 善走下焦, 可使内热自小便而泄。诸药合用, 可使气机畅, 烦热除, 心神安。若胸闷心悸、濒死感明显者, 用龙骨 60g, 牡蛎 60g; 广泛性焦虑为主者, 用栀子 20g; 口干明显者, 加天花粉 15g; 便秘, 加生大黄 10g; 夜眠差, 加酸枣仁 10g, 茯神 10g。每日 1 剂, 水煎, 早晚分服, 10 天为 1 个疗程, 连续服 3 个疗程。黄敏以本方为基础方, 按上述加减用药, 治疗本病 16 例, 结果显效 8 例, 进步 6 例, 无效 2 例。总有效率 87.5%。

【病案举例】 钱某, 男, 74 岁, 大学教授, 1993 年 7 月 22 日住院。主诉: 烦躁、胸闷、心慌、紧张、睡眠欠佳 3 月余。3 月前某日洗澡时突感头晕目眩, 站立不稳, 持续约数秒钟, 当时

未在意。数日后复发，且伴心悸、胸闷，有濒死感，持续十余分钟。此后患者对健康状况十分担心，惟恐突遭不测，整天紧张，愁眉苦脸，坐立不安，常感胸闷，呼吸不畅，喜叹息，饮食无味，口干多饮，尿急尿频，溲解不多，大便干结，夜难成寐。曾在外院住院治疗1月而诸症未减，1周来病情加剧，自觉浑身难受，度日如年，向妻儿交代后事，要求“安乐死”。来我院，中医症见面容憔悴，坐立不安，手足无措。舌质红苔黄，脉弦细数。诊为焦虑症。治用基本方，栀子用至20g，加生大黄10g（后下），天花粉15g，茯神10g。进10剂后神情渐安，饮食渐增，大小便调和，诸症渐退。30剂后诸症悉除。

【方名】 黄连温胆汤。

【组成】 黄连5g，半夏10g，陈皮10g，茯苓10g，甘草8g，生姜6g，竹茹10g，枳实10g。

【来源】 陆廷诊《六因条辨》。

【功效】 清胆和胃除痰，清心宁神。

【适应证】 老年焦虑性神经症，证属胆虚痰热上扰者。

【方药简析】 本方所标药物剂量为编者所加。方中陈皮、半夏燥湿化痰，理气和胃为主；竹茹、黄连清热化痰为辅；茯苓利湿化痰宁心，枳实破滞降逆除三焦痰壅，生姜降逆化痰，共为佐药；甘草调和诸药为使。全方可清胆和胃化痰。张觉人以此方为基础方，随证佐以夜交藤、合欢皮、僵蚕、胆南星、龙齿、夏枯草、郁金、葛根、白芷，治疗本病有良效。

【病案举例】 向某，女，61岁，退休工人，1990年7月13日就诊。患者近3个月来焦虑、紧张，时而烦躁易怒，时而性情抑郁，有莫明其妙的畏惧感，或恐惧感，以至一人常不敢睡觉。症见：少寐多梦，心悸不宁，口苦纳减，舌苔黄腻，脉象弦滑。诊断为老年焦虑性神经症，综析脉症，本案系痰热内扰，胆失中

正,波及于肝。肝与胆相为表里,肝藏魂,主谋虑,木郁不达,则多疑虑,善暴怒,神魂不定诸症由生。据症拟案,治以清胆和胃、解郁化痰。方用黄连温胆汤加味:黄连 5g,夜交藤、茯苓各 12g,生甘草 8g,陈皮、枳实、姜半夏、竹茹、胆南星、合欢皮、郁金各 10g,远志 9g,夏枯草 15g。日 1 剂,每剂煎服 3 次。7 月 20 日再诊,诉服药 5 剂后,恐惧感减轻,性情渐开朗,不再焦虑易怒,每晚能睡 5~6h,惟头额痛,舌苔腻略黄。仰原方加葛根 15g,白芷 5g,又服 5 剂。7 月 25 日 3 诊,诉恐惧感诸症消失,头额痛亦除,它无不适,睡眠正常,舌苔薄黄。前方继进 5 剂,以巩固善后[张觉人,新中医,1994,(11):58]。

【方名】 温胆定心汤。

【组成】 陈皮 10~12g,朱茯苓 15~20g,枳实、竹茹、胆南星、石菖蒲各 10g,制远志、煅龙骨、煅牡蛎、全瓜蒌、法半夏各 10~20g,炙甘草、黄连各 6g,琥珀末(冲服)4g。

【来源】 许心纯,新中医,1994,(11):21。

【功效】 清胆和胃,理气化痰。

【适应证】 心脏神经症,证属胆虚痰热内扰者。

【方药简析】 本方是由温胆汤加味而成。方中陈皮、法半夏燥湿化痰,理气和胃;竹茹、全瓜蒌、黄连清热化痰;朱茯苓、石菖蒲、制远志化痰宁心;煅龙骨、煅牡蛎、琥珀宁心定志。正如陈修园《时方妙用》所云:“二陈为安胃祛痰之剂,加竹茹以清膈上之虚热,枳实除三焦之痰壅,热除痰清,而胆自宁……。”胆属少阳,具升发之气,胆气升,十一脏之气皆升,各脏腑功能即能恢复正常活动。本方水煎服,每日 1 剂,15 天为 1 疗程。许心纯用本方按上述方法用药,治疗本病 35 例。治疗 2 个疗程后,治愈(症状消失,恢复正常工作,随访 6 个月未复发者)29 例,占 83%;好转(心前区疼痛等临床症状大部分消

热、五心烦热较重者加地骨皮 15~20g, 银柴胡 10g; 心慌、易惊较重者加龙齿 10g, 紫石英 15g; 不效时可再加用琥珀、朱砂各等份, 共为细末, 1 次 3g, 1 日 2 次, 温开水送服; 如遇胸中烦热、急躁易怒者, 即加用炒山栀、竹茹各 10g; 兼有阳虚者加制附子、肉桂各 10g; 兼有气滞血淤者加香附 10g, 丹参 12g。程广里以本方为基础方, 按上述加减用药, 治疗焦虑伴发植物神经功能失调症状(心悸易惊, 五心烦热出汗为主要表现)50 例。结果显效(用药后, 病人自觉各种症状明显减轻乃至消失)27 例, 进步(用药后, 病人主要症状明显减轻乃至消失)21 例。以上两项病人, 经治疗均自觉头脑清楚、精神振作、脑力和体力均有较显著的提高, 并观察半年以上未有复发。无效(服药后症状无明显变化)2 例。

【病案举例】 徐某, 女, 47 岁, 1981 年 4 月 27 日初诊。自述 3 年来, 经常头晕头沉, 似有物压迫, 精神不振, 并时有头面部阵发性烘热, 热则汗出心慌, 并伴有胸中烦热, 手足心热, 少眠, 多恶梦。近年来, 健忘, 遇事易惊, 工作效率降低, 经我院内科检查未发现器质性病变, 诊断为“植物神经功能失调”。3 年来, 虽多方求治, 然效果不著。今见患者面色无华, 精神萎靡, 语言无力, 舌质红, 舌苔薄白, 脉象沉弦细数。用新加逍遥饮加味治之, 处方: 生地 40g, 当归 12g, 酸枣仁 20g, 山药 16g, 茯神 12g, 炙甘草 12g, 陈皮 10g, 远志 12g, 沙参 10g, 丹皮 12g, 地骨皮 18g, 龙齿 10g。水煎服, 1 日 1 剂, 分 2 次温服。上方服 6 剂后, 精神转佳。头晕头沉、心悸易惊、夜寐不安均有明显减轻。但仍感五心烦热、头面烘热、阵发性汗出。又诉咽舌干燥, 上方加银柴胡 12g。继服 6 剂而精神大振, 自觉头脑清楚, 烘热汗出消失, 舌转淡红, 脉见缓象。药症合拍, 前法继进。以上方加减出入, 服药月余, 诸症皆失, 随访半年, 上症未见复发。

【方名】 加味安神定志汤。

【组成】 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 12g, 酸枣仁 10g, 茯神 10g, 龙齿 30g, 朱砂 0.8g(冲), 远志 10g, 石菖蒲 10g, 甘草 3g。

【来源】 时全志等, 河南中医学院学报, 1980, (2): 70。

【功效】 益气养心, 镇惊安神。

【适应证】 焦虑性神经官能症, 证属心胆气虚者。

【方药简析】 本方所标药物剂量为编者所加。方中党参性味甘平, 有补益心气, 安神益智的作用, 故用为本方之主药; 白术、茯苓以开运后天之本, 化气血滋壮心胆; 配入酸枣仁宁心益胆、安神定志; 茯神宁心安神, 治疗惊悸失眠, 常与枣仁同用; 龙齿、朱砂尤善镇惊壮胆; 远志、石菖蒲可开窍醒神, 资助心气以宁志。莲子补益心脾, 养心安神尤佳; 甘草调和诸药。共奏益气养心、镇惊安神之效。若兼有肝郁惊恐发作者加郁金、琥珀; 若兼命门不足者加肉桂。时全志等以本方为主, 按上述加减用药治疗本病 10 例有良效。

【病案举例】 周某, 女, 25 岁, 农民, 1975 年 5 月 19 日就诊。患者素日性情抑郁, 近年来常觉心慌气短, 多梦健忘, 胆怯易惊, 精神昏沉, 纳差不欲食。半月前因与家人吵嘴, 病情加重。每于傍晚之时, 心惊胆怯, 六神无主, 西医诊断焦虑症。中医症见舌质淡嫩, 苔薄白, 脉弦细, 主症同前。此症属于心胆气虚, 兼有肝郁之势。拟益气镇惊、安神定志, 佐以疏肝之法。方用加味安神定志汤: 党参 15g, 炒白术 12g, 茯苓 12g, 莲子 10g, 茯神 10g, 龙齿 30g, 郁金 10g, 石菖蒲 10g, 远志 10g, 酸枣仁 10g, 炙甘草 3g, 朱砂 0.8g(另冲), 琥珀末 0.6g(另冲), 水煎服 4 剂。服上药后, 自感精神振作, 惟觉头晕、气短乏力、四肢麻酸、脉细缓。上方去琥珀, 加黄芪 30g, 再进 3 剂。半年后随访, 已经康复。

已安,效不更方再进6剂。服后患者已不再感害怕,精神转佳,再以养血安神丸以善其后(马阴笃等,奇难病精华,河南中医,1986,(3):28)。

【方名】 甘麦大枣白石汤。

【组成】 小麦30g,大枣7枚,炙甘草5g,白芍15g,石英10g。

【来源】 吴敦序,上海中医药杂志,1983,(6):9。

【功效】 滋养心肝,安神缓急。

【适应证】 焦虑症,证属阴血不足、心肝失养者。

【方药简析】 方中所标药物份量为编者所加。本方是金寿山由甘麦大枣汤加味而成。方中小麦伍大枣养心安神;配炙甘草,共成甘平之剂,又可缓肝之急;且炙甘草、大枣健脾补中,助气血生化,以滋养心肝;伍入白芍则有芍药甘草汤之意,可酸甘化阴,缓解挛急;配入石英,白石英入气分,紫石英入血分,质重能镇纳浮阳以定惊悸,安心神。全方滋养心肝,安神缓急。若治心神不安,一般可加枣仁、柏子仁、远志、茯神、夜交藤;若心悸怔忡,筋惕或惊厥加龙骨、牡蛎、磁石;若见拘挛、瞤动、抽搐,重用白芍、甘草,并加阿胶、枸杞子、女贞子、丹参、鸡血藤、桑寄生、钩藤、石决明之类。金寿山以本方为基础方,按上述加减用药,治疗心神不安,肌肉紧张(编者注:焦虑症运动性不安症状),证属阴血不足、心肝失养者有良效。

【病案举例】 郭某,女,57岁,退休工人,右腿阵发抽掣面部肌肉瞤动,全身阵发触电样感觉,反复发作已10年。发时心情焦急,大便偏干,脉弦细,舌淡中剥。中医诊断为脏躁,此属血虚生风、筋脉失养。治以滋阴润燥、养血柔肝。处方:炙甘草4.5g,淮小麦30g,白芍15g,紫石英(先煎)12g,枸杞子9g,石决明(先煎)15g,钩藤(后下)12g,桑寄生15g,鸡血藤15g,

枳壳 4.5g, 童子益母草 15g, 大枣 7 枚, 7 剂。服药后焦虑感已除, 右下肢抽掣尚作, 胸闷, 时有泛恶, 口干欲饮, 大便干结, 脉弦细, 苔中剥。治从原法, 于一诊方中去枸杞子、石决明、童子益母草, 加火麻仁 9g、丹参 9g、女贞子 9g、龙骨(先煎) 15g、牡蛎(先煎) 30g、炒白芍加至 30g。服 14 剂后诸症较减, 脉细, 舌红中剥, 治从原方出入: 淮小麦 30g, 炙甘草 4.5g, 大枣 5 枚, 炒白芍 30g, 紫石英 12g, 丹参 12g, 鸡血藤 15g, 钩藤 12g, 枳壳 9g, 佛手 9g。服 7 剂后, 四诊: 抽搐未止, 脉细, 舌红中剥, 处方: 淮小麦 30g, 炙甘草 6g, 大枣 3 枚, 炒白芍 15g, 阿胶 9g, 丹参 12g, 鸡血藤 15g, 钩藤 12g, 夏枯草 9g, 生牡蛎 30g。服四诊方后大好, 抽搐已止, 脉细, 舌红中剥已减, 于上方大枣加至 5 枚, 10 剂, 善后治疗。

【方名】 百合安神汤。

【组成】 南百合 30~40g, 女贞子 20~30g, 旱莲草 10g, 炒枣仁 20~30g, 夜交藤 20~30g, 生龙齿 20~30g, 珍珠母 20~30g, 五味子 3~6g。

【来源】 卢海涛等, 河南中医, 1992, (5): 25。

【功效】 益心镇惊, 安神定志。

【适应证】 焦虑症, 证属心胆亏虚者。

【方药简析】 方中南百合益心气以调神为主; 女贞子、旱莲草滋肾阴上交心神, 炒枣仁、夜交藤养心安神, 生龙齿、珍珠母镇潜浮阳, 共为百合之辅佐。全方益心镇惊, 安神定志。若阴虚阳亢者加生白芍、生龙骨、生牡蛎; 肝郁气滞者加醋柴胡、郁金; 心血不足之见证明显者加当归身、生阿胶、生白芍; 兼心悸怔忡者加朱远志; 痰浊内郁者去麦门冬、五味子, 加茯苓、石菖蒲、清半夏; 心肾不交者加黄连。吉良晨以本方按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 孙某,男,31岁,干部。1个月前因突受惊恐刺激后,渐感终日头脑空虚,神志恍惚,坐卧不安,如人将捕之状,心悸汗出,不寐多梦,易寤,寤后不易入寐,心烦焦躁,记忆力明显减退,食少纳呆,口苦咽干。每晚服氯硝安定方能勉强入睡,迁延月余,西医诊断为焦虑性神经官能症。中医症见:主症如前,舌苔微白黄润,脉沉弦细,按之略有指痕。证属心胆亏虚,神魂失养,脾失健运。治以益心镇惊,安神定志,健脾助运。方拟百合安神汤加减:南百合 30g,女贞子 30g,夜交藤 30g,朱远志 10g,益智仁 10g,郁金 10g,茯苓 15g,炒枣仁 30g,炒白术 10g,生龙骨、生牡蛎各 30g。服 7 剂后神志较前安定,心悸除,汗出止,夜能寐 3~4h,但仍多梦,口不苦,咽干轻,纳食增多,舌脉同前。予前方去生龙骨、生牡蛎、易生龙齿 30g,南百合加重 40g,另加五味子 3g。继服 7 剂后诸症大减,夜能寐 6~7h,时有做梦,神志安定,惊恐之状除,开始上班,舌脉皆转为常。为巩固疗效,继服 5 剂,1 月后随访病告愈。

【方名】 宁心忘忧煎。

【组成】 浮小麦 30g,百合 30g,柴胡 10g,郁金 10g,当归 10g,炒白芍 10g,丹参 12g,柏子仁 10g,朱茯苓 10g,磁石 20g,大枣 5 枚,炙甘草 6g。

【来源】 李惠治等,百病临床指南,220。

【功效】 解郁舒肝,宁心安神。

【适应证】 焦虑症等,证属肝郁阴血不足者。

【方药简析】 本方由甘麦大枣汤、百合地黄汤、磁朱丸 3 方化裁而成。方用浮小麦补脾胃,养心气,和肝用,除客热,止自汗,宁心安神;百合补中益气,安心定胆益志,养五脏,治癰邪狂叫、惊悸、涕泣不止,治百合病,故浮小麦、百合 2 味药为君;当归、炒白芍补血养肝;柴胡、郁金疏肝行气解郁,与归、芍

共为臣；朱茯苓入心，安神定志；磁石入肾，益阴潜阳，重镇安神；丹参祛瘀生新；柏子仁宁心安神，4味药共为佐；甘草、大枣缓急和中，既助浮小麦治脏躁，又可养胃和诸药为使。全方共收解郁舒肝，宁心安神之功。胸闷胸痛，加瓜蒌、薤白；胸脘痞闷，加厚朴花、玫瑰花；郁火多汗，加梔子、丹皮、青蒿；心肾不交常致失眠，凡心阴不足，心火偏旺者，加黄连、阿胶；若因肾阴不足，伴虚风作眩者，加龟板、龙骨；若肾阴已亏，心火又旺者，两组药对均可入选，以交通心肾。每日1剂，煎2次，于午后及睡前分2次服。张翼以本方为基础方，按上述加减用药，治疗脏躁症，现代医学的隐匿性抑郁症、焦虑症、更年期抑郁症、强迫观念等，超过百例，除个别患者外，绝大多数患者症状很快缓解，郁火消失，情绪稳定，食欲睡眠好，能坚持日常工作或家务劳动，遇再发时，症状亦轻，治疗亦易。

【病案举例】 马某，男，69岁，1992年1月18日初诊。3月前幼子因白血病病故，患者心情不悦彻夜失眠。对生活失去兴趣，时叹息，喜悲伤欲哭，心烦焦躁而又心悸胆怯易惊，因久治不效而来诊。既往有高血压病。病后纳谷不香，伴便秘、头晕耳鸣，舌淡嫩红，苔薄少津，脉弦滑。证属脏躁，治以宁心安神、怡悦情怀。先予交谈，心理治疗，后进汤液。因有头晕耳鸣，用以宁心忘忧煎加减治疗。处方：合欢皮10g，郁金10g，炒白芍10g，当归10g，朱茯苓10g，磁石20g，浮小麦30g，百合30g，玄参30g，生地10g，竹茹10g，胆南星6g，炒枣仁10g，夏枯草10g，珍珠母30g。每日1剂，水煎服。1992年1月23日二诊：连服5剂药后，自感病减五成，大便通畅，头晕耳鸣及胆怯消失。心悸烦躁减轻，情绪可控制，睡眠明显改善。但药后胃脘灼热，疑与药凉滋腻有关。舌淡苔薄，脉沉滑。续以前方去玄参、生地、竹茹、胆南星、炒枣仁，加炒黄连5g，吴茱萸5g，法半夏10g，山药10g，炙甘草6g，6剂。1992年1月29日三

诊：药后胃脘灼热消失，食欲增加，夜眠已安，情绪平稳，心烦急躁已不明显，舌脉同前。嘱前方再进 10 剂，善后巩固。

【方名】 酸枣仁汤。

【组成】 酸枣仁 60g，甘草 10g，知母 15g，茯苓 12g，川芎 9g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 滋补肝血，安定神魂，清热除烦。

【适应证】 焦虑性神经症，证属肝阴不足者。

【方药简析】 方中所标药物份量系由丁德正根据其先父丁浮艇临床经验所定。本方即重用酸枣仁以养肝血，复以茯苓、甘草益气健脾，助化源以资肝；知母清润育阴，滋肾崇水，补肾以养肝；更佐以川芎调血养肝。因之肝血充，肝阴足，魂得养而自敛，虚烦可止而寐可安。丁德正用本方治疗本病有良效。

【病案举例】 李某，女，24 岁，已婚，1980 年 5 月 7 日诊。患焦虑性神经症已 5 年，诊前月余症状加剧。自谓“病重危在旦夕。”故惶恐焦虑，紧张万分，烦躁不眠，悲泣不已。频呼“救命”。诊时，惶惶然频频询问：“我是心脏病？治不好吧”余虽再三解释，然其惶惧焦虑之情，终难尽释。诊断为焦虑性神经症。中医症见：主症如前，患者肤瘦面晄，双颧微红，间或午后潮热，口干咽燥，舌红苔少，脉细数，头晕，目昏，肢体麻木，爪甲枯白凹陷。证为肝阴不足。予酸枣仁汤，服药 25 剂，焦虑惶惧及虚烦不眠之象大减。继服 20 剂，虚烦止，夜寐佳，焦虑尽失。后于上方酌事增损以制丸，嘱续服 8 个月以资巩固。据访，现健康如常[丁德正，河南中医，1987，(1)：21]。

【方名】 逐淤除烦汤。

【组成】 当归 15g,生地 24g,桃仁 15g,红花 9g,赤芍 12g,牛膝 12g,枳壳 12g,柴胡 9g,川芎 9g,桔梗 12g,淮小麦 30g,甘草 15g,淡竹叶 9g,大黄 5g,木通 9g,大枣 10 枚。

【来源】 唐宋,河南中医学院学报,1980,(1):28。

【功效】 活血化淤,清热安神。

【适应证】 焦虑性神经官能症,证属气滞血淤化热者。

【方药简析】 本方由血府逐淤汤、导赤散合甘麦大枣汤加减而成。血府逐淤汤意在行气活血化淤;用导赤散功在清心热而除烦躁;用甘麦大枣汤以养心安神、缓急和中,3方合用,可以互相促进,加强疗效,即能活血化淤清热,又能调理气血阴阳,以达到宁心安神之目的;方中用小量大黄,不是取其泻下,而取其攻其淤血的作用。若心悸较重者,加丹参;左肋满痛较重者加青皮;若体弱者,改用四物汤合导赤散。唐宋以本方为主,按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 某女,60岁,工人。与爱人口角而患病。初见头晕头痛,胁肋胀满疼痛,口干舌燥,心中烦热,但皮肤发凉。迭经治疗,它症已除,惟独心里热,皮肤凉,屡治不验。检查血糖、尿糖,皆为阴性。后来病情越来越重,每晚9时发作,突然心烦急躁,热如火焚,不能安卧,必揭衣被在房内走转,但皮肤发凉。大约15~20min的时间,不服药亦可逐渐消失,发作后气短乏力。继之由日发2~3次,发展到日发6~7次,发作时间20min逐渐延长到30min左右,延续6年之久,西医多次诊断为焦虑性神经官能症。中医诊断为灯笼病,服本方,连服9剂而愈,追访4年,未再复发。

【方名】 奔豚汤。

【组成】 葛根 15g,川芎 10g,当归 10g,黄芩 10g,白芍 10g,半夏 10g,桑白皮 15g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 化痰泻火，舒肝解郁。

【适应证】 焦虑性神经官能症惊恐发作，证属痰火郁结、肝肾气逆。

【方药简析】 方中桑皮止心烦逆，降奔豚气；葛根、黄芩清热平肝；芍药、甘草缓急；半夏、生姜和胃降逆；川芎、当归调养肝血。全方化痰泻火、舒肝解郁。若心悸而脉弦结者，加党参、五味子；若阵发性胸满，烦热上冲，喘而难于平卧者，加党参、麦门冬、五味子、紫苑。朱进忠以本方为基础按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 苏某，女，28岁，阵发性心胸烦热，逆气上冲，发作恐惧欲死而倒地5年，心情不愉快时发病，曾经多次住院检查治疗，诊断为焦虑性神经官能症。近来心情一直不愉快，1天发作1~2次，发作恐惧时先感胃部烦热，进而胸中烦热，咽喉憋闷难于呼吸，甚则发作恐惧欲死而倒地，几秒后突然全身汗出而清醒，醒后上症消失。发作时感觉有热气从胃脘部上冲，经胸、咽直冲至头部。刻诊，舌苔白，脉弦滑而涩，诊断为痰火郁结，肝郁不舒之奔豚气。服上方1剂，诸症稍减，服30剂，诸症消失而愈（朱进忠，难病奇治，169）。

【方名】 吴茱萸汤。

【组成】 吴茱萸 18g，党参 18g，生姜 18g，大枣 6枚。

【来源】 刘景琪，上海中医药杂志，1982，（4）：18。

【功效】 暖肝散寒，安神定志。

【适应证】 急性焦虑，证属肝寒脾虚者。

【方药简析】 本方是由张仲景的吴茱萸汤加重剂量而来。方中吴茱萸温肝散寒；党参健脾益气，安神定志；大枣益脾土调和营卫，为散肝寒、暖脾胃之方。如服后胃脘无不适，重症

病人可加大剂量至1倍,失眠严重者加炒枣仁、合欢花、夜交藤;胸憋满者加枳实、木香、青皮。少数病人初服有轻度胃脘不适,继续服药反应可消失。刘景琪以本方为基础,按上述方法加减用药,治疗本病32例,结果最少服药3剂,最多服药90剂,痊愈28例(症状消失,纳眠好,体重增加,恢复工作),进步4例。因吴茱萸有小毒,用药宜从小剂量开始逐渐增加。

【病案举例】 曹某,女,51岁,农民,1年前因爱人发生意外而受惊,遂失眠多噩梦、心烦易怒、头痛、恶心纳呆、吐涎沫,全身乏力、面色萎黄。近2个月来经常发作烦躁不安欲死,甚则昏厥、口唇发青、手足苍白逆冷,每日发作4~6次,每次20~40min。中医症见:主症如前,舌淡苔薄白,脉象左沉紧滑,右沉紧,诊断为焦虑性神经官能症。服上方6剂,昏厥停止,服36剂后临床治愈。

【方名】 桂枝加桂汤。

【组成】 桂枝18g,白芍9g,生姜9g,大枣4枚,炙甘草6g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 疏肝通阳,化饮降逆。

【适应证】 焦虑症惊恐发作,证属寒盛中虚者。

【方药简析】 本方重用桂枝配生姜通阳降逆为主药;辅以白芍、甘草、大枣柔肝以缓急。全方疏通肝阳,化饮降逆。杨毓书以本方加白术,治疗本病有良效。

【病案举例】 智某,男,35岁,汽车司机,1977年3月初诊。主诉:自1976年8月开始,少腹部发胀,微痛,自觉有一股气流从少腹部上冲心下,甚者冲到咽部,如哽似噎,气塞如堵,呼吸困难。此时心中空虚,如惊非惊,如恐非恐,如饥非饥,痛苦莫可名状,四肢困倦无力,不愿说话,不欲睁眼,更不想动

小便清长,口淡不欲饮水。入冬以来,烦躁加剧,每天需到大江中冷浴 3 次,每次 1~2h,始觉舒适,否则坐卧不安,烦闷非常。西医诊断焦虑性神经官能症。中医症见:主症如前,精神尚好,面色苍白,两颧淡红,语言清晰,胸腹未见异常,四肢动作自如,惟手足逆冷,舌质淡红胖嫩,苔薄白,脉浮弦细数,沉取无力。中医诊为阴躁,乃真寒假热,阴盛格阳之证。处方:桂枝 50g,熟附子 25g,黄芪 30g,白芍 25g,白术 25g,柴胡 10g,生甘草 6g。2 剂,水煎服。9 月 20 日复诊:胃部服药后稍觉舒适,知饥思食,头痛手麻木稍减,仍有烦躁,又去洗浴 2 次,脉如前,稍有力,宗原方加茯苓 25g、川芎 15g,日进 1 剂。10 月 8 日又诊,病情日渐好转,已不到江中洗浴,自觉症状消失,惟口燥舌干,舌质微红,脉沉细稍数。照上方加入丹皮 20g、麦门冬 15g,2 剂,水煎服,以巩固疗效。经随访未再复发。

44 恐怖性神经症

恐怖性神经症也称恐怖症,是以患者回避接触人们习以为常的物体、境遇或与人交往等,若被动接触时产生异乎寻常的恐惧与紧张不安的内心体验(可致脸红、气促、出汗、心悸、血压变化,甚至恶心、无力、昏厥等症状)为主要表现的一组神经官能症。本病在普通人群中较常见,但其中仅有少数就医。本病病因未明,临床所见恐怖的对象十分繁多,几乎生活中的每一事物都可能成为恐怖的对象,一般分为3类:空间恐怖症(恐怖对象为商店、公共汽车、剧院、教室、电梯、旷野、广场等),社交恐怖症(恐怖对象是需要与之交往的人)和单一恐怖症(恐怖对象是某一具体的物体、动物等)。许多文献中多以恐怖对象作为疾病名称,如飞行恐怖症、恐水症等。本病需与普通人的恐怖情绪、焦虑症、强迫症、疑病症、颞页癫痫相鉴别。临床多采用行为疗法及口服安定、心得安、多虑平、阿米替林、氯丙咪嗪等治疗。

中医文献中散见有恐怖症的记载但无专一的名称和分类,可见于郁症、卑慄、惊怖、惊悸、脑鸣症等。本病的病因病机主要是由于先天不足,后天失养,饮食劳倦,情志所伤等原因造成精气不足,五脏气血失和,神气不能振持周济于外,而遇一定对象则动摇,以致于愈趋愈避,交互作用,发为恐怖症,在五脏与心肝肾关系最为密切。临证首先应辨别清楚恐怖对象与五脏交互作用的关系。若以情志为主导因素时,应着重从情志上进行调节,以心理治疗或精神治疗为主,例如,以惊平惊

法，参禅疗法等。若以机体因素为主导时，应着重于辨证施治。肝郁不舒者用逍遥散；肝气郁结、阳气亢急者用芍甘安恐汤；心气虚怯、营卫失和者用桂枝加龙骨牡蛎汤；阳气虚弱、神气失养者用桂枝龙牡汤；心脾两虚者用归脾汤；肾虚者用大补元煎等。靳朴等将恐怖症分为4型（心脾两虚者用归脾汤加减；胆虚痰热者用温胆汤加减；若肝郁气滞者用逍遥散加减；若肾虚者用六味丸加减），配合以心理治疗（如心理修养按喻昌所云：“居处安定，无为惧惧，无为欣欣，则意志和，精神定，悔怒不生，魂魄不散，五脏俱宁”的要求，告诫病人对外界事物要冷静处理，保证情绪稳定，防止情绪激动和大起大落，注意保持良好心境。情志疏导按吴塘所云“详告以病所由来，使人知之而不敢再犯”“曲察……隐情，婉言以开导之，庄言以震惊之，危言以恍惧之，必使之心悦而诚服，而后可以奏效如神”通过与病人对谈，认真了解患者心理社会致病因素，进行病情解释和有的放矢的心理疏导，取得病人的信任与合作。对某些病人进行脱敏治疗，鼓励病人接触其所恐惧的事物，或先由人伴同而后单独，或由少到多，或由浅到深，反复练习，而不采取回避，直至完全适应为止），和医疗气功（太和元气法：即存想法。卧姿，让病人一心存想天空中有-圈太和元气，温暖祥和，光彩绚烂，降临头上，如雾如露，透皮入骨，由头而颈而胸而腹，逐渐渗入整个脏腑、四肢百骸，全身如浴于治疗百病药液之中。自觉五脏充实，六腑能畅，一股真气直达气海，斯须进入涌泉，周行全身。于是全身温暖，心情舒畅，病痛尽失，恐怖全消。宜于疾病恐怖症，虚证型。数息法：卧姿，让病人排除杂念，放松肌肉，调匀呼吸，由胸式逐渐转为腹式，要求顺畅、舒缓、自然，然后全神贯注，默数呼吸，一呼一吸为一，十而及百，百而及千，渐入忘我佳境，痛苦全消，恐怖尽去。宜于恐怖症之实证型。静坐法：蟠坐，排除杂念，放松，调匀呼吸，意守丹田，渐入

佳境,从而打破恐惧的恶性循环。宜于各种恐怖症)。本组 33 例,确诊为境遇恐怖者 5 例,包括广场、聚会、车厢、高墙、寝室恐怖各 1 例;社交恐怖 2 例,包括注目恐怖、红面恐怖各 1 例;特殊事物恐怖 26 例,包括癌症(鼻咽癌、食道癌、肝癌、结肠癌)恐怖 16 例,心脏病恐怖 3 例,癆病恐怖 2 例,“撞红”(性事值经期)恐怖 2 例,恐孕症 2 例,秃发恐怖 1 例。采取上述综合治疗,疗程最短者 10 天,最长者半年,平均 38 天,治愈 22 例(恐怖症状完全消失,恢复正常生活),占 66.6%;好转 7 例(恐怖症状强度减弱),占 21.2%;无效 2 例(恐怖症状同治疗前),占 6.1%;中断治疗 2 例。治愈后随访 5 例,1~2 年无复发[新中医,1996,(7):40]。

【方名】 逍遥散。

【组成】 柴胡 10g,当归 10g,白芍 10g,白术 10g,茯苓 10g,生姜 10g,炙甘草 10g,薄荷 6g。

【来源】 《太平惠民和剂局方》。

【功效】 疏肝解郁,健脾养血。

【适应证】 性病恐怖症、社交恐怖症等,主证属肝郁气滞者。

【方药简析】 本方系由四逆散衍化而成。方中柴胡疏肝解郁,当归、白芍养血补肝,3 味药配合补肝体而助肝用为主药;配伍以茯苓、白术补中理脾;少许薄荷、生姜为佐,以助本方疏散条达;炙甘草助脾健胃调和诸药为使。全方可疏肝解郁、健脾养血。若兼湿热下注者加扁蓄、瞿麦、茵陈、泽泻、滑石、木通、车前草;兼肾阴虚者加知母、黄柏、金樱子、桑螵蛸、益智仁、山茱萸等;兼心阴虚者加夜交藤、合欢皮、炒枣仁、远志、莲子心等;兼肾阳虚者加仙茅、仙灵脾等。同时结合心理治疗,努力使患者转移注意力,改变心态环境,减少病人自己寻

为阴性,血尿常规检查正常,前列腺液检查2次均正常,梅毒血清反应USR(一)。西医诊断:淋病治愈后性病恐怖症。中医症见:主症如前,舌质红,舌苔白腻,脉弦滑。中医辨证:肝郁气滞、湿热下注,用逍遥散加味治疗,配合心理咨询。服药7剂后自觉症状明显减轻,睾丸已不胀痛,上腹胀满及小腹胀痛减轻,胃纳好转,但仍觉阴囊粘湿,尿道口轻度灼热,大便秘结。原方加生大黄6g,再服7剂。药后诸症缓解,但仍觉阴囊发粘湿,继服前方,同时加用苍术、苦参、白鲜皮、茵陈、蛇床子、白矾煎水坐浴,3周后所有症状消失,痊愈。追踪2个月未复发[庄逢康,北京中医,1995,(2):22]。

某男,28岁,硕士,研究人员,未婚。缘患者月前与同事某女接触较多,适女离婚不久,年龄相若。1周来产生对人恐怖,每与该女接触,目光相遇即面红耳赤、心慌心跳、出汗、心情紧张无法自持,恐怖感严重,常有意回避,成为“心病”。虽以服药,但赤面恐怖有增无减,曾向组织提出调动工作未果。自知对该女并无爱恋之情,思路荒唐,恐怖无由,但摆脱无策,日夜焦虑不安。经检查排除其他疾病,诊为赤面恐怖症,辨证为肝郁气滞。治疗:首先进行心理疏导,给予其知识、安慰、心理支援,增强其治愈信心,借给他心理咨询专业书阅读,再与之讨论;教作太和元气功;治以疏肝解郁、宁志安神,用丹栀逍遥散加减。对谈20余次,治疗4个月而愈[靳朴等,新中医,1996,(7):41]。

【方名】 甘芍安恐汤。

【组成】 甘草20g,淮小麦90g,大枣15枚,炒白芍、丹参各20g,柴胡6g,合欢花、合欢皮各9g,琥珀6g(1日2次分吞服)。

【来源】 张建明,中医杂志,1990,(3):10。

【功效】 养心安神,舒缓肝气。

【适应证】 恐怖症,证属肝气郁结、神不潜宁者。

【方药简析】 方以仲景甘麦大枣汤养心安神、和中缓急为主药;芍药甘草汤养阴舒筋为辅药,2方合用则酸甘化阴以平阳亢气乱之急;又以丹参、柴胡、合欢花、合欢皮、琥珀疏肝理气化淤,定惊安神解郁为佐使药。诸药共奏养心安神、舒缓肝气之效。若气虚易汗者可加黄芪、浮小麦益气敛汗。张建民用本方治疗恐怖症有良效。

【病案举例】 沈某,女,33岁,驾驶员,1987年5月7日就诊。1年前因驾车不慎肇祸死人后,遂心中恐惧不辍,甚时于驱车途中也只得停下以定心神,干他事则正常自如,服中西镇静剂不效,休息4个月后复行驾车,恐惧依旧不减。诊断为恐惧症。中医症见:主症如前,舌衬紫、苔中厚微黄,脉沉细带弦。惊恐气乱,则肝气郁结,心灵动摇,神不潜宁,以致无故紧张恐慌不已。治以养心安神、舒缓肝气。处以上方,服5剂后症状大减,续服原方7剂而愈,恢复上班,至今未见复发。

【方名】 桂枝加龙骨牡蛎汤。

【组成】 桂枝12g,白芍9g,甘草6g,生姜5片,大枣10枚,龙骨、牡蛎各30g。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 镇心安神,调和营卫。

【适应证】 性交恐惧症,证属阴阳不调,营卫不和者。

【方药简析】 方用桂枝加龙骨牡蛎汤,取桂枝汤调补阴阳、调和营卫之功,加之龙骨、牡蛎固涩、安神之效,善敛重镇以安心神,止惊降逆以定惊悸。诸药并施,使心神得敛,阴阳营卫调和,则惊恐自消,诸症得愈。张润民用本方治疗性交恐惧症有良效。

【病案举例】 朱某,男,26岁,1992年6月5日诊。患者婚后1年,每与爱人同房时,触及皮肤则惊恐万状,心神不安,随之全身寒战,皮肤汗呈珠状,周身乏力。而后阳萎不举,彻夜难眠。曾经多方治疗,未显效,甚为苦恼。诊断为性交恐惧症。中医症见:主症如前,舌淡,苔白,脉细弱,投以桂枝加龙骨牡蛎汤以镇心安神、调和营卫。处以本方,水煎早晚分服。连服5剂,同房时仅有惊恐感,无寒热汗出。不更方续7剂,临床诸症消失。随访1年无恙[张润民,四川中医,1994,(1):7]。

【方名】 桂枝龙牡汤。

【组成】 桂枝45g,炙甘草、黄芪各30g,党参24g,枣仁18g,生龙骨、生牡蛎各60g,生姜15g,大枣5枚。

【来源】 丁德正,中医杂志,1986,(8):17。

【功效】 温壮心阳,镇惊安神。

【适应证】 卑慄,证属心阳虚,心失所养者。

【方药简析】 本方系由张仲景《伤寒论》中桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤化裁而成。方中以桂枝、炙甘草温补心气,壮心阳为主药;党参、黄芪补气升阳,益卫固表,配镇惊安神之生龙骨、生牡蛎以辅主药振持神机;生姜助药力之行散为佐药;同时炙甘草、大枣补中调和诸药为使药。诸药合用阳气得振,神气得养,神机得以振持,则羞怯惊避自除。丁德正用本方治疗本病(编者注:社交恐怖)有良效。

【病案举例】 曾某,女,30岁,1983年9月1日诊。患者患此证已9载,见人羞怯而惊避,常处暗室,拉之不出,曾多次就医治之,先予温胆宁神,后予涤痰化淤,悉皆罔效。诊之,患者肌肤不温,略虚浮,额汗浸润,面色苍白,舌质淡白而润,脉迟弱无力,心悸气短,时发气促。诊为心阳虚,神失所养之卑慄,处以上方服20剂,肌肢转温,疏懒孤僻、羞怯惊避之象略

减。再服 20 剂,肤有润色,能出户走动,且与人稍事交谈。续服 20 剂,羞怯及疏懒孤僻之象尽消,神情怡然。后以上方略事加减制丸,嘱其续服 4 个月以巩固疗效。1985 年 10 月随访一直颇佳。

【方名】 归脾汤。

【组成】 白术 9g,茯神 10g,黄芪 12g,龙眼肉 10g,酸枣仁(炒去壳)10g,人参 12g,木香 5g,甘草 5g,当归 10g,远志 10g。

【来源】 严用和,济生方(后 2 味药是从《校注妇人良方》补入的)。

【功效】 补心脾、宁心神。

【适应证】 恐怖症等,证属心脾两虚者。

【方药简析】 方用党参、黄芪补气健脾为主;辅以当归、龙眼肉养血和营,合主药以益气养血;用白术、木香以健脾理气使补而不滞;茯神、远志、枣仁以养心安神,共为佐药;使以甘草、生姜、大枣和胃健脾,以资生化,则气旺而血充,心神安宁。全方补心脾、宁心神。靳朴等用本方加减配合心理治疗、医疗气功治疗本病有良效。

【病案举例】 某女,50 岁,画家,诉睡眠恐怖。缘患者数年来失眠少寐,每日只能睡 3~4h,常服安眠剂。近半年来出现焦虑不安,尤以深夜回卧室就寝之际,精神紧张,惟恐难眠,愈怕难于入睡,愈感恐怖,常伴心慌心跳,头晕冷汗。诊断为睡眠恐怖症。中医症见:主症如前,患者面色无华,神疲纳差,舌淡、苔白,脉细弱。辨证属心脾两虚。治以补心脾、益肝肾,方用归脾汤加味。并给予心理疏导,解释睡眠与恐怖症,解除焦虑,鼓励作简易气功,嘱渐减安眠剂,服少量安定药。调理 4 个月,恐怖感消失,心情舒畅,日睡 6~7h,工作愉快[靳朴,新中

[医,1996,(7):41]。

【方名】 加味大补元煎。

【组成】 熟地黄 20g,山茱萸 15g,杜仲 10g,当归 10g,枸杞子 10g,人参 15g,山药 30g,石菖蒲 12g,升麻 9g,黑芝麻 15g,磁石 30g,酸枣仁 15g,炙甘草 10g,猪脑髓(另外食用)1具。

【来源】 黄俊山,上海中医药杂志,1996,(12):23。

【功效】 补肾填精,益脑壮胆。

【适应证】 脑鸣症(恐怖症),证属肾精亏损,脑髓虚减,胆气虚老。

【方药简析】 方中熟地、山茱萸、枸杞子、人参、山药、当归补肾填精;磁石、酸枣仁、石菖蒲壮胆宁神;升麻、杜仲补督升提。诸药共奏补肾填精、壮胆宁神之效。配合猪脑髓以脏补脏,及心理疗法3管齐下,使脑髓充,神宁不惊。黄俊山用本方按上述方法治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,52岁,干部,闻重低音后脑鸣3年。3年来逐渐出现对重低音,尤其是超重低音的恐怖感,如钟声、低音喇叭声、木梯板振动声等。闻后即感前额至后项脑鸣,轻者如蟋蟀鸣叫,甚者如鼙如雷,恐惧不堪,约1h左右恢复正常。无论何时何地,再次闻超重低音则复发如故。患者主动求治,人格保持完整,接触现实好,未发作时工作、生活、饮食、睡眠如既往,先后就诊多家医院,曾经心脑血管系统及神经系统检查(包括颅脑CT、心电图、24h动态心电图、超声心动图、血生化等项检查),均未发现器质性病变。西医诊断为恐怖症,给予安定、谷维素等药,未见效;多方求治中医,诸医多用活血化瘀、平肝熄风之剂仍未效,且逐渐加重。就诊时发现患者谨慎胆怯,性格不开朗,伴腰酸,神疲乏力,记忆力减退。

头发稀少。舌淡、苔薄白、脉沉细，左尺尤甚。证属肾精亏损，脑髓虚减，胆气怯弱。投以本方配合以系统脱敏疗法，综合治疗10天，症状大减。重复治疗半个月，诸症尽除，如释重负，精神倍增。随访3年未复发。

【方名】 以惊治惊法。

本方法相当于现代的系统脱敏或满灌疗法。主要是让患者分次逐步或一次充分地接触所恐怖的对象，从而以恐胜恐。最早记载见于《黄帝内经》。适用于恐怖症的治疗。

【病案举例】 据张子和《儒门事亲》一书记载，一对夫妻旅居在客舍里，夜间忽有盗贼烧房抢劫，稀里哗啦，一片声响。妻子十分害怕，惊倒不能站立。自此以后，每有声响，则惊吓瘫倒，昏不知人。家人走路要蹑手蹑脚，说话要轻声细语，惟恐弄出响声，将夫人吓倒。诸医均作心病治疗，人参、珍珠、定志丸都服过，但都无效。治疗一年余，不见好转。张子和诊后，对病家说：惊和恐是不同的，惊为阳证，病从外入；恐为阴证，病从内生。惊是因为自己不知道的缘故，而恐则是自己明知而故怕。夫人患的是惊证，是由于她不解“响声”能否伤害自己而引起的。于是让两位侍女将病人按在高椅之上，二女分别架着病人的两只胳膊，高椅的前面放一茶几。张子和手执木块对病人说，你看这里，说着就用木块猛击茶几一下，发出声响，病人大惊。张子和说，我用木块击茶几，你怕什么？病人心神稍定，又击一下，病人又惊，但较上一次稍减。如此反复多次，惊吓之状愈来愈轻。后来又用棍杖击门，或暗地派人敲病人的窗户，病人知是吓她，也不再害怕，反而笑说，这是什么治法？从此，这个病人不再害怕响声，即使听到雷鸣，也若无其事（刘道清，怪病怪治，283）。

45 强迫性神经症

强迫性神经症,也称强迫症,是以强迫症状为主要临床相的神经症。强迫症患者在我国约占居民群体的0.3%,男女患病比例基本相等。起病多在童年、青少年和成年早期,平均起病年龄20岁。半数患者有诸如妊娠、分娩、性问题或亲人去世等诱因。有1/2~1/3病前属强迫型人格。强迫症状的特征是反复有违反患者理性和意志的思维、表情、冲动等出现于患者的意识当中,患者感到不是自己精神中所固有的部分,强烈地欲要摆脱、抗拒之,引起患者痛苦,促使患者采取行动以减轻痛苦。临床常见表现有4种:①总怀疑被粪便、灰尘、细菌等污染,反复洗涤;②总有不完善不确定感,反复思虑或检查、摆弄门窗、电灯、水龙头、衣物、书籍等或寻求其他无聊问题的答案以达到完善、确定;③担心由于自己的不慎、有伤害性的冲动、某种念头,或他人的不慎而使亲人受到伤害、发生不幸,或遭飞来横祸。④反复再现亵渎或猥亵的念头,或生怕在公开场合说出这些念头或做出窘事。强迫症状也可见于抑郁症、精神分裂症及脑器质性病变,应加以鉴别。本病一般用氯丙咪嗪、丙咪嗪及行为治疗。

强迫症可见于中医的癫狂、郁证,或将之归于怪病。本病的病因病机多是由于情志因素或久病所伤,妊娠、分娩、年老、气衰等各种原因造成机体气滞、痰浊淤血阻络及正气耗伤,阴阳失调,窍机不和的基础上,缘于特定的性格(倔强、固执、刻板或优柔寡断、多疑多虑)使心神不宁,而形成强迫性症状,故

【病案举例】 某男,30岁,乡村教师。患者而立之年,性情孤僻,不善言辞,因心境不佳,独自烦恼,久之感觉眉心舌本如有绳索牵拉,整天双眉紧锁,吐舌弄舌不止,又感阴囊处有千万蚂蚁在爬行甚则爬向全身,日夜不得安宁,多处求医罔效。经上海某医院诊断为“强迫症”,劝其回家休息调治。患者为免受莫名之苦,曾几次企图自杀,后经人推荐,转诊于余。刻诊:面暗晦有黑斑,舌紫暗,虽不停吐舌但转动不灵,语言不流利,脉细涩。诊断为淤血闭窍之证。予上方,初取3剂症稍减,继服7剂,明显好转,夜能安寐,又服30余剂,诸症痊愈,继以归脾丸补益气血、安定神志以善后。

【方名】 加味涤痰汤。

【组成】 茯苓20g,清半夏、陈皮、竹茹、党参、炒香附各10g,郁金、石菖蒲、胆南星各8g,黄连、生甘草、生枳实各5g。

【来源】 刘国升,实用中西医结合杂志,1991,(2):109。

【功效】 清化痰热,开窍宁神。

【适应证】 强迫症,证属痰热内扰者。

【方药简析】 方中以陈皮、清半夏、茯苓、生枳实、竹茹清化痰热,乃温胆汤之意,加入胆南星黄连则以增强其清热祛痰之力共为主药;又加益气的党参,并重用健脾渗湿之茯苓以益气健脾化痰,炒香附、郁金、石菖蒲,以理气解郁,开窍宁神,共为辅佐药;以生甘草补中虚并调和诸药为使。诸药共取清化痰热,开窍宁神之效,以使胆和神安则病除。若兼有血淤者可加桃仁。血虚者可去石菖蒲、郁金、胆南星,加生白芍、生龙骨、生牡蛎以敛镇潜,养血宁神。刘国升用本方按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 吴某,女,27岁,1989年8月5日初诊。患者产后两月。1周前因婴儿腹泻而致心情恐慌,不知所措,见

婴儿哭啼则心烦欲死,继又出现强迫思维,反复考虑婴儿之疾是否能治愈,柔嫩之体何以养活成人,小儿腹泻虽已治愈,但强迫思维仍无法摆脱,以致夜不安寐,易哭善悲,饮食欠佳。诊断为强迫症。中医症见:主症如前,患者目光呆滞,表情淡漠,舌苔厚腻略黄,脉象沉滑偏数,乃痰热内扰、神不守舍。治以清化痰热,开窍宁神。方以加味涤痰汤 5 剂。二诊,强迫思维明显好转,夜眠仍差,舌尖偏红,苔薄黄,脉数。于上方中去郁金、石菖蒲、胆南星,加生龙骨、生牡蛎、生白芍各 15g,服 5 剂而愈。

【方名】 宣清导浊汤。

【组成】 晚蚕沙 12g、皂角荚(去皮)9g、茯苓、猪苓各 15g,寒水石 18g。

【来源】 吴鞠通《温病条辨》。

【适应证】 顽固性吐唾(强迫行为),证属湿热阻滞中焦者。

【方药简析】 方中晚蚕沙和胃化浊,皂角荚开窍祛痰,两味药相配通宣气机、祛痰湿,为主药;茯苓、猪苓淡渗利湿,使湿浊从小便而出,寒水石清热泻火,共同辅佐主药清化湿热、淡渗分利。全方清化湿热,通宣气机,淡渗分利。蒲王茂用本方加佩兰、藿香、通草治疗顽固性吐唾(强迫性行为),属湿热阻滞中焦,气机不宣,清浊不分者有良效。

【病案举例】 李某,男,37 岁,教师,素有泄泻病史,又恣食辛辣醇酒厚味,去秋因外感猝然吐泻交作,病愈后半月,出现吐唾呈清水样,每 2~3min 吐 1 次。曾服清胃散、泻黄散、缩泉丸等方药,迭服西药阿托品、多种维生素,均未见效。病势日趋加重,又赴蓉治疗。经某医院检查,咽喉无炎症和异物阻碍,口、舌亦无炎症、食道不狭窄,脾、胃、肝、肾功能均正常。诊断

为强迫性吐唾。服西药月余,病终莫愈。中医症见:主症如前,面色萎黄,忧郁倦怠,目光乏神,口淡,纳减,厌油腻,肢体酸重,小腹胀满,吐唾频作,日吐20~30次,时吐稀唾,时无唾可吐,仍不能自制。小溲短少,大便溏泻而不爽,脉濡数,苔灰厚而腻。综观全证,此乃湿热阻滞中焦,气机不宣,清浊不分。治宜清化湿热,宣通气机,淡渗分利。仿《温病条辨》宣清导浊汤化裁:晚蚕沙、皂角荚(去皮)各15g,茯苓、猪苓各12g,寒水石、佩兰、藿香各10g,通草5g。日服1剂,分3次服。服1剂吐唾大减,再服1剂,翌日患者来云:“吐唾已止,小溲已趋正常”。再诊脉不濡数,缓和有力,舌苔垢腻已退。继以甘淡实脾之法调理1月,诸症遂愈。信访至今,未见复发(薄正茂,上海中医药杂志,1983,(2):8)。

【方名】 陈半赤龙汤。

【组成】 陈皮10g,法半夏10g,胆南星10g,郁金10g,香附10g,丹参15g,麦冬10g,地龙10g,赤芍10g。

【来源】 欧阳兆龙,中医药信息,1992,(3):17。

【功效】 化痰活血祛瘀。

【适应证】 强迫症,痰瘀交结者。

【方药简析】 方中陈皮、法半夏、胆南星、燥湿化痰,丹参、赤芍活血化瘀;共起化痰祛瘀作用为主药;郁金、香附理气解郁以助主药化痰祛瘀;麦冬养阴防前药之燥,地龙清伏热通络佐主药除痰瘀阻闭。诸药合用使痰化瘀除,神明清静。欧阳兆龙用本方治疗强迫症属痰瘀交结者有良效。

【病案举例】 王某,女,28岁,乡村干部,1979年3月8日初诊。患笑症已1月余。久则半月发1次,频则每月几次,发笑时心里知道,但不能控制,3至5min后复常。平素身体健康。诊断为强迫症。中医症见:主症如前,发笑时痰多,体胖经

调补气血,养血安神,处以百合逍遥汤 3 剂。二诊:1987 年 7 月 9 日,洗衣、洗手、扫地等强迫行为明显减少,情绪渐稳定,饮食有所增加,时有头痛头晕。舌质暗淡,舌苔薄微黄,脉象弦细。处以生白芍、炒白芍、女贞子、旱莲草、生地黄、熟地黄,百合各 15g,桃仁、炙甘草各 10g,浮小麦 30g,生白术 12g,炒香附 8g,薄荷 4g,大枣 5 枚。服 10 剂而愈。

【方名】 龙胆泻肝养阴汤。

【组成】 龙胆草、生山栀各 5g,柴胡、黄芩、木通、麦门冬、北沙参、川楝子、枸杞子、当归各 10g,生地黄 20g。

【来源】 程运文,福建中医药,1991,(5):35。

【功效】 疏肝泄热,养阴止笑。

【适应证】 笑性强迫症,气郁化火伤阴者。

【方药简析】 本方系由李东垣的龙胆泻肝汤与《柳州医话》之一贯煎合方化裁而成。方中于龙胆泻肝汤中去泽泻、车前子之渗利,使泻肝胆实火而不伤阴;配一贯煎以滋养肝肾之阴,疏肝理气之郁。全方疏肝泄热,养阴止笑。可加丹皮凉血活血,白芍养阴缓急或加太子参、白术建脾益气。程运文用本方按上述加减治疗由所愿不遂或大怒伤肝,肝疏泄失司,气机郁滞化火,灼伤肝阴所致笑性强迫症有良效。

【病案举例】 纪某,女,37 岁,工人,1987 年 5 月 18 日初诊。因家中不睦,渐至无故发笑,喜怒无常,经某医院脑电图检查无异常发现,确诊为“笑性强迫症”。经治疗 2 月,效果不明显。就诊时见每小时狂欢大笑 5~8 次不等,每次持续 10s 左右,性急暴躁,恶梦纷纭,头昏眼花,胁肋胀满,月经后期量少,舌质红少苔,脉细弦数。证属肝郁化火,魂失守舍。治拟疏肝泄热,养阴止笑。龙胆草、生山栀各 5g,柴胡、黄芩、丹皮、木通、白芍、麦门冬、北沙参、川楝子、枸杞子、当归各 10g,生地

黄 20g。服 10 剂后,狂笑著减,诸症减轻。上方加白术、太子参各 10g,又服 10 剂。狂笑止,诸症消失。最后用一贯煎做丸,早晚各服 10g,调理 1 月。随访 1 年,旧恙未发。

【方名】 黄连龙磁汤。

【组成】 黄连、知母、生甘草各 5g,生栀子、黄芩各 10g,玄参 20g,磁石(先煎)、生龙骨(先煎)各 30g。

【来源】 程运文,福建中医药,1991,(5):34。

【功效】 清心泻火,镇静止笑。

【适应证】 笑性强迫症,心火过旺,神无所舍者。

【方药简析】 本方系由《外台秘要》所引崔氏黄连解毒汤加减而成。方中以黄连清心泻火为主药;知母、生甘草、生栀子、黄芩、玄参清泻三焦养阴凉血为辅药,磁石、龙骨平肝潜阳安神为佐药。全方清心泻火、镇静止笑。大便偏溏可加白术、茯神。程运文用本方按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 洪某,男,31 岁,教师,1986 年 5 月 28 日初诊。因受强烈精神刺激,常无故发笑。经某省级医院确诊为:“笑性强迫症”。就诊时见每日狂笑 5~10 次不等,每次大笑持续 3~5min,笑时面红目赤,心悸。并伴有烦躁好动,口渴喜冷饮,大便干结,舌质红,苔黄,脉数。证属心火亢盛,神不宁静。治拟清泻心火,镇静止笑。治疗:黄连、知母、生甘草各 5g,生山栀、黄芩各 10g,玄参 20g,磁石(先煎)、生龙骨(先煎)各 30g。5 剂后,狂笑每日减为 2~3 次,诸症减轻,但大便偏溏。上方加茯神、白术各 10g,又服 10 剂。狂笑止,诸症消失。最后早晚各服天王补心丹 10g,调理 1 月。随访 1 年,旧恙未发。

【方名】 天王补心丹。

【组成】 生地黄 120g,五味子、当归身、天门冬、麦门冬、

柏子仁、酸枣仁各 30g, 人参、玄参、丹参、茯苓、远志、桔梗各 15g。

【来源】 洪九有《摄生秘剖》。

【功效】 滋阴安神止笑。

【适应证】 笑性强迫症等, 心阴不足, 神失安宁者。

【方药简析】 方中以生地黄滋阴清热, 使心神不为虚火所扰, 为主药; 玄参、天门冬、麦门冬协助生地黄以加强滋阴清热之力, 丹参、当归身补血养心, 使心血足而神自安, 党参、茯苓益心气而安心神, 柏子仁、远志宁心安神, 五味子、酸枣仁以酸敛心气的耗散, 并能安神, 共为辅佐药; 桔梗载药上行, 以朱砂为衣制丸剂, 亦取其入心以安神, 均为佐使。诸药合用, 有滋阴安神之效。原方为末, 炼蜜为小丸, 每服 9g, 温开水送下, 亦可按比例酌减改为水煎服。若治疗笑性强迫症、心阴不足、神失安宁重症者, 易生地黄为熟地黄以增强滋阴补血之力, 并酌加郁金、绿梅花以理气解郁, 加石菖蒲、龙齿开窍镇静安神; 对笑性强迫症治疗后期, 症状消失, 心阴未复者, 用本方丸剂口服以善后调理。程运文用本方按上述加减用药治疗本病有良效。秦子河以本方加甘麦大枣汤治疗本病亦有良效。

【病案举例】 胡某, 男, 43 岁, 科研人员, 1986 年 7 月 25 日初诊, 长期从事文字工作, 工作不分昼夜, 加之精神刺激, 而患“笑性强迫症”。经数家大医院治疗数月, 效果不佳。就诊时见时善喜笑, 每小时喜笑 5~6 次不等, 持续 1min 左右。诊断为强迫症。中医症见: 心悸常作, 胸闷不舒, 失眠多梦, 五心烦热, 咽干舌燥, 饮水较多, 盗汗, 舌红少津, 脉细数。证属心阴耗损, 神志不宁。治拟滋补心阴, 安神止笑。熟地黄、太子参、郁金、天门冬、麦门冬、当归, 茯苓、茯神、炒枣仁、柏子仁各 10g, 绿梅花、远志、石菖蒲各 5g, 生龙骨(先煎)30g。10 剂后, 喜笑著减, 诸症缓解。上方去远志, 加白术 10g, 又服 20 剂, 喜笑全

止,诸症消失。最后服天王补心丹3月,善后调理。随访1年,旧恙未发(程运文,福建中医药,1991,(5):35)。

王某,女,52岁,1982年8月15日初诊。患者由家人陪同入室,见余即双手遮面哧哧发笑,颜面潮红似有羞涩感,颈动脉怒张,两目呈欲哭之状。其家人代述:前几天与邻居发生口角,3天后即见人嘻笑不休,心烦,健忘,夜难寐。每次发作前有恐惧感,胸部闷胀,胸骨后感到好像有一条虫向上爬,直达咽喉即笑声大作。每次发作数分钟,声调失常,心中明了,但不能自控。诊断为强迫症。中医症见:主症如前,脉浮弦数,舌红无苔有裂纹。脉证合参证属肝郁气结,郁而化火,暗耗心阴,心神外越而笑声自作。治以滋养心阴,安神宁志。处方:天王补心丹改为汤剂加甘麦大枣汤:生地黄30g,五味子10g,当归20g,天门冬20g,麦门冬20g,柏子仁20g,酸枣仁30g,党参20g,玄参15g,丹参30g,白茯苓30g,远志10g,桔梗10g,甘草10g,大枣7个,小麦1把,朱砂2g,(分3次冲服)。8月20日二诊。服上方2剂即感头后枕部有凉爽感。服3剂后头部清爽范围扩大,颜面潮红消失。5剂服完笑声基本控制,遇不顺心事或急躁时,有欲发作的感觉,但尚能自控;心烦、失眠等证均好转。宗前方续服5剂后,诸证均消失,迄今未再复发[秦子河,河南中医,1984,(5):47]。

【方名】 交泰丸。

【组成】 黄连4.5g,肉桂4.5g。

【来源】 韩天爵《韩氏医通》。

【功效】 交通心肾。

【适应证】 (强迫性)笑症、心肾不交者。

【方药简析】 本方药物份量系编者所加。方中黄连苦降善清心火,使心火下降于肾;肉桂辛甘大热,可温补脾肾,引火

归源益火消阴,使肾水上济于心。全方交通心肾使水火相济、阴平阳秘。浦东声以本方为基本方加半夏、茯苓、远志、石菖蒲、地龙、丹参、礞石滚痰丸等豁痰通络之品,及紫石英、牡蛎、磁朱丸等镇潜安神之品治疗狂笑症(强迫症)属心肾不交,痰热阻络者有良药。

【病案举例】 周某,女,76岁,1981年1月14日初诊。诉半年前偶然在小便时身体触及房门,遂即独自哂笑,最后狂笑不能自己。日益加剧,尤以夜间为甚。每笑约2~3min。发作时神识清楚。狂笑后即遗尿裤上,往往1日数易裤,甚感愁苦。曾经某医院治疗未效。西医检查无阳性体征。诊断为强迫症。中医症见:主症如前,诊寸关脉俱洪数,2尺沉细,舌质红苔薄,根薄黄略腻。辨证为心肾不交,痰热阻络,治拟交泰心肾,豁痰通络。处方:黄连4.5g,肉桂4.5g(后下),制半夏9g,茯苓15g,炒远志9g,石菖蒲9g,紫石英30g(先煎),连翘15g,磁朱丸9g(包煎),礞石滚痰丸12g(包煎)。5剂。另万氏牛黄清心丸两盒,每服6丸。二诊:药后白天狂笑止,夜间小便时偶然发笑,遗尿大有改善。药证合拍,遂前意鼓进。处方:黄连4.5g,安桂心4.5g(后下),朱茯苓15g,地龙15g,丹参12g,紫石英30g(先煎),炒远志9g,石菖蒲9g,朱灯心9g,磁石30g(先煎),煅龙骨、煅牡蛎(各)30g,礞石滚痰丸12g(包煎)。5剂。三诊:狂笑止,遗尿亦廖。舌根黄苔腻好转,寸关脉和缓。症趋坦途,无需易辙,固本可矣。处方:党参15g,炒白术12g,陈皮9g,茯苓15g,丹参12g,地龙15g,炒远志9g,石菖蒲9g,磁石30g,牡蛎30g,连翘12g,黄连4.5g,肉桂4.5g(后下),炙甘草6g。5剂。前后服药15剂,痊愈。随访3个月,未复发[浦东声,上海中医药杂志,1982,(4):41]。

【方名】 六味地黄交泰汤。

【组成】 熟地黄、山药、山茱萸各 20g,茯苓、丹皮、泽泻各 10g,黄连 5g,肉桂 3g。

【来源】 程运文,福建中医药,1991,(5):35。

【功效】 滋补肾阴,降火止笑。

【适应证】 笑性强迫症,肾阴不足,心肾失交,心火上浮者。

【方药简析】 本方系由《小儿药证直诀》的六味地黄丸与《韩氏医通》的交泰丸合方而成。方中以六味地黄丸滋阴补肾,配交泰丸降心火而化肾水使心肾交通,水火即济。全方能滋补肾阴,降火止笑。可酌加生地黄以清血分之热,加茯神、枣仁以养心安神。程运文用本方为主按上述加减治疗本病有良效。

【病案举例】 程某,男,34岁,干部,1986年7月11日初诊。因工作失误,处理过重,而致失眠,渐至时善喜笑,经某省级医院检查确诊为“笑性强迫症”。就诊时见时善喜笑,每小时约笑6~8次不等,每次1min左右。失眠多梦,五心烦热,每周遗精2~4次不等,耳鸣健忘,腰膝酸软,舌红少苔,脉细数。证属肾阴亏耗,心肾不交。治拟滋补肾阴,降火止笑。生地黄、熟地黄、山茱萸、山药各 20g,丹皮、茯苓、茯神、炒枣仁、泽泻各 10g,黄连 5g,肉桂 3g。10剂后,喜笑大减,上方续服 30剂,喜笑全止,诸症消失。最后服六味地黄丸 3月,善后调理。随访 1年,旧恙未发。

【方名】 益气摄纳汤。

【组成】 黄芪、白术各 12g,党参、菟丝子、当归各 10g,升麻、益智仁、桑螵蛸各 6g,炙甘草、沙苑子、五味子各 5g。

【来源】 姚公树,新中医,1986,(6):51。

【功效】 补气温阳摄纳。

【适应证】 (强迫性)见水思尿证,证属气虚摄纳无权者。

【方药简析】 方中以黄芪、党参、白术、升麻益气健脾升清降浊为主；菟丝子、沙苑子、益智仁、桑螵蛸、五味子补肾固涩为辅药；佐当归以养血；炙甘草调和诸药为使。诸药共奏补气温阳摄纳之效。姚公树用本方治疗因气虚摄纳无权，膀胱失约所致(强迫性)见水思尿症有良效。

【病案举例】 王某，女，12岁，学生，见水或听见流水声，即要登厕已2月。患儿面黄肌瘦，神疲乏力，羞而不愿求医。诊见舌淡苔薄，脉细无力。诊断为(强迫性)见水思尿症。乃属气虚摄纳无权，膀胱失约。治以补气温阳摄纳，处以上方。服药3剂，患儿尿次明显减少，见水已能制约小便，患儿甚喜，继服5剂而愈。随访半载未见复发。

【方名】 二仙缩泉汤。

【组成】 淫羊藿 30g，仙茅 12g，肉苁蓉 15g，巴戟天 12g，枸杞子 12g，山药 30g，益智仁 12g，菟丝子 30g，乌药 6g，珍珠母 20g，黄柏 10g。

【来源】 邱友文，中医杂志，1980，(4)：80。

【适应证】 见水欲尿症(强迫症)，证属肝肾亏虚者。

【方药简析】 本方系由二仙汤合缩泉丸化裁而成。方中以补肾阳、滋阴降火的二仙汤中去知母、当归之寒润，辅以肉苁蓉、菟丝子、枸杞子补肝肾益精血，山药补脾胃，珍珠母平肝潜阳，佐以缩泉丸温肾祛寒涩小便。全方益肝肾，补肾气，潜阳摄便。邱友文用本方治疗见水欲尿症(证属肝肾亏虚，肝阳上亢，肾气早衰者)有良效。

【病案举例】 刘某，女，56岁，职工家属，1975年元月初诊。患者有高血压病史10年，停经4年。平素常感头晕头痛，性急易怒，多梦少寐。于1975年春节前在水管取水时即发生小便不能自控，之后每见水则欲尿。平时无尿频、尿急、尿痛。

尿常规检查数次无异常发现。查其形体肥胖,面色淡白,舌嫩苔薄白,脉弦缓,两尺细弱。诊断为(强迫性)见水欲尿症。证属肝肾阴虚,肝阳上亢,加之年届八七,肾气早衰,膀胱开阖失职,是以小便不能自控。拟用二仙缩泉汤。服3剂,症状显著减轻,连服15剂,基本痊愈。

46 癔 症

癔症是由明显的精神因素,如生活事件,内心冲突或情绪激动,暗示或自我暗示等所导致的精神障碍。主要表现为感觉或运动障碍,或意识状态改变,症状无器质性基础。首次癔症性精神障碍发作,有强烈的精神因素时,诊断为心因性精神障碍。癔症在普通人群中的患病率约为3.55%,大多在20~40岁首次发病,多见于女性,与男性之比约为8:1。癔症的症状极其丰富,它的临床表现几乎可以模拟任何疾病。通常包括以精神活动之间互相脱节为特征的分离症状(不同程度的意识障碍,包括癔症性遗忘、神游症、假性痴呆、具有发泄特征的急剧情绪暴发、急性起病的身份障碍、鬼神附体、多重人格等,统称为癔症性精神障碍)和缺乏病理基础的,模拟神经系统疾病表现的躯体性障碍(但植物神经系统支配的内脏系统除外)为特征的转换症状(包括癔症性的感觉脱失、癔盲、癔聋、癔症性失音、癔症性瘫痪、癔症性痉挛发作等,统称为癔症性功能障碍)两大类。癔症应和反应性精神病,精神分裂症,所有与神经系统有关的疾病以及肝脏疾病,肺性脑病,肾功能衰竭,心脏疾病,甲亢,诈病等相鉴别。癔症的治疗主要有个别心理治疗、暗示疗法、系统脱敏疗法,以及针对患者伴有的焦虑、抑郁、脑衰弱、疼痛、失眠等症状的药物治疗,此外还有精神分析、电抽搐、二氧化碳气体吸入疗法等。

本病可见于中医郁证、脏躁、百合病、气厥等病证。本病主要病因病机是情志失调,气血逆乱,火郁痰结,食积湿聚,血淤

气滞，正气耗伤，以致脏腑气血阴阳升降失调，波及表里内外、四肢九窍而产生各种复杂多变的表现。临症治疗首当注意本病无论是什么样的症状表现，但总属情志之郁凭借虚实之体而发，对二者的关系须详加辨别，然后才能恰当施治。二是在辨证的基础上一般常用的治疗有解郁化痰，顺气降逆（可选用半夏厚朴汤、四七汤、温胆汤、温胆定搐汤、温胆明目汤、天麻半夏开窍汤、滚痰丸汤等加减），泻火降逆（大黄、黄连泻心汤、地骨清金汤、加味六磨汤等加减），理气破淤（蛭虻止瘕汤加减），理肝（桂枝加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤、柴胡加龙骨牡蛎安脏汤、加味逍遥散、羚角钩藤汤等加减），安神解郁（甘麦大枣汤、桂枝龙牡汤、防己地黄汤、加味百合地黄汤等加减）。三是在药物治疗的同时应注意暗示治疗和情志疏导，按吴塘所说：“曲察……隐情，婉言以开导之，庄言以震惊之，危言以恍惧之，必使之心悦而诚服，而后可以奏效如神”。四是针灸治疗对本病有良好疗效。

聂树良用重刺阴包穴治疗瘕症性精神障碍 7 例，当即中止发作，称效果巩固满意[新中医，1985，(9)：35]。

黄建平用针刺治疗瘕症性木僵 21 例。选入中和双侧合谷穴，用短毫针反复强刺激，随症状缓解而逐渐减弱。据称疗效迅速确切，一般在 5min 左右完全恢复正常，不需其他措施配合[江西中医药，1988，(4)：38]。

孙肖雷用电兴奋治疗瘕症性失音 11 例，治疗方法：①感应电流刺激：复溜(双)通电 30s，风池(双)通电 10s，内关(双)通电 30s。②直流电刺激：内关和外关两穴对刺激，每次通电各 1s，反复 3 次；哑门和人中两穴对刺激通电半秒钟，反复 3 次；风池(双)，每次通电半秒钟，反复 3 次。在治疗时，正负电极不考虑。电量开至患者能耐受的最大限度。在操作治疗中，不时引诱病人说话，言语随音增而渐渐清楚。结果 1 次治愈者

10例,两次治愈者1例(第1次治愈,次日复失音,再经治愈未再复发)。平均4min即可治愈[山东中医杂志,1985,(4):21]。

夏淑珍等用针刺治疗癔症性弱视18例,方法是从睛明、太阳、合谷、人中、视区5个穴位中每次选取1~2个。针得气后均用小幅度捻转重刺激,留针20min,每隔5min在施用手法的同时要让患者看目力表,大部分患者经1次治疗,可获得满意效果[天津中医,1986,(1):17]。

马宏欣用针刺治疗癔症性瘫痪16例。方法是:①遵“心病要从心来医”的原则,耐心了解病情,详细检查,体贴病人,以取得患者真正的信任。并讲明该病可以针刺速愈,争取患者积极配合。②针对病情选穴:四肢瘫痪取哑门;上肢瘫痪取后溪、中渚;下肢瘫痪取隐白、外踝边、涌泉等。③采用强刺手法,以患者有明显针感,感传到达病所而止,不留针。出针后,被动活动瘫痪肢体2~3min,即让患者自行活动。结果1次治愈者10例,其余均在针刺3~5次后症状消失。后者除2例多动型外,病程均为半年到两年余[陕西中医学院学报,1982,(4):45]。

【方名】 半夏厚朴汤。

【组成】 半夏18g,厚朴15g,茯苓15g,生姜12g,干苏叶(后下)9g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 行气开郁,降逆化痰。

【适应证】 癔症(精神发作、耳聋、失语等),痰郁见证者。

【方药简析】 方中半夏化痰开结、和胃降逆,厚朴行气开郁、下气除满,同为主药;苏叶助半夏、厚朴以宽胸畅中,宣通郁气,茯苓助半夏化痰,生姜助半夏和中止呕,同为辅佐药。诸药合用,辛以散结,苦以降逆,辛开苦降,化痰降逆,斡旋气机,

则可解痰气郁结之证。初病气郁偏甚者加香附、甘松各 15g；病久痰浊交结甚者加川贝母、郁金、枳实各 15g；病久挟瘀者加桃仁 12g，红花 10g，水蛭 15g；病久耗伤正气而显气虚者加党参 24g，白术 15g；痰郁日久有化热之象者加天竺黄 24g，海浮石 30g，黄芩 15g；郁痰滞扰心神呈神志迷乱或“神鬼附体”之象者加石菖蒲、远志各 15g，琥珀（研末冲服）6g。每日 1 剂，早、午、晚 3 次服，症状缓解后，服六君子汤以善后巩固。丁德正用本方按上述加减治疗瘧症 104 例，结果近期 103 例痊愈，显著进步 1 例，获愈最短时间为 5 天，最长时间为 27 天，以 8~15 天为多。远期良好者 91 例，大致良好者 1 例，拆迁难查者 5 例，患躯体疾病死亡 4 例。

【病案举例】 文某，女，27 岁，数年来，因家事不睦，多愁善郁。近年来觉胸脘满闷，气急痰多，叹息不止。8 日前偶谈起邻村某妇被扼死事，患者颇为之痛怜。是夜如神鬼所凭大作。始则神情忿郁而迷惘，自称“扼死妇”，仿其语，泣诉其被害经过，继之，做被扼死状而面青目突，伸颈吐舌，喘促声粗痰声漉漉，倾刻憋闷昏绝。呼甦后大叫“胸闷喉紧”，以指探喉，吐出痰涎遂许方安。不发则一如常人，惟胸闷气急痰多而已。如是入暮则作。曾诊为脏躁服甘麦大枣汤罔效。诊之，肤胖，面滑多垢，目光呆凝而惶惑，舌质红，苔白浊腻，脉沉滑，诊为瘧病气郁痰阻。予半夏厚朴汤加郁金 20g，石菖蒲、远志各 15g，琥珀 6g，并作劝解工作。服 3 剂，如鬼神所凭之发作得止，继服 12 剂，愁闷痰多等症亦释，后又守六君子汤以巩固之。随访 6 年未复发〔丁德正，河南中医，1991，（3）：20〕。

【方名】 四七汤。

【组成】 制半夏 15g，茯苓 15g，厚朴 15g，苏叶 12g，生姜 3 片，大枣 1 枚。

【来源】《太平惠民和剂局方》引《简易方》。

【功效】行气,开郁,化痰,斡旋气机。

【适应证】瘧病性瘫痪,七情气郁,痰涎壅结见证者。

【方药简析】方中以半夏散结除痰,厚朴降气除满,苏叶宽中散郁,茯苓渗湿安神健脾,生姜降逆和中。诸药合用,主攻七情气郁,痰涎壅结,功在行气开郁,降逆化痰。若见脾虚者佐以六君子汤,实脾除虚;若见痰气淤阻者佐以四磨饮子,以逐痰破淤行气;若肝郁脾虚者用逍遥散以疏肝健脾。汤国富用本方按上述加减治疗本病有良效。

【病案举例】焦某,男,45岁,1995年6月12日,由家人用车拉来就诊。由其妻代诉:双目突然失明,双下肢软瘫。本人平素性情急躁,1月前女儿自杀身亡,后不愿见人,随之全身发抖,站立不起,嗜睡不思饮食。小便正常,大便1周不解。经多方调治半月不见好转。查体:颈软,肌力正常,巴彬斯基试验阳性,站立双下肢抖动,不得移步。听诊:心肺正常,肝脾未及。心电图正常。血压12.5/8.6kPa,生化检查:钾、钠、钙参数正常。西医诊断为瘧病性瘫痪。中医症见:主症如前,脉细弦滑,舌质色暗,尖红,边有齿痕。据证可辨,此患者平素体健,性情急躁,心肝火旺,爱女突然自杀受惊,肝气上逆,浊气失降,痰气淤阻,清窍失养,四肢失充废用。治则:柔肝熄风,补脾强心,清淤通络活血,润养经脉。方拟四七汤合四磨汤加减:厚朴、茯苓、法夏各12g,苏叶、枳实、白芍各10g,乌药、沉香、槟榔各9g,柴胡3g,生姜3片。早晚冷水煎熬温服。服药1剂大便通可扶墙站立,在亲属搀扶下室内缓步活动。效不更方,续服2剂,自觉下肢不抖,可缓步行走,纳食知味,脉滑数,舌苔白腻。更方为四七汤合逍遥散加减:制半夏、厚朴、枳实各12g,青皮、白芍、茯苓、白术、当归各10g,丹参15g,延胡索、炙甘草各9g,生姜3片,每日1剂,冷水煎熬,早晚温服。连服3

剂,始自理生活,精神恢复,食量大增。再另以香砂六君子汤以巩固疗效。4 月后随访一切正常[汤国富,陕西中医,1996,(2):171]。

【方名】 温胆汤。

【组成】 半夏 12g,竹茹 12g,枳实 12g,橘皮 9g,生姜 9g,甘草 6g,茯苓 12g。

【来源】 孙思邈《千金要方》。

【功效】 清降痰热,化痰宁神。

【适应证】 瘵症等属痰热内扰者。

【方药简析】 方中以二陈汤治一切痰浊;竹茹清热和胃;枳实行气降浊。六味相济相须,温凉配伍得宜,使痰浊得化,胆气自清。后世医家增加茯苓更增利湿化痰之力。若痰火扰心者以本方合泻心汤;若痰聚阻气者以本方合逍遥丸化裁。王长瀛以本方为主,按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 郭某,男,26 岁,农民,1984 年 1 月以胸闷失眠,时时哭泣 3 个月就诊。患者因婚事不遂,3 个月来胸膈憋闷,烦躁易怒,失眠甚至彻夜不寐,时时悲伤哭泣,或呈痴呆状不与人语。某精神病院诊为神经官能症(瘵症),治疗无明显好转,且头脑昏胀,耳内轰鸣。诊见患者身体壮实,面红气粗,怒目发呆,舌红、苔黄燥,脉弦有力。痰火之证显然,治以泻心汤合温胆汤加减。处方:黄连、大黄(后下)各 10g,黄芩、枳实、竹茹、法半夏、茯苓、石菖蒲各 12g,珍珠母 20g,甘草 6g。水煎服,日 1 剂。服药 3 剂睡眠好转,头昏耳鸣减轻,悲哭亦少。前方去大黄加栀子 12g,白芍 15g,连进 9 剂,诸症悉除,睡眠、精神如常并从事农活劳动[王长瀛,新中医,1992,(7):26]。

【方名】 温胆定搐汤。

【功效】 疏肝解郁,化痰开窍。

【适应证】 癥症性黑蒙,痰淤阻络者。

【方药简析】 本方由温胆汤加味而成。方中用温胆汤化痰理气清胆和胃;石菖蒲、郁金、佛手以疏肝解郁开窍。全方可使络通神光发越而鉴视万物。李颀松等以本方为主治疗痰淤阻络,蒙蔽清窍所致癥症性黑蒙有良效。

【病案举例】 王某,男,18岁。患者半月前与他人发生口角,遂抑郁不舒,神志恍惚,夜间难以入眠,白天精神疲倦,食欲下降。第11天时突然双目视物不见。双眼外观端好,眼底亦无异常发现。诊断:暴盲(癥症性黑蒙)。中医症见:主症同前,舌淡暗,苔白厚,脉弦。属痰淤阻络,蒙蔽清窍所致。治宜疏肝解郁,化痰开窍。处以本方,进3剂,诸症好转,继进12剂,双目复明而愈。

【方名】 天麻半夏开窍汤。

【组成】 天麻、法半夏各15g,茯苓24g,石菖蒲7g,全蝎、远志、木香各6g,陈皮12g,粉甘草、白附子、胆南星、羌活各10g,薄荷3g,姜汁、竹沥各1匙。

【来源】 肖作亮等,黑龙江中医药,1991,(1):28。

【功效】 祛风豁痰开窍。

【适应证】 癥症性失音,属风痰浊湿闭窍者。

【方药简析】 方中天麻、半夏、茯苓、石菖蒲相伍祛风豁痰开窍为主药;全蝎祛风通络,远志祛痰开窍;木香、陈皮、胆南星、竹沥理气化痰,共为辅药以助主药祛风痰开窍;羌活祛风胜湿、散寒解表,薄荷清利头目,姜汁行散,甘草调和诸药,共为佐使药。诸药合用祛风豁痰开壅闭。肖作亮以本方治疗癥症性失音属风痰浊湿聚闭清窍者有良效。

【病案举例】 又某,女,29岁,农民。患者于1985年5月

会诊。病人仍处昏睡状态。其家人说,发病前身体尚可,平素寡言少语,大便已有5天未解。观其面色红赤,扪之皮肤有灼热感,扳开口见其舌似短半截状,且苔黄腻燥垢,脉滑数有力。此证属痰浊邪气内闭,逆蒙心神。治拟涤痰逐邪,通腑清心。处以本方:滚痰丸、制南星、制半夏、石菖蒲各12g,生大黄(后下)、玄明粉(冲)各9g,广木香20g,牛黄清心丸2粒(研冲)。1剂,水煎服(因病人昏睡采用鼻饲)。嘱家人,服后有何反应,即与值班医生联系。午12时去病房查看,见金某正酣睡。其母说,服上药约半小时后,即腹泻,泻下为燥屎及痰沫状物。腹泻后病人即张目说话,神志转清。其兄当即叫醒金某,问答如常。第2天,神志清爽,病情明显好转,嘱其原方继服1剂。第3天,病人痊愈出院要求带中药续服。予上方去大黄、玄明粉、木香、牛黄清心丸,加枸杞子、五味子、旱莲草、女贞子。4剂。后随访4年未发。

【方名】 大黄黄连泻心汤。

【组成】 大黄10g,黄连6g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 泄热安神。

【适应证】 瘧症,肝郁化火冲心见证者。

【方药简析】 方中大黄泻热和胃开结;黄连清心胃之火。2药共用使邪热得除,则心神自安。用麻沸汤浸渍须臾,绞汁,以取其气轻扬,不欲甘味之重浊,以利清上部无形之邪热。李道仪以本方加黄芩、木香、代赭石治疗瘧症(肝郁化火冲心者)取得良效。

【病案举例】 王某,男,23岁,1990年5月诊。其母代述:患者因失恋,以致心神不定,食少,胸闷,渐渐不能坐卧,整夜不睡,急躁易怒,有时哭笑,在神经病院诊为“瘧症”。住院半月

不见好转。现患者面部潮红,气盛不安,胸中躁热,5日没解大便,舌红,苔黄而腻,脉弦数。此乃肝郁化火,邪气冲心,发为狂躁。《伤寒论》154条:“心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。”处方:大黄10g,黄芩10g,黄连6g,木香12g,代赭石20g。服3剂,药后解大便1次,症状稍有好转,但第4天又哭闹不宁,拟前方加大黄至20g,再服2剂,大便泻污水数次,患者夜能入睡,白天时有哭泣。予以甘麦大枣汤和四逆散疏肝解郁,补脾安神进20剂药,方致痊愈[李道仪,南京中医学院学报,1994,(1):21]。

【方名】 地骨清金汤。

【组成】 地骨皮30g,龙胆草5g,决明子15g,石菖蒲、郁金、玄参、黄芩、半夏各10g,胆南星4g。

【来源】 招振海,新中医,1990,(7):39。

【功效】 清肺泻肝,开郁化痰。

【适应证】 瘵症失音,痰火郁结于肺见证者。

【方药简析】 方中重用地骨皮为主药;合黄芩、玄参增强清肺之功;龙胆草、决明子泻肝,泻肝所以清肺;石菖蒲“通九窍,明耳目,出声音”(《神农本草经》),合郁金开郁,配半夏、胆南星化痰。诸药合用,共奏清肺泻肝、开郁化痰之功。招振海以本方为主治疗属痰火郁结于肺所致瘵症性失音有良效。

【病案举例】 刘某,男,42岁,干部,发作性失音10余年。病起于与他人争吵诱发,每日发作数次,发作时伴心胸闷憋,历时10余分钟或数小时不等,间歇期如常人。五官科及神经系统检查未发现异常。西医诊为“瘵症失音”,历经中西药多方治疗无效。刻诊:呼之不应,呼吸时而急,时而闭气,半小时后所言如上,目赤、舌红、苔黄,脉细弱。处以上方,日服1剂,服至3剂症减,又服5剂仅偶而言语不利。继服5剂症除,随

访至今,虽有情感因素,也未见复发。

【方名】 加味六磨汤。

【组成】 沉香 6g,木香 6g,槟榔 12g,乌药 10g,枳实 15g,大黄(后下)10g,黄连 10g,生石决明(先煎)30g,生代赭石(先煎)30g。

【来源】 余亚东,江西中医药,1996,(6):6。

【功效】 泻热平肝,破滞降逆。

【适应证】 癰症,气盛化火成厥者。

【方药简析】 方中以沉香、木香、槟榔、乌药、枳实破滞降逆;大黄、黄连清心泻热;钩藤、石决明、代赭石平肝降逆。诸药共用以使火热得泻,冲逆得以平复。余亚东以本方治疗本病有良效。

【病案举例】 沈某,女,48岁,农民。因邻里不睦,争吵打闹致癰症大发作,在某医院治疗未能控制,转来我院时1日发作数次。发作时全身强直抽搐,角弓反张,牙关紧闭,四肢逆冷,紧握双拳,面赤气粗,口鼻气热而秽臭。针刺人中、合谷后约10min左右才慢慢缓解,旋即又发,间歇时则烦躁不宁,辗转不安,口渴喜饮。大便秘结,小便黄短,舌赤苔黄,脉象弦数。为气盛化火,火气内闭,发为气厥。服上方,1剂知,3剂已。

【方名】 蛭菖止癰汤。

【组成】 水蛭 6~15g,石菖蒲 6~20g,大黄 6~20g,郁金 10~20g,丹参 15g,茯苓 15g,白芍 10g,远志 10g,甘草 6g。

【来源】 符俊,湖南中医杂志,1994,(3):16。

【功效】 破瘀降逆,醒脑调神。

【适应证】 女性癰症昏厥,证属气逆血瘀,上蔽神明者。

【方药简析】 方中以水蛭、石菖蒲为君药,取水蛭性迟

缓,破血逐瘀而不伤正,石菖蒲味芳香,具开窍醒神健脑之功;重用大黄以助破瘀之力,使瘀滞从大小便排出,配郁金、丹参理气活血共为辅药;茯苓健脾宁心,白芍养血敛阴,远志安神开窍,甘草调和诸药,共为佐使药。全方破瘀降逆、醒脑调神。初发且体健者加细辛 6g,枳实 10~15g,并加大方中水蛭、大黄剂量;常发体弱去大黄加龙骨、牡蛎各 15g,太子参 30g;兼牙关紧闭,呼吸气粗,四肢颤抖者加钩藤、石决明各 20g,沉香 6g。符俊以本方为主,按上述加减治疗本病 38 例,结果痊愈 28 例(症状消失,恢复如常人,追踪 3 年未复发者),占 73.6%;好转 8 例(症状缓解,但 3 年内仍发作 1~3 次,昏厥最长时间不超过 30min 者),占 21%;无效 2 例(服药期间可控制发作,停药后遇精神刺激即复发者),占 5.4%;总有效率为 94.6%。最少服药 3 剂,最多服药 60 剂,平均服药 25 剂,多数服药 10~20 剂即愈。

【病案举例】 李某,女,21 岁,1987 年 5 月 18 日初诊。其父代诉,患者因婚姻不遂,致心下痞塞,纳呆,渐至坐卧不宁,彻夜不眠,烦躁易怒,不时捶胸哭骂。今年春节后曾在某精神病医院诊为“癔症”,住院月余,好转出院。昨夜家人同她谈议旧事,一夜哭泣,终未成眠,次日清晨诱发昏厥,急请当地医生打针不效而抬送入院。刻诊:患者已昏厥约 4~5h,现牙关紧闭,两手握拳,时或颤抖,面色潮红。母诉患者起病后月经未曾来潮,且常感有血冲头顶而急躁昏扰。脉沉弦而涩。证属气逆血瘀,上蔽神明而致昏厥。治宜破瘀降逆、醒脑调神。药用:水蛭、石菖蒲、大黄、郁金、丹参、茯苓、赤芍各 15g,石决明 20g,钩藤 10g,沉香 6g,甘草 6g。急煎待凉鼻饲,约 30min 后患者张目而视,并问陪人为何来到医院。当天尽剂,翌日晨入厕解腥臭黑粪甚多,便后顿觉清醒。继服上药 2 剂,第 3 天月经来潮,血紫黑有块。仍予原方出入:水蛭 6g,大黄 6g,石菖蒲 6g,

郁金 10g,柴胡 10g,枣仁 10g,丹参 10g,白芍 10g,当归 10g,茯神 10g,川芎 10g,甘草 6g。连服 10 剂后,诸症悉除,随访 3 年未见复发。

【方名】 桂枝加龙骨牡蛎汤。

【组成】 桂枝 10g,白芍、炙甘草各 20g,生龙骨、生牡蛎各 30g,生姜 5g,大枣 30 枚。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 疏肝平亢,调和阴阳。

【适应证】 癔症性晕厥,证属肝郁阳亢者。

【方药简析】 方中以桂枝汤调和阴阳,加龙骨、牡蛎潜镇摄纳,使阳能固秘,阴能内守,则肝气得疏,肝阳得平。付美清以本方治疗肝气郁结、肝阳上亢所致之癔症性晕厥有良效。

【病案举例】 吴某,女,36 岁,营业员,1986 年 6 月 24 日就诊。5 年前因与人口角而突然晕倒,不省人事,四肢僵硬,约数分钟后苏醒,但仍觉头晕乏力。后反复发作,每月 2~3 次,每逢情志不畅则发作频繁,多种检查未发现器质性病变。西医诊断为癔症。5 年来,服多种中西药罔效,遂求诊于余。刻诊:发作后 2 天,表情抑郁,少语寡言,时时惊恐,伴头晕,时自汗出,舌淡、苔薄白,脉弦略浮。予桂枝加龙骨牡蛎汤治疗。处方:桂枝 10g,白芍、炙甘草 20g,生龙骨、生牡蛎各 30g,生姜 5g,大枣 30 枚。每日 1 剂,水煎分 2 次服。服药 5 剂,自觉诸症消失,效不更方,守原方续进 30 余剂,5 年沉痾遂愈,随访至今未再复发[付美青,新中医,1992,(7):44]。

【方名】 柴胡桂枝汤。

【组成】 桂枝 4.5g(去皮),白芍 4.5g,黄芩 4.5g,人参 4.5g,甘草 4.5g,半夏 4.5g,大枣 6 枚(擘),生姜 4.5g(切),

柴胡 12g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 疏肝理气，畅达枢机，调和营卫。

【适应证】 瘧症性瘫痪等，主证为肝郁气滞，气血不和，筋脉失养者。

【方药简析】 本方是小柴胡汤、桂枝汤各取半量，合剂而成。方中小柴胡汤有显著的解郁功能，治郁滞肝胆、枢机不利证尤宜；而桂枝汤擅长调和营卫，有益诸理气血。肝藏血，对血液有重要的调节作用，而这种调节作用，实属肝主疏泄所为。疏泄正常，情志和悦，气机舒利，血无所阻，顺应阴阳，则“筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。”内可通五脏六腑，外能达四肢百骸，经脉自充，“足受血而能步”。本方疏肝之主药柴胡，其用量可适当加重。有血虚及痰浊蒙闭心窍之候，佐当归、石菖蒲治之；有血淤阻涩下肢脉络见症，加牛膝、丹参攻之。王忠民用本方按上述加减治疗本病收到满意疗效。

【病案举例】 孙某，女，34岁，农民，1985年4月24日初诊。罹患瘧症性瘫痪3月余。患者生育2女，不愿做输卵管结扎术。手术良好，住院1周出院。翌日因与他人口角，对方誓其“绝户”，立致哭闹不休。事后日胸闷欲死，太息频作，时哭时笑，手舞足蹈，倒地翻滚，常出死者之言，纳食显减，四肢酸软无力，心悸头晕。2天后复遭患怒，继之突然倒地昏厥近20min，不言不语，双目紧闭，全身僵直，清醒后言下肢动弹不得，之后即卧床不起。病后曾服西药治之，下肢如初。检查：下肢腱反射存在，肌张力正常，无锥体束征，电刺激反应正常。有时可见双腿不规则的运动，下肢肌肉未见明显萎缩。诊断为瘧症性瘫痪。此乃肝郁气滞，气血不和，筋脉失养。治宜疏肝解郁，理气活血，方以柴胡桂枝汤出入。处方：柴胡 30g，黄芩 12g，半夏 12g，人参 6g（另煎），炙甘草 12g，桂枝 30g，白芍

【方名】 加味逍遥散。

【组成】 柴胡 24g, 党参 9g, 菊花 12g, 甘草 9g, 白芍 30g, 炒白术 24g, 当归 15g, 茯苓 12g。

【来源】 陈明举等, 新中医, 1983, (1): 37。

【功效】 疏肝解郁, 健脾养血。

【适应证】 癔症盲和癔症性弱视, 肝郁血虚见证者。

【方药简析】 本方是由逍遥散化裁而成。方中柴胡、白芍、当归疏肝解郁且补肝血为主; 党参、白术、茯苓健脾益气为辅; 菊花疏风清热明目为佐; 甘草助脾且调和诸药为使。全方可疏肝解郁, 健脾养血。若肝气上逆明显者加珍珠母、钩藤、丹皮; 肝郁明显者加制香附、炒枳壳、槟榔; 兼痰郁加石菖蒲、远志、白附子、胆星; 郁久化热, 舌苔黄厚者加炒山栀、黄芩等。陈明举等用本方按上述加减治疗由情志不畅、肝气郁结、脾湿痰扰, 使气机升降失调, 气血不能濡养于目所致之癔症盲和癔症性弱视 5 例, 均取得满意效果。

【病案举例】 王某, 女, 30 岁, 农民, 生气后发病 1 年。治疗前检查远视力 0.3、0.3; 近视力 0.1、0.1。瞬目反射少, 对光反射及眼底正常。诊断为癔症性弱视。中医症见: 主症如前, 并见头痛、胁痛, 寒热往来, 食少纳呆, 目直神呆, 舌红无苔, 脉弦细数。来诊前曾用过维生素、泼尼松、中药治疗, 治疗无效。现治以行气解郁, 养血健脾。以上方加丹皮、槟榔、麦门冬。服药 9 剂, 视力恢复, 诸症消失。

【方名】 羚角钩藤汤。

【组成】 羚羊角 3g, 钩藤 9g, 桑叶 6g, 菊花 9g, 生地黄 15g, 白芍 9g, 甘草 3g, 贝母 12g, 竹茹 15g, 茯神 9g。

【来源】 俞根初《通俗伤寒论》。

【功效】 熄风止痉。

【适应证】 瘧症,阴虚火旺,肝阳浮越见证者。

【方药简析】 方中以羚羊角、钩藤、桑叶、菊花平肝潜阳、清热熄风;生地黄、甘草、白芍养阴增液、柔肝舒筋;贝母、竹茹清热化痰;茯神健脾宁心安神。全方清热平肝、熄风止痉。可随证加入清热平肝之地龙、石决明;通络止痉之蜈蚣;平肝潜阳之龙骨、牡蛎、龟板、鳖甲;滋养阴血之阿胶、石斛等。王元潮以本方为主,按上述加减用药,治疗因津伤液枯、肝木失养、风火上旋、扰乱心神之瘧症发作2例均获良效。

【病案举例】 蔡某,女,34岁,1978年12月10日收入临时病房。病已半月,虽经抗精神病药处理,好转不显,且有输液反应,会诊诊断为瘧症,但病情仍未能得到控制,于是改用中药。证见形体消瘦,两颧潮红,兴奋躁动,齿唇焦干,持续高热38℃左右,神志时清时昧,抽搐阵作,舌光绛,脉细数。证属阴虚火炽,虚风内动,治宜平肝熄风、滋阴补血,方用羚羊角钩藤汤加减:羚羊角1g,钩藤、生白芍、五味子、鳖甲、龟板、白菊花、朱茯苓、阿胶各12g,生地黄、生牡蛎、珍珠母各30g,川石斛15g,桑叶5g。4剂后体温渐退,并转安静,诸证衰减,化险为夷。前方既已中的,乘胜再进。前后加减服至20余剂,能起床行走,自理生活[王元潮,浙江中医杂志,1982,(9):413]。

【方名】 甘麦大枣汤。

【组成】 炙甘草9g,淮小麦30g,大枣7枚。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 养心神,缓肝急。

【适应证】 瘧症性精神障碍,证属心肝失养者。

【方药简析】 方中以淮小麦养心安神,炙甘草、大枣甘润补中缓急。诸药合用可养心神、缓肝急,而消除焦虑抑郁情绪。

【方名】 桂甘龙牡汤。

【组成】 桂枝 10g,白术、茯苓、远志、石菖蒲、炙甘草各 12g,酸枣仁、生龙骨、生牡蛎、合欢花各 15g。

【来源】 王长瀛,新中医,1992,(7):46。

【功效】 温通心阳,健脾镇摄安神。

【适应证】 瘵症。

【方药简析】 方以桂枝温通心阳为主;白术、茯苓健脾,远志、石菖蒲、酸枣仁、龙骨、牡蛎、合欢花镇摄安神,共为辅佐;炙甘草补气和缓,调和诸药为使。诸药共用使心阳得通,心神得养、得安。王长瀛以本方治疗忧思气结,伤于心脾所致瘵症发作有良效。

【病案举例】 孙某,女,32岁,农民,1983年2月初诊。发作性胸闷心悸,精神恍惚近3年。其夫当汽车司机,在外地工作,多年来时时挂怀,渐致失眠,多梦易惊。继呈发作性胸闷心悸,精神恍惚,意识朦胧,每3~5天发作1次,历数小时乃至1天多方可清醒。发作前四肢发凉,胸口空悬冷缩之感,发作后头昏、焦虑不安、失眠加重、食少乏力。某医院诊为瘵症,用药罔效。中医症见:患者精神倦怠,忧郁寡欢,舌淡、苔白,脉弱无力。此乃思郁日久,损伤心脾,治以温通心阳为主。初用甘麦大枣汤取效不显,继投桂甘龙牡汤加味。处方:桂枝 10g,白术、茯苓、远志、石菖蒲、炙甘草各 12g,酸枣仁、生龙骨、生牡蛎、合欢花各 15g。水煎服,日1剂。服药5剂症状发作减轻,失眠好转,守方继服10余剂,上述症状未再发作,精神如常。其后3年之中曾有2次轻微的发作,均用上方3~5剂即愈。

【方名】 防己地黄汤。

【组成】 生地黄 150g,防己 3g,防风 9g,桂枝 9g,甘草

3g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 益养阴血，疏风清热。

【适应证】 癔症性精神发作，证属阴血匮乏，邪并于阳者。

【方药简析】 本方原出自张仲景《金匱要略》，用治营血郁热病如狂状。方中重用生地黄益阴清热、养血固本为主；防己、防风、桂枝轻清升散风邪为辅。全方益阴养血、疏风清热。将上述药物除生地黄外全部放入黄酒中浸12h左右，然后将药捣烂，加开水150ml，取汁。生地150g，浓煎取汁（忌用铁器），两煎混匀，然后兑入上药所取之汁，混合分早、中、晚3次温服。丁德正用本方按上述方法用药治疗本病有良效。

【病案举例】 李某，女，33岁，已婚，1978年2月7日就诊。患者数年来眩晕易乏，少眠多梦，时或怔忡躁慌。月余前其疾发作，时而哭啼吵闹，时而昏扑欲绝。经当地医院诊为癔病，服甘麦大枣汤等数剂无效。来诊前夜，症状益剧或张嘴吐舌，称鬼弄怪；或精神恍惚，奔走村外，自言自语。诊见患者清瘦，面略赤，脉轻取浮，重按细数，舌质红，无苔，唇干，口苦。家属云：“患者常谓项强，头皮拘紧，如绳缚之。”证属阴血匮乏、风邪外并、阳热内郁、神明失司而致。处以上方服2剂，神思略定，妄行独语大减，又服3剂，症状若失，头皮发紧及项强等症亦去。嘱服朱砂安神丸善后，随访迄今，健康如常[丁德正，河南中医，1984，（4）：31]。

【方名】 加味百合地黄汤。

【组成】 百合30g，生地黄15g，炒枣仁30g，远志9g，茯苓9g，龙骨9g，知母12g，郁金9g，竹茹15g，甘草6g。

【来源】 杨钟发，陕西中医，1980，（4）：18。

【功效】 甘凉清润,养血安神。

【适应证】 瘵症,烦躁悲伤欲哭,证属阴血不足、心神失养者。

【方药简析】 方以百合、生地滋阴养血;知母、竹茹清心除烦;枣仁、远志、龙骨、茯苓安神宁心;郁金理气开窍;甘草调和诸药。共奏甘凉清润、养血安神之效而达到平衡阴阳、恢复健康之目的。若头痛头晕者加川芎 9g,天麻 9g;恶心纳差者加陈皮 9g,清半夏 9g;气血不足者加黄芪 18g,当归 12g;胸胁痛者加川楝子 9g,延胡索 9g;咽干耳鸣者加麦冬 9g,桑椹子 15g;昏厥者加针刺人中穴。杨钟发以本方为基础方,按上述加减用药治疗本病 45 例,临床治愈者 23 例(治疗后症状全部消失,观察 1 年以上无复发),占 51.1%;明显好转者 11 例(症状消失,偶有心烦急躁,睡眠不佳),占 24.4%;好转者 8 例(主要症状解除,有时头晕失眠,或全身不适,偶有轻微的发作),占 17.8%;无效者 3 例(症状改善不大,或暂时减轻,但不能解除),占 6.7%。总有效率 93.3%。

【病案举例】 乔某,女,23 岁,未婚,农民,1976 年 9 月 16 日入院。患者因到县城参加追悼会,在会场突然昏倒,急送来我院内科住院治疗。醒后自诉头痛,烦躁易怒,手足乱动,翻滚不安,有时嚎叫哭闹,语无伦次,恶心不能吃饭,害怕,失眠,大小便正常。既往有头痛失眠史。检查:青年女性,发育尚好,营养一般,体温 36.7℃,血压 14/9kPa,心肺(一),病理反射未引出。胸透(一),红细胞计数 $4.1 \times 10^{12}/L$,血色素 130g/L,白细胞计数 $6.1 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.68,淋巴细胞 0.32,尿常规(一)。诊断:瘵症。曾注射鲁米那,口服利眠宁等镇静剂治疗。中医症见:主症如前,舌质淡红,舌苔白薄,脉象弦细。予以甘凉清润、养血安神之加味百合地黄汤加减。处方:百合 30g,生地黄 15g,竹茹 15g,知母 12g,酸枣仁 30g,远志 9g,龙

47 神经衰弱

神经衰弱是由于大脑功能活动长期持续过度紧张,导致精神活动能力减弱,以精神活动易兴奋和脑力与体力容易疲劳为特征的一种精神障碍。伴有多种躯体主诉,病程多迁延,病情波动与心理社会因素有关。本病可根据临床表现的性质分为衰弱症状(稍用脑即感到疲乏、没精力、迟钝,注意不集中或不能持久,记忆差,或回忆联想增多且控制不住,静不下来),伴随症状(入睡困难,睡眠浮浅、多梦、易醒、节律紊乱,睡眠感丧失,紧张性头痛及肢体肌肉酸痛不适,情绪易波动,心慌、气急、胸闷、皮肤划痕征等全身各系统植物神经失调症状)和继发症状(多为在衰弱症状和伴随症状的基础上产生的社会心理冲突表现,易烦恼、激惹、焦虑、忧郁,疑病和恐惧。本病应排除躯体疾病、脑器质性疾病、其他类型的神经症和精神病方可诊断。治疗本病一般用镇静剂、振奋剂,抗焦虑、抗抑郁药物,及安眠药、止痛剂、促脑代谢或维生素类等药物治疗;电刺激或理疗;心理治疗;体育、劳动、环境治疗。

本病属于中医“健忘”、“惊悸”、“不寐”等症的范畴。本病的病因病机主要是由于脑力劳动过度,长期七情过激,紧张及先天不足后天受累等因素造成阳气上浮,阴血不足,精神活动难以持久为继,或阳弱气衰,精神活动不得固秘,以致于易兴奋,易疲劳。其病机主要涉及到心、肝、脾、肾、脑而出现失眠、心悸、健忘等复杂多变的兼证。治疗本病首当辨证。若阴血不足,心神上浮者用三石二子汤加减;若心神不宁兼挟他证者,

用宁神合剂加減;若肝郁抑脾、阴亏神浮者用解郁定神散或加減安眠丸加減;若气血不足、阴虚火炎、心肾不交者用黄连阿胶汤加減;若心脾两虚、心肾不交者用卧龙丸加減;若脾肾亏虚者用调节丸加減;若肝肾阴虚者用舒神丸加減;若气阴两虚、心脾两亏者用慰神口服液加減;若气血不足,脑髓失养者用魏长春补脑汤加減;若气血不足,脑失所养者用益智饮加減;若精血不足、脑失所养者用健脑丸加減。灵活运用镇潜、滋养、疏通等方法达到交通阴阳、协调平衡的目的。此外龙宏功将本病辨为3型治疗,心脾亏损型方用归脾养心汤加減(党参30g、茯神20g,远志10g,黄芪20g,白术10g,龙眼肉15g,枣仁10g,淮山药20g,甘草6g,夜交藤15g),女性患者伴月经不调者加当归15g,心胸郁闷不舒者加郁金15g,痛经甚者加桃仁10g、赤芍12g;脾胃不和型方用温胆汤加減(法半夏10g,陈皮6g,茯苓12g,竹茹5g,枳实10g,厚朴10g,枣仁10g,太子参10g),煎水送服保和丸或五积散,伴大便溏泻者加白术15g;阴虚火旺型方用知柏地黄汤加減(生地黄20g,山茱萸20g,泽泻15g,茯苓20g,知母15g,黄柏8g,山药15g,丹皮10g,麦门冬12g,远志6g,枣仁10g,参须10g),伴月经色红量少者加阿胶20g(蒸兑),痛经甚者加丹参20g。总共治疗本病107例,临床治愈(临床症状消失,饮食睡眠正常)82例,有效(临床症状基本消失,但仍感疲乏,精神不振)17例,无效(经治疗1个月,症状体征无明显改善者)8例。总有效率为92.5% [湖南中医杂志,1994,(5):38]。

陈龙金等用耳穴贴压王不留行,主穴取神门、皮质下、神经衰弱点、枕,心脾两虚配加心、脾、小肠,心肾不交配加心、肝、肾,若腹胀纳差去神门加脾、胃、三焦。治疗操作:先用84-1型肿瘤探诊仪(湖北仙桃产),在所取耳穴上,通电1~2min,并将治疗探头在穴区内移动,以寻找最佳敏感点,然

后将粘有王不留行的胶布块贴在耳穴上,再以拇食两指适量捏压,并嘱患者每天自行捏压数次,睡前捏压1次,每次操作以耳廓有热胀麻痛等感觉为度。每天治疗1次,每次用1侧耳穴,两耳交替,10次为1疗程,每疗程间隔3~4天。本组病人156例,痊愈(不用辅助药物,自觉症状消失,睡眠时间维持在6h以上者)89例,显效(自觉症状改善,睡眠时间增加2~3h者)30例,好转(自觉症状部分改善,睡眠时间增加1~2h者)22例,无效(治疗1个疗程,症状无明显改善,或虽有好转,但易反复者)15例。总有效率为98.4%[陕西中医,1991,(4):178]。二是本病患者应注意饮食,魏长春认为本病以阴虚阳亢者最为多见,因此患者平时宜食凉润、潜降之食品,如水果、蔬菜、海产品之类,而不宜食温热辛辣具刺激性的食物及浓茶、咖啡等饮料。除病久阳虚者外,一般不宜进食红参、鹿茸等温热性滋补品。此外,在病情稳定后,也可以采用以饮食代药,巩固疗效[山东中医,1985,(2):33]。三是医疗气功(见恐怖性神经症篇)对本病亦有较好疗效。四是配合解劝、鼓励、安慰,以增强患者战胜疾病的信心,对治疗有益。五是心理咨询,帮助患者优化其心理,对有些患者可以从根本上防止本病发生,有着药物所不可取代的作用。

【方名】 三石二子汤。

【组成】 生紫石英(先煎)、磁石(先煎)、枸杞子、五味子、当归各15g,龙骨(先煎)9g。

【来源】 姚政,浙江中医杂志,1988,(10):441。

【功效】 镇潜安神,益气养血。

【适应证】 顽固性神经衰弱,证属阴血不足,心神上浮者。

【方药简析】 本方以生紫石英镇静安神为主药;磁石潜

摄浮阳以安心神,龙骨平肝镇静安神,2味药共辅主药以制阳气上浮;枸杞子、当归养血柔肝,五味子收敛津气以养心,共为佐使药。诸药共用,使上浮之神气得制,气血得以充养。若心脾两亏者加黄芪、淮山药以助气血生化之源;阴虚火旺者加黄连、阿胶以育阴清热;心胆气虚者加知母、枣仁以安神。本方水煎2汁分2次服,每日1剂,治疗41日为1个疗程。姚政以本方为基础方,按上述加减用药,治疗本病53例,结果基本痊愈28例,显效15例,有效9例,无效1例,总有效率为98.1%。

【病案举例】 戚某,女,29岁,1986年10月17日初诊。患者于1980年起常头昏头晕,头胀而重,甚则如坐舟车,感觉周围环境摇动,当时某院按神经血管性眩晕治疗,有所好转。1985年7月间,因邻居失火,惊恐不安,而后略有惊吓,即心惊肉跳,焦虑不安,精神抑郁,闷闷不乐,失眠,早醒,注意力涣散,记忆力减退,稍有紧张,诸症尤重。近月来有时彻夜难寐,白天头昏头晕甚重,不能持久看书,稍久则头痛头晕加重,纳谷减少,体重减轻,常暖气频频,矢气多。西医诊断为神经衰弱。中医检查舌质淡,脉弦细。用三石二子汤加用知母、枣仁,连进4周,症状改善,自觉睡眠已安,惊悸已除,精神转佳。随访半年,一直正常。

【方名】 宁神合剂。

【组成】 淮小麦30g,生地黄、红枣、夜交藤各15g,百合、炙甘草各9g。

【来源】 徐兆泮,浙江中医杂志,1982,(9):412。

【功效】 宁心安神。

【适应证】 神经衰弱,证属心神不宁者。

【方药简析】 本方系由张仲景甘麦大枣汤合百合地黄汤加夜交藤组成。方中淮小麦养心阴、安心神为主药;生地黄、

夜交藤、百合共用以养阴补血、清心缓急安神,辅助主药;炙甘草、大枣补益中气,润脏躁为佐使药。诸药共用有宁心安神之效。徐兆洋以本方为基础方,将本病分为4型,肝气郁结、痰火扰心者合逍遥散加减;阴虚火旺、扰乱心神者配合六味地黄丸加减(肾虚肝旺者再加枸杞子、甘菊、磁朱丸,偏心肾不交者再加交泰丸或朱砂安神丸);若心脾两虚者配合归脾汤加减;脾肾阳虚者合金匱肾气丸加减。本组共110例,结果痊愈(症状全部消失,恢复正常劳动)12例,占10.9%;显效(主要症状消失三分之二)32例,占29.1%;有效(主要症状消失一半)60例,占54.5%;无效(症状无减轻或反而加重)6例,占5.5%。痊愈显效率为39.9%,总有效率94.5%。

【病案举例】 赵某,男,42岁,干部,1979年9月13日初诊。有头痛、失眠等症状已20余年。一般体检、神经系统检查及脑电图均阴性,诊断为神经衰弱,常服谷维素、巴氏合剂之类,病情时好时坏。开始由于过度疲劳失眠严重,头痛以两颞为甚,早上尚能坚持工作,下午则筋疲力尽,头昏脑胀,腰酸腿软,急躁易怒,怒后更加疲乏无力。中医症见:主症如前,舌质红、苔黄,脉弦细。证属阴虚火旺,扰乱心神,予宁神合剂及六味地黄丸合交泰丸加减。治疗50余天后症状基本消失,已能参加正常工作。

【方名】 解郁安神散。

【组成】 郁金 10g,梔子 10g,大枣 5枚,生龙齿 15g,远志 10g,枣仁 30g,柴胡 10g,当归 10g,茯神 10g,石菖蒲 10g,百合 30g。半夏 10g,南星 10g,炙甘草 7g。

【来源】 孙怡,天津中医,1985,(6):27。

【功效】 解郁安神。

【适应证】 神经衰弱,证属肝郁抑脾,阴亏神浮者。

【方药简析】 方中药物剂量为编者所加。本方是由逍遥散、甘麦大枣汤、酸枣仁汤化裁而成。方中郁金理气解郁；栀子、大枣、生龙齿、远志、枣仁共用以除烦，缓急潜阳，养心安神；柴胡、当归、茯神疏肝健脾、养血安神；石菖蒲开窍醒神；百合清心肺虚热；半夏、南星化痰；炙甘草配大枣即辅主药缓急安神，又调和诸药。全方有解郁安神的作用。本方制成冲剂，每袋 5g，每天睡前餐后冲服 1 袋。孙怡用本方按上述方法用药，治疗本病 73 例，显效 14 例，占 19.3%；好转 56 例，占 76.7%；无效 3 例，占 4%。总有效率为 96%。

【病案举例】 患者，男，49 岁，总工程师，1984 年 12 月在我科门诊治疗。患者于 15 年前因工作忙而睡眠少，每夜只能睡 1~2h，多恶梦，记忆力减退，心烦，耳鸣，心悸，乏力，诊断为神经衰弱。曾服中西药无效，每晚靠安眠酮 1 片和硝基安定 2 片，可睡眠 4~5h，遂服药成瘾。改用解郁安神散，中午饭后冲服 1 袋，晚上服 2 袋，2 周后明显好转，睡眠由 2h 延长至 6h，头疼基本消失，很少有恶梦，自觉精力较前充沛。

【方名】 加减安眠汤。

【组成】 百合 30g，生地黄 35g，炙甘草 6g，延胡索 10g，大枣 7 枚，柴胡 10g，茯神 10g，竹茹 6g，丹参 15g，枣仁 30g，远志 10g，夜交藤 30g，合欢花 15g，五味子 10g，麦芽 10g，陈皮 10g。

【来源】 李成军，中医药学报，1985，(1)：23。

【功效】 滋阴养血，疏肝健脾，养心安神。

【适应证】 神经衰弱，证属肝郁脾虚，阴血不足，心神失养者。

【方药简析】 方中药物份量为编者所加。本方系由酸枣仁汤、逍遥散、百合地黄汤、甘麦大枣汤、温胆汤化裁而成。此

4个方均有滋养阴血的作用。现代研究方中夜交藤、合欢花、远志、枣仁、丹参等药物中有效成分都有镇静安眠的作用,能调节人大脑皮层兴奋和抑制的平衡,延长脑神经组织细胞的同化过程,而恢复人体情志思维活动和提高机体工作效应。另一方面本方以散郁为其特点,肝郁首用柴胡,心郁者重用合欢,2者配伍丹参、麦芽、陈皮疗效更显著。若失眠多梦重者,百合、夜交藤、枣仁加至50g;兼有腰背酸痛者配合交泰丸交通心肾;虚热升火者白芍改赤芍,酌加丹皮、栀子;无失眠多梦并有周身困倦无力者,减上述镇静安神之品,加入参、仙灵脾;痰热内炽,胃失和降,心烦少寐,可合温胆汤加减;暑热夏日,汗出过多,气阴两伤,心悸头晕,神疲口渴,配伍生脉散治疗。李成军以本方为基础方,按上述加减用药治疗本病49例,取得满意疗效,一般均可在短期内收效。

【病案举例】 杨某,男,18岁,学生,因脑力过度,而致神经衰弱,已休学治疗1年,中西医多方治疗难以收效。主诉:自觉整天头晕脑胀,总有一种睡不醒之意,但夜间难以入睡,每晚只能有3~4h睡眠、梦多纷纭,晨起两目干涩,咽干口苦,眉宇间有紧缩之感。望舌淡尖边红,切脉弦细而数。本人选用“加减安眠汤”加菊花、川芎、蔓荆子3剂大显效果,夜晚已安睡5~6h,又连投6剂,诸证基本消失,现已上学半年,未见再发。

【方名】 黄连阿胶汤加减方。

【组成】 黄连6g,鸡子黄1个(兑)、枸杞子10g,阿胶10g(烔化),党参10g,白术10g,茯苓10g,黄芪10g,菊花10g,生地黄、熟地黄各10g,炙甘草10g。

【来源】 贾金铭,河北中医,1994,(5):22。

【功效】 育阴清热,交通心肾,健脾益气,补血养心。

【适应证】 神经衰弱,证属气血不足、阴虚火炎、心肾不交者。

【方药简析】 本方系由张仲景黄连阿胶汤化裁而成。方中黄连、菊花清泻心火;鸡子黄、阿胶补心血;生地黄、熟地黄、枸杞子补肾阴;党参、白术、茯苓、炙甘草、黄芪健脾益气。从而达到育阴清热、交通心肾、健脾益气、补血养心之功效。贾金铭用本方治疗青少年神经衰弱 36 例,结果以头晕健忘为主要疗效标准,6 日内症状消失 10 例,9 日内消失 22 例,12 日内消失 4 例,全部治愈。

【病案举例】 董某,男,16 岁,学生,1991 年 4 月 3 日初诊。自诉在升高中考试前 3 个月,因家庭和社会压力,思虑过度,情绪不定,精神紧张继而失眠健忘,头晕心悸,梦寐惊恐,胆怯不安,化验血色素 100g/L,心电图示:窦性心动过速,心率 105 次/分。诊断为神经衰弱。中医症见:主症如前,食欲不振,夜间盗汗,腰痠腿软,舌质红苔薄,舌边有齿痕,脉沉细弱。证属:气血不足,阴虚火炎,心肾不交。治宜益气养阴,交通心肾。黄连 6g,菊花 10g,鸡蛋黄 1 个(兑),阿胶 10g(烊化),生地黄、熟地黄各 10g,党参 10g,白术 10g,茯苓 10g,黄芪 10g,枸杞子 10g,炙甘草 10g。服 3 剂失眠健忘好转,又服 6 剂诸证消失,至今未复发,各项检查恢复正常。

【方名】 卧龙丸。

【组成】 苦参 10g,酸枣仁、白术、山药、枸杞子、木香各 12g,远志 9g,夜交藤 30g,龙眼肉 15g,天麻 9g,大枣 5 枚,安定适量。

【来源】 简文安,湖北中医杂志,1989,(2):18。

【功效】 滋肾补肝,健运脾胃,宁心安神。

【适应证】 神经衰弱,证属心脾两虚、心肾不交者。

【方药简析】 本方选用酸枣仁、远志、夜交藤宁心安神；山药、大枣补脾益气；龙眼补益心脾、养血安神；枸杞子滋肾补肝。诸药合用，共建滋肾补肝，宁心安神之功效。胃气不得冲和，亦是不寐发生的重要因素。方中白术、木香化其经络之淤滞，使胃中之气化息下行，上焦之气皆可因之下行，上焦之阳气与下焦之阴气会合，心肾自然相交。《本草纲目》中记载苦参有补阳气、补中、明目、定志益精、利九窍之功；酸枣仁具有镇静催眠作用，苦参与酸枣仁配伍则镇静催眠作用更明显。为使患者获得较快镇静效果，在本方每1剂中加入安定2.5mg，起入睡镇静诱导作用，俾中药易于为力也。制法：取苦参、山药、远志、夜交藤、大枣加水(1:6~8)，煎煮两次，浓缩成稠膏，其余药物烘干，粉碎成细末，以成药12g中含安定2.5mg之比例计算出总量后，加入安定粉过筛，用炼蜜制丸。服法：每次12g，早晨、晚间(睡前半小时)各服1次，连服10日为1疗程。简文安以本方为主，按上述方法用药，治疗本病84例，结果痊愈(睡眠时间在6h以上，自觉精神愉快、情绪稳定，头昏头痛、疲乏等症状基本消失，半年随访未复发)66例；好转(睡眠在4h以上，伴随症状明显减轻或停药后复发)15例；无效(服药前后无改变)3例。

【病案举例】 刘某，男，51岁，干部，因失眠头昏3年，加重1月入院。从1984年起，无明显诱因出现失眠、头痛，每晚仅睡1~2h，多恶梦，全身乏力，恶心，心慌不适，纳差。曾服中药和西药安定、鲁米那等，初服2~3天有效，以后安定服至8~10片亦无效。近1周上述症状加重，彻夜不眠，烦躁不安，不能工作，曾产生轻生念头。体检：神清，眼底正常，神经系统检查正常，脑电图正常，血粪尿常规正常。血清钾、钠、氯、钙等正常。诊断：神经衰弱症。给予卧龙丸治疗，第3天逐渐好转，第5天睡眠8h以上，伴随症状消失，持续稳定20天痊愈。

出院。随访半年未复发。

【方名】 调节丸。

【组成】 当归 3500g,茯苓 3000g,山药 5000g,益智仁 3000g,枸杞子 3000g,菟丝子 3000g,牡蛎 3000g,白芍 2500g,巴戟天 3000g,莲肉 3000g,十大功劳叶 2000g,琥珀 2000g。

【来源】 邓坦,吉林中医药,1983,(6):18。

【功效】 滋阴补肾,益肾助阳,补脾健胃,镇静安神。

【适应证】 神经衰弱,证属脾肾两虚、心神不宁者。

【方药简析】 方中以当归、茯苓、山药滋阴补血、健脾安神为主药;当归、枸杞子、白芍、十大功劳叶养血滋阴、清热安神;益智仁、菟丝子、巴戟补肾助阳;莲肉养心益肾健脾;牡蛎、琥珀镇静安神。全方滋阴补肾,益肾助阳,补脾健胃,镇静安神。本方制为蜜丸,每丸10g。每日3次,每次1丸,饭后白开水送服。邓坦用本方按上述方法用药治疗本病400例收到满意疗效。

【病案举例】 孙某,男,15岁,学生,1980年8月2日初诊。主诉:头痛,失眠多梦已半年。现病史:半年前因学习紧张,经常头痛头昏,失眠多梦,食欲减退。经服西药镇静剂及中药安神丸等治疗,疗效不佳。检查:两眼睑虚浮震颤,精神萎靡不振;心肺正常,腹软,肝脾不大。诊断:神经衰弱(单纯型)。中医症见:主症如前,舌质红、苔薄白,脉沉细。治疗:内服调节丸,每日3次,每次1丸。服10丸后,能入睡,梦少,食欲好转。继服50丸后,精神振奋,身体渐胖。1年来未复发。

【方名】 舒神丸。

【组成】 何首乌 15g,山茱萸 15g,白芍 15g,桑椹 15g,知母 10g,远志 10g。

【来源】 许仕纳,福建中医药,1993,(3):16。

【功效】 滋阴养血,清热降火,镇静安神。

【适应证】 神经衰弱,肝肾阴虚型。

【方药简析】 本方中药物份量系编者所加。方中主药何首乌味甘微苦涩,性质平和,具有养血益精、调补肝肾功能;山茱萸味酸而涩,既补且敛,平补阴阳;配合白芍缓急柔肝;桑椹补血;知母降火;远志安神益智。共有调治根本,滋阴养血,又能清热降火,镇静安神作用。使肾阴充沛,心肝得养,则神宁志和,情绪平稳,故适宜于肝肾阴虚型患者。经提取精制成胶囊,每天服用3次,每次2粒,饭后开水送服,连服2周为1疗程。因情绪剧烈刺激,用脑过度精神特别兴奋,以及焦虑、疑病患者,往主求医心切,急于见效,而丸剂作用较缓,故多先给汤剂(即本胶囊原方酌予加减)4~7剂后,再与胶囊继续治疗。许上纳用本方按上述方法用药治疗本病87例,结果失眠80例,缓解19例(服药2个疗程后,症状缓解,观察3个月以上无复发者),好转55例(服药后症状缓解,停药复发但较轻,再用本药用仍有效者),无效(服药2个疗程以上症状不减轻)6例。总有效率达95%。对烦躁易怒、头痛、头昏、健忘、耳鸣、心悸也有良效。有些病者兼见疲乏无力、食欲不振,也能明显改善。但对焦虑忧郁、疑病等效果欠佳。

【病案举例】 唐某,男,48岁,经商,长期失眠,疲乏无力,烦躁易怒,头昏,诊断为神经衰弱,服用中西药无法解除。经服本药1个疗程(14天)上述症状明显缓解。患者自述如释重负,心情欢悦。于1991年11月委托另一回大陆台胞述:患者返台后,宿疾未复发,要求再购此药40瓶带回台湾,赠送同病亲友。

【方名】 慰神口服液。

【组成】 榧木 200g, 松石蕊 150g, 香菇、白芍、陈皮各 50g, 西洋参、酸枣仁、枸杞子各 100g, 山楂 200g。

【来源】 李兴民, 陕西中医, 1992, (4): 145。

【功效】 镇静安神, 养心益肝, 调补气阴, 活血化淤止痛。

【适应证】 神经衰弱, 证属气阴两虚、心脾两亏者。

【方药简析】 本方是在清代陈梦雷所撰的《医部全录》所载的镇心爽神汤基础上, 结合临床和实验室筛选结果最后拟定的。方中松石蕊有较强的镇静、安神、止痛作用, 故用于不寐、头痛有较好的效果, 和酸枣仁、茯苓、白芍合用, 可以加强安神定志、养心益肝作用; “神经衰弱”诸型多表现有气阴两亏、心脾两虚的征象, 方中西洋参、榧木、香菇、枸杞子、白芍合而用之, 气阴两补; 山楂、陈皮健脾开胃, 而且榧木合陈皮还有活血化淤、行气、止痛的作用, 对加速解除神经衰弱的头晕、头痛、失眠等症尤为重要, 其次该方用滋阴腻滞药物较多, 榧木、陈皮可以避其副作用。总之本方比较平和, 可用于神经衰弱各型所引起的头晕、头痛、失眠、心悸、健忘、食少纳呆、腰膝酸软、四肢无力、阳萎等症, 尤侧重“虚损”为主的症候较佳。经醇提水沉, 低温浓缩, 制成口服液 10000ml, 每次服用 10ml, 每日 2 次, 连续服用 30 天为 1 疗程。李兴民以本方按上述方法用药治疗本病 94 例, 结果痊愈(症状全部消失, 随访 3 个月, 未复发者) 15 例, 显效(大部分症状消失) 31 例, 有效(部分症状消失) 35 例, 无效(治疗前后无变化) 13 例。总有效率 87.2%。

【病案举例】 张某, 男, 38 岁, 工人, 1989 年 4 月 21 日来院疗养。患者 3 年来经常失眠, 同时表现头晕、心悸、健忘、腰膝酸软、食欲不佳、大便秘结等症。3 年来, 在许多医院求诊, 均未查出阳性体征。诊断为: 神经衰弱(阴亏肝旺型)。长期服用安定、利眠宁、谷维素等西药, 也常同时服用杞菊地黄丸等

中成药,效均不显。中医症见:主症如前,患者舌质红、无苔,脉弦。从1989年5月3日开始服用慰神口服液,每日2次,每次1支,连服7天后,患者即觉睡眠有改善,头晕、心悸消失。继续服该制剂至1月,以上诸症状基本消失,即停药。停药3月来,除偶有1~2天睡眠欠佳外,大部分时间睡眠良好,头已完全不晕,其他不良症状也未见反复发生,故最后定为痊愈。

【方名】 魏长春补脑汤。

【组成】 制黄精、制玉竹各30g,决明子9g,川芎3g。

【来源】 费原子,浙江中医杂志,1988,(5):194。

【功效】 调阴阳,益气血,充脑髓、强精力。

【适应证】 神经衰弱,证属气血不足、脑髓失养者。

【方药简析】 本方以制黄精、制玉竹补中益气、养胃生津;配决明子、川芎通上达下,调达气机,补脑益智。全方共用可调阴阳、益气血、充脑髓、强精力。若健忘严重者加远志、石菖蒲;经常失眠多梦,加枣仁、五味子;心悸、怔忡加珍珠母;情绪易激动、烦躁加白芍、香附。费原子以本方按上述加减用药治疗本病多例,获效较佳。

【病案举例】 李某,女,27岁,1987年6月15日初诊。用脑过度,常头晕且痛,心烦少寐,注意力不集中,记忆力差,精神痿靡。曾诊断为神经衰弱症,经服用多种西药,症状未见好转。笔者先拟归脾汤加减治之少效,后又较长时间服用安神补心丸,服后效果亦不甚理想。中医症见:主症如前,形体消瘦,舌质偏红,苔薄,脉细弦。投以补脑汤加味:制黄精、制玉竹各30g,决明子、远志、石菖蒲、香附各9g,川芎3g,枣仁15g,白芍12g。3剂后复诊,诸症明显好转,上方略化裁再进10剂,病竟告愈,随访至今,未再复发。

【来源】 华伦荣,新中医,1994,(1):28。

【功效】 补气养血填精,宁心健脑安神。

【适应证】 神经衰弱。证属精血不足、脑失所养者。

【方药简析】 本方系刘仕昌教授所创。方中用红参须大补元气、养心安神,蜜制黄芪健脾益气;当归补养心血;龟甲填精补肾;五味子补肾宁心;知母、麦门冬养心脾;远志、石菖蒲、益智仁益智安神、通心开窍;甘松行气理脾。病机与用药丝丝入扣,俾其气旺血盛,精足髓满,而神自为用。现代研究亦证明,红参须、黄芪、五味子、龟甲等,能促进脑神经细胞代谢,增加脑血流量,补充对脑神经细胞有益的微量元素,从而改善脑功能,增强思维活力。本方每日1剂,水煎服,1个月为1疗程,连续服2个疗程统计疗效。华伦荣以本方按上述方法用药,治疗本病153例,结果临床痊愈(所有临床症状全部消失)23例,显效(症状学标准中的5项均有不同程度的缓解)78例,有效(临床症状至少有2项以上缓解)44例,无效(临床症状无缓解)15例。总有效率95.12%。

【病案举例】 毕某,女,44岁,教师,1983年5月10日初诊。主诉:精神疲乏,梦多,善忘3年余。患者自述近3年多来常感精神疲乏,食少心悸,稍用脑即感头晕痛,以眉棱骨为甚,注意力不集中,不能阅读业务书籍,只能翻阅一般的报刊、杂志,但过目即忘,入睡困难,梦多,常因精力不足而焦急、苦恼。血压不稳定,经现代医学检查排除脑器质性病变。诊断为神经衰弱。曾先后多次服用谷维素、维生素、安定及多种中成药和中药煎剂,疗效不稳定,初服有效,继则无效。刻诊:症如上述,望其面色晄白,口唇色淡,舌淡,无苔,脉细弱无力。中医辨证:健忘(心脾不足,精血虚弱)。西医诊断:神经衰弱症候群。治法:补气养血填精,宁心健脑安神。处方:健脑丸原方,12剂,水煎服,日1剂,分早晨空腹及晚睡前2次服。二诊,精神转

佳,睡眠较好,头晕心悸略减。效不更方,继守健脑丸原方,前后共服 50 余剂,症状消失,精力充沛,工作如常。

1/3 以上的患者不能归入以上 4 种基本类型的任何 1 型,而被纳入“混合型”或“未定型”。本病应与躁狂抑郁症、青年适应反应、反应性精神病、强迫症、癔症、神经衰弱、器质性精神病相鉴别。治疗本病目前常用抗精神病药物氯丙嗪、氯氮平、五氟利多、奋乃静、泰尔登、舒必利等,及电抽搐治疗、胰岛素治疗以及精神治疗,工娱治疗等。

精神分裂症可见于中医的癫狂症。本病病因病机主要是由于七情内伤或胎病遗传导致机体产生气滞血淤或痰火内扰、阴阳失调的病理变化,“重阳者狂,重阴者癫”(《难经二十难》)。对本病的治疗首当辨证。痰火为患者可选用三生汤、红芽大戟煎、清心安神汤、丹赭黄蒲汤、龙胆泻狂汤、杨氏升降散、白金散、温胆汤、温胆铁落汤、甘麦大枣铁落汤等为主加减;痰淤为患者选用礞石滚痰梦醒汤、活血醒癫汤、通淤开窍汤等为主加减,或从肝论治选用柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡加龙骨牡蛎去参桂汤、枕中逍遥散等加减,阴血不足可选用防己地黄汤加减,阳气不足可选用温阳兴奋汤加减。

丁德正对 218 例精神分裂症偏执型患者分为 8 型治疗,痰气郁结型(治以疏郁化痰达神汤:柴胡 24g,香附、郁金各 21g,黄芩、胆南星各 9g,海浮石、薄荷、狼眼各 15g,甘草 10g,另琥珀 6g(研末分 3 次冲服);针刺肺俞、肝俞、胃俞、内关、丰隆、太冲、百会,施泻法,留针 3h 许,每 30min 捻针 1 次);痰火上扰型(治以清心化痰汤:黄连 12g,天竺黄、栀子、黄芩、郁金各 15g,大黄 30g,(后下),胆南星 9g,海浮石、礞石、寒水石各 30g,石膏 60g,远志、石菖蒲、竹茹、甘草各 9g,朱砂 6g(研末分 3 次冲服);针刺心俞、胃俞、内关、神门、通里、丰隆、风府。耳穴:脑点、胃、神门,泻法,留针 3h 许,每 30min 捻针 1 次);气虚痰结型(治以益气涤痰镇神汤:党参、黄芪、炙甘草、酸枣仁各 30g,白术、茯苓、郁金、远志、石菖蒲、枳实各 15g,胆南星

g,海浮石、礞石、龙齿、磁石各 30g,朱砂、琥珀各 3g(和研分 3 次冲服);针刺:肺俞、脾俞、心俞,补法,针后加灸:百会、神门、内关、丰隆、泻法,留针 3h 许,每 1h 许捻针 1 次);肝气虚型(治以益肝养血安神汤:熟地黄、当归、枣仁各 30g,阿胶(烔化)、茯苓、柏子仁、远志各 15g,龙骨、牡蛎、磁石各 30g,甘草、甘桔各 9g,朱砂、琥珀各 3g;针刺肝俞、脾俞、心俞,补法;行间、神门、耳穴:肝、脑点、神门,用平补平泻法,留针 2h 许,每 20min 捻针 1 次);淤血型(治以祛淤达神汤:当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、枣仁各 15g,大黄 20g(后下),丹参、郁金、龙齿各 30g,甘草 9g,琥珀 6g;针刺心俞、膈俞、内关、神门、通里、百会,耳穴:心、神门、皮质下,泻法,留针 3h 许,每 30min 捻针 1 次);痰淤内结型(治以涤痰化淤达神汤:胆南星 10g,枳实、桃仁、红花、远志、石菖蒲、水蛭、虻虫、枣仁各 15g,大黄(后下)、海浮石、礞石、丹参、郁金各 30g,甘草 9g,琥珀 6g;针刺心俞、膈俞、脾俞、丰隆、百会、人中、神门、内关、间使、风府,泻法,留针 3h 许,每 30min 捻针 1 次);血虚风稽型(治以养血祛风安神汤:当归、熟地黄、党参、酸枣仁、五味子各 30g,柏子仁、茯神各 15g,远志、秦艽、羌活、防风、薄荷、白芷、甘草各 9g,龙骨 30g,朱砂 6g;针刺心俞、脾俞,用补法,百会、风府、风池、肺俞、曲池、合谷、神门、通里,泻法,留针 3h 许,每 30min 捻针 1 次);湿毒内扰型(治以温阳利湿解毒汤:黄芪、炙甘草、党参、白术、桂枝、枣仁各 30g,苦参 24g,茯苓、泽泻、远志、石菖蒲各 15g,木通 10g,朱砂 5g;针刺:脾俞、肺俞、气海、中脘,补法,针后加灸;心俞、胃俞、内关、神门、百会、通里、足三里,泻法,留针 3h 许,每 1h 许捻针 1 次)。上述方药每天 1 剂,针灸每天 1 次,直至获愈。获愈后,转入缓慢巩固,在原服方药之基础上,递减祛邪品,加益血养阴、补气助阳及镇心安神品。巩固开始之第 1 个月每天 1 剂,第 2~4 个月间日 1 剂,第 5~7

个月3日1剂,第8~12个月4日1剂,1年以后每月5剂,初发病而病较轻者,约须1年左右巩固,病程长而病较重者约须2~3年。近期疗效:痊愈(自知力恢复,诸种妄想及幻觉症状等消失)212例,占97.2%;无效(经治疗,症状无改善,或一度好转,为时不久又恶化)6例,占2.8%。获愈最短时间为47天,最长为438天。以150~200天为多。10年内远期效果:在近期获愈之212例中,11人已死亡。在其余的201例中,良好(未复发,精神状况良好)97例,占48.3%;显著进步(曾复发过,目前自知力未全复,有稍许妄想及幻觉症状,但不影响日常工作和生活)65例,占32.3%;好转(自知力部分恢复,妄想或幻觉症状部分存在,但有部分工作和生活能力)27例,占13.4%;无效(症状如故或加剧,或已出现精神衰退)12例,占6%[北京中医杂志,1988,(6):28]。

李禄斌等以自拟“精复康1号”(生石膏、柴胡、生大黄、生铁落、夜交藤、青皮、青礞石)及川芎菊蚕散(生石膏、川芎、僵蚕、菊花、生地、黄柏、黄连、钩藤、代赭石、炒枣仁、炒栀子)加减治疗本病50例,近期总有效率为98%,5年内总复发率为28.6%,认为本方不仅近期疗效好,且远期效果也较巩固[中医杂志,1995,(5):23]。

王松龄等用下法(大黄、巴豆霜、芒硝、金礞石等)、吐法(生桐油、淮小麦面、瓜蒂、郁金等)相结合治疗急性精神分裂症43例,结果基本治愈20例,显效11例,有效9例,无效3例,总有效率92.9%,平均起效时间为6.5天,并认为下、吐两法结合治疗该病有见效快、疗效高、毒副作用小、复发率低的优点[北京中医学院学报,1992,(6):41]。

张保汉等亦用吐泻法治疗精神分裂症124例,其中属狂症者87例,癫症者37例,吐法用白矾(冲服)、藜芦、瓜蒂、黄芩、生石膏、白矾等;泻法用芒硝、大黄、枳壳、槟榔、滑石、连

翹、黄柏、黄连、郁金、贝母、熟地黄、橘红、瓜蒌、石菖蒲,结果近期治愈率男 93.2%,女 81.3%,102 例治愈者经随访 1 年,远期治愈率 77%,好转率 23%,男、女复发率分别为 8%和 12%[山西中医,1991,(5):22]。

朱静芳等用张锡纯荡痰汤为主(代赭石 45g、清半夏 15g、大黄 24g、芒硝 12g、醋甘遂 3~4.5g。代赭石打碎加半夏先煎 10 余沸,再入大黄煮 2~3 沸,最后入芒硝,临服时以醋甘遂研粉吞服,如虚中夹实者,醋甘遂酌情减少。隔日 1 次,上午 9 时半空腹服用,10 剂为 1 疗程,中病即止),继用活血化瘀之柴胡汤、逍遥丸等调理,巩固疗效。在服中药期间,氯丙嗪(或泰尔登)维持在 300mg/日,治疗本病,62 例中痊愈 3 例(4.84%),显著进步 18 例(29.0%),进步 32 例(51.6%),无效 9 例(14.59%),总有效率为 85.5%(中医杂志,1991,(3):40)。

张本等用激光针灸治疗本病 31 例,选用两组穴位:①大椎、神庭。②双太阳,针刺深度 5 分,两组穴位隔日交替,每日治疗 15min,疗程 5 周,氯丙嗪组作为对照,结果发现激光针灸治疗焦虑抑郁的疗效略优,而治疗幻觉、妄想、紧张、敌意猜疑冲动等症状具有与氯丙嗪相等的效应,治疗迟滞性症状略差于氯丙嗪,激光组患者无锥体外系副作用[中华神经精神科杂志,1991,(2):81]。

吕雅芝采用华佗夹脊穴第 1 胸椎至第 7 胸椎,第 4、5 腰椎至第 1 骶椎两旁夹脊穴,左右夹脊穴之间包括大椎、陶道、无名、身柱、神道、灵台、至阳、腰阳关、第 17 椎下、腰俞 10 个督脉穴位计 10 个埋线点(两侧共 20 个埋线点),配穴:天泉、大肠俞、委中、承山,15~20 天埋线(羊肠线)1 次,3 次为 1 疗程,治疗本病 100 例,总有效率为 96%,痊愈率 59%,多数埋线于 2~4 次即见效果,最显著的疗效出现在第 3 次埋线之

后。此法对病程较短,复发次数较少,症状以青春型、紧张型的疗效为好,尤以初发者治愈率为高[中国针灸,1988,(5):12]。

杨春林用桃黄片(桃仁 20g,大黄 40g,赤芍 40g,提取制成浸膏糖衣片 50 片,每服 10~15 片,最大剂量 25~30 片。日 2 次,上午 9 时、下午 3 时服用)配合小量抗精神病药物治疗本病 186 例。6 周为 1 疗程。1 个疗程结束后评定疗效,治愈(精神症状消失,自知力恢复)73 例,占 39.2%;显著进步(精神症状基本消失,自知力大部分恢复)25 例,占 29.5%;进步(精神症状有改善)55 例,占 29.5%;无效(精神症状无改善或反增剧者)42 例,占 22.6%[中医杂志,1986,(9):31]。

宋乃光认为应以疏调为主的方法,药物选择应避免大攻大破、过燥过润。选用以柴胡、桂枝为主的方药,肝脾气结、痰淤阻窍以逍遥散加减,脾虚停饮、肝气挟痰浊泛逆用柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散加减[辽宁中医杂志,1989,(11):44]。

郭树昆等用解郁散(陈皮、半夏、枳壳、竹茹、梔子、红花、香附、石菖蒲、山楂、苍术、砂仁、苏合香、冰片)治疗本病 200 例(其中 30 例为其他精神疾病),结果总有效率为 98%[天津中医,1986,(5):19]。

张继志对本病患者出院后以懒散少动为主证者,选用炙甘草汤、人参归脾汤、金匱肾气丸等治疗;以注意力不集中、失眠等为主证者,选用养心汤、安神丸、知柏地黄丸等治疗;以情志不稳、易激惹为主证者,选用温胆汤、导痰汤、血府逐瘀汤等治疗[中西医结合杂志,1988,(7):431]。

杨春林等以金蒲丹片(郁金 40g、石菖蒲 40g、丹参 40g、香附 20g,以上共制成 50 片,每片含生药 2.8g)合并小剂量抗精神病西药,对本病 204 例进行了观察,显效率为 65.7%,与用大剂量抗精神病药物的西药组比较,无显著性差异($P>$

0.05)。药理实验表明,该药有安定和减少自主活动的作用,对动物和人体无不良影响。因子分子显示,该药对焦虑抑郁、迟滞效尤佳,对活动过多效果较差。在以上研究基础上,他们又对金蒲丹片提取过程加以改进,合并小剂量抗精神病药舒必利,制成复方金蒲丹(郁金 30g、石菖蒲 25g、丹参 15g,提取有效成分后浓缩成浸膏,加入舒必利 0.5g,混合压成 20 片,每片含生药 3.5g,舒必利 0.025g),对本病 24 例治疗的结果,显效率 66.7%,与舒必利组比较,无显著性差异($P>0.05$),因子分析比较,复方金蒲丹对焦虑抑郁的疗效优于舒必利,且毒副反应比舒必利低[中西医结合杂志,1987,(9):529。中国医药学报,1992,(2):30]。

【方名】 三生汤。

【组成】 生石膏 248g,生大黄 62g(泡水兑服),生铁落 31g,青礞石 62g,代赭石 62g,朴硝 24g(冲)。

【来源】 乔玉川,难症萃方,15。

【功效】 攻下退火解毒。

【适应证】 精神分裂症体质壮实者。

【方药简析】 本方是基于精神分裂症“火重毒深”的观点,以重剂生石膏、生大黄攻下清退阳明邪热为主;朴硝助主药软坚泻下、清热泻火为辅;生铁落重坠安神,代赭石镇肝潜阳,青礞石逐痰共为佐药。诸药共成攻下退火解毒的基础方。临床上偏属血虚痰火型者加入天竺黄 12g,以助清热化痰,加入鸡血藤 62g、当归 31g,以养血补血,使泻中有补,或改用“精分 2 号方”(由石菖蒲、生石膏、生大黄、芦荟、黄柏、黄芩、薄荷、芒硝、牛黄粉、天竺黄、鸡血藤组成),侧重于养血安神、清热开窍;若偏属肝郁火旺型者,方中可加入冰片 1.5g(冲)、青皮 31g 以助理气解郁,开窍醒神,或改用“精分 1 号方”(由生

洗净,用铁锅煎煮,取汁 300ml,顿服。服药得吐下后,狂势衰减不显著者,第2日续用上药 250g 煎服。狂势得挫后,用糜粥调养。结果 12 例均获痊愈。对全部病例进行远期疗效随访,其中随访 1~5 年者 6 例,6~10 年者 5 例,10 年以上者 1 例,均未见复发。

【病案举例】 孙某,男,22 岁,1983 年 8 月 22 日初诊。患者于 1980 年 2 月因行为不轨而受他人责打,郁怒难伸,遂罹狂乱。经本省某精神病院诊为精神分裂症。曾 2 次住院,经用氯丙嗪、氟哌啶醇等药物以及教育疗法、工娱疗法、电休克疗法,效果不显。近来病情日重,躁狂骂詈,不食不眠,气力逾常,大便闭结,常持刀棍追打行人。被其家属捆绑至我院诊治。查得实气粗,面色如赭,目珠通红,肌肤灼手,舌质红,苔黄厚而干,脉象弦数鼓指。参合脉症,属郁怒伤肝,不得宣泄,以致肝胆气逆,肝木化火,炼液成痰,痰火暴萌互纠,冲激元神所致。即经谓“重阳者狂”是也。宜吐清并用,搜逐攻决三焦痰火。药用:红芽大戟 500g,煎煮后灌之。服药后,吐痰如破絮,泻下痰水如鸡子清,量约 1000ml。自此,狂势顿挫,静卧思睡。3 日后欣然来告,病已得痊。追访 2 年,未见复发。

【方名】 清心安神汤。

【组成】 黄连 9g,麦门冬 15g,朱砂 6g(水飞,冲服),黄芩 12g,栀子 12g,生大黄 15g,炒枣仁 20g,茯神 20g,远志 9g,石菖蒲 12g,生地 12g。

【来源】 张宏宽,陕西中医,1984,(11):13。

【功效】 清心安神,清热泻火。

【适应证】 精神分裂症等,证属痰火上扰心神者。

【方药简析】 本方以黄连、麦冬、朱砂为君,清心火,养心阴,安心神;辅以生大黄、黄芩、栀子清泻阳明、少阳之实热;茯

神、枣仁、远志、石菖蒲安神化痰开窍，以助朱砂之功；生地既能助君药以清心养心，又能清热凉血，与诸气药有两清之妙，是为佐使。诸药合用，有清心安神、滋阴泻火之效。用治本病，特别是初发病例，疗效尤佳。对于反复发作、病程较长的病例，本方疗效欠佳，但延长疗程，加之护理得当，收效还是比较满意的。对急躁易怒，打人毁物者，加龙胆草、芦荟；体质壮实而狂躁甚者，加藜芦、甘遂；口渴口干、舌苔黄燥或焦黑者，加玄参、生石膏；痰多者，加胆南星、瓜蒌仁、天竺黄、浙贝母；胸闷气滞重者，可酌加沉香、枳壳、香附、柴胡、郁金、青陈皮；夜寐不安、多恶梦者，加琥珀、生龙骨、生牡蛎；精神抑郁者，加合欢皮；语言增多者，加木通、灯芯草；狂躁缓解后，出现语无伦次、动而多喜或沉默痴呆、旁若无人者，改以定志汤（人参、茯苓、石菖蒲）为君，减少清心安神汤内苦寒、重镇药之用量；根据病情，酌加竹沥、姜汁；癫之虚证，见便溏尿清、体虚脉弱者，则忌用本方。张宏宽用本方按上述加减治疗包括相当于精神分裂症的癫狂 306 例。结果治愈（精神症状全部消除，随访 3 年以上无复发者）167 例，占 54.6%；好转（精神症状基本消除，3 年内虽有反复，但症状较初发时明显减轻；或精神症状基本消除，生活能自理，并能主动参加一般劳动；或精神症状控制后而未坚持治疗者）113 例，占 36.9%；无效（连续治疗 3 个月以上，精神症状无明显改善，改用其他方法或治疗不足 1 疗程而中断联系，疗效无法判定者）26 例，占 8.5%。总有效率 91.5%。

【病案举例】 刘某，女，25 岁，工人，1980 年 6 月 9 日初诊。患者于 1979 年 2 月 3 日因情志不遂而发病，某精神病院诊断为精神分裂症，住院治疗 8 月余，病情稳定后出院。回厂不到两月，因生气，病情复发。语无伦次，骂詈不避亲疏，毁物伤人，昼夜不眠，面红目赤，口干渴，思冷饮，每日须喝 6~7 热

【方药简析】 本方中药物剂量是编者所加。方中丹参活血凉血，消血中之火，配合大黄清凉之力骤增，酒大黄又具有峻下实邪之功，故2味药相伍，直折其火势，俾痰火随之而下，清窍血络顿开，神识顿开，神识昏蒙得解；代赭石重镇降逆，下上冲之逆气，与前药相配，相得益彰，曠郁之气随之平息。石菖蒲开窍醒神，并可引经报使。四药相配，量大功专，可除痰火交炽之袭扰；能除淤痰阻络之积垢，颇中肯綮。然痰火骤清，淤去气顺，但终疗仍以活血醒神为要。若痰火盛者加生石膏，并冲服朱砂；痰壅盛者加远志冲服麝香；痰血阻络者加琥珀冲服地龙末；浊痰壅塞者加白芥子冲服苦丁香。服用中药期间禁用一切抗精神病药。王瑜华用本方按上述加减治疗包括相当于精神分裂症的癫狂30例。近期临床治愈（精神症状完全消失，理智恢复至病前水平，并能从事病前的全日制工作）18例；显效（主要精神症状消失或基本消失，但理智未恢复至病前水平，能坚持一般型轻工作）7例；有效（部分精神症状减轻显著或好转，理智恢复较差，不能有效的坚持轻工作）2例；无效（主要精神症状与治疗前无变化，理智无恢复者）3例。总有效率占90%。

【病案举例】 杨某，女，19岁，学生，1984年5月18日初诊。2月前因学业不佳，事与愿违，又加之家中琐碎之事纠缠，起初沉默寡言，失眠多梦，渐至言词繁多，语意烦乱，目珠呆滞，前去西安精神病院诊治，诊断为“精神分裂症”青春型。口服安定、眠尔通、泰尔登等药。出现语序繁多，烦躁不宁，或外出奔走。就诊时目赤面红，急躁不安，动作怪诞。舌质瘦小且红，尤以舌尖为著，脉象洪而滑数有力，证属肝郁气滞，中宫敦阜之气受戕，久则煎熬成痰，蒙蔽心包。治以峻泻痰热、降气开窍。处方：丹参、代赭石（先煎）、酒大黄（后下）各120g，石菖蒲30g，朱砂4g（冲），1剂。二诊，服药后共排大便10余次，至第

2 天下午神志清晰,言词有序,疲乏无力,舌红苔白。处方:丹参 120g,石菖蒲 30g,郁金 10g,地龙末 30g(冲服)。服 2 剂。三诊:神志清楚,行动语言无异常,惟困倦乏力,嘱加强饮食营养,注意节制操劳,服天王补心汤 2 剂,以资巩固。半年后随访无异常。

【方名】 龙胆泻肝汤。

【组成】 龙胆草 15g,柴胡 6g,栀子 10g,黄连 10g,黄芩 10g,代赭石 30g(先煎),石菖蒲 12g,龟板 15g(先煎),生龙骨 15g(先煎),朱茯苓 15g,生地黄 20g,羚羊角粉 1 支(冲服)。

【来源】 涂世福,江西中医药,1991,(2):42。

【功效】 泻火平肝。

【适应证】 精神分裂症,证属肝郁火逆者。

【方药简析】 本方采用李东垣龙胆泻肝汤加减而成。方中龙胆草泻肝火为主药;柴胡疏肝解郁,栀子、黄芩、黄连苦寒泻火,茯苓利湿以协助胆草清泻肝胆郁火,共为辅药;代赭石、龟板、生龙骨、羚羊角粉镇潜平肝,朱砂镇心安神,石菖蒲醒神,生地养血益阴,共为佐使药。诸药共用,使肝火得泻,气逆得解,则窍开神清症除。涂世福以本方治疗本病有良效。

【病案举例】 胡某,男,19 岁,学生,1988 年 10 月 20 日就诊。患者素来睡眠欠宁,因高二年级分科未遂意,在高考的第 2 天下午突然在河边玩耍,拒绝参加考试,甚至打人,从此神志失常。某医院诊断“精神分裂症”,住院月余,症状控制,但终日不下楼,一天晚上病复发,打闹不休,不认亲疏,次日找余诊治。现症心烦意乱,烦躁不安,面色潮红,苔黄,脉弦数,证属肝火上扰,法宜泻火平肝,方拟:龙胆草 15g,柴胡 6g,栀子 10g,黄连 10g,黄芩 10g,代赭石 30g(先煎),石菖蒲 12g,龟板 15g(先煎),生龙骨 15g,(先煎),朱茯苓 15g,生地 20g,羚羊

为“精神分裂症·妄想型”。近日来数饮不食，小便黄赤，大便数日未解，双腿挛屈，自叙不能伸屈。反复念叨：“孔明卧龙就是我，我的人才被埋没了。”舌质红绛，苔黄褐燥，蓬头垢面，衣着不整。口出秽浊之气，腹肌紧张，按之呼痛，脉未详（患者不配合）。证为郁火内发，痰火扰心。治宜开泄郁火、涤痰开窍，佐以凉血。用本方加减：僵蚕 15g，蝉蜕 12g，片姜黄 3g，大黄 5g，生石膏 100g，茜硝 20g（烺化），薄荷 18g，盐黄柏 15g，黄连 10g，生栀子 12g，生地 30g，桃仁 20g，磁石 30g。水煎 2 次，共取汁 500ml，分 2 次服，每 6h1 次，日 2 剂。次日大便 6~7 次，先硬后溏，粪便奇臭。双腿伸屈自如，狂言战栗稍止。第 3 天晚睡 8h 许。1988 年 6 月 7 日复诊，语言多但可制止，自叙耳边常有人语，可与对答，幻听仍明显。心悸心慌时发，喜歌喜呼，舌质红绛，苔黄燥，较前薄，脉弦数有力。仍遵上法，改鲜生地 100g，水煎服，日 1 剂。1988 年 6 月 23 日三诊：先后共服上方 18 剂，谵语、幻听、幻觉再未发，少有心烦，睡不实。继与：僵蚕 150g，蝉蜕 120g，片姜黄 35g，大黄 200g，桃仁 120g，胆南星 100g。共研极细末，每服 6g，日 2 次。调治 2 月痊愈。李鸿奇，北京中医杂志，1991，（6）：257。

【方名】白金散。

【组成】白矾 9g，郁金 21g，石菖蒲 6g，朱砂 4g，人造牛黄 1.5g。

【来源】黄森，新中医，1992，（7）：1。

【功效】清热泻火，祛痰解郁，宁神定志。

【适应证】精神分裂症，痰郁证者。

【方药简析】白矾性味酸寒，清热豁痰，燥湿；郁金行气解郁清心；石菖蒲开窍，朱砂安神；人造牛黄清热化痰开窍。诸药共奏清热、豁痰开窍、安神之功。便秘脉实者加大黄（醋炒）

6g;久病元虚者加西洋参10g;痰多者加蛇胆川贝末2~3个。将上药研末分21包,体壮者1日3服,体弱者日1剂,小儿酌减,温开水送服。纳呆者用梗米粉调白糖少量蒸糕服。7天为1疗程,连服6~8个疗程。一般无毒副作用。钟明远用本方按上述方法用药治疗本病有良效。

【病案举例】 陈某,女,19岁,4个月前,因看电影人多拥挤突被狂徒拦腰紧抱,大声呼救,力争获释,奔走回家。自此之后出现神志失常,百问不答,低头不语,有时泼掷药物,瞋目而视,有1天竟欲吞服乐果,意图自戕,家人见状,莫不奈何。曾住精神病基层院治疗29天,病仍如故,且时有冷笑、暗泣之状。并见食少纳呆,舌苔薄白而腻,脉弦滑。据证诊为痰而兼郁之“癫疾”。处方:白矾5g,郁金10g,石菖蒲、川贝母、法半夏各6g,朱砂4g,共为细末,分12包冲米汤服,饭后每次服1包,每天3次。4天为1疗程,服至第4疗程后,方去川贝母、法半夏,加入人造牛黄1.5g,继续服用。共服11剂后,诸症悉除,要求工作上班,随访1年,如常人。

【方名】 温胆汤。

【组成】 半夏12g,陈皮6g,枳实9g,竹茹9g,茯苓15g,甘草6g。

【来源】 孙思邈《备急千金要方》。

【功效】 清化痰热,宁心安神。

【适应证】 精神分裂症等,证属胆虚痰热上扰者。

【方药简析】 本方中药物份量为编者所加。方中半夏燥湿化痰,降逆和中,止呕消痞;后世于方中增入茯苓利水渗湿健脾、宁心安神,现代药理试验有镇静作用;甘草补脾益气和中;竹茹清热和胃化痰;陈皮理气消痰,温胃而止呕逆;枳实降逆破气消胀。全方温凉并用,清热而不寒,化痰而不燥,用于胆

虚痰热上扰、心神不宁、神明逆乱者有清化痰热、宁心安神之效。陈超于本方中易枳实为枳壳,加入炙远志、石菖蒲、炒枣仁、生龙骨、生牡蛎、珍珠母、麦门冬等镇静安神之品为主。若痰涎壅盛者加天竺黄、胆南星、明矾、礞石滚痰丸等;肝郁气滞者加柴胡、香附、郁金、川芎等;痰热伤阴者加南沙参、生地、白芍等;躁扰不安者加莲子心、朱砂、琥珀等;热盛心烦者加黄连、黄芩、栀子、大黄、龙胆草、生石膏等;躁狂奔走者加生石决明、生铁落等。治疗包括精神分裂症在内的癫狂症 30 例(其中 16 例确诊为精神分裂症),结果近期临床治愈(精神症状完全消失,能坚持全日工作)13 例,占 43%;显效(主要精神症状基本消失或显著减轻,能坚持一般轻工作)5 例,占 17%;有效(部分精神症状消失或好转)8 例,占 27%;无效(主要精神症状无变化)4 例,占 13%。总有效率达 87%。疗程最短者 16 天,最长者 224 天,平均 78.7 天。

【病案举例】 王某,男,14 岁,1979 年 5 月 14 日初诊。患者于 4 月 22 日因与同学闹意见后,感到语言不利,思维不能用语言表达,烦躁,时有恶心呕吐,曾下颌小抽 3~4 次,即到附近就医,症见好转。1 周前又下颌抽搐,去某医院急诊,疑为脑炎而收入住院。脑脊液检查为阴性,除外脑炎,但精神症状逐渐加重,精神抑郁,表情淡漠,两眼发直,自知力和计算力差,答非所问,时而痛哭流涕,大喊大叫,甚则动手打人,寐差,食欲不振,口干大便干,给服西药镇静剂等不见好转而出院,出院时诊断精神分裂症青春型。就诊时患者两眼发直,默默不语,呈痴呆状,烦躁,坐立不安,面赤,目微赤,苔白黄腻,脉弦滑数(心率 112 次/min)。证属情志不遂、肝失调达、肝郁化火生痰、痰火扰心。治当平肝清热化痰安神。处方:竹茹、炒枳壳、郁金、黄芩各 9g,酒大黄、茯神各 15g,陈皮、甘草、炙远志、石菖蒲各 6g,姜半夏 12g,炒枣仁 24g,制礞石 30g,生龙骨、生牡

师 15g。服 5 剂。二诊：患者精神症状明显好转，烦躁、痛哭流涕、喊叫和打人等症均消失，谈笑自然，情绪及睡眠均好转，纳增，大便已畅，但仍口干乏力，头昏耳鸣，舌质稍赤，苔白薄，脉滑稍数，前方去酒大黄，加麦门冬 12g，朱砂 2g。上方续服 5 剂后诸症悉除，唯偶有情绪不好，以后共随诊 8 次，服药 55 剂而愈[陈超，中医杂志，1984，(11)：31]

【方名】 温胆铁落汤。

【组成】 法夏、陈皮、枳实、竹茹、石菖蒲、黄芩、胆南星各 9g，茯苓、瓜蒌各 12g，黄连 6g，生铁落 30g(先煎)，生姜 4 片，甘草 1.5g。

【来源】 王俊国，陕西中医，1987，(3)：139。

【功效】 清热化痰，泻火开窍，重镇安神。

【适应证】 精神分裂症，痰热内阻为主证者。

【方药简析】 本方以温胆汤清化痰热，破滞降逆为主：黄芩、黄连清心泻上焦之火；胆南星、瓜蒌以清化痰热；石菖蒲开窍宁神；生铁落重镇安神。全方清热化痰、泻火开窍、重镇安神。若心悸不宁加朱砂 3g(冲服)，龙骨、牡蛎各 30g；不寐加琥珀 3g(冲服)，远志 9g；大便燥结不下加大黄 10～30g，玄明粉 10～15g；血瘀加丹参 24g，桃仁、红花各 9g；痰涎壅盛加天竺黄 9g；纳少加焦三仙各 9g。少数病例配合冬眠灵 100mg，1 日 3 次。王俊国以本方为主，按上述加减用药治疗本病 30 例，结果痊愈(精神症状基本消失，神清语利，生活自理，记忆力恢复，饮食睡眠如常)16 例；好转(精神症状明显减轻，精神安静，有时清醒，反应及判断能力较差，生活尚不能完全自理)12 例；无效(精神症状治疗后无明显变化)2 例。服药最短 8 天，最长者 45 天，以 16～38 天者居多。

【病案举例】 吴某，女，18 岁，学生。1984 年 8 月初，患者

因考试成绩不佳,情绪低沉,心烦躁不安,彻夜不眠,继之妄见所闻,表情淡漠,自言自语,喋喋不休,时而破口大骂,外出奔走,口苦而干,唇红干裂,头晕头痛,腹胀纳呆,大便5日未下,小便短黄,生活不能自理,舌红苔黄厚腻,脉滑数,经某医院诊断为“精神分裂症”,因西药治疗效不著而转余诊治。辨证属痰热阻于肝胆,蒙蔽清窍所致。治宜清热化痰、泻火开窍。用上方加大黄12g,服4剂后,泻下燥屎,腐臭难闻,神识稍清,症状好转,效不更方,依前方将大黄减半,继服4剂,神识转清,烦躁去,夜能寐,苔转薄黄,火势已平,痰热尚未尽去。继以清热化痰、安神定志,原方去石膏蒲、黄芩、大黄,加生地12g,柏子仁9g,又服6剂,药后神清语利,舌红少苔,脉转细数,病至恢复期,热盛伤阴之象已显,遂改投清热养阴安神之剂。处方:生地、玄参、麦门冬、枣仁、茯苓各12g,柏子仁、瓜蒌各9g,丹参18g,黄连3g,远志、陈皮、甘草各6g,生姜3片,连服12剂,诸症悉除。随访至今未见复发。

【方名】 甘麦大枣铁落汤。

【组成】 炙甘草10g,小麦100g,大枣5枚,贝母、制南星、陈皮、法半夏、茯神、炙远志各10g,钩藤15g,生铁落100g,枳壳8g,竹茹10g。

【来源】 黄典清,湖北中医杂志,1985,(6):24。

【功效】 平肝泻火,豁痰开窍。

【适应证】 精神分裂症等,阴伤痰热内盛为主证者。

【方药简析】 本方系由甘麦大枣汤合生铁落饮化裁而成,方中取炙甘草、小麦、大枣养心益气,旨在扶正祛邪,“精胎则邪却也”;茯神、炙远志、夜交藤,生铁落镇安心神,意欲召浮躁之神气,使心有所主也;重用法半夏、陈皮、制南星、贝母、天竺黄、瓜蒌、竹茹荡涤痰浊则邪去正安,神明得以为用也。若肝

阳上扰而见头痛、头晕、目眩较重者加菊花、草决明(或石决明)、生龙骨、生牡蛎、生白芍;肝胆实热重者加栀子、黄连、大黄、龙胆草;气郁痰结、胸中烦扰重者加瓜蒌、天竺黄;呕吐涎沫者以食盐化水饮之。黄典清用本方按上述加减治疗包括精神分裂症在内的癫狂病 12 例,治愈(症状全部消失,能劳动或上班工作,观察 2~11 年未复发)8 例;显效(发病间隔时间延长,1 年以上未复发)2 例;有效(症状基本消失,1 月以上未复发)1 例;无效 1 例。

【病案举例】 唐某,女,20 岁,农民,1981 年 12 月 14 日初诊。诉:于 1975 年 5 月 17 日晚,因恶梦惊醒发生狂叫,胆怯,不眠、闭目即有幻觉。此后,神志失常,淡漠寡言,自感头晕、脑胀、乏力、嗜睡、不欲饮食,继而胡言妄语,夜不能寐,先后服用氯丙嗪、风引汤等药物不效,病情日笃。现在证:抑郁,急躁易怒,语无伦次,喋喋不休,日夜游走,甚则骂人毁物,食少,大便结干,小便短赤,舌质红,苔黄腻,脉弦而滑。诊为癫狂,系病久阴亏,肝火横逆,灼液为痰,痰火上扰,清窍蒙闭所致,治以养心安神、豁痰泻肝。以上方加炒栀子、龙胆草、大黄各 10g,黄连 5g,3 剂,水煎服,日服 1 剂。次诊(12 月 19 日):服药后大便日行 2~3 次,神志转清,语言减少,躁性顿减,且能入睡,但觉头晕耳鸣、面热目胀,胆怯,四肢不温。斯时,虽肝胆之火得以清解,但肝阳上亢之证仍显,故宗上方去栀子、龙胆草、黄连、大黄、制南星、枳壳,加菊花 10g、钩藤 20g、草决明 20g、生地 15g、天竺黄 15g,3 剂,以期平肝镇逆、安神豁痰。三诊(12 月 24 日):病证大减,神志清醒,语言有序,自诉仍时感胆怯,且腰痛,白带多,按二诊方去天竺黄加黄连 5g,续断 15g,6 剂。四诊(1982 年 1 月 23 日):患者自诉一切正常,稍有心悸眼花口干之证,见其舌红少苔,脉细弦,拟滋肾平肝、养血补脾之剂(太子参 15g,女贞子 10g,白芍 15g,珍珠母 30g),嘱

【组成】 郁金、合欢皮、丹参各 30g,红花、桃仁、当归各 15g,川芎 12g,赤芍 15g,香附 12g,石菖蒲 30g,远志 10g,茯神 30g,地龙 10g,炒枣仁 30g,檀香 3g

【来源】 李长远,辽宁中医杂志,1991,(8):17.

【功效】 活血化淤,行气破滞,化痰开窍

【适应证】 病程较长的精神分裂症青春型、妄想型,证属气滞血淤痰阻者

【方药简析】 方中以桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、丹参、郁金相伍,破沉痾之淤血,兼而行气;以香附、檀香,理气行气、化痰破滞并行;合欢皮活血解郁安神;茯神健脾利湿、宁心安神;石菖蒲、远志化痰开窍定神;地龙清热熄风通络;枣仁养心安神,全方用于气血淤滞于脏腑经络,痰结于心胸之间者有活血化痰、行气破滞、化痰开窍之功。李长远用本方治愈精神分裂症青春型 5 例,3 年后复发 1 例。治愈精神分裂症妄想型 1 例,2 年后复发 1 例。有较好的远期疗效。

【病案举例】 张某,女,23 岁,1978 年 3 月 5 日初诊。精神分裂症病史 3 年,多次复发,时轻时重,近又复发 1 个多月。刻诊:面部贴有 10 余个红纸条,自称为七仙女下凡,忽而哈哈傻笑,忽而悲伤啼哭。其母训斥一下,则突然惊惶万分,言及玉皇大帝派孙悟空来捉拿她;忽而跑出门外,凝视天空,侧耳倾听,口中念念有词,细听之,内容荒诞无稽。诊为精神分裂症青春型。其母言其经行 2~3 个月 1 次,今已近 1 年未至。中医症见:主症如前,舌质紫黯,舌尖有紫色斑点,脉弦涩。投活血醒脑汤 6 剂,病情无明显变化,又服 6 剂,无故哭笑次数,程度较前稍有好转。继进 6 剂,患者已知洗脸整洁。服至 28 剂时,月经来潮,量多,粘稠,夹有大量紫黑血块,精神症状明显好转。因邻居吵架,突受惊吓,病情复又加重。前方加朱砂、琥珀各 3g,又服 1 剂,举止渐趋正常,喜笑未再出现,自己认识到

有病,要求给予彻底治疗。原方稍有出入,继续服药,前后共治疗3个月零6天,患者一切恢复正常,现已10余年,随访未再复发。

【方名】 通淤开窍汤。

【组成】 石菖蒲 12g,天竺黄 9g,白金丸 4.5g(吞),当归 10g,制大黄 6g,红花 6g,桃仁 9g,郁金 9g,制香附 9g。

【来源】 凌耀星,上海中医药杂志,1989,(6):31。

【功效】 理气解郁,祛痰破淤,开窍安神。

【适应证】 精神分裂症,证属气郁痰结血阻者。

【方药简析】 方以石菖蒲芳香通窍闭、宁神为主药;天竺黄、白金丸化痰,辅主药以豁痰开窍;当归、大黄、红花、桃仁破血淤,郁金、香附疏肝理气,在方中共为佐使。诸药共用可通心气、开心窍、解肝郁、祛痰、泄浊、活血通络而使心气得伸,肝气疏脾运健,痰浊化清阳开,精力旺盛,诸症自除。凌耀星用本方治疗本病有良效。

【病案举例】 黄某,女,29岁,职员。患者有精神病家族史,在安徽农村因受惊后,精神失常,后调至苏州,经精神病院诊断为精神分裂症,服西药治疗。1981年1月26日前来要求中药调治。患者面色不华,表情淡漠,反应迟钝,动作缓慢,颈部不灵活,回首时常连身子一起转动。不思纳食,大便3~4日1行,喉间有痰,夜眠不宁,多梦,言语对答尚可,但不时讲:“他们要弹瞎我的眼睛”,“我的眼睛被他们弹瞎了。”查其眼,完好无损,视力正常。向她作解释,意志执拗,无可理喻,月经闭止已3月,脉小弦,舌颤抖,难以伸出。证属心肝气郁、痰血互结。治以疏通为主,处方:石菖蒲 12g,天竺黄 9g,白金丸 4.5g(吞),当归 10g,制大黄 6g,红花 6g,桃仁 9g,郁金 9g,制香附 9g。二诊:精神渐振,胃纳增加,大便通利,粘痰消失,脉

象小弦，舌仍颤抖。治予前法加减：石菖蒲 12g，当归 10g，制大黄 3g，红花 8g，川芎 6g，朱茯神 9g，远志 9g，夜交藤 15g。三诊：精神佳，略心烦，每日大便 1 次，间或语“眼睛弹瞎”。脉趋和缓，舌不颤抖，能伸出口外。平时主动做些家务及编织绒线等。处方：石菖蒲 10g，当归 10g，红花 6g，川芎 6g，赤芍 9g，生地 12g，瓜蒌仁 10g，远志 9g，麦门冬 10g，莲子芯 3g。四诊：停经已半年，于 3 月 27 日恢复来潮。除大便干燥外，余无异常。按前方出入调治。精神愉快，于 5 月 1 日返回苏州。几天后即上班工作。此后偶有心烦等，经服上药，很快恢复正常。1988 年 5 月随访，6 年来一直上班工作，精神正常，身体健康，月经如潮。

【方名】 柴胡加龙骨牡蛎汤。

【组成】 柴胡 12g，龙骨 30g，牡蛎 30g，黄芩 10g，生姜 10g，铅丹 30g，人参 10g，桂枝 10g，茯苓 10g，半夏 10g，大黄 10g，大枣 7g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 寒热并用，攻补兼施，上透下达，开结散邪，重镇安神。

【适应证】 精神分裂症等，证属三焦余邪积热，肝郁气滞，痰结血淤者。

【方药简析】 本方中药物份量是由编者所加。方中既有大黄攻下，又有人参补中；既有黄芩之苦寒，又有桂枝之辛温；既有半夏、生姜之辛散，又有龙骨、牡蛎敛阴潜阳；既有柴胡之轻清，又有铅丹之重镇。从而体现了寒热并用、攻补兼施、上透下达、开结散邪、重镇安神之功。若肝胆火旺，证见面红目赤，心烦易怒，狂言乱语，小便短赤，大便干结者，上方去桂枝、人参，加黑山栀 12g，龙胆草 10g，夏枯草 15g；肝阴不足，肝气

桃仁、红花，加三棱、莪术、川芎各10g。连服21剂，病情缓解，至今未见复发[杨培泉，新中医，1986，(7)：28]。

【方名】 柴胡加龙骨牡蛎去参桂汤。

【组成】 柴胡12g，黄芩12g，生龙骨15g，生牡蛎15g，大黄12g，制半夏12g，生铁落20g。

【来源】 王延敏，国医论坛，1987，(2)：22。

【功效】 理气解郁，泻火清热，化淤开窍，镇心安神。

【适应证】 精神分裂症等，痰火上蒙为主证者。

【方药简析】 本方是由张仲景柴胡加龙骨牡蛎汤化裁而成。柴胡加龙骨牡蛎汤是仲景为邪传少阳而设，本方具有和解少阳、镇惊除烦、扶正攻邪的功用，然而癫狂实邪致病者，用此方时当用具攻邪诸药，切不可妄投桂枝、人参等扶正之品，否则，抱薪救火有害无益。方中的铅丹和铁落同具平肝镇惊坠痰之功，但铅丹不如铁落力猛，故用铁落代之。若属痰火上扰者加焦栀子、天竺黄、胆南星、石菖蒲；痰气郁结者加礞石、胆南星、郁金、枳实、石菖蒲；血淤痰阻者加枳实、郁金、桃仁、丹参、川芎；热扰血室者加生地、丹皮、桃仁等。王延敏用本方按上述加减治疗包括精神分裂症的癫狂病52例。结果痊愈（精神症状完全消失，神态恢复，能胜任工作，随访1年以上未复发）39例；好转（主要精神症状基本消除，生活能自理，1年内虽有复发而症状较初患病时有明显减轻）10例；无效（经长期服药精神症状无改善或改善不明显）3例。总有效率94.2%。

【病案举例】 鲁某，女，30岁，1985年2月3日诊。1年前因精神刺激，引起神志失常，经某精神病院诊为“精神分裂症”，用镇静药治疗半年余效果不著，后配合中药其病渐愈。此次因财产纠纷，暴怒后突然狂乱无知，妄语不休，毁物打人，昼夜烦躁不寐，小便频急，大便干且4~5日1行。患者面红目

赤，怒目而视，神情若惊，舌红，苔黄厚腻，脉弦大滑数。此属痰火上蒙清窍、扰乱神明所致之狂证。治宜清泻肝胆、涤痰开窍、镇心安神。药用醋柴胡 12g，生龙骨 15g，生牡蛎 20g，生铁落 20g，大黄 20g，黄芩 15g，焦栀子 12g，天竺黄 15g，胆南星 12g，石菖蒲 12g，3 剂，日服 1 剂。3 日后来述服 1 剂后即大便 3 次，冲清狂止，3 剂服完主要精神症状基本消失。上方去铁落，大黄减量，继服 6 剂而愈。1986 年 12 月 20 日随访未复发。

【方名】 枕中逍遥散。

【组成】 丹皮 15g，栀子 15g，柴胡 10g，白芍 10g，朱茯苓 15g，白术 10g，绿萼梅 6g，郁金 10g，当归 10g，枕中丹 1 丸。

【来源】 涂世福，江西中医药，1991，(2)：42。

【功效】 疏肝解郁，佐以清热。

【适应证】 精神分裂症，证属肝气不舒，气结气乱者。

【方药简析】 方中以柴胡疏肝解郁，当归、山药养血补肝，3 味药配合补肝体而助肝用为主药；茯苓、白术、补脾理中，绿萼梅、郁金理气解郁共为辅药；朱砂、枕中丹安神开窍，丹皮、栀子清热共为佐使药。诸药共用使郁结得解、气机调畅、神安窍开，诸症自除。涂世福用本方治疗本病有良效。

【病案举例】 陈某，女，20 岁，务农，1986 年 4 月 10 日初诊。患者 1 年来因婚事不顺心，神志恍惚，常常自言自语，失眠不寐，不能参加劳动，在某市精神病医院诊断为“精神分裂症”，服氯丙嗪等药治疗 3 月余，病情未见明显好转。现证失眠不寐，不思饮食，急躁易怒，语言错乱，苔薄黄，脉弦而数。证属木失调达，肝火内郁。法宜疏肝解郁，佐以清热，方拟枕中逍遥散加减：丹皮 15g，栀子 15g，柴胡 10g，白芍 10g，朱茯苓 15g，白术 10g，绿萼梅 6g，郁金 10g，当归 10g。1 日 1 剂，1 日 3 次。

服 25 剂后,症大减,连服 65 剂,睡眠安宁,神志正常,坚持农活。2 年后随访,病未复发。

【方名】 防己地黄汤。

【组成】 防己 3g,防风 9g,桂枝 9g,甘草 3g,生地黄 150g。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 益阴养血,疏风清热。

【适应证】 精神分裂症等,证属血虚生热、邪并于阳者。

【方药简析】 本方重用生地黄益阴清热、养血固本为主;防己、防风、桂枝轻清升散风邪为辅。对血虚生热邪并于阳之证,可收益阴养血、疏风清热之效。本方先将生地黄浓煎取汁(忌用铁器)两煎混合;余药放黄酒中先浸 12h 左右,然后将药捣烂,加开水 150ml,将汁绞出,与生地黄汁混合,分早、中、晚 3 次温服。丁德正以本方治疗本病有良效。

【病案举例】 宋某,女,25 岁,1979 年 3 月 5 日初诊。患者发病于 1971 年 5 月,少眠、多动、语无伦次,狂躁异常。当时诊断为精神分裂症青春型,经多方治疗,时轻时重,迄今未愈。近年来狂象虽减,但痴痴癫癫,秽浊不知,间或妄笑,独语不休。且喜时搔头部,剃光之头皮被抓得血迹斑斑。刻诊:身体拘强,面容消瘦惨白,双颊微红,脉洪大无力,舌质红、干而少津。诊断为癫狂。综观脉证,显属狂久火盛伤阴,阴血不足,风邪入侵,扰及神明。处以防己地黄汤。服 10 剂,独语妄笑略减,夜稍能眠,胡乱游走,呼之能止。又服 20 剂,疾廖约半。又服 20 剂,神情言行皆恢复正常,已能参加工作[丁德正,河南中医,1984,(5):31]。

【方名】 温阳兴奋汤。

【组成】 巴戟天 9g,仙茅 9g,附子 9g,肉桂 6g,干姜 6g,党参 6g,黄芪 15g,熟地黄 15g,龟板 15g,陈皮 9,砂仁 3,丹参 9,甘草 5g。

【来源】 胡海浪等,陕西中医学院学报,1994,(7):29。

【功效】 温阳兴奋,消阴宁神。

【适应证】 精神分裂症,脾肾阳虚型。

【方药简析】 方中以巴戟、仙茅相伍补肾阳、温脾阳为主药;附子、肉桂、干姜合用以温补命门,引火归源,振奋阳气,辅助主药消阴宁神;佐以党参、黄芪健脾益气,熟地黄、龟板滋阴潜阳,陈皮、砂仁理气和胃,丹参活血化淤;甘草调和诸药为使。全方可温阳兴奋、消阴宁神。若精神萎靡,畏寒重者加大附子、黄芪、党参用量,顽固不化者干姜改为炮姜加焦白术;神情呆滞者加石菖蒲、远志。胡海浪等以本方为主按上述加减用药,同时服用小剂量抗精神病药物(三氟拉嗪、氟奋乃静、氯氮平),30天为1疗程,治疗精神分裂症脾肾阳虚型80例。结果2个疗程内治愈40例(症状消失,自知力恢复),占50%;好转34例(症状部分消失,自知力部分恢复),占42%;无效6例(症状无变化,自知力缺失),占8%。马晓中报道朱曾柏单独用类似方加减治疗本病亦有良效。

【病案举例】 陈某,女,35岁,1980年12月29日初诊。患精神分裂症已16年之久,时反复发作,近来每月发作1次,多在夜晚发作。昨夜复发,余视其神情呆钝,闭目少言,蒙头倦缩,舌淡,脉沉。家属代述平时小劳即发热汗出,此阳虚也,治宜甘温益气,温补肾阳。处方:黄芪 20g,仙茅 10g,丹参 10g,茯苓 10g,远志 10g,仙灵脾 15g,石菖蒲 15g,莱菔子 20g,肉桂 6g。文火浓煎,日1剂,日3次,每次用药汁送服阳起石末3g。服药4剂,饮食少增,余症未见改善。继守原方服药12剂,诸症悉除,3个月未发。于1981年4月20日又发作1次,但

症状也较为轻。嘱其服原方15剂,加服金匱肾气丸调治,迄今未发[马晓中,辽宁中医杂志,1984,(7):6]。

【方名】 洋金花注射液。

【主要成分】 东莨菪碱,莨菪碱,阿托品。

【来源】 卢煌,广西中医药,1985,(2):9。

【功效】 阻断胆碱系统,广泛而深入的调整中枢和植物神经。

【适应证】 精神分裂症等。

【方药简析】 洋金花主要成分为东莨菪碱、莨菪碱、阿托品,其中东莨菪碱占85%。据有关资料报道:乙酰胆碱在体内浓度和动态平衡的变化,对精神病的发病与治疗关系较大。东莨菪碱对中枢和周围神经都有明显抗胆碱能作用,乙酰胆碱主要通过一些基团与胆碱能相结合而发挥作用。洋金花制剂也含有类似基团。因此,能紧密地结合在胆碱能受体的表面,形成牢固的药物-受体复合体,有效地阻止乙酰胆碱和受体结合。这种阻断胆碱系统,对中枢和植物神经起到广泛而深入的调整,使皮质功能得到调整,促进功能的恢复。因目前精神分裂症的真正病因尚不明确,治疗机制有待继续深入研究。治疗方法:① 洋金花注射液肌肉注射,每晚或隔日用药1次,首次2mg,然后逐渐增加至6~8mg,个别病人最高剂量可达15mg。② 洋金花注射液静脉注射,每晚用药1次,每次2~4mg,加入10%葡萄糖注射液20ml稀释后缓慢注入。③ 使用洋金花治疗过程中,可酌情给予少量抗精神病药物治疗,如每日口服氯丙嗪200~300mg,个别病情严重者可450mg/日。如病人注射洋金花后出现烦躁不安,可临时给予口服10%水化氯醛15ml,或肌注苯巴比妥钠0.2g。用药后一般在30min左右,病人即进入朦胧状态,静脉注射见效快者2min

即发生作用。有些患者用药后出现口渴、烦躁不安、呼吸和心率加快等症状,个别病人还可出现发热、尿潴留现象。用药15~20次为1个疗程。卢焯等用本方治疗精神分裂症85例(妄想型67例,未定型12例,紧张型3例,青春型2例,单纯型1例)。一般治疗1~2疗程即可见效。本组病例治愈34例,显效15例,进步11例,无效25例。

【病案举例】 刘某,男,29岁,1976年11月15日入院。患者于1974年7月无明显原因出现失眠,自觉遭人陷害,经常写控告信,行为躁动,伤人毁物。体查无异常发现。精神检查:夜间不眠,生活不能自理,情感淡漠,精神运动性兴奋,吵闹,破坏行为明显,时歌时舞,不知秽洁,随地打滚,有明显被害妄想。诊断:精神分裂症妄想型。11月24日晚肌注洋金花注射液4mg,同时内服冬眠灵125mg,每日3次。注射后有些烦躁,入眠不深。25日晚肌注洋金花注射液6mg,注射后入睡比昨晚深。26日肌注洋金花注射液7mg,可入睡6h。27日以后,隔日肌注上药7mg。12月1日开始病情逐渐稳定,行为紊乱逐渐消失,白天能卧床休息。注射19次后精神症状完全消失,病情稳定,自知力恢复。经23次洋金花治疗,安静合作,生活能自理,被害妄想消失,临床治愈。

49 躁狂抑郁症

躁狂抑郁症,简称躁郁症,是一组以情感的异常高涨或低落为临床主要特征的精神疾病,发病时伴有相应的思维及行为改变,一般不表现人格缺损,轻者可不到精神病程度,统称为情感障碍。美国有人估计重性重复性情感障碍在人群中患病率为12%。本病的病因是内源性的,外界环境因素多是诱因。双相及40岁前发病的病人遗传倾向明显。首次发病多在16~30岁,女多于男,具有反复发作、自行缓解、发作期症状晨重暮轻等特点。缓解期精神活动完整,不残留人格缺损,多次发作亦不衰退,少数人可迁延成慢性。本病起病可急可缓,病前常有无力、失眠。躁狂相发作,可先有烦躁,一过性情绪低落,继之情感高涨,可分为急性躁狂状态(意识模糊,思维澎湃,话多而滔滔不绝,喊闹不休,声音嘶哑,情感高涨,易于激惹,躁动不安,昼夜少眠,拒食拒药)、轻躁狂状态(思维联想迅速,言语增多,随境转移,常伴有夸大色彩,情感高涨时易激惹,精力充沛,昼夜少眠,动作增加)。抑郁相发作起病多缓,病前常并见有纳差及内感不适,情感低落是主要症状(情绪忧郁,晨间低潮明显,言语减少,行动迟钝),也常见有自杀意念或行为,食欲减退,体重减轻,睡眠障碍(特别是早醒),疲乏、精力不足,阳萎闭经,焦虑、激越、自责自罪,疑病观念,有时可出现人格解体,犹豫不决和强迫症状,幻觉不多见。本病须与精神分裂症,分裂情感性精神病,忧伤心境,神经衰弱,焦虑症,痴呆等鉴别。躁狂发作者常用氯丙嗪、碳酸锂等,抑郁状态

常用多虑平、阿米替林等治疗。

本病属于中医癫狂,解郁郁证的范畴,本病的病因病机主要是阴阳失调,七情所伤,痰气郁阻,气血凝滞 4 个方面,与心脾肝胆 4 脏关系最为密切。一般说心气实为狂,心气虚为癫;肝火亢盛为狂,肝血虚馁为癫;肝胆气郁,痰热实火扰心为狂,肝郁气滞,湿阻脾土为癫;瘀血扰神为狂,痰湿阻闭为癫。由于病损关系到机体的气耗与阳复的过程,所以可形成虚实相代而癫狂互变。亦有因气血淤滞,导致阴阳不相顺接而见癫狂互易发作。治疗本病首当辨证,心气实,火热扰心者可选用清心泻火镇狂汤、清心泻火定狂汤、清热定狂汤、安宫牛黄丸等加减;肝火盛或肝胆气郁,痰热实火扰心者用龙胆泻火汤、礞石滚痰丸、柴龙牡蛎汤、精神病 1 号方等加减;气滞血瘀者用癫狂梦醒汤加减;心气虚者用补气养心振神汤加减;肝血虚、心阴不足或兼脾郁者用酸枣仁汤、甘麦大枣汤、解郁汤加减;肝郁气滞、湿阻脾土用小柴胡解郁汤加减;痰湿阻闭气机者用化痰祛风启神汤加减。对狂症不可苦寒太过,并应及时用甘温益气合养阴之品调补,对癫症亦应及时以调理脾胃和安神类药物善后,以免产生癫狂互变的结果。此外,刘正学将本病躁狂相分为 2 型治疗,心肝郁热、痰蒙心窍,表现为急性躁狂状态,治以清热涤痰为主,辅以疏肝安神(黄连 15g,龙胆草 30~40g,栀子 15g,黄芩 15g,生地黄 30g,大黄 15~60g(后下),芒硝 9~15g(冲),木通 12g,枳壳 9g,胆南星 9~15g,郁金 15g,每日 1 剂,两煎。代赭石 30~60g,磁石 30~60g,生龙骨 30g,生牡蛎 30g,知母 15g,远志 15g,朱砂 1.5g(冲),每晚煎服),结果治疗 2 例均获痊愈,疗程 4 周左右;心肝郁热、痰火扰心,表现为轻躁狂,治法基本同前,但苦寒泻下药用量宜轻。当精神运动性兴奋严重、大便燥结时,可冲服大黄、芒硝,或加生石膏;舌质深红,加赤芍、丹皮,以凉血清热;伴有意识模糊,可酌

加石菖蒲、莲子心,以清心开窍。本组治疗 18 例,结果痊愈 5 例,显效 5 例,好转 5 例,无效 3 例[天津中医,1985,(1):10]。

张莉用甘麦大枣汤(炙甘草 30g,大枣 10~15 枚)治疗本病抑郁相 5 例,结果服药 5 天后 2 例恢复,3 例好转,服药 9 天,5 例均恢复正常,随访 1 年,其中 2 例因精神紧张因素复发,再次用药而愈[实用中西医结合杂志,1993,(6):381]。二是运用大剂量甘草,可起到类似于单胺氧化酶抑制剂的抗忧郁作用,但有引起水钠潴留的副作用,用药应从小剂量(10mg/d)开始,逐渐增加用量,如有水肿出现,应及时处理,或停止用甘草。甘草是否不利于躁狂相病人的治疗或加重躁狂症状,目前尚未见报道。三是可配合音乐治疗。四是抑郁相病人常有自杀倾向,治疗期间应予以特别护理。

【方名】 清心泻火镇狂汤。

【组成】 生地黄 30g,玄参 24g,赤芍 15g,黄连 10g,黄芩、栀子各 18g,大黄 30g(后下),珍珠母、寒水石各 60g,淡竹叶 10g,木通 6g,甘草 9g,朱砂 6g。

【来源】 丁德正,中国医药学报,1989,(5):43。

【功效】 清心、泻火,益阴安神。

【适应证】 躁郁症躁狂状态(单相和双相),证属心气实者。

【方药简析】 本方是由导赤散合泻心汤化裁而成。方中以生地、玄参、赤芍共用,清热泻火、凉血养阴、祛瘀,在方中为主药;以泻心汤清泻心胃炽火,栀子清三焦邪热,寒水石清热泻火除烦,配入竹叶、木通、甘草为导赤散之意引心火从下而出,珍珠母平肝潜阳,朱砂镇心安神,共为辅佐。全方清心泻火、养阴安神。若挟痰瘀者,方中加化痰祛瘀之品;若火势已

寐,少洩洩赤,大便略干。此乃心气虚实变易,心气实之候也。予处清心泻火镇狂汤,日1剂,上述穴位每日针刺1次。治至第72天,喜笑狂乐消失,神情正常,后于益阴安神为主之善后方中加黄芪、党参、茯苓等甘温益气之品以巩固之。始则每日1剂,3个月后间日1剂,1年以后,每月6~10剂,共服2年。随访至1989年4月初,未再发作。

【方名】 清心泻火定狂汤。

【组成】 黄芩、栀子各16g,大黄、玄参各30g,生地黄、龙齿各30g,珍珠母、寒水石各60g,黄连、竹叶各10g,木通、甘草各9g,朱砂6g(研末冲服)。

【来源】 丁德正,陕西中医,1985,(12):511。

【功效】 清心泻火安神。

【适应证】 初癫后狂的癫狂症,证属心火亢盛者。

【方药简析】 本方是由黄连解毒汤合导赤散化裁而成。方中以黄连解毒汤泻火解毒,因证属心火亢盛,邪热在上,故去黄柏不用,加导赤散清心养阴、利水导热,即可救心火亢盛伤阴之急,又可使邪热从小便排出,2方配合巧妙;再配玄参清热凉血养阴,寒水石清热泻火除烦,大黄泻热存阴,更可增2方效用;佐以龙齿、珍珠母、朱砂镇静安神。则全方清心泻火安神。对心火亢盛初癫后狂的癫狂证(相当于躁狂抑郁症),丁德正用本方配合针刺肾俞(施泻法),心俞、神门、通里(施平补平泻法),留针1h,每15min捻针1次,治疗本病有良效。

【病案举例】 段某,女,25岁,教师,1978年6月7日诊。病已半载,初为癫,后为狂,就诊中浓妆艳丽,翩翩起舞,证见:脉洪数,面红耳赤,舌红而干,少苔,渴喜冷饮。诊为心火亢盛,予清心泻火定狂汤,并针刺上述穴位。服药6剂及针刺6次后,兴奋狂乐之象大减,继服上方10剂及针刺10次后,神情

安定。后于前方去大黄，加枣仁 10g，取 15 剂，制为散剂，继服两月病愈。随访至今未犯。

【方名】 清热定狂汤。

【组成】 大黄 20g(后下)，黄芩 12g，黄连 9g，栀子 12g，石膏 90g，寒水石 30g，生地黄 20g，地龙 15g，玄参 20g，珍珠母 30g，薄荷 15g，菊花 15g，甘草 10g，朱砂 6g(研末冲服)。

【来源】 丁德正，辽宁中医杂志，1984，(7)：23。

【功效】 清泄邪热，镇神定狂。

【适应证】 癫狂邪热炽盛型(相当于躁狂症)。

【方药简析】 方中大黄通腑泻热，釜底抽薪，以除炽盛之邪热为主药；辅以黄芩、黄连、栀子清三焦，特别是上焦扰心之火，石膏、寒水石清阳明之热；生地黄、地龙、玄参清热泻火凉血益阴平肝，珍珠母平肝潜阳，且薄荷、菊花清头目之热，朱砂镇心安神，共为佐药；使以甘草调和诸药。全方可清泄邪热、镇神定狂。若大便秘结者倍加大黄 45～60g，芒硝 30g(首煎冲服)以加强通腑泻热之效。丁德正用本方按上述方法加减治疗相当于躁狂症的癫狂邪热炽盛型，有良效。

【病案举例】 林某，男，35 岁，患狂症年余。曾作阳明实热、肝火、痰火扰心等施治无效。近来症状益剧，昼夜奔走，数日不归，动辄打人。诊之，患者面红，目赤有神，脉浮数有力，舌尖红绛而干，苔薄而焦黄，肌肤略瘦，渴而多饮，大便秘结。据脉证及病前近期无“得之忧饥”史，显系劳倦过度，卫失其御，致“风邪乘虚而入，并于阳则谓之重阳，故其病妄笑好乐，妄行不休…”(《普济方》)。诊为狂症，风入阳经，邪热炽盛型。予清热定狂汤加大黄量为 45g，芒硝 30g。5 剂药尽，泄泻较频，狂象略减，夜稍能寐。于上方去硝黄，又服 10 剂，狂象大减，言行基本正常。于上方加枣仁 15g，减石膏为 30g。续进 10 剂，言

然向学生诽谤，声音激昂，然语意不伦。1988年7月延余诊之：面色潮红，口干而渴，烦躁少寐，大小便短黄，大便干结，…至5天，解，舌红少津，苔少，脉细数。诊为狂证（火盛伤阴），乃因妒恶其夫另有外遇，情悻不畅，肝郁化火，神明被扰，神志溃乱而发狂；火盛伤阴，虚火迁延不缀而神乱未已。治以清心开窍、滋阴降火安神。予安宫牛黄丸，每日服1丸，另以二阴煎化裁：生地黄15g，麦门冬10g，玄参15g，枣仁10g，茯苓10g，黄连6g，灯心2g，磁石30g，龙齿30g，石菖蒲10g，生铁落50g，大黄6g，每日煎服1剂。至第4天，神乱尽释，余症未了。停服安宫牛黄丸。为防苦寒太过伤阴，原方去大黄、黄连，续服3个月，大便恢复正常，火盛伤阴之症全消，病告愈而恢复工作。[蒙本荣，中国医药学报，1992，（1）：33]。

【方名】 龙胆泻火汤。

【组成】 龙胆草10g，栀子10g，大黄（久煎）20g，黄连10g，黄芩10g，车前子10g，木香10g，胆南星10g，茯苓10g，磁石30g，合欢皮10g，琥珀（冲）3g。

【来源】 刘培志等，实用中西医结合杂志，1993，（7）：162。

【功效】 清肝泻火，化痰安神。

【适应证】 躁狂症等，属肝郁化火，痰火内结，邪扰神明者。

【方药简析】 方中以龙胆泻肝汤泻肝胆实火为主，去泽泻、木通以免利湿伤阴化燥之过，去柴胡以避其升阳之弊；黄连、黄芩可增强清泻三焦火热之功为辅药；重用大黄久煎以缓其峻下而取其清血分之热邪；木香走窜通窍，调畅气机，胆南星、茯苓以化痰，磁石、合欢皮、琥珀以安神，相伍共佐主药泻火化痰安神；甘草调和诸药为使。诸药共用以清肝泻火、化痰

安神。刘培志等以本方治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,24岁,营业员,1990年9月来诊。该患者2年前患躁狂症住院治疗1次,近7~8天犯病,主要表现为:高兴、愉快,整日忙忙碌碌,见人就纠缠,在女同志面前表现放肆,稍有劝阻则大发雷霆,企图动手打人,言语增多,失眠等。因服用抗精神病药物出现严重不良反应。中医症见:表情愉快,情感高涨,对答如流,有明显的音联意联,随景转移现象,舌尖红起芒刺,苔厚腻。脉洪数。诊断为狂症。辨证:肝郁化火,痰火内结,邪扰神明。治宜:清肝泻火,化痰安神。方药:龙胆草、栀子、大黄、黄连、黄芩、车前子、木香、胆南星、茯苓、磁石、合欢皮、琥珀5剂,服后症状减轻。后在原方的基础上略有加减,连续服25剂,症状全部消失,自知力恢复,痊愈。1年后随访未见复发。

【方名】 礞石滚痰丸。

【组成】 大黄(酒蒸)、黄芩(酒洗净)各240g,礞石30g(捶碎用焰硝30g煨),沉香15g。

【来源】 《丹溪心法》。

【功效】 降火逐痰。

【适应证】 实热老痰发为癫狂。

【方药简析】 本方中所标药物份量为配丸剂用量。方中以礞石为主,取其药性燥悍,与硝石同煨,能攻逐陈积伏匿之痰;辅以大黄苦寒,荡涤实热,泻火通便;佐黄芩清热泻火;又以沉香速降下气,为诸药之开导。诸药合用,降火逐痰。对相当于躁狂抑郁症之癫狂,王国璠用本方加川贝、瓜蒌仁、花粉、朱砂等治疗有良效。

【病案举例】 杨某,女,36岁。平素心胸狭隘,志切上人。1957年8月某日,因贪凉而致寒闭暑邪,热甚不休,经他医治

疗3日,外热告退,头痛未止,卧不安席,渐至语言错乱,自诩自贤,时而歌笑,时而弃衣奔驰,喜顺意语言,逆则骂詈不休,临诊不敢近。遂先遣人顺语相告;患者点首应许。诊见面如朱涂,目光射人,口渴恣冷,月经准期,大便燥结,舌质绛,苔黄垢,脉象洪数鼓指。诊为狂症。证属外感激发郁伏之痰热而妄乱。方用:青礞石12g,大黄12g(另包后下),黄芩9g,沉香6g,川贝母6g,瓜蒌仁9g,花粉9g,六一散15g,朱砂4.5g(分冲)。服2剂后二诊:药后大便畅下燥屎及痰丝,妄气已平,神气尚难宁靖,语言呢喃,舌红苔白滑,脉弦滑。嘱安神静养,勿令惊犯。改易滋液化痰,宁心安神。处方:天冬9g,麦冬9g,玄参9g,川贝母6g,胆南星4.5g,连翘心4.5g,丹参9g,茯苓9g,茯神9g,远志4.5g,钩藤12g(后下),朱砂3g(冲)。生铁落30g煎汤代水,再煎诸药。三诊:服上药3剂后,诸恙悉蠲。盖患者素性急躁,犹恐焦争过甚,痰火复萌;仍用上方5剂,碾粉蜜丸,铁落水下,尽剂,迄今一直未发[邓以林,湖北中医杂志,1984,(2):20]。

【方名】 柴龙牡蛎汤。

【组成】 磁石100g(先煎20min),生龙骨、生牡蛎各30g(先煎20min),茯苓25g,柴胡18g,黄芩、半夏、太子参、石菖蒲、郁金各15g,桂枝12g,大黄、生姜、大枣各10g。

【来源】 刘兴旺,四川中医,1993,(10):27。

【功效】 疏郁导滞,泄热蠲湿,重镇开窍。

【适应证】 躁狂抑郁性精神病,证属肝胆郁结,痰火上扰者。

【方药简析】 本方是取柴胡加龙骨牡蛎汤去铅丹加磁石、石菖蒲、郁金、朱砂而成。去铅丹防久服中毒而疗效不减;取小柴胡汤而去甘草,以调和肝胆;加桂枝抑上冲之气;生龙

骨、生牡蛎是摄纳浮阳之要药，且生龙骨、生牡蛎得半夏与所加之茯苓，能豁肝胆之惊痰，又导以大黄，则痰滞更得下行；生龙骨、生牡蛎配磁石、石菖蒲、郁金、朱砂能制狂醒脑，镇心开窍；太子参、生姜、大枣扶正护胃。诸药配伍，功效益彰，使室滞之机得畅，横恣之热得柔，蒙窍之痰得清而达到止躁制狂之目的。刘兴旺等用本方治疗本病26例，其中女性18例，男性8例；年龄最小18岁，最大59岁；病程最短1月，最长5年。治疗期停药一切西药，结果痊愈21例，随访1年未复发；3例因未坚持服药而复发；2例症状控制，现在观治中。

【病案举例】 朱某，男，20岁，学生。1990年10月4日诊。因成绩差，偷练散打功，受父母吵骂而发病。情绪低沉，少动寡语，纳差嗜睡月余。近1周，突然兴奋言多，情感高涨，少寐多动，常通夜不眠，练功大叫，扰及四邻，不分场合表演自唱，遇生熟人都滔滔不绝。诊为躁狂抑郁性精神病躁狂状态，辨证属肝胆郁结，痰火上扰，心神不宁。治宜疏郁导滞，泄热蠲湿，重镇开窍。服本方12剂，精神正常，配服丸剂1月。随访2年，未复发。

【方名】 精神病1号方。

【组成】 厚朴 8g，槟榔 10g，草果 10g，常山 6g，黄芩 12g，知母 10g，赤芍 10g。

【来源】 崔双庆，中医杂志，1990，(2)：23。

【功效】 调和脾胃，畅达气机，祛痰清热。

【适应证】 情感性精神病，精神分裂症，证属痰热内蕴者。

【方药简析】 方中所标药物份量系编者所加。本方是由达原饮衍变而来。方中厚朴宽中消痰，理肠胃之气滞；草果芳香入脾，味辛行气开郁，善治郁伏之痰浊；槟榔辛开苦降，除痰

消积之力颇强；常山辛开苦降，宣畅气机，宜以去壅，善开痰结以祛痰截病；黄芩、赤芍、知母3味药，既能清除阳明之邪热，又可制草果、厚朴等品之香燥。合方共奏调和脾胃，畅达气机，祛痰清热之力，达到脾胃和则五脏安，痰热除则神志调的目的。若痰重偏抑郁者加石菖蒲；热重心烦狂躁者加炒山栀、淡豆豉；睡眠欠佳或梦多者加远志或生龙骨、生牡蛎；偏阴虚或服药偏燥者加麦门冬、生地黄；大便偏干者加大黄；偏血瘀者加丹参、泽兰。崔双庆等以本方为基础方，按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 王某，女，40岁，1980年开始发病，某院诊为情感性精神病，一直服用氯丙嗪和碳酸锂，效不稳定。1981年10月30日来诊，患者多疑，胆小恐惧，心情抑郁不舒，对生活无兴趣，烦躁不安，失眠，时有幻听，目光呆滞，反应迟钝，饮食尚可，大便偏干，舌暗红，苔薄黄略腻，脉弦滑数。现在正在服用氯丙嗪125mg，碳酸锂0.75g。诊为郁证。病机为痰热内蕴，扰乱神明。处方以调畅脾胃气机，消除痰热为主，兼佐舒肝。1号方加减如下：槟榔10g，枳实10g，厚朴8g，草果6g，常山6g，生大黄1g（后下），栀子10g，淡豆豉10g，知母10g，赤芍10g，黄芩12g，柴胡8g，甘草6g。日1剂，并嘱逐渐减西药。11月20日二诊，述中药已服18剂，多疑幻听已消失，抑郁、心烦、失眠等症明显好转，西药已停。后又以上药加减配制成水丸，每服7g，日服3次，以巩固疗效，随访至1987年年底未发。

【方名】 加减癫狂梦醒汤。

【组成】 柴胡、枳壳、赤芍、香附、丹皮、丹参、半夏、桃仁各18g，青皮、桑白皮各15g，甘草10g。

【来源】 高广见，云南中医杂志，1992，（1）：4。

【功效】理气化痰醒神。

【适应证】癫狂症，见狂躁与抑郁循环发作，证属气血失调，痰淤扰神者。

【方药简析】本方是由王清任癫狂梦醒汤加减而成。方中以柴胡疏肝理气解郁为主；枳壳、香附、青皮加强疏肝行气之力为辅；丹皮、丹参、桃仁共用活血化瘀，半夏、桑皮共用可除痰实之壅滞，两组药物同用以祛痰淤之阻滞，使气血调畅为佐药；甘草缓急补中调和诸药为使药。全方理气化痰，调畅气血醒神。对相当于躁狂抑郁症之癫狂证，高广见用本方为基础方，狂时合白虎汤、调胃承气汤，癫时加石菖蒲、郁金治疗有良效。

【病案举例】李某，女，45岁，农民，1980年2月25日就诊。癫狂3载，多方治疗无效。时而忧郁痴呆，不食不眠；几日后，骂咒不休，躁扰不宁，癫狂迭见，并咳嗽痰多，舌红有淤斑，苔薄黄腻，两关脉弦。乃气血失调，痰淤扰神予加减癫狂梦醒汤加石菖蒲、郁金、瓜蒌仁、莱菔子、焦栀子各15g。服10剂后好转，少量出入只20剂病愈。后巩固治疗，至今安好。

【方名】补气养心振神汤。

【组成】黄芪60g，党参、炙甘草各30g，桂枝、白术各24g，茯苓18g，甘松15g，远志、五味子、酸枣仁各9g，大枣5枚，朱砂3g(研末分3次冲服)。

【来源】丁德正，中国医药学报，1989，(5)：42。

【功效】补益心气、益养振神。

【适应证】躁郁症抑郁型，证属心气虚者。

【方药简析】本方重用黄芪、党参、炙甘草、桂枝、白术和大枣甘温益气；甘松理气消滞；远志、五味子、酸枣仁化痰养血安神。全方可补益心气，益养振神。现代药理学研究，甘草中

精神沮丧,垂首向隅,频频太息,且吸泣不已。唤其就诊,潸然泪下,言:“我已变笨,成为废物,徒为家人之累赘,且耳已聩,目已昏,爪甲枯白,命既如风中残烛,治之复何益哉?”据查,患忧郁症已四载,曾屡服疏郁悦神一类药物,罔效。诊为忧郁症中医症见:主症如前,虚烦少眠。形容枯槁,面眇而惨,唇舌色淡,脉弦细,此乃肝血虚所致也。盖肝血虚,肝气失养,则“将军之官”一反其气急多动、志坚刚强之性,而为怠惰志馁、懦怯抑郁之态,宜补肝血,予酸枣仁汤。服15剂,忧郁减半;且肤有润色,虚烦少眠之象亦减。继服20剂,忧郁消失,夜寐转佳,后以上方制丸,嘱续服6个月以巩固之。随访至今情况良好。[修正,河南中医,1987,(1):21]。

【方名】 甘麦大枣汤。

【组成】 炙甘草 50g,淮小麦 30g,大枣 50枚。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 养心安神,和中缓急。

【适应证】 解郁(抑郁性精神障碍),主证属心阴不足者。

【方药简析】 方中主以淮小麦调养心阴而安心神;辅以炙甘草和中缓急;佐以大枣补益中气,润脏躁。3者合用甘润滋养,有养心安神和中缓急之效。国外有人研究发现甘草中含有抗忧郁作用的单胺氧化酶抑制剂,所以本方有良好的抗忧郁作用,甘草用量一般均在10~60g之间。因为甘草有皮质激素样作用,不适当的服用可能引起水钠潴留和高血压,中医文献中亦提出中满湿胜者不宜使用,因此炙甘草之剂量必须有的放矢,严格掌握。使用时除血压监测外,并检查是否出现水肿。血压增高者剂量不宜加大,水肿者一般采用附子、黄芪、车前子之类药物同用。其间个体差异较大,有每日炙甘草用至100g而无不良反应者,亦有每日15g即出现水肿之敏感者。

韩钟傅以本方为基础方,将本病分为4型治疗:肝肾不足型合二仙汤、酸枣仁汤化裁为:仙灵脾 10g,仙茅 10g,知母 10g,黄柏 6g,当归 12g,五味子 6~20g,炙甘草 12~50g,大枣 10枚,淮小麦 30g,炒枣仁 30g,川芎 10g,姜半夏 12g,茯苓 20g。肝虚脾郁型合逍遥散、酸枣仁汤化裁:柴胡 10~15g,当归 10g,茯苓 15g,炙甘草 12~50g,生姜 2片,薄荷(后下)1.5g,白术 15g,大枣 10枚,炒枣仁 30g,知母 10g,川芎 10g,丹皮 10~12g,生大黄(后下)6g;苔厚腻者重用苍术。阴虚内燥型合生脉散、酸枣仁汤化裁为:炙甘草 12~70g,大枣 10枚,五味子 10~30g,天花粉 30g,炒枣仁 30g,麦门冬 10~15g,石斛 30g,知母 10g。气滞血淤型(此处从略)。结果本组 58 例(抑郁症 20 例(包括 3 例产后抑郁,4 例更年期抑郁),抑郁性神经症 38 例。入组前以钟氏抑郁自评量表(SDS)测定,55 分以上者入组。治疗后每两周测 1 次,至第 4 周,第 8 周再测 1 次,为第 1 疗程),痊愈及显效 21 例(抑郁分下降至 55 分以下,自我感觉良好,完全恢复病前情绪及体力者),占 36%;有效 28 例(抑郁分下降,情绪及体力有改善,但抑郁分未能降至 55 分以下),占 48%;无效 9 例(抑郁分无下降,情绪仍差,无明显改善者),占 16%。总有效率 84%。

【病案举例】 张某,男,41 岁,8 年前曾患肝炎,肝病稳定数年,近 1 年来常疑心肝病恶化,忧心忡忡,觉活着害人,对前途无信心,毫无生趣,曾企图自杀。精神检查:意识清,接触好,愁容满面,称上午心境最坏,晚上略好,昼重夜轻较明显,浑身觉得无力,不想动,“手也不想举,脚也提不起”,心烦难寐。苔薄黄腻,脉虚弦。诊为解郁。证属脾虚肝郁,治拟柔肝解郁。依脾虚肝郁方炙甘草 15g 开始,因心烦、苔黄加肉桂、黄连、焦栀子。3 天后患者自觉宽松。2 周后炙甘草加至 30g,4 周后加至 80g,病情趋于稳定。第 8 周检查,SDS 降至 56 分,觉

精力不如病前,但心境尚感平和。治疗过程中血压均在 12~13/8~9kPa,从未出现浮肿,未服安定及其他催眠药物。3 个月内甘草曾加至 100 克/日[韩钟博,上海中医药杂志,1994,(2):14]。

【方名】 解郁汤。

【组成】 柴胡、制香附、炙甘草各 6g,白芍、炒枣仁、郁金各 12g,当归、朱茯神各 15g,龙齿 20g,石菖蒲 10g,大枣 7 枚,陈小麦 60g。

【来源】 彭法忠,安徽中医学院学报,1988,(4):25。

【功效】 疏肝解郁宣窍,养血益心安神。

【适应证】 抑郁状态,主证属肝郁血虚者。

【方药简析】 本方用柴胡、郁金、香附、石菖蒲舒肝解郁宣窍;又因肝郁而抑脾,导致脾虚食少,或久郁伤神,暗耗营血,心神失养,故方中以当归、白芍合甘麦大枣汤加朱茯神、龙齿、炒枣仁养营血、益心脾、安神宁心。本方水煎,每日 1 剂,早、晚分服。若悲伤欲死另加佛手柑、生牡蛎;神志恍惚、口苦、小便黄加百合、知母;烦躁不安加生栀子、淡豆豉;大便秘结者加生大黄、瓜蒌仁或礞石滚痰丸;昼夜不眠加合欢花、夜交藤,口干舌燥者加石斛、天花粉;痰多而稠者加胆南星、天竺黄。彭法忠以本方按上述加减为主,配合阿米替林 25mg 或多虑平 25mg,每日中午、晚上各服 1 片。如服上述中药睡眠仍差者,加硝基安定 5mg 或舒乐安定 1mg,睡前服。抑郁状态消失后,停中药,仍以西药维持治疗,逐渐减量,直至最后停药。治疗各种抑郁状态 40 例(躁狂抑郁症抑郁型 18 例,抑郁性神经症 11 例,躁郁症抑郁发作 2 例,更年期忧郁症 3 例,精神分裂症后抑郁 2 例,分裂情感性障碍、分裂-抑郁障碍 4 例),结果痊愈(精神症状完全消失,对疾病能作出正确的批判和认识,并

能正常地生活和学习)25例;显进(精神症状大部分消失,对疾病有一定认识和批判能力,但缺乏深刻分析,能参加一定的工作和学习,但不能完全恢复以前的能力)13例;进步(精神症状部分好转,包括自杀欲念和行为消失,能料理自己生活,并能作一部分辅助工作,但缺乏对疾病的认识和批判能力)1例;无效(精神症状未改善,或精神症状虽有部分好转但不稳定,遂又发)1例。总有效率97.5%。

【病案举例】 夏某,女,44岁,已婚,工人,1982年12月1日诊。病前性格急躁、要强、话多,家族无类似病史。1980年11月因与车间女工殴打及车间领导处理不当而心情抑郁,渐至失眠、疑虑。1982年11月病情加剧,昼夜不眠,呆滞不语,回答反应迟缓,仅见嘴唇微动而听不见声音。患者情绪低落,不愿吃饭,疏远亲友,不关心子女,有轻生欲念。诊为躁郁症抑郁型。脉弦细,舌苔薄。拟解郁汤去甘草、大枣、陈小麦加生牡蛎15g,合欢花10g,夜交藤30g,炒神曲12g,每日1剂。每天晚服阿米替林25mg。治疗5天,患者饮食增加,轻生欲念消除。治疗20天,患者情感及行为均恢复正常。以后停中药,每晚服阿米替林25mg,巩固治疗62天,停药。1983年3月25日恢复工作。1986年4月随访,患者一直正常上班。

【方名】 小柴胡解郁汤。

【组成】 柴胡15g,酒黄芩12g,党参20g,姜半夏10g,甘草10g,生姜6片,大枣6枚。

【来源】 李发明等,山西中医,1996,(2):10。

【功效】 疏利三焦,调达上下,宣通内外,和畅气机。

【适应证】 抑郁症,主证属肝郁气滞者。

【方药简析】 本方将张仲景小柴胡汤的药物及剂量略事变通。方中柴胡疏肝解少阳之郁滞,黄芩清胸腹蕴热除烦满,

【组成】 枳实 12g,胆南星 9g,礞石 30g,海浮石 30g,茯苓 15g,远志 15g,石菖蒲 15g,防风 9g,羌活 9g,麻黄 6g,紫苏叶 3g,甘草 6g,生姜 10g。

【来源】 丁德正,辽宁中医杂志,1984,(7):23。

【功效】 化痰开窍,祛风启神。

【适应证】 癫痫,证属痰湿内盛者。

【方药简析】 本方以枳实配胆南星、礞石、海浮石、茯苓,可助脾运,化湿浊祛老痰,再配以石菖蒲化浊开窍醒神,在方中共为主辅;防风、羌活、麻黄、紫苏叶、生姜行散于表,用以祛风、胜湿、散寒,开上而启下,通调水道,使痰湿去,神机振,共为佐药;甘草补中缓急,调和诸药为使。全方可化痰开窍、祛风启神。丁德正用本方治疗相当于躁郁症抑郁型木僵状态的癫痫,辨证为痰湿内盛者有良效。

【病案举例】 李某,男,发病于1975年2月。未病前,工作积极主动,学习勤奋努力,病后性情一反既往,沉闷疏懒无心学习,兴致素然,不喜谈吐,闭户不出,忧念丛生,消极厌世,曾数次自杀未遂。此后迟滞若呆,或终日倦卧扶之不起,或木然僵立,推之不移。询其所苦,答之寥寥,惟唏嘘短叹而已。两个月来,症状逐渐加重,整日昏睡似僵死之态,大小便不知自理,饭水灌入口中含终日而不咽,唤之甚久而不语,间或睁目微视。诊其脉浮滑,舌苔白腻,舌面润滑多垢略黯青。诊为癫痫,风痰蒙闭型。予化痰祛风启神汤。10剂后,昏睡似僵死之态趋解,能主动进食,略与人语,且能作户外活动,然仍较沉闷少动。仍予上方又服15剂,能主动接近人。话亦较自如,神情渐趋坦然,基本痊愈。出所时,予六君子汤加远志,石菖蒲等制面为散,续服月余以善后,随访至今,一切很好。

病、分裂情感性精神病相鉴别。治疗常以甲状腺素、甲烷硫氧嘧啶、性激素、避孕药、谷维素、多虑平、舒必利、达营片、电休克等治疗。

周期精神病属于中医癫狂、经前诸症的范畴。本病的病因病机主要是由于年轻女子阴血方盛而阳气未充且心脾不足；或精神不畅，肝气郁滞而化火、生痰、成淤；或忧思抑郁损伤心脾，聚湿生痰；或奇经受损，气滞淤阻。无论是阳气不足还是实邪淤阻，都可导致阴阳往来不和而周期性的或癫或狂。本病临证治疗，首当辨证。淤血内阻者，可选用经期癫狂协定方、十四味达营汤、八味达营汤、四味达营汤、达营片、加味桃仁承气汤等加减治疗；心脾不足者可选用甘麦大枣百合汤、人参琥珀汤等加减；心火亢盛者可用清心汤加减；痰淤阻滞者可用清痰化淤汤加减；调理肝胆可用小柴胡通调汤、调经解郁汤、逍遥调补汤等加减；调理奇经可用升冲化淤汤、降冲化淤汤加减；或益阳和阴用桂附八味龙牡汤、桂枝汤等加减。应掌握经前宜于破淤，经后宜补虚的原则相机用药方可取得理想治疗效果。二是本病在发作期精神紊乱严重难以管理者可配合用氟哌啶醇针剂 10mg/日肌注，能暂时控制其行为。三是本病中药治疗破淤药用量大多超过常规用量许多，就目前临床报道看，未见有引起经血过多等副作用，但用药时仍应慎重观察，可结合现代医学检查患者是否有出血倾向及肝肾功能障碍，以策安全。四是本病为周期发作、自行缓解性疾病，判定疗效应以下次发作情况为依据。

【方名】 经期癫狂协定方。

【组成】 三棱、莪术各 10～20g，红花 6～10g，桃仁 10～24g，丹参 10g，生大黄 10～15g，大枣 7 枚，牛膝 15g，甘草 6g。

【来源】 杨培良，陕西中医，1985，(12)：538。

【功效】 活血止癲。

【适应证】 经期癲狂(周期精神病),证属气滞血淤者。

【方药简析】 方中应用三棱、莪术、桃仁、红花活血破淤为主药;丹参养血活血宁心;大黄则增强活血之功,又可通腑泻浊;大枣、甘草甘缓和中;牛膝为引经药。全方组合使气机利,淤血行,实践证明每能收到满意的疗效。若痰淤同病,神志恍惚者加白芥子、制半夏各 10g;心悸失眠者加酸枣仁 12g,茯苓 30g;情绪偏低者加佛手花、合欢花各 10~15g;烦躁不安加黄连 6g;惊悸、幻觉者加龙齿、牡蛎、磁石各 30g。如精神症状明显者三棱、莪术可用至 20g,但精神症状控制后可将三棱、莪术减为 6g,或去三棱、莪术加当归、白芍、生地黄等养血活血之品;又如淤热明显、大便干结者可将大黄加至 30g;如月经不畅或有血块,或腹痛难忍者可将桃仁加至 24g。本组患者即使行经期间重用活血化淤药亦未出现 1 例出血不止的现象,即使已经大便溏薄的患者仍可用大黄(可将生大黄换为制大黄,取其活血之功)。杨培良等以本方为基础方按上述加减治疗经期癲狂 40 例,服药每天 1 剂,35 天为 1 疗程。在急性期可配合用氟哌啶醇针剂 10mg/日肌注,或合用氯丙嗪,总剂量每天不超过 200mg,个别病人因兴奋明显难以管理者可用电休克,1 日 1 次。结果临床痊愈 8 例(精神症状消失,内省力完全恢复,正常参加工作);显效 24 例(精神症状大部消失,内省力恢复);进步 5 例(精神症状改善,但内省力未恢复);无效 3 例(精神症状无变化)。总有效率为 93%,经随访 12 例有轻度复发。

【病案举例】 王某,女,20 岁,渔民,1984 年 2 月 29 日初诊。1 年前,夜间行船,受到惊吓,当即发呆,随后兴奋话多,吵闹打人,大笑不休,当时正值行经期,经后精神症状自动缓解。以后每月经前兴奋话多,歌笑不休,月经后都能自动缓解。近

日病情发作严重,冲动伤人,收我院治疗。诊其舌质暗红、苔黄腻、脉细数。诊为经期癫狂。证属气滞血淤,治以活血化淤法为主。拟方:三棱、莪术、桃仁、丹参、白芥子各 10g,生大黄 10g(后下),甘草、桂枝、红花各 5g,牛膝 15g,大枣 7 枚。连服 1 个月,精神症状控制,月经来潮时未见明显精神症状,唯午后潮热,梦多,舌苔薄、质红,脉细数。上方去三棱、莪术,加白芍、生地黄、酸枣仁各 10g。连服 28 帖,病愈出院,随访至今未见复发。

【方名】 十四味达营汤、八味达营汤。

【组成】 三棱、莪术、赤芍、大黄、桃仁、丹皮、丹参、柴胡、黄芩、青皮、香附各 15g,红花、龙胆草、川芎各 9g。

【来源】 周康,中华神经精神科杂志,1986,(2):114。

【功效】 破血引气,疏肝解郁。

【适应证】 周期精神病,证属淤血内阻、营血失于畅达者。

【方药简析】 十四味达营汤中以三棱、莪术相配破血行气为主药;桃仁性润可除沉痼之淤血,大黄攻逐淤血,赤芍、丹皮、丹参行淤兼凉血,川芎活血并行气,红花活血通经。诸药共辅主药以祛淤调营;柴胡、青皮、香附疏肝理气,黄芩、龙胆草清泻肝胆郁热并引药入肝经,共为佐使药。全方破血行气、疏肝解郁,使营血调畅,则心神自安。八味达营汤(三棱、莪术、桃仁、红花、大黄、赤芍、柴胡、青皮各 15g)是由本方进一步精简而成,其功效、适应证亦与本方相同。本方宜制成浓煎剂(取 100~200 剂大锅水煎 3 次,压榨取汁,集中浓缩至每剂 160ml,加防腐剂备用)。周康用本方治疗本病 44 例,结果有效 40 例(90.9%),无效 4 例(9.1%)。随访中有 8 例复发,均在首次治疗缓解后,停药 1~3 年之间,再次治疗后病情即一

直缓解长达10年未再复发。有9例仍在月经来潮期间常见有数日情绪急躁(经前紧张症)。本组病人服药后可见排便增多,未见引起月经量多及经期提前或其他不良反应。

【病案举例】 张某,16岁,女,学生,未婚,1965年6月11日因坐卧不安、猜疑、行为紊乱入院。当时诊断为精神分裂症,经胰岛素治疗17次,病情缓解,自知力恢复。停胰岛素后不到1个月,于7月12日又发病,紊乱、激惹、言语增多,再予电休克及氯丙嗪治疗,2周后病情又缓解,至8月12日再发病,续作电休克治疗仍不能控制,1周后,病情自行缓解,于是确诊为周期精神病。改中药治疗(十四味达营汤),但9月7~9日曾一度言语增多,发作未能完全控制,仅其程度较轻,继服50剂,并用达营丸后,病情缓解,巩固2个月出院。经13年随访,除月经来潮前情绪略有波动外,未见精神症状,工作良好。

李某,女,20岁,未婚,入院前5个月每月发病1次,兴奋多言,乱找人谈话,废寝忘食,经某院诊断为躁狂症,经电休克治疗15次,及服大量多种抗精神病药物无效而入院。诊断为周期精神病,给予中药八味达营汤治疗,1个月后仍然发病,只发病日期延迟,乃停服中药,改用碳酸锂、避孕1号片、氟哌啶醇及泰尔登等治疗,仍然不能控制其发病。因此考虑初服中药时虽不能彻底阻断发作,但使发病期延长11天,可能属病重药轻。仍用八味达营汤每日2剂(煎4瓶),达营丸加倍,结果当月即得以控制。出院后3个月停药,随访4年,情况颇佳。

【方名】 四味达营汤。

【组成】 三棱 60g,莪术 60g,赤芍 30g,大黄 30g。

【来源】 孙兆庆,山东医药,1982,(12):28。

【功效】 破血行气,逐瘀除烦。

【适应证】 周期精神病,证属气滞血淤者。

【方药简析】 本方系由十四味达营汤精简而成。方中三棱、莪术合用破血行气,以除血行之淤滞;赤芍活血凉血;大黄攻逐淤血于下,釜底抽薪而除淤热于上。全方破血行气,逐淤除烦,药简而力专。孙兆庆用本方治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,18岁,两月前出现少眠少食,卧床不起和缄默,经服用氯丙嗪和中药,10天后症状消失。1月后又重复出现上述症状,且语无伦次,行为异常。到精神病院治疗,检查发现思维零乱,情感淡漠,智力差,无自知力,诊为嫁接性精神病,给予氯丙嗪,10天后症状消失。间歇7~8天上述症状又发作。入院3个月,每月发作1次,症状相同。用抗精神病药不能控制,但间歇期如正常人,改诊为周期精神病,用谷维素和四味达营汤治愈。

【方名】 达营片。

【组成】 莪术 100g,大黄 30g,赤芍 30g。

【来源】 周康,上海中医药杂志,1992,(2):11。

【功效】 攻逐淤血。

【适应证】 少女月经周期精神病,证属气滞血淤者。

【方药简析】 本方由四味达营汤进一步精简,去三棱,加重莪术用量而成。方中莪术破血行气;赤芍活血凉血;大黄攻逐淤血于下,除淤热于上。全方配伍精当,药简而力专,能逐淤除烦安神。本方所标药物份量为1日量,制成糖衣片分服。周康用本方治疗本病26例,其中有4例在第一周期即控制,下月未再发作,一切如常;有7例经第1个周期治疗后,哭泣减少,呆滞减轻;其余均连续治疗2~4个周期后病情控制,一切如常。随访5年中,有4例已考取大学,月经期、量、色、质亦趋正常。血液流变学方面,在发病时其全血比粘度、还原粘度和

血浆比粘度、红细胞压积、血沉等,均明显高于正常同年龄者,经治疗后,均较治疗前降低或接近正常。

【病案举例】 王某,15岁。幼年发育良好,个性内向,脾气温柔,少言。13岁初潮时有两夜失眠,紧张不安。月余后第2次月经来潮,又连续3天失眠,情绪紧张,经净后转正常。第3次来潮前7天,又见动作迟钝、失眠、情绪低沉、常哭泣、口臭明显。精神药物治疗9个月,仍不能控制每月发作。刻诊见接触不佳,语言减少,发音较低,吞吞吐吐,意识恍惚,口臭极重,口唇干燥且见破裂,诊为少女月经周期精神病,予本方治疗。当月即控制,以后巩固治疗1个月,未再复发,每月来潮时照常上课。1年随访,情况佳。

【方名】 加味桃仁承气汤。

【组成】 桂枝 6~12g,桃仁 10~15g,大黄 10~14g,芒硝 10~16g,甘草 10~30g,木香 6~10g,生山楂 100g,益母草 10g,丹参 30g。

【来源】 胡炜昌,北京中医学院学报,1988,(4):33。

【功效】 破血下瘀,佐以行气消积。

【适应证】 女性周期性精神病,证属瘀热互结于下焦、上扰神明者。

【方药简析】 方以桃仁破血祛瘀,大黄攻下瘀积,荡涤热邪,2味药合用,瘀热并治,共为主药;桂枝通行血脉,益母草、丹参活血化瘀,山楂消积化瘀,助桃仁破血行瘀;芒硝软坚散结,木香理气化滞,共助大黄通便泻热;甘草调胃安中,并缓和诸药峻烈之性,以为佐使。全方破血下瘀,行气消积。于月经前可加细辛 3g,每次递增 1g,直至经行方可定量,但最高不可超过 18g,经期只可将细辛用至 3g,腹胀满者可加乌药 10~30g。经后可将甘草用至 30~100g,益母草用至 30g。本方每

于月经期前 6~10 天开始服用。连续服至经血来潮。如症状消失可改用四物汤合加味乌药汤,服至经血回潮。胡炜昌用本方按照上述加减治疗女性周期精神病 300 例,结果有效 265 例,占 88.37%;而 300 例未经治疗的病人配对比较,未经治疗的自然缓解率为 19%。

【病案举例】 于某,女,24 岁。每至经期前 10 余天左右开始睡不好觉,情绪波动极大,变化无常,且有幼稚情感,傻笑难止,有时大哭,却可突然止哭大笑。有时无故大发雷霆,令人不能捉摸,动作常常幼稚愚蠢。性色彩明显,当众打自己母亲耳光,要找个对象,用手玩弄阴器,手淫,外跑夜不回家,追逐异性。言语紊乱,有时喃喃自语,难以深入交谈。幻觉内容离奇古怪,妄想荒谬而不固定,病人的动作表情常受着妄想的支配,表现出愉快或恐惧,时而出现躁动行为。诊为周期精神病。中医症见:主症如前,面有油垢,色青黄而暗,小腹胀硬痛,按之更甚,性急烦躁,口燥不欲饮,小便自利,舌质暗红有淤点,脉沉弦。于经前 5 天服本方 4 剂,经血来潮,以上症情稳定,躁动缓解。以后每月经前 1 周之内提前服本方,连续服 3 个月,经期如候,其症自解。

【方名】 清心汤。

【组成】 黄连 3g,黄芩 9g,栀子 9g,连翘 9g,薄荷 9g,生甘草 4g,芒硝 9g,大黄 6g,竹叶 9g。

【来源】 高秋松,浙江中医杂志,1986,(2):58。

【功效】 清心泻火醒神。

【适应证】 女性周期性精神病,证属心经邪热偏盛便秘者。

【方药简析】 本方中药物份量由编者所加。方中黄连清心火为主药;黄芩、栀子、连翘、薄荷、生甘草相配,以辅主药泻

火清心醒神为辅药；芒硝、大黄、通腑泻热，竹叶清心泻火利尿，使热邪得解，共为佐药；生甘草调和诸药为使药。全方可清心泻火醒神。若大便秘结不甚，可易芒硝为礞石滚痰丸。若兴奋躁动不眠可加琥珀、生铁落、朱砂、石菖蒲、远志。若淤血内结，可加丹参、泽兰、红花。高秋松用本方为基础按上述方法加减治疗本病，属心经邪热偏盛者有良效。

【病案举例】 裴某，22岁，工人，1980年8月10日初诊。因受惊吓起病，半年来每月于经前3~4日开始烦躁不安，头晕不眠，双目怒视，不知整洁，有时叫骂，打人毁物，大便秘结。曾去某精神病院诊治，诊断为周期性精神病。服药少效，改就中医。现精神正常，对答无误。近3月来经仅点滴，1天干净，色紫黑，经来少腹胀痛，发作持续1周。脉弦，舌红、苔黄。治拟清心汤加减：川连、琥珀末（吞）各3g，黄芩、炒栀子、连翘各9g，生铁落30g（先煎），竹叶心30支，朱茯苓10g，石菖蒲6g，朱远志4.5g，礞石滚痰丸（吞）、牛膝各12g，丹参20g，生甘草4g。9月15日复诊。服上药10剂后，症状大减，大便溏软，每日2次，仍烦躁少寐，目睛不活，经前2日，少腹隐痛，经来色紫。脉弦，苔薄黄。仍宗前法，上方去琥珀、朱茯苓、朱远志、石菖蒲、生甘草，加生首乌、夜交藤各30g，泽兰9g，红花3g；连翘带心用，丹参加至30g，礞石滚痰丸减为9g。服药10剂后，诸证尽除，月经经行3日，其量增加。为巩固疗效，嘱服前方加减3个周期。1985年1月随访，未见复发。

【方名】 清痰化淤汤。

【组成】 苍术、白术、竹沥、半夏、郁金、胆南星、黄芩、桃仁、丹参、牛膝各10g，全瓜蒌15g。

【来源】 涂九兰，江苏中医杂志，1981，（5）：3。

【功效】 清化痰浊，活血化淤。

【适应证】 周期精神病，证属痰热夹淤者。

【方药简析】 方中以胆南星清热化痰为主药；黄芩、竹沥、瓜蒌仁清热化痰以助胆南星之力，又以郁金理气以助化痰，共为辅药；苍术、白术、半夏健脾和胃、燥湿化痰以治生痰之源，桃仁、丹参、牛膝、活血化淤引血下行，共为佐使药。诸药合用使痰热得解，气血归经，则神志自可复常。本方在月经净后服用方合其用，并应配服礞石滚痰丸，以增强其逐痰之力。月经期间，上方去桃仁、丹参、牛膝、黄芩，加夜交藤 30g，柏子仁、朱茯苓、合欢皮各 10g，以专意于清化痰热，养心安神。涂九兰以本方为基础按照上述加减月药治疗情志所伤等原因造成脏腑气血失调，致使血不归经，与热搏结，化生痰浊，内扰心神之周期精神病有良效。

【病案举例】 张某，女，24 岁，1973 年 9 月 3 日月经初潮，而经量过多，出血不止，收入本院妇科用大量雌激素而经净出院。继以“乙黄周疗”3 个月，月经转为正常，量中等，色紫红，无血块。但每到经前即出现睡眠不实，且逐渐加重。于 1974 年来院门诊，给予清热安神，又转益肾清肝，间断治疗年余，同时在他院配用西药镇静，效果不显，病情日趋加重，每到经前 1~2 天，则胸闷烦躁，精神兴奋，昼夜不眠，话语不绝，所问能答，经净后 1~2 天又转沉默少言。曾经精神病院治疗，病情始终未能解除。给服避孕药，致人工闭经后精神如常。待停药月经来潮，则精神症状如故。于 1977 年 4 月 20 日邀余诊治，当时患者 20 岁，月经正常，正值经后，唯头昏腰酸，便干难解，面红口粘，形体稍胖，脉细数滑，苔黄厚腻，质有紫点。诊为经期癫狂。证属痰热夹淤。拟清化痰浊、活血化淤。方药：①礞石滚痰丸 5g，每日 3 次。②苍白术、竹沥、半夏、郁金、胆南星、黄芩、桃仁、丹参、牛膝各 10g，全瓜蒌 15g，连服 15 帖。在经前期，上方去桃仁、丹参、牛膝、黄芩，加夜交藤 30g，柏子

仁、茯苓、合欢皮各 10g。经净后仍服前方。连用 3 个月,5 月 15 日经潮,经前几天自觉话多,但能入睡,经净后发呆沉默,亦较前好转。7 月 18 号经潮一切正常。以后每到经前服前方数帖,巩固 3 个月。于 1978 年 5 月因经前口角,旧病复发,仍按上述治疗 3 个月病愈。随访 3 年,未再发病。

【方名】 小柴胡通调汤。

【组成】 柴胡、枳实、红花、黄芩、半夏、党参各 10g,石菖蒲、郁金各 12g,桃仁、赤芍各 6g,甘草 3g。

【来源】 宋祖慧等,四川中医 1993,(11):39。

【功效】 疏肝理气,益气化淤。

【适应证】 月经周期性精神病,证属肝郁气滞、气虚血淤者。

【方药简析】 本方系由张仲景小柴胡汤化裁而成。方中柴胡、郁金疏解气机壅滞;黄芩清解少阳之郁热;党参、甘草益气和中,调和营卫,扶正以祛邪;桃仁、红花、赤芍活血凉血,通络祛淤;更以石菖蒲芳香开窍,枳实调理气机,行气散结以宽中。综观全方:疏肝理气,益气化淤,芳香开窍。本方月经来潮前 5 天开始服用,连服 10 剂。宋祖慧等用本方治疗月经周期精神病,属肝郁气滞、气虚血淤者有良效。

【病案举例】 李某,女,16 岁。平素健康,性格内向,家族中无精神病遗传史。1988 年 3 月开始发病,表现为时而语无伦次,时而大吵大闹,并拒绝用药。继之,精神恍惚,少言寡语,问之不答,而且行为紊乱,定向不良,对外界刺激缺乏反应。重者,出现木僵状态,饮食起居、大小便全然不知。约持续 2~3 天后,木僵消失,又转入精神烦躁。4~5 天后,症状渐减。发作期间伴见半边肢体热、半边肢体冷,半边脸潮红发烫、半边苍白发冷,月经色暗、量少。曾 3 次以“狂躁型精神病”诊断,住某

市精神病医院,服用氯丙嗪、碳酸锂等药物,但效果均不理想,且病情反复发作,时轻时重,曾一度出现休克症状和碳酸锂蓄积中毒。1990年11月就诊于我院。经过详细询问病史(父母代述),根据症状,查阅有关资料,初步确诊为与月经周期有关的精神病。查病人面色黯滞,情绪抑郁,月经量少,色暗,舌质淡,脉细涩。辨证此属肝郁气滞、气虚血淤之经行情志异常证。故拟疏肝理气、益气化淤治疗。处方:柴胡、枳实、红花、黄芩、半夏、党参各10g,石菖蒲、郁金各12g,桃仁、赤芍各6g,甘草3g。水煎分2次饭后服,每日1剂。从月经来潮前5天开始服,连用10剂,同时配合服用谷维素40mg,每日3次。服药后第1个月经周期,症状有所减轻;继用2个月经周期,前述症状基本消失。以后又连续应用前方和服法治疗3个月经周期,疾病完全治愈,无任何后遗症。随访2年,未复发。

【方名】 调经解郁汤。

【组成】 柴胡5g,当归、白芍、郁金、川芎、远志、丹皮各10g,栀子、黄连、石菖蒲各6g,甘草3g。

【来源】 汪济南,四川中医,1994,(8):41。

【功效】 解热散郁,豁痰宣窍。

【适应证】 月经周期性精神病,证属肝郁化火、内扰心神者。

【方药简析】 方中柴胡、当归、白芍、郁金、川芎疏达肝郁以调郁滞之气血;丹皮、栀子、黄连苦寒泄火以清解血中之郁热,血得凉则缓,促使月经应期而下,移情易性,破其发病规律,一旦病人情绪稳定,再以桃仁、红花、牛膝等祛淤通经以调经,药后经行,出奇制胜。若神志痴呆、嗜睡者加胆南星、法半夏、鲜竹沥;若烦躁不寐者加茯神、枣仁;大便秘结者加用生大黄。药物剂量,可酌情运用。采用周期性治疗,经前发病,提前

5天服药；经期发作，提前3天服药，每天1剂，早晚煎服。王济南用本方为基础按上述加减治疗月经周期性精神病2例，均获良效。

【病案举例】 董某，女，16岁，学生，1979年2月3日初诊。患者半年前因月经来潮时精神受刺激后产生错乱，轻则自言自语，独自游走，重则如痴如癫，语无伦次。赴某地精神病医疗队诊治，拟诊为“反应性精神分裂症”。后又经某精神病院诊为“月经周期性精神病”。先后服用氯丙嗪、氟哌啶醇等药，症状有增无减，每值经期精神紧张时，抑郁与烦躁则相继而作。或心烦不寐，夜甚于昼；或呆若木鸡，茶饭不思。经后症状好转，仍精神恍惚，郁郁寡欢，视其外表，体盛丰满，脉弦而数，唇朱舌绛。诊为经期癫狂。辨为肝郁化火，内扰心神。投以调经解郁汤加减：醋柴胡、丹皮各6g，当归、白芍、郁金、远志各10g，月季花、炒栀子各6g，石菖蒲、黄连、甘草各5g，生地黄10g。按疗程先服10剂。药后复诊诸恙略有改善，夜已能眠，家属见药已奏效又自服10剂，月经愈期未至，患者虽面有笑容，仍感头晕乏力，胸闷不展，脉细弦，舌绛朱唇依然，再宗原方出入：柴胡、郁金、远志、当归尾、川牛膝各10g，桃仁、益母草、制香附各10g，红花、川芎各6g，泽兰、生地各9g，服药3剂后经行，未见有复萌之兆，后加用麦门冬、朱茯神以宁神，共治3个疗程，经追访，患者已恢复正常学习。

【方名】 逍遥调补汤。

【组成】 柴胡10g，当归10g，白芍10g，茯苓10g，炒白术10g，甘草6g，黄芪15g，枸杞子15g，续断10g，制香附30g，陈皮10g。

【来源】 周皓，江苏中医，1994，(2)：20。

【功效】 健脾益肾调肝。

【适应证】 经前紧张综合症,证属肝郁脾肾不足者。

【方药简析】 本方系由逍遥散化裁而成。方中以逍遥散疏肝解郁、健脾养血;黄芪以益气助脾之健运;枸杞子、续断补益肝肾;香附、陈皮理气解郁。全方健脾益肾调肝。周皓用本方治疗经前紧张综合征 47 例,结果治愈(各种症状均消失者)率 64.5%,好转(各种症状减轻或部分症状消失者)率 31.2%,总有效率 95.7%。

【病案举例】 荣某,20 岁,未婚,1982 年 2 月 19 日初诊。近 2 年来每次月经来潮前 1 周即觉两乳房饱满作胀触痛,伴烦躁易怒,腰酸,神倦乏力,食欲不振,月经来前症状更甚。经行第 1 天少腹胀痛伴作恶,常需服止痛片,经行后诸症减轻,渐自消失。月经 14—6/28—30。末次月经为 1982 年 2 月 13 日,色黯红,有小块,量较多。苔薄,舌淡红,脉细弦。经西医妇科诊断为经前期紧张综合征。治拟健脾益肾调肝法,予基本方 7 剂,每日 1 剂,水煎分服。嘱下次经后第 5 天复诊。3 月 21 日复诊:病史如前,末次月经 3 月 15 日,6 天净,色鲜红,无块,量中等,经来除少腹稍有作胀外,无其他不适症状,苔脉如前,原方再进 7 剂,巩固疗效。

【方名】 甘麦大枣百合汤。

【组成】 淮小麦 30g,大枣 10 枚,熟地黄 10g,百合 15g,龙齿 20g,珍珠母 30g,当归 10g,白芍 12g,远志、酸枣仁、柏子仁各 10g,茯神 12g,甘草 5g。

【来源】 赵祖文,辽宁中医杂志,1986,(6):31。

【功效】 养心安神,补血缓急,镇潜浮阳。

【适应证】 周期精神病,证属心脾两伤者。

【方药简析】 方中以仲景甘麦大枣汤养心安神,百合地黄汤滋阴养肺共为主药;当归、白芍补血,酸枣仁、柏子仁、茯

方治周期精神病属心脾两虚、痰蒙心窍者有良效。

【病案举例】 刘某,女,16岁,中学生。幼年活泼好动,13岁天癸至,月事先后不定期。每逢月信前少腹拘急精神紧张。翌年后性格变内向,少言寡语。1989年8月信将近,出现神志恍惚、表情淡漠,自语,愿自居一室,善悲欲哭。值经前3日神呆,不思饮食。某市医院诊为“周期性精神病抑郁症”,经后好转。刻下值经前6至7日发作,当地踵见数医延治效不显。1990年3月16日张师诊治,舌体胖有齿印,苔薄白,脉沉。此经前志乱,属心脾血虚,痰蒙心窍。拟宁心定志,安神祛痰法。处以人参琥珀汤,水煎,经前连服10剂。本方加减出入40帖病瘥。

【方名】 降冲化淤汤。

【组成】 生牡蛎、龟板、炙鳖甲各30g(先煎),丹参、麦门冬、山茱萸各15g,钩藤20g(后下),莪术、郁金、三棱各12g,石菖蒲6g。

【来源】 姚寓晨,中医杂志,1985,(5):140。

【功效】 镇固奇经,化淤宁心,潜纳虚阳。

【适应证】 周期精神病,证属肝肾不足、冲任失守、淤浊肝风上扰者。

【方药简析】 方中以生牡蛎、龟板、鳖甲、山茱萸合用以镇固奇经,降冲脉之逆;丹参、三棱、莪术活血化瘀;郁金理气解郁;麦门冬养阴清心;钩藤熄风止痉;石菖蒲醒神宁志。全方可镇固奇经,化淤宁心,潜纳虚阳。本方可在发病前2天开始连服5剂,经后见肝肾不足者,改为调冲佐以和营,药如:山茱萸、炙龟板、生地黄、熟地黄、当归、枸杞子、牛膝、赤芍、白芍、川芎、香附等连服10剂。姚寓晨用本方治疗周期精神病,兴奋、好动、急躁见证者有良效。

【病案举例】 高某,女,20岁,1981年6月20日初诊。患者14岁月经初潮,周期准,量少。17岁时遇事不遂,逐渐出现每次月经来潮前10日即表现为情志兴奋,烦躁易动,时有哭笑,心悸不宁,神志恍惚,心怀疑窦。并多次无目的外出,但无人格缺损,上述情况每月出现,症状基本相同,经后神志如常。西医诊为“周期性精神病”。曾用防风通圣散、失笑散、礞石滚痰丸治疗均无佳效。顷诊:病起2天,近3月来,月经淋漓不净夹有血块,腹胀刺痛,腰脊痠软。每届经前10日左右即感颜面潮红,周身烘热,口干咽燥,健忘恍惚,心神不宁,惊悸难寐,躁动不安,甚则呓语神糊,不能自持。苔薄微黄,舌质暗红,脉弦小数。责之肝肾不足,冲任失守,淤浊夹肝风上扰清窍,拟予镇固奇经,化淤宁心而潜虚阳。处以降冲化淤汤4剂。上方服后,神清寐安。1周后月经来潮,量少、色紫暗,有血块,腰脊痠软,少腹胀痛兼见心悸肉瞤,舌质偏红苔薄,脉细弦。刻下奇经宜养,血脉宜通,拟予育阴和营参用理气调冲之品。药如山茱萸肉、炙龟板、生地黄、熟地黄、当归、赤芍、白芍、川芎、枸杞子、柏子仁、制香附、怀牛膝等出入调治,于经后连服10剂。嗣后在发病前服第1方5剂,两方如法连服3月,经前症状业已控制,月经如常,惟每次经行仍感头昏口干,经量较少,嘱以杞菊地黄丸、当归丸交替服用1月而愈。随访1年,未再复发。

【方名】 升冲化淤汤。

【组成】 紫石英24g(先煎),巴戟天、肉苁蓉、丹参各5g,肉桂5g(后下),鹿角片、三棱、莪术片、制香附各12g,白芷5g,陈皮6g。

【来源】 姚寓晨,中医杂志,1985,(5):14。

【功效】 温补奇经,化淤通脉,升冲开窍。

【适应证】 周期精神病,证属冲任虚亏、气滞淤凝者。

【组成】 桂枝、白芍、生姜各 9g,甘草 6g,大枣 12 枚,龙骨、牡蛎各 9g。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 益阳和阴,镇心安神。

【适应证】 月经周期性精神病,证属心肾阳虚、冲任虚寒者。

【方药简析】 方中以桂枝配白芍益阳和阴为主药;生姜行散助桂枝益阳,大枣、甘草补中可助白芍和阴,共为辅药;龙骨、牡蛎镇心安神为佐;甘草又可调和诸药为使。全方有益阳和阴、镇心安神之效。彭景星以本方加朱茯神、酸枣仁、橘红、半夏、旋复花、石菖蒲为基础方,将月经周期性精神病辨为 2 型,虚证加附子、仙茅、仙灵脾,或当归、菟丝子、海螵蛸、茜草、牛膝等;实证加益母草、桃仁、酒大黄、泽兰、当归等。治疗本病有良效。

【病案举例】 徐某,36 岁,1980 年 4 月发病,时哭时笑,语言颠倒,或昏昏欲寐,随月经周期发作,仅经期后平静 20 余日,经来病如故,甚为苦恼。1981 年 3 月及 8 月,曾两次去某精神病院,均诊断为“癔病”而给药回家。服药多时,乏效。于 1982 年 4 月来我处就诊。患者面浮色晦,四肢不温,喜欠伸,咽中如有物梗塞,舌淡苔薄白,脉沉细。月经量中等。19 岁结婚,20 岁初产,正产 4 胎,流产 1 胎。近 1 年经量渐减。末次月经 2 月 15 日,量更少,1 日即净。停经两月余,经妇科检查非孕,诊属经期癫狂。属心肾阳虚冲任虚寒,胞宫失养。拟温补心肾,调冲任。处方:桂枝 10~15g,白芍、茯神(朱拌)、酸枣仁各 15g,甘草、法半夏、旋复花(包)、生姜、牡蛎各 30g(先煎),石菖蒲 6g,橘红 8g,大枣 3 枚,6 剂。药后,四肢转温,咽中如有物梗塞及喜欠伸等症状未除,精神仍抑郁。按上方去大枣、甘草,制附子改为 6g,另加淡豆豉、射干各 10g,通草、郁金各

5g。服 15 剂后，咽中梗塞感除，月经尚未通。按初诊方去仙灵脾、仙茅、附子，加当归、菟丝子、海螵蛸、茜草、牛膝各 15g，两天服 1 剂，连服两月。月经行，仅感心悸多梦，续予归脾汤合甘麦大枣汤加减，调理善后[彭景星，新中医，1983，(12)：28]。

51

反应性精神障碍

反应性精神障碍是由急剧而紧张或缓慢而持久的精神刺激引起的以精神症状为突出表现的应激反应。在我国本病占各类精神病的3%~4%。发病年龄多在16~45岁之间,女性多于男性。按反应的时间因素可分为急性心因(应激)反应(在遭遇到强烈精神刺激之后数分钟至数小时内起病,常表现为精神恍惚,意识范围缩小,注意力不集中,定向困难,对周围事物理解困难,盲然行动,神游症状,昏睡木僵状态,感知觉迟钝,情感淡漠、麻木、抑郁、焦虑、惊恐,运动减少,呆滞,肌肉紧张,社会性退缩,坐立不安,无目的徘徊,活动过度,心跳、多汗,面部潮红,假性痴呆。病程短暂,数小时至数日内症状即可缓解,特别是离开刺激源后,症状迅速消失,对发生的情况部分或完全遗忘),急性反应性精神病(除急性心因性反应的症状外,还表现联想松弛,喃喃自语,片断妄想与幻觉,行为紊乱,怪异姿势,自杀或攻击行为,记忆与定向障碍,病程数小时到1个月不等,最终完全缓解),迁延性心因(应激)反应(在精神刺激事件发生后数周至6个月以内发病,反复呈现的与事件有关的应激性体验闯入到意识中萦绕不云,甚则恍如身临其境,出现错觉、幻觉;或出现对创伤性事件的心理性遗忘,对周围环境普通刺激反应迟钝,情感麻木,社会性退缩,对以往爱好失去兴趣,不愿接触人,对前途感到渺茫、失望,悔恨自责,注意力不集中,难入睡而易醒转。病程持续1月以上,可达数年,症状严重程度有波动性),心因性妄想(有急性妄想反应

与迁延心因妄想症两种。前者病程在数周至数月内即缓解,后者以多年不愈为特征,可表现为敏感多疑、关系妄想或被害妄想,有的可出现幻听等幻觉,妄想包含现实性,具体内容与心因紧密相关,如不涉及妄想内容一般生活行为与社会接触保持良好)。以上4种情况中的症状可以以某一方面为主出现也可混合出现。本病应与癔症,反应性抑郁症,精神分裂症相鉴别。本病治疗包括改变或转移环境,与刺激脱离接触,支持性心理治疗,镇静安眠类药物治疗,保证营养与日常生活需要,注意安全和护理。

反应性精神病见于中医的癫狂、百合病、脏躁。其病因病机是由于素体为不稳定素质者,暴受惊恐、羞愤等精神刺激,导致气机逆乱化生痰火淤血,上扰于神明而为急性心因性反应或急性反应性精神病;或意外精神创伤忧思郁结化火,耗伤阴血,热伏血中,阴不潜阳,迫及神明,发为迁延性心因反应。一般急性反应性精神病多属实证,迁延性心因反应多为虚证,但临床上多有虚实错杂者宜注意辨识。本病治疗首当辨证。痰火上扰者用礞石滚痰丸加減;痰气郁结者用荡痰汤,或涤痰解郁汤加減;痰火互结者用温胆汤、温胆安神汤、加味安神汤等加減;痰淤互结者用涤痰祛淤汤加減;肝郁化火,痰火交阻者用柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡龙牡铁落汤加減;真阴不足、营血郁热者以防己地黄汤加減;偏于心肺阴虚者以百合知母一贯煎加減;偏于肝肾阴虚者以龙齿芍贝一贯煎加減;肝寒脾虚者用吴茱萸汤加減。二是在药物治疗的同时,应尽量使患者离开受刺激的环境,做好基础护理予以支持疗法。三是恰当的疏导与安慰,消除其紧张不安等情绪反应,说明疾病本质并对预后做适当的保证,使患者正确认识和对待致病的精神因素,促使病情向好的方面转化。本病给予支持性心理治疗,常可收到不药而愈的效果。如《续名医类案·癫狂》记载,汪石山治一解

差,因犯人投河而死被告索骗威逼犯人致死,后虽脱罪,“未免费财,忧愤成病,如醉如痴,谬言妄语,无复知识。诊之日:此人费财而忧,……令其熔锡作银数錠,置其侧,病者见之果喜,握视不置,后病遂愈。”

【方名】 礞石滚痰丸。

【组成】 青礞石 35g,沉香 5g,黄芩 15g,大黄 10g,茯神 20g,朱砂 2g(研末冲服)。

【来源】 朱丹溪,丹溪心法,引王隐君方。

【功效】 降火逐痰,安神定志。

【适应证】 反应性精神病,证属痰火上扰者。

【方药简析】 方中礞石为君,其性燥悍重坠,善能攻逐陈积伏匿之老痰;大黄苦寒,荡涤实热,开痰火下行之路;以黄芩泻火,清上焦气分之热;沉香降气,乃治痰先顺气之理;茯神、朱砂镇静安神。全方降火逐痰,安神定志。因本病一般来势急骤,故改丸为汤,以荡涤痰热。若病情急骤,狂乱无知,逾垣上层,气力逾常者加生铁落、橘红、石菖蒲、远志等镇心涤痰、清泻肝火药;病两周后其势渐减,疲惫不堪,多言善惊,时而烦躁者减大黄,加生地黄、麦门冬、玄参、黄连、炒枣仁、甘草等滋阴降火,安神定志药。肖桂宏以本方为基础按上述方法加减用药,治疗本病 10 例,其中 4 例服药 5 剂痊愈,5 例服药 10 剂痊愈,1 例服药 10 余剂效果不显著,配合小剂量安定剂和心理治疗 3 个月后,症状基本消失。

【病案举例】 张某,女,36 岁,农民。患者 4 天前与他人吵架,随即出现狂躁易怒,打人骂人,躁扰不安,狂言乱语,夜不能寐。诊断为反应性精神病。中医症见:主症如前,目赤面红,4 日无大便,小便黄赤,脉象滑数,舌质红,苔黄腻。处方以青礞石 35g,沉香 5g,黄芩 15g,大黄 10g,茯神 15g,生铁落

【方名】 涤痰解郁汤。

【组成】 制半夏 15g, 广陈皮 10g, 茯苓 15g, 甘草 10g, 炒枳实 10g, 陈胆南星 10g, 天竺黄 10g, 石菖蒲 8g, 郁金 15g, 瓜蒌 15g, 大贝母 10g, 礞石滚痰丸 15g(包煎)。

【来源】 王应模, 江苏中医, 1995, (7): 3。

【功效】 涤痰解郁, 开窍醒脑。

【适应证】 反应性精神病, 痰郁见证者。

【方药简析】 方以燥湿化痰的二陈汤配以破滞降逆的枳实以化痰降逆为主; 胆南星、天竺黄清化痰热, 石菖蒲开窍醒脑, 郁金行气化痰, 瓜蒌、贝母化痰清热, 滚痰丸降火逐痰, 在方中共为辅佐以清降郁积之老痰。全方涤痰解郁、开窍醒脑。若胆怯喜惊者加炙远志、琥珀末; 哭笑交替失常者加灵磁石、飞铁落; 狂躁不安者加羚羊角粉、代赭石、川黄连。梅九如以本方为基础方按上述加减用药治疗本病多例, 有良效。

【病案举例】 陆某, 男, 13岁, 1991年7月2日诊。患者9天前因不慎脚踏一蛇, 突遭其缠绕腿上, 受惊恐继而神志失常, 心神不安, 夜不入寐, 易惊悸, 语无伦次, 整天乱说乱动乱跑。家人一不注意, 不知跑向何处。问其何故? 回答言语不清, 表情烦躁, 纳谷尚可。诊断为反应性精神病。经使用安定、奋乃静等药, 疗效不显。中医症见, 主症如前, 苔薄腻, 脉弦细。证属肝胆郁热挟痰, 突受惊恐, 痰蒙清窍所致。拟涤痰解郁, 开窍醒脑法。予涤痰解郁汤加炙远志 6g, 琥珀末 4g(分吞)。5剂服后言语清楚, 精神安定。再服5剂, 思维活动如常, 随访半年未复发。

【方名】 温胆汤。

【组成】 半夏 12g, 竹茹 12g, 枳实 12g, 陈皮 15g, 茯苓

15g,生姜 24g,甘草 6g。

【来源】 孙思邈《备急千金要方》。

【功效】 燥湿化痰,清热除烦。

【适应证】 反应性精神病等,证属痰淤蔽窍者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中以半夏、陈皮燥湿理气化痰为主;伍入竹茹清热化痰,枳实破滞降逆散淤,后世增入茯苓更有助于燥湿化痰,共为辅药;生姜制半夏之毒,助半夏、陈皮、枳实行气消痰为佐,甘草调和诸药为使。全方燥湿化痰,清热除烦。刘国升以本方为基础方加炒香附、郁金、丹参、远志,若火盛者再加黄连,气滞者再加木香,治疗本病有良效。

【病案举例】 王某,女,17岁,学生,1988年11月17日初诊。患者两月前因于惊恐而发精神恍惚、胆怯疑虑、渐致夜不安寐、哭笑无常,喃喃独语而来诊。诊断为反应性精神病。中医症见:主症如前,其舌质略红、舌尖有淤点、舌苔薄腻、脉象沉弦。证属气机逆乱,痰淤蔽窍。治当理气化痰活淤为主。处方:清半夏、炒香附、石菖蒲、郁金、竹茹各 10g,炒枳实、生甘草、远志各 6g,丹参 15g,茯苓 12g,陈皮 9g,黄连 4g。服 5 剂症减,继以上方去黄连加木香 6g,续服 5 剂而愈。随访半年,不曾复发[刘国升,陕西中医,1994,(12):548]。

【方名】 温胆安神汤。

【组成】 陈皮 10g,半夏 10g,枳实 10g,竹茹 10g,朱茯神 20g,龙齿 20g,磁石 20g,石菖蒲 10g,远志 10g,天竺黄 10g,羚羊角粉 3g(冲服)。

【来源】 王澍,黑龙江中医药,1991,(2):25。

【功效】 清心泻火,化痰开窍,镇静安神。

【适应证】 反应性精神障碍,痰火互结见证者。

【方药简析】 方中半夏、陈皮、茯苓、甘草和中燥湿，理气化痰；配入竹茹清热化痰；枳实破滞降逆散淤；茯神、龙齿、磁石镇静安神；石菖蒲、远志、天竺黄开窍化痰；羚羊角粉平肝清热定惊。诸药共奏清心泻火，化痰开窍，镇静安神之功效。王澍用本方治疗反应性精神病属惊恐气乱，痰火互结，内犯心包者有良效。

【病案举例】 夏某，男，20岁。10天前因车祸，撞伤人命，患者当时受惊即昏倒不省人事，醒后则意识迟钝，沉然少语。近日来举动失常，言语错乱，不食不寐，目赤直视，日益增重。身体健壮，无精神病史。诊断为反应性精神障碍。中医症见：主症如前，苔黄腻脉沉滑，证属惊恐气乱，痰火互结，内犯心包。方药：朱茯神、龙齿、磁石各20g，枳实、竹茹、陈皮、远志、石菖蒲、天竺黄、制半夏各10g，羚羊角粉3g（冲服）。服药3剂，神志渐清，问之能答，再进原方共15剂一切复常而愈。

【方名】 加味温胆汤。

【组成】 橘皮15g，半夏10g，茯苓15g，枳壳15g，竹茹10g，柏子仁15g，炙远志15g，枣仁15g，石菖蒲15g，天竺黄15g，青礞石15g，黄连10g，甘草10g，朱砂5g（冲服）。

【来源】 肖桂宏，黑龙江中医药，1991，（6）：23。

【功效】 养心安神，助脾益血。

【适应证】 由精神刺激所引起的癫症，证属心脾两虚者。

【方药简析】 方以温胆汤清化痰热，温和胆腑，助其决断之功能；加柏子仁、炙远志、炒枣仁养心安神；石菖蒲、天竺黄、青礞石豁痰开窍醒神；黄连清心安神、朱砂镇心安神。全方养心安神、助脾益血。肖桂宏以本方为主治疗本病有良效。

【病案举例】 翟某，女，22岁，店员。自诉：20天前夜间受意外惊恐后，心悸易惊，神思恍惚，魂梦颠倒，头晕，少寐，心

【组成】 柴胡 12g, 龙骨、黄芩、生姜(切)、铅丹、人参、桂枝(去皮)、茯苓各 4.5g, 半夏 4.5g, 大黄 6g, 牡蛎 4.5g, 大枣 6 枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 调肝胆, 利枢机, 除痰热, 潜亢阳。

【适应证】 反应性精神障碍, 证属肝郁化火、痰火交阻者。

【方药简析】 方中以小柴胡汤和解少阳, 疏泄肝胆; 桂枝、茯苓通阳健脾, 调和中州; 龙骨、牡蛎潜亢阳、镇心神; 铅丹镇惊敛神, 有除热坠痰之效; 大黄导滞泻热, 意在釜底抽薪。全方融和解, 宣泻、通调、升降于一体, 坠痰扶正, 调整阴阳。陈未娟以本方去铅丹、桂枝, 加朱砂、麦门冬、僵蚕、石菖蒲治疗本病有良效。

【病案举例】 许某, 女, 32 岁, 1980 年 10 月 18 日初诊。主诉: 数天前因家中失火, 导致心悸失眠、恐惧不安, 继而头痛时作, 病势较剧, 有时语言错乱、纳呆腹胀, 胸胁胀闷不舒, 大便 3 天未解, 小便短赤。查患者: 体温 37.5℃, 唇舌色黯红、苔薄黄, 脉细弦略数, 表情淡漠, 对答尚好, 心肺正常。诊为反应性精神障碍。证属情志所伤, 气机逆乱, 肝郁化火, 痰火交阻, 内扰心神。治宜疏肝解郁、清热化痰、安神定志。用柴胡加龙骨牡蛎汤化裁。处方: 柴胡、法半夏各 6g, 牡蛎、龙骨 30g, 黄芩、大黄(后下)各 12g, 茯苓 18g, 朱砂(冲)2g, 麦门冬 15g, 僵蚕 10g, 石菖蒲 5g。二诊: 服上药 2 剂, 大便通, 诸证均减。照上方大黄改为 6g 同煎, 再加入党参 15g, 连服 6 剂而愈[陈未娟, 新中医, 1986, (2): 31]。

【方名】 柴胡龙牡铁落汤。

【组成】 柴胡 10g, 龙骨 30g, 牡蛎 30g, 黄芩 12g, 制半夏

10g,生大黄 10g,丹参 12g,茯苓 30g,桂枝 6g,石菖蒲 30g,生铁落 30g,大枣 7 枚,生甘草 3g。

【来源】 杨培泉,山东中医杂志,1984,(3):24。

【功效】 上透下达,开结散邪,重镇安神。

【适应证】 反应性精神病等,证属气滞邪郁化火者。

【方药简析】 本方系由张仲景柴胡加龙骨牡蛎汤化裁而成。方中既有柴胡之轻清,又有铁落之重镇,黄芩之苦寒,桂枝之辛温,半夏、石菖蒲之辛散,龙骨、牡蛎之敛阴潜阳,丹参、大枣、甘草之益气和营,生大黄之泄热攻下。全方寒热并用,攻补兼施,共奏上透下达、开结散邪、重镇安神之功。如气郁日久化火、大便秘结者,则生大黄可用至 10g~30g 不等;素体脾胃虚弱者,则龙骨、牡蛎、铁落不可过量,以免碍胃滞气,以 15g 为宜,过轻则影响疗效;心悸失眠明显者,加酸枣仁 12~30g,首乌藤 30g;胸闷为主者,加厚朴花 10g,佛手花 10g,降香 6g,瓜蒌 15g;呃逆加丁香 10g,代赭石 20~30g;痰多者加陈皮 6g,胆南星 10g,白芥子 10g;食欲不振,加砂仁 6g,生麦芽 30g;头痛明显者加石决明 30g,钩藤 15g;遗精加芡实 10g,莲须 10g;白带多者,加椿根白皮 15g,土茯苓 15g;月经不调者,加当归 10g,白芍 10g,红花 6g。一般 30 天为 1 疗程,最长 90 天,最短 14 天。杨培泉以本方为基础方,按上述加减用药,治疗郁证(包括反应性精神障碍、癔症、更年期精神病、神经衰弱)35 例。治疗结果:症状消失者为痊愈,计 15 例,占 42%;症状基本消失有复发者,为显效,计 10 例,占 29%;症状部分消失为有效,计 9 例,占 26%;症状无变化 1 例,占 3%。

【病案举例】 蒋某,女,20 岁,农民,于 1983 年 3 月 18 日急诊。患者于 2 天前,路遇流氓,意欲强奸,当即昏倒在地,被过路人送进第四人民医院门诊,诊断为癔病,服安定剂、补液,症状未减,故转我院。其证心悸,胸闷,烦躁,神志恍惚,口

中不断发出“哼哼”声，两目紧闭，时而哭叫，两手紧拉母亲的衣服，西医诊为反应性精神病。面色潮红，大便两天未行，小溲黄赤，舌质红，苔灰腻，脉弦数。中医诊为郁症。病机乃惊恐所伤，惊则气乱，郁结化火，上扰清窍所致。治法：镇惊泻火、解郁开窍。方用柴胡加龙骨牡蛎汤加减：柴胡 10g，龙骨 30g，牡蛎 30g，大黄 15g，茯苓 30g，黄芩 10g，丹参 12g，黑山栀 10g，制半夏 10g，石菖蒲 30g，生铁落 30g，生甘草 3g。日 1 剂，水煎服。上方服 7 剂后病情大减，神志清醒，夜寐尚可，大便通畅，舌质红，苔薄腻，脉细数，惟仍心悸，恶梦。继用上方加减：柴胡 6g，龙骨 30g，牡蛎 30g，石菖蒲 20g，生地黄 15g，百合 30g，酸枣仁 12g，淮小麦 30g，大枣 10 枚，生甘草 10g。继进 14 剂，病体得康，随访半年，未见复发。

【方名】 防己地黄汤。

【组成】 防己 3g，防风 9g，桂枝 9g，甘草 3g，生地黄 150g。

【来源】 张仲景《金匱要略》。

【功效】 益养阴血，疏散郁热。

【适应证】 反应性精神障碍，营血郁热见证者。

【方药简析】 本方重用生地黄益阴清热、养血固本为主；防己、防风、桂枝轻清升散以泄郁热为辅。对真阴不足，营血郁热，逼及神明之证可收益阴养血、疏散郁热之效。先将生地黄除外的全部药物放入黄酒中浸 12h 左右，然后将药捣烂，加开水 150ml，将药汁滤出绞尽。再取生地黄 150g，浓煎取汁（忌用铁器），两煎混匀，然后兑入上药所取之汁，混合分早、中、晚 3 次温服。丁德正以本方按上述方法用药治疗本病有良效。

【病案举例】 薛某，女，35 岁，1972 年 5 月 6 日初诊。患者发病已 1 月，缘其独生子落水溺死，先号啕痛哭，昼夜不眠，

渐致精神失常谓其子未死,仍于河畔嬉戏,故昼夜行于河畔不归,时而谓已闻孩子叫“妈妈”之声,而欣喜若狂,且唤且找,时而双目呆滞,沉闷沮丧,泣诉有声。诊为反应性精神障碍。中医症见:主症如前,诊其脉细数,舌质红绛,无苔,双目微红。此乃忧思伤心,心血耗竭,心经蓄热,郁热无泄,逼及神明所致。投上方服1剂,狂痴之状顿失。又以生地黄、麦门冬、柏子仁等滋阴血安神之品数剂,继服以巩固[丁德正,河南中医,1984,(5):31]。

【方名】 百合知母一贯煎。

【组成】 北沙参 30g,生百合 30g,生地黄 15g,栀子 12g,麦门冬 15g,知母 12g,川楝子 10g,白茅根 30g。

【来源】 孙继芬等《黄河医话》。

【功效】 清心养肺,滋补肝肾。

【适应证】 反应性精神障碍,证属阴虚内热者。

【方药简析】 本方系由百合知母汤合一贯煎加减而成。意外精神创伤,忧思过度,郁结化火,阴血暗耗,热伏血中,心肺阴虚内热,故以仲景百合知母汤清养心脾之津;子盗母气,心病可及肝,肝病可及肾,精神创伤迁延日久,必致肝肾精血不足,故合一贯煎滋补肝肾之阴;方中配栀子、白茅根加强清热凉血之效。全方清心养肺、滋补肝肾。阴虚内热甚者可加清骨散;若见善太息、悲伤欲哭者加甘麦大枣汤。刘茂林以本方为基础方,按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 邱某,女,已婚。半月前,患者丈夫在“渤海2号事件”中罹难。患者奔赴现场,悲痛欲绝,数次晕倒在地。事后昼则食少,夜不成寐,整天默默无言,时常欲卧又起,欲行又止;近来时而思水,复不能饮;象是怕冷,又不欲衣;意欲食,又不能吃。刻诊见:表情淡漠,精神恍惚,沉默寡言,面色晄白,

两颧潮红,头晕目眩,心惊耳鸣,口苦咽干,尿少尿黄,时时自汗,唇舌有小疮,舌红缺津,脉弦细微数。诊断为百合病。断为由意外精神创伤、忧思过度致郁结化火,阴血暗耗,阴虚内热,热伏血中,以心肺阴虚内热为主要病理变化。治以清心养肺、滋补肝肾。处方:北沙参 30g,生百合 30g,生地黄 15g,栀子 12g,麦门冬 15g,知母 12g,川楝子 10g,白茅根 30g。上方连服 9 剂后精神、语言、饮食均好转,脉转和缓,舌上生津,疮疡已愈,惟有头晕,少眠,自汗;又见善太息、喜悲伤欲哭。以前方去白茅根加浮小麦 10g,大枣 10 枚,白芍 15g,炙甘草 6g。连进 12 剂,诸症悉愈。后嘱服天王补心丹以善其后。

【方名】 龙齿芍贝一贯煎。

【组成】 沙参 9g,生地黄 12g,炒川楝子 9g,生白芍 12g,枸杞子 9g,川贝母 9g(冲服),青龙齿 24g,青箱子 24g,珍珠母 24g,钩藤 9g。

【来源】 王渭川,《王渭川疑难病症治验选》。

【功效】 滋养肝肾,养阴潜阳。

【适应证】 反应性精神障碍,阴虚阳亢见证者。

【方药简析】 精神因素致忧思郁结,耗伤营阴,阴不潜阳,阳气偏亢。方中一贯煎,滋养肝肾为主;以青龙齿、青箱子、珍珠母、钩藤潜阳为辅佐;川贝母助枸杞之滋养肝肾;生白芍酸敛以补血。若纳减者,可加鸡内金、槟榔、木香以化积和胃,气郁不舒可加佛手以理气解郁。全方滋养肝肾、养阴潜阳。王渭川以本方为基础方按上述加减用药,治疗迁延性心因性反应、阴虚阳亢见证者有良效。

【病案举例】 陈某,女,46 岁,农民,1975 年 6 月 20 日初诊。患者因长子游泳淹死后心乱失眠,悲伤即哭。其爱人百般劝慰,亲友相问概不理睬。有时彻夜不眠,开门外出,须臾返

回,闷闷无语,已历数月之久。家人亲友苦劝就医不去。月经紊乱,渐至量少或数月一行,点点滴滴而已。忽闻长女产子抱外孙,次子又考进中学读书,因而转忧为喜,其爱人乘机带来就诊。诊断反应性精神障碍。中医症见:主症如前,刻诊见失眠,少食,耳鸣,面容极端愁苦,舌质红绛,脉弦细而数。治以滋养肝肾,佐以潜阳。处方:沙参 9g,生地黄 12g,炒川楝子 9g,生白芍 12g,当归 9g,枸杞子 9g,银柴胡 10g,川贝母 10g(冲服),青箱子 24g,珍珠母 24g,青龙齿 24g,钩藤 30g,槟榔 6g,鸡内金 10g,木香 6g。1 周服 6 剂,连服 2 周后病情好转,愁苦忧思大减,食欲增健,能睡,心惊自汗减轻,舌质淡红,苔薄,脉弦缓。仍以上方加减为:炒川楝子 10g,生白芍 12g,鸡内金 10g,淮山药 24g,金樱子 60g,佛手 6g,又服半月,诸症悉解。2 月后体质转壮,健康如常。

【方名】 吴茱萸汤。

【组成】 吴茱萸 18g,党参 18g,生姜 18g,大枣 6 枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 散肝寒,暖脾胃。

【适应证】 反应性精神障碍,肝寒脾虚见证者。

【方药简析】 方中吴茱萸温肝散寒;党参健脾益气,安神定志;姜枣益脾上调和营卫。合为散肝寒暖脾胃。如服后胃脘无不适,重症病人可加大剂量至 1 倍。失眠严重者加炒枣仁、合欢花、夜交藤;胸憋满者加枳实、木香、青皮。少数病人初服有胃脘轻度不适,继续服药,反应可消失。刘景棋以本方为基础方,按上述加减用药,治疗本病有良效。

【病案举例】 方某,男,47 岁,干部,1979 年 10 月初诊。患病已 8 年。于文化大革命中遭受迫害,精神长期处于愤懑抑郁状态,久之心烦易怒,恶心,吐涎沫,巅顶痛不可忍。近两年

来病情加重,失眠多梦易惊,记忆力减退,精神恍惚,性情暴躁,多猜善疑,甚则厌世。诊断为反应性精神障碍。中医证见:主症如前,胃纳日减,体衰消瘦,气短,手足凉,出冷汗,舌质淡,苔黄厚腻,脉象左沉弦滑、右沉紧。服本方 30 剂后诸症基本消失,纳眠良好,服至 60 剂,临床治愈[刘景祺,上海中医药杂志,1982,(1):18]。

52 抑郁症

抑郁症是以情绪异常低落为主要临床表现的精神疾患，轻者可仅见抑郁心境，重者可出现精神运动抑制。此外常有自杀意向，植物神经和躯体伴随症状（早醒、便秘、厌食、消瘦、性机能减退，精神萎靡，症状昼夜起伏），妄想、幻觉等精神症状及神经官能症表现。本组病症根据发病原因及症状特点可分为神经官能性抑郁或抑郁性神经官能症（主要为持久的抑郁心境，表现为没有兴趣，没有希望，失去精力、失去自信，可持续2年以上，常伴有焦虑和躯体伴随症状，但无明显的运动性抑制与思维抑制，社会功能不受严重影响），反应性抑郁（有明确的精神刺激引起的迁延性抑郁心境，可持续数月，数年后仍可触景生情），内源性或精神病性抑郁（发病环境因素居次要地位，除抑郁心境外，还突出有言语减少，行动迟钝，晨间低潮，严重者整日卧床，吃喝需督促，甚至木僵，自杀行为突出，即躁郁症抑郁），隐匿性抑郁症（失眠、早晨嗜睡、阳痿、睡眠中有恐惧窒息感，夜间心悸、胸痛、肢体不宁、头痛耳鸣及胃肠不适，但病人否认主观情绪变化，常呈周期性病程），产后抑郁症（产褥期首次发病，与发病环境因素关系密切，但可表现为精神病性抑郁状态）等。此外还有更年期抑郁症（属更年期精神病）、精神分裂症后抑郁症等。轻度的抑郁心境用心理治疗效果较好，重度抑郁和隐匿性抑郁症需用抗抑郁药物如阿米替林等治疗。

本病属于中医郁证解体的范畴。本病的病因病机主要是

情志不舒,气机郁滞。若郁怒不畅,使肝失条达,气失疏泄,而致肝气郁结;若气郁化火则兼见肝火证候;若气郁日久,则血瘀不行;若肝郁及脾或思虑不解,劳倦伤脾,均能使脾失健运,蕴湿生痰,导致气滞痰郁,若湿浊停留或食滞不消或痰湿化热,则发展为湿郁、食郁、热郁等证;情志不遂则肝郁抑脾,耗伤心气,营血渐耗,心失所养,神失所藏可致心神不安;若久郁伤脾,饮食减少,生化无源,则气血不足,心脾两虚;郁久化火则伤阴血,可累及于肾,而阴阳失调。所以,治疗本病,首当辨证。肝气郁结者用疏肝解郁汤加减;肝郁化火者用泻火宁心汤加减,气滞痰郁者用平心忘忧汤加减;痰热上扰者用温胆汤加减;痰湿食滞不化者用精神病2号方加减;肝郁抑脾,心神失养者用逍遥安神汤、清养心脾开郁汤、甘麦大枣解郁汤、百合地黄汤加减;若久郁伤脾者用柴芍六君汤、补元解忧汤加减;若累及于肾,阴阳失调者用二仙汤加味。此外张良栋等用逍遥散加味(柴胡、当归、白芍、白术、茯苓各15g,甘草9g,薄荷3g),偏阳虚型加附子9~18g,大枣、淮小麦各45g;偏阴虚型加生地黄、麦门冬、石斛、玉竹各15g,大黄、芒硝各3~15g,代赭石、龙骨各30g。每日1剂,8周为1疗程(对有严重自杀企图的病人,只限在临睡前给予安定5~10mg或泰尔登25~100mg,病情好转后,逐渐减少),共治疗抑郁状态40例(躁郁症抑郁相10例,抑郁症30例),结果精神症状完全消失20例,精神症状大部分消失15例,症状无变化5例[上海精神医学,1990,(1):7]。

日本金子善彦等用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗抑郁状态12例(内因性10例,神经症性1例,疑为反应性1例),本剂的生药成分:柴胡17.4%,半夏14%,桂皮10.5%,茯苓10.5%,黄芩8.8%,大枣8.8%,人参8.8%,牡蛎8.8%,龙骨8.8%,生姜3.5%。剂型为颗粒状粉末,系上述生药煎剂的干燥提取

物。剂量为每日 3~7.5g。结果显效 3 例,有效 4 例,稍有效 2 例,无效 3 例;多在服药后 3~5 天出现症状改善,疗效出现较快[日本医学介绍,1981,(11):31]。

郭树昆等用温胆汤合越鞠保和丸方加减(陈皮、半夏、枳壳、竹茹、砂仁、梔子、红花、香附、石菖蒲、山楂、苍术、苏合香、冰片等)制成胶囊,每个胶囊含生药 0.45g,口服每日 2 次,每次 4~8 粒,治疗精神病 50 例(精神分裂症 20 例,神经症 17 例,忧郁症 10 例,焦虑症 1 例,心因性精神障碍 1 例,强迫症 1 例),结果:痊愈 16 例,显著进步 27 例,进步 6 例,无效 1 例,认为本方对解除精神郁闷、心烦急躁,对抗精神忧郁,促进食欲、增强精力等具有独特疗效(天津中医,1986,(5):19)。二是对本病常见的睡眠障碍合并用小剂量阿米替林可迅速改善症状,而副作用很小,一般剂量为每日 25~50mg/日。三是针灸治疗。张鸣九用头皮针治疗抑郁状态 81 例,主穴上星、神庭(上星透神庭),辅穴辨证施治:悲观厌世、疑病妄想突出加目窗透临泣,焦虑紧张、胆颤心惊、睡眠障碍加脑空透窍阴,口干、皮肤苍白、多汗、厌食加承灵透正营,强迫思维记忆减退加强间透脑空。手法与针法:平刺透穴或透经,平补平泻静留针 1~2h,可加温灸,每日 1 次,10 次为 1 疗程,第 2 疗程可改间日 1 次,第 3 疗程改每星期 3 次。一般治疗和观察时间为 3 个月,治疗结果:基本痊愈 46 例(56.7%),显著进步 28 例(35%),进步 4 例(4.3%),无效 3 例(4.0%),本法疗效好而无不良反应(中国中西医结合研究会,中国中西医结合研究会精神病专业委员会成立大会暨学术讨论会论文汇编,1987,71)。

罗和春等电针百会、印堂穴(用 G6805 治疗仪,电压(6V)电流调到患者感到舒适而穴位局部肌肉微有抽动为度,脉冲频率 80~100 次/分),每日治疗 1 次,每次 1h,6 周为 1 疗程,

轻度抑郁、焦虑，无运动迟滞症状，被动接触良好，生活自理尚佳。无绝望行为，无幻觉、妄想，内省力良好。舌苔薄腻，脉弦。诊断：抑郁性神经症。中医辨证属肝郁气滞证。治则：疏肝解郁，以疏肝解郁汤化裁。处方：柴胡 10g，合欢花 10g，郁金 10g，青皮 10g，香附 10g，白芍 10g，生麦芽 30g，枳壳 10g，茯神 30g，珍珠母 30g，鸡内金 10g，甘草 3g。二诊：上方进 10 剂后，胁肋胀痛，脘闷暖气大减，但有口干欲饮，纳食尚差，不安情绪亦见减缓。舌稍红，苔薄腻，脉弦稍数。治拟疏肝柔肝、养血宁心。处方：柴胡 10g，合欢花 10g，白芍 30g，生麦芽、谷芽各 30g，香附 10g，枳壳 10g，茯神 30g，珍珠母 30g，女贞子 10g，旱莲草 15g，炙甘草 3g。三诊：上方又进 10 剂后，焦虑不安消失，纳食亦增，社会交往增加。后以逍遥散(丸)与杞菊地黄丸交替使用以巩固疗效。随访半年，未见复发。

【方名】 泻火宁心汤。

【组成】 龙胆草 6g，柴胡 10g，白芍 10g，大黄 10g，生栀子 10g，丹皮 10g，琥珀(冲服)3g，朱砂(冲服)1g，黄芩 10g，生地黄 30g，木通 10g，甘草 3g。

【来源】 陈洪祥等，福建中医药，1994，(6)：27。

【功效】 清肝泻火。

【适应证】 抑郁性神经症，属肝郁化火型者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中以龙胆泻肝汤清肝泻火为主，并去其泽泻、车前子，以防渗利伤阴；柴胡配白芍以疏肝解郁清热；大黄、丹皮通腑泻热凉血；佐以朱砂、琥珀镇心安神。全方清肝泻火，调畅情志，则抑郁不畅自除。若头痛背痛者加蔓荆子、薄荷；情绪不稳、急躁加紫石英、地龙；肝阴不足者加重白芍至 30g，并加女贞子；夜寐不安者加酸枣仁、夜交藤等。陈洪祥等以本方为基础，按上述方法加

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血化淤，解郁化痰。

【适应证】 隐匿性抑郁症，证属气滞血淤者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血祛淤；牛膝祛淤血通血脉并引淤血下行；柴胡疏肝解郁，升达清阳；桔梗、枳壳开胸行气，使气行则血行；生地黄凉血清热，配当归又能养血润燥，使祛淤而不伤阴血；甘草调和诸药。全方不仅行血分淤滞，又能解气分之郁结，活血而不耗血，祛淤又能生新。尤亚贤用本方加远志、合欢皮为主治疗隐匿性抑郁症 68 例。服药方法每日 1 贴，20 贴为 1 疗程。病情好转者，可继服 10~15 贴以巩固治疗。同时配合服阿米替林（日量为 75~100mg）或多虑平（日量为 75~100mg），结果痊愈（精神躯体症状完全消失，情绪愉快，恢复病前劳动能力）43 例，显效（主要症状基本消失，情绪良好，能从事一般的劳动或适应日常生活）22 例，进步（症状较就诊时有所改善）3 例。

【病案举例】 李某，女，50 岁，因失眠、头痛、乏力、胃部不适、恶心呕吐而就诊于当地县医院，按“胃肠功能紊乱”治疗多年未愈，病情时重时轻。1978 年因生气而病情加重，上腹不适，不思饮食，强食则吐，体重减轻至 30kg。胃肠道多次钡透均属正常，经市区几所医院多次治疗无效，多年来未能确诊。1982 年 7 月 26 日转来我院。体检：面色无华，形体消瘦，心肺（-），肝脾未扪及，神经未见阳性体征，脑电图正常，汉密顿抑郁量表测定总分为 24 分。患者情绪抑郁而沮丧，失去治疗信心，对生活不感兴趣，多次轻生未遂，诊为“隐匿性抑郁症”。中医症见舌质淡紫伴有淤斑，脉沉迟。乃缘情志拂逆，木失条达，气机不舒而血淤致病。予血府逐淤汤加远志、合欢皮、白术、茯苓等联合阿米替林 75mg/日，治疗 1 月，诸症悉减，食欲倍

增,睡眠正常,心情愉快。宗原方加味制成膏剂,以冀进步,3个月后,体重增至50kg,终见全功。随访2年半,病情稳定[王亚贤,陕西中医,1985,(6):247]。

【方名】 逐淤解郁汤。

【组成】 赤芍 15g,桃仁 10g,红花 6g,川芎 15g,当归 12g,柴胡 15g,枳壳 8g,桔梗 12g,厚朴 10g,郁金 10g,合欢皮 12g,薏苡仁 30g,川牛膝 12g。

【来源】 郭云物等,河南中医,1993,(3):132。

【功效】 理郁行淤,除湿,舒展气机安神。

【适应证】 神经症性忧郁症,证属气血淤滞者。

【方药简析】 本方是由血府逐淤汤化裁而成。方中赤芍、桃仁、红花、川芎、当归,活血祛淤;川牛膝祛淤通血脉并引活血下行;柴胡疏肝解郁、升达清阳;桔梗枳壳开胸行气;郁金行气化痰,使气行则血行;厚朴、薏苡仁理气燥湿健脾以助气血生化之源;合欢安神解郁。全方理郁行淤,除湿,舒展气机安神。方中可加石菖蒲、远志开窍宁神,或加夜交藤、柏子仁以养血安神。郭云物等用本方为基础方,按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 郑某,男,35岁,农民。患者2年前因经济纠纷,精神受刺激引起失眠多梦等症。发病初用安定、鲁米那等可使睡眠改善。近半年来失眠加重,每晚只睡1~2h,有时整夜难眠,服用大剂量镇静剂亦难奏效,某省级医院诊断为“抑郁性神经官能症”,服用阿米替林、氯硝安定及中药黄连温胆汤,症状未得明显改善。中医诊见:失眠多梦,精神抑郁喜静少动,懒与人言,胸闷时有刺痛,纳呆腹胀,舌质暗,苔白腻而厚,脉弦带滑。中医诊断为郁证,失眠。病郁较久,久病多淤治以理郁行淤。以逐淤解郁汤出入服3剂开始逐步减西药,服

至15剂后,完全停用西药,睡眠保持在5~6h,精神紧张、胸闷症状消失。因胆囊炎改予利胆和胃善后,半月后,睡眠一直可以。

【方名】 六味达营汤。

【组成】 三棱 30~60g,莪术 30~120g,赤芍 30g,生大黄 15~30g,玄胡 30g,甘草 10g。

【来源】 韩钟博,上海中医药杂志,1994,(2):16。

【功效】 活血化淤。

【适应证】 解郁(抑郁性精神障碍),气滞血淤型。

【方药简析】 本方是由四味达营汤加味而成。方中三棱、莪术合用破血行气为主;赤芍活血凉血,生大黄同煎以缓其泻下作用而取其清热攻逐淤血,元胡活血理气止痛,共为辅药;甘草缓急,现代药理研究有抗忧郁作用,在方中为佐药。全方活血化淤以解抑郁。韩钟博用本方治疗气滞血淤型解郁(抑郁性精神障碍)9例,结果痊愈及显效者占56%;有效者占33%;无效者占11%(疗效参考钟氏抑郁自评量表(SDS)评定。抑郁分下降至55分以下,自我感觉良好,完全或基本恢复病前情绪及体力者,为痊愈或显效;抑郁分下降,情绪及体力有改善,但抑郁分未能降至55分以下者为有效;抑郁分无下降,情绪仍差,无明显改善者为无效)。

【病案举例】 李某,女,26岁,顺产1男婴,3天后开始失眠,惶惶无主,担心自己生活不能照顾,恹恹郁闷,伴幻听,耳闻责怪自己的语言,为此立遗嘱,4次自杀。门诊诊断为产后抑郁症。经住院2个半月以抗抑郁剂阿米替林及电休克(12次)治疗,病情又明显加重。精神检查:意识清,言简语迟,称“病不会好了,与其连累家人不如一死了之”,“身上一一点劲也没有,骨骨节节都松了,手也抬不起”。苔薄、舌暗,脉弦。SDS

>70分。本次月经将及期,考虑产后得病,且又反复发作,明显周期加剧倾向,治予活血化淤法。以三棱、莪术、赤芍、大黄、延胡索各30g,甘草9g,生大黄和诸药同煎,不予后下。服药2周后,情绪趋平稳,头4天大便日3~4次,4天后每日2次,无不适。续予原方,后2次月经期间病情亦有波动,但程度明显减轻。6周后病情基本稳定,第8周SDS<55分。上药连服5个月,随访7年未见复发。

【方名】 平心忘忧汤。

【组成】 磁石、礞石各30g(另包先煎30min),枳实、黄柏、半夏、厚朴、朱茯苓、神曲各12g,肉桂、苏叶、石菖蒲各6g,牛姜9g。

【来源】 胡思荣,湖北中医杂志,1996,(2):4。

【功效】 清利肝胆,解郁化痰。

【适应证】 抑郁症,证属痰气郁结者。

【方药简析】 本方以半夏厚朴汤疏肝利胆、解郁化痰、行气散结;合磁朱丸重镇安神、宁心定志;礞石、枳实豁痰开窍,用量宜大,因本病气郁痰结过甚,一般行气化痰之药无济于事,欲使顽痰速去,必用此药;黄柏清下痰火;佐石菖蒲芳香化湿和胃,宁神开窍。以上12味合为清肝利胆、解郁化痰之妙方,有助于患者忘却忧愁与烦恼,解除因脏腑机能紊乱而引起的一系列症状。本方以水煎,于早饭、中饭后和临睡前3次内服。若伴湿盛痰多、恶心欲呕者,加藿香6g,川羌活10g;失眠多恶梦者,加枣仁15g,远志12g;血压偏高,大便干结者,将黄柏改为大黄10g。胡思荣在用心理治疗(主要是认知领悟疗法,疏导交谈的方式)的基础上,配合以本方按上述加减用药,心身兼治,治疗本病470例,其中痊愈(临床症状完全消失,心情良好,能正常工作,1年后随访无复发)330例,占70.2%。

好转(临床症状基本消失,生活自理,可以工作)95例,占20.2%;无效(临床症状无好转或加重)45例,占9.6%。总有效率90.4%。治疗时间最短者30天,最长者180天。一般服药4~7天,伴随症状减轻或消失,心情舒畅,情绪稳定,忘却了过去的忧愁与烦恼,饮食及睡眠也逐渐好转。

【病案举例】 李某,男,39岁,个体户,1993年6月19日初诊。患者本人及其妻诉:半年前,患者14岁的女儿因病死亡,由于悲伤过度而发病。始见失眠多恶梦,渐至彻夜不眠,胆小害怕,以至于不敢从医院门口经过,不敢外出,甚至不敢进家门。时而神志恍惚,脑子里一片空白,有时竟不知自己是谁,身上总装着一张写有姓名和门牌号的字条,以防自己丢失。总是突发奇想,一日自觉腹中一段肠子正在变细变薄,随时都有断裂危险。想到次日要到医院看病,即找来一条长40cm,宽2cm的胶布从前胸贴至小腹,以免肠子因汽车震动而断裂。病发后经多方治疗均未奏效,某医院住院治疗诊为:神经症,给予安定、谷维素、多虑平、氨基酸等药物治疗,但病情日重,伴心烦易怒,咽中如有物阻塞,吞咽困难,全身肌肉呈游走性痉挛跳动,纳差呃逆,周身疲乏无力,大便干结,生活不能自理,昼夜要人陪伴。后经人介绍来我处就诊。诊见患者衣衫不整,蓬头垢面,痛苦异常。经核磁共振、多普勒扫描、脑功能测定和B超检查,仅提示:轻度脑动脉供血不足,余无异常。体检:面容憔悴,精神萎靡不振,神志恍惚,反应迟钝,舌红苔黄腻,脉弦滑,血压:17/12kPa。诊断:神经症。笔者接诊后,先以心理治疗进行交谈,而后给予“平心忘忧汤”内服。4天后,患者自觉诸症大减,病情开始好转。8天后心烦失眠、多恶梦、呃逆、全身肌肉跳动等临床症状基本消失,心绪平静下来,精神、饮食及睡眠转佳,可以自己来医院就诊。36天后自觉头脑特别清醒,一如常人。半年后能独自去上海、广州做生

意。

【方名】 温胆汤。

【组成】 半夏 12g,竹茹 12g,枳实 12g,陈皮 15g,茯苓 15g,生姜 24g,甘草 6g。

【来源】 孙思邈《备急千金要方》。

【功效】 燥湿化痰,清热除烦。

【适应证】 反应性忧郁,属痰热上扰者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中半夏、陈皮燥湿理气化痰为主;伍入竹茹清热化痰,枳实破滞降逆散淤,后世增入茯苓更增燥湿化痰之力,共为辅药;由生姜制半夏之毒,助半夏、陈皮、枳实之行气消痰为佐;甘草调和诸药为使。全方燥湿化痰、清热除烦。沈才栋以本方为主加郁金、香附、玫瑰花、绿萼梅、代赭石、石菖蒲,治疗本病有良效。

【病案举例】 戴某,女,20岁,日前因所求不遂发生争吵,之后即精神恍惚,忧郁寡语,有时呈痴呆状,善太息。自诉咽部有物梗阻,常以手指在舌根诱吐无物,胸闷纳差,泛恶,痰少质粘。苔黄腻,脉弦滑。诊断为郁证。证属痰气郁结,化热中阻,治以理气解郁、清热化痰。处方:半夏、竹茹各 12g,陈皮、枳实、郁金、香附、玫瑰花、绿萼梅、代赭石、茯苓各 12g,石菖蒲、甘草各 5g。服药 5 剂后呕感已平,咽梗减轻,精神爽朗,胃纳亦增,继以柴芍六君子汤合逍遥散出入,调理而愈[沈才栋等,黑龙江中医药,1995,(2):25]。

【方名】 精神病 2 号方。

【组成】 半夏、白术、枳实各 10g,青皮、陈皮各 8g,茯苓 12g。

【来源】 翟双庆等,中医杂志,1990,(2):24。

【组成】 柴胡 12g,白芍 15g,茯神 20g,当归 2g,木香 6g,枳壳 12g,郁金 12g,合欢皮 20g,夜交藤 30g。

【来源】 李文超,河南中医药学刊,1996,(6):41。

【功效】 疏肝解郁,调气安神。

【适应证】 抑郁性神经症等,证属肝气郁结者。

【方药简析】 本方由逍遥散化裁而成。方中柴胡疏肝解郁,当归、白芍补血养肝,3味药配合补肝体而助肝用;木香、枳壳、郁金理气消滞助肝疏泄;合欢皮、夜交藤养心安神解郁。诸药合用可使肝气条达,气血和顺,魂归神藏。若胸胁胀痛明显者,加佛手 12g、川楝子 12g;恶梦多者,加生龙骨、生牡蛎各 15g;肝郁脾滞、纳呆者,加焦山楂、焦神曲、焦麦芽各 15g;月经不调者,加香附 12g、坤草 12g;心烦者,加栀子 12g。本方每日 1 剂,水煎分 2 次内服,5 剂为 1 疗程。李文超等用本方按上述加减用药治疗以顽固失眠为主要表现的抑郁症 60 例(属抑郁性神经症者 20 例,神经衰弱者 13 例,心因性抑郁者 14 例,急性心因反应者 3 例,癔症 5 例,抑郁症者 3 例,产后精神障碍 2 例)。治疗 3 个疗程痊愈者 46 例,占 76.7%;好转者 12 例,占 20.0%;无效者 2 例,占 3.3%。总有效率为 96.7%(疗效评定以患者对睡眠需要的满意程度为标准,而睡眠时间的长短仅作参考。其中对睡眠满意者为痊愈,对睡眠基本满意者为好转,治疗前后无改善者为无效)。

【病案举例】 张某,女,30 岁,工作,已婚,1993 年 5 月 15 日初诊。10 天前因婆媳争吵,又受丈夫辱骂,而出现闷闷不乐,悲观欲死,不停叹息,胸胁胀痛,夜不成眠,甚则通宵不眠,时时惊醒。平时性格内向,爱生闷气,经用谷维素、阿米替林、安定、朱砂安神丸等药治疗,效果不佳。西医诊断:心因性抑郁。诊其舌红苔白、脉弦。证属情志所伤、肝气郁结、心神不安而失眠。投以逍遥安神汤加减,以疏肝解郁、调气安神。方药:

柴胡 12g,白芍 15g,茯神 20g,当归 12g,木香 10g,枳壳 12g,佛手 12g,郁金 12g,合欢皮 20g,夜交藤 30g,生龙骨、生牡蛎各 20g,炙甘草 30g。服药 3 剂后,夜能睡眠 6h,情绪明显改善,胸胁胀痛已减,但睡眠不佳、早醒,继用上方 5 剂而痊愈。

【方名】 清养心脾开郁汤。

【组成】 丹参 21g,生地黄 12g,炙远志 6g,郁金 10g,合欢皮 20g,浮小麦 40g,茯苓、茯神各 15g,煅龙齿 30g(先煎),白芍 15g,漂白术 12g

【来源】 张赤志,湖北中医杂志,1994,(6):7。

【功效】 清养心脾,开郁安神

【适应证】 忧郁症,证属心脾被郁,心神失养者。

【方药简析】 本方选用丹参、生地黄、浮小麦、茯苓、白术清养心脾;炙远志、郁金、白芍、茯神、煅龙齿、合欢皮开郁安神。全方清养心脾为主,开郁安神为辅,治本开源,使营血充,神自安。吕继端用本方治疗忧郁症有良效。

【病案举例】 宋某,女,32岁,1991年9月2日就诊。自诉失眠 10 余年,甚则通宵不眠,省某医院精神科诊断“忧郁症”。每晚睡前服安定片 5mg,则能入睡 3~4h,但睡眠多梦,醒后不解乏。诊时诉几天来失眠明显,通宵睁眼不寐,服安定片无效,伴心悸健忘、神疲体倦、食欲不振,大便软每日 1 次,小便调。舌质淡边有齿印,苔薄白,脉细。诊为郁证。治以清养心脾、开郁安神。服 7 剂明显好转,不服安定片每晚能睡 6~7h,服 14 剂后状如常人。

【方名】 甘麦大枣解郁汤。

【组成】 炙甘草 5~10g,淮小麦 30g,大枣 5 枚,炙远志 10g,酸枣仁 15g,制香附、柴胡、郁金、香橡皮各 10g。

【来源】 丁文娟等,江苏中医,1994,(4):18。

【功效】 理气解郁,养心安神。

【适应证】 抑郁症,证属气郁,心神失养者。

【方药简析】 本方是由甘麦大枣汤加味而成。方中炙甘草甘缓和中,以缓急迫;淮小麦微甘微寒以养心气;大枣甘平能补益中气、坚志除烦。三药合用以奏养心安神、甘润缓急之效。中气不足、营血亏少、神失所养多缘之于肝郁而抑脾,故方中配以炙远志、酸枣仁养血安神;制香附、柴胡、郁金、香椽疏肝解郁为助。全方可理气解郁养心安神。若见心烦不寐、口苦便艰、舌红苔黄糙,加龙胆草、黄连、枳壳实等;心虚胆怯、惊惕肉瞤、夜难入寐、舌淡胖等,加党参、黄芪、当归、茯神等;若兼胸闷纳差、痰多、舌苔白腻,加茯苓、炒白术、石菖蒲、竹茹等。因其他疾病引起抑郁症者当积极治疗原发病。如果配合服用三环类抗忧郁药引起口干、咽燥、心慌、便秘等副作用,在中药中加入生地黄、玄参、麦门冬、石斛之类以养阴生津、润燥通便,减少西药副作用。丁文娟等以本方为基础方,按上述方法加减治疗抑郁症40例,结果对轻、中度抑郁症治疗效果较好,一般服药3~5天症状开始缓解,睡眠渐渐好转;服药半月症状均能基本缓解。待症状缓解后仍继续服药调补,巩固疗效。本组病例痊愈27例(抑郁症症状消失,完全恢复正常生活,随访2年未再复发),占67.5%;好转10例(抑郁症状消失,但有小反复,或加服小剂量多虑平100mg/日),占22%;无效3例(症不能缓解,转精神病院治疗),占7.5%。总有效率89.5%。

【病案举例】 屈某,男,61岁,离休干部,1985年5月22日住院。患者因郁闷不舒,心烦难眠1周入院。患者离休后感无事可做,成天闷闷不乐,渐渐不愿与人接触。近1周因岳母患老年性痴呆,整天吵闹不休,以致心烦易怒,胸胁胀闷,夜间

失眠,少言懒动,对任何事不感兴趣,纳少便干。在某精神病院诊断为“抑郁症”,予服多虑平、舒乐安定等,因感口干难耐,终日头晕不清,要求服中药治疗。入院后观其面色无华,愁眉苦脸,反应较迟钝,双目有红丝、眼眵较多,口苦口干,便艰尿赤,整夜难寐。脉弦小数,舌红、苔黄腻而糙。证属肝郁气滞,气郁化火,痰火蕴结,心神失宁。治拟清肝泻火、理气解郁、养心安神。方选本方合龙胆泻肝汤加减。淮小麦 30g,大红枣 7 枚,甘草、龙胆草各 5g,生栀子、姜竹茹、枳壳、枳实、郁金、石菖蒲、佛手各 10g,玫瑰花(后下)5g,瓜蒌仁(打)30g。服药 5 剂,诸症悉减,精神渐振,能与交谈。再服 5 剂,肝气郁结症状均除,苔黄腻渐化,惟夜难入眠。再用本方合归脾汤调理月余,抑郁症状均消失,病愈出院。随访 3 年未再复发。

【方名】 百合地黄汤。

【组成】 百合 60g,生地黄 30g。

【来源】 张仲景《金匮要略》。

【功效】 调养神气、补益气阴。

【适应证】 忧郁症,主证为心肺阴血不足者。

【方药简析】 方中百合为主药,以调心安神、益气开郁;生地黄滋阴养血,导泻郁中之热。全方调养神气、补益气阴。加知母清热除烦则成百合知母汤。李卫等用本方为基础方,辨证与辨病相结合治疗本病:单纯抑郁表现者用百合地黄汤或百合知母汤;有血虚表现者用百合地黄汤加味;兼气滞血淤、痰热内结者先用百合地黄汤加味,后改用百合知母汤。若伴见它证则辨证遣药,或理气,或活血,或清热,或祛痰结,或补益不足。本组共治疗 6 例,其中男 2 例,女 4 例;年龄最大的 38 岁,最小的 24 岁,病程在 1~8 年之间,都经过西药抗抑郁治疗,或因效果不佳,或因不耐毒副作用而改为中医治疗。结果平均

每人服9剂临床治愈,随访6个月均无复发。

【病案举例】 余某,男,26岁,已婚,主诉心头闷痛2年,伴精神不佳。2年前因此症状到地区人民医院及精神病医院诊治,皆诊断为“忧郁症”,予抗忧郁药物治疗,效果不佳,且副作用使其更感不适。中医诊见:舌质暗,舌下系带青紫,苔薄黄,脉弦涩。曾服血府逐瘀汤3剂无效。拟治则调养神气,补益气阴,疏郁活血,祛瘀通经。方用百合地黄汤加味:生地黄30g,百合60g,柴胡12g,白芍15g,枳壳12g,地龙15g,荆芥12g,远志12g,石菖蒲15g,胆南星12g,半夏12g,陈皮10g,甘草15g。服3剂后头痛消失,精神大振,惟腹胀,舌质可,苔略白,予原方去石菖蒲、胆南星,陈皮增至15g。3剂愈。此后,1年中又复发2次,分别以百合知母汤及百合地黄汤加味痊愈之[李卫等,河南中医,1992,(2):74]。

【方名】 柴芍六君汤。

【组成】 醋炒柴胡10g,白芍15g,党参20g,炒白术15g,茯苓20g,陈皮10g,法半夏12g,炙甘草6g,当归20g,炒枣仁15g,益母草20g,王不留行20g。

【来源】 李喜枝,云南中医学院学报,1991,(2):1。

【功效】 健脾舒肝。

【适应证】 产后抑郁症,证属肝郁脾虚者。

【方药简析】 方中以柴胡、白芍合用调肝以助脾;党参、白术、茯苓、陈皮、法半夏健脾和胃,共助气血生化之源;当归、酸枣仁养肝血、安魂魄、宁心神;益母草、王不留行活血化淤,使补而不滞、血畅气调。全方可健脾舒肝,使肝气条达心神健旺、神清气爽、情志畅适。若血虚明显者加阿胶、女贞子、旱莲草,气虚明显者加炙黄芪,偏寒者加炮姜、炒艾叶,纳差苔白者加藿香、砂仁,心烦、舌红者加栀子、淡竹叶,痰多者加贝母、竹

茹、鲜竹沥，乳汁少者加炮穿山甲、通草。所有患者均给予解释开导，并要求家人配合，给予精神安慰。症状消失大半后即停药，代之以当归 30g、炮穿山甲 10g 炖鸡或猪脚服食，食前加醋数滴。李喜枝用本方为主，按上述加减用药治疗本病 10 例，结果其中轻、中症 9 例中，服药 3 剂症状大半消失者 7 例，服药 6 剂症状大半消失者 2 例，重症 1 例，服药 10 剂，纳食增加，睡眠有改善，但仍早醒、精神不振、情绪低落，视为无效。全部病例均服用当归、炮穿山甲炖鸡或猪脚 5 剂以上，最多者 10 剂。服药后首先改善的是食欲，随之睡眠，精神好转，情绪渐开朗，乳汁增多，但有 2 例乳汁未明显增多。

【病案举例】 某某，女，23 岁，已婚，工人，1989 年 7 月 3 日初诊。其夫代述：产后 20 天，抑郁少言 15 天。患者 20 天前顺产 1 女，因盼子得女，恐其夫不悦，虽母女均安，仍闷闷不乐。出院返家后渐渐情绪低落，抑郁少言，纳食少，乳汁全无，乏力明显，或无端担心其女将有不测，眠差早醒，问其症状，良久始答，语气低微，但回答切题。诊为产后抑郁症。观面色萎黄，舌质淡，苔白，脉细弱。证属脾虚肝郁、心神失养。治宜健脾舒肝、养心安神。方用柴芍六君汤加味：醋炒柴胡 10g，白芍 25g，党参 20g，茯苓 20g，炒白术 15g，陈皮 10g，法半夏 12g，炙甘草 10g，炒枣仁 15g，当归 20g，王不留行 20g，炮穿山甲 10g，藿香 10g，砂仁 6g，炙黄芪 20g，3 剂，水煎服。同时加以劝慰开导，取得其夫配合。4 天后二诊，自述病情，述药后纳食转馨，抑郁稍舒，夜间已能安静入睡 5h，仍较乏力，大、小便调，查舌脉同上，上方再进 3 剂，诸症消失大半。嘱其以当归 20g，党参 30g，炮穿山甲 10g 炖鸡或猪脚服食，半月后其夫来述，症状消失，唯乳汁不足。

【方名】 补元解忧汤。

【组成】 党参 20g,太子参 30g,熟地黄 30g,山药 10g,柴胡 6g,五味子 30g,当归 10g,山茱萸 10g,杜仲 10g,肉苁蓉 10g,炙甘草 10g。

【来源】 雍履平,中医杂志,1994,(4):246。

【功效】 养元复神。

【适应证】 忧郁症,证属神气大虚,真元亏损者。

【方药简析】 本方是由张景岳大补元煎化裁而成。方中用大剂党参、太子参补阳补气,非桂、附苦温燥烈伤阴可为;以熟地黄、山药补阴补精,非知母、黄柏苦寒伤阳可比;少佐柴胡升发阳气以舒神胜忧;加用五味子敛神除郁而无耗气动血之弊;当归、山茱萸、杜仲、肉苁蓉、炙甘草一派甘温益气之品以回天赞化,救本培元。元充则神复,郁证可痊。雍履平用本方为基础方,随证加减治疗本病有良效。

【病案举例】 吴某,女,38岁,6个月前,因屈从引产1男死婴,从此惋怒交加而心情不悦。日渐寐少,不思饮食,寡言少语,懒于行动,忧心忡忡,消极厌世,几觅短见未遂。经某医院检查,诊断为忧郁症。乃投中西药治疗,效果不显。遂于1992年3月26日来我脑科就诊。视其面容憔悴,忧郁神情,形体孱弱,呆坐或缓步,频频太息;询之胸闷不适,小溲正常,大便3日未行,家人代告曰:已3天彻夜无眠,常有“对不起死婴”悔恨之语;诊其脉,细弱无力;察其舌,苔少舌红中有裂纹。诊为郁症。证属神气大虚、真元亏损。治宜养元以复神。方用补元解忧汤加减。处方:党参 20g,太子参 30g,熟地黄 30g(砂仁 3g 拌捣),淮山药 10g,川杜仲 10g,山茱萸 10g,枸杞子 10g,肉苁蓉 10g,五味子 30g,炙甘草 10g。上方5剂服后睡眠稍安,大便已行,唯忧郁心情无明显好转。再以前方加柴胡 6g,连服10剂。4月15日再诊,夜寐已达5h许,有欢乐感,情绪亦稳定。复以上方增减,先后服25剂,告愈。已经随访1年,病症未见

复发。

【方名】 二仙解忧汤。

【组成】 仙茅、仙灵脾、当归、巴戟天、石菖蒲、夜交藤各 12g,知母、黄柏各 9g。

【来源】 郭建武,陕西中医,1986,(2):59。

【功效】 协调阴阳,醒神清脑。

【适应证】 抑郁症,证属阴阳失调者。

【方药简析】 本方是由二仙汤加味而成。方中仙茅、仙灵脾、巴戟天温热壮阳;知母、黄柏滋肾以降浮火;当归补血养血,全方共奏协调阴阳,改善机体机能,醒神清脑之功,且无毒副作用。本方每日 1 剂,分 2 次煎服。若懒言少动,表情呆滞者重用石菖蒲,加郁金;心烦不眠者重用夜交藤,加炒枣仁;纳呆畏寒去黄柏、知母加干姜;情绪极度抑郁、卧睡难以入眠者加合欢皮、茯神。对于个别顽症、重症患者,同时配用小剂量 3 环类抗抑郁药,具体用法是:抑郁症状突出者,配服丙咪嗪 25mg,每日早晨服 1 次;焦虑不安或焦虑性激动为主者,配服阿米替林或多虑平,初用量 25 mg,每日 2 次,症状控制后改为每日服 1 次。郭建武以本方为主,按上述方法加减治疗抑郁症 64 例(躁狂抑郁性抑郁症 2 例,更年期抑郁症 27 例,反应性抑郁症 6 例,抑郁性神经官能症 28 例,分裂情感性抑郁状态 1 例),结果治愈 22 例(临床症状消失,从事正常的工作学习,1 年内无复发),好转 38 例(抑郁或焦虑不安情绪改善,可胜任一般工作),无效 4 例(精神抑郁或焦虑不安症状时轻时重,胜任原工作困难)。总有效率 93%。

【病案举例】 齐某,男,18 岁,学生,1986 年 3 月 16 日初诊。患者 2 年来,焦虑不安,睡眠不佳,他医按神经衰弱治疗,投以镇静安神之品,罔效。近半年来自觉头痛昏晕,胸中憋

53

更年期精神病

更年期精神病是指从中年到老年这一过渡时期,在内分泌功能紊乱的基础上,由于精神和躯体等因素诱发而首次发病的一类精神障碍。发病年龄一般女性多在46~50岁绝经期前后,男性多在51~55岁之间,以女性多见,发病率80%左右。多数患者渐隐起病,诱发因素常不明显,早期症状常较多,类似神经衰弱,且植物神经系统的症状比较突出,可有性欲减退或月经紊乱、停经,多发展为更年期忧郁症,如为急性起病,诱发因素常较为突出,早期症状不明显。病情进一步发展,根据其临床表现不同可分为更年期忧郁症(以焦虑、紧张、失眠、全身不适,头昏、耳鸣、眼花、潮热感、食欲减退、疲乏无力,心悸、坐立不安、易激动、缺乏耐心、多愁善感、引不起兴趣,或发展为心神不宁,甚至极度烦躁、忧郁痛苦、自责自罪、消极行为,或形成疑病观念及疑病、贫穷、虚无妄想为主)和更年期妄想症(以罪恶、被害、疑病、妒嫉妄想及牵连观念为主,有的可见人格分裂、幻觉、思维贫乏)2类。本病还常有体重增加、肥胖、血压增高、骨质疏松的症状。临床上常将涉及本病的各种症状统称为更年期综合征。本病应与抑郁症、精神分裂症妄想型、反应性精神病、神经官能症、脑动脉硬化性精神病、药物中毒性精神病相鉴别。本病常用泰尔登、多虑平、阿米替林、谷维素及电休克、精神治疗、工娱治疗。

本病属于中医绝经前后郁证、脏躁等范畴。本病的病因病机主要是更年期女子因经、孕、产、乳数脱于血,男子房劳屡

伤于精,而阴伤及阳,或阴虚阳浮,或阳损痰湿气血淤阻。在此生理病理基础上,由于一定的心理素质特点,或遇一定的精神刺激而易使肾阳失衡,常致木火升发、心火妄动,并可兼夹痰热淤血,使神魂失位而发为本病。本病治疗首当辨证。阴虚阳亢者用百合更忧汤加减;心肾两虚、神魂不宁者用百合宁神汤加减;肝肾阴虚、肝阳上亢、心肝失养者用柴甘更年方加减;阴虚肝旺者用景岳逍遥饮加减;阴亏血少、阴阳不调者用更年欢加减;脾肾阳虚,痰水淤血为患者用更年期良饮加减;心肝火旺、胆胃不和、痰热内扰者用十味温胆汤加减;肾虚精亏变生诸证用归肾丸、二仙汤、三花二仙汤等加减。在临床症状减轻后应进一步从补肾上调理治疗,常用的有六味地黄丸、金匱肾气丸、二仙汤等。二是配合用调整植物神经、内分泌的药物或方剂。

王大增用清心平肝汤(黄连、麦门冬、白芍、甘草、白薇、丹参、龙骨)以1月为1疗程,观察248例,平均疗程1.5月,有效率91.3%。治疗后性激素水平无明显改变,唯睾酮(T)在治疗后较前明显降低,提示FSH、LH升高与本病之症状出现与消失无直接的因果关系,而T含量的降低与症状的改善有关。动物实验证实,清心平肝汤能有效地降低去势大鼠下丘脑中NE及血浆CAMP的含量,从而推论其作用机理之一是调整植物神经功能的高级中枢[中医杂志,1989,(1):31]。

陆启滨用更年1号新方(生地黄、女贞子、丹皮、酸枣仁、朱茯苓、钩藤、合欢皮、佛手、仙灵脾、莲子心、煅紫贝齿)治疗本病,8周为1疗程,研究证实绝经前后阴虚火旺与尿CA、17-OHCS排泄量增高密切相关,该方具有使尿CA3项指标下降的作用,其中NE、DA治疗前后有显著差异,NE/E比值减少,尿17-OHCS降低,改善症状的总有效率为89.2%。推测本方的作用机理可能是与降低中枢儿茶酚胺水平而抑制交

感-肾上腺髓质和交感-肾上腺皮质系统的过度兴奋有关[中国中西医结合杂志,1991,(9):535]。

王玉明用中药(天麻、钩藤、鸡血藤、川牛膝、丹参、桑寄生等)水煎服,配合针刺四关(双侧合谷、太冲)、三阴交,日1次,10日为1疗程。治疗本病106例,痊愈93例,显效6例[云南中医杂志,1992,(1):20]。

张家庆认为成药六味地黄丸可使本病患者在症状改善的同时,白细胞雌激素受体含量及血浆雌二醇明显增高,说明六味地黄丸对本病的治疗效果与在受体水平上调节患者内分泌状态有关[中国中西医结合杂志,1991,(9):251]。三是精神上的安慰治疗,解除精神压力,特别是家庭多给患者关怀、体贴、理解、鼓励患者多参加娱乐活动。

【方名】 百合更忧汤。

【组成】 生地黄 15g,百合 15g,知母 10g,麦门冬 10g,龙骨 20g,牡蛎 30g,磁石 20g,石菖蒲 5g,茯神 10g。

【来源】 白国生,江苏中医,1995,(8):13。

【功效】 滋阴潜阳,养血宁神。

【适应证】 更年期忧郁症,主证为营血虚耗、心神失养者。

【方药简析】 本方是由百合地黄汤加味而成。方中用百合、生地黄、知母、麦门冬滋阴养血凉血以除虚热,虚热得清而内火熄,心神安宁,焦虑忧郁可除;龙骨、牡蛎重镇潜阳,浮阳得潜而神守于舍,则紧张猜疑自解。本方每日1剂,水煎2次,早晚分服,20剂为1疗程,服药期间停用其他疗法。若兼有肝气郁结、暖气咽梗者,加白蒺藜、佛手、苏梗;兼有脏躁、叹息伸欠、哭笑无常者,加甘草、小麦、大枣。白国生用本方为基础方,按上述方法加减用药,治疗本病20例,结果临床治愈

定魄是为主药;炒枣仁养心安神,夜交藤安神益肾,合欢花解郁,3味药共辅百合安神定志;当归、丹参养血和血,佐主药宁心解郁;甘草强心气、调和诸药为使。全方共奏养心宁神解郁之功。陈光恩以本方为基础方,将本病分为10型:肝郁气滞加柴胡、白芍、枳实;气郁血滞加桃仁、红花、香附、青皮;肝郁化火加柴胡、白芍、丹皮、栀子、龙胆草;火热扰心加犀角、生地黄、栀子、连翘、竹叶、莲子心;思虑伤脾、痰湿内蕴加陈皮、法半夏、茯苓、白寇仁、石菖蒲、郁金、远志;郁犯脾肺、痰气互结加杏仁、厚朴、法半夏、木香、枳壳;郁而挟食加山楂、神曲、莱菔子、木香、枳实;久郁伤神、心脾两虚加党参、白术、淮山药、桂圆肉、远志、木香;因郁伤正、精血亏耗、心肾两虚加熟地黄、何首乌、黄精、五味子、菟丝子、鹿角、磁石;郁热伤阴、阴虚火旺、心肾不交加生地黄、熟地黄、龟板、五味子、龙骨、牡蛎、黄连、肉桂。治疗本病多例有良效。

【病案举例】 张某,男,60岁,农民,1975年12月22日住院,西医诊为更年期忧郁症。数月前曾因思虑烦闷而有自杀行为,后仍有家务纠纷缠绕难以超脱,出现情绪低落及精神失常、日渐加重,症见极度恐惧不安,怕见生人,做事疑虑不定,与之食则欲吞又止,彻夜不眠,蹑蹑走动,窃窃私语唯恐他人听到,窥听而张望惶惶然恐人将捕之。形瘦憔悴、下肢浮肿,舌嫩、苔剥,脉细小而沉。查眼底动脉硬化(++),血红蛋白90g/L,心尖区闻及Ⅱ级收缩期杂音。证属因郁伤正、心肾两虚、神魂不宁。治宜宁神解郁、养血健肾。方用百合宁神汤加石菖蒲、远志、磁石、珠珀粉、淮山药、莲子、何首乌、黄精、枸杞子、菟丝子。6剂后睡眠渐安,饮食自进,精神如梦如醒。又进12剂后,症状消失,精神恢复,躯体明显改善,心音正常,20天出院。

【方名】 柴甘更年期方。

【组成】 柴胡 9g,党参 15g,姜半夏 9g,炙甘草 6g,黄芩 9g,淮小麦 30g,大枣 6枚,栀子 9g,珍珠母(先煎)30g,仙灵脾 12g。

【来源】 曹静安,上海中医药杂志,1984,(3):19。

【功效】 和畅气机,养心安神,协调阴阳。

【适应证】 更年期精神病,气机郁滞,心神失养者。

【方药简析】 本方是由小柴胡汤合甘麦大枣汤化裁而成。方中用小柴胡汤以疏利三焦,调达上下,宣通内外,和畅气机;甘麦大枣汤可养心安神、和中缓急。据现代中医临床研究证明,前者对消除抑郁症的各种症状有较好的效果,后者对调节焦虑、抑郁情绪有较好效果,2方合用,可从不同方面治疗本病的精神症状。方中配栀子清三焦虚火,除烦安神;加珍珠母平肝潜阳;用仙灵脾协调阴阳。全方配伍精当,可和畅气机、养心安神、协调阴阳,为一首治疗本病忧郁为主的各种症状的处方。若见高血压者加钩藤 15g 或地龙 9g、牛膝 9g;失眠者加五味子 3g、夜交藤 15g;口渴者加石斛 12g、玉竹 9g。待症状缓解后,再投补肝益肾之剂以治其本。曹静安以本方为基础方,按上述加减用药,治疗本病 21 例,结果烘热、面部潮红、汗出症状消失 9 例,明显减轻 3 例,有所减退 9 例。对心烦易怒、失眠、心悸、哭泣几种症状均有不同程度的疗效。

【病案举例】 刘某,女,49岁,1977年12月7日初诊。以往月经尚准,去年开始紊乱,2~3个月来潮1次,末次月经9月底。现自觉面部潮红汗出,时有烘热,难以忍受,伴有头目眩晕,恶心欲吐,腰脊酸痛,脚跟痛,血压波动(最高为24/15kPa)。诊断为更年期精神病。中医症见:主症如前,苔薄白,舌体胖,脉细弦数。辨证为肝肾阴亏,肝阳上亢,心肝失养。柴甘更年期方加味:党参 9g,柴胡 9g,姜半夏 6g,炙甘草 6g,黄芩

9g,淡吴茱萸 1.5g,姜黄连 1.5g,钩藤(后下)12g,珍珠母(先煎)30g,大枣 6 枚,菟丝子 12g。7 贴。二诊(12月24日):服药后烘热汗出之症显减,夜寐略安,纳谷佳,苔薄黄质胖,脉细数。仍宗前方续进:柴胡 9g,党参 9g,姜半夏 6g,炙甘草 6g,钩藤(后下)15g,牛膝 9g,淮小麦 30g,大枣 6 枚。服药 14 贴后,时有烘热,面部潮红汗出基本消失。于 1978 年 3 月改用滋养肝肾药以治其本,给六味地黄汤随症加减,以徐图调摄收功。

【方名】 景岳逍遥饮。

【组成】 熟地黄 20~40g,当归 12~18g,酸枣仁 15~20g,白芍 15~20g,茯神 12~16g,炙甘草 10~15g,陈皮 10g,远志 12g。

【来源】 张景岳《景岳全书卷》。

【功效】 益肾调肝,安神宁志。

【适应证】 更年期精神病,主证为肝肾阴虚,心神失养者。

【方药简析】 本方以熟地黄为君,补血益阴滋肾;白芍入肝敛阴养血;然血虚多滞,经脉隧道欠畅,又恐熟地黄、白芍纯阴之性,性无温养流动之机,故用当归之辛甘而温,能养血而行血中之气;阴血不足,心神失养,虚火上炎,以致虚烦不眠,故以酸枣仁补肝宁心、镇静安眠;远志合茯神安神定志;陈皮理气健脾;炙甘草调和诸药。全方益肾调肝、安神定志。若心脾两虚、气血不足、经量减少、经期缩短者合归脾汤加减;肾阳衰微、脾阳虚弱,统摄失职、血不循经、经量增多或呈崩漏者合固冲汤加减(黄芪、白术、煅龙骨、煅牡蛎、山茱萸、生白芍、海螵蛸、茜草、棕榈炭、五倍子);阵发性烘热、面部潮红加地骨皮 15~20g、银柴胡 10g、丹皮 12g;心慌易惊加龙齿 10g、紫石

【方名】 更年欢。

【组成】 淫羊藿 12g,紫草 8g,当归 10g,栀子 8g,枸杞子 12g,女贞子 12g,百合 12g,珍珠母 30g。

【来源】 李德名等,新中医,1996,(7):37。

【功效】 养血宁心安神,平衡阴阳。

【适应证】 更年期精神病,主证为心神失养、阴阳失调者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中淫羊藿温补肾阳,且有雄激素作用;紫草清热凉血,有明显抗垂体促性腺激素及抗绒毛膜促性腺激素作用;栀子、丹皮清热凉血;枸杞子平补肝肾;女贞子育阴养心;百合清心宁神;珍珠母平肝潜阳,且含钙质,对神经应激有抑制作用。诸药柔润而不刚燥,配伍合用,有养血宁心安神、平衡阴阳之功。若肝郁气滞加柴胡、白芍;失眠严重加酸枣仁;汗多加煅龙骨、浮小麦、麻黄根;头晕耳鸣加磁石、石菖蒲;阴虚加熟地黄;阳虚去紫草、栀子、丹皮,加附子、肉桂。每剂水煎2次,早晚服。李德名等以本方为基础方,按上述方法加减用药治疗本病27例,结果治愈16例(临床症状体征消失),占59.26%;好转9例(临床诸症减轻),占33.33%;无效2例(临床诸证无变化),占7.41%。

【病案举例】 某某,女,51岁,1988年9月20日初诊。患者从49岁起月经周期不正常,2~3个月1至。经量或多或少。近因儿子参军离开家乡而忧思不乐。症见每天有1~2次面部潮红发热,情绪急躁易怒,常焦虑失眠,心悸,胸胁脘腹胀闷,食欲不振。请妇科会诊检查无异常发现。诊为更年期综合征。中医症见:主症如前,舌红、苔薄黄,脉弦细。证属肝郁气滞。治宜疏肝解郁、宁心安神。方用更年欢加味。处方:柴胡、

紫草、丹皮、栀子各 8g,白芍、炒枣仁、百合、女贞子、仙灵脾、枸杞子各 12g,当归 10g,珍珠母 30g。服药 5 剂,诸症稍为好转。再服 5 剂,兼用逍遥丸 10g,日 2 次,诸症大减。仍以原法治疗 35 天而愈。

【方名】 更年期良饮。

【组成】 党参 10g,黄芪 15g,白术 10g,茯苓 10g,薏苡仁 15g,山楂 15g,山药 15g,当归 10g,肉桂 3g,莪术 6g,三棱 6g,郁金 10g,柴胡 10g,大腹皮 15g,木香 6g。

【来源】 崔传鲁,黑龙江中医药,1987,(6):21。

【功效】 补气益肾,破瘀疏肝,利水。

【适应证】 更年期精神病,主证为痰水淤结者。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中以党参、黄芪补气,肉桂温补肾阳,共为主药;白术、山药、茯苓、薏苡仁配主药健脾利水为辅;山楂、当归、莪术、三棱破血,柴胡、郁金、大腹皮、木香疏理滞满,在方中共为佐使药。全方可补气益肾、破瘀疏肝、利水,则其虚得补,淤滞可除。神气自得调畅。若淤血明显者可易当归为红花,或加丹参、丹皮、延胡索;若肝郁气滞明显可再加陈皮、香附;若水湿停滞留明显,可再加扁豆、冬瓜皮、泽泻;若肾阳不足者,可加附子、续断、狗脊、杜仲、菟丝子、巴戟天、淫羊藿之类。崔传鲁以本方为基础方,按上述加减用药治疗本病 100 例有良效。

【病案举例】 于某,女,45 岁,干部,1976 年 6 月 2 日来诊。患者头疼眩晕,食欲不振,周身乏力浮肿已半年。其于 6 月热天门窗紧闭,畏风怕人躲在其内,疑心大,感情脆弱,激惹易怒,常太息欲悲哭,失眠多梦,心悸不安,腰膝痠疼,月经错后,小腹冷疼,经血紫黑成块,白带多。诊断为“更年期综合征”。中医症见:主症如前,脉象沉细,舌质淡白,苔薄白。治法:

除精神安慰解除思想压力外,采用补气益肾,破淤疏肝,利水,以“更年期良饮”(党参、黄芪、白术、茯苓、杜仲、当归、枸杞子、丹皮、三棱、莪术、木香、炒枣仁、柴胡)随证加减,水煎,每日1剂。6月17日二诊,自觉症状减轻,食欲增加,心情愉快。照原方继服四剂后,患者愿出房间与友人谈笑、散步,相继服上方22剂而愈。

【方名】 十味温胆汤。

【组成】 党参 12g,制半夏 10g,茯苓 12g,枳实 10g,陈皮 10g,熟地黄 12g,炒枣仁 20g,远志 6g,五味子 6g,生姜 4片,大枣 4枚。

【来源】 王肯堂《证治准绳》。

【功效】 清胆和胃,健脾化痰,益气养血安神。

【适应证】 更年期精神病,主证为气血亏虚、痰热内扰者。

【方药简析】 方中半夏、茯苓、陈皮降逆和胃、理气燥湿化痰;枳实行气消痰;党参健脾益气养血;熟地黄、五味子滋肾阴以敛心肝火旺;酸枣仁与茯苓相伍以养肝宁心安神除烦;远志交通心肾,使水火既济、阴阳平衡;甘草、生姜、大枣益脾和胃调合诸药。诸药合用共奏清胆和胃、健脾理气化痰、益气养血安神之效。本方水煎服,10天为1疗程。若见更年期功血症,上方加阿胶 15g、荆芥炭 10g,去熟地黄加生地黄炭 20g,同时口服谷维素、复合维生素B、维生素E。经期延长、经量增多者,加服妇血宁,待月经来潮时间缩短,经量减少停止服用。若出现烦躁不安、精神紧张,可短期口服安定 2.5mg,日3次。刘长惠以本方为主,按上述加减用药治疗本病56例。治疗结果:自觉症状消失、月经周期紊乱明显改善、体力工作恢复正常者48例,占85.7%;月经紊乱得到改善、自觉症状减轻者

6例,占10.7%;2例无效,占3.6%。

【病案举例】 王某,女,52岁。主诉:自46岁始月经不按月来潮,时20余天1至,时70余天1至。此次月经来潮近半月淋漓不尽,量多,色淡,无血块,无腹痛,时有心前区闷痛,恶心欲吐,伴头晕心慌,烦躁不安,潮热汗出,全身乏力,甚则有时哭笑无常。曾肌注黄体酮,口服安络血、云南白药、归脾丸、补中益气丸等药,其效不佳。查心率稍快,律齐,腹部平软,无压痛,舌苔薄白,脉弦滑。血象:血红蛋白80g/L,白细胞计数 $6.5 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.70,淋巴细胞0.30,血小板计数 $180 \times 10^9/L$ 。B超提示:子宫大小正常,轮廓规整,肌层光点回声均匀,内膜显示不清,双侧附件区未见异常。诊断为更年期精神病伴功血。拟十味温胆汤加生地黄炭20g,阿胶15g(烔化),荆芥炭10g,水煎早晚分服。连服10剂,月经停止,自觉症状明显改善。为巩固疗效,继服妇血宁,配合谷维素、复合维生素B、维生素E,半月后停药。经治疗月经未再来潮,贫血得到改善,自觉症状消失。随访半年,身体健康状况良好[刘长惠等,山东中医杂志,1994,(11):506]。

【方名】 归肾丸。

【组成】 菟丝子30g,杜仲15g,枸杞子15g,山茱萸15g,山药10g,当归15g,熟地黄10g,茯苓15g,白术10g,柴胡10g。

【来源】 张宗芳,中国医药学报,1996,(3):37。

【功效】 补肾填精,疏肝理气。

【适应证】 妇女更年期精神病,主证为肾虚精亏、肝郁气滞者。

【方药简析】 方中菟丝子、杜仲既补肾阳,又补肾阴;枸杞子、山茱萸肉、当归、熟地黄滋肾养血填精;山药、茯苓、白术健

脾益气,以滋化源,助生精血;柴胡疏肝理气、调畅气机。全方重在补肾填精、疏肝理气,俾肾气充盛,精血充足,气机调畅,各种情志、精神异常症状自可随之消除。若兼肝郁者可加合欢皮 10g,川楝子 10g,以增强舒肝解郁之功效。兼肝阳上亢者加钩藤 15g,生石决明 30g,茯神 15g 以平肝潜阳。若见心火亢盛者加盐知母 10g、盐黄柏 10g、浮小麦 30g、炙甘草 10g、大枣 7 个以清虚火、滋阴润燥。若为心脾两虚者加仙茅 10g,枣仁 15g 以温肾壮阳、宁心安神。若为肾虚挟痰型去当归、山萸肉,加胆南星 10g、半夏 10g、石菖蒲 10g、枳实 10g 以理气豁痰。张宗方以本方为基础方,按上述方法加减用药治疗本病多例有良效。

【病案举例】 崔某,女,49 岁,干部,1992 年 1 月 29 日初诊。患者因更年期功能性子宫出血,经保守治疗无效,于半年前行全子宫及右侧附件切除术。术后逐渐情绪急躁,易激动,常因小事与同事及家人争吵不休,不愿上班,并意与爱人离婚。睡眠差,梦多,烘热汗出,胸胁胀痛,头晕,舌质正常,脉弦细。诊为绝经前后诸证,(肾虚肝旺型)。治以滋肾平肝。方用:女贞子 15g,白芍 15g,当归 15g,钩藤 15g,生石决明 30g,茯神 15g,柴胡 10g,郁金 10g。服上方加减月余,急躁易怒减轻。但转为忧虑、沉闷,害怕同事及爱人不理解自己,心悸、失眠。改用补肾养血益精、宁心安神之法,用归肾丸加减治疗。方用仙茅 10g,菟丝子 30g,杜仲 10g,枸杞子 15g,山茱萸 15g,山药 10g,女贞子 15g,当归 10g,白芍 15g,柴胡 10g,合欢皮 10g,茯神 15g,大枣 7 个。经以本方加减服用月余而痊愈。

【方名】 二仙汤。

【组成】 仙茅 12g,仙灵脾 12g,当归 9g,巴戟天 6g,黄柏 9g,知母 9g。

【来源】 上海曙光医院方《中医方剂临床手册》。

【功效】 补肾精清虚火,调阴阳理冲任。

【适应证】 更年期精神病,主证为肾虚精亏,阴阳失调者。

【方药简析】 方中仙茅、仙灵脾、巴戟天温肾阳、益肾精;伍当归养血而调理冲任;用知、柏清虚火而滋养肾阴。诸药合用,则肾精得补,阴阳协调,调理冲任。现代药理证实,温补肾阳药能作用于下丘脑-垂体-性腺轴,并调整三轴的功能紊乱,进而调整全身的内分泌功能。仙灵脾、仙茅更具有雄性激素的作用。杨更生以本方为基础合二陈汤治疗本病 14 例,结果全部治愈(以症状消失,精神状态恢复正常为治愈,仅性功能恢复不列入治愈),治疗时间 10~30 天不等。

【病案举例】 贝某,男,54 岁,4 年来血压一直在 25.5/13.5kPa 以上波动,体重 90kg,阳痿有 2 年。近 1 年来,短气乏力日见加重,以致行走困难,伴心情焦虑,容易激动,自卑多疑,睡眠欠佳,曾转治多处,未能治愈。经检查未发现其他异常。诊为男性更年期综合症。中医症见:主症如前,舌质偏红,苔微腻,脉沉。证属肾气渐衰,天癸将竭,阴阳不和,冲任失调。治以补肾精、调阴阳、理冲任、化痰湿。方用:二仙汤合二陈汤:仙茅 15g,仙灵脾 15g,当归 10g,巴戟天 10g,黄柏 6g,知母 6g,法半夏 10g,陈皮 10g,茯苓 15g,炙甘草 3g。共进 15 剂,血压降至正常,体重稍有减轻,阴茎偶能勃起,短气乏力大减,行走已如常人,心情也乐观平静。再进 10 剂,以期巩固[杨更生,辽宁中医杂志,1986,(4):31]。

【方名】 三花二仙汤。

【组成】 合欢花 12g,绿梅花 12g,佛手花 9g,仙茅 9~15g,仙灵脾 9~15g,旱莲草 9~15g,茯苓 12~18g,白术

作加减,服 30 余剂,自觉症状消失。继以上方制丸药 1 料服用。1 年后随访,未复发。

54

脑动脉硬化性精神病

脑动脉硬化性精神病是脑血管病伴发的精神障碍的一种。脑动脉硬化性痴呆、脑血管性痴呆、多发梗死性痴呆、卒中性痴呆均指本病或本病的一定阶段。本病为老年人常见疾病之一。有人统计痴呆发病率高达2%~8%，其中本病占40%。病理基础为大脑多灶性小梗死或脑出血反复发作及大面积梗死后全脑缺血、脑循环障碍、脑机能降低。本病起病较急，整个病程呈阶段性加重，临床表现包括类功能性精神病（如神经官能症样反应，以神经衰弱综合征多见，少数可出现转换性癔症或癔症性情感爆发、强迫症状、焦虑或抑郁等。在易感素质个体中，可促发内源性抑郁症、轻躁狂及晚发性精神分裂症），急性器质性脑病（为急起的意识障碍，如嗜睡、意识模糊或昏迷，也可谵妄或朦胧状态，精神运动性兴奋伴有生动幻觉及片断妄想。少数病人在一次或数次卒中后可很快进入慢性器质性脑病阶段。此外还有暂时性遗忘发作），慢性器质性脑病（即脑血管性痴呆，主要表现为记忆力与智能发生全面进行性的减退，最早累及近记忆，以后则远记忆明显受损。部分病人可有思维贫乏，理解、判断、分析与综合能力丧失。在痴呆背景上出现情感脆弱、情绪不稳定、欣快或抑郁以及情感爆发、妄想性情绪、缺乏情感体验的强制性哭笑等器质性情感障碍表现。晚期一切智能活动严重衰退，情感活动日趋淡漠，人格逐渐瓦解，处于植物性活动状态）。这3种表现在病程演进的不同阶段可单独出现，也可合并出现。本病应同各种失语、抑郁症、

老年性痴呆(SDAT)等相鉴别。治疗原则为改善脑血流,促进脑循环、脑代谢,常用护管药、钙离子拮抗剂,抗焦虑药治疗。

本病属于中医的癫狂、郁证、健忘、呆证、文痴等范畴。本病的病因病机主要有两方面。一是老年人脑髓渐空,易为邪客而蒙;二是身体老衰则阴阳失衡,易生火、生痰、生风,痰火乘风上扰,势必出现脑之元神迷乱,神志病变由生。一般初起以邪扰为主,日久则以本虚标实为主。其病位在脑,病机责之于心肝脾肾四脏失调。临症治疗首当辨证。属肝胆实火扰动元神者可用龙胆泻肝汤加减;痰火上扰者用黄连温胆汤加减;心火亢盛者用黄连豁痰汤、黄连解毒醒脑汤加减;风痰上扰者用半夏白术天麻汤加减;痰阻血瘀者用温胆汤加味或涤痰化淤汤加减;气虚血瘀者用加味通窍活血汤、补阳还伍汤加减;肝肾阴虚者用六桃汤、定智汤、加味左归丸加减。

傅仁杰把本病分四型治疗,髓海不足者治宜补肾填精益髓为主,佐以化淤通络、开窍醒神之品,方用补肾益髓汤加味;肝肾亏损者,治宜滋补肝肾,佐以熄风安神定智,方用定智汤加减;肝阳上亢者,治宜平肝熄风、育阴潜阳、醒神开窍,方用天麻钩藤汤、镇肝熄风汤加减;心火亢盛者,治宜泻火清心为主,佐以化淤通络、醒神开窍,药用黄连、黄芩、栀子、生地黄、玄参、当归、川芎、丹参、丹皮、石菖蒲、郁金、远志;湿痰阻窍者,治宜标本兼顾,健脾化痰、醒神开窍,方用转呆丹合指迷汤加减;气郁血虚者治宜理气和血、醒神开窍,方用逍遥散合甘麦大枣汤加减[北京中医杂志,1988,(5):27]。

王昌俊治疗本病方选益智合剂:菟丝子、熟地黄、巴戟天、丹参、浙贝母、人参、天门冬、辛夷、胆南星、法半夏、炙远志。兼痰火扰心者,加用滚痰丸2g,或黄连、竹茹各6g;若肝肾阴虚甚者,加服杞菊地黄丸10g,或阿胶、山茱萸;兼气郁不舒者加四制香附丸6g,或川楝子、石菖蒲、佛手、郁金;血淤阻络明

8]。

李贯彻等用补阳还五汤加味(黄芪、当归、川芎、桃仁、红花、地龙、赤芍、石菖蒲、远志、丹参),日服1剂,水煎两次,先后两次分服,30剂为1疗程,治疗本病12例,结果痊愈(主要症状基本消除,神志清醒,定向健全,回答问题正确,反应灵敏,生活自理,能进行一般社会活动者)5例,占41.7%;有效(主要精神症状有所减轻或部分消失,生活基本自理,回答问题基本正确,但反应迟钝,智力与人格仍有部分障碍者)5例,占41.7%;无效(服药60剂,主要症状无改变或病情有发展,生活不能自理,回答问题不正确,神志痴呆者)2例,占16.7%。全部病例经2个疗程治疗,总有效率为83.3%,且对8例伴有神经功能缺损,临床功能改进者6例,占75%[上海中医药杂志,1994,(4):9]。

杨文金等以解语丹(天麻、石菖蒲、白附子、胆南星、远志、全蝎、羌活、木香、甘草、泽泻、蜈蚣、水蛭、川牛膝、丹参)为基本方,气虚加黄芪,心神不宁加酸枣仁,阴虚阳亢加鱼翅、生龙骨、生牡蛎,痰热重加牛黄、佩兰。治疗本病31例,按“老年呆病的诊断、辨证、分型及疗效评定标准(讨论稿)”评定治愈18例,有效11例,无效2例,治愈率为58.06%,总有效率为93.55%,疗效优于西药对照组[山东中医杂志,1994,(11):493]。二是采取预防与调护措施,控制动脉硬化的发展,对改善大脑组织的血液灌注,维护大脑代谢正常,预防痴呆的发生具有积极意义。在辨证的基础上酌情选用月见草、泽泻、泽兰、白术、川芎、黄芪、葛根等,亦可选服下列药物之一:月见草油胶囊,4粒,日3次;复方丹参片,3片,日3次;泽泻白术散,10g,日2次;活血通脉片,5片,日3次;愈风宁心片,3片,日3次。三是注意脑力锻炼,调节饮食起居及肢体功能锻炼。四是饮食应以清淡而营养的食物为佳,多吃新鲜蔬菜、水果,摄

取足够的维生素,要保持大便通畅。五是注意保持心情愉快,力戒忧思愤怒悲伤。多参加集体活动,以及读书看报,听音乐等,接受外界的各种刺激以维持大脑兴奋状态对于防止精神衰退具有不可估量的价值。六是脑力训练以激发病人志趣,增加思维联想,提高记忆为主。根据病人脑力损害程度及偏瘫部位及语言蹇涩情况,从简单到复杂,分别进行功能锻炼。另外也可采用温泉浴、气功的松静功法。灸两侧足三里每天5壮,亦能防止衰老,防止痴呆。

【方名】 龙胆泻肝汤。

【组成】 龙胆草(酒炒)、柴胡各6g、泽泻12g、车前子(炒)9g、木通9g、生地黄(酒炒)9g、当归尾(酒拌)3g、栀子(炒)9g、黄芩(酒炒)9g、甘草6g。

【来源】 李东垣《兰室秘藏》。

【功效】 泻肝胆实火,清三焦湿热。

【适应证】 脑动脉硬化性精神病等,证属肝胆实火扰动元神者。

【方药简析】 方以龙胆草泻肝胆实火,除下焦湿热为主药;黄芩、栀子协助清湿热为辅药;泽泻、木通、车前子引火从小便而出,归尾活血,生地黄养血益阴,柴胡舒畅肝胆,甘草调和诸药,共为佐使。各药合用泻中有补,清中有养,即泻肝火清湿热,又能养阴血。张觉人用本方为基础方加入石决明、龙齿、菊花治疗本病有良效。

【病案举例】 周某,女,52岁,教师,1987年7月15日诊。中风(脑血栓形成)半年余,经中西医治疗,口喎、语蹇、偏瘫悉瘥。惟近半月来,头痛头晕,两颞发胀,失眠多梦,面红耳赤,口苦心烦,兴奋骚动,急躁易怒,常与人因小事而发生争吵不休。伴肢体麻木,血压24.0/14.7kPa。诊断为脑动脉硬化性

3月,痴呆面容消失,反应较前灵敏,步履变稳,记忆较过去明显增强。嘱改用天麻丸、白金丸,以巩固善后[张觉人,新中医,1991,(7):51]。

【方名】 黄连温胆汤。

【组成】 黄连 3g,半夏 10g,陈皮 10g,茯苓 10g,甘草 5g,生姜 10g,竹茹 10g,枳实 10g。

【来源】 陆廷珍《六因条辨》。

【功效】 化痰泻火。

【适应证】 失眠、心烦及老年脑动脉硬化性精神病,证属痰火内扰者。

【方药简析】 方中所标药物份量系编者所加。本方是由清化痰热之温胆汤中加黄连直拆心火,以使火泻、痰去、神安。张觉人用本方为基础方,痰火扰神而兴奋不安者加莲子心、胆南星、川贝母;夜寐不安加夜交藤、石菖蒲等;腑实者加大黄或合小承气汤等。治疗本病有良效。

【病案举例】 陈某,男,60岁,教师,1985年10月15日诊。中风(脑血栓形成)年余,经中药、针灸治疗,病情好转,可以跛行。近半月来,情感易激动,兴奋骚动,暴哭暴笑,言语不休,语无伦次,面红耳赤,肢体震颤麻木,动作不稳,大便秘结。诊断为脑动脉硬化性精神病。中医症见:主症如前,舌红苔黄腻,脉弦滑数。症系腑实痰火上扰,神志逆乱。治宜泻火涤痰,以安元神。方用小承气汤合黄连温胆汤加减。处方:生大黄(后下)、莲子心各6g,黄连3g,枳实、橘红、姜半夏、茯苓、淡竹茹、胆南星各10g,生甘草5g。连服10剂,大便通畅,性情平静如常,舌面黄腻苔退尽,质色转为淡红,续予调理而瘥[张觉人,新中医,1992,(3):56]。

【方名】 黄连豁痰汤。

【组成】 黄连粉 3g, 栀子 6g, 生地黄 10g, 竹茹 10g, 玄参 30g, 麦门冬 10g, 黄芩 6g。

【来源】 傅仁杰等, 中医杂志, 1991, (4): 24。

【功效】 清心豁痰, 醒神开窍。

【适应证】 多发梗死性痴呆(心火亢盛、痰火内扰型)。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中以黄连粉内服, 清心泻火且豁痰醒神; 黄芩、栀子协助黄连泻火清心; 生地黄、玄参、麦门冬养阴生津; 竹茹清化内扰之热痰。诸药合用可清心豁痰、醒神开窍。傅仁杰等以本方为基础方, 痰多色黄者加天竺黄、竹沥水、瓜蒌; 大便干结不下者加大黄、元明粉。治疗初期一般给予通络熄风注射液(黄芪、赤芍、川芎、丹参等中药提取有效成分制成), 每次用 2g, 加入 5% 葡萄糖溶液中静脉滴注, 每天 1 次, 用 15~30 天。伴有严重高血压、冠心病、糖尿病等给予相应的药物治疗。本病 18 例(按 4 型划分, 本型 5 例)经上述治疗 1~3 周, 痴呆症状部分改善者 10 例(心火亢盛、痰热内扰型 4 例, 肝肾阴虚、肝阳上亢型 2 例, 气虚血淤型 3 例, 髓海不足型 1 例), 症状无改善或加重者 8 例, 症状改善率为 55.6%。偏瘫、失语等神经功能缺损症状及临床功能改进者 14 例, 占 77.8%。

【病案举例】 刘某, 男, 66 岁, 因走路不稳、言语不利、伴情绪明显改变 2 个月, 于 1990 年 2 月 1 日入我科住院治疗。患者从 1989 年 12 月起渐出现走路不稳、言语不利、左侧上下肢静止性震颤, 同时情绪明显改变, 记忆力减退, 易急躁紧张, 强迫思维, 遇事解释不清, 小便有时不能自制, 心烦失眠。CT 示双侧脑梗死、脑萎缩, 用脑益嗪等治疗症状无明显改善, 否认有冠心病、糖尿病病史。入院查体: 血压 21.0/13.0 kPa, 神志清楚, 表情淡漠, 近事记忆差, 远事记忆尚可, 计算能力下

降,定向力正常。情绪表现为焦虑、强迫,人格尚完整。眼球活动可,双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏。口角无喎斜,听力可,颈软无抵抗,四肢肌力均 IV 级,左侧上下肢肌张力轻度齿轮样增高,双手动作笨拙,碎步前冲步态,左上下肢腱反射活跃,病理征未引出。西医诊断:① 双侧脑梗死。② 多发梗死性痴呆。③ 震颤麻痹。中医症见:主症如前,舌质红,舌苔黄厚,脉弦滑。中医辨证为痰火上扰兼阴虚风动之证。治以清火豁痰、育阴熄风。处方:黄连粉 3g(分冲),黄芩 6g,栀子 6g,决明子 30g,玄参 30g,麦门冬 10g,生地黄 10g,枳实 10g,柏子仁 10g。3 剂,水煎服。服上药 3 剂后,病人自觉走路较前有力,大便自解,睡眠好转,急躁情绪改善,但仍有强迫小便症状。继服上药 4 剂,震颤减轻,小便排出较顺利,强迫症状部分改善。再服上方 6 剂,震颤停止,睡眠佳,小便基本能顺利排出,可独自行走 50~60m,症状明显改善,继续予上方加通络熄风注射液治疗。

【方名】 黄连解毒醒脑汤。

【组成】 黄连 6g,黄芩 10g,山栀 1g,生地黄 12g,玄参 12g,当归 10g,川芎 8g,丹参 15g,丹皮 8g,石菖蒲 10g,郁金 10g,远志 8g。

【来源】 傅仁杰,北京中医杂志,1988,(5):27。

【功效】 泻火清心,化淤通络,醒神开窍。

【适应证】 脑血管性痴呆,证属心火亢盛者。

【方药简析】 本方系由黄连解毒汤化裁而成。方中黄连清心泻火;黄芩、栀子,以加强泻火清心之力;生地黄、玄参、当归、川芎、丹参、丹皮、郁金凉血养阴活血化淤通络,石菖蒲、远志化浊开窍醒神。全方清心泻火、化淤通络、醒神开窍。本方水煎服,10~20 天为 1 疗程,或为蜜丸连服 3 个月。若实火

伤阴、肾经真水欲绝者配合补肝益肾、生津润燥，加花粉、葛根；若肝肾阴虚突出者，去黄芩加何首乌、五味子、山茱萸。傅仁杰用本方为主，按上述加减治疗本病有良效。

【病案举例】 谢某，男，64岁，干部，以左侧肢体活动不利，口角歪斜两个月，智能下降，答非所问1个月而入院治疗。患者于两个月前在清醒状态下，突然出现口角向左侧歪斜，左侧肢体活动不灵，1周后病情加重，即入当地医院治疗，诊断为“脑血栓形成”。曾给予中药脑立清、大活络丹、人参再造丸、醒脑静等，西药曾服复方降压片、潘生丁、芦丁、抗栓丸等治疗1个月，口角歪斜基本消失，肢体活动明显改善，惟两腿无力，走路不稳，其后逐渐发现神情呆滞，智力减退，记忆力不佳，说话杂乱无章，计算力差，答非所问，走出病室后回来找不到自己病室。饮食量多（每日主食米饭馒头约750g），小便黄，大便干，舌红苔黄，脉弦滑而数。既往有高血压病史8年，平时血压在20.0~21.0/12.5kPa，最高可达24.0/12.5kPa，经常服降压药物；发现糖尿病7年，曾服降糖灵。否认其他传染病史。检查：一般状态尚可，体温36.1℃，呼吸16次/min，脉搏88次/min，血压19.0/12.0kPa；神志清楚，自动体位，神情呆板，形体肥胖，面色红润有光泽，二目红赤；左侧鼻唇沟稍浅，皮肤粘膜正常，淋巴结不大，颈部无抵抗；语言欠流利，反应迟钝，答非所问；胸廓对称无畸形，双肺呼吸音清，叩诊清音，心率86次/min，律整，心脏各瓣膜区未闻及杂音；腹部平坦柔软，肝脾无肿大，左侧肢体活动不利，肌力Ⅳ级，肌张力增高，左侧感觉减退，右侧肢体活动自如，生理反射存在，病理反射未引出；血常规及血沉、肝功均在正常范围，胆固醇4.40mmol/L，甘油三脂3.3mmol/L，血糖7.44mmol/l，尿糖（+）；头颅CT示左侧基底节区内囊膝部梗死灶。西医诊断：①右侧大脑中动脉血栓形成，轻度左半身不遂；②脑血管障碍性痴呆；③糖尿

病、中医分析：患者年高体弱。阴气自半，水亏火旺，肝肾亏损，脑髓失养则神明失聪，智能下降；心火亢盛，热扰心神，肝阳化风，中于经络则错语不眠、半身不遂、火热灼伤津液，胃火炽盛则消谷善饥。中医诊断：①中风（肾阴不足，肝阳化风，阻于经络）；②文痴（心火亢盛，热扰神明）；③消渴（热灼津液，胃火炽盛）。以中医治疗为主，采用抑阳扶阴、泻心经亢盛之实火、滋肾经欲绝之真水，配合补益肝肾，生津润燥、化淤通络、醒神开窍之品。方以黄连解毒醒脑汤化裁：黄连 6g，栀子 10g，生地黄 12g，玄参 12g，天花粉 15g，当归 10g，丹参 15g，葛根 10g，石菖蒲 12g，郁金 12g，远志 10g。水煎服。上方连服 7 剂，自觉头脑转清，精神及表情呆滞亦有一定好转，睡眠增多，口渴善饮减轻，舌质红苔薄黄，脉弦细而数，心经之火渐退，肝肾阴虚之本渐显。原方去黄芩、葛根，加何首乌、五味子。服 7 剂后，精神清朗，智能逐渐恢复，思维合理，走出病区后能自己回到病室，问答切题，肢体活动接近正常，脉象弦细。效不更方，以上方为基础加减变化，连服共 30 余剂，并配合针灸、语言及肢体功能训练等进行综合治疗后，患者的饮食、行动、思维、肢体运动等基本恢复正常，各项理化检查基本正常，生活可自理，痊愈出院。

【方名】 半夏白术天麻汤。

【组成】 半夏 9g，天麻 6g，茯苓 6g，橘红 6g，白术 9g，甘草 2g，生姜 1 片，大枣 2 个。

【来源】 程钟龄《医学心悟》。

【功效】 化痰熄风，健脾祛湿。

【适应证】 脑血管性痴呆，证属风痰上扰者。

【方药简析】 本方由二陈汤、白术、天麻而成。方中以半夏燥湿化痰，天麻熄风止眩晕，合用共除风痰为主药；白术、茯

苓健脾祛湿,以治生痰之源为辅药;橘红理气化痰,甘草、生姜、大枣调和脾胃,均为佐使药。全方化痰熄风、健脾祛湿。张觉人以本方为基础方加石菖蒲、郁金、浙贝母、远志、僵蚕、炒水蛭、益智仁治疗本病有良效。

【病案举例】 朱某,男,57岁,干部,1991年5月15日就诊。患者有高血压病10余年。1988年3月12日,突然跌倒,失语伴右侧肢体偏瘫而入市某医院,头部CT扫描示:左壳核脑血肿(40mm×63mm×30mm)。经救治93天。可由人搀扶行走而出院。惟近3年来,家属发现其神情逐渐呆滞,言语蹇涩,记忆力明显障碍,判断能力减退,计算困难,书写思维障碍,性格变异,固执,常无故吵闹。西医诊断:脑血管性痴呆。中医症见:主症如前,头晕重着,胸闷呕恶,舌淡紫暗,苔白厚腻,脉象弦滑。证系风痰上扰,阻蔽清窍。治宜化痰熄风、开郁通窍。处以本方,日1剂,每煎服2次。守方连服半年,加核桃肉10g、肉苁蓉10g、枸杞子10g以填髓益脑。患者记忆力明显增强,再少有失认,可以计算2位数加减法,并能抄写较为工整的中文字体。家属诉其思维较年前连贯,说话句子变长,不再颠三倒四,面部表情不似前呆板,舌淡红苔薄白。投填髓化痰品巩固善后[张觉人,上海中医药杂志,1995,(3):27]。

【方名】 涤痰化淤汤。

【组成】 半夏、茯苓、枳实、石菖蒲、郁金、竹茹、僵蚕各10g,胆南星、天麻各12g,丹参30g,陈皮、甘草各6g。

【来源】 杜曦,浙江中医学院学报,1995,(1):25。

【功效】 涤痰开窍,化淤通络。

【适应证】 脑血管性痴呆、阿尔采默性痴呆属痰阻血淤者。

【方药简析】 方中以温胆汤为主;胆南星、石菖蒲涤痰;

主;麝香、石菖蒲开窍醒神活血散结为辅;加黄芪、当归、枸杞子补血益气,山楂消积化滞并降低血液粘稠度,生姜助药力行散,大枣补中共为佐使。诸药合用益气化淤、活血通窍。若头痛加天麻、夏枯草;耳鸣、耳聋加蝉蜕、熟地黄;语言不利加路路通、大蝴蝶;失眠健忘加炒枣仁、丹参、琥珀;烦躁易怒加菊花、鳖甲、炒栀子;兼阴虚加制首乌、生地黄;气滞加枳壳、木香;兼痰浊加竹茹、远志。谢长颜用本方为基础方按上述加减治疗本病7例,结果显效(头晕头痛、耳鸣(聋)、语蹇、疲乏、不寐、健忘等症基本消失,近记忆力基本恢复,注意力集中,情绪稳定,喜怒有节,脑局灶损害CT和脑血流图检查明显恢复)5例,有效(头晕头痛、耳鸣(聋)、疲乏、不寐、健忘等症减轻,近记忆力有所恢复,但不够准确,注意力略集中,情绪较稳,有时喜怒不能自控,脑CT和脑血流图复查有改善)2例,无效(治疗1~2个疗程(每个疗程30天),症状及辅助检查无变化甚或加重)0例。总有效率为100%。服药多在半月后显效,随着疗程增加,效果愈明显。临床观察,症状改善和脑局灶性损害CT检测等不成正比,但脑血流量有明显改善,说明脑部血液循环及供氧经治疗均有好转,淤滞症状缓解。

【病案举例】 喇某,男,69岁,退休医师,1985年12月27日初诊。主诉:左侧肢体运动不利,舌强语迟3天,情绪不稳,哭笑无常,大、小便失控。入院检查神情淡漠,皮肤有老年斑,书写其名不认识,问其不知多大岁数,一般数字运算不能辨认,左上肢肌力Ⅱ级,左下肢Ⅳ级,舌胖淡暗,苔薄白脉弦紧。血压23.0/11.0kPa。头部CT报告:“右侧基底节及顶枕叶见片状,低密度灶,边清楚,右侧脑室扩大,中线结构无移位”。诊为脑动脉硬化性痴呆。中医辨证为年高久病,肝肾阴亏,气虚血淤。本方加夏枯草、代赭石、熟地黄、制首乌、炒枣仁等,煎服,每日1剂,并用脑得生4片每日3次口服。用本方

前后增损服 50 多剂,查肌力提高 I 级,精神状态良好,语清,大小便自控。随访出院至今,疗效巩固。

【方名】 补阳还伍汤。

【组成】 生黄芪 60g,当归尾 6g,赤芍 6g,地龙 3g,川芎 3g,桃仁 3g,红花 3g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 补气、活血、通络。

【适应证】 中风后遗症,脑血管性痴呆等,气虚血淤、痰阻脑窍者。

【方药简析】 本方是由补气药与活血祛淤药相配伍而成。方中重用黄芪补气,使气旺血亦行,祛淤而不伤正,为主药;辅以归尾、川芎、赤芍、桃花、红花、地龙活血通络。全方重用生黄芪,取其力专性走,周行全身,以助推动诸药之力,使气旺血行、淤祛络通。张觉人以本方为基础方,加入僵蚕、全蝎、蜈蚣、水蛭、天麻、海蛤壳、浙贝母、石菖蒲、通天草、郁金、丹参、葛根等治疗本病有良效。

【病案举例】 叶某,男,56岁,1990年5月22日入院。患者7个月前猝感头目晕花,后进行性头晕目眩加剧,临厕时大小便失禁,逐渐少语,整日呆坐,纳减多寐。遂去某医学院附院诊治,作脑CT检查报告:双侧基底节区多发脑梗死。诊断为脑动脉硬化性痴呆。中医症见:表情痴呆,语声低怯,言语涩,言辞颠倒,近事记忆差,举动不径,间或大小便失禁,颜面晦滞,肢软乏力,舌淡黄、苔白腻。病系气虚血淤、痰阻脑窍。治宜益气化淤通络,兼以涤痰开窍。方用补阳还五汤合菖蒲郁金汤加味。处方:黄芪 50g,红花 8g,赤芍、川芎、地龙、桃仁、石菖蒲、郁金、竹茹、远志、浙贝母各 10g,当归、僵蚕各 12g,全蝎 5g,丹参 30g。日 1 剂,煎 2 次服。守方迭服 50 余剂,患者精神

明显好转。颜面渐有表情，主动与旁人交谈，喜欢下床活动，遗忘近事减少，大小便能自控，头目眩晕消失，后出院巩固治疗[张觉人，新中医，1991，(7)：51]。

【方名】 六桃汤。

【组成】 熟地黄 30g，山萸肉 15g，山药 15g，茯苓 10g，泽泻 10g，丹皮 10g，桃仁 12g，桂枝 6g，大黄 12g，芒硝 6g，炙甘草 6g。

【来源】 胡杰一等，河南中医，1992，(5)：226。

【功效】 滋肾益阴，活血化淤。

【适应证】 脑血管性痴呆，证属肝肾阴虚、淤血阻蒙神明。

【方药简析】 本方所标药物份量为编者所加。方中以六味地黄丸滋肾益阴，桃核承气汤活血化淤，2方合用祛实补虚、标本兼顾。若以淤血为主时加丹参、郁金；若淤血渐退，肾阴亏虚渐显，去桃仁、桂枝加制首乌，并配合电针、心理疗法、语言及肢体功能训练。胡杰一等用本方为主，按上述加减治疗本病 62 例（包括痰火为主者、肝肾阴虚为主者，脾虚痰浊为主者，髓海不足为主者 4 种不同主证类型），结果，基本痊愈（近事记忆基本恢复，能较正确判断时间，别人讲话能够理解，并能进行一般会话，能短时间走路，进餐基本自理，大、小便尚可，可干复杂家务者）15 例；显效（远事记忆尚可，对讲话、手势以及复杂动作尚能理解，可讲极简单的话。帮助可用餐，能干极简单的家务者）20 例；有效（偶尔能回忆往事，能认识家人亲友，但说不出名字者）20 例；无效（症状体征无明显改善者）7 例。总有效率为 88.7%。

【病案举例】 李某，男，50 岁，工人，以言语蹇涩，多疑妄想，智力下降，右侧肢体活动不利 3 年，于 1986 年 10 月 9 日

入院治疗。患者于10年前因故诱发精神失常,言语错乱,行为离奇,曾在某省精神病院按精神分裂症治疗数年,效果不佳。近3年来,发现患者言语蹇涩,多疑妄想,智力下降,记忆力减退,计算力差,有时找不到家门,右侧肢体活动不利,大便干。既往有滑精、脱肛、痔疮下血病史10年余,其间曾求诸中西医治疗(服药杂乱),均未获验。体检:体温36.8℃,心律87次/min,血压18.9/12.3kPa,神志清楚,自动体位,表情呆滞,形体丰腴,面色灰黯,右侧鼻唇沟稍浅,言语欠流利,反应迟钝。右侧肢体活动不利,肌力Ⅳ级,肌功能均正常。头颅CT示左侧基底节内膝部血栓形成。西医诊断:a.左侧大脑中动脉血栓形成,右半侧轻瘫;b.脑血管障碍性痴呆。中医症见:舌质紫、苔黄,脉弦滑数。证属血瘀为患,阻蒙神明,故发癫狂。滑精、痔疮下血缠绵不愈,俾精血渐损,血虚肝阳化风,中于经络,肢体活动不利。中医诊断:a.中风(阴血不足,肝阳化风,中于经络);b.文痴(血瘀阻内,神明不用)。治以滋肾益阴、活血化淤之法。方用六桃汤加减:熟地黄15g,山茱萸10g,怀山药10g,泽泻10g,丹皮10g,茯苓30g,桃仁泥10g,桂枝12g,生大黄9g(后下),玄明粉9g(入药汁内服),生甘草6g,丹参30g,石菖蒲12g,郁金24g,水煎服。服药1剂后,大便通下。遂予上方去生大黄、玄明粉续服。同时服用槐角丸,每次9g,每日2次。10剂服后,自觉头脑较清,精神较佳,表情亦有一定好转,舌质紫变浅,舌苔薄黄,脉弦细数。淤血渐退,肾阴虚亏渐显,原方去桃仁、桂枝,加制首乌20g。服10剂后,神情清爽,智力渐复,思维合理,滑精及痔血皆止,肢体活动接近正常,脉弦细,效不更方。以此方(停服槐角丸)共连服40余剂,并配合电针、语言及肢体功能训练等综合治疗后,患者行为、思维、肢体运动等恢复正常,生活自理,基本痊愈出院。

【方名】 定智汤。

【组成】 生地黄、熟地黄各 12g,丹参 20g,当归 10g,枸杞子 12g,龟板 12g,阿胶 12g,党参 12g,炒枣仁 10g,柏子仁 10g,龙骨、牡蛎各 20g,茯苓 12g,远志 6g,珍珠母 40g,沉香末 2g(冲服)。

【来源】 傅仁杰,北京中医杂志,1988,(5):27。

【功效】 滋补肝肾,熄风定智。

【适应证】 脑血管性痴呆,肝肾亏损型。

【方药简析】 方中主以生地黄滋阴清热,熟地黄滋阴补血;辅以丹参、当归、枸杞子养血活血,与龟板、阿胶之血肉有情之品配用可共同协助主药填补精血,滋补肝肾;佐以党参健脾益气,炒枣仁、柏子仁、龙骨、牡蛎、茯苓、远志、珍珠母养心平肝安神;沉香行气温中调脾胃,防诸药滞塞气机。全方滋补肝肾、熄风定智。本方水煎服 30~40 天为 1 个疗程,或蜜丸常服 3 个月。若见心火亢盛者可加黄连,若肾精不足突出时加河车粉、猪脊髓。傅仁杰用本方为基础方按上述加减治疗本病有良效。

【病案举例】 孟某,男,70 岁,干部,左上下肢麻木活动不灵 20 天,伴智能下降 1 周。该患者于 5 月 21 日起左手指麻木,次日夜小便后手指麻木加重,不能握物,渐左下肢亦麻木,舌强语蹇,口角歪斜,左半身感觉障碍,直至上下肢完全瘫痪。当地医院诊为“脑血栓形成”。先后用丹参注射液、脉通、维脑路通、抗栓丸等治疗。11 天后出院,但左侧肢体麻木、活动不灵仍未改善,同时出现反应迟钝、记忆力减退、回答问题不确切、计算数字能力明显下降及言语不流利等症。检查:神志清楚,两目瞳孔等大等圆,左侧鼻唇沟变浅,伸舌右偏。左侧上下肢活动不利,右侧肢体运动自如,左侧上下肢肌力Ⅱ级,肌张力高,左侧肢体感觉减退,左下趾关节位置感觉消失,指鼻

试验、跟膝胫试验呈阳性，腱反射亢进，左侧 Babinski 征、Chaddock 征、Oppenheim 征、Garden 征均呈阳性。舌质红，苔薄黄而腻，脉象弦滑而数。化验：胆固醇 3.26 mmol/L，甘油三酯 1.36 mmol/L，纤维蛋白元测定 360 mg/dL，凝血酶元时间 17"；X 线示主动脉型心脏，B 超检查肝胆胰未见异常，心电图大致正常，头颅 CT 示多发性梗死灶，右侧额顶叶可见 42 mm × 35 mm 低密度区。西医诊断：① 右侧大脑中动脉血栓形成，左侧肢体偏瘫；② 脑动脉硬化症；③ 高血压病 III 期。中医诊断：① 中风（肾虚风阳上亢，瘀血阻络）；② 眩晕（肾精不足，肝阳上亢）；③ 文痴（肾水不足，心火亢盛）。拟滋补肝肾、通络醒神之法。方用：何首乌 15g，生地黄 12g，山茱萸 12g，阿胶 12g，丹参 15g，当归 10g，黄连 6g，栀子 10g，郁金 12g，石菖蒲 12g，远志 8g，五味子 10g。此方服 6 剂后，患者神志较前清爽，头晕减轻，可以在别人搀扶下跛行 10 余步。左侧肢体肌张力仍高，足跟着地无力，神情呆滞，反应迟钝，口角已无明显的歪斜。饮食增加，大便调均，舌质红苔薄白，脉弦而细。左上肢肌力 IV 级，腱反射亢进，Hoffmann 征、Babinski 征及 Chaddock 氏阳性。肝肾阴虚，肾精不足仍在。治宜补肾益髓、醒神开窍为主。何首乌 15g，生地黄 12g，山茱萸 12g，龟板胶 12g，丹参 20g，淮山药 15g，石菖蒲 12g，河车粉 2g（冲），当归 12g，郁金 12g，远志 10g，猪脊髓 4g（烘干冲服）。上方共服 30 余剂，并配合牛黄心丸每日 2 丸，共治疗 1 个月余，精神恢复，语言流畅，问答切题，口无歪斜，夜寐亦安。惟留走路蹒跚，左侧肌张力增高，左侧肢体肌力恢复至 IV ~ V 级，腱反射亢进，Babinski 征可疑阳性，上肢抬举能平肩。好转出院。

【方名】 加味左归丸。

【组成】 熟地黄、龟板（先煎）各 30g，山茱萸、枸杞子、何

首乌、山药、牛膝各 15g,菟丝子、鹿角胶(烊化冲服)各 12g,赤芍 15g,丹参 20g,石菖蒲、远志各 10g。

【来源】 蔡春华,江苏中医,1994,(11):9。

【功效】 滋补肝肾,充养脑髓,化淤通络。

【适应证】 脑血管性痴呆,肝肾阴虚型。

【方药简析】 本方是由左归丸加味作煎剂。方中用熟地黄、枸杞子、山茱萸、何首乌、山药滋补肝肾之阴;鹿角胶、龟板等血肉有情之品填精补髓养阴;菟丝子、鹿角胶能温补肾阳,从阳引阴;牛膝补肾强壮腰膝;因老年性痴呆多伴有痰淤阻络,所以佐用赤芍、丹参、石菖蒲、远志等活血通络化痰之品。全方具有滋补肝肾、充养脑髓、化淤通络的作用,且性质平和、久服无碍。每日 1 剂,水煎服,50 天为 1 个疗程。若眩晕头痛,加龙骨、牡蛎、石决明、菊花、天麻平肝潜阳;若视物不清,加女贞子、草决明养阴明目;若肢体瘫痪疼痛,加鸡血藤、丝瓜络、路路通活血通络。蔡春华以本方为基础方,按上述加减用药,治疗本病 31 例,1 个疗程后,显效 16 例(主要症状基本消失,神志清醒,定向健全,回答问题正确,反应灵敏,生活自理,能进行一般社会活动),占 51.6%;有效 10 例(主要症状部分消失或有所减轻,生活基本自理,回答问题基本正确,但反应尚迟钝,智力与人格仍有部分障碍),占 32.3%;无效 5 例(主要症状无改变,病情有发展,生活不能自理,回答问题不正确,神志痴呆),占 16.1%。

【病案举例】 徐某,男,64 岁,1991 年 4 月 11 日初诊。患者 1 年前丧偶后表现性格固执,急躁易怒,迟钝,健忘,眩晕头痛,耳鸣,偏左侧半身麻木。有疑病妄想,总是疑虑自己患有肝癌、胃癌等不治之症,异常恐惧,虽经多次肝功能、B 超、上消化道、胃镜等检查(均正常),但仍精神紧张,夜眠不安,面色潮红。查舌红少津,脉弦细。经 CT 检查提示:脑实质内多发性

软化灶。西医诊断：脑血管性痴呆。中医诊断：老年性痴呆。证属肝肾阴虚，虚阳上扰。治宜滋补肝肾、育阴潜阳，佐以化淤通络。方药：熟地黄、龟板（先煎）各 30g，枸杞子、山茱萸、何首乌、山药各 15g，石决明（先煎）、珍珠母（先煎）各 20g，赤芍、白芍各 12g，牛膝、刺蒺藜、丹皮各 12g，丹参 20g。服药 20 剂后，头痛眩晕明显好转，夜间能安寐。原方去石决明、珍珠母，加菟丝子、鹿角胶（烊化冲服）各 12g。又继服 30 剂，患者情绪安定，记忆力增强，能正确回答问题，并能从事简单的家务劳动。

55 老年性精神病及早老性精神病

老年性精神病或早老性精神病,也称为老年性痴呆或早老性痴呆(SDAT 或 AD),为老年期常见疾病之一,发病率为2%~8%。本病病理基础为神经原纤维缠结和老年斑,导致大脑的慢性萎缩。多隐袭起病,最早出现性格改变。患者变得顽固迂执,自私自利,好发牢骚,疑窦丛生,过份关注自己的健康,兴趣减退,灰心丧志,言语罗嗦;或一反往常,不修边幅,生活懒散,不爱整洁,或足不出户,日益与社会隔绝;或放荡不羁,挥霍任性,暴躁易怒。随着病程进展丧失羞耻感、义务感、责任感,不听劝海,冷酷无情;智能改变,近事记忆最先受累,可发生错构和虚构。以后理解、判断、计算等智能活动全面下降,情绪反应幼稚,行为荒诞无稽。后期日常生活不能自理,大小便失禁,进食不知饥饱,出门不知归途,收集废品,言语杂乱不清。末期整日卧床,精神功能几乎丧失殆尽。在病程早期心理代偿反应而出现被窃妄想、疑病妄想、被害妄想、贫穷妄想、夸大或嫉妒妄想,部分病人可发生片断的听、视幻觉,随痴呆加重而逐渐消退。在渐进的病程中患病、创伤、镇静药物过量、急性精神创伤等因素可诱发老年性谵妄,出现精神症状急剧恶化(定向不全、思维不连贯、紧张焦虑和行为紊乱),如能妥善处理,祛除病因,意识可恢复。也有以谵妄起病,嗣后出现人格和智能改变。近年由于脑CT的普遍应用,临床上常着重于以本病脑萎缩的病理改变作出诊断。本病须与发生于老年期的抑郁症,脑血管病引起的失语、失用、失认等神经症状及动

溪；下肢取主穴环跳、阳陵泉、足三里，配以绝骨、解溪、太冲、太溪、冲脉等。于神阙、关元、血海、足三里施灸。治疗脑萎缩共济失调症 1 例，三个月而基本痊愈[江苏中医，1987，(3)：27]。

二是配合食疗，如食用兔或猪脑、脊髓、核桃、大枣，新鲜蔬菜水果，可起到辅助治疗作用。

三是本病在临症辨证时，往往几种证型同见，尤其是常为虚实夹杂，而且各型之间又互为因果，相互转化，所以宜根据临床具体情况，互相参照，灵活施治，并应注意慎用攻伐。

四是本病病情常呈慢性进行性发展，因此病程较长，治疗难收速效，一般疗程宜在 3 个月以上。但如果治疗 1 个月后仍未见效，则应重新辨证，调整方药；如果治疗有效，则不宜为急于求成而过多变动方药。更不宜骤然停药或改服其他药物，否则易导致病情反复。

五是本病治疗中，病人切忌跌仆倾倒及脑部外伤，同时尽量预防感染发热，避免情绪的大起大落，并不宜频繁进行各种头颅检查，否则常可在已取得疗效之时而功亏一篑，甚至导致病情的急剧恶化而难以再度奏效。

【方名】 四二宣窍汤。

【组成】 白芍 15g，柴胡 10g，枳壳 10g，陈皮 10g，半夏 10g，茯苓 20g，瓜蒌 10g，胆南星 10g，香附 10g，龙齿 30g，郁金 10g，石菖蒲 10g。

【来源】 王仕鑫，山东中医杂志，1992，(2)：35。

【功效】 解郁调痰宣窍。

【适应证】 老年性痴呆，证属肝气郁、脾失健运、痰浊蒙蔽清窍者。

【方药简析】 本方是由四逆散合二陈汤化裁而成。方中

以四逆散透解郁热、疏肝理脾,以二陈汤燥湿化痰。2方合用助肝条达、脾得健运,可解郁化痰;配以瓜蒌、胆南星以助祛胸中积痰;配香附、郁金理气开郁,龙骨镇静安神,石菖蒲开窍醒神。全方解郁蠲痰宣窍。张子仪用本方配食大枣、葵花子及心理调护治疗本病有良效。

【病案举例】 刘某,男,70岁,1990年5月就诊。患者中年丧妻,与长子同居,其子性情暴躁,常同妻吵架,父则抑郁不乐,两目常呆滞,少言。一日又遇儿、媳口角,遂目瞪不瞬,时傻哭傻笑,时喃喃独语,自责自罪。经潍坊市某医院做脑部CT扫描,示脑萎缩,诊断为老年性痴呆。延医数人罔效,求张师诊治。查舌质红、苔白腻,脉弦滑无力。予解郁蠲痰宣窍法。方投自拟四二宣窍汤,水煎服,每日1剂。先后守方出入调治服药70余剂,神识清晰,未再见傻哭傻笑现象,待人接物如常。调护:改善环境,避免郁怒,务使心情舒畅,适当参加社会活动。常食大枣、葵花子。

【方名】 半夏白术天麻汤。

【组成】 半夏 9g,天麻 6g,茯苓 6g,橘红 6g,白术 9g,甘草 2g,生姜 1片,大枣 2枚。

【来源】 程钟龄《医学心悟》。

【功效】 化痰熄风,健脾祛湿。

【适应证】 早老性精神病,证属痰邪阻闭脑窍者。

【方药简析】 本方即由二陈汤加白术、天麻而成。方中半夏燥湿化痰,天麻熄风止眩,2味药合用善除风虚内作之痰,为主药;白术、茯苓健脾祛湿,以治生痰之源为辅药;橘红理气化痰,甘草、生姜、大枣调和脾胃,共为佐使药。全方化痰熄风,健脾除湿。张觉人以本方为基础方,加麝香(或以藁本、白芷合而代之)、石菖蒲、远志、杏仁、浙贝母、丹参、郁金、益智仁治疗

本病有良效。

【病案举例】 黄某,女,58岁,会计员,1991年7月20日就诊。患者记忆力明显减退3年余。外出坐车常迷失方向,计算障碍,思维常无故中断,健忘,反应迟钝,面部表情呆板。于1991年7月12日在市某医院做脑CT诊断“轻度脑萎缩”。诊断为早老性精神病。中医症见:主症如前,头重如蒙如裹,脉象弦滑。证系风痰上扰,窍蔽神蒙。治拟化痰熄风、开郁透窍。处方以半夏白术天麻汤合菖蒲郁金汤加味:天麻10g,白术10g,橘红10g,姜半夏10g,茯苓10g,甘草8g,石菖蒲10g,郁金10g,远志10g,杏仁10g,浙贝母10g,白芷10g,藁本10g,益智仁10g,丹参18g。日1剂,每煎服3次,守方连服3个月,患者表情不再呆板,诉头部感觉清爽,记忆力、计算力增强,未出现外出迷路现象,舌苔转薄白。嘱服天麻丸巩固善后[张觉人,上海中医药杂志,1995,(3):27]。

【方名】 新加半夏白术天麻汤。

【组成】 半夏15g,陈皮15g,石菖蒲20g,泽泻15g,天麻15g,钩藤(后下)30g,菊花15g,白术15g,苍术15g,茯苓30g,党参20g,砂仁10g,木香10g,葛根30g,甘草6g。

【来源】 陈立富,四川中医,1993,(10):26。

【功效】 健脾渗湿,化痰熄风。

【适应证】 脑萎缩,证属风痰上扰者。

【方药简析】 方中所标药物份量系编者所加。本方是由半夏白术天麻汤加减而成。方中取半夏、陈皮、石菖蒲、泽泻化痰降浊;天麻、钩藤、菊花息风定眩;白术、苍术、茯苓、党参健脾渗湿;砂仁、木香行气和中;葛根升举清阳之气,使清阳得升、浊阴得降;甘草调和诸药。全方健脾渗湿,化痰熄风。陈立富用上方治疗本病有良效。

【病案举例】 李某,男,67岁,因头晕目眩、站立不稳2年,加重半年,于1991年5月15日入院。两年前无明显诱因渐感头晕、目眩、站立不稳。曾在某省医院做CT检查,诊断为“脑萎缩”。1991年5月3日复查CT示:额顶叶脑皮质萎缩。服用脑复新、维脑路通、肌苷等药物,病情无好转。半年来症状加重,伴恶心、胃脘撑胀,食欲不振,健忘,眼干,面色萎黄,步态蹒跚,站立时身摇不定。舌质暗红、苔白厚腻,脉弦。中医诊断为健忘。证属风痰上扰。拟本方以化痰息风定眩:半夏、白术、苍术、天麻、菊花、陈皮、泽泻各15g,茯苓、钩藤(后下)各30g,砂仁、木香各10g,石菖蒲20g,甘草5g。水煎服,每日1剂。3剂后,眩晕减轻,食欲好转,胃脘撑胀消失。5月23日诊,头晕轻微,胃脘无不适,食欲基本正常,唯站立仍不稳;上方加龟板30g。5月31日诊,头晕不明显,恶心消失,双下肢痿软,站立不稳,苔转薄白。考虑肝肾不足,改以滋肾养肝息风为主:熟地黄、山药、茯苓、石菖蒲、枸杞子各20g,山茱萸、天麻、菊花、陈皮、泽泻各15g,龟板30g,甘草6g。服60剂,病情竟无好转,多寐,精神不振,胃脘胀满,舌苔增厚,遂改健脾渗湿化痰为主:党参、白术、石菖蒲各20g,茯苓、葛根各30g,泽泻、半夏、陈皮、天麻、菊花、枸杞子各15g,川芎10g,甘草6g。水煎服,每日1剂。头晕逐渐消失,精神稳健,饮食、睡眠均正常。随访至今,病未复发。

【方名】 益气聪明汤。

【组成】 人参12g,黄芪18g,炙甘草6g,升麻6g,葛根10g,蔓荆子10g,白芍12g,黄柏10g。

【来源】 王肯堂《证治准绳》。

【功效】 益气升阳,平肝降浊。

【适应证】 老年人因元气亏损、中气不足、风热上扰所致

的头痛眩晕、耳鸣、痴呆等。

【方药简析】 方中所标药物份量为编者所加。本方用药严谨,组方紧扣气虚阳浮之症,依益气升阳、平肝降浊法则而立。方中黄芪、人参、炙甘草大补元气为主;用葛根、升麻升举清阳;配白芍平肝敛阴、收引浮越之气;蔓荆子体轻性浮;黄柏苦寒引虚气于下以利降浊。使全方具有升降相宜、刚柔相济之效。据现代药理研究证明:本方诸药具有扩张血管、降血脂、镇静、防止脑微血管阻塞、改善脑细胞功能的作用,对老年脑病有显著的治疗和预防作用,特别是对调整老年人“本虚标实”和体内动态平衡易失调的病理、生理特点有很好作用。临床运用时若辨证为老年中气不足、清阳不升、痰浊上扰,用本方加枳实、竹茹、石菖蒲、夜交藤等化痰降浊、除烦宁神镇脑,收到升降平衡之效;若辨证为中气受损、痰浊内阻,以本方加苍术、法半夏燥湿化痰,天麻平肝熄风,郁金解郁宁心;若辨证为气阴两亏、脑失濡养,用本方加何首乌、麻仁养阴润肠,桑叶、菊花、龙骨、牡蛎疏风清热平肝,丹参养血活血、除烦安神。姚金汉用本方以参芪补中益气为主,按上述加减用药治疗老年性痴呆,所有病例达到中气康复、清升浊降、诸证痊愈的效果。

【病案举例】 陈某,男,58岁,1990年7月14日初诊。患者1989年11月因事患怒忧郁而发病。初为哭笑无常、语言错乱,继而意志消沉、表情淡漠、呵欠频作。中医症见:主症如前,舌胖质淡,苔薄白,脉细无力。查血压17.3/10.7kPa,CT报告“颅内无占位性病变,无梗死”。西医诊为:“早老性痴呆症”。中医辨证:患怒伤肝,忧思伤脾,中气受损,痰浊内阻。治宜补中益气、豁痰解郁。方用益气聪明汤加味。处方:黄芪18g,党参、天麻、法半夏各12g,葛根、白芍、郁金、苍术、石菖蒲各10g,升麻、远志各6g。服药40余剂,呵欠消失,识别能力渐增。再按原方增损调治2个月,能独自步行外出,心情欢畅而治愈[姚

含糊,语言错乱,阵阵躁动不安,对自己的姓名、年龄、住址均不能作答,却又否认自己有病。察舌质紫黯、苔垢腻,脉沉涩。恙由高年气血运行不畅、淤阻于内、蒙蔽神明而病癫狂。治当逐淤宁神、醒脑开窍。为议桃仁复苏汤。1986年12月17日二诊:药后神志清醒,对答得当,睡眠、饮食、二便均正常。舌质黯红、苔薄腻,脉和缓。除邪务尽,收效不更张,原方5剂,病愈。

【方名】 通窍活血汤。

【组成】 赤芍 12g,川芎 6g,桃仁 10g,红花 10g,老葱 1根,生姜 3g,红枣 5g,麝香 0.2g(冲)。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血通窍。

【适应证】 早老性痴呆等,淤水互结者。

【方药简析】 方中所标药物份量由编者所加。本方以赤芍、川芎、桃仁、红花活血化淤为主;配以老葱、麝香通阳开窍;生姜助药力行散,大枣补中。全方活血通窍。程运文以本方为基本方,将脑萎缩分为3型,脾阳虚损、淤水互结、脑失所养者合实脾饮加减;肝阳不足、淤水互结、脑失所养者合桂枝加附子汤、五苓散;肾阳虚衰、淤水互结、脑失所养者合右归饮、五苓散,本组患者4例,均在服药50剂左右临床症状消失,身体康复。

【病案举例】 齐某,男,54岁,工人,1986年4月29日初诊。近7个月来,经常头痛,头重脚轻,神疲乏力,渐至步履不稳,记忆力显著减退,吞咽困难,四肢不温。经某医科大附院脑血流图检查:脑血管弹性减退,右侧脑内动脉系统血管呈痉挛状态,提示脑动脉血流量减少。CT扫描:脑萎缩。胆固醇 7.25mmol/L,甘油三酯 2.37mmol/L,血压 20.0/11.0kPa。诊断为早老性痴呆。经中西医结合治疗一个月罔效。中医症见:主

症如前,舌暗淡,舌苔薄白滑,脉沉细。证属脾阳虚损、淤水互结、痹阻脑络、脑失所养。治拟温补脾阳,活血利水。方用:炮附子、干姜、白术、茯苓、党参、猪苓、车前子(包)、桃仁、红花、丹参、枳壳各 10g,泽泻、川芎各 30g。20 剂后,头痛偶作,诸症显减。上方去枳壳,减川芎、泽泻为 10g,加生苡仁 10g,50 剂后,诸症消失,身体康复。胆固醇 5.96mmol/L,甘油三酯 1.70mmol/L,血压 19.0/11.0kPa。后服理中丸 5 个月,并要求早晨坚持慢跑锻炼。随访两年,旧疾未发[程运文,中国医药学报,1989,(6):44]。

【方名】 活脑汤。

【组成】 桃仁、红花、赤芍各 10g,川芎、石菖蒲、郁金、熟地黄、肉苁蓉、巴戟、菟丝子、枸杞子、益智仁、桑螵蛸各 15g,丹参、山萸肉、龟板各 30g(先煎)。

【来源】 黄政叶等,辽宁中医杂志,1995,(1):15。

【功效】 行气活血,补肾益脾,通养元神。

【适应证】 老年性精神病,证属脑髓失充、气血不调者。

【方药简析】 方中以桃仁、红花、赤芍、川芎、郁金、丹参行气活血;石菖蒲、益智仁安神开窍,以使气血上荣于脑;因本病为本虚标实之证,为防化淤更伤阴液,故配熟地黄、枸杞子、巴戟、菟丝子、桑螵蛸、山萸肉、龟板补脾肾、益精血、填补脑髓。全方行气活血,补肾益脾,通养元神。黄政叶等用本方治疗本病有良效。

【病案举例】 陈某,女,60 岁,干部,症见:头晕头痛,记忆力减退,性格改变,生活不能自理,对近远期事情易遗忘,对周围环境的人和事缺乏兴趣;忧郁迟钝,步态不稳,言语不清,双腿酸软无力,小便失禁,情绪烦躁,表情淡漠,不能自行回答问题等。于 1992 年 9 月入院。脑电图示双侧不对称, α 波漫

化。头颅CT扫描示：脑室、脑沟及脑池增宽，提示脑萎缩。诊断为老年性精神病。中医查见：主症如前，舌暗淡，有淤斑，脉沉迟。证属年老肾虚、脑髓失充，加之久病气血不调，淤阻脉络而不能上荣脑髓而致病。治宜活血行气、补肾益脾为主。药用上方，水煎服，每日1剂，2次分服。经服药8剂后，临床症状明显改善，小便自解，能回答一般问题。连服4个疗程，在家属指导下生活基本自理，能回忆起往事，主动与医生和病友交谈。间断服药4个月治愈出院，经2年随访未复发。

【方名】 通窍还少汤。

【组成】 熟地黄 15g，龟板 15g(先煎)，枸杞子 15g，山茱萸 15g，巴戟天 15g，桃仁 10g，红花 10g，丹参 15g，川芎 10g，石菖蒲 15g，郁金 15g，赤芍 10g，桑螵蛸 20g，益智仁 10g。

【来源】 雷慧敏等，中医杂志，1992，(12)：34。

【功效】 补肾健脑，行气活血。

【适应证】 老年性痴呆，肾虚淤阻型。

【方药简析】 本方是由通窍活血汤合还少丹化裁而成，方中以熟地黄、龟板、山茱萸、黄精、何首乌、枸杞子益髓填精以滋肾阴；巴戟天、桑螵蛸、益智仁固精益髓以补肾阳；桃仁、红花、川芎、丹参、郁金、赤芍行气活血；石菖蒲开窍宁神；尤以龟板为血肉有情之品，补肾中真阴真阳，培固根元，化气生血，滋肾填精，充养精髓。全方可使气血旺、淤阻消、神明复还、元神充沛。雷慧敏等用上方治疗本病19例，有效15例。

【病案举例】 梁某，女，68岁，干部，1991年2月入院。患者因性格改变、记忆力逐渐减退(病情发展到痴呆)、生活不能自理而入院。进院后患者表情淡漠，不能自行回答问题，不知自己姓名及家庭住址。小便失禁，时有头晕，两腿疲软无力，喜卧床，少活动。舌质暗淡有淤斑，脉弦不充。证属久病气血不

调、淤阻脉络而不能上荣脑髓。治以补肾健脾、活血行气。用本方,水煎服,每日1剂,早晚分服。服药5剂后,患者经人提醒能自解小便并能回答简单问题(如自己姓名及吃饭否)。效不更方,患者服药40剂时,已能主动向大夫述病情并向大夫表示谢意。服药60剂,患者饮食、大小便经家人照顾已能自理。2月后出院,将上药配成丸药常服,以巩固疗效。

【方名】 荣脑汤。

【组成】 紫河车、龙眼肉、桑椹、赤白芍、太子参、茯苓、石菖蒲、丹参各10g,当归、生蒲黄各15g,远志、郁金各12g,熟地黄20g,炙甘草6g。

【来源】 李滋栋,陕西中医,1992,(9):397。

【功效】 填精益髓,活血开窍。

【适应证】 早老性精神病,精血亏虚、痰淤阻窍者。

【方药简析】 方中以桑椹、紫河车、龙眼肉滋阴清肝热;熟地黄、太子参、赤白芍补益肝肾;茯苓、郁金解郁除湿;生蒲黄、石菖蒲、远志清热开窍;当归、丹参养血活血;炙甘草调合诸药。全方共奏填精益髓、活血开窍之功。若兼见痰热者加竹茹、清半夏、胆南星;兼失眠者加酸枣仁、生龙齿;兼肢体活动障碍者加全蝎、瓜蒌;头痛重者加细辛、僵蚕。李滋栋用本方按上述加减治疗本病25例,结果临床治愈20例(临床症状消失,可参与日常工作及正常人际交往),好转4例(性格基本恢复,生活能自理,语言较流畅,但仍时有健忘、精神欠佳、反应迟钝等),无效1例(症状无明显好转)。总有效率为96%。治疗时间最长者60天,最短者25天。服药最少者24剂,最多者57剂。

【病案举例】 王某,女,55岁,工人,1988年2月初诊。患者有头痛病史3年,近两年记忆力逐渐减退,性格固执自私,

待人淡漠,情绪易急躁,时哭、时笑,反复无常,自言自语,语言有时增多,身乏无力伴失眠。常服去痛片、安定、安络痛,间断服用过中药汤剂,效果不明显。作CT提示脑萎缩。诊断为早老性精神病。就诊时,中医症见:主症如前,面色皤白无光彩,头晕耳鸣,头空痛,下肢痿痿无力,舌红少苔,脉细沉无力。经服用荣脑汤,记忆力减退明显好转,判断、识别、分析能力明显提高,失语、失用、震颤、瘫痪等症状全部消失,语言流畅,食欲增加,睡眠恢复正常,生活完全自理,能参与做一般工作。经过CT复查,脑沟变宽,脑室扩大,基本恢复正常。

【方名】 首乌健脑汤。

【组成】 制首乌 24~30g,枸杞子 15g,黄精 18g,生地黄、熟地黄各 18g,白芍 24~60g,当归、川芎各 15g,制南星、远志各 6~8g,石菖蒲 8~10g,郁金 18~24g。

【来源】 薛昌森,黑龙江中医药,1992,(4):10。

【功效】 补肝肾,填精髓,养血活血化淤、交通心肾。

【适应证】 健忘,肾精不足,髓海空虚。

【方药简析】 方中制首乌乃补肝益精血之品,《开宝本草》云其“益血气、黑鬓发、悦颜色,久服长筋骨、益精髓,延年不老”,李时珍谓其“能养血益肝,固精益肾,为滋补良药”。今之研究认为“首乌所含卵磷脂为构成神经组织特别是脑髓的主要成分,同时为血细胞及其他细胞膜的主要原料,并能促进血细胞的新生及发育”;臣以枸杞子、黄精强阴精、滋肝肾、润心肺、填精髓;佐以补血调血的主方四物汤,养血活血化淤;倍用川芎载药上行,专治头脑诸疾。近代动物实验和临床研究证明,川芎有扩张血管、改善微循环、增加脑血流量、改善脑的血供和保护血管内皮细胞及减轻脑水肿等作用;使以制南星、远志祛风除痰、交通心肾;石菖蒲、郁金行气解郁开脑窍。全方补

具(如法炮制)、人参 30g、琥珀 20g,共为细粉过筛,炼蜜为丸,每丸重 10g,每服 2 丸,日 3 次。1984 年 4 月,丸方服完,又继续服首乌健脑汤加减或杞菊地黄丸等,除轻度耳鸣、梦多、偶尔头晕痛外,余无不适。1985 年 6 月恢复工作。同年出差内地,复查脑 CT 报告脑萎缩与原片比较明显好转。

【方名】 元神丹。

【组成】 人参 15g,黄芪 30g,龟板 30g,鹿角胶 12g,田三七 3g,水蛭 3g,蜈蚣 3g,杜仲 15g,穿山甲 10g,山萸肉 15g,枸杞子、何首乌各 15g,菟丝子 15g,巴戟天 15g,丹参 20g,红花 3g,石菖蒲 10g,远志 10g。

【来源】 赫连锁,中医杂志,1994,(5):275。

【功效】 滋肾填精,益髓健脑,豁痰开窍,破瘀散结,祛瘀生新。

【适应证】 健忘,证属肾精亏虚,脑络淤阻者。

【方药简析】 本方中所标药物份量系编者所加。方以熟地黄、何首乌、山萸肉、枸杞子益髓填精以滋肾阴;巴戟天、菟丝子、杜仲益髓填精以助肾阳;人参、黄芪、丹参益气养血、补益肾气;三七、穿山甲、红花、水蛭、蜈蚣化瘀通络;石菖蒲、远志豁痰开窍;尤以龟板、鹿角胶为血肉有情之品,补肾中真阴真阳,培固根元,化气生血,滋肾填精,充养精髓。诸药相合,则气血旺、瘀浊消、神明复,元神得充而病症遂除。赫连锁用本方按一定比例制成丸药(每丸 3.5g),早晚饭后各服 1 丸,温开水送服。治疗本病有良效。

【病案举例】 邢某,男,63 岁,干部,1991 年 9 月 5 日初诊。患者有高血压病史 18 年,1979 年患糖尿病,1987 年又患脑血栓病。1991 年 8 月 23 日突然昏倒。8 月 26 日头部 CT 检查示:双侧脑室对称扩大,双侧裂池扩大,双侧额、蛛网膜下腔

增宽。诊断：脑萎缩。证见神情呆滞，反应迟钝，记忆力减退，头昏，站立、行走不稳，前倾，行走需人挽扶。语言蹇涩，舌强，呛咳，流涎，尿频。舌胖而暗紫，苔薄白，脉沉细。中医诊断为健忘。证属肾精亏损、脑络淤阻。服用元神丹1天后，自感站立较前平稳，行走时不再前倾。7天后语言较前流利，流涎、呛咳消失，头昏减轻。30天后，上下楼自如，头昏消失，记忆力增强，反应灵敏，双目有神，并能写书信，自感和正常人一样。40天后外出散步能行10km。1991年12月7日来信告知：精力充沛，能上下五六层楼，经常参加社会活动，外出时常骑自行车。1992年5月20日头部CT复查示：双侧蛛网膜下腔明显增宽；脑实质未见异常病灶；脑室未见异常；中线结构居中。诊断：局限性脑萎缩。

【方名】 加味二仙汤。

【组成】 仙茅15g，仙灵脾15g，枸杞子15g，鹿角胶10g（烊化），龟板胶10g（烊化），阿胶20g（烊化），何首乌30g，人参6g，黄柏6g，知母6g，龙齿30g。

【来源】 王仕鑫等，山东中医杂志，1992，（5）：34。

【功效】 益肾补脑安神。

【适应证】 老年性痴呆，证属肾精亏损、脑髓不足者。

【方药简析】 本方是由二仙汤加减而成。方中以仙茅、仙灵脾阴阳双补；龟板、阿胶为血肉有情之品，可填补精血；何首乌补肝肾益精血；人参大补元气，知母、黄柏滋肾阴，泻相火；龙齿潜阳镇静安神。全方益肾补脑安神。张子仪以本方每日配淡盐水煮猪脑30g，及新鲜蔬菜水果和一定的心理调护治疗本病多例有良效。

【病案举例】 王某，男，65岁，1991年1月4日就诊。其子代诉：两个月前，腰痛畏寒，尿失禁，继而神情呆滞，近事长

时间回忆不起,答非所问。10天前饮酒无度,翌日静而不语,呆若木偶,小便失禁。经青岛医学院附属医院做脑CT扫描示:轻度脑萎缩。诊断为老年性痴呆,遂转本院。中医症见:主症如前,舌质略淡,苔薄,脉沉细无力,两尺脉显。治宜补肾填精荣脑。方投自拟加味二仙汤水煎服,每日1剂。服药5剂,能较正确回答问题,有些近事已能回忆清楚。调护:戒酒;多做室外活动,多与他人接触交谈;每日用淡盐水煮食猪脑30g,并多吃新鲜蔬菜水果。

【方名】 鹿麻汤。

【组成】 鹿角 9g,黑芝麻 12g,生地黄 30g,山萸肉 12g,山药 25g,茯苓 15g,丹皮 10g,泽泻 10g,何首乌 15g,当归 10g,石菖蒲 12g,枸杞子 15g,菊花 15g,远志 10g,甘草 5g。

【来源】 董俊峰,实用中医内科杂志,1993,(2):15。

【功效】 滋补肝肾。

【适应证】 早老性精神病,证属肝肾不足、脑髓不充者。

【方药简析】 方用鹿角、黑芝麻、生地黄等滋阴清热、补肾为主;山萸肉、枸杞子、山药补益肝肾,丹皮、泽泻清泻肝肾之火,茯苓渗脾湿,石菖蒲、远志清热开窍,当归、何首乌养血活血,共为辅佐;甘草调和诸药为使。全方共奏滋补肝肾之效。若兼见痰热者,加竹茹、半夏、胆南星;兼失眠者,加炒枣仁、生龙齿;兼高血压者加石决明、决明子;兼肢体活动障碍者加全蝎、地龙、豨莶草;头痛重者加僵蚕、天麻。每剂中药水浸泡20min,文火煎2次,取药液混匀2份,早晚各服1份。连续服用2天为1疗程,停药3天继续服用。董俊峰用本方按上述加减用药治疗本病31例。5个月后统计疗效,结果治愈22例(临床症状消失,可参与日常工作及正常人际交往),好转8例(性格变化基本恢复,生活自理,语言流畅,但仍健忘,精神欠

佳,反应迟钝),无效1例(临床症状无明显改变)。

【病案举例】 颜某,男,52岁,干部,1989年3月初诊。患者头痛病史4年有余,近2年记忆减退,性格变化,对人淡漠,情绪急躁易怒,哭笑无常,自言自语,失眠,全身无力。常服颅通定、安定、中药汤剂等药物,效果不显。做CT扫描查示:脑萎缩。诊断为老年性精神病。就诊时患者面色苍白,目无光彩,舌淡苔薄白,脉细弱。证属肝肾不足。脑髓不充。治以滋补肝肾法。方用鹿麻汤。处方:鹿角9g,黑芝麻12g,生地黄30g,山茱萸12g,山药25g,茯苓15g,丹皮10g,泽泻10g,何首乌15g,当归10g,石菖蒲12g,枸杞子15g,菊花15g,远志10g,甘草6g。水煎,服10剂,诸证减轻,夜寐明显好转,但饮食欠佳。上方加神曲12g、山楂15g,继服5剂,诸证消失,恢复正常工作。随访3年未再复发。

【方名】 定眩汤。

【组成】 龟板30g,黄精30g,何首乌20g,山茱萸15g,白芍15g,牛膝20g,地龙15g,石菖蒲15g,生牡蛎30g。

【来源】 贺仲华,吉林中医药,1992,(6):11。

【功效】 补益精血,潜阳开窍。

【适应证】 眩晕、健忘,证属肝肾阴虚、肝阳上亢者。

【方药简析】 方中以龟板、黄精、何首乌、山茱萸、白芍、牛膝补益精血;地龙、石菖蒲、牡蛎潜阳开窍。所用药物性质平和,补而不腻,长期服用无不良反应。每日1剂,水煎服。若伴肢体功能障碍者加生黄芪、全蝎、乌梢蛇、当归;语言不利者加郁金、远志;苔黄腻、脉弦滑、痰浊内盛者加郁金、胆南星、茯苓;大便秘结者加火麻仁、肉苁蓉;伴头痛且血压增高者加天麻、草决明、龙胆草;伴便溏者去黄精、龟板。15天为1疗程,一般需治疗2个程,并配合体育锻炼。贺仲华用上方治疗本病

【功效】 滋补肝肾,填精益髓。

【适应证】 早老性精神病,证属肝肾不足、脑髓不充者。

【方药简析】 方中桑叶、黑芝麻、生地黄等滋阴清肝热;山茱萸、山药补益肝肾;丹皮、泽泻清泻肝肾之火;茯苓渗脾湿;石菖蒲、远志清热开窍;当归、何首乌养血活血。全方滋补肝肾、填精益髓。兼见痰热者加竹茹、清半夏、胆南星;兼失眠者加炒枣仁、生龙齿;兼肢体活动障碍者加全虫、丹参、豨莶草;头痛重者加僵蚕、天麻。每剂水浸泡 30min,文火熬 2 遍,取药液混匀分成 2 份,早晚各服 1 份。连续服用 30 天为 1 疗程,停药 2~3 天继续服用,2 疗程后可制成丸药服用。服药期间酌情配合降血压、降血脂等对症治疗。田立用上方治疗本病 23 例,治愈 12 例(临床症状消失,可参与日常工作及正常人际交往),好转 9 例(性格变化基本恢复,生活自理,语言较流畅,但仍时有健忘、精神欠佳、反应迟钝),无效 2 例(症状无明显改变)。

【病案举例】 郑某,女,50 岁,教师,1986 年 4 月初诊。患头痛病史 4 年,近 2 年记忆力逐渐减退,性格变化,固执自私,对人淡漠,情绪易躁易怒,时伴哭笑无常,自言自语,失眠,全身乏力,做 CT 扫描检查示:脑萎缩。诊断为早老性精神病。中医症见:主诉如前,面色晄白,目无光彩,舌淡苔薄白,脉细弱。证属肝肾不足、脑髓不充。治以滋补肝肾之桑麻地黄汤加减。处方:桑叶 10g,黑芝麻 12g,生地黄 30g,山茱萸 12g,山药 30g,茯苓 20g,丹皮 10g,泽泻 10g,何首乌 15g,石菖蒲 10g,远志 10g,炒枣仁 30g,僵蚕 10g,菊花 15g,甘草 6g,水煎服。服药 10 剂,诸证减轻,夜寐好转,但饮食欠佳。上方去僵蚕,加炒谷芽、炒麦芽各 12g,继服 20 剂,诸证消失,恢复正常工作。至 1990 年 3 月,再遇病人时,未再复发。

【方名】 定智地黄汤。

【组成】 生地黄 15g,熟地黄 15g,山茱萸 10g,何首乌 12g,枸杞子 10g,党参 12g,茯苓 10g,远志 10g,生龙骨 15g,生牡蛎 15g,龟板(先煎)10g,阿胶(烔化)10g,益智仁 10g,补骨脂 12g,骨碎补 12g。

【来源】 王恒松,中医杂志,1994,(4):526。

【功效】 补肝益肾,滋阴定智。

【适应证】 老年性精神病,证属肝肾阴亏阳浮者。

【方药简析】 方中所标药物份量系编者所加。本方是由定智汤合杞菊地黄汤加减而成。方中用生熟地黄、山茱萸、何首乌、枸杞子滋阴补肾、填精充髓;党参、茯苓、远志补益心脾、调补气血;生龙牡配龟板、阿胶滋阴潜阳、增智醒脑;益智仁、补骨脂、骨碎补宁心安神、补脑增智。诸药合用,补而不滞,补中有通之妙。若虚阳上浮、潮热盗汗明显时可不用补骨脂、骨碎补;若阴阳两虚突出时,去龟板、阿胶,加紫河车。同时配合精神调治、饮食调养,多吃新鲜蔬菜和瓜果。王恒松用本方按上述加减用药治疗本病有良效。

【病案举例】 钱某,女,71岁,离休干部,1年来头昏逐渐加重,性格变得有些主观,常为琐事而生气,轻度智力障碍,记忆力下降,反应迟钝,视力模糊,两目少神,语言欠清,词不达意。心电图:冠状动脉供血不足;B超:脂肪肝,胆囊炎,胆石症;颈椎摄片:颈椎退行性变;脑血流图:脑血流缓慢,供血不足;诱发电位:双侧视传导通路功能障碍;动态心电图:房性早搏;头颅CT:脑室轻度扩大(左室为著),脑沟、池亦轻度增宽,结论为轻度脑萎缩。诊断为老年性精神病。中医症见:口干且苦,潮热盗汗,胃脘不适,心慌气短,寐少有梦,舌质偏红、苔少、脉细微数。证属肝肾阴亏、津液不足、髓海失养、虚阳上浮。治宜补肝益肾、滋阴定智。以定智地黄汤加减:枸杞子

有淤点者(属气滞血淤)宜加丹参、赤芍、川芎。此外根据中医“以脏补脏”的理论,可用兔脑、猪脊髓等动物神经组织加入药中,并在辨证的基础上配合服用康宝液、维尔康、月见草胶囊、活血通脉片等活血化淤和抗衰老药物(可补偿大脑中某种成分的不足)。国内外研究资料证明,前者(动物的神经组织)含有大量氨基酸及肽类物质,它们可使脑组织增生;后者(药物)能提高神经元的代谢机能。减少星状细胞水肿,增加脑血流量。陈桂铭用上方为主按上述加减治疗轻、中、重度痴呆 25 例(服药 1~3 个月)。治疗结果:轻度痴呆 8 例中显效 3 例,有效 2 例,无效 3 例;中度痴呆 11 例中显效 5 例,有效 3 例,无效 3 例;重度痴呆 6 例中显效 0 例,有效 2 例,无效 4 例(显效:主要症状基本恢复,神志清醒,定向健全,回答问题正确,反应灵敏,生活自理,能进行一般的社会活动。有效:主要精神症状有所减轻或部分消失,生活基本自理,回答问题基本正确,但反应迟钝,智力与人格仍有部分障碍。无效:主要症状无改变或病情发展,生活不能自理,回答问题不正确,神志痴呆)。陈桂铭观察本方治疗轻、中度患者的疗效高于重度患者,且服药疗程越长,有效率越高。本方对患者智能的语言能、记忆能和动作能有明显改善与提高,而对判断、思维能改变不明显,说明各种智力能力的缺陷与相关脏腑受损与不足有关,改善某些脏腑的功能,有可能改善相关能区的智力。

【病案举例】 黎某,女,62 岁,近 1 年来头晕耳鸣,倦怠无力,精神呆滞,步履不正逐渐加重,于 1989 年 4 月 1 日入本院治疗。患者从 1988 年 12 月起渐出现痴呆面容,记忆减退,经常呆坐,懒于动作,嗜卧。情绪明显改变,时啼号无泪,时笑泪如雨流,昼则对人瞌睡,夜则独卧惺惺,行动迟缓,思维迟钝。CT 示:双侧脑萎缩。用脑益嗪、适脑脉等药治疗症状无明显改善,否认冠心病、高血压病、糖尿病病史。查:血压 14.0/

10.0kPa,神志清,表情淡漠,近事记忆差,远事记忆尚可,计算能力下降,定向力正常,人格尚完整。双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏。口角无喎斜,听力可,颈软,四肢肌力均Ⅳ级,病理反射未引出。西医诊断:老年性痴呆。中医症见:主症如前,舌淡、苔薄白,脉沉细弱。中医辨证为肾精亏损、髓海失养、神明散乱之证。治以补肾填精、健脑益智。方用补肾益脑汤加丹参15g,郁金、柏子仁各10g。5剂,日1剂,水煎服2次。服上药后,病人自觉头晕减轻,睡眠好转,走路较前有力,情绪改善。继服10剂,睡眠佳,可独自行走、上下楼梯,情绪稳定,能打太极拳和收听收音机,症状明显改善。守上方连进2个月,痴呆面容消失,反应较前灵敏,步履变稳,记忆较过去明显增强。改用天麻丸、康宝液、活血通脉片,继服以善后。

56 有机磷中毒伴发精神障碍

有机磷进入体内与胆碱酯酶迅速结合,使其活性受到抑制,丧失功能,造成乙酰胆碱在体内代谢蓄积,胆碱能神经过度兴奋,导致神经系统功能紊乱,引起复杂而多变的精神神经症状。若短期接触中毒者称为急性中毒。中毒程度较重时很快陷入昏迷死亡。接触量小轻度中毒者,开始有头晕、酩酊感、头痛、乏力、恶心、甚至呕吐;1~2天即可出现兴奋多语、激惹、嬉笑、寻事生非,类似急性躁狂症,但短暂兴奋之后,迅速陷入极度疲劳状态,不得不卧床休息;睡眠很差,多梦,常在噩梦中惊醒,醒后又躁狂如故,一日往往有数次这种兴奋与疲劳的交替。若长期接触有机磷近1年半以上,然后逐渐精神异常者,为慢性有机磷中毒。开始时头晕、目眩、恶心、呕吐、胸痛、全身不适和乏力,然后开始肌肉痉挛或颤动,精神症状以注意力不能集中、全身乏力、精神萎靡、疲劳感激增为主,然后诱发紧张与焦虑不安,易激惹;或出现抑郁,哭泣、丧失信心;距离判断能力、理解力、定向能力下降,偶见精神分裂症的思维障碍;人格障碍,常不觉做出无礼的行为;有时可出现腾云驾雾感,对噪音敏感反应过度。神经系统症状及体征中可见毒蕈碱样症状(如食欲减退,恶心、呕吐、腹痛腹泻、多汗流涎、胸闷、心惊心慌,视力模糊)及烟碱样症状(如肌纤维震颤、肌肉痉挛、癫痫样发作、肢端发麻、疼痛、触觉减退等)。本病经过临床抢救后,体内仍有一部分残毒,对机体所造成的损伤也不易恢复,仍会根据中毒深浅,出现上述各种症状,临床上称为有机

磷中毒后遗症。本病的治疗,应清除毒物并防止毒物继续进入体内,给阿托品、胆碱脂酶复活剂。中毒恢复后根据不同的精神症状给以抗精神病药物治疗。

中医认为有机磷毒侵犯机体,损伤脏腑,阻碍气机,使机体阴阳失调,气机逆乱,痰浊阻滞,变生诸症。临证首先是对因治疗,给予有效的解毒药积极抢救,在洗胃、阿托品化等抢救措施基础上,可用生大黄液口服。二是对有机磷中毒后遗症辨证施治。痰浊阻滞、气机郁闭者用涤痰汤或藿半解毒汤、昌阳泻心汤加减;肝胆不和者用蒿芩清胆汤加减;虚火上炎、痰浊上泛者用地黄饮子加减;心营被劫者用黄连清心饮加减;心气耗伤者用养心汤加减;邪却正虚者用补中益气汤加减;脾胃受伤、肝肾亏损、气虚血枯、经络失养者用三痹汤加减方化裁。此外,朱晓明以藿香、佩兰、陈皮、薏苡仁、石菖蒲、白豆蔻、黄芩、薄荷、连翘等芳香化浊、清热利湿药为基础方,将本病分为4型。湿热偏湿者(证见头晕、胸闷、纳呆恶心,或腹泻、疲乏、身体沉重感、舌苔白厚腻)加苍术、半夏、陈皮、焦山楂、炒麦芽、神曲;湿热偏热者(证见头痛或头晕、纳呆、口苦、大便干或滞下不爽,舌苔黄腻,舌质红)加黄连、竹叶;湿热挟风邪者(病程较长,大都在2个月以上,证见头痛头晕,以头痛为主,或见呕吐恶心纳呆,或见四肢颤抖、筋惕肉瞤,舌苔薄腻)加川芎、防风、菊花、葛根、牛膝;湿热兼脾虚者(证见头晕目眩、心慌,或有旋转感、乏力倦怠、纳少、舌稍淡、苔薄白、脉细)加白术、党参、茯苓、泽泻。心慌失眠者加琥珀、枣仁、远志;胸闷腹胀暖气者加木香、香附、厚朴花;腹泻稀水者加焦三仙、荷叶、扁豆花;咽部异物感者加半夏、桔梗;四肢麻木、颤抖、筋惕肉瞤者加当归、白芍、何首乌、蜈蚣、钩藤、僵蚕等;头痛重者用川芎至30g,加细辛、白芷、藁本、延胡索等。本组19例中,自中毒缓解后至来诊时,病程最长者1个月,最短者五天。服药最少3剂,

最多 30 剂。经治疗痊愈者 16 例,治愈率 84.4%,3 例有效,总有效率 100%。1 年及 2 年后随访 11 例,其中除 1 例因服药 7 剂症状减轻后中断治疗,现遗留头痛、记忆力减退外,其余 10 例均已痊愈[山东中医杂志,1983,(5):21]。

荣陆一以三仁汤为基础方,将本病分为 4 型:肝郁脾虚(头痛,胸闷,腹胀,恶心呕吐,食欲不振,倦怠乏力,嗜睡,舌质淡,苔白腻,脉弦细,方选逍遥散和三仁汤加减),肝阴不足(头晕、头痛,心烦,视力模糊,时有肌肉颤动,舌质红,苔白、脉细数,方选一贯煎和三仁汤加减),心脾两亏(头晕、心悸食少倦怠,气短神怯,失眠多梦,舌质淡,苔薄白,脉弱,方选归脾汤和三仁汤加减),中焦湿热(头重如裹,胸闷腹胀,恶心呕吐,口苦咽干,食欲不振,嗜睡,四肢酸重乏力,方选藿香正气散和三仁汤加减)。本组 36 例中,最短的接受治疗 4 天,最长的 30 天,除 3 例中断治疗,2 例治疗中间又诱发其他疾病转科外,全部治愈;服药最少的 8 剂,最长的 22 剂,平均 13.5 剂[中医药学刊,1991,(1):46]。三是若中毒引起血清谷草转氨酶升高久不恢复正常,可在辨证的基础上加入五味子、丹参、虎杖治疗。

【方名】 生大黄液。

【组成】 生大黄 30~60g。

【来源】 王尧,山西中医,1992,(1):20。

【功效】 排毒解毒。

【适应证】 急性经口有机磷中毒。

【方药简析】 本方制成生大黄液经胃给药,可通腑排毒、活血化淤。据现代药理研究证实,大黄具有解除微循环障碍、恢复肝细胞功能、促进蛋白合成、促使人体产生干扰素的功能,使滞留在肠道的病原体、毒素等加速排出,减少吸收,并增加全身组织的血液灌流,使心功能即时改变的心率减慢,心肌

耗氧量降低。临床观察也证实了大黄在排毒解毒及缓解中毒所致的心肝肾等的损害,遏制阿托品过量铸成的心率加快、便秘等确有一定的疗效。制剂方法:大黄 30~60g,加冷水 1000ml 煮沸 3~5min,或开水浸泡 10min,捣拌大黄成糜,滤汁,微温服用。一般在洗胃、阿托品化后给以大黄液以洗胃后经胃管灌入为宜,拔出胃管者可口服或鼻饲,日 1~2 剂,每次 200~500ml,不拘次数。药后 2h 元大便可配合大黄灌肠。排便后减量,日 1 剂,连服 3 日。停药后改拟疏肝健脾善其后。王尧用本方治疗本病 36 例,疗效优于对照组(承气汤组、西药组、芒硝组)。

【病案举例】 李某,女,34 岁,1986 年 10 月 17 日诊。患者 6 日前怒服乐果原液约 30ml,半小时后洗胃,用大剂量阿托品。洗胃后灌入芒硝 60g,但未大便,70h 后因反跳,将阿托品增至 50mg,静注,10min 1 次。至第 6 日阿托品用量近 33mg,患者深度昏迷,大便秘结,保留导尿转我院抢救。诊为阿托品中毒,立即停用阿托品,给以输氧、输血、输液、激素、甘露醇等,鼻饲加灌肠应用大黄液。用药后 20h 内大便 3 次,小便亦通利,去掉导尿管未见反复,14h 后神志清。调养 5 日告愈出院。

【方名】 涤痰汤。

【组成】 陈皮 12g,半夏 15g,茯苓 20g,石菖蒲、胆南星、竹茹、枳实各 10g,甘草 6g,人参(另煎)5g,生姜 3 片,大枣 8 枚。

【来源】 严用和《济生方》。

【功效】 辟秽解毒,化痰开窍,醒脾和胃。

【适应证】 有机磷农药中毒后遗症,痰浊内阻者。

【方药简析】 方以半夏燥湿化痰、醒脾和胃为主药;陈皮

理气燥湿，枳实行气消痰散结，胆南星、竹茹化痰为辅药；茯苓、人参益气健脾渗湿治痰之本，石菖蒲开窍宁神，生姜制半夏之毒助半夏行气消痰共为佐药；甘草大枣补中，调和诸药为使药。诸药合用可辟秽解毒、化痰开窍、醒脾和胃。若头痛头晕、苔黄腻加天麻、天竺黄、白芷；失眠、心悸者加远志、酸枣仁、夜交藤；胸闷、抑郁者加柴胡、瓜蒌、郁金；痰热壅盛者加黄芩、僵蚕；腹胀纳呆、恶心呕吐者加藿香、木香、砂仁、白蔻仁；神疲体倦乏力者加黄芪、白术、桂枝；大便秘结者加生大黄；血清谷草转氨酶升高，加五味子、丹参、虎杖；视物不清加菊花、枸杞子。张立营等以本方为基础方，按上述加减用药，治疗本病 50 例，结果 47 例治愈（临床症状消失，胆碱酯酶恢复正常）；3 例显效（临床症状明显好转，胆碱酯酶接近正常）。治疗时间最短 3 天，最长 21 天，平均 7.5 天。

【病案举例】 王某，女，21 岁，1989 年 10 月 7 日初诊。3 天前因婚事与家人发生争吵后，口服敌敌畏 70ml，1h 后被发现，急送当地医院抢救。经反复洗胃，同时使用胆碱酯酶拮抗剂和复活剂等治疗，10h 后苏醒，病情逐步缓解。但精神抑郁，表情淡漠，胸闷叹息，腹胀纳呆，呕恶不适，体倦乏力，舌淡苔薄白，脉弦细。投涤痰汤加瓜蒌 15g，郁金、柴胡、砂仁、木香各 10g，3 剂后，精神好转，纳食渐增，唯觉周身痠楚乏力。上方加黄芪 15g，白术 10g，续进 3 剂，诸症均瘥[张立营，浙江中医杂志，1992，(1)：214]。

【方名】 藿半解毒汤。

【组成】 藿香 12g，半夏 10g，陈皮 10g，当归 12g，大黄 6g，茯苓 12g，车前子 12g，滑石 20g，甘草 15g，绿豆 60g。

【来源】 王星田，国医论坛，1989，(3)：32。

【功效】 和胃悦脾，通利解毒。

【适应证】 有机磷农药中毒后遗症,药毒损伤脾胃者。

【方药简析】 本方以藿香配二陈汤以和胃悦脾为主。佐以当归活血配大黄通腑解毒且活血化淤;车前子、滑石利小便排毒;绿豆、生甘草甘寒养阴解毒。全方可和胃悦脾、通利解毒。本方以水煎,每日1剂分3次服。头痛头晕加川芎、菊花、石菖蒲;胃败纳少加神曲、麦芽;身疲乏力加黄芪、党参;恶风怕冷加桂枝、防风;经消化道中毒者加白术、白蔻;经皮肤中毒者加金银花、连翘;经呼吸道中毒者加桔梗。王景田以本方为基础方,按上述加减用药治疗本病29例,结果痊愈(临床症状及体征全部消失,完全恢复劳动能力,随访3月无任何不适者)28例,占96.6%;显效(临床症状明显减轻)1例,占3.4%。其中服药最多者15剂,最少者3剂,平均9剂。

【病案举例】 张某,女,36岁,农民,已婚,1987年6月24日初诊。病人自述20天前因生气服“敌敌畏”,曾在某医院治疗5天,脱离危险后因经济困难带3天口服西药出院。回家后一直感觉身困乏力、头晕、胸脘满闷,时有恶心,不能参加劳动。期间村医注射过几次阿托品并输两次计3000ml葡萄糖液,月余来不见好转。检查:形体发育正常,表情淡漠,心率64次/分,律齐,肝脾未触及,脘腹叩诊呈鼓音,血压14/9kPa,体温36.8℃,胸透心肺无异常,化验血象正常,尿见少许红细胞。舌淡苔白腻,脉沉缓。证属药毒损伤脾胃、攻于巅顶,致中焦枢机不利、升降失调、上窍清阳被蒙所致。治宜和胃悦脾、醒脑开窍、清便解毒。处方:当归15g,白术12g,白蔻5g,半夏10g,陈皮10g,藿香12g,大黄5g,石菖蒲10g,茯苓12g,滑石18g,甘草15g,绿豆60g(先煎)。1日1剂分3次服。连服3剂后,纳食明显增加,头晕诸症消失或轻微留存,能下地劳动。上方去石菖蒲、大黄,加神曲15g、党参15g,续进3剂。1年来随访健康如初。

得以清宣，上下分消而解。若火郁甚者可加大黄。郝文轩以本方按上述加减，治疗有机磷农药中毒痰浊中生、郁火内扰、肝失疏泄、胆失清降、肝胆不和见证者有良效。

【病案举例】 王某，男，22岁，有机磷中毒抢救脱险后，胸胁苦满，呕不饮食，寒热如疟，小便黄赤，舌边尖红赤，苔黄腻，脉弦数。此肝胆湿热、木火内郁之症。予上方加大黄，3剂而安，续予温胆汤2剂善后（郝文轩，浙江中医杂志，1982，（9）：414）。

【方名】 地黄饮子。

【组成】 生地黄 20g，巴戟 10g，山茱萸 20g，石斛 20g，肉苁蓉 10g，肉桂 6g，茯苓 20g，麦门冬 20g，五味子 20g，附子 6g，石菖蒲 10g，远志 10g，薄荷 6g，生姜 3片，大枣 3枚。

【来源】 刘完素《宣明论方》。

【功效】 滋肾阴，补肾阳，开窍化痰宁神。

【适应证】 有机磷中毒后遗症，下元虚损者。

【方药简析】 方中以生地黄配石斛、五味子、麦门冬滋肾阴；巴戟配山茱萸、肉苁蓉、肉桂、附子补肾阳益精血。诸药共用以阴中求阳，阳中求阴，补下元之虚损，在方中为主辅药；茯苓健脾化痰，石菖蒲、远志开窍宁神，薄荷醒脑，生姜片辛散助药力之行散，大枣补中，共为佐使药。诸药共用滋肾阴补肾阳、开窍化痰，使水火相济、虚火得清。虚阳上浮甚者加牡蛎、鸡子黄以滋阴潜阳；瞳孔散大日不识人者加菊花、枸杞子平肝息风滋阴明目。王先农以本方为基础方按上述加减用药治疗有机磷农药中毒（下元虚损，见舌强不言、足废不用等症者）有良效。

【病案举例】 某小儿，1983年4月11日诊，其父代诉：1983年8月15日晚6时在家里误服敌敌畏，30min后到县医

院经抢救后症状好转,但5天后出现大小便失禁、昏睡、不认识人,治疗几天无效,故转市级医院儿科住院治疗11天,病情仍无好转,经该院内科、神经科会诊(脑电图和脑脊液化验正常)诊断为敌敌畏中毒后遗症,转外地治疗。由于患儿家属经济困难未能前往,1983年4月11日邀余诊治。当时诊查所见:患儿意识不清,不懂问话,双侧瞳孔散大,头频繁摇动,手足蠕动,频频用嘴咬自己手而不知疼痛,高热烦躁,彻夜不眠,舌绛红苔焦黑,脉弦细数。证属乃热极生风。治用安宫牛黄丸清热解毒、豁痰开窍。服上药4丸后,症状稍轻,夜已能寐,但神倦而伴有虚烦,目不识人,面色晄白,有时潮红,容易出汗,肢体微呈拘挛强直,口干不欲饮,舌苔浮腻,质淡而干,脉细小而数,舌强不能言,足废不能用。此证属下元虚衰、虚火上炎、痰浊上泛、堵塞窍道所致。治宜地黄饮子加牡蛎、鸡子黄滋阴潜阳。处方:生地黄10g,巴戟5g,山茱萸10g,石斛10g,肉苁蓉5g,肉桂8g,茯苓10g,麦门冬10g,五味子10g,附子8g,石菖蒲5g,远志5g,薄荷3g,牡蛎10g,生姜8片、大枣3个、鸡子黄1枚。4月26日诊:服上药10剂后,大见好转,并能安然入睡,自己能下地行走、开门和躲避障碍物,并知要东西吃,自知大小便。便干溲赤,口干神倦,虚烦,指颤握物无力,双侧瞳孔仍散大,不识亲人,脉细数。此乃肝肾两亏、精血不足、精气不能上输于目之证。仍以上方加菊花、枸杞子平肝熄风、滋阴明目。5月3日诊:服上药6剂后目已能分辨东西,诸症悉除,为巩固疗效,令其再进上方5剂。追访患儿3年,病已痊愈,恢复常态[王先农,黑龙江中医药,1984,(4):48]。

【方名】 黄连清心饮。

【组成】 黄连6g,生地黄9g,当归9g,枣仁18g,远志9g,茯神10g,人参4g,甘草3g,莲子6g。

【来源】 郝文轩,浙江中医杂志,1982,(9):414。

【功效】 养血安神,清泄心火。

【适应证】 有机磷中毒,心营被劫,神志不宁者。

【方药简析】 本方药物剂量为编者所加。方中以黄连清泄心火为主;生地黄、当归清心营,养心血;枣仁、远志、茯神养心安神;人参、甘草益气补中安神,莲子清心火除烦,共为佐使药。方中诸药共用以养心安神、清泄心火。心阴不足明显者可加百合、知母。郝文轩以本方为主按上述加减治疗有机磷农药中毒(失治日久,或阴虚火旺之体、心营被劫、神志不宁者)有良效。

【病案举例】 郭某,女,19岁,有机磷中毒抢救复苏后,精神恍惚,喜笑无常,舌质红、苔薄黄,脉细数。此心营被劫、神志不宁之症。予上方加百合、知母,10剂后渐安,后与百合地黄汤调理半月而愈。

【方名】 养心汤。

【组成】 人参 4g,黄芪 6g,当归 6g,川芎 6g,远志 4g,枣仁 4g,茯苓 6g,茯神 6g,柏子仁 4g,五味子 10粒,半夏 6g,肉桂 4g,炙甘草 2g。

【来源】 王肯堂《证治准绳》。

【功效】 益气生血,养心安神。

【适应证】 有机磷中毒,心气耗伤者。

【方药简析】 方中以人参、黄芪、当归、川芎相配,益气生血为主;远志、枣仁、茯神、柏子仁、五味子为佐,辅助主药养心安神;茯苓、半夏利湿化痰,肉桂引火归源以制浮阳,炙甘草和中并调和诸药,共为佐使药。诸药共用使气血得补,心神得养,化源得充,则精神自复。郝文轩以本方加减治疗有机磷中毒(心气受劫者)有良效。

【病案举例】 陈某,女,21岁,有机磷中毒后遗症1年不愈。头痛时作时止,面色不华,精神困顿,舌胖,脉虚数。此心气不足之症。予上方20剂,头痛止,精神渐复。改用柏子养心丸,服2月而愈[郝文轩,浙江中医杂志,1982,(9):414]。

【方名】 补中益气汤。

【组成】 黄芪15g,炙甘草5g,人参10g,当归10g,橘皮6g,升麻3g,柴胡3g,白术10g。

【来源】 李东垣《脾胃论》。

【功效】 益气升阳,调补脾胃。

【适应证】 有机磷农药慢性中毒,正气不足者。

【方药简析】 本方以黄芪为主,补中益气,升阳固表;辅以人参、炙甘草、白术益气健脾,合主药以益气补中;佐以陈皮理气和胃,当归以养血,少量升麻、柴胡协助主药以升提下陷之阳气。诸药合用,使脾胃强健、中气充以扶正托毒。陈秀菊以本方加枳壳、山楂、神曲、麦芽治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,36岁,1984年3月18日以阵发性晕厥加重3天求治于余。家人代述:7个月前患者连续使用、接触农药后出现严重农药中毒症状,经当地卫生院积极抢救后脱险。1个月后,患者突然不明原因晕倒,大、小便失禁,口吐涎沫,齟齿似冷状,汗出,醒后如常人。当时曾疑为癫痫,经作脑电图并结合家族及既往史予以排除,然而上病愈发愈频,甚时日发作10余次,观其舌苔白而腻,脉见弦滑稍数。思之再三治疗难以着手,细察之,精神恍惚,体质瘦弱,频频吐涎,时时叹息。问:“胸闷否?”对:“闷极。”前贤曾云“百病皆有痰作祟”,遂用导痰汤加味:半夏、橘红、制南星、枳壳、石菖蒲、郁金、僵蚕各10g,云茯苓15g,生甘草3g。服药2剂,诸症明显减轻,发作次数日降到5~6次,纳差,身懒乏力,苔薄白,脉

身细无力。此乃邪却正虚之候,给予补中益气汤加味:黄芪 30g,白术、陈皮、柴胡、当归、枳壳、山楂、神曲、麦芽各 10g,党参 15g,甘草 6g。服 4 剂诸症悉除。继服 4 剂巩固,随访 3 年身体健康[陈秀菊,四川中医,1994,(1):37],

【方名】 三痹加减方。

【组成】 附片 15g,人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、当归、川芎、独活、杜仲、枣皮、牛膝各 10g,赤芍、地龙、鸡血藤各 20g,生地黄、黄芪各 30g。

【来源】 黄宏植,湖北中医,1989,(3):23。

【功效】 益气健脾,培补肝肾,养血舒络。

【适应证】 有机磷农药中毒后遗症,属肝肾亏损、经络失养之痿证。

【方药简析】 本方是由《妇人良方》中的三痹汤化裁而成。方中人参、黄芪、白术、茯苓、甘草补中益气健脾;陈皮醒脾和胃、畅达气机;附片补命门真阳;重用生地黄养血以平调附片之热性;枣皮、杜仲、牛膝补肝益肾;当归、川芎、地龙、赤芍、鸡血藤养血和营;独活祛风胜湿。诸药合用共奏益气健脾、培补肝肾、养血舒络之功。黄宏植用本方治疗本病 15 例,其中除 1 例外,14 例辅以当归并用维生素 B₁ 注射液穴位注射,取穴肩髃、曲池、手三里、外关、髀关、足三里、阳陵泉。结果本组 15 例均愈,服药多者 45 剂,少者 20 剂。3~5 年后随访,均无复发。

【病案举例】 何某,男,32 岁,1984 年 11 月 20 日诊。患者在 9 个月前服敌百虫 100 片,经本地区医院抢救脱险。2 个月后出现两下肢肌肉萎缩,逐渐发展到两上肢肌肉亦萎缩,肘腕指、膝踝趾关节感觉迟钝,手不能握物,足不能支身,肌肤失泽,触之滑腻,咽下口渴,舌红苔黄腻,脉沉弦缓。证属痿证,系

因脾胃受伤后肝肾亏损、气虚血枯,不能营养经络所致。治当填补真阳、补益后天,以生化津液精血,来滋养经脉筋骨。按基本方加黄芩 10g,麦门冬 20g,15 剂。辅以当归注射液 4 毫升、维生素 B₁ 注射液 0.5ml 混合注射环跳、风市、阳陵泉、承山、解溪等穴,间隔 3 天 1 次。20 天后复诊,踝趾关节外屈曲,并能短时站立。上方减黄芩继服 25 剂,后改用药酒服用 3 月而愈。4 年后随访未见复发。

气机方得畅达,九窍必赖烟阳之涩方能固守,即产生药物依赖。然“此物性属纯阳,善行善启”,一旦中断吸服,脉络寒润而不行则身体诸痛,皮毛失温则寒战,腠理失涩则汗出,目失温涩则多泪,胃失和降而呕吐,肾失温涩而滑精,心失温养而烦乱,肺失温养而悲忧。即出现以阳虚、阳脱为特征的症候群。气血耗伤,致神志失养,其中以心脾两亏为突出。故其毒性表现为面黄肌瘦、汗出乏力、失眠。本症属本虚标实之证,治疗时首当辨证。毒结脏腑者可用仙方戒毒灵;阳虚、阳脱者可用桂附吴茱萸汤;吸毒日久、正气大衰者,可用补元解毒汤;寒滞淤阻者可用少腹逐淤汤;精气亏损阳萎者可用金水宝。

曲巧敏用瘾消舒合剂(白芍、天麻、炮附子、川芎、延胡索、生甘草)治疗戒断症状,40天为1疗程,47例门诊患者,15天脱瘾率达100%,疗程结束后,6个月随访复吸率19.17%(河南中医,1996,3)。

何荣昌用洛恩胶囊治疗海洛因依赖30例有良好效果[中国神经精神疾病杂志,1994,(5):附6]。

杨良等用康灵片(冬虫夏草等中药复方制剂)用于治疗海洛依赖有较好效果(中国药物性依赖通报,1995,(4):210),庄礼兴取穴内关(双)、素髻。心悸配神门(双);胸闷、腹痛配足三里(双)。戒断症状出现予针刺,强刺激,或加电针连续波。并用戒毒汤:柴胡10g,法半夏、黄芩、竹茹、枳实、党参、郁金、大黄(后下)、车前子各15g,甘草5g,白茅根20g。日1剂,水煎服。戒毒25例治疗2周,结果显效(戒断症状消失,无寻药现象,体温、呼吸、脉率、血压正常,精神好转,面色红润,食欲增加2倍,体重增加>1kg)18例,有效6例,中断治疗1例。治疗后16例IgA、IgM、IgG高于正常范围,11例恢复正常;19例T-淋巴细胞转化率低于50%,12例恢复正常[针灸临床杂志,1995,(6):11]。

刘福倍用常规贴压法,取耳穴神门、肺、脾或胃、皮质下、内分泌、耳背心,随症加穴。针刺取百会、翳风穴,进针得气后,接 G6805 电针仪,连续波,输出量以患者能耐受为度,30~60min,日 1 次。必要时予冬眠灵 25~50mg、安定 10~20mg 肌注。戒毒 40 例。结果治愈 30 例,显效 6 例,无效 4 例,总有效率 90%。平均住院 6.13 日(陕西中医,1993,(2):81)。四是恢复期即戒断症状期的半年内,治疗目的在于消除海洛因对人体的慢性毒害,应采用药物治疗和精神鼓励相结合的方法。药物治疗主要针对气血双亏、心神不宁,治以补益气血、安养心神,常用归脾汤、八珍汤等。并发感染者加清热解毒之品。另外可以南瓜藤煎汤代茶饮用,以预防戒毒后复发[马敬明,陕西中医,1996,(10):457]。

【方名】 仙方戒毒灵。

【组成】 柴胡 10g,大黄 20g,枳实 20g,黄连 6g,黄芩 10g,白芍 20g,大枣 6 枚,半夏 20g,栀子 20g,豆豉 20g,山楂 20g,延胡索 20g,生姜 6g,甘草 10g。

【来源】 刘东亮,实用中医药杂志,1994,(4):31。

【功效】 荡涤脏腑,宁神清窍,调理脾胃。

【适应证】 吗啡类药物依赖戒断症候群属实证者。

【方药简析】 方中药物份量为编者所加。本方重在汤涤毒浊、通腑泻实,使毒浊之气从下而排,使三焦复通、脏腑郁结渐解。方中重用大黄、枳实汤涤脏腑、通腑泻浊;黄芩、黄连、栀子、豆豉、甘草清心泻浊、宁神除烦;延胡索、山楂、白芍、姜、枣调理脾胃、护阴止痛。诸药共奏荡涤脏腑毒浊、宁神清窍、恢复脾胃功能之效。若见腹痛明显,数日不食不饥,恶心呕吐频作,大便黑而干结(15~20 天 1 行),舌苔灰黑而厚燥津少,脉弦实者为胃肠郁闭,上方可加芒硝、番泻叶以加强通泻之功,配

【功效】 温阳固脱,控制戒断症状出现。

【适应证】 海洛因成瘾戒断症状。

【方药简析】 本方是由桂枝甘草汤、四逆汤、桂枝加附子汤、吴茱萸汤、桂枝加龙骨牡蛎汤共同化裁而来。方中附子走而不守,能通行十二经,兼以温阳,为主药,然而有毒,用药时应注意观察心律变化以防中毒;辅以红参补心肺之气,龙骨牡蛎固脱安神,吴茱萸温中止呕止利,炒枣仁养心安神;佐以桂枝、白芍、生姜调和营卫、解肌止痛;甘草为使。全方共奏温阳固脱安神的作用。成隐者对镇静药有耐受性,故炒枣仁非大剂量难以奏效,本方用至 60g;若症状甚者加罂粟壳。马敬明以本方为主,按上述加减用药治疗本症有良效。

【病案举例】 张某,男,24岁,1993年5月4日初诊。患者于2年前开始吸毒,曾于戒毒所强行戒毒1次,但戒毒后3个月复发。现日吸“白粉”2包。自诉多次想自行戒毒,但停吸毒后躁扰不宁,虽服用安定 2.5mg×50片仍难于入眠,故特此求治。处方:红参 10g,附子 9g,吴茱萸、远志各 12g,鲜生姜 25g,炒枣仁 60g,龙骨、牡蛎、罂粟壳各 20g。于停止吸毒后 1、2、3、4、5 天内分别服本方 1 剂、2 剂、3 剂、2 剂、1 剂。第 6 天来诊,精神好转,饮食睡眠良好,小便增多,改方用黄芪、炒枣仁各 30g,党参 20g,白术、茯神、远志各 10g,当归 12g,陈皮 9g,甘草 6g,1 天 1 剂,共服 12 剂。复诊体重较前增加 4kg,身体感觉良好,改服归脾丸巩固治疗。2 年后随访,再未吸毒。

【方名】 补元解毒汤。

【组成】 白术 30g,茯苓 30g,黄芪 30g,桂圆肉 30g,酸枣仁 30g,人参 5g,熟地黄 20g,当归 10g,山茱萸 20g,枸杞子 20g,山药 20g,木香 10g,远志 10g,生姜 6g,甘草 6g。

【来源】 刘东亮,实用中医杂志,1994,(4):31。

【功效】 填精固髓,培补脾胃。

【适应证】 吗啡类药物依赖戒断症候群虚证者。

【方药简析】 本方以大补元煎合归脾汤化裁而成。方中用大补元煎填精固髓,以归脾汤培补脾胃,2方合用使气血得补、肾虚得复、精神得守。服用本方前,先服大承气汤(大黄、芒硝、枳实、厚朴)为先导,意在通腑逐毒、急下存阴,使毒浊从大便而出。待苔变白,脉势渐缓,毒去正气渐复,此时是培补填固之时机再投本方。若口苦、咽干、恶心、干呕者,可于大承气汤中加柴胡、半夏、生地黄、鱼腥草;失眠加合欢皮。刘东亮用本方按上述加减用药治疗吗啡类药物依赖戒断症候群属虚证者有良效。

【病案举例】 王某,男,23岁,汉族,个体经营者。患者吸食毒品5年,每日吸食量约1.5g。入院时身形枯槁,精神恍惚,迷乱无定,倦怠乏力,目光呆滞,时而语无伦次。症见:数日不眠,如醉如痴,大便干结(12~16日1行),尿黄赤,口干咽燥,恶心干呕无物,舌暗苔厚灰,燥而少津,脉虚细无力,证属毒结脏腑、脾肾两虚。治宜先通腑排毒、急下存阴。处方以大承气汤加减论治:大黄6g(后下),芒硝10g,枳实10g,厚朴20g,生地黄20g,鱼腥草30g,制半夏30g,柴胡10g,合欢皮30g,甘草6g。服3剂后,泻下黑稀便,夜可安寐2~3h,干呕消失,诸症好转,神志较清,怔忡惊悸,脉细弱,舌淡苔白。证属心脾两虚、心肾不交。治宜填精固髓、培补脾胃。以本方调治。进药3剂后,收效甚佳,诸症悉减,大小便如常,神情渐复,语清,日可安寐4h许。效不更方,守方13剂,饮食正常,精神佳,无吸毒欲望,系临床治愈出院。

【方名】 少腹逐淤汤。

【组成】 小茴香15g,干姜8g,延胡索15g,当归10g,没

10g,川芎 12g,肉桂 8g,赤芍 10g,蒲黄 15g,五灵脂 15g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血祛瘀,温通止痛。

【适应证】 吗啡药物依赖。

【方药简析】 本方中药物份量系编者所加。方中以小茴祛寒理气,善止寒证腹痛为主药;干姜散寒,延胡索理气活血止痛,共用为辅药;没药、当归、川芎、赤芍、蒲黄、五灵脂活血通利血脉而止痛,肉桂温中补阳散寒止痛,共用为佐使药。全方有活血祛瘀、温通止痛之功效。余亚东用本方加桃仁、大黄、枳实治疗吗啡药瘾腹痛有良效。

【病案举例】 龙某,男,52岁,工人,初因腹部绞痛,误诊为阑尾炎、胆石症、输尿管结石症等,经数次剖腹手术均未发现病灶。后腹痛加剧频繁发作又误诊为肠粘连而手术,终未解除绞痛之苦,最后诊断为胃肠神经官能症。每次发作只有注射吗啡方可止痛,因而导致吗啡成瘾,历时已5年之久。近因麻醉药品管理甚严,再不能给成瘾患者使用,故腹绞痛又频繁发作,痛如刀绞难以忍受。刻诊:腹痛难忍,拒按,痛有定处,肠鸣音增强。诉曾用过行气止痛、温阳散寒药无效。考虑为气滞血瘀,用少腹逐瘀汤加味:小茴香 15g,干姜 8g,延胡索 15g,没药 10g,当归 10g,川芎 10g,肉桂 8g,赤芍 10g,蒲黄 15g,五灵脂 15g,桃仁 10g,大黄(后下)10g,枳实 12g。服上方1剂腹痛即止,连服3剂即安然无恙。继以当归芍药散加味:当归 12g,白芍 20g,泽泻 10g,白术 10g,川芎 12g,炙甘草 4g,枳实 12g,延胡索 12g,山药 12g,茯苓 12g。服10剂以善后。隔1月左右腹痛复发1次,但症状轻,又如前法先服少腹逐瘀汤2剂,继服当归芍药散5剂,即可止痛。当年中仅复发3次,次年仅复发2次,每次复发都守上方获效,第3年以后未再复发,恢复工作,身健如初[余亚东,江西中医药,1996,(6):7]。

天后,阴茎勃起坚硬,历时约 10min 之久。停药,解除房禁,性生活完全恢复正常,追访半年,未见复发。

牡汤加减；湿热蕴结者用三黄四苓汤加减；肝旺扰神者用益脑宁加减；肝肾虚、肝阳亢者用静平汤、滋潜合剂、静灵丹、静灵口服液加减；心肾两亏者用归脾肾气汤加减；肾虚者用龟鹿益智汤、龟鹿二仙汤加减。

宋知行将本病分为 2 型，实证以痰热为主，除多动症表现外，伴见喉间多痰、脘痞纳少、两脉软滑、舌苔白腻或见舌尖红刺，或见尿黄，用黄连温胆汤加味；虚证属髓海不足，症见动作欠灵、思维较慢、记忆不清、脉弱苔润，治拟左归丸加味。收治 50 例，服药方法为 1 周 5 帖（周六、日暂停），坚持 1 至 3 月，结果显效 14 例，好转 24 例，有效 8 例，无效 4 例[陕西中医杂志，1987，(8)：397。辽宁中医杂志，1987，(6)：24]。

张永华把本病具体分为 3 型：肝肾阴虚、神动智变。证见神思涣散，烦急易怒，多语多动，指甲发泽不荣，唇舌红而下，脉细数或弦细而数，治以滋阴潜阳、宁神益智，自拟静灵丹；心脾气虚、神浮智变，证见神思涣散，多语而少激昂，多动而不暴戾，身疲乏力，饮食少思，而色萎黄不泽，唇舌色淡而润，脉濡缓，治拟温养心脾、宁神益智，以桂枝甘草龙骨牡蛎汤合六神散加减；痰热内扰、神浮智变，证见神思涣散，烦急易怒，多语不避亲疏，多动难以制约，纳呆口臭，小溲黄赤混浊，舌质红苔黄厚滑腻，脉浮滑或弦滑，治拟清化痰热、宁神定智，方拟黄连温胆汤合栀子豉汤加减。共治 326 例，服药 30 天为 1 个疗程，总有效率为 92.5%[北京中医学院学报，1987，(3)：27]。

张永等治疗本病属心气虚亏 6 例（除多动症表现外，伴有梦多、而色萎黄、精神倦怠、食欲不振、大便较硬、脉细弱，舌淡苔少。治宜益气养心，方用归脾汤或养心汤加减），心肾两虚 8 例（除多动症表现外，见神萎、足无力、面色㿠白，畏寒肢冷、小溲清长或短数，脉沉迟或微弱，舌淡少苔。治拟温肾养心，方用肾气丸或右归丸），心阴亏少型 2 例（除多动症表现外，并见性

牡汤加减；湿热蕴结者用三黄四苓汤加减；肝旺扰神者用益脑宁加减；肝肾虚、肝阳亢者用静平汤、滋潜合剂、静灵丹、静灵口服液加减；心肾两亏者用归脾肾气汤加减；肾虚者用龟鹿益智汤、龟鹿二仙汤加减。

宋知行将本病分为 2 型，实证以痰热为主，除多动症表现外，伴见喉间多痰、脘痞纳少、两脉软滑、舌苔白腻或见舌尖红刺，或见尿黄，用黄连温胆汤加味；虚证属髓海不足，症见动作欠灵、思维较慢、记忆不清、脉弱苔润，治拟左归丸加味。收治 50 例，服药方法为 1 周 5 帖（周六、日暂停），坚持 1 至 3 月，结果显效 14 例，好转 24 例，有效 8 例，无效 4 例[陕西中医杂志，1987，(8)：397。辽宁中医杂志，1987，(6)：24]。

张永华把本病具体分为 3 型：肝肾阴虚、神动智变。证见神思涣散，烦急易怒，多语多动，指甲发泽不荣，唇舌红而下，脉细数或弦细而数，治以滋阴潜阳、宁神益智，自拟静灵丹；心脾气虚、神浮智变，证见神思涣散，多语而少激昂，多动而不暴戾，身疲乏力，饮食少思，而色萎黄不泽，唇舌色淡而润，脉濡缓，治拟温养心脾、宁神益智，以桂枝甘草龙骨牡蛎汤合六神散加减；痰热内扰、神浮智变，证见神思涣散，烦急易怒，多语不避亲疏，多动难以制约，纳呆口臭，小溲黄赤混浊，舌质红苔黄厚滑腻，脉浮滑或弦滑，治拟清化痰热、宁神定智，方拟黄连温胆汤合栀子豉汤加减。共治 326 例，服药 30 天为 1 个疗程，总有效率为 92.5%[北京中医学院学报，1987，(3)：27]。

张永等治疗本病属心气虚亏 6 例（除多动症表现外，伴有梦多、而色萎黄、精神倦怠、食欲不振、大便较硬、脉细弱，舌淡苔少。治宜益气养心，方用归脾汤或养心汤加减），心肾两虚 8 例（除多动症表现外，见神萎、足无力、面色晄白，畏寒肢冷、小溲清长或短数，脉沉迟或微弱，舌淡少苔。治拟温肾养心，方用肾气丸或右归丸），心阴亏少型 2 例（除多动症表现外，并见性

急烦躁、口渴喜饮、梦多不安、便秘干结、脉细数，舌红苔剥。治拟滋阴养心，方用百合地黄汤、天王补心丹、生脉散出入），结果显效4例，好转11例，无效1例（上海中医药杂志，1983，（6）：24）。临床辨为湿热蕴结者10例。立清热利湿之法，药用导赤散或三黄合四苓散，经治1个半月至4个月左右，皆有好转，其中4例恢复正常[辽宁中医杂志，1983，（10）：31]。

张横柳以内服小柴胡汤加减治疗本病80例，1个月为1个疗程，1～3个疗程评定疗效，结果有效率为86.25%，在改善智商、遗尿、眼眶黧黑等方面，均优于利他林对照组[中西医结合杂志，1990，（5）：278]。二是在辨证的基础上，选用有类似中枢兴奋和镇静作用的药物（远志、石菖蒲、龟板、茯苓、龙骨、鹿角胶、熟地黄、淮山药、五味子、附子、龙胆草等）进行治疗。三是针灸治疗。张家维用针灸治疗本病48例，主穴取内关、太冲、大椎、曲池。注意力不集中配百会、四神聪、大陵；活动过多配定神、安眠、心俞；情绪烦躁甚者配神庭、膻中、照海，用泻法，不加灸，每天或隔天1次，10次为1疗程。每次针刺后即用梅花刺叩背部夹脊、膀胱位、督脉，以叩至皮肤潮红为度，心俞、肾俞、大椎等穴则要重点叩刺。结果痊愈39例，好转5例，无效4例[新中医，1987，（1）：29]。四是对患儿进行教育引导。

【方名】 温胆龙牡汤。

【组成】 黄连1.5g，陈皮4.5g，半夏4.5g，茯苓10g，竹茹4.5g，石菖蒲15g，远志4.5g，龙骨30g，牡蛎30g，琥珀2g。

【来源】 宋知行，陕西中医，1987，（9）：397。

【功效】 化痰清热，开窍宁神。

【适应证】 儿童多动症，痰热实证者。

【方药简析】 方中药物份量为编者所加。本方系由黄连

温胆汤化裁而成。用黄连温胆汤以清化痰热；石菖蒲、远志以化浊开窍宁神；配龙骨、牡蛎、琥珀以镇潜浮阳、安定心神。全方化痰清热开窍宁神。若心肝火盛、痰湿不重，症见烦躁易怒、尿赤便燥、眠扰梦多、舌质较红，上方去陈皮、半夏、茯苓，加龙胆草、钩藤、竹叶、麻仁等；若痰湿蕴结、邪热不显，症见时作咳嗽、纳呆呕恶、大便偏溏、舌苔腻浊，上方去黄连，加厚朴、山楂、神曲等。服药方法是1周5剂，周六周日暂停，坚持1至3个月。宋知行等用本方，按上述加减用药治疗本病14例，有良好效果。

【病案举例】 徐某，男，10岁，1986年6月28日初诊。好动2年，现4年级，有多动症各项表现，外院诊断儿童多动症，服用西药无效。神经检查均为阳性。拟诊儿童多动症。中医症见纳可消瘦，时有痰嗽、夜寐欠安、遗尿频作，脉软滑，舌边尖红刺，苔薄腻。证属痰热扰神，治以化痰清热开窍。药用：黄连1.5g，龙胆草、远志、陈皮各4.5g，柏子仁10g，石菖蒲15g，淮小麦、煅龙牡各30g，炙龟板、桑螵蛸、覆盆子各9g。上方加减，曾参入琥珀、珍珠母、钩藤、生地诸品，服用80天左右，病情日见好转。随访至1987年1月，多动症症状基本告平。

【方名】 三黄四苓汤。

【组成】 黄连10g，黄柏5g，黄芩、白术、茯苓、猪苓、泽泻各9g。

【来源】 张永，辽宁中医杂志，1983，(10)：31。

【功效】 清热利湿。

【适应证】 儿童多动症，湿热蕴结见证者。

【方药简析】 方中以黄连、黄芩、黄柏相伍清三焦湿热为主；以《丹溪心法》之四苓散利水渗湿，使湿热从小便排出。诸药共用以清利湿热。若湿火内阻者加知母、厚朴、佩兰以利湿

泻火；若湿热扰神者加苍术、远志、石菖蒲、钩藤、淮小麦、甘草等以清化利湿、养心安神。张永以本方为主按上述加减用药治疗本病10例，治疗1个半月至1个月左右，皆有好转，有4例基本接近正常。

【病案举例】 魏某，男，11岁，1981年8月18日初诊。家长主诉患儿平时注意力不集中，上课小动作多，性格比较孤僻，语言表达力差。曾作24h尿检儿茶酚胺测定偏低。西医拟诊脑功能轻微失调。经服西药无效且有副作用。中医症见大便干结，小溲黄赤，口渴饮多，唇色樱红，胃纳不香，口臭咽痛，脉象滑数，舌尖红苔白腻。证属湿火内阻、熏蒸扰神。治拟利湿泻火。处方：黄连1.5g，黄芩9g，赤茯苓9g，猪苓6g，泽泻9g，藿香佩兰各10g，厚朴3g。服5剂。后以本方加减，服用月余。10月6日四诊。患儿注意力能保持较长时间集中，家长反映脑功能轻微失调的各种表现有明显减轻。复查24h尿检儿茶酚胺测定已经正常。现大便尚有时干结，唇色较红，舌尖红苔薄腻，脉数带滑。湿火未净，再宗前法。黄柏6g，黄芩9g，白术6g，赤茯苓9g，泽泻9g，枳壳4.5g，厚朴2g，陈皮3g，苡仁10g，甘露消毒丹12g(包)，更衣丸2g(需要时服)。7剂。嗣后症情更见好转，其病渐平。

【方名】 益脑宁。

【组成】 龙胆草4.5g，茯苓9g，远志4.5g，珍珠母30g，神曲9g，甘草4.5g。

【来源】 朱锦善，江西中医药，1984，(5)：38。

【功效】 扶土抑木，宁心安神。

【适应证】 儿童多动症，证属肝旺神扰者。

【方药简析】 方中所用药物份量为编者所加。方中龙胆草清热平肝；远志、珍珠母、茯苓、神曲等宁心安神；茯苓、神

枸杞子 12g,夜交藤 12g。

【来源】 滕宣光,北京中医杂志,1987,(5):5。

【功效】 平肝潜阳,滋补肝肾。

【适应证】 儿童多动症,证属肝旺阳亢阴亏者。

【方药简析】 方中以生牡蛎、珍珠母合用平肝潜阳;白芍、女贞子、枸杞子、夜交藤合用滋补肝肾之阴。诸药合用可平肝潜阳、滋补肝肾。若阴血不足者加熟地黄、阿胶;脾气虚弱者加茯苓、白术;心血不足者加炒枣仁;烦躁易怒加丹参;脾肾气虚加补骨脂、黄精。滕宣光以本方为基础,按上述加减用药,治疗本病 15 例,结果 15 例患儿全部治愈(3 个月内症状全部消失),疗程最长者仅 1 例 55 天,最短者仅 15 天,平均约 25 天。经随访半年内皆未复发。

【病案举例】 叶某,男,8 岁,1974 年 3 月 7 日初诊。不自主耸肩、抬胸已两年,近 1 月来发作频繁,接连不断地耸肩抬胸、鼓肚、气息喘促,屡经说服也不能自控。诊见面色萎黄,大便干结,食欲不振,舌质暗红,苔薄黄,脉弦数。证属阴血不足,肝失濡养。治宜滋阴养血、平补肝肾。方药:生地黄 10g,熟地黄 10g,白芍 10g,珍珠母 10g,生牡蛎 12g,枸杞子 12g,女贞子 15g,阿胶 12g,生鳖甲 12g,夜交藤 12g。服药 3 剂,耸肩抬胸、鼓肚等症状基本消失,晚间睡眠前偶有发作,舌苔白腻,脉滑略数。原方去赭石加菖蒲 10g,取芳香化湿醒窍之用,连服药 18 剂,症状完全消失,随访 1 年未再复发。

康某,男,8 岁,1982 年 11 月 9 日初诊。4 年来不断眨眼、咧嘴、挺胸伸颈、仰头、腹肌抽动。多处求医,服镇静药物未见功效,来院求治中医。诊见频频不自主地眨眼、咧嘴、伸颈仰头、挺胸耸肩、腹肌抽动。1 月来加重,不能上课学习,烦躁易怒,夜寐多梦,食欲欠佳,大便时有糟粕,睡间遗尿,舌苔白腻,舌质红,脉弦而滑。证属脾肾两虚、肝阳偏亢。治宜补益脾肾、

平肝潜阳。方药：生龙齿 15g，生牡蛎 15g，珍珠母 15g，丹参 12g，女贞子 15g，枸杞子 15g，夜交藤 12g，茯苓 15g，熟地黄 10g，白芍 10g。投药 3 剂，眨眼、伸颈、仰头症状消失。又服药 5 剂，挺胸、耸肩、咧嘴、腹肌抽动停止，夜眠安舌质略红，苔薄白，脉弦滑原方继服 3 剂。停药十天后，病情略有反复，症见眨眼、挺胸、伸颈（症状甚微），食欲欠佳，偶有遗尿，舌质转淡，苔薄白湿润，脉沉滑。肝阳上亢渐平，脾肾气虚尚未复原，予以益肾健脾，再处：茯苓 15g，白术 6g，补骨脂 10g，黄精 10g，丹参 10g，炒枣仁 15g，生牡蛎 15g，夜交藤 15g，白芍 10g，五味子 10g。连服 5 剂，眨眼、伸颈、挺胸症状尽逝，遗尿未再出现。原方去五味子，改用女贞子 12g 巩固疗效，随访 6 年未再发。

【方名】 滋潜合剂。

【组成】 生龙骨 10g，生牡蛎 10g，知母 5g，黄柏 5g，熟地黄 15g，茯苓 5g，石菖蒲 10g，远志 10g，五味子 10g。

【来源】 王立华，山东中医学院学报，1989，（2）：16。

【功效】 滋阴潜阳，宁神益智。

【适应证】 儿童多动症，证属肾阴不足肝阳偏盛者。

【方药简析】 方中药物剂量系编者所加。本方是根据钱乙创制的六味地黄丸为基础加减变通而成。方中六味地黄丸是滋阴益肾的代表方剂，知母、黄柏是治疗阴虚火旺的最佳配伍；石菖蒲芳香而散。《本草从新》中说，其药能开心孔、利九窍、舒心气、畅心神、益心志、怡心情；远志能养心安神；五味子滋肾水、敛津、收阳中之阴、养五脏。药理研究其能克制过度兴奋，改善智力，增强注意力，改善精细协调动作，使大脑反层兴奋和抑制过程趋于平衡；生龙骨、生牡蛎安神镇惊潜阳。制成合剂，每支 10ml，12 岁以上者，每次口服 1 支，日 3 次；12 岁以下者，每次 1 支，日 2 次。王立华以本方为主治疗本病 62

例,痊愈3例(临床症状完全消失,学习成绩有提高,停药后随访3~6个月,疗效巩固者);显效18例(多动、注意力涣散等症明显改善,情绪稳定接近正常儿童,学习成绩有提高);有效34例(临床症状部分消失,学习成绩有一定提高,但不稳定);无效6例(学习困难、行为障碍无变化或略有改善)。总有效率90.5%。无明显副作用,而且能改善睡眠、遗尿、盗汗等兼证。服药最短者60天,最长者120天,平均74天。见效最快者15天,最慢者90天。

【病案举例】 刘某,男,10岁,小学1年级学生,1986年6月就诊。患儿为第1胎1产,难产,无产伤。多动病史5~6年,家族中无类似病史。患儿4岁、5岁时头颅外伤各1次,局部缝合。自幼活动过多,难以静坐,乱翻乱拆物品,上课不能集中精力听讲,不能自主完成作业,兴趣多变。计算、理解困难,学习成绩30~40分,留级2次。查体:体格瘦小,体重26kg,身高120cm,翻手试验(一)。脑电图有轻度异常改变。诊断为儿童多动症。中医症见:主症如前,夜卧不稳,梦游、盗汗、遗尿。性情急躁,不顾危险,不服管教。舌质红少苔,脉细数。证属肾阴不足、肝火偏旺。口服上方每次1支,日2次。服药4周,症状略轻,遗尿消失,睡眠好,未梦游。服药3个月,各症明显好转,上课能认真听讲,按时完成作业,多动表现消失,对事物反应较前灵敏。又隔日服药1个月,学习成绩语文82分、数学78分。共济试验(一)。

【方名】 静灵丹。

【组成】 熟地黄15g,龟板10g,知母6g,黄柏3g,龙齿10g,远志10g,石菖蒲10g,山茱萸7g,山药7g,茯苓5g。

【来源】 张立华,北京中医学院学报,1987,(3):28。

【功效】 滋阴潜阳,宁神益智。

【适应证】 儿童多动症,肝肾阴虚见证者。

【方药简析】 方中所用药物剂量由编者所加。本方系由六味地黄丸加减变通而成。方中熟地黄、山茱萸、山药、茯苓等为六味地黄丸的主要组成部分,以滋阴益肾为主;配知母、黄柏以疗阴虚火旺;石菖蒲、远志相配以醒神宁志;龙齿配龟板以平肝潜阳、镇惊安神。诸药相配共奏滋阴潜阳、宁神益智之效。以本方为主要成分,依法炮制,共研细末,炼蜜为丸,丸重6g。4~6岁每日早晚各服3g;7~13岁每日早晚各服6g;14~16岁每日早晚各服9g。温开水或淡盐水送服,连服30天为1个疗程。张立华以本方按上述方法用药治疗本病307例。结果痊愈98例(临床症状完全消失,学习成绩有显著提高,共济试验阴性,停药后随访3至6个月疗效巩固),占31.9%;有效74例(临床症状大部分消失,学习成绩有所提高,共济试验有明显改善),占24.1%;显效119例(临床症状部分消失或有所好转,某些已成为习惯的动作尚未能消除,共济试验有所改善),占35.4%;无效16例(临床症状及共济试验均无任何改善),占5.2%。

【病案举例】 张某,男,10岁,小学3年级学生,1982年7月29日初诊。主诉(其母代述):母亲妊娠期恶阻严重。顺产,出生百天曾患“大头病”,囟门开阔,颇大,西医诊为脑积水病。曾服用钙片,注射维生素D₃,两岁时颅缝始合。自幼睡眠少,学步时即以跑代步,从小尿床,至今未愈。稍大即发梦呓、梦游。3、4岁时便有多动多语、急躁易怒、冲动任性。7岁上学后以上表现更为突出,且注意力涣散,集中时间短暂,极易被来自周围环境中的细微事物干扰而分散,上课心不在焉,东张西望,如坐针毡。在家翻箱倒柜,毁坏玩具及书等物。做作业丢三落四,有头无尾,即使被强制亦难很好完成,学习成绩经常不及格。放学后不能按时回家,而在外惹事生非,爬墙攀

高,追车辆,打架,莽撞不顾后果,常致头破足伤。说谎话,难以遵守纪律和约束,批评责打均不能使其有所慑服,家长和教师为此很伤脑筋。就诊时无片刻安静,让其握物占住双手,则亦努嘴鼓腮,吐舌弄眼,出怪声,做鬼脸。共济试验(+)。诊为儿童多动症。中医症见:主症如前,形体瘦小,肤色黎黑,头颅呈△形(前后凸出),两目凹陷,中度鸡胸,指甲失泽,发干疏而成穗状。大便干燥,嗜冷食。身高1.35m,体重25kg。舌质红,苔少而下,脉弦细而数。辨证为肝肾阴虚、神动智变证。治宜滋阴潜阳、宁神益智。给静灵丹30丸,每日早晚各服1丸。1981年8月18日复诊,患儿语言、动作、注意力明显好转,睡眠时间延长,再未尿床。继服静灵丹30丸。9月5日三诊,动作、语言、注意力已接近正常儿童,教师反映上课能安心听讲。放学后能按时回家,在家能主动完成作业,看电视能聚精会神静坐1h左右。共济试验明显改善,梦游、梦呓、尿床均愈。再给静灵丹30丸以资巩固。追访1年,疗效巩固,学习成绩显著提高。主要课程均在80~90分以上,有了爱好和专长。饮食明显增加,发育明显改善,体重、身高均不差于同年龄儿童。多动症状全部消失,性格变得温文礼貌。共济试验均(-)。

【方名】 静灵口服液。

【组成】 熟地黄15g,淮山药7g,山茱萸7g,丹皮5g,茯苓5g,泽泻5g,石菖蒲10g,远志10g,龙齿10g,知母5g,黄柏5g。

【来源】 瞿秀华,上海中医药杂志,1989,(3):30。

【功效】 开窍益智,培补精血,调整阴阳,安神镇惊。

【适应证】 儿童多动症,证属肝肾阴虚、肝阳偏亢者。

【方药简析】 本方系由钱乙创制的六味地黄丸加味而成。方中淮山药、熟地黄、山茱萸健脾补肾、培补精血;龙齿滋

阴潜阳、镇静安神；石菖蒲、远志开心窍、益智能、化痰湿；茯苓、泽泻、丹皮、五味子等配合前药补脾肾、平肝阳、安神益智。诸药协同开窍益智、培补精血、调整阴阳、安神镇惊。瞿秀华以本方为主要成分制成口服液，治疗本病40例，结果25例显效（多动和注意力不集中显著改善，情绪稳定，智能接近正常，学习成绩有较大幅度的上升）；8例有效（多动和注意力不集中有一定改善，学习成绩也有提高）；7例无效（多动和注意力改善不明显，学习成绩无明显提高）。总有效率82.5%。

【病案举例】 潘某，女，6岁，1987年6月20日初诊。自幼患婴儿痉挛症，反复发作。5岁时华山医院神经科明确诊断为小儿癫痫症。经西药硝基安定、鲁米那、激素等治疗，癫痫症有所改善，脑电图复查，痫性电波消失。但至该儿读1年级时，发现上课思想分散，小动作不停，不能静坐，易被周围事物吸引，在别人讲话时要插嘴，说谎。对指及翻手试验笨拙不协调，智商80。诊断为儿童多动症。中医诊见舌苔薄白，脉细弦。中医辨证：肝肾阴虚、阴阳失调。以静灵口服液治疗。投药1星期后，患儿上课思想集中，静心听课、不再做小动作，数学由45分上升至95分，语文由60分上升至85分，智商由80上升到120。

【方名】 归脾肾气汤。

【组成】 党参9g，黄芪12g，白术12g，茯神15g，枣仁6g，益智仁9g，胡桃肉12g，熟地黄15g，淡附片3g，仙灵脾12g。

【来源】 张永，上海中医药杂志，1983，（6）：24。

【功效】 温肾补心养神。

【适应证】 儿童多动症，心肾亏虚见证者。

【方药简析】 本方系由归脾汤与肾气丸合方化裁而成。

方中党参、黄芪、白术、茯神、枣仁以益气养心；熟地黄、淡附片、仙灵脾、胡桃肉温肾养心；益智仁收涩固精敛神。诸药共奏温肾补心养神之效。若见眠难梦扰者加钩藤、龙齿、珍珠母、琥珀等；夜有遗尿者加菟丝子、覆盆子、金樱子等；记忆不佳者加枕中丹诸味；情绪冲动者合甘麦大枣汤；湿热蕴结者宜改用四苓散合导赤散；心阴亏少者改用百合地黄汤、天王补心丹、生脉散等出入。张永以本方为主按上述加减治疗本病 16 例，显效 4 例（服药 1 个月以内，多动症典型症状表现已有明显改善，注意力能保持集中，学习比较顺利）；好转 11 例（服药在 1 个月以上，多动症典型症状有所改善）；无效 1 例（服药在 1 个月以上，多动症典型症状毫无改善）。

【病案举例】 徐某，男，9 岁，1982 年 4 月 21 日初诊。患儿上课不能安定，注意力不集中，记忆力差，学习困难，成绩下降，外院诊断为脑功能失调症。中医症见：主症如前，睡眠欠佳，多梦，胃纳一般，大便稍干，面色㿔白，时有头晕，不耐体力劳动和运动，易感倦怠乏力。脉细弱，舌质淡，苔薄净。辨证为心气虚亏，治以补心养神。处方：党参 9g，黄芪 12g，白术 12g，茯神 9g，枣仁 6g，益智仁 9g，胡桃肉 12g，熟地黄 15g，淡附片 3g，仙灵脾 12g。连服 1 个月，病情显著好转，活动减少，注意力能集中，记忆力改善，精神亦振，学习成绩上升，得到老师表扬。上方加减续服数剂，以资巩固。

【方名】 鹿龟益智汤。

【组成】 鹿角片 2g，龟板 10g，柏子仁 10g，淮小麦 30g，石菖蒲 15g，远志 4.5g，龙骨 30g，牡蛎 30g，琥珀 2g。

【来源】 宋知行，陕西中医，1987，（9）：397。

【功效】 填精益脑开窍。

【适应证】 儿童多动症，肾虚证。

【方药简析】 方中药物剂量系编者所加。方中鹿角片、龟板为血肉有情之品，可补肾阳益精血、补髓海之虚；柏子仁、淮小麦养心安神；石菖蒲、远志开窍宁神；龙骨、牡蛎、琥珀镇潜安神。全方填精益脑开窍。若形寒肢冷、腰腿软弱、脉沉微、舌体胖淡，是阳虚为主，上方去龟板，加附片、黄芪；若口渴喜饮、心烦躁急、难寐梦扰、脉细苔净，则为阴精亏乏，上方去鹿角，加生熟地黄、百合、石斛之类。此外，有遗尿者加桑螵蛸、覆盆子；咬啮指甲或其他东西的，加醋炒五谷虫、炒山楂等。宋知行以本方为基本方按上述加减用药治疗本病 36 例，有良好效果。

【病案举例】 刘某，男，10 岁，1986 年 5 月 28 日初诊。好动 3 年，有多动症各种表现，经外院诊为儿童多动症。服西药有效，但见腹痛而停用。神经检查均为阳性。拟诊多动症。中医症见：主症如前，纳食较馨，眠扰梦惊，夜尿频多，大便尚调，脉细，舌苔薄润。证属肾虚髓亏，治以填精益脑开窍。药用：鹿角片 2g，炙龟板、百合、柏子仁各 10g，石菖蒲 15g，远志 4.5g，龙骨、牡蛎、珍珠母各 30g，琥珀 2g，炒山楂、神曲各 9g，红枣 7 枚。上方加减，服用 35 帖，先后加入生地黄、石斛、淮小麦、钩藤等药物，诸症改善。随访至 1987 年 2 月，多动症症状明显好转，情况稳定。

【方名】 龟鹿二仙汤。

【组成】 鹿角 10g，龟板 12g，石菖蒲 20g，益智仁 12g，枸杞子 12g，五味子 15g，何首乌 30g，丹参 30g，白芷 10g。

【来源】 周继武，河南中医，1987，增刊。

【功效】 补肾健脑。

【适应证】 小儿脑功能轻微障碍，证属肝肾不足、脑髓不充者。

59 睡行症

睡行症,是一种意识缩窄的精神障碍。本病过去称为梦游症,但睡眠实验研究证明睡行症不是发生在梦中,而是发生在入睡后前3h之内的无梦睡眠中。本病发生率约1%~6%,多见于儿童,男孩更常见。儿童的睡行症往往于6~9岁时开始,多数患儿每周发作1次左右,常于少年期以后自愈,起始迟于8~15岁,发作频率高于每周3次者多不易自愈,常迁延至成年期。本病的发生与患者的中枢神经发育不成熟、遗传因素、心理因素有关。在精神紧张或睡眠环境改变时往往发作加频。临床主要表现为患者突然从深睡中睁开眼睛(表情茫然或显惊恐状),起身离床,行动显得迟缓和呆笨,行为缺乏目的性,或搓揉摸索,或徘徊漫步,数分钟后又回到床上继续睡觉;有些睡行症患者的行为可比较复杂,他们起身能穿衣戴帽,入厨吃喝,入厕小便,然后开门外出,漫无目的走到较远地方,异地而眠。睡行症每次发作中的行为有重复性,次晨醒来回忆不起发作的经过,对所作过的事情感到惊诧不已。本病应同分离性癔症、老年性痴呆、脑器质疾病及癫痫鉴别诊断。本病一般用利眠宁、安定、硝基安定、氯基安定、氯羟安定等防止睡行症发作。

本症中医未例专病论述,其散见于有关郁症、不寐、痫证、惊证、夜游症、遗尿症等各篇。本病的主要病因病机是由于稚阳之体不耐邪扰,及五志所伤,或阴虚阳亢,或痰火内扰,或痰淤内阻,导致心神不能下潜入于阴分,肝魂不宁,魂不随神而

往来,则发为睡行症。临床所见多为虚实夹杂之症,故临证首当辨证。阴虚阳亢者用龙牡芍药宁心汤加减,肝阳上亢者用龙牡芍药镇肝汤加减,阴气亏虚者用龙牡芍药四物汤加减,脏阴不足者用甘麦大枣二冬汤加减,心肾气虚者用补肾摄纳汤加减,虚中挟痰热者用舒神煎或枣仁汤或定游汤加减,阴虚火扰用百合安夜汤加减,血虚挟风痰淤阻者用天麻钩藤通窍汤加减,痰火扰心者用黄连温胆镇魂汤、朱磁丸加减,阳虚饮结、肝胆失调者用柴胡加龙骨牡蛎汤加减。二是在辨证的基础上注意配合镇潜心神的龙骨、牡蛎、珍珠母、生铁落、朱砂等,及养心安神的小麦、枣仁、柏子仁、五味子等药物。三是避免能加深睡眠的因素,如过度劳累、熬夜、服催眠药、饮酒等,以防止本病发作。四是在药物治疗的同时不可忽视护理及对危险的防范,对发作中的患者不要勉强去唤醒,可牵回家中继续睡觉。

【方名】 龙牡芍药宁心汤。

【组成】 生龙骨 30g,生牡蛎 30g,生白芍 20g,枣仁 20g,生地黄 20g,莲子 20g,太子参 12g,石决明(先煎)20g,茯苓 12g,五味子 12g,甘草 10g。

【来源】 田振典,河南中医,1993,(6):260。

【功效】 滋阴潜阳,宁心安神。

【适应证】 睡行症,阴虚阳亢型。

【方药简析】 方中生龙骨、生牡蛎镇肝敛魂,白芍滋阴养肝,共为主药;辅以枣仁、五味子、莲子、太子参诸药益心气、养心阴、宁心安神;生地黄助白芍滋养肝阴;石决明助龙骨、牡蛎镇肝敛魂。全方共使阴津充、阳气潜、魂有所收,以达滋阴潜阳、宁心安神之效。冯化驯以本方为主治疗本病有良效。

【病案举例】 李某,男,35岁,司机。2月前晚间其突然从睡眠中起床,无意识地乱翻家中箱柜,持续约10min左右,后

自行入睡,未引起家人注意。时隔1周,晚上突然从寐中起床,披衣外出,在院内走动约10min,步态蹒跚,回屋后自行入睡,次日不能回忆。经查脑电图示:界限性脑电图。诊断为睡行症,曾用安定、利眠宁治疗,效果不明显,发作次数有增无减,每晚即发。中医症见:主症如前,精神不振,形体消瘦,全身乏力,心烦多梦,手足心有汗,入睡时手足颤动不可自制。苔微黄,质红,脉象弦细。辨证为情志所伤、阴精暗耗、不能遏制肝阳。治宜滋阴潜阳,佐以宁心安神。方用龙牡芍药宁心汤原方,水煎服,日服1剂,分2次服。服15剂后诸症皆平。随访半年,未见复发。

【方名】 龙牡芍药镇肝汤。

【组成】 生龙骨、生牡蛎各30g,白芍15g,枣仁12g,茯神15g,代赭石30g,草决明15g,石决明(先煎)20g,菊花20g,甘草6g,生地黄20g,莲子12g。

【来源】 田振典,河南中医,1993,(6):260。

【功效】 镇肝潜阳,养心安神。

【适应证】 睡行症,肝阳上亢型。

【方药简析】 本方系由龙牡芍药宁心汤加减而成。方中龙牡芍药宁心汤即平肝潜阳,又滋心肝之阴;代赭石增强龙骨、牡蛎之重镇;草决明、菊花以助白芍等滋心肝之阴。冯化驯以本方为主治疗本病有良效。

【病案举例】 李某,男,27岁,司机。患者禀性刚暴,争强好胜。发病前2天因业务琐事与人争吵,第3天晚突然从睡眠中起床披衣外出,登入自有汽车厢内转几圈后,回屋自行入睡,次日不能回忆。脑电图检查未见异常。诊断为睡行症。中医诊见:主症如前,头晕、烦躁、易怒,耳鸣如蝉,入夜尤甚,口干不欲饮,大便头干。舌苔黄、质暗红,脉象弦而有力。证属肝

气升发太过、阳气浮动于上的肝阳偏亢证。治以镇肝潜阳，佐以养心安神。方用龙牡芍药镇肝汤原方。服10剂后除头晕、烦躁、易怒、耳鸣口干尚存外，余症皆除。舌质红，苔微黄，脉象弦而有力稍平，略带数象。乃阴津尚未平复，以上方代赭石减至15g，加黄芩12g，旱莲草15g，枸杞子12g，又进20剂，诸症悉平。为善其后，以六味地黄丸巩固之。

【方名】 龙牡芍药四物汤。

【组成】 生龙骨、生牡蛎各15g，白芍12g，当归15g，川芎9g，生地黄12g，枣仁12g，莲子15g，茯苓12g，五味子10g，甘草6g，丹参20g。

【来源】 田振典，河南中医，1993，(6)：260。

【功效】 滋阴潜阳，养血安神。

【适应证】 睡行症，阴血亏虚型。

【方药简析】 本方系由龙牡芍药宁心汤合四物汤而成。方中龙牡芍药宁心汤滋阴潜阳；四物汤补暗耗之阴血。全方滋阴潜阳、养血安神。冯化驯以本方为主加减治疗本病有良效。

【病案举例】 阎某，男，30岁，干部。患者于年内因晋职称未遂，加之准备考试，大伤于神思。出现失眠、多梦、夜烦不能卧，睡眠时手足颤动不能自制。在某医院服用安定之类，开始尚有效，后效不佳。于3个月前发生夜间突然起床外出，在马路上来回徘徊走动，约10min左右，后返回入睡，次日不能回忆。每周发作2~3次，发作时家人呼之不应。某医院做脑电图示右颞部可见棘波病灶，诊为精神运动性癫痫，给服抗癫痫药（药名不详），效不显。中医诊见：失眠、多梦、夜烦不能卧，睡眠时手足微颤。苔薄黄、质淡，脉象弦细数。诊断为血虚不能养神之梦游症。给服龙牡芍药四物汤原方。连服20剂后症状控制，苔转薄白、质稍红，脉象较前缓和。继服本方30剂，痊

愈，嘱其服归脾丸以善其后。

【方名】 甘麦大枣二冬汤。

【组成】 小麦 60g，甘草 6g，大枣 9 枚，柏子仁、五味子、麦门冬、天冬、玄参各 15g。

【来源】 温建余，新中医，1992，(12)：22。

【功效】 平躁缓急，养心安神。

【适应证】 睡行症，脏阴亏虚、心神失养证者。

【方药简析】 本方以甘麦大枣汤加柏子仁、五味子调养心阴、养心气而安神为主；麦门冬、天冬、玄参生津补阴，滋燥泽枯为辅。诸药合用，有平躁缓急、养心安神之效。温建余以本方为主治疗本病有良效。

【病案举例】 黄某，男 14 岁，学生，1990 年 3 月 13 日诊。3 年前无诱因而突然夜间起床，手舞足蹈，嚎叫不休。嗣后则间歇发作，长则半月，短则 5～6 天 1 发，以精神受刺激后易发。每发均在夜间入静之后，发作时呼之不应，无口吐白沫和抽搐，只是不停地叫唤，手足舞动，约持续 30min 左右后自然平静，平静反肢冷出汗。翌日自觉精神疲倦，询问其昨宵情景，茫然无知。平时心惕易惊，寐多呓语，智力减退，口干思饮。脑电图、脑血流图等辅助检查均无异常。诊断为睡行症。服用中西药物不效。中医症见：主症如前，饮食二便正常，舌淡红，苔白微腻，脉略滑数。处以上方 3 剂，水煎服，每日 1 剂，睡前顿服。1 年后随访，服上药后未再发病。

【方名】 补肾摄魂汤。

【组成】 熟地黄 15g，山药 20g，枸杞子 20g，五味子 15g，肉桂 10g，附子 10g，人参 10g，茯神 15g，石菖蒲 15g，枣仁 15g，远志 15g，龙骨 15g，牡蛎 15g，桑螵蛸 15g，益智仁 15g。

【来源】 朱永志,中医杂志,1994,(8):464。

【功效】 补肾摄纳,养心安神。

【适应证】 睡行症,心肾气虚者。

【方药简析】 方中所标药物剂量为编者所加。本方以熟地黄、山药、枸杞子、五味子、肉桂、附子温补肾气;人参、茯神、石菖蒲、枣仁、远志益气养心;龙骨、牡蛎、桑螵蛸、益智仁等收敛固摄。诸药相伍,心肾气复、神志得藏、下元得固,则夜游遗尿之疾可愈。张琪治用本方为主随证加减治疗本病有良效。

【病案举例】 姜某,女,13岁,1984年11月30日诊。患夜游症1年余,且伴有遗尿症。本年7月份曾因车祸而致昏迷,经抢救后神志恢复,未遗有其他症状,但夜游加重,每晚必发,发则睡中出走。遗尿也随之加重,每夜必遗。几经治疗未效,因请诊治。中医症见夜寐不安,夜游遗尿,面色无华,神疲乏力,舌淡红,脉沉而无力。诊断:夜游遗尿症。证属心肾气虚、神志失藏且下元不固、膀胱失约。治以补肾摄纳、养心安神。处方:龙骨20g,牡蛎20g,益智仁15g,远志15g,龙齿15g,山药20g,五味子15g,熟地黄15g,甘草10g,人参10g,杏仁15g,石菖蒲15g。服药6剂,遗尿症状减轻,隔1~2日遗尿1次,但仍有夜游,睡眠不安。面色较前转佳。前方加枣仁15g、枸杞20g,再服。又6剂后夜游外出次数大减,时间亦缩短,遗尿基本控制,近1周来未有遗尿。精神转佳,但夜寐多梦,舌淡红,脉沉迟。继用前方加附子10g、肉桂10g,连服14剂。1985年1月3日四诊,述除12月18日有1次遗尿外夜游、遗尿未再发生,但尚有夜间多梦易惊。此心肾气虚渐复,尚未收全功。嘱继用前方桑螵蛸15g半月,巩固半月。后追访半年,已痊愈。

【方名】 舒神煎。

【组成】 生百合20g,炒枣仁20g,生地黄12g,知母12g,

茯苓 12g,半夏 12g,炙甘草 15g,生龙骨 30g,生牡蛎 30g,浮小麦 30g,柴胡 10g,大枣 5 枚。

【来源】 闫金兰,中医研究,1994,(2):40。

【功效】 清热养阴,化痰平肝,敛魂安神。

【适应证】 睡行症,心肝两虚,痰火上扰见证者。

【方药简析】 心肝两虚,挟痰火上扰神明,神无所主,肝血亏损,魂不守舍,发为睡行症。方中生百合、生地黄、知母、炒枣仁、炙甘草、浮小麦、大枣补阴血以安神为主;辅以茯苓、半夏化痰;佐以柴胡、生龙骨、生牡蛎调肝敛魂安魄;甘草、大枣补中并调和诸药为使。全方虚实并调,可使脏虚得补,痰火熄灭,神魂安和。方中可加胆南星以加强清化痰热之力。闫金兰以本方为主按上述加减治疗本病有良效。

【病案举例】 张某,男,51 岁。患者常心烦寐差,时睡梦中惊醒。近两个月来,每 5 到 6 天,睡至深夜不自觉外出行走数百米,碰到异物而清醒回家续睡。白天照常工作,仅感乏力,精神不振口苦咽干。饮食尚可,大、小便正常。舌质红,苔腻稍黄,脉弦滑。诊为阴血亏虚、痰火上扰神明之夜游症。治以养阴血、安心神、敛魂魄,佐以清痰火。给予舒神煎加胆南星,服 16 剂,愈。

【方名】 枣仁汤。

【组成】 炒酸枣仁 30g,柏子仁 15g,合欢皮 12g,夜交藤 12g,川芎 12g,知母 12g,茯神 12g,生龙骨 12g,生牡蛎 12g,朱砂 1.5g(分 2 次冲)。

【来源】 刘继延等,《奇难病证验案选萃》引《临证录》方。

【功效】 养血安神,清热祛痰。

【适应证】 睡行症,五志化火、伤阴生痰见证者。

【方药简析】 本方系由张仲景的酸枣仁汤化裁成。方中

【方名】 百合安夜汤。

【组成】 百合 12g, 生地黄 12g, 知母 9g, 黄连 3g, 白芍 9g, 当归 9g, 茯神 9g, 石决明 16g, 珍珠母 30g, 远志 4.5g, 炙甘草 4.5g。

【来源】 陈克正, 中医杂志, 1981, (6): 442。

【功效】 滋阴清肺, 宁心安神。

【适应证】 睡行症, 阴血不足、心肺火旺见证者。

【方药简析】 本方系由仲景百合地黄汤加味而成。方中百合、生地黄润肺清心为主; 黄连、知母辅助主药清心除烦; 佐以白芍、当归以加强养阴补血, 茯神、石决明、珍珠母、远志以镇静安神; 炙甘草调和诸药为使。诸药合用使心肺阴血之虚得补, 邪火得除, 魂魄于阴分得以安宁。陈克正用本方治疗睡行症(属阴血不足、心肺火旺者)有良效。

【病案举例】 江某, 男, 45岁, 农民, 1979年12月4日初诊。由病人家属陪来代诉: 患者向来身体尚好, 少有疾病, 1月前因吵架而出现夜游症, 夜间入睡后, 突然起床在屋外行走, 良久又回床而卧。起初家人不注意。不数日又夜游, 问其为何夜出? 病人称未有夜出, 于是引起家人和邻里注意。开始3~5日1发, 近日越发越频, 或隔夜1次, 或每日1次。白天问之, 均谓未曾夜出, 反见神思恍惚、烦躁不安。虽仍可参加田间劳动, 但效力很差。曾在当地卫生所服过镇静剂(如苯巴比妥等), 不见效, 故来求诊。西医诊断为睡行症。望其面色, 不见异常。问其便食, 尚属一般。切其脉, 细数不静, 而两寸尤甚。察其舌, 质地偏红, 且微有薄苔。反复询问病者感何不适? 病人默坐于椅上, 称唯感心悸不宁、有所焦躁、口味时苦、小便色黄而已。辨证为阴血不足、心肺火旺。处以本方服药3剂, 3日来已不见夜游, 自觉心悸烦躁不安之象大有好转。再服3剂, 夜游已无, 脉舌也见好转。带回安神补心丸2瓶, 以巩固疗效。1

年后遇其家人,谓病愈后一直很好。

【方名】 天钩汤。

【组成】 钩藤 9g,天麻 9g,刺蒺藜 18g,夜交藤 60g,蜈蚣 2条,白花蛇 9g,全蝎 9g,青箱子 24g,珍珠母 24g,铁落 9g(布包煎),酸枣仁 9g,桃仁 9g,红花 9g,半夏 9g,生谷芽 60g。

【来源】 王渭川《王渭川疑难病症治验选》。

【功效】 养血安神,熄风通络,佐以活血化淤。

【适应证】 睡行症,阴血不足、心肝火亢见证者。

【方药简析】 本方系以天麻钩藤饮合通窍活血汤化裁而成。方中以天麻、钩藤、珍珠母、青箱子、铁落平肝潜阳为主;酸枣仁养心为辅;佐以蜈蚣、乌梢蛇(或白花蛇)、全蝎熄风通络,桃仁、红花活血化淤,半夏祛痰,谷芽健脾胃。诸药合奏养血安神、熄风通络、化淤祛痰之效。肝阳平则神自归,心得养则魂自守。方中可酌加天竺黄、麝虫、生蒲黄、九香虫、山楂、内金、砂仁、蔻仁等以增强疗效。王渭川以本方为主,按上述加减治疗本症有良效。

【病案举例】 李某,男,26岁,厨房勤杂工,1924年6月28日初诊。病情:1924年6月20日晚上,病人睡至半夜,突然起床,没穿衣服,拿起扁担,开始到江边挑水(当时尚无自来水,食用水都靠挑水工从江边挑水)。挑米即倒在玉昌百货公司店堂内,一连挑了10余担,玉昌店堂内已积水盈寸。当时已是早晨4时多,天色渐亮,被值班警察看见。警察见他赤身露体,即叫他回去穿上衣服。病人并不理睬,警察气极,打了他一顿,病人负痛才逃回玉昌百货公司。警察追至,说这个人是疯子,赶快送医院。当即将他送到一家外国人办的医院检查,诊断为夜游症。用嗅剂治疗,无效,即来请我诊治。刻诊脉型平缓,舌质淡红,苔薄白。治则:养血安神,熄风通络,佐以活血化

【组成】 生地黄 60g,黄连 18g,当归 50g,甘草 15g,煅磁石 30g,建曲 18g,朱砂 9g。

【来源】 熊继柏,中医杂志,1981,(7):62。

【功效】 清心泻火安神,镇肝定魂。

【适应证】 睡行症,证属火热扰心、神魂失守者。

【方药简析】 本方是由朱砂安神丸合磁朱丸而成。方中磁石入肾、能镇摄安神、益阴潜阳;朱砂入心能清心安神,2药合用,重镇安神,镇摄浮阳;再配黄连清心除烦安神,共为主药;辅以当归、生地黄养血滋阴,补其被灼阴血;建曲健脾理气和胃,使金石之药不碍胃气为佐;使以甘草和中调药。全方可清心泻火安神、镇肝定魂。上6味碾末和蜜为丸,外以朱砂9g水飞为丸衣,丸如黄豆大,早晚各吞服1次,每服30丸。熊继柏以本方按上述方法用药,治疗本病有良效。

【病案举例】 龙某,男,14岁,学生,1970年就诊。家长代诉,患儿每于睡梦中惊起,启门而出,跌仆于田野荒丘,依然沉睡,甚则出走至5里之外,以至跌受伤。如此迁延半载,每夜必有人伴睡。遍求医治,屡药鲜效。诊断为睡行症。中医症见患儿神态如常,自觉心烦耳鸣,夜卧而出并不知觉,唯多梦多惊而已。舌红苔黄,脉弦数。详思此症,为火热内扰神魂之候。张景岳云:“神之为德,如光明爽朗、聪慧灵通之类皆是也;魂之为言,如梦寐恍惚、变幻游行之境皆是也。”盖神属心所主,魂为肝所藏。今火扰于心而心烦,火升木亢而耳鸣,变幻游行。治当清心泻火安神、镇肝定魂,予朱磁丸。服完2料丸剂,其病竟瘳。

【方名】 柴胡加龙骨牡蛎汤。

【组成】 柴胡 10g,半夏 10g,黄芩 10g,党参 10g,铅丹 1.5g,桂枝 15g,茯苓 15g,大黄 6g,龙骨 15g,牡蛎 15g,生姜 4

片,大枣 2 枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 和解泻热,重镇安神。

【适应证】 睡行症,证属肝之升降失调者。

【方药简析】 本方系小柴胡汤加味而成。小柴胡汤加桂枝可使内陷之邪从外解;龙骨、牡蛎镇潜安神止烦惊;大黄泻热和胃而令神安和;茯苓宁神、通利小便。诸药合用使错杂之邪从内外而解。若肝火亢盛,加夏枯草、龙胆草等以清肝经郁热;或白芍、龟板、炙甘草等以柔肝缓急;大黄可易为当归龙荟丸以泻肝火;铅丹有毒常去之不用或用生铁落代之。朱进忠用本方加减治疗本病有良效。

【病案举例】 高某,男,60 岁。患者数十年来,在睡眠过程中,经常大声呼叫,有时突然嚎啕大哭,有时突然起床作一些劳动活,如劈柴、烧水、担水等,有时突然起床钻入床下,有时甚至到街上乱转好久,又回家继续睡眠。这病开始没有引起个人的注意,最近一个时期来,几乎 2 天即发生 1 次,特别是近 4 个月来,有时睡眠过程中突然穿上衣服到其他一些同事家敲门,有时甚至还和人家说几句话,回家后,继续睡眠而完全不知此事,及至其他同事问起此事时,才有所发觉。不得已,请中、西医治之,服药数个月后,睡眠虽然很实,但以上症状仍时见发生。诊断为睡行症。中医症见:主症如前,精神、食欲均正常,舌苔薄白,脉弦紧。综合脉证及前医所用药物效果后,反复考虑:前用安神镇静之剂无效,说明其病不在心,而在其他脏腑。夜间不由自主的游动,乃魂之所主,魂藏于肝,魂不安舍,肝之升降失调所致也。治宜也从肝论治。宗柴胡加龙骨牡蛎汤升清阳,降浊明,调营卫。处方:柴胡 10g,半夏 10g,黄芩 10g,党参 10g,甘草 6g,桂枝 15g,茯苓 15g,大黄 6g,龙骨 25g,牡蛎 15g,生姜 4 片,大枣 7 个。服药 2 剂后,上述诸证 1

60 失 眠

失眠是最常见的睡眠障碍形式,指睡眠时间不足和质量差,从而产生疲困和种种不适的感觉,没有清新舒泰感,注意力不集中,无力,警觉性差,情绪不佳,头痛,紧张等。失眠通常有入睡困难、睡眠浮浅易醒、早醒、多梦、睡眠节律紊乱和睡眠感觉缺乏等表现形式。失眠是症状,一般是患者长期主观得不到正常睡眠时才成为临床主诉。本症常见于心理障碍(焦虑、忧郁情绪,过份思虑某个问题或关注睡眠等),适应性障碍(由远地迁居、入伍入校、失业离婚、职位升迁等生活事件引起抑郁、焦虑心境和躯体不适等引起),反应性精神病(长期失眠多为迁延性心因反应的症状之一),神经官能症(常见于神经衰弱、抑郁性神经症、焦虑症、恐怖症、强迫症、疑病症等),精神分裂症,情感性精神病,更年期精神病等以及伴见于各种躯体疾病(高血压、脑动脉硬化等)。但也有许多失眠的原发病由于缺乏典型症状,难于做出明确诊断。治疗失眠常用药物有安定、佳静安定、三唑伦、硝基安定、氯羟安定、多虑平、阿米替林等,但主要是治疗原发病。

失眠属于中医不寐的范畴。本病的病因病机主要是气郁化火,扰动心神;胃中不和,痰热内扰;阴虚火旺,心肾不交;思虑劳倦,内伤心脾;中焦虚寒,寒浊上逆;阴盛阳衰,气机不振;心胆气虚,神摇善惊;气滞血淤、阴阳不畅等,均可影响心神而致不寐。治疗本病首当辨证。若气郁化火、上扰心神者,用疏肝泻火安神汤加减;若阴阳不调、心神不安者用手心敷药、赅

石龙枣汤等加减;若阴亏血少者用催眠丸加减;若阴虚火扰者用苦参酸枣仁合剂、女贞子汤、夜合汤等加减;若中气不和、心肾不交者用二夏汤、半夏汤、和中交泰汤加减;若表里交蒸、里热炽盛者用防风通圣安寐汤加减;若痰淤内扰者用白金丸加减;若中焦虚寒者用吴茱萸汤加减;若气滞血淤者用桃红四物汤、血府逐淤汤,癫狂梦醒汤、补阳还伍汤等加减;若阴盛阳衰者用麻桂汤加减。

王国才将本病分为2型,阳虚证用补中益气汤加远志、柏子仁及阿米替林(每日50~100mg)、舒乐安定(每日3mg);阴虚证用酸枣仁汤加女贞子、五味子、莲子、龟板、牡蛎、磁石、琥珀及罗拉片(每日1.5~3mg)。本组病例113例,结果显效89例(症状基本消失,睡眠良好,睡后不易转醒,熟睡7h以上,白天精神饱满、情绪稳定,随访3个月无复发),进步15例(睡眠不稳定,多梦,似睡非睡,但能睡4~5h),无效9例(睡眠无改善,症状依然如故,每晚能睡2~3h)。总有效率为92%[黑龙江中医药,1995,(1):11]。

陈元鸿用益气升阳法(党参15g,茯苓12g,炙甘草8g,白术12g,苍术10g,黄柏12g,黄芪30g,山药30g,谷芽20g,麦芽20g,大枣15g,酸枣仁20g,桂圆肉10g,合欢皮25g,夜交藤20g)为基础方。若阴虚火旺型去党参加沙参,去苍术加黄连6g、山栀子12g,加冰糖30g水煎,1日1剂,连服5剂。治疗本病27例,结果有效24例(夜眠超过7h),好转2例(夜眠介于6~7h之间),无效1例(夜眠低于6h)[实用中西医结合杂志,1993,(12):751]。

田凤兰等用养阴镇静丸(当归100g,生地黄50g,茯苓100g,玄参75g,麦门冬75g,柏子仁25g,丹参75g,五味子62.5g,党参100g,桔梗50g,夜交藤50g,珍珠母125g,远志50g,朱砂12.5g。以上药物共为细末,每100g药粉加蜂蜜

110g,制成大蜜丸,每丸重 9g),口服每次 1 丸,每日 3 次,连服 30 丸为 1 疗程。治疗本病 100 例,结果显效(症状基本消失)19 例,好转(失眠多梦症明显好转,其他症状亦明显减轻)63 例;无效(大部分症状无进步)18 例。总有效率 82%[吉林中医药,1986,(2):25]。

李德益用复方独活胶囊(取独活 30g,朱砂 6g,琥珀 6g,共研为末,混合后装入 2 号空心胶囊内),每晚睡前 2h 服胶囊 6 粒,连用 10 天后观察效果。治疗本病 210 例,结果临床治愈 175 例(睡眠显著改善至正常,伴随症状消失或基本消失),有效 30 例(睡眠改善,每晚延长不足 3h,伴随症状减轻),无效 5 例(治疗前后无改善或者加重者)(湖北中医杂志,1991,(2):6)。二是在辨证的基础上,加用一些兴奋药物与镇静药物联合治疗顽固性失眠。如丁洄对本病心脾两虚、心胆气怯者加麻黄、桂枝、附子,对阴虚火旺、虚热扰神者加仙灵脾、生黄芪、肉桂粉(剂量在 3~10g 以内),具有较好效果[湖北中医杂志,1992,(1):42]。

李德新用人工旋律,要求患者每天 5 点半左右起床散步,饭后或上午 9 点左右饮咖啡或浓茶 1~2 杯,以使精神达到高度兴奋、精力充沛。每天下午 3 点及晚上 10 点左右各服 1 剂半夏秫米汤(法半夏 40~60g,苡米 30g。气阴两虚者加党参 15g、麦门冬 15g、五味子 12g、炒枣仁 15g;心肾不交者加黄连 6g、肉桂 3g、夜交藤 30g、远志 12g;阴虚火旺者加生地黄 15~20g、阿胶 12g(烊化)、鸡蛋黄 2 枚(冲服)、女贞 15g、旱莲草 15g;心悸怔忡、脉弦数者加朱砂 3g、琥珀 3g(分 2 次冲服);晚上 10 点半前卧床休息。本组久治不愈失眠 20 例,结果痊愈 15 例(恢复常人的睡眠,每晚 6~8h,偶尔反复),无效 1 例(较治疗前无变化)(河北中医,1989,(6):2)。三是择时服药可提高疗效,如陈桂英在辨证(肝肾阴虚、虚火上扰者,给予能滋下

清上、宁志安神之品,方用乌菟汤或酸枣仁汤加减;心脾两虚、阴血不足者,给予能补养心脾、宁志安神之品,用归脾汤加减;心阴受损、心火亢盛者,给予滋阴清火之品,用朱砂安神丸加减)的基础上采用入夜1次服药,治疗本病124例,疗效明显优于对照组[山东中医药,1987,(4):15]。四是针灸及按摩对调节睡眠有一定帮助,限于篇幅在此不再述及。五是帮助患者提高对睡眠的认知,并注意节制性生活,禁烟酒、辛辣刺激食品,遇事少怒,放松思想负担,消除精神顾虑。

【方名】 疏肝泻火安神汤。

【组成】 丹皮、栀子、合欢皮各10g,炒枣仁、夜交藤各24g,柴胡5g,生龙骨(先煎)、生牡蛎(先煎)各30g。

【来源】 莫太安,江苏中医,1993,(2):13。

【功效】 疏肝泄火,调养心神。

【适应证】 不寐,证属气郁化火、上扰心神者。

【方药简析】 方中用丹皮、栀子清泄肝经郁火;柴胡疏畅肝胆之气;合欢皮、夜交藤、酸枣仁养心安神;生龙骨、生牡蛎重镇安神;诸药合用,共奏疏肝泄火、调养心神之功。若口燥咽干者加沙参、麦门冬各15g;心气心血不足者加黄芪、桂圆肉各15g;心肾不交者加交泰丸。每日1剂2煎,1煎午睡前服,2煎睡前半小时服,1周为1疗程。在治疗期间,不使用其他药物。嘱咐患者保持心情舒畅,注意起居有度,适当体育锻炼。莫太安用本方为主,按上述加减用药治疗本病41例。结果显效(睡眠明显改善,包括入睡时间缩短、睡眠总时间延长、梦减少,其他如心烦、急躁易怒等症状消失)17例,占41.4%;有效(睡眠改善,具备前述睡眠明显改善3项指标中之一,心烦、急躁易怒等症状减轻或消失)22例,占53.7%;无效(睡眠无明显改善)2例,占4.9%。总有效率95.1%。疗效明显优于对照

组(服安定、谷维素)。

【病案举例】 张某,男,16岁,1988年9月5日诊。患者1月前因升学落榜而心情不畅,继则夜不能寐,伴心烦、急躁易怒、纳差、健忘、体倦乏力。经西医多次检查,均无阳性体征。每晚仅能睡眠1~3h,服镇静安眠剂后,其效不显。伴见面红目赤。舌质红、苔薄黄,脉弦数。中医诊断为不寐。证属情志不遂、木失条达、气郁化火、上扰心神所致。即服疏肝泄火安神汤,同时嘱患者保持心情舒畅,每日坚持跑步。经治1周睡眠基本恢复正常,每晚能睡6~7h。守方继服1周,诸症尽除。随访1年,未见复发。

【方名】 手心敷药。

【组成】 生龙骨20g(研细),珍珠粉4.5g,琥珀末5g。

【来源】 吴月斌等,江西中医药,1991,(2):36。

【功效】 镇心安神,安养五脏。

【适应证】 失眠,证属阴阳不调,心神不安者。

【方药简析】 方中生龙骨甘平无毒,能“养精神,定魂魄,安五脏”,使阳入阴;配琥珀镇惊安神、通腑利湿,使气血调和;珍珠甘咸寒,除能安养五脏外,尤能清心肝之火(此药古人善于外用,如《本草纲目》记载可点目、涂面、涂手足等治疗多种疾病),调竹沥贴手心,吸收快,清心安神效果明显;竹沥甘寒,可祛痰养血、清热除烦。调配药末,能保持敷药湿润,使药物均匀地透达体内,避免了上述诸药内服时苦寒过甚、伤脾胃之弊。四药合用,制成掌心敷药,共奏镇心安神、安养五脏、使阳入阴之效。若邪热内扰者加黄连末5g;痰偏盛者加半夏10g;阴虚火旺者加黄连6g、肉桂末1g;气血两虚者加服归脾丸,无血虚证者于基本方加朱砂5g。手心给药方法是:3药合调拌匀,装瓶备用,每天以3~4g加鲜竹沥少许调湿,分为2份,用

2层纱布包妥。中午和晚上入睡前,将药分别置于手心(劳宫穴周围),外用胶布固定,并用手指轮流缓慢按压药包30~50min,每分钟40~60次。夜间可留药于次日晨取下。治疗期间,除高血压病人继服原降压药以外,一般停止使用其他药,并禁食辛辣刺激物。吴月娥等以本方为基础,按上述加减用药治疗本病54例(高血压2例,偏头痛4例,血管性头痛11例,神经衰弱30例,更年期综合征7例),治疗时间最长30天,最短7天,平均20天。结果显效者23例(用药后每晚能入睡4~6h,心烦、眩晕、恶心等症完全消除或显著减轻,病情稳定),有效者27例(睡眠时间比治疗前有显著延长,但不甚稳定,其他症状明显减轻),为无效者4例(睡眠仅有轻度好转,停药易复发)。

【病案举例】 陈某,女,40岁,已婚,1987年6月7日初诊。患者3年前因精神刺激常失眠、心情抑郁。1985年5月曾因“神经衰弱”入某医院中西医结合治疗,好转后出院。去年7月因失眠、郁证再次入某院中医治疗50天,睡眠有短暂改善,出院后仍常服安定、利眠宁等。近月来病情逐渐加重,常彻夜不寐,伴心烦、眩晕、恶心、肢软、口干口苦,形体逐渐消瘦,月经量少。行经时下腹稍胀痛,舌尖红,苔薄黄,脉弦细。检查血常规正常,脑电图正常,脑血流图示:①脑血管弹性减弱。②两侧波幅不对称,相差24%。中医诊断为不寐。证属肝气郁结,气郁化火,上扰心神。治疗:基本方加黄连末6g,方法同前所述。治疗5天后,失眠明显改善,每晚用药30min左右,即可入睡,睡眠时间延长,诸症减轻,治疗信心大增。继续治疗10天,每日能保持深睡眠5~6h,精神较前明显好转,眩晕基本消除,无恶心及口干苦等,再用药10天,诸证消除而停药。3个月后,睡眠再次欠佳,患者照前方法用药数天,很快康复,脑血流图复查正常。后随访1年,未见复发。

【适应证】 失眠，证属阴亏血少者。

【方药简析】 方中药物剂量系编者所加。催眠丸以天王补心丹为基础，去朱砂、桔梗，加阿胶、黄连、石菖蒲。其中阿胶、当归、人参补气血为君；枣仁、柏子仁等安神为臣；佐以黄连泻火；麦门冬、生地黄等滋阴；丹参行血引诸药循行入心。全方滋阴清热、养心安神。冰醋丸之冰片、石膏清心除烦热，琥珀镇心而安神，小茴芳香化浊理气，米醋助药渗入耳道皮肤内。塞耳后清香袭脑，脑际清静，烦恼杂念顿消，且阻断了外界噪音的传入。内外合用，共奏补其不足、泻其有余、调和阴阳、养心安神之效。催眠丸依法制为蜜丸，每丸重20g。冰醋丸制法：冰片、石膏、小茴香、琥珀等，研末，过120目筛，装瓶备用。临用时将米醋（随用随做，药醋比例为2:1.5）15g，加药粉20g调湿拌匀，做成2颗弹头状药丸，外包2层纱布，丸尾留纱布条。催眠丸睡前2h服1次，共60g。睡前忌吸烟、饮酒、喝浓茶，温水洗脚15min，然后用做好的冰醋丸塞入耳道，双耳各塞1丸，松紧适度，外留纱布条，晨起丸内水份吸干，轻带纱布条即可完整取出。10日为1疗程，1疗程无效者，停用10天，再用1个疗程，如此连用3个疗程。邹新民用本方按上述方法用药治疗本病226例，结果痊愈（能入睡，睡眠持续6~8h，主症消失兼症明显好转，随访1年未复发者）116例；有效（能入睡，睡眠全程时有中断，但能再入睡，主症明显好转，兼症有所好转者）78例；无效（经治疗3个疗程，主症、兼症无明显好转者）32例。总有效率为84.2%。

【病案举例】 许某，女，40岁，教师，失眠8年。患者于32岁婚变后开始失眠，入睡困难，辗转入睡后，似睡非睡，梦多易醒，醒后难入睡，靠服用安定维持每晚3h左右的睡眠，经多年多种方法治疗，效果不佳。症见纳差消瘦，面色无华，舌淡苔白，脉弱。中医诊断为不寐。用安定已增至1次6片，已无力

工作,申请病退。接受本法治疗 3 个疗程,停用安定,病告痊愈,伴随症状消失,体重增加,重上讲台,随访 1 年未复发。

【方名】 苦参酸枣仁合剂。

【组成】 苦参 30g,酸枣仁 20g。

【来源】 文云学,实用中西医结合杂志,1995,(3):186。

【功效】 镇静催眠。

【适应证】 各种失眠,证属血虚火扰者。

【方药简析】 本方两味药组成,苦参性味苦寒,归心、肝、胃、大肠、膀胱经;酸枣仁性味甘平,归心、肝经。由于失眠症以心、肝 2 经病引起者居多,且 2 药一补一清,相得益彰。据现代药理研究,苦参所含的苦参碱,有对抗实验性心律失常的作用,并通过对照观察认为苦参的镇静、催眠作用可与鲁米那、冬眠灵等媲美;酸枣仁含枣仁皂甙、枣仁甙、元枣酸等,其水溶成分亦具镇静、催眠作用。故临床施用苦参酸枣仁合剂效果颇佳。至于该合剂 2 药的药量是否与疗效有关,尚有待探讨。该药服后少数病人有恶心等症,但停药后即消失。此 2 味药每贴加水 200ml,浓煎至 200mg,日服 1 贴,睡前 30min 服,10 贴为 1 疗程,连服 1 至 2 个疗程。文云学以本方治疗各种失眠 85 例(器质性病变中出现的 45 例,功能性疾病中出现的 32 例,情志改变引起的 8 例)。治疗结果:近期治愈(服 1 至 2 个疗程后失眠症消失,能入睡 6~7h,并稳定半年)33 例;好转(服 1 至 2 个疗程后失眠症明显改善,能入睡 5 至 6h)43 例;无效(服药后失眠症状无改善)9 例。

【病案举例】 袁某,女,37 岁。患者以神经官能症入院,主诉:失眠、多梦、头昏胀痛 10 个月。曾用养心安神中药数 10 贴及西药安定、谷维素等,疗效不佳,中医诊断为不寐。入院后予中药杞菊地黄汤、归脾汤加减治疗,诸症不减。又用安定

5mg,日2次,初觉入睡尚可,继之诸症如故。及投苦参酸枣仁合剂治之,5贴后,睡眠有改善。继服5贴,夜晚入睡尚可,但仍头昏胀,再服5贴,能入睡7至8h,梦亦少,头昏胀痛明显减轻。随访半年,除偶感头痛外,睡眠仍可。

【方名】 女贞子汤。

【组成】 女贞子 30g,酸枣仁 15g,石莲子 10g,五味子 5g,琥珀末 4g(冲服)。

【来源】 易介仁,新中医,1982,(11):34。

【功效】 宁心安神,滋阴制火,催眠镇静。

【适应证】 顽固性失眠,证属阴虚火扰者。

【方药简析】 方中女贞子味甘苦凉,滋肾益肝,补阴液不足;酸枣仁甘酸平,养心宁神;琥珀性味甘平,安神定惊;五味子酸甘入心肾,补肾养心;石莲子甘寒微涩,开胃气而清心降浊。配合针刺陶道穴,该穴属于督脉经,主治神经衰弱,对治疗顽固性失眠,尤其对阴亏火旺,心胆气虚所致者为佳。本方每日1剂,分下午和晚上各服1次。针刺陶道穴,快速进针,深度为1.5~2寸,不留针,每日上午1次,连续5次。在治疗期间,一般要求中午不午睡。易介仁等以本方为主,按上述方法加减用药治疗本病102例。结果显效(症状基本消失,睡眠良好,睡后不易转醒,能睡7h以上,白天精神饱满,情绪稳定,随访半年无复发者)62例,占62.78%;进步(睡眠不稳定,多梦似睡非睡,但能睡4~5h)29例,占28.49%;无效(睡眠无改善,症状依然如故,每晚入睡约2~3h整夜不能入眠)11例,占10.79%。总有效率89.2%。最少服5剂,最多服15剂。

【病案举例】 黄某,男,22岁,学生,因长期失眠伴头昏痛,情绪易激动已5年,不能坚持学习。校方劝其停学,回乡休养,住当地县中医院治疗3个月,服用中西药物,未见好转。于

上,随访6年未见复发。

【方名】 二夏汤。

【组成】 半夏 30g,夏枯草 30g。

【来源】 袁昌华,黑龙江中医药,1993,(2):29。

【功效】 降逆气,和阴阳。

【适应证】 不寐,证属心胆气虚、痰热扰心、心阴不足、心脾两虚、肝气郁结者。

【方药简析】 方中半夏辛温,直驱少阴厥逆之气;夏枯草辛寒,入肝经,能泄阳补阴。寒温并用,阴阳和调,寐可立至。若心胆气虚、善惊易恐者加珍珠母、党参、生龙齿;痰热扰心加瓜蒌、栀子、远志;心阴不足加五味子、麦门冬、柏子仁;胃中不和加神曲、陈皮;心脾两虚加人参、龙眼肉、炒枣仁;肝气郁结加合欢皮、郁金。水煎服,于晚上睡前1h1次服净。服药期间停用一切催眠药。袁昌华以本方为基础,按上述加减用药,治疗本病62例。结果治愈(不需服镇静催眠药,睡眠在6h以上,半年内未复发者)44例,占71%;好转(睡眠时间3~5h,不足6h者)13例,占21%;无效(用药后症状未见改善者)8例,占8%。总有效率为92%。

【病案举例】 张某,男,34岁,技术员,于1987年12月6日就诊。诉失眠9年余,在大学就读时因失眠常服催眠类药物。近半月来失眠加重,每晚只能睡1~2h。形体消瘦,口干舌燥,舌红少苔,脉细。中医诊断为不寐。辨证为心阴不足。处方:制半夏30g、夏枯草30g、麦门冬15g、五味子15g、柏子仁25g。服药2剂,能入睡5h,继服3剂,睡眠恢复正常。后给天王补心丹加减调理善后,随访半年未复发。

【方名】 半夏汤。

【组成】 清半夏 12g, 秫米 60g(即黄小米)。

【来源】 《黄帝内经》。

【功效】 决渎壅塞, 通行经络, 调和阴阳。

【适应证】 严重失眠, 证属阳虚痰少者。

【方药简析】 本方的特点是: 秫米性味甘而粘, 微凉, 能养营补阴; 清半夏味辛性温, 能和脾胃化痰湿, 除腹胀疗目不得眠。2 药配合, 决渎壅塞、通行经络、调和阴阳, 阴阳和合则安然入睡。若胸脘胃脘满闷, 舌红苔黄腻者加鲜莱菔 120g。上药水煎, 以米熟悉为度, 取汁 200ml, 轻者日 1 剂, 睡前服; 重者日 3 剂, 早中晚各 1 剂。张铁敏以本方为主, 按上述加减用药治疗本病, 不论伴有何种疾病者 20 例。治疗结果: 显效(药后可熟睡 6~8h, 晨起轻松愉快, 精神饱满者)11 例, 占 55%; 有效(入睡快, 睡眠较前实, 梦少, 可睡 4~6h, 晨起无头晕者)7 例, 占 35%; 无效(服药后睡眠同服药前)2 例。总有效率 90%。确有“其卧立至”之效。然而有的病人遇到某种精神刺激后, 又会影响睡眠, 但较服用半夏汤之前病情轻, 再服药疗效仍显著, 故某些病人尚需间断服药。

【病案举例】 郭某, 女, 27 岁, 油工, 1982 年 8 月 24 日就诊。患者即往睡眠欠佳, 近日因婆母患病, 心情不悦而一昼夜未眠。心烦、心悸, 头晕而不思睡。伴有产后风湿痛。查: 舌淡尖红, 边尖有齿痕, 苔薄白, 脉弦细而无力。中医诊断为不寐。处方: 半夏 12g, 秫米 60g。水煎, 睡前服。患者因去病心切, 服药时未去渣, 服后 10min 左右, 全身微汗出, 自觉全身舒适, 无一处疼痛, 安然入睡, 至翌日 5 时 30 分, 方被孩儿哭醒[张铁敏, 中西医结合杂志, 1983, (5): 299]。

【方名】 和中交泰汤。

【组成】 制半夏、焦白术、炒枣仁、夜交藤各 15g~30g,

枸杞子、制香附、佛手、茯神各 12g,黄连、肉桂各 2g~5g,生甘草 3g。

【来源】 张广修,湖北中医杂志,1992,(5):17。

【功效】 交通心肾,交敛魂肝,健脾和中,调畅阴阳。

【适应证】 顽固性失眠,证属三焦失和、心肾不交者。

【方药简析】 本方将半夏秫米汤、酸枣仁汤、交泰丸、四君子汤等融为一体。方用白术、枸杞以补中下二焦之“不足”,用半夏、黄连以泻中上二焦之“有余”;黄连配肉桂以交通心肾;用枸杞配酸枣仁以交敛魂肝;用半夏、白术、香附、佛手健脾燥湿、理气催眠,以治其标;另加生甘草调和药性。全方标本同治,三焦同调,切中病机。若血虚加熟地黄、阿胶(冲服);阴虚加百合、生地黄;阳亢加钩藤(后下)、生石决明(先煎);痰浊甚加远志、石菖蒲;血瘀加丹参、生山楂;火盛加栀子、黄芩;便秘加大黄、火麻仁等。每日 1 剂,水煎分两次温服。每周服药 6 剂为 1 疗程。一般以 3 个~4 个疗程为宜。服药期间,宜清淡饮食,劳逸结合,忌烟酒,戒恼怒,节房事。张广修以本方为基础按上述加减用药,治疗本病 54 例,结果痊愈(每夜入睡 6h 以上,伴随症状消失)36 例,好转(每夜入睡少于 6h,伴随症状减轻)11 例,无效 7 例,总有效率 87%。

【病案举例】 曹某,男,62 岁,1991 年 11 月 20 日初诊。患者于 30 年前,因外出车翻受吓,遂得失眠。30 年来,辗转求医,均无效验,安定片每晚增至 6 片,仍不济事。自诉 30 年来,夜难入眠,以致头脑嗡嗡不宁,白天神疲乏力,头昏脑胀,似痛似晕,触事易惊,记忆力显著减退。伴胸脘痞闷,心中时烦,口淡无味,口干少饮,纳谷不佳,大、小便尚调。查:舌尖偏红,苔薄白腻,脉象缓弱。血压:23/14kPa,3 大常规、心电图、脑电图等项检查正常。中医诊断为不寐。乃突受惊吓,魂不舍肝,殃及心肾,水火失济。病久失治,损及中宫,阴阳升降受阻,演为

失眠顽疾。治拟交通心肾、交敛魂肝、健脾和中、调畅阴阳。用和中交泰汤加草决明、淮牛膝，3个疗程后，每夜能入睡2~3h，头昏心慌等症明显减轻。续服1个疗程，每夜能入睡7h，诸症亦消失，测血压：18/13kPa。原方去草决明、淮牛膝，嘱隔日服1剂，连服6剂以善后。1月后随访，症未复发。

【方名】 防风通圣安寐汤。

【组成】 防风、荆芥各10g，大黄8g(后下)，白芍15g，连翘12g，枳实8g，甘草5g，厚朴10g，栀子12g，豆豉1撮，芒硝12g(冲服)。

【来源】 陈厚智，湖南中医杂志，1989，(1)：40。

【功效】 表里双解，泄热安神。

【适应证】 不寐，证属表里交蒸、里热炽盛、热扰神明者。

【方药简析】 本方是由防风通圣散加减而成。方中芒硝、大黄、枳实、厚朴泄热通便兼清腑实；荆芥、防风辛温解表透邪微使汗出；白芍疏肝养血；连翘清心气热兼凉胃；栀子、豆豉除烦宁心；黄芩清大肠湿热；甘草和中而调和诸药，共奏双解表里、泄热安神之功。陈厚智用本方加减治疗本病有良效。

【病案举例】 陈某，男，30岁，1987年9月21日初诊。患者失眠月余，自诉通夜难寐，微恶风，目赤睛痛，伴头目晕眩、胸膈痞闷、胃中不适。烦躁，腹胀，腹部拒按，大便秘结，迭经3医治疗均罔效，症益剧，转余诊。检视前医方药皆投以归脾、养心之剂。刻诊：口中有臭秽浊气，舌质红、苔黄白相兼，脉弦紧。中医诊断为不寐。证属表里交蒸、里热炽盛、热扰神明所致之不寐证。治宜表里双解、泄热安神。方拟防风通圣散加减：荆芥、防风各10g，大黄8g(后下)，白芍15g，连翘12g，枳实8g，甘草5g，厚朴10g，栀子12g，豆豉1撮，芒硝12g(冲服)。3剂，水煎服，每日1剂。复诊(9月24日)：服上方1剂后，自诉

腹痛、肠鸣；服完 2 剂后，大便泻下燥屎数 10 枚，失眠减；服完 3 剂，大便稀臭，日 3~4 行，睡眠转佳，每日能睡 4~6h，唯口干，喜饮，四肢乏力，周身酸楚。苔黄转为薄白，脉弦稍数。示方已对证，效不更方，上药去芒硝、大黄、厚朴，减荆芥、防风量，加太子参 15g、朱茯苓 12g、淮山药 12g，以滋养胃阴、扶正安神，进 3 剂后睡眠正常。随访 3 月，病未再发。

【方名】 白金丸。

【组成】 白矾 1.5g，郁金 10g。

【来源】 王惟德《外科全生集·马氏试验秘方》。

【功效】 清心活血，化痰安神。

【适应证】 顽固性不寐等，证属痰淤内扰者。

【方药简析】 方中白矾祛痰燥湿之功甚强。痰湿去，火无由生，不犯心宫，心神得宁；郁金辛开苦降，入气行气解郁，入血凉血散淤，为血中气药，用之则气得行、血得散、心得养。2 药合用 共奏清心活血、化痰安神之功。马汴梁以本方加琥珀为基础方，将本病分为 2 型。顽痰淤血痹阻心窍脉络者加枸杞子、川芎、地龙、鸡血藤等；肝郁痰火扰动心神者加当归、栀子、香附、枣仁、茯苓等，治疗本病有良效。

【病案举例】 孙某，男，32 岁，1983 年 6 月 9 日初诊。患者自述失眠、多梦、头晕、头痛 2 年余，加重 2 个月。轻时入寐 2~3h，重时彻夜不寐，伴见手足麻木，皮肤有紧皱感，不能任物，立久则甚。查：舌质红绛，苔白，脉弦。曾服用安定、利眠宁等及采用中药疗法，效果不佳。中医诊断为不寐。余详辨之，实属顽痰淤血痹阻心窍脉络，气血运行不畅所致。治宜豁痰安神、活血通络。方用减量之白金丸加味：郁金 12g，白矾 1.5g，枸杞子 12g，白芍 10g，川芎 7g，地龙 10g，琥珀 2g（另冲），鸡血藤 30g。6 月 13 日二诊：药后入寐如常人，头痛减轻，余症仍

存,原方继服6剂。6月20日三诊:睡眠正常,手足麻木减轻,舌质淡,苔白,脉细。原方加黄芪20g、党参10g、生地黄20g,以益气养血调理善后。随访半年,上症未再复发[马汴梁,国医论坛,1986,(2):40]。

【方名】 吴茱萸汤。

【组成】 吴茱萸9g,人参9g,生姜18g,大枣12枚。

【来源】 张仲景《伤寒论》。

【功效】 暖肝温胃,降逆上呕。

【适应证】 重症失眠,证属中焦虚寒、寒饮上逆、心神受扰者。

【方药简析】 方中吴茱萸暖肝温胃、散寒降逆;配以生姜散寒止呕。人参、大枣补虚和中;佐加陈皮理气祛痰饮;桂枝助阳化气,增强吴茱萸之功,故奏效迅速。黄明以本方为基础,按上述加减治疗重症失眠有良效。

【病案举例】 杨某,女,57岁,农民,1984年7月20日初诊。患者素体虚弱,1个月前失眠,甚则彻夜难寐,近日尤甚。开始时服安定、利眠宁等尚能睡1~3h,其后服3~5片亦无济于事,反因副作用昏沉无力,不能劳作。伴有头痛、干呕、吐涎沫、头顶有冷风感、手足寒、纳少,舌淡、苔白滑,脉沉弦。中医诊断为不寐。审证求因,为中焦虚寒、寒饮上逆、心神受扰而不藏所致。拟暖肝温胃、降逆止呕。用吴茱萸汤加味:吴茱萸、人参(先煎)各9g,桂枝、陈皮各10g,生姜18g,大枣12枚。取3剂,水煎服,每日1剂,忌生冷,停用西药。3剂药尽,能入睡3~4h,再守方6剂药后睡眠正常,余症悉除。嘱其服补中益气丸缓补中阳[黄明,新中医,1989,(9):44]。

【方名】 麻桂汤。

间夜间工作,劳累过度,起居失节,久之则阴阳失调,以致形成阴盛阳衰之证。试拟扶阳益阴,调和阴阳为法。方用麻桂汤加减。处方:麻黄、附子、细辛各 10g,白芍、桂枝各 20g,炙甘草 6g,龙骨、牡蛎各 30g,生姜 3 片,大枣 5 枚。3 剂后复诊:服上药 3 剂后,白天睡意略减轻,较前有精神,夜间仍不得眠。守方加减:麻黄 15g,细辛、黄芩、半夏、柴胡各 10g,白芍、桂枝各 20g,附子(先煎)、龙骨、牡蛎各 30g,生姜 3 片,大枣 5 枚,5 剂。上药服后明显好转,白天睡意淡漠,夜可睡 5~6h。药中病机,续以进剂,前后加減共服 20 余剂,夜间基本可入睡,昼日无睡意。并嘱其注意起居有节、避免过度劳累。

【方名】 桃红四物汤。

【组成】 桃仁 10g,红花 6g,当归 10g,川芎 10g,白芍 10g,生地黄 10g。

【来源】 吴谦等《医宗金鉴》。

【功效】 活血调血,祛瘀通络。

【适应证】 重症不寐,证属瘀血内阻者。

【方药简析】 本方所标药物剂量系编者所加。方中四物汤补血调血,使活血而不伤正;四物中易熟地黄为生地黄,以去其腻滞增其养阴清热之效;桃仁、红花、滋润祛瘀。全方活血调血、祛瘀通络。若气虚者加党参、黄芪、茯苓;血瘀显者加丹参、三棱;血虚显者重用当归、熟地黄。朱宝贵用本方为主,按上述加減用药,治疗各种重症不寐 10 例(高血压 2 例,脑动脉硬化症 1 例,神经衰弱 6 例)。治疗结果(所有病例全部停服安眠镇静药,服用活血化淤药,时间均在 1 个月以内);6 例治愈(夜间能安睡 6~7h 以上,头昏头痛,乏力等症消失);3 例显效(夜间安睡 5~6h,症状减轻);1 例好转(睡眠时间延长)。

【病案举例】 张某,男,58 岁,失眠 3 年,服安眠药无效,

白天更觉倦怠、纳呆。有肝硬化病史,肝功能异常,白球蛋白明显倒置,已不能再服安眠药。证见头昏,神疲纳呆,面色少华,动则汗出气急,舌质黯红、苔白薄腻,脉细涩。中医诊断为不寐。辨证为气虚血淤。治宜益气活血。药用桃红四物汤加党参、黄芪、茯苓、当归、丹参。连服7剂,夜寐转安,不服安眠药,已能入睡4~5h,惟头昏明显,纳谷不香。继上方加山楂、神曲,再服7剂,夜间已能安睡7h左右,汗出减少,精神大振,纳谷转香,舌质转红、苔薄白。再处以养血、活血、益气方药,调治月余,未见复发[朱宝贵,浙江中医杂志,1988,(2):70]。

【方名】 血府逐淤汤。

【组成】 当归 15g,生地黄 12g,桃仁 6~10g,赤芍 12g,川芎 10g,枳壳 6g,柴胡 6g,桔梗 6g,川牛膝 30g,西红花(另煎)2g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 活血化淤。

【适应证】 失眠,证属淤血内阻者。

【方药简析】 方中当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血祛淤;牛膝祛淤血、通血脉,并引淤血下行;柴胡疏肝解郁、升达清阳;桔梗、枳壳开胸行气,使气行则血行;生地黄配当归凉血清热、养血润燥;甘草调和诸药。全方活血化淤,不仅行血分淤滞,又能解气分之郁结,活血而不耗血,祛淤又能生新。若伴气虚,加西洋参或太子参;阴虚加阿胶、龟板、知母、鹿角胶;脾虚加白术、茯苓、山药等。此外,可适当选用重镇安神药,如磁石、朱砂、琥珀、生龙骨、生牡蛎等药物。赵福顺以本方为基础方,按上述加减用药,治疗本病40例。结果以成年人正常睡眠时间为标准,痊愈(睡眠时间达5~7h)20人;显效(睡眠时间4~6h伴少梦)16人;有效(睡眠时间3~5h伴少梦)4人。

【病案举例】 刘某,男性,49岁,1990年6月12日初诊。患者做会计工作10余年,后主管行政兼管财会,因过度劳累、心情不畅、思虑繁重、致劳伤心脾、神失所主,日久发为失眠。始为间断性不眠,经治疗后稍有好转,后因工作繁忙、情志不遂,发为通宵不眠,再医无效。发病1年有余,曾屡服中药以养心安神、重镇安神为主,兼用安眠剂等,时能间断少寐,但恶梦频繁,终日疲乏无力,复求治于笔者。症见:面色少华,精神疲惫,自述:心胸烦热,易急躁,时有心悸,口干少饮,舌质暗红边有淤斑,少苔,脉双弦细数。中医诊断为不寐。辨证为气阴两亏、血瘀不眠证。拟活血祛瘀为主,投以血府逐瘀汤:当归20g,生地黄12g,桃仁6g,川芎6g,枳壳5g,柴胡6g,桔梗6g,川牛膝30g,西红花(另煎)2g。水煎服3剂。6月14日复诊,已能入眠,时有心悸少梦。原方加茯苓、太子参各30g,知母、黄柏各10g,麦门冬、合欢皮各15g,继服5剂而愈[赵福顺,江西中医药,1992,(2):28]。

【方名】 癫狂梦醒汤。

【组成】 桃仁12g,柴胡10g,香附15g,木通10g,赤芍12g,半夏10g,大腹皮15g,青皮14g,陈皮12g,桑白皮12g,苏子10g,甘草15g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 行气、活血、化痰,调畅气血。

【适应证】 严重失眠症,证属郁怒伤肝、气滞血瘀者。

【方药简析】 方中以桃仁、红花活血化瘀;半夏燥湿化痰;柴胡、香附、大腹皮、青皮、陈皮、桑白皮、苏子行气破滞,降痰气之壅滞;木通导热下行;甘草调和诸药。全方行气、活血、化痰,调畅气血。若伴悲伤欲哭者加小麦30g、大枣5枚;胸腹胀满纳呆便秘者加枳实12g、焦三仙30g、瓜蒌仁12g;头昏脑

胀者加磁石 30g,重用半夏至 12g、苏子 12g;若见精神抑郁、目光呆滞、舌苔厚腻者加石菖蒲 12g、郁金 10g、麝香 0.3g(冲服)。王连芳等以本方为基础方,按上述方法加减用药,治疗本病 15 例,均在服药 3~6 剂达到安眠目的。

【病案举例】 患者:吕某,女,45 岁,教师,1983 年 10 月 12 日初诊。失眠 3 年余,1 周前因郁怒加重,3 天来竟昼夜不眠。烦躁气急,头昏脑胀,夜间尤甚,胸腹胀满,曾服冬眠灵、速可眠等大量镇静药,失眠程度有增无减。就诊时,双目炯炯,面红目赤,急躁易怒,有欲狂之势。舌苔白干,脉弦有力。中医诊断为不寐。拟基本方加枳实、磁石,服 6 剂痊愈。半年后追访,病情稳定,每日睡眠 7~8h[王连芳等,河北中医,1986,(1):33]。

【方名】 补阳还伍汤。

【组成】 黄芪 60g,当归尾 6g,赤芍 6g,地龙 3g,川芎 3g,桃仁 3g,红花 3g。

【来源】 王清任《医林改错》。

【功效】 补气,活血,通络。

【适应证】 顽固性失眠等,证属血淤、虚实夹杂者。

【方药简析】 方中重用黄芪以补其气;当归尾、赤芍、桃仁、红花、川芎、地龙活血通经、养心血、宁心神。诸药合用,使心气旺盛、血脉通畅、失眠自愈矣。潘鸿琼以本方加丹皮、茯苓治疗本病有良效。

【病案举例】 彭某,男,71 岁,1987 年 10 月 6 日初诊。失眠时轻时重已 3 年有余,服安眠药多则每夜能寐 3~4 个 h,近半年来症状有所加重,每晚只能合目 1~2h 即醒,醒后再难以安睡。自诉心慌气短,心胸不舒、头晕脑胀、食少神倦,时而微烦、急躁,小便微黄,大便两日 1 次。舌暗红、边有淤点,脉稍

见结。曾以神经官能症、神经衰弱等症多次留医治疗,效果欠佳。参见前医先后反复选用酸枣仁汤、柏子养心汤、朱砂安神丸、生脉散、炙甘草汤等方剂,投以远志、朱砂、夜交藤、龙齿等养心安神镇肝药。细思此例失眠如此顽固难愈,屡进养心、滋阴补血、清火调肝等剂而无功,乃因只注意其气阴之虚,忽视其血瘀之实,故投以补气、活血、振脉之品。予补阳还伍汤加减:黄芪 50g,赤芍、当归尾、丹皮、茯苓、桃仁、川芎、地龙各 8g,红花 6g。5 剂,水煎服。10 月 20 日再诊:服上药后,心慌气短渐平,睡眠好转(每晚均能安寐 4~5h),精神亦振,纳食增进,舌质同前,苔薄,脉细,药获初效。上方桃仁增至 12g,继服 6 剂,诸症消失。同年 12 月随访,自觉稍有胸闷外,余无不适而安然入寐[潘鸿琼,新中医,1990,(1):41]。

加味大补元煎 493
 加味六磨汤 522
 加味左归丸 694
 加味百合地黄汤 531
 加味安神定智汤 473
 加味参附汤 462
 加味涤痰汤 198
 加味桃仁承气汤 608
 加味逍遥散 527
 加味通窍活血汤 688
 加味温胆汤 629
 加味安眠汤 539
 加味癫狂梦醒汤 593

六划

当归川芎方 8
 芍防钩芎汤 16
 芎背汤 17
 芎甘全蝎汤 26
 防风蜈蚣散 38
 补气养阴汤 61
 当归四逆汤 87
 曲直汤 88
 当归四逆桃红饮 89
 芎甘五藤汤 91
 地黄利水方 385
 刘春圃治脑积水方 390
 防眩汤 273
 芍药甘草汤加味 311
 阳和汤 295
 血府逐瘀汤 255

地黄饮子 139
 导痰通络汤 210
 防瘫汤 242
 当归四逆汤 323
 地骨清金汤 521
 地黄饮子 732
 百合宁神汤 663
 百合地黄汤 654
 百合更忧汤 662
 百合知母一贯煎 634
 百合安夜汤 769
 百合安神汤 476
 百合逍遥汤 502
 达营片 607
 血府逐瘀汤 643
 朱磁丸 771
 交泰丸 506

七划

坐骨舒 93
 抑痛散 208
 抗痛灵 210
 抗痛胶囊 214
 补血祛风牵正饮 35
 补中益气汤 117
 补骨脂红枣汤 378
 补阳还五汤加味 250
 补气升阳和中汤 445
 芎芷石膏汤 158
 补中气滋肾汤 334
 补气增力汤 337

补血安神汤 339
 补肝调肾汤 344
 补益温通方 399
 补肾建脑方 389
 补肾地黄汤 392
 龟芍牡乳菖蒲汤 418
 佛手补髓汤 231
 肚关芪附汤 378
 肝肾两补通痹散 129
 麦门冬汤 132
 忘痛安脑汤 436
 杞菊地黄汤 437
 芪甲通脉汤 239
 芳香醒脾汤 244
 吴萸泻心夺命汤 259
 补气活血化淤汤 229
 补气化淤通络汤 241
 安宫牛黄丸 588
 冰醋丸 781
 阴躁汤 483
 防己地黄汤 530
 防风通圣安寐汤 789
 红芽大戟煎 558
 杨氏升降散 564
 更年欢 668
 更年期良饮 669
 吴茱萸汤 481
 龟鹿二仙汤 758
 补元解忧汤 656
 补元解毒汤 740
 补中益气汤 733

补中益气止厥汤 457
 补气养心振神汤 594
 补阳还仇汤 690
 补肾益脑汤 720
 补肾摄魂汤 764
 陈半赤龙汤 500

八划

定痛饮 159
 虎参胶丸 402
 定眩汤 272
 软迟丸方 354
 定振丸 294
 泻心汤加味 265
 昏痛缓解汤 428
 金刚丸加味 141
 金水两全通经散 130
 固本通灵涤痰汤 224
 建瓴汤 234
 苦参酸枣仁合剂 783
 奔豚汤 480
 枕中逍遥散 577
 枣仁汤 766
 卧龙丸 541
 固肾摄脾汤 462
 昌阳泻心汤 729
 金水宝 743
 知柏地黄安厥汤 463
 和中交泰汤 787
 泻火宁心汤 612
 定眩汤 716

定智地黄汤 719
定智汤 693
定游汤 768
夜合汤 785
经期癫狂协定处方 603
降冲化淤汤 617

九划

柔肝解痉汤 20
洋白附子通窍活血汤 33
牵续汤 38
面瘫汤 40
活络效灵丹 79
枳陈槟榔汤 79
祛寒宣痹汤 94
美的平 104
复方泽泻汤 113
复肌汤 151
活血止痛汤 161
星香加味方 180
复方养血熄风汤 295
复力散 340
活血通络汤 422
活血醒脑汤 427
独活寄生汤 134
急救稀涎散 438
茯苓四逆汤加味 254
茵陈栀子汤 451
荣脑汤 710
荡痰汤 626
复生汤 464

宣清导浊汤 499
养心汤 732
首乌健脑汤 711
活血醒脑汤 571
洋金花注射液 580

十划

益气健脾汤 58
消渴痹痛汤 68
益气行滞汤 69
枳枝芍药知母汤 90
眩平汤 111
柴胡川芎饮 171
通腑降浊汤 193
健脾祛痰调气和中汤 203
消斑止痛汤 413
通窍活血利水汤 386
消囊利水方 391
眩晕汤 271
眩晕丸 274
益气聪明汤 277
桃红定眩汤 279
祛风定震汤 120
祛风通络汤 421
逍遥散加味 313
桂枝新加汤 316
桃红四物汤 316
振痿汤 148
逍遥散 358
养血祛风解毒汤 359
健益固脬汤 374

- | | |
|---------------|-----------------|
| 桑螵蛸散 377 | 桃红四物汤 793 |
| 通脉饮 321 | 逐瘀除烦汤 479 |
| 通窍利脑汤 426 | 逐瘀解郁汤 645 |
| 益气活血健脑升窍汤 429 | 柴甘更年期方 665 |
| 柴精汤 434 | 柴龙牡蛎汤 591 |
| 复元活血汤 436 | 柴芍六君汤 655 |
| 柴胡细辛汤 438 | 柴胡龙牡铁落汤 631 |
| 养血柔肝熄风汤 288 | 柴胡加龙骨牡蛎去参桂汤 576 |
| 凉膈散 290 | 柴胡加龙骨牡蛎安脏汤 526 |
| 桂附稳步汤 363 | 柴胡加龙骨牡蛎汤 574 |
| 桃红四物汤加味 303 | 柴胡桂枝汤 460 |
| 桂枝加龙骨牡蛎汤 301 | 健脑丸 547 |
| 益气通脉汤 227 | 涤痰化淤汤 687 |
| 通脉汤 228 | 涤痰汤 726 |
| 消栓汤 I 233 | 涤痰祛淤汤 630 |
| 消风通脉饮 234 | 涤痰解郁汤 627 |
| 消栓汤 II 235 | 益气聪明汤 277 |
| 起瘫煎 237 | 益气摄纳汤 508 |
| 益化通汤 237 | 益脑宁 749 |
| 涤痰化淤汤 243 | 益肾豁痰汤 705 |
| 通腑化淤汤 257 | 益智饮 547 |
| 脑衄化淤汤 258 | 调节丸 543 |
| 涤痰汤 449 | 逍遥化欲汤 501 |
| 桂甘龙牡汤 530 | 逍遥安神汤 650 |
| 桂枝汤 459 | 逍遥调补汤 614 |
| 桂枝加龙骨牡蛎汤 490 | 逍遥散 487 |
| 桂枝加桂汤 482 | 调经解郁汤 613 |
| 桂枝龙牡汤 491 | 通窍开郁汤 573 |
| 桂附八味龙牡汤 619 | 通窍还少汤 709 |
| 桂附吴茱萸汤 739 | 通窍活血汤 707 |
| 桃仁复苏汤 706 | 桑麻地黄汤 717 |

十一划

菊花明目饮 6
清泄和络汤 10
菊花茶调撮风散 23
黄芪桂枝八物汤 71
鹿马丸 95
黄芪桂枝三七汤 96
清眩汤 109
旋复代赭汤 115
偏痛饮 163
清上蠲痛汤 167
排囊汤 191
清心汤 407
清肝养血汤 279
颅内消瘀汤 422
鹿茸益智散 353
清心止遗汤 379
培元熄风通络汤 225
蛇蝎蜈蚣散 232
清脉饮 320
羚羊钩藤汤 252
麻杏石甘汤 450
清官汤 452
清瘟败毒饮 152
黄芪桂枝五物汤 122
黄芩苍术汤 275
黄连龙磁汤 504
黄连阿胶交泰汤 470
黄连阿胶加减方 540
黄连阿胶复脉汤 462

黄连清心饮 731
黄连温胆汤 265
黄连温胆镇魂汤 771
黄连解毒醒脑汤 684
黄连豁痰汤 683
栀子龙牡汤 467
羚羊钩藤汤 527
清心汤 609
清心安神汤 559
清心泻火定狂汤 586
清心泻火镇狂汤 584
清养心脾开郁汤 652
清热定狂汤 587
清痰化淤汤 610
麻桂汤 791
鹿角溢智汤 757
鹿麻汤 715

十二划

散偏汤 24
温经止痛汤 27
强直牵正复元汤 36
脾肾两补通痹散 129
疏肝理脾汤 206
强肌健饮 330
温经通络汤 396
琥珀安神汤 417
舒筋安腿汤 315
滋肾补脾汤 354
犀角地黄汤 267
遗尿灵 372

葱神口服液 544

十八画

魏长春补脑汤 516

十九划

囊虫丸 189

霍半解毒汤 727

二十划

髓海定风饮 162

二十一划

癔病痉 217

癫狂梦醒汤 795

二十二划

调痛汤 165

